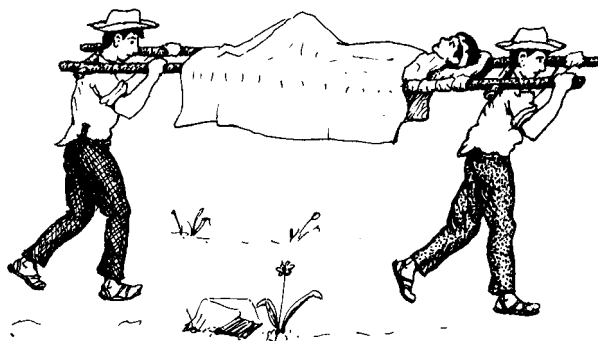


ТАМ, ГДЕ НЕТ ДОКТОРА

~ исправленное издание ~

Дэвид Вернер,
Кэрол Сотамен и Джеймс Максвелл



с рисунками Дэвида Вернера

Библиотека Конгресса в каталоге данных

Вернер Давид 1934-

Там, где нет доктора/ Давид Вернер; с Керол Туман и Джейн Максвелл. Испр. изд.

ISBN 0-942364-15-5

1. Медицина, популярная. 2. Здравоохранение в сельской местности.

I. Туман Керол, 1959-- . II. Максвелл Джейн, 1941-- . III. Титул

[DNLM: 1. Общественная медицинская помощь - справочники

2. Медицина - популярные работы.

3. Здравоохранение в сельской местности - справочники.

WA 39 W492w]

RC81.W4813 1992 610 - dc20

DNLM/DLC 92-1539

Для библиотеки конгресса CIP

Издано:

фондом Геспериана

П.О. ящик 1692

Пало Алто, Калифорния 94302

США

Копия © 1992 фонд Геспериана.

Первое издание на английском языке, октябрь, 1977.

Исправленное издание на английском языке май, 1992

Третье издание, апрель, 1996

Оригинал этой книги на английском языке был выпущен в 1977 как пересмотренное и исправленное издание перевода с испанского издания *"Donde No Hay Doctor"*.

Любые страницы из этой книги, включая иллюстрации, можно копировать, размножать, адаптировать к местным условиям без разрешения автора или издателя.

Разрешается распределять размноженные издания бесплатно или за плату - но не в целях выгоды. Для распространения с коммерческими целями необходимо получить разрешение автора или фонда Геспериана. Автор и фонд Геспериана были бы признательны, если ему вышлют копию любого материала, в котором был использован текст или иллюстрации.

Примечание для тех, кто будет переводить книгу: чтобы избежать дублирования и для адаптации информации в этой книге, **перед тем как начинать перевод, пожалуйста, свяжитесь с фондом Геспериана.**

ЭТО ПЕРЕСМОТРЕННОЕ И ИСПРАВЛЕННОЕ ИЗДАНИЕ МОЖНО УЛУЧШИТЬ С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ. Если вы сельский работник здравоохранения, врач, мать или любой человек, у которого есть идеи или предложения по изменению этой книги для лучшего использования в вашем обществе, пожалуйста, напишите автору на адрес фонда Геспериана. Благодарим вас за помощь.



Благодаря работе и преданности многих групп людей и отдельных лиц со всего света книга "Там, где нет доктора" была переведена более чем на 50 языков.

Ниже представлен следующий список некоторых переводов и адресов, где вы можете получить их.



ИСПАНСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ
The Hesperian Foundation
P.O. box 1692
Palo Alto, CA 94302
U.S.A.

ИСПАНСКИЙ
Editorial Pax-Mexico
Ave. Cuauhtemoc 1434
Mexico, D.F. 03310
MEXICO

ФРАНЦУЗСКИЙ
ENDA
B.P. 3370
Dakar, SENEGAL

ПОРТУГАЛЬСКИЙ
Edicoes Paulinas
Caixa Postal 8.107
Sao Paulo, S.P. BRAZIL

АРАБСКИЙ
Arab Resource Collective
P.O. Box 7047
Nicosia, CYPRUS

СУАХИЛИ
Rotary Club of Dar es Salaam
P.O. Box 1533
Dar es Salaam, TANZANIA

ХИНДИ
VNAI
40, Institutional Area
(Near Qutab Hotel, S. of I.T.T.)
New Delhi, 11016

ВЬЕТНАМСКИЙ
CIDSE — Vietnam
G.P.O. Box 2914
General Post Office
Bangkok, THAILAND

ИНДОНЕЗИЙСКИЙ
Yayasan Essentia Medica
P.O. Box 58
Yogyakarta, INDONESIA

ИТАЛЬЯНСКИЙ
Lay Volunteers Internat'l Assoc
Via Meucci 35
12100 Cuneo, ITALY

Для получения информации о изданиях на других языках, включая амфарик, бенгальский, китайский, дари, немецкий, ибан, канадский, корейский, лао, марати, маршалльский, мискито, непальский, ушту, квегуа, шуар, синдхи, синхала, тамильский, тхай, тигро, тигрино, тевани и урду, а также английский пишите в фонд Геспериана. Издания адаптированы для различных стран.

Мы ищем способы доставить эту книгу тем, кому она может послужить лучше всех - а именно людям в отдаленной сельской местности. Если вы в состоянии помочь нам или у вас есть предложения, пожалуйста, свяжитесь с фондом Геспериана. Мы предлагаем эту книгу по низкой цене лицам с малым доходом, живущим в бедных странах.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Это издание книги “Там, где нет доктора” создано общими усилиями. Я благодарю многих людей во всем мире, которые пользуются этой книгой, пишут нам на протяжении многих лет, делятся своими замечаниями и предложениями - они направляют нас, предоставляя необходимую информацию.

Керол Тамен и Джейн Максвелл помогали нам в редактировании, написании и подготовке этого издания. Я выражаю глубокую признательность за их отличную и очень тщательную работу.

Еще мне хотелось бы поблагодарить других людей, которые редактировали и написали некоторые главы этого издания: Сюзан Клейн, Ронни Лович, Мери Эллен Гарой, Шилли Кахане, Паулу Элстер и Джорджа Кента. За информацию, полученную из африканского издания, благодарю Эндрю Пиарсон и других авторов из издательства Макмиллан.

Многие врачи и специалисты в области здравоохранения во всем мире провели обзор книги. Мы не можем перечислить всех, но некоторых нельзя не упомянуть: Дэвид Сандерс, Рихард Лаинг, Билл Бауэр, Грег Тролл, Дебора Бикел, Том Фриден, Джейн Зукер, Дэвид Морлей, Френк Катчпул, Лонни Шавелсон, Рудольф Бок, Джозеф Кук, Саджа Гринвуд, Виктория Шеффилд, Шерри Хиласки, Пам Зинкин, Фернандо Витери, Джордан Таперо, Роберт Гелбер, Тед Грейнер, Стефен Глойд, Рейнер Арнольд и Майкл Тэн. Их квалифицированный совет и помощь оказались очень ценными.

Я тепло благодарю преданных членов Фонда Гесперана за помощь в подготовке рукописи: Кайл Кравена за изобразительное искусство и макет, Стефена Вабба, Синтия Роута и Элизабет де Авилла за компьютерную графику. Я выражаю благодарность тем, кто помогал в подготовке этой книги, это: Кэти Альберт, Мери Клейн, Эван Смит, Джейн Бовелас, Ким Геннон, Хейди Парк, Лаура Гибней, Нэнси Огаз, Мартин Бастос, Карен Вудбери и Труд Бок.

Иллюстрации для нового издания были созданы Дэвидом Вернером, Килем Кравеном и Сюзен Клейн. Также были использованы некоторые рисунки Фелисити Шепарда из африканского издательства Макмиллан. Я признателен “Новому Интернационалисту” и Джеймсу Огвангу за рисунки на 417 странице. Как и в первом издании, я благодарю Мак Гроу-Хилл Бук Компани за разрешение использовать рисунки, которые находятся на стр. 85 и 104 из “Скорой медицинской помощи” Джона Хендерсона, которые были иллюстрированы Ниллом Харди. Моя благодарность Дейл Кросби за рисунки на страницах 29, 32, 35, 100, 181 и 200 и моему отцу Карлу Вернеру за рисунки на страницах 5-8, 121, 187, 229, 231, 235-238, 240, 245, 256, 276 и 281.

Прекрасная работа тех, кто помогал в создании первой версии книги, заметна почти на каждой странице. Моя благодарность Вэли Прайсу, Эл. Хотти, Родни Киндол, Максу Капестани, Рудольфу Боку, Кенту Бенедикту, Альфонсо Даррикадесу, Карлосу Фелипе Сото Миллеру Паулю Квинтара, Дэвиду Морли, Биллу Баверу, Аллизон Орозко, Сюзен Клейн, Грегу Троллу, Кэрол Вестбург, Линн Гордон, Мире Полинджер, Труду Бок, Роджеру Банч, Линн Коем, Джорджу Кенту, Джеку Мэй, Оливеру Бок, Биллу Гонда, Рей Блейчер и Джесус Манджаррес.

За это новое издание мы признательны финансовой поддержке Корпорации Карнеги, Гладис и Меррил Муттарт Фонду, Мире Полинджер, Фонду общественного благосостояния, Мизереор W.K., Келлог Фонду, Санфлауэ Фонд и Эдна Мак Коннел Кларк Фонду.

Наконец, моя теплая благодарность сельским работникам здравоохранения проекта Piaxtla в Мексике – особенно Мартину Райсу, Мигелю Ангелю Манджаррису, Мигелю Ангелю Альварресу и Роберту Фаджардо – чьи высокая квалификация и опыт обеспечили основу этой книги.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ЗАМЕЧАНИЕ ОБ ЭТОМ НОВОМ ИЗДАНИИ

СОВЕТЫ НАРОДНОМУ ВРАЧЕВАТЕЛЮ с1

Требования к здоровью
и человеческие нужды **с2**
То, что помогает сохранить здоровье **с7**
Ознакомьтесь получше
со своим обществом **с8**
Используйте местные ресурсы
для своих нужд **с12**
Решайте, что делать
и с чего начинать **с13**
Испытание новой идеи **с15**
К установлению баланса
между людьми и землей **с16**

Установление баланса
между профилактикой
и лечением **с17**
Разумное и ограниченное
применение лекарств **с18**
Понимание того, что сделал
прогресс (оценка) **с20**
Преподавание и совместная учеба - работник
здравоохранения как педагог **с21**
Средства обучения **с22**
Как лучше пользоваться
этой книгой **с28**

Глава 1

ДОМАШНЕЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПОПУЛЯРНОЕ МНЕНИЕ О НЕМ1

Домашние средства, которые
помогают **1**
Вера, приносящая людям добро **2**
Вера, которая делает людей
больными **4**
Колдовство – черная магия – дурной глаз **5**
Вопросы и ответы на некоторые народные
приметы и домашние средства лечения **6**

Впалый родничок, или мягкое место **9**
Мнение о том, работает или нет домашнее
лечебное средство **10**
Лекарственные растения **12**
Кустарные гипсы для установки на место
сломанных костей **14**
Клизмы слабительные и очищающие: когда
пользоваться ими, а когда нет **15**

Глава 2

БОЛЕЗНИ, КОТОРЫЕ ЧАСТО ПУТАЮТ17

В чем причина болезней **17**
Различные болезни и их причины **18**
Неинфекционные болезни **18**
Инфекционные болезни **18**
Болезни с одинаковыми
симптомами **20**

Болезни, которые часто путают или которым
дали одинаковое название **21**
Недоразумения из-за путаницы в названиях
25
Путаница между различными болезнями,
вызывающими жар **26**

Глава 3

КАК ОСМАТРИВАТЬ БОЛЬНОГО 29

Вопросы **29**
Температура **30**
Как пользоваться
термометром **31**
Дыхание (респирация) **32**
Пульс (сердцебиение) **32**

Общее состояние здоровья **30**
Глаза **33**
Уши, горло, нос **34**
Кожа **34**
Живот (желудок) **35**
Мышцы и нервы **37**

Глава 4

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА БОЛЬНЫМ 39

Комфорт для больного человека 39

Особый уход

за тяжело больным человеком 40

Жидкости 40

Пища 41

Гигиена и изменение положения в постели 41

Наблюдение за изменениями 41

Признаки опасной болезни 42

Когда и как обратиться за медицинской
помощью 43

Что говорить работнику здравоохранения 43

Карточка пациента 44

Глава 5

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ 45

Лечение с водой 46

Когда вода лучше лекарств 47

Глава 6

ПРАВИЛЬНОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЛЕКАРСТВ 49

Руководства по употреблению лекарств 49

Наиболее опасные злоупотребления
лекарствами 50

Когда не надо употреблять
лекарства? 54

Глава 7

АНТИБИОТИКИ: ЧТО ЭТО И КАК ИХ УПОТРЕБЛЯТЬ..... 55

Руководства по употреблению антибиотиков 56

Что делать, если кажется, что антибиотик не
помогает 57

Ограничить употребление
антибиотиков 58

Глава 8

КАК ОТМЕРЯТЬ И ДАВАТЬ ЛЕКАРСТВО 59

Жидкая форма лекарства 61

Как давать лекарство маленьким
детям 62

Как принимать лекарства 63

Инструкция по дозировке для людей, которые
не могут читать 63

Глава 9

ИНСТРУКЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИНЪЕКЦИЯХ..... 65

Когда делать инъекцию, а когда нет 65

Случаи, когда очень важно срочно сделать
инъекцию 66

Лекарства не для инъекций 67

Риск и меры предосторожности 68

Опасные реакции при инъекции определенных
лекарств 70

Как избежать серьезных реакций при
инъекциях пенициллина 71

Как приготовить шприц для
инъекции 72

Как делать укол 73

Как уколы могут искалечить детей 74

Как чистить (стерилизовать) инструменты 74

Глава 10

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 75

- Жар **75**
- Шок **77**
- Потеря сознания **78**
- Когда что-то застряло в горле **79**
- Утопление **79**
- Что делать, когда останавливается дыхание:
дыхание рот в рот **80**
- Травмы, вызванные перегревом **81**
- Как остановить кровотечение из раны **82**
- Как остановить кровь из носа **83**
- Порезы, царапины и маленькие раны **84**
- Большие порезы: как закрыть их **85**
- Повязки **87**
- Инфицированные раны: как их распознать и
лечить **88**
- Пулевые, ножевые и другие тяжелые ранения
90
- Серьезные проблемы с кишечником (Острый
живот) **93**
- Аппендицит, перитонит **94**
- Ожоги **96**
- Сломанные кости (Переломы) **98**
- Как переносить тяжело раненого **100**
- Вывихи (Кости, что сошли с места в суставах)
101
- Растяжения и разрывы (Ушиб или разрыв в
вывихнутом суставе) **102**
- Отравление **103**
- Укусы змей **104**
- Другие ядовитые укусы **106**

Глава 11

ПИТАНИЕ: ЧТО НАДО ЕСТЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ107

- Болезни, вызванные плохим
питанием **107**
- Почему так важно правильно питаться **109**
- Предупреждение недоедания **109**
- Основная и вспомогательная еда **110**
- Правильное питание сохраняет
здоровье **111**
- Как распознать недоедание **112**
- Как питаться лучше, когда у вас мало денег
или земли **115**
- Полные люди **126**
- Запор **126**
- Диабет **127**
- Откуда получать витамины: из пилюль, уколов,
сиропов – или из пищи? **118**
- Чего избегать в нашей диете **119**
- Наилучшая диета для малышей **120**
- Вредные представления о диете **123**
- Особые диеты при некоторых
болезнях **124**
- Анемия **124**
- Рахит **125**
- Высокое давление (гипертония) **125**
- Кислотное расстройство, изжога и язвы
желудка **128**
- Зоб (опухоль или шишка на горле) **130**

Глава 12

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: КАК ИЗБЕЖАТЬ МНОГИХ БОЛЕЗНЕЙ.....131

- Чистота – и проблемы, которые
возникают из-за ее недостатка **131**
- Основные правила соблюдения
чистоты **133**
- Общественная чистота (санитария) **137**
- Глисты и другие кишечные паразиты **140**
- Аскариды **140**
- Острицы **141**
- Хлыстовики **142**
- Нематоды **142**
- Солитер **143**
- Трихины **144**
- Амебы **144**
- Кровяные сосальщики (шистосомы,
бильгарции) **146**
- Вакцинация (иммунизация) – простая и
надежная защита **147**
- Другие методы предупреждения болезней и
травм **148**
- Привычки, которые влияют на здоровье **148**

Глава 13

НЕКОТОРЫЕ САМЫЕ ОБЫЧНЫЕ БОЛЕЗНИ151

Обезвоживание	151	Кашель	168
Понос и дизентерия	153	Бронхит	170
Уход за младенцами с поносом	159	Пневмония	171
Рвота	161	Гепатит	172
Головные боли и мигрени	162	Артрит (болезненные, воспаленные суставы)	173
Простуды и грипп	163	Боль в спине	173
Забитый нос и насморк	164	Варикозные вены	175
Заболевания синуса (синусит)	165	Шишки (геморрой)	175
Сенная лихорадка (аллергический ринит)	165	Отеки ног и других частей тела	176
Аллергические реакции	166	Грыжа	177
Астма	167	Припадки (конвульсии)	178

Глава 14

СЕРЬЕЗНЫЕ БОЛЕЗНИ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ.....179

Туберкулез		Лихорадка денге (Жар с ломотой в костях, "походка франта")	187
(ТБ, чахотка)	179	Бруцеллез (Лихорадка Мальта)	188
Бешенство	181	Брюшной тиф	188
Столбняк	182	Сыпной тиф	190
Менингит	185	Лепра (Болезнь Хансена)	191
Малярия	186		

Глава 15

КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ193

Общие правила лечения кожных болезней	193	Стригуций и опоясывающий лишай	
Инструкции по применению горячих компрессов (Горячие примочки)	195	(Грибковые инфекции)	205
Болезни кожи (Руководство для отождествления)	196	Белые пятна на лице и на теле	206
Чесотка (Семилетний зуд)	199	Маска беременности	207
Вши	200	Пеллагра и другие кожные болезни из-за недоедания	208
Клопы	200	Наросты (Бородавки)	210
Клещи и тропические блохи	201	Мозоли	210
Маленькие раны с гноем	201	Угри и черные головки (Прыщи)	211
Импетиго	202	Рак кожи	211
Фурункулы и абсцессы	202	Туберкулез кожи и лимфоузлов	212
Зудящая сыпь, волдыри или крапивница (аллергическая реакция на коже)	203	Рожи и целлюлиты	212
Растения и другие вещи, вызывающие зуд или ожоги кожи	204	Гангрена (Газовая гангрена)	213
Опоясывающий лишай (герпес опоясывающий)	204	Язвы кожи от плохого кровообращения	213
		Пролежни (раны от давления)	214
		Кожные проблемы у детей	215
		Экзема (красные пятна с маленькими волдырями)	216
		Псориаз	216

Глава 16

ГЛАЗА 217

- Опасные признаки **217**
- Травмы глаза **218**
- Как удалить соринку из глаза **218**
- Химические ожоги глаз **219**
- Красные, болезненные глаза – различные причины **219**
- “Розовый глаз” (Конъюнктивит) **219**
- Трахома **220**
- Инфицированные глаза у новорожденных (Послеродовой конъюнктивит) **221**
- Ирит (Воспаление радужки) **221**
- Глаукома **222**
- Инфекция слезного мешочка (Дакриоцистит) **223**
- Проблемы со зрением **223**
- Косоглазие и блуждающий или “ленивый” глаз (Страбизм) **223**
- Ячмень (Хордеолум) **224**
- Птеригиум **224**
- Царапина, язва или рубец на роговице **224**
- Кровотечение в белке глаза **225**
- Кровотечение за роговицей (Гифема) **225**
- Гной из роговицы (Гипопион) **225**
- Катаракта **225**
- Ночная слепота и ксерофтальмия (Дефицит витамина А) **226**
- Пятна или “мушки” перед глазами **227**
- Двоение в глазах **227**
- Речная слепота (Онхоцеркоз) **227**

Глава 17

ЗУБЫ, ДЕСНЫ И РОТ 229

- Уход за зубами и деснами **229**
- Зубная боль и нарывы **231**
- Инфекция десен (Пиорея) **231**
- Болячки или трещины в углу рта **232**
- Белые пятна или прыщи во рту **232**
- Простудные болячки и волдыри от жара **232**

Глава 18

МОЧЕВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ 233

- Проблемы мочевого тракта **234**
- Инфекции мочевого тракта **234**
- Камни в почках или в мочевом пузыре **235**
- Увеличение предстательной железы **235**
- Болезни, передаваемые половым путем (Венерические болезни) **236**
- Гонорея (Триппер) и Хламиды **236**
- Сифилис **237**
- Бубон: Разрыв лимфоузлов в паху (Лимфогранулема венерическая) **238**
- Как и когда употреблять катетер (Резиновую трубку для выведения мочи из пузыря) **239**
- Женские болезни **241**
- Выделения из влагалища (Слизь или похожее на гной вещество, вытекающее из влагалища) **241**
- Как женщина может избежать многих инфекций **242**
- Боль и дискомфорт в нижней центральной части живота у женщины **243**
- Мужчины и женщины, которые не могут иметь детей (Бесплодие) **244**

Глава 19

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ МАТЕРЕЙ И АКУШЕРОВ 245

- Менструальный цикл (Ежемесячное кровотечение у женщин) **245**
- Менопауза (Когда у женщин прекращаются месячные) **246**
- Беременность **247**
- Как оставаться здоровой при беременности **247**
- Незначительные проблемы во время беременности **248**
- Опасные признаки при беременности **249**
- Проверки во время беременности

(Предродовой уход) 250	Трудные роды 267
Карта предродового ухода 253	Разрывы родового отверстия 269
Предметы, которые мать должна приготовить к родам 254	Уход за новорожденным ребенком 270
Подготовка к родам 256	Болезни новорожденных 272
Предвестники близких родов 258	Здоровье матери после родов 276
Периоды родов 259	Родильная лихорадка (Инфекция после родов) 276
Уход за новорожденным 262	Уход за грудью 277
Уход за обрезанной пуповиной 263	Опухоли и новообразования в нижней части живота 280
Рождение плаценты (Последа) 264	Выкидыш (Самопроизвольный аборт) 281
Геморрагия (Сильное кровотечение) 264	Большой риск матерей и детей 282
Правильное использование стимуляторов: Эргоновина, Окситоцина, Питоцина и т.д.) 266	

Глава 20

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ - ИМЕТЬ СТОЛЬКО ДЕТЕЙ, СКОЛЬКО ХОТИТЕ..... 283

Планирование семьи и контроль рождаемости 284	Другие методы контроля рождаемости 290
Хорош ли контроль рождаемости – и безопасно ли это? 284	Методы для тех, кто никогда больше не хочет иметь детей 293
Выбор метода контроля рождаемости 285	Домашние методы предупреждения беременности 294

Глава 21

ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНИ ДЕТЕЙ 295

Что делать для защиты здоровья детей 295	Дифтерия 313
Рост детей – и “путь к здоровью” 297	Детский паралич (Полио, полиомиелит) 314
Карта здоровья ребенка 292	Как сделать простые костыли 315
Обзор проблем детского здоровья, рассмотренных в других главах 305	Врожденные болезни детей 316
Проблемы детского здоровья, не рассмотренные в других главах 309	Вывихнутое бедро 316
Ушная боль и инфекции ушей 309	Пупочная грыжа (выпирающий узелок на животе) 317
Больное горло и воспаление миндалин 309	“Опухшее яичко” (Водянка или грыжа) 317
Суставной ревматизм 310	Умственно отсталые, глухие или уродливые дети 318
Инфекционные болезни детства 311	Спастический ребенок (Церебральный паралич) 320
Ветряная оспа 311	Отставание в развитии в первые месяцы жизни 321
Корь 311	Болезнь серповидной клетки 321
Коревая краснуха 312	Помощь в обучении детей 322
Свинка 312	
Коклюш 313	

Глава 22

ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНИ СТАРЫХ ЛЮДЕЙ 323

Краткое изложение проблем здоровья, обсуждаемых в других главах 323	Другие важные заболевания в старом возрасте 325
--	---

Болезни сердца **325**
 Обращение к молодым людям, которые хотят
 быть здоровыми в старости **326**
 Удар
 (Паралич, апоплексия, инсульт) **327**
 Глухота **327**

Потеря сна (Бессонница) **328**
 Болезни, наиболее часто встречающиеся у
 людей старше 40 лет **328**
 Цирроз печени **328**
 Проблемы желчного пузыря **329**
 Принятие смерти **330**

Глава 23

АПТЕКА 331

Как заботиться о своей аптечке **332**
 Покупая запасы для аптечки **333**
 Домашняя аптечка **334**

Сельская аптечка **336**
 Обращение к сельским лавочникам (или
 фармацевтам) **338**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Употребление, дозы и меры предосторожности для лекарств, на которые ссылаются в этой книге..... 339

Список лекарств в Приложении 1 341
 Индекс лекарств в Приложении 1 345
 Информация о лекарствах 351

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 331

СПИД **399**
 Язвы на половых органах **402**
 Обрезание и отрезание **404**
 Особый уход за маленькими,
 преждевременными и недоношенными детьми
405
 Ушная сера **405**

Лейшманиоз **406**
 Ришта **406**
 Срочная помощь при простуде **408**
 Как измерять кровяное давление **410**
 Отравление пестицидами **412**
 Осложнения после аборта **414**
 Наркомания **416**

СЛОВАРЬ..... 419

АДРЕСА ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 429

ИНДЕКС (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 433

Инструкция по дозировке для людей, которые не могут читать.
 Составление медотчетов

ВВЕДЕНИЕ

Этот справочник был написан главным образом для тех, кто живет далеко от медицинских центров, в местах, где нет врача. Но даже там, где есть врачи, люди могут и должны ухаживать за своим здоровьем. Так что эта книга для любого заинтересованного человека. Она написана с уверенностью что:

1. Уход за здоровьем – это не только право, но и обязанность каждого.
2. Обучение правильному уходу за здоровьем должно быть главной целью любой оздоровительной программы или деятельности.
3. Обычно люди, владеющие простой и ясной информацией, могут предупредить и лечить самые распространенные болезни в домашних условиях – быстрее, дешевле и часто лучше, чем это могут сделать врачи.
4. Медицинские знания должны быть доступными для каждого.
5. Все люди могут использовать на практике медицинские знания.
6. Основной уход за здоровьем должен не предоставляться, а поощряться.

Совершенно ясно, что часть тех, кто информирован об уходе за своим здоровьем, знает свои возможности. Поэтому руководства включают не только, **что делать**, но и **когда обратиться за помощью**. Книга указывает на те случаи, когда важно обследовать больного или получить совет работника здравоохранения или врача. Но поскольку врачи или работники здравоохранения не всегда находятся поблизости, книга также советует, **что нужно делать тем временем** – даже в очень серьезных случаях.

Эта книга написана на основе хорошего английского языка, так что люди без особого официального образования (или те, для кого английский не родной язык) могут понять ее. Язык простой, но я надеюсь, что не детский. Есть несколько трудных слов, которые использованы там, где они соответствуют смыслу или хорошо подходят. Обычно они использовались таким образом, чтобы их значение можно было легко угадать. Следовательно, те, кто читает эту книгу, имеют шанс повысить знания языка, также как и знание медицины.

Важные слова, которые читатель может не понять, объясняются в списке слов или в *словаре* в конце книги. Слово из словаря, которое вскачивается первый раз, в главе обычно выделяется *курсивом*.

Книга «Там, где нет доктора» впервые была написана на испанском языке для фермеров в горах Мексики, где 27 лет тому назад автор помогал создавать сеть пунктов по охране здоровья, которая сейчас обслуживается самими сельчанами. Эта книга была переведена более чем на 50 языков, и используется работниками сельского здравоохранения более чем в 100 странах.

Первое издание на английском языке появилось в результате многочисленных просьб адаптировать ее для использования в странах Африки и Азии. Я получил

помощь и советы от людей с большим опытом работы во многих частях света. Но, английское издание, кажется, потеряло много тонкостей по сравнению с испанским, которое было написано для определенной местности и для людей, которые в течение многих лет были моими соседями и друзьями. Когда книга была переписана, чтобы послужить людям во многих уголках мира, она в некоторых отношениях стала слишком общей.

Для более полного использования книга должна быть адаптирована людьми, знакомыми с требованиями к здоровью, обычаями, особыми методами лечения и местным диалектом.

Люди или программы, которые хотят использовать эту книгу или ее части для подготовки своих собственных учебников для сельчан или работников здравоохранения, поощряются для того, чтобы сделать это. Разрешение автора или издателя не обязательно – **распросанять размноженные копии можно бесплатно или за плату – но не в целях выгоды.** Было бы похвально, если бы вы (1) включили примечание о кредите и (2) отправили бы копию вашего выпуска в Фонд Гесперiana, Box 16992, Palo Alta, California 94302, U.S.A.

Для местной или региональной программы здоровья, у которой нет средств для пересмотра этой книги или для подготовки своих собственных учебников, убедительно советую при использовании настоящего издания снабдить книгу листовками или вкладышами для обеспечения необходимой дополнительной информацией.

В Приложении 1 (применение, дозы, меры предосторожности для лекарств) оставлены пустые места, чтобы вписать основную торговую марку лекарства и его цену. Еще раз, местные программы или организации, распросаняющие эту книгу, должны составить хороший список основных или дешевых торговых марок и цен, которые включаются в каждую копию этой книги.

Книга была написана для каждого, кто хочет сделать что-нибудь для своего здоровья и здоровья других людей. Однако она широко используется как учебник для работников здравоохранения. По этой причине, вводная часть была дополнена обращением к работникам здравоохранения, разъясняющим, что **первоочередная обязанность работника здравоохранения – делиться своими знаниями и помогать обучать людей.**

Сегодня в развитых и слаборазвитых странах существующая система здравоохранения находится в кризисном состоянии. Часто потребности человека не удовлетворяются. Слишком мало справедливости. Слишком много находится в руках немногих.

Давайте надеяться на то, что более интенсивное распросанение знаний и обучение правильному применению лучших методов традиционного и современного исцеления, сделает людей добрее, заставит их разумнее подходить к уходу как за собственным здоровьем, так и за здоровьем других.

Д.В.

ЗАМЕЧАНИЯ О НОВОМ ИЗДАНИИ

Это исправленное издание «Здоровье для всей семьи» мы дополнили новой информацией и модернизировали старую, основываясь на последних научных достижениях. Специалисты по охране здоровья из многих частей света щедро давали свои советы и предложения.

Когда это не влияло на изменение нумерации страниц, мы добавляли новую информацию в основную часть книги. (Таким образом, номера страниц остались теми же, так что ссылки на страницы в наших других книгах, таких как «Пособие Для Работников Здравоохранения», будут правильными.)

Приложение 2 – совершенно новый раздел в конце книги (с. 399) – содержит информацию о растущих или особо опасных проблемах здоровья: СПИД, язвы на половых органах, лейшманиоз, осложнения после аборта, ришта и другие. Здесь еще есть и новые темы, такие как измерения кровяного давления, злоупотребление пестицидами, склонность к наркотикам и методы ухода за ранними и недоношенными детьми.

Новые идеи и информацию можно найти по всей книге – медицинские знания всегда меняются! Например:

- Советы **по питанию** изменились. Специалисты обычно советовали матерям кормить детей пищей, богатой протеином. Но как сейчас стало известно, большинство недоедающих детей нуждается больше в энергетической пище. Многие дешевые энергетические продукты, особенно зерна, обеспечивают нужное количество протеина, если ребенок употребляет их в достатке. Сейчас уделяется внимание поиску путей обеспечения достаточным количеством энергетической пищи вместо “4-х пищевых групп”. (см. Глава 11.)
- Совет по лечению **язвы желудка** сейчас совсем другой. В течение многих лет врачи советовали пить большое количество молока. Но согласно последним исследованиям, лучше употреблять больше воды, а не молока. (см. с. 129.)
- Знания о **специальных напитках при поносе** (оральная регидроновая терапия) тоже изменились. Еще недавно специалисты считали наилучшими напитки с сахаром. Но сейчас мы знаем, что напитки, приготовленные из злаков, приносят больше пользы для предупреждения потери воды, уменьшения поноса и борьбы с истощением, чем напитки на основе сахара или “ОРС” пакеты. (см. с. 152.)
- Раздел был дополнен информацией о **стерилизации оборудования**. Это очень важно для предупреждения распространения определенных болезней таких, как СПИД. (см. с. 74.)
- Также были дополнены разделы по **лихорадке денге** (с. 187), **серповидной анемии** (с. 321) и **контрацептивным имплантам** (с. 293). Страница 105 содержит дополненную информацию о лечении укусов змей.
- Смотрите с. 139 для подробностей о постройке **УВВ туалетов** для борьбы с мухами.

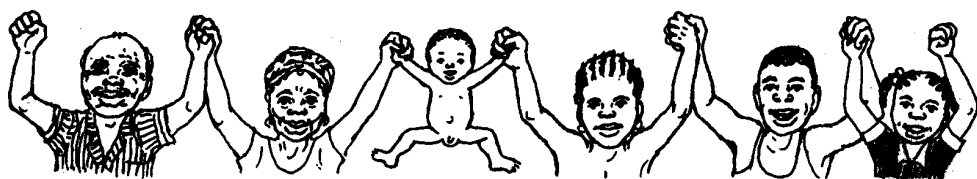
Если у вас есть предложения по улучшению этой книги, пожалуйста, дайте нам знать. Ваши идеи очень важны для нас!

В Приложение 1 сейчас включены дополнительные лекарства. Это потому, что некоторые болезни приобрели сопротивляемость к тем препаратам, которые использовались в прошлом. Поэтому сейчас труднее сделать простое медицинское назначение для таких болезней, как малярия, туберкулез, брюшной тиф и венерические болезни. Часто мы предлагаем несколько способов лечения. Но для многих инфекционных заболеваний нужен местный совет о том, какое лекарство доступнее и эффективнее в вашей местности.

Пересмотрев информацию по лекарствам, мы главным образом включили те, которые содержатся в *Списке Важных Лекарств ВОЗ*. (Однако мы также обсуждаем некоторые широко используемые, но опасные лекарства, чтобы предостеречь от их применения – см. на с. 50-52.) Пытаясь предусмотреть потребности здравоохранения и их изменения в разных частях света, мы представили список лекарств более обширный, чем это требуется для одной какой-то местности. Людям, которые готовят адаптацию этой книги, мы настоятельно советуем сократить Приложение 1 и модифицировать его так, чтобы оно соответствовало потребностям вашей саны.

В этом новом издании «Здоровье для всей семьи» мы продолжаем подчеркивать ценность традиционных форм лечения и дополнили его «домашними средствами лечения». Однако поскольку многие традиционные методы лечения зависят от местных растений и обычаев, мы добавили только несколько наиболее распространенных, таких как чеснок. Мы надеемся, что те, кто адаптирует эту книгу, дополнят домашними средствами, полезными в вашей местности.

Активности общества уделено внимание по всей книге. Например, сегодня часто недостаточно объяснить матерям, что грудное питание самое лучшее. Общество должно организовать работу так, чтобы матери были уверены, что смогут кормить грудью детей и в рабочее время. Такие проблемы, как злоупотребления пестицидами (с. 412), употребление наркотиков (с. 416) и опасные аборты (с. 414) лучше решать людьми, работающими вместе, чтобы сделать их общество безопаснее, здоровее и честнее.



“Здоровье для всех” может быть достигнуто только при организованном требовании людьми большего равенства в распределении земли, зарплаты, услуг и основных прав. Больше власти людям!

ДОМАШНЕЕ ЛЕЧЕНИЕ и ПОПУЛЯРНОЕ МНЕНИЕ О НЕМ

Повсюду на земле люди пользуются домашними методами лечения. В некоторых местах старые, или традиционные, методы лечения передаются из поколения в поколение в течение сотен лет.

Одни домашние средства имеют большую ценность. Другие меньшую. А применение некоторых может быть опасным или вредным. Домашние средства, как и современные лекарства, можно использовать с определенными предосторожностями.

**Пытайтесь не причинять вреда.
Употребляйте домашние средства только тогда, когда
вы уверены, что они безопасны, и знаете точно, как
пользоваться ими.**

ДОМАШНИЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ

Испытанные домашние средства от многих болезней помогают также хорошо, как и современные лекарства — иногда даже лучше. Они чаще бывают дешевле. А в некоторых случаях они безопаснее.

Например, многие виды травяного чая, которыми люди пользуются для домашнего лечения от кашля и простуды, действуют лучше и вызывают меньше проблем, чем микстуры от кашля и сильные таблетки, предписанные врачами.

И еще, «рисовая вода», чаи или подслащенные напитки, которые многие матери дают младенцам от поноса, часто безопаснее и полезнее, чем любое современное лекарство. И что самое важное — так это то, что ребенок с поносом должен получать огромное количество жидкости (см. с. 15).



ОТ КАШЛЯ, ПРОСТУДЫ И ОБЫЧНОГО ПОНОСА ЧАЙ ИЗ ТРАВ ЛУЧШЕ, ДЕШЕВЛЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЛЕКАРСТВ

При некоторых болезнях помогают домашние лекарства. Другие болезни лучше лечить современными медикаментами. Это относится к большинству серьезных инфекций. Такие болезни, как пневмония, брюшной тиф, туберкулез, аппендицит, венерические заболевания, передаваемые половым путем, и послеродовую горячку, нужно лечить современными лекарствами, и как можно быстрее. При лечении этих болезней нельзя терять время, пытаясь использовать сначала только домашние средства.

Иногда трудно быть уверенным в том, какие домашние лекарства действуют хорошо, а какие нет. Нужно более тщательно изучать их. Поэтому:

Часто безопаснее лечить очень серьезные болезни современными лекарствами, следуя совету работника здравоохранения, если это возможно.

СТАРЫЕ И НОВЫЕ МЕТОДЫ

Некоторые современные методы лечения помогают более хорошо, чем старые. Но иногда старые, традиционные, способы лучше. Например, традиционные методы ухода за детьми или стариками чаще добрее и помогают лучше, чем некоторые новые, менее индивидуальные методы.

Не так давно каждый считал, что материнское молоко — наилучшая пища для младенца. Они были правы! Затем крупные компании, которые производили консервированное и искусственное молоко, начали убеждать матерей, что бутылочное кормление лучше. Это неправда, но многие матери поверили им и перешли на искусственное вскармливание своих детей. В результате тысячи младенцев пострадали и умерли от инфекций или голода. Поэтому **кормление грудью — самое лучшее**, см. с. 271.

Уважайте традиции своего народа и следуйте им.

Для дополнительных представлений о применении местных обычаев см. главу 7. "Пособие Для Работников Здравоохранения", Глава 7.

ВЕРА, ПРИНОСЯЩАЯ ЛЮДЯМ ДОБРО

Некоторые домашние лекарства оказывают непосредственное воздействие на тело. Другие, по-видимому, помогают лишь потому, что люди в них верят. **Вера в силу исцеления может быть очень сильной.**



Например, я однажды видел человека, который страдал от сильной головной боли. Чтобы вылечить его, женщина дала ему маленький кусочек батата, или сладкого картофеля. Она сказала, что это сильное болеутоляющее. Мужчина поверил ей, и боль быстро прошла.

Это была вера в ее лечение, а не сам батат, который заставил мужчину почувствовать себя лучше.

Многие домашние средства действуют аналогичным образом. Они помогают многим потому,

что люди верят в них. По этой причине они **особенно полезны для лечения придуманных самим человеком болезней или тех болезней, что вызываются самовнушением больного, беспокойством или страхом.**

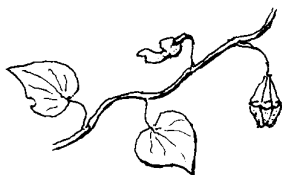
В эту группу включены следующие болезни: колдовство или магия, беспричинный или истерический страх, неопределенные "боли и страхи" (особенно у людей, которые перенесли стрессовое состояние, как например, девочки-подростки или стареющие женщины), беспокойство или нервные срывы. Сюда также входят и еще некоторые болезни: астма, икота, несварение, язва желудка, головная боль при мигрени и даже бородавки.

Для всех этих проблем **действия или "прикосновения" целителя могут быть очень важными.** Ваше внимание, забота, помощь больному человеку часто помогают поверить, что ему будет хорошо, или просто помогут ему расслабиться.

Иногда личная вера в домашнее средство может помочь в решении проблем, которые вызваны полностью физическими причинами.

Например, сельские жители Мексики применяют следующие домашние средства от укуса ядовитой змеи:

1. Использовать листья "гваяко"



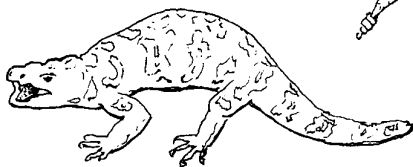
2. Укусить змею



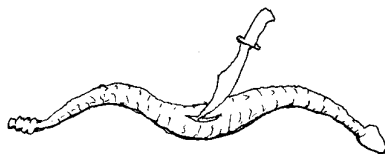
3. Применить табак



4. Приложить шкуру ядовитой ящерицы



5. Намазать на укус змеиную желчь



В других странах у людей имеются свои собственные лекарства от укусов змей – часто самые различные. Насколько мы знаем, **ни одно из этих домашних средств не является эффективным при укусе змеи**. Человека, который утверждает, что домашнее лекарство не дало возможности яду змеи нанести вред, может быть укусила совсем не ядовитая змея.

И все-таки любое из этих домашних лекарств может оказать помощь, если человек верит в него. Если это заставляет его меньше бояться, то его пульс замедляется, он спокойнее двигается и меньше дрожит, и в результате яд медленнее распространяется у него по организму. Итак, опасность меньше!

Но польза от этих домашних лекарств при укусе змеи ограничена. Несмотря на их обычное употребление, люди могут сильно заболеть или умереть. Насколько нам известно:

Домашнее лечение от ядовитых укусов (будут ли это змеи, скорпионы, пауки или другие ядовитые животные) не более эффективно, чем исцеляющая сила веры.

При укусах змеи обычно лучше использовать современное лечение. Будьте готовы: приобретите "антитоксин" или "сыворотку" от ядовитых укусов **прежде**, чем они понадобятся вам (см. с. 105) Не ждите, пока будет слишком поздно.

ВЕРА, КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ ЛЮДЕЙ БОЛЬНЫМИ

Сила веры может помочь исцелять людей. Но она же может и нанести вред им. Если человек верит достаточно сильно, что что-то причиняет ему боль, его страхи могут сделать его больным. Например:

Однажды меня позвали осмотреть женщину, у которой только что произошёл выкидыш и началось небольшое кровотечение. Около ее дома росло апельсиновое дерево. Поэтому я предложил больной выпить стакан апельсинового сока. (Апельсины содержат витамин С, который помогает укреплению кровеносных сосудов). Она выпила его, хотя и боялась, что это может ей навредить.



Ее страх был настолько велик, что вскоре она сильно разболелась. Я обследовал ее, но не смог найти никаких физических отклонений. Я попытался успокоить ее, сказав, что она вне опасности. Но она твердила, что умирает. Наконец, я сделал ей укол дистиллированной воды (абсолютно чистой). Дистиллированная вода не дает никакого медицинского эффекта. Но поскольку вера женщины в уколы была очень сильной, она вскоре почувствовала себя лучше.

На самом деле сок не причинил ей вреда. Что ей навредило, так это убеждение в том, что от сока она могла бы заболеть. А вылечила ее вера в уколы.

Многие люди все-таки продолжают верить выдуманным идеям о колдовстве, уколах, диетах, и многим другим вещам. Результат этого – ненужные страдания.

Возможно, в некотором смысле я помог этой женщине. Но чем больше я размышлял над этим, тем все больше понимал, что тоже допустил ошибку; я заставил ее поверить в то, что было неправдой.

Я решил сказать ей правду. Спустя несколько дней, когда она совсем окрепла, я пошел к ней домой и извинился за то, что я сделал. Я пытался помочь ей понять, что не апельсиновый сок, а страх сделал ее больной. И что не укол воды, а освобождение от страха помогло ей почувствовать себя лучше.

Поняв правду об апельсине, уколе и своем обмане, возможно эта женщина и ее семья освободятся от страха и будут лучше следить за своим здоровьем в будущем. Для здоровья очень важно понимание и свобода от страха.

Многие вещи наносят вред только потому, что люди считают их вредными.

КОЛДОВСТВО – ЧЕРНАЯ МАГИЯ – ЗЛОЙ ГЛАЗ

Если человек сильно верит, что у кого-то есть сила, чтобы навредить ему, он может заболеть на самом деле. Любой, кто верит в колдовство или злой глаз, становится жертвой своих страхов (см. Ужас, с. 24).

“Ведьма” не имеет силы над другими людьми, за исключением своей способности заставить людей поверить в то, что у нее такая сила есть. Поэтому:

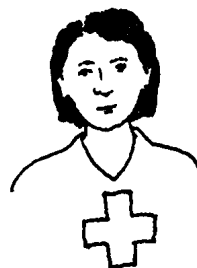
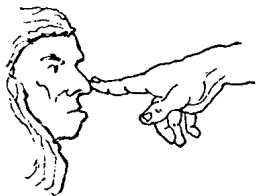
Невозможно околдовать человека, который не верит в колдовство.

Некоторые люди думают, что их “околдовали”, когда у них появляются незнакомые или пугающие болезни (такие, как опухоли половых органов или цирроз печени, см. с. 328). Такие болезни не имеют ничего общего с колдовством или черной магией. Их причины естественные.

Не тратьте ваши деньги на “магические центры”, которые утверждают, что могут избавиться от колдовства. Не пытайтесь отыгаться на ведьме, потому что это ничего не даст. Если вы серьезно больны, обратитесь за медицинской помощью.



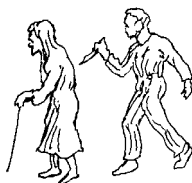
Если у Вас незнакомая болезнь: не обвиняйте ведьму, не обращайтесь в магический центр, а попросите медицинскую консультацию



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НЕКОТОРЫЕ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ДОМАШНИЕ СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ

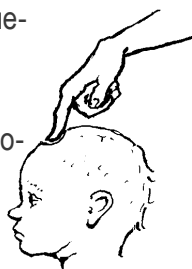
Это примеры народных поверий из горных районов Мексики, областей, которые я хорошо знаю. Возможно, некоторые из этих поверий похожи на ваши. Продумайте, какие из них в вашей местности приводят к улучшению здоровья, а какие нет.

Когда люди думают, что кто-то околдован, правда ли, что ему будет лучше, если его родственники навредят колдунье или убьют ее?



НЕПРАВДА. Никто и никогда еще не помог, нанося вред другому человеку.

Правда ли, что когда “мягкое место” на макушке головы ребенка западает, то это означает, что ребенок умрет от поноса, пока не получит специального лечения?



Часто это правда. “Мягкое место” западает, когда ребенок теряет слишком много жидкости (см. с. 151). Если он не получит больше жидкости, он может умереть (см. с. 152).

Правда ли, что когда свет луны при затмении падает на беременную, ее ребенок родится уродливым или отсталым?



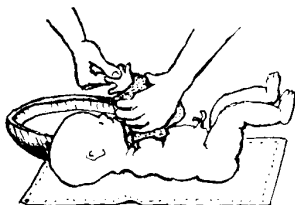
Это неправда. Но дети могут родиться глухими, отсталыми или уродами, если мать не пользуется йодированной солью, если она принимает определенные лекарства или по другим причинам (см. с. 318).

Правда ли, что матерям лучше рожать в затемненной комнате?



Правда, мягкий свет легче для глаз матери, и новорожденного. Но света должно быть достаточно для акушерки, которой надо видеть, что делать.

Правда ли, что новорожденного не следует купать, пока не отпадет пуповина?



Правда! Культия пуповины должна быть сухой, пока не отпадет. Но ребенка можно нежно протирать чистой, мягкой, влажной тряпочкой.

Через сколько дней после родов мать может искупаться?



Мать может искупаться в теплой воде на следующий день после родов. Обычай не купаться неделями после рождения ребенка может приводить к инфекциям.

Правда ли, что грудное вскармливание лучше, чем "современное" кормление из бутылочек?



ПРАВДА! Самое лучшее питание — это грудное молоко, и оно помогает защитить ребенка от инфекций.

Какую пищу должна избегать женщина в первые недели после рождения ребенка?



В первые недели после рождения ребенка женщина не должна избегать никаких питательных продуктов. Наоборот, она должна кушать много фруктов, овощей, мяса, молока, яиц, разных круп и бобов (см. с. 276).

Хороша ли идея искупать больного, или это причинит ему вред?



Это хорошая идея. Больного следует купать каждый день в теплой воде.

Правда ли, что апельсины, мандарины и другие фрукты вредны, если у человека простуда или жар?



НЕТ! Все фрукты и соки полезны, если человека простуда или жар. Они не вызывают застойных явлений и не причиняют никакого вреда.

Правда ли, что когда у человека высокая температура, его нужно закутать, чтобы воздух не навредил ему?



НЕТ! Когда у человека высокая температура, разверните его и разденьте. Пусть воздух обвеет тело. Это поможет снизить жар (см. с. 76).

Правда ли, что чай из коры ивы поможет снизить температуру и снять боль?



Правда. Это помогает. Кора ивы содержит в себе натуральные препараты, подобные аспирину.

ВПАЛЫЙ РОДНИЧОК, ИЛИ МЯГКОЕ МЕСТО

Родничок — это мягкое место на макушке головы новорожденного ребенка. Здесь кости черепа еще не полностью сформировались. Обычно требуется полтора года, чтобы это мягкое место полностью закрылось.

Матери разных стран понимают, что когда мягкое место западает внутрь, их дети в опасности. У них много всевозможных поверий для объяснения этого. В Латинской Америке матери считают, что мозги ребенка соскальзывают вниз. Они пытаются исправить положение, всасывая мягкое место или нажимая на небо рта, или, перевернув ребенка вниз головой, шлепают по ножкам. Это не помогает. Впалое мягкое место вызвано обезвоживанием организма (см. с. 151).



Это означает, что ребенок теряет гораздо больше жидкости, чем он выпивает. Он слишком сухой — обычно из-за поноса или поноса с рвотой.

Лечение:

1. Давайте ребенку много жидкости: регидрон (см. с. 152), грудное молоко или кипяченую воду.
2. Обязательно следует избавиться от поноса и рвоты (см. с. 152 и 161). В большинстве случаев от поноса лекарства не требуются, они могут принести больше вреда, чем пользы.

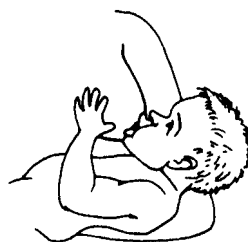
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВПАЛОГО МЯГКОГО МЕСТА.

Не делайте этого

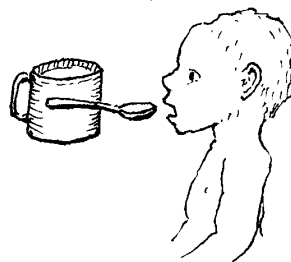


(Магические приемы также не помогут)

Поступайте так



или так



Примечание: Если мягкое место опухло или **выпирает наверх**, это может быть признак менингита. Начинайте лечение сразу (см. с. 185) и обратитесь за медицинской помощью.

МНЕНИЯ О ТОМ, ПОМОГАЕТ ЛИЛИ НЕТ ДОМАШНЕЕ ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО

Хотя многие люди применяют домашнее лечение, это еще не означает, что оно помогает или что оно безопасно. Часто бывает трудно узнать, какие лекарства полезные, а какие могут быть вредными. Перед применением их необходимо тщательно изучить. Вот 4 правила, которые помогут определить, какие лекарства, по крайней мере, работают, а какие опасные. (Примеры из мексиканских деревень).

1. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛЕКАРСТВ ОТ КАКОЙ-ТО БОЛЕЗНИ, ТЕМ МЕНЬШЕ ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО ХОТЬ ОДНО ИЗ НИХ ПОМОЖЕТ.

Например: В селах Мексики существует много домашних средств от зоба, но ни одно из них не является действенным. Вот некоторые из них:

1. Привязать краба к зобу



2. Потереть зоб рукой мертвого ребенка



3. Намазать зоб мозгами грифа



4. Намазать чело-
веческие
лии на зоб



Ни одно из этих многочисленных средств не помогает. Если бы хоть одно помогло, другие были бы не нужны. Когда для лечения болезни применяется одно народное средство, значит, оно наилучшее. Для предупреждения и лечения зоба пользуйтесь йодированной солью (с. 130).

2. ГНИЛЫЕ И ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА ВРЯД ЛИ ПОМОГУТ, А СКОРЕЕ НАВРЕДЯТ.

Например:

1. Идея о лечении проказы напитком из тухлых змей



Идея о том, что сифилис можно вылечить, если съесть грифа.

Эти два лекарства не помогают совсем. Первое может внести опасные инфекции. Вера в подобные лекарства иногда задерживает получение необходимой медицинской помощи.

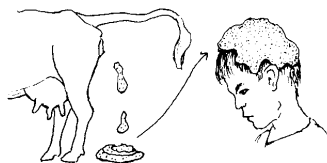
3. ЛЕКАРСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ ЖИВОТНЫЕ ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТХОДЫ, НЕ ПРИНОСЯТ НИЧЕГО ХОРОШЕГО, А МОГУТ ВЫЗВАТЬ ОПАСНЫЕ ИНФЕКЦИИ. НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИМИ.

Примеры:

1. Наложение человеческих фекалий вокруг глаза не исправит плохое зрение, а может вызвать инфекции



2. Наложение коровьего навоза на голову для борьбы со стригущим может вызвать столбняк и другие опасные инфекции

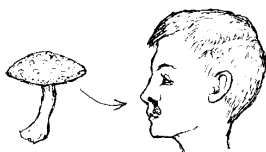


Кроме того, помет кроликов или других животных не заживает ожоги. Пользоваться ими очень опасно. Коровий навоз, зажатый в руке, не может помочь сдерживать припадки. Чаи из фекалий человека, свиньи или других животных не лечат ничего. От них люди только сильнее болеют. Никогда не накладывайте фекалии на пупок новорожденного младенца. Это может вызвать столбняк.

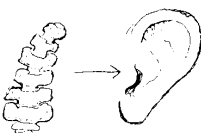
4. ЧЕМ БОЛЬШЕ ГОВОРЯТ О СРЕДСТВЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ, ТЕМ ВЕРОЯТНЕЕ ПОЛЬЗА ОТ СИЛЫ ВЕРЫ В НЕГО.

Связь между каждой из нижеследующих болезней и ее лечением ясна на этих примерах из Мексики.

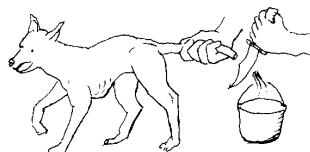
1. При кровотечении из носа используйте uesca (яркий красный гриб)



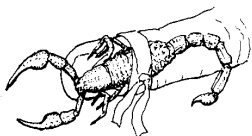
2. При глухоте положите в ухо измельченные кольца гремучей змеи



3. При укусе собаки пейте чай из собачьего хвоста



4. При укусе скорпиона привяжите скорпиона к ужаленному пальцу



5. Для предупреждения поноса при прорезании зубов у ребенка наденьте ожерелье из зубов змеи ему на шею



6. Для "проявления" сыпи от кори заварите чай из коры капки



Эти средства, как и многие другие, им подобные, не имеют лечебной ценности сами по себе. Они могут принести какую-то пользу, если люди верят в них. Но в случае серьезных проблем постарайтесь, чтобы их употребление не задержало более эффективного лечения.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

Многие растения обладают лечебными свойствами. Некоторые лучшие современные лекарства производят из диких трав.

Тем не менее, не все используемые людьми “лечебные растения” имеют медицинскую ценность, а те, что имеют ее, не всегда используются правильно. Изучите травы вашей местности и выясните, какие из них стоит применять.



ОСТОРОЖНО! Некоторые лечебные травы очень ядовиты, если их принимать больше рекомендуемой дозы. По этой же причине часто безопаснее пользоваться современными лекарствами, поскольку дозировку легче контролировать.

Вот несколько примеров растений, которые могут быть полезны, если ими правильно пользоваться:

ДУРМАН (*Datura arborea*)

Листья этой травы и некоторых других видов этого семейства пасленовых содержат наркотик, который помогает снять спазмы кишечника, успокоить боли в животе и даже боли в желчном пузыре.

Размельчите 1 или 2 листа дурмана и замочите их на сутки в 7 столовых ложках (100 мл) воды.

Дозировка: От 10 до 15 капель каждые 4 часа (только для взрослых).

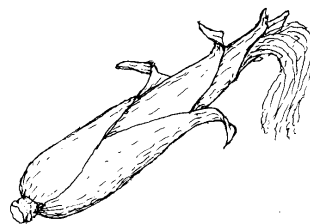


ВНИМАНИЕ: Дурман очень ядовитый, если принимать больше рекомендуемой дозы.

КУКУРУЗНЫЕ РЫЛЬЦА (кисточки или “шелк” у кукурузного початка)

Чай, заваренный из кукурузных рыльцев, оказывает сильное мочегонное действие. Это может помочь при отечности ног, особенно у беременных женщин (см. с. 176 и 248).

Вскипятите большую горсть кукурузных рыльцев в воде и выпейте 1 или 2 стакана. Это не опасно.



ЧЕСНОК

Напиток сделанный из чеснока, может избавить от остриц и поноса.

Мелко растолочь или порубить 4 зубчика чеснока и смешать с 1 стаканом жидкости (воды, сока или молока).

Дозировка: При острицах принимать по 1 стакану ежедневно в течение 3 недель. При поносе пить по 1 стакану каждые 2 часа, пока понос не прекратится.

Для лечения чесноком влагалищных инфекций см. с. 241 и 242.



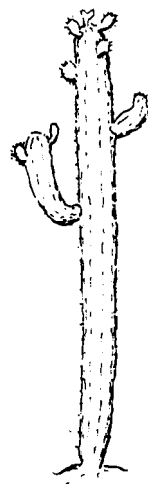
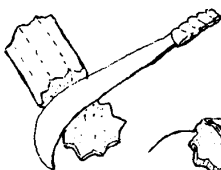
КАКТУС ДРЕВОВИДНЫЙ (*PACHYGERIUS PECTIN-ABORIGINUM*)

Кактусовый сок можно использовать для очистки ран, когда нет кипяченой воды и негде ее достать. Кактус также помогает остановить кровотечение из раны, потому что сок закрывает поврежденные кровеносные сосуды.

Отрежьте кусок кактуса чистым ножом и наложите его прямо на рану.

Когда кровотечение прекратится, привяжите кусочек кактуса к ране полоской ткани.

Через 2-3 часа снимите кактус и промойте рану кипяченой водой с мылом. Более подробные инструкции о том, как обращаться с раной и остановить кровотечение, на с. 82-87.



АЛОЭ ВЕРА (*SABILA*)

Алоэ можно использовать для лечения маленьких ожогов и ран. Густой и липкий сок этого растения успокаивает боль и зуд, способствует заживлению ран и предохраняет от инфекций. Отрежьте кусочек растения, снимите с него кожицу и наложите мякоть листа или выдавите сок прямо на ожог или рану.

Алоэ также помогает лечить язву желудка и гастрит. Разрежьте губчатые листья на маленькие кусочки, залейте их на ночь водой, а затем пейте по 1 стакану липкой, горькой жидкости каждые 2 часа.



ПАПАЙЯ

Зрелые плоды папайи богаты витаминами и помогают пищеварению. Их особенно полезно кушать слабым и пожилым людям, которые жалуются на расстройство желудка, когда едят мясо, кур или яйца. Папайя помогает легче усваивать эту пищу.

Папайя также помогает избавиться от кишечных глистов, хотя современные лекарства помогают лучше. Соберите 3 или 4 чайные ложки (15-20 мл) "молочка", которое выделяется при надрезе зеленых фруктов или ствола дерева. Смешайте это с равным количеством сахара или меда и разведите в чашке с горячей водой. Если возможно, пейте вместе со слабительным или высушите и сотрите в порошок зерна папайи. Принимайте по 3 чайные ложки, смешанные со стаканом воды или небольшим количеством меда, 3 раза в день в течение 7 дней.



Папайю можно использовать также при лечении пролежней. Фрукты содержат химические вещества, способствующие размягчению омертвевшей ткани, которую потом легче удалять. Сначала очистите и промойте пролежень с омертвевшей тканью. Затем смочите стерильную тряпочку или марлю "молочком" из ствола или зеленого фрукта папайи и наложите такую повязку на пролежень. Очищайте пролежень и меняйте повязку 3 раза в день.

КУСТАРНЫЕ ГИПСЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА МЕСТО СЛОМАННЫХ КОСТЕЙ

В Мексике для изготовления гипсов используют несколько различных растений, таких, как *tepeguaje* (дерево из семейства бобовых) и *solda con solda* (огромный древесный выющийся аронник лилейный). Однако годится любое растение, если из него можно приготовить сироп, который при высыхании станет твердым и крепким и не будет раздражать кожу. В Индии костоправы делают гипс, используя смесь яичных белков и трав вместо сиропа из сока растений. Но метод похожий. Испробуйте разные растения в вашей местности.

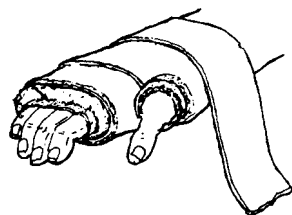
Гипс из *tepeguaje*: 1 кг коры кипятите в 5 л воды до тех пор, пока не останется 2 л. Отвар процедите и кипятите до образования густого сиропа. Полоски из фланели или полотна окуните в сироп и используйте следующим образом.

- Убедитесь в правильном положении костей (с. 98).
- Не накладывайте гипс прямо на кожу.
- Оберните ногу или руку мягкой тканью.
- Затем следует слой ваты или капки.
- Наконец, наложите мокрые полоски ткани, чтобы они образовали гипс твердый, но не тугой.

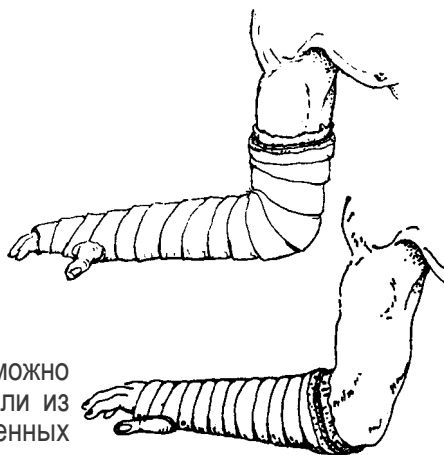


Большинство докторов рекомендуют, чтобы гипс покрывал связки над и под переломом, предохраняя сломанные кости от смещения.

- Это означает, что для сломанного запястья гипс будет покрывать почти всю руку вот так:
- Оставьте кончики пальцев свободными, чтобы вы смогли увидеть, сохраняют ли они нормальный цвет.

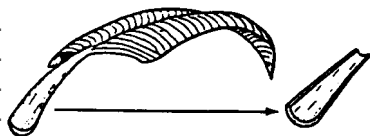


Однако костоправы Китая и Латинской Америки используют короткий гипс при простом переломе руки, считая, что небольшая подвижность концов костей ускоряет лечение. Последние научные исследования доказали, что это правда.



Временную ножную или ручную шину можно сделать из картона, оберточной бумаги или из толстого закрученного черенка высушенных листьев банана или пальмы.

ОСТОРОЖНО: Даже, если гипс не очень тугой, когда вы накладываете его, сломанная конечность может позже опухать. Если человек жалуется, что гипс слишком тугой или если его пальцы или конечности становятся холодными, бледными или синими, снимите гипс и наложите новый, свободнее.

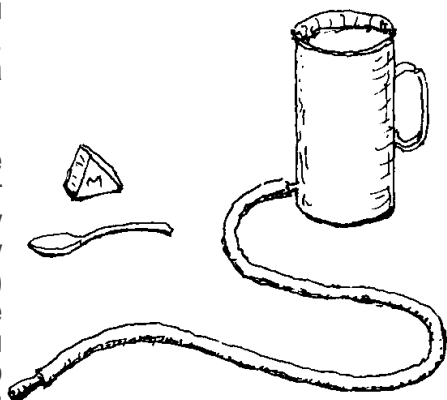


Никогда не накладывайте гипс на рану или порез.

КЛИЗМЫ СЛАБИТЕЛЬНЫЕ И ОЧИЩАЮЩИЕ: КОГДА ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМИ, А КОГДА НЕТ

Многие люди делают клизмы и принимают слабительное очень часто. “Срочная чистка” широко распространена в мире.

Клизмы и очищение — очень популярные домашние средства. Но они часто наносят вред. Многие люди верят, что температуру и понос можно “смыть”, применяя клизму (втекание воды в кишечник через анус) или используя очистительное или сильное слабительное. К сожалению, такие попытки промыть или очистить больное тело часто причиняют больше вреда уже больным кишкам.



Реже применяйте клизмы или слабительные, иногда в этом нет ничего хорошего. Часто они опасны — особенно сильные слабительные.

Случаи, когда Опасно Пользоваться Клизмами или Слабительными

- Никогда не пользуйтесь клизмой или слабительным, если у человека больной кишечник, признаки аппендицита или “острый живот” (см. с. 93), даже если проходят дни без испражнений.
- Никогда не делайте клизму и не давайте слабительное человеку с пулевым ранением или другим повреждением кишечника.
- Никогда не давайте сильное слабительное слабому или больному человеку. Это ослабит его еще больше.
- Никогда не делайте клизму и очищение ребенку меньше двух лет.
- Никогда не давайте слабительное или очистительное ребенку с сильным жаром, при рвоте, поносе или признаках обезвоживания (см. с. 151). Это может повысить обезвоживание и убить ребенка.
- Не привыкайте к частому употреблению слабительного (см. Запор, с. 126).

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИЗМЫ

1. Простые клизмы могут помочь облегчить запор (сухой, твердый стул). Пользуйтесь только теплой водой или водой с малым количеством мыла.

2. Когда человек с сильной рвотой обезвожен, вы можете заменить воду, деля ему клизму из регидрона очень медленно (см. с. 152).

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ И СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЮТСЯ

КАСТОРОВое МАСЛО ЛИСТ СЕННЫ КОРА ХИННОГО ДЕРЕВА (cascara sagrada)	Это раздражающие очистительные средства, которые часто приносят больше вреда, чем пользы. Лучше не пользоваться ими.
КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ МОЛОКО МАГНЕЗИИ ГОРЬКАЯ СОЛЬ (сульфат магнезия) (см. с. 383)	Это солевые очистительные средства. Пользуйтесь ими только в малых дозах, как слабительные средства, при запорах. Не пользуйтесь ими часто, и никогда при болях в животе.
МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО (см. с. 383)	Этим средством иногда пользуются от запора люди с геморроем, но оно подобно стремительно проходящим камням. Не рекомендуется.

ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛАБИТЕЛЬНЫМИ И ОЧИСТИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Слабительные подобны очистительным, но слабее. Все вещества, перечисленные выше, являются слабительными, когда берутся в малых дозах, и очистительными, когда взяты в больших дозах. Слабительные смягчают и ускоряют опорожнение кишечника, очистительные вызывают понос.

Очистительные средства: В единственном случае человек должен воспользоваться сильной дозой очистительного, когда он принял яд и должен быстро от него освободиться (см. с. 105). В любых других случаях очистительное вредно.

Слабительные средства: Можно использовать молоко магнезии или другие соли кальция в малых дозах, как слабительные, в некоторых случаях запора. Люди с геморроидальными шишками (геморрой, с. 75), страдающие запором, могут применять минеральное масло, но это средство сделает стул скользким, но не размягчает его. Доза минерального масла: от 3 до 6 чайных ложек перед сном (никогда не во время еды, потому что масло отбирает у организма важные витамины, содержащиеся в пище). Это не лучший способ.

Свечи, или пулеподобные шарики, которые можно вставить в прямую кишку, тоже можно использовать для облегчения запора или геморроя (см. с. 175, 383 и 392).

ЛУЧШИЙ СПОСОБ

Пища с волокнами. Самый здоровый и наиболее легкий способ иметь более мягкий и частый стул — это пить много воды и есть больше пищи с натуральным волокном или “грубой пищи” типа капусты, свеклы или отрубей (оболочка зерен пшеницы) и других зерновых злаков (см. с. 126). Очень помогает обильное питание фруктами, овощами.

Люди, которые традиционно едят пищу с натуральным волокном, намного реже страдают геморроем, запорами и раком кишечника, чем те, которые употребляют много рафинированных “современных” продуктов. Для улучшения работы кишечника избегайте рафинированных продуктов и кушайте еду, приготовленную из неполированного и неочищенного зерна.

Болезни, Которые Часто Путают

ГЛАВА

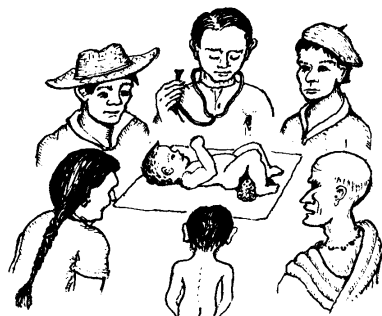
2

В ЧЕМ ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ?

Люди из разных местностей и разного происхождения по-своему объясняют, что является причиной болезни.

У ребенка понос. А почему?

Люди из маленьких деревень могут сказать, что это родители ведут себя неправильно или они разозлили бога или духа.



Врач может сказать, что у ребенка инфекция.

Народный целитель может сказать, что сельчане не имеют хорошей системы водоснабжения или не пользуются уборной.

Общественный деятель может сказать, что нездоровые условия, приводящие к частым детским поносам, вызваны несправедливым распределением земли и богатств.

Учитель сведет вину к недостатку образования.

Люди судят о причине болезни с точки зрения собственного опыта и своих взглядов на жизнь. Кто же тогда прав, говоря о причинах? Наверное, прав или частично прав каждый. Это потому, что...

Болезнь — это результат многих причин.



Почему мой ребенок?

Каждая из причин, предложенных выше, может быть частью главной причины, вызывающей у ребенка понос?

Для предупреждения и успешного лечения болезни необходимо как можно больше знать о типичных болезнях в вашей местности и о сочетании причин, которые вызывают их.

В этой книге обсуждаются различные болезни с точки зрения современной или научной медицины.

Чтобы лучше использовать эту книгу и безопасно применять лекарства, которые рекомендуют, вам понадобится некоторое понимание болезней и их причин в соответствии с медицинской наукой. Чтение этой главы может помочь.

РАЗЛИЧНЫЕ БОЛЕЗНИ И ИХ ПРИЧИНЫ

При обсуждении вопроса о профилактике или лечении различных болезней помогает разделение их на 2 группы: инфекционные и неинфекционные.

Инфекционные болезни — это те, которые передаются от одного человека к другому. Здоровым людям необходимо предохраняться от этих болезней.

Неинфекционные болезни не передаются от одного человека к другому. Они имеют другие причины. Поэтому важно знать, какая болезнь инфекционная, а которая нет.

Неинфекционные Болезни

Неинфекционные болезни имеют много различных причин. Но они никогда не вызываются микробами, бактериями или другими живыми организмами, которые проникают в тело человека. Они никогда не передаются от одного человека к другому. Важно понять, что антибиотики, или лекарства, которые борются с микробами (см. с. 55), не помогают при лечении неинфекционных болезней.

Запомните: антибиотики нельзя использовать при неинфекционных заболеваниях.

ПРИМЕРЫ НЕИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Болезни, которые изнуряют или разрушают организм: ревматизм сердечный приступ припадок эпилепсии паралич мигрень катаракта рак	Болезни, которые причиняют вред и рассаживают организм: аллергия астма отравления укус змей кашель от курения язва желудка алкоголизм	Болезни, вызванные ограничением потребностей организма: недоедание анемия пеллагра куриная слепота и ксерофтальмия зоб и кретинизм цирроз печени (частично)
Врожденные болезни		Болезни, связанные с психикой (психические болезни)
заячья губа косой или с бельмом глаз (косоглазие) другие деформации	эпилепсия (некоторые виды) задержка в развитии детей (отсталость) родимые пятна	беспочвенный сахар (паранойя) нервные травмы (беспокойство) вера в магию (колдовство) неконтролируемый сахар

Инфекционные Болезни

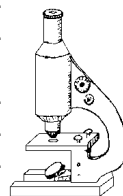
Инфекционные болезни вызываются бактериями и другими живыми организмами, которые вредят человеку. Они распространяются различными способами. Вот некоторые, самые важные виды организмов, которые вызывают инфекцию, и примеры болезней, которые они вызывают:

ПРИМЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Организм, что вызывает болезнь	Название болезни	Как передается или проникает в организм	Основные лекарства
бактерии (микробы или бациллы)	туберкулез	через воздух (кашель)	различные антибиотики от разных бактериальных инфекций
	столбняк	грязные раны	
	понос	грязные пальцы, вода, мухи	
	пневмония (некоторые виды)	через воздух (кашель)	
	гонорея, хламиди и сифилис	половым путем	
	ушная боль	от простуды	
	инфицированные раны	контакт с грязными вещами	
	гнойные раны	прямой контакт (прикосновение)	
вирус (микробы меньше, чем бактерии)	простуды, грипп, корь, свинка, ветрянка, детский паралич, вирусный понос	от больного через воздух, кашель, мухи и т.д.	аспирин и другие болеутоляющие (Нет лекарств, которые эффективно борются с вирусами. Антибиотики не помогают.) Вакцинация предупреждает некоторые вирусные инфекции.
	бешенство	укусы животных	
	бородавки	прикосновение	
грибки	микроспория	прикосновением или от одежды	серная мазь, микозолон
	грибковое заболевание ног чесотка		
внутренние па-разиты (вредные животные в теле человека)	В кишках: глисты амебы (дизентерия)	Когда кал попадает в рот, недостаток чистоты	различные особые лекарства хлорохин, Делагил, Хингамин(или другие лекарства от малярии)
	В крови: малярия	укусы	
внешние паразиты (вредные животные, живущие в теле)	вши блохи клопы чесотка	контакт с инфицированными больными или с их одеждой	инсектициды, линдан

Бактерии, как и многие организмы, вызывающие инфекции, настолько малы, что их нельзя увидеть без микроскопа — инструмента, который увеличивает крошечные предметы. Вирусы еще меньше, чем бактерии.

Антибиотики (пенициллин, тетрациклин и др.) — лекарства, которые помогают при лечении определенных болезней, вызываемых бактериями. Антибиотики не оказывают никакого эффекта при болезнях, причиной которых являются вирусы, такие как простуда, грипп, свинка, ветрянка и т.д. Не лечите вирусные инфекции антибиотиками. Они не помогут, а навредят (см. Антибиотики, с. 57).

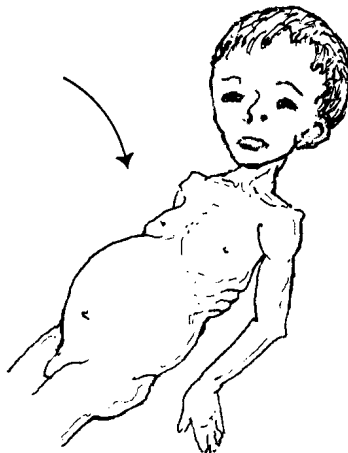


БОЛЕЗНИ С ОДИНАКОВЫМИ СИМПТОМАМИ

Иногда болезни, которые имеют различные причины и требуют различного подхода к лечению, выглядят очень похожими. Например:

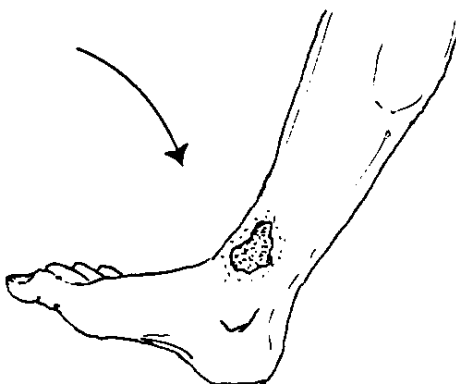
1. У ребенка, который постепенно худеет и чахнет, тогда как его живот все сильнее раздувается, одна (или несколько) следующих болезней:

- недоедание (см. с. 112);
- большое количество глистов (обычно вместе с недоеданием) (см. с. 140);
- запущенный туберкулез (см. с. 179);
- хроническая, тяжелая инфекция мочевых путей (см. с. 234);
- некоторые осложнения печени или селезенки;
- лейкемия (рак крови).



2. У пожилого человека с большой, открытой, медленно растущей раной на лодыжке может быть:

- плохое кровообращение, которое является результатом варикозных вен или других причин (с. 213)
- диабет (см. с. 127)
- инфекция костей (остеомиелит)
- проказа (см. с. 131)
- туберкулез кожи (см. с. 212)
- запущенный сифилис (см. с. 237)



Медицинское лечение каждой из этих болезней разное, поэтому чтобы лечить их правильно, очень важно рассматривать их по отдельности.

Многие болезни сначала кажутся похожими. Но если вы зададите правильные вопросы и узнаете то, что требуется, вы сможете получить информацию о признаках, помогающих определить, какая болезнь у человека.

Эта книга описывает типичные истории и признаки многих болезней. Но будьте осторожны! Не всегда проявляются описанные признаки. В трудных случаях помощь профессионального работника или врача необходима. Иногда необходимо провести специальные тесты и анализы.

**Работайте в пределах своих знаний!
Пользуясь этой книгой, помните, что легко сделать ошибки. Никогда не претендуйте на то, что вы не можете. Если вы не совсем уверены, что за болезнь и как ее лечить, или если болезнь очень серьезная — получите медицинскую помощь.**

БОЛЕЗНИ, КОТОРЫЕ ЧАСТО ПУТАЮТ ИЛИ КОТОРЫМ ДАЛИ ОДИНАКОВОЕ НАЗВАНИЕ

Многие обычные названия болезней были впервые использованы людьми надолго до того, как стало известно о микробах или бактериях и о лекарствах для борьбы с ними. Различным болезням, которым создавали более или менее похожие проблемы — таким как “сильный жар” или “боль в боку” — часто давали одинаковое название. В различных частях света этими обычными названиями еще продолжают пользоваться. Городские врачи часто не знают или не используют эти названия. Поэтому люди иногда думают, что они относятся к “болезням, которые врачи не умеют лечить”. Тогда они лечат эти домашние болезни травами или домашними средствами.

В действительности большинство из этих домашних или “народных болезней” хорошо известно медицинской науке. Только они имеют другие названия.

При многих болезнях хорошо помогают домашние средства. Но некоторые болезни намного лучше лечить современными медицинскими препаратами. Это особенно справедливо для таких опасных инфекций, как пневмония, брюшной тиф, туберкулез или послеродовые инфекции.

Чтобы узнать, при каких болезнях действительно необходимы современные медикаменты и решить, какие препараты применять, важно выяснить, что это за болезнь с точки зрения квалифицированных медработников и этой книги.

Если вы не сможете найти болезнь, просматривая эту книгу, поищите ее под другим названием или в главе, где рассматривается похожая проблема. Используйте ОГЛАВЛЕНИЕ и ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Если вы не уверены в том, какая это болезнь — особенно, если она кажется серьезной — постарайтесь получить медицинскую помощь.

В конце этой главы приведены примеры общих или традиционных названий, которые люди используют для обозначения различных болезней. Часто одно и то же название дается болезням, которые согласно медицинской науке отличаются друг от друга.

Эти примеры невозможно привести для каждой саны или местности, где может использоваться эта книга. Поэтому я привожу примеры из испанского издания этой книги с теми названиями, которыми пользуются сельские жители Западной Мексики. Эти названия будут не такими, какими пользуетесь вы. Однако люди во многих частях света думают и говорят о своих болезнях таким же образом. Так что эти примеры помогут вам вспомнить, как люди называют болезни в вашей местности.

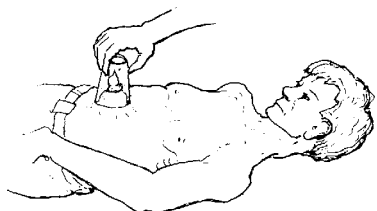
Можете ли вы вспомнить названия, которыми пользуются люди для нижеследующих “народных болезней”? Если сможете, напишите их после испанского названия, где говорится.

Название в Вашей местности: _____

ПРИМЕРЫ МЕСТНЫХ НАЗВАНИЙ БОЛЕЗНЕЙ

Испанское название: **ЕМРАЧНО (ЗАСОРЕНИЕ КИШОК)**

Название в Вашей местности: _____



Медицинский термин *етрачо* (ущемление) означает, что кишки закупорились или засорились (см. с. 34). Но в мексиканских деревнях любую болезнь, вызывающую рези в животе или понос, можно назвать *етрачо*. Говорят, что клубок волос или что-то еще блокирует часть кишок. Люди сваливают вину на ведьм или злых духов и лечат магическими средствами и банками (см. рисунок). Иногда народные целители делают вид, что удаляют клубок волос или колючек из кишок, высасывая его из живота.

Различные болезни, которые вызывают боль в желудке или дискомфорт, которые иногда называют *empacho*, следующие:

- понос или дизентерия с судорогами (с. 153)
- глисты (с. 140)
- опухший живот из-за недоедания (с. 112)
- расстройство или язва желудка (с. 128)
- и редко настоящее засорение кишок или аппендицит (с. 94)

Большинство этих болезней не поддается магическому лечению или лечению банками. Для лечения *empacho* попытайтесь определить и лечить болезнь, которая является его причиной.

Испанское название: **DOLOR DE IJAR (БОЛЬ В БОКУ)**

Название в Вашей местности: _____

Этим названием пользуются для любой боли, которую ощущают женщины в каком-то месте живота. Часто боль отдается в среднюю или нижнюю часть спины. Возможные причины такой боли:

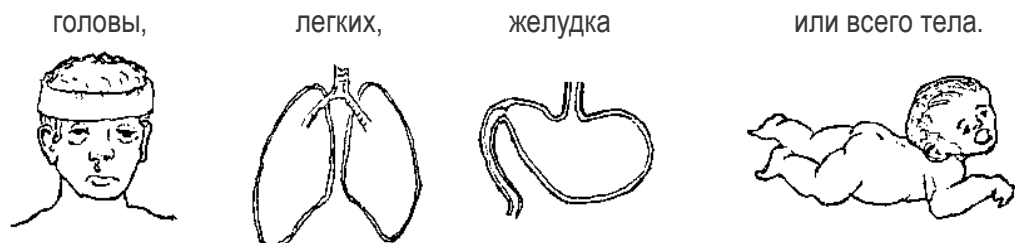
- инфекция мочеполовой системы (почки, мочевого пузыря или соединяющие их трубы, см. с. 234);
- судороги или боли вследствие скопления газов (см. понос, с. 153);
- боли во время месячных (см. с. 245);
- аппендицит (см. с. 94);
- инфекция, киста или опухоль в матке или в яичниках (с. 243) или внематочная беременность (см. с. 280).



Испанское название: **LA CONGESTION (ЗАСТОЙ)**

Название в Вашей местности: _____

Любые внезапные душевные расстройства или болезни, которые вызывают сильное недомогание, в мексиканских деревнях называют *la congestion*. Люди говорят о *la congestion*



Говорят, что *la congestion* поражает людей, когда они нарушают “диету” (см. с. 123), употребляя пищу, которая запрещена, после рождения ребенка, принимая лекарства, или же когда они простужаются или кашляют. Хотя эти продукты обычно не причиняют вреда и иногда в них нуждается организм, многие люди не трогают их, потому, что боятся получить *la congestion*.

Различные болезни, которые называют иногда *la congestion*:

- Пищевое отравление испорченными продуктами вызывает внезапную рвоту с последующим поносом, судорогами и слабостью (см. с. 135).
- Тяжелая аллергическая реакция у людей, страдающих аллергией после употребления некоторых продуктов (устрицы, шоколад и т.д.), принятия некоторых лекарств или инъекций пенициллина. Может вызвать рвоту, понос, холодный пот, затрудненное дыхание, зудящую сыпь и тяжелое недомогание (см. с. 166).
- Любое внезапное расстройство желудка или кишечника: см. понос (с. 153), рвота (с. 161) и “острый живот” (с. 93).
- Внезапное или серьезное затруднение дыхания вызывается астмой (с. 167), пневмонией (с. 171) или чем-то, застрявшим в горле (с. 79).
- Болезни, которые вызывают припадки или паралич: см. припадки (с. 178), столбняк (с. 182), менингит (с. 185), полиомиелит (с. 314) и паралич (с. 327).
- Сердечные приступы: большей частью у пожилых людей (с. 325).

Испанское название: **LATIDO (ПУЛЬСАЦИЯ)**

Название в Вашей местности: _____

Latido - название, которым пользуются в Латинской Америке для обозначения пульсации или “подергивания” в подложечной ямке. Это действительно пульс аорты, или большого кровеносного сосуда, идущего от сердца. Этот пульс можно увидеть и ощутить у человека, который очень худой и голодный. *Latido* - это часто признак недоедания (с. 112) или голода! Единственное реальное лечение — хорошее питание (с. 110).

Испанское название: **SUSTO (ИСТЕРИЯ, СТРАХ)**

Название в Вашей местности: _____

Согласно мнению мексиканских сельчан *susto* вызывается внезапным испугом человека или колдовством, черной магией или злыми духами. Человек с *susto* очень нервный и боязливый. Он может дрожать, странно вести себя, не может спать, теряет в массе и даже умирает.

Возможные медицинские объяснения для *susto*:

1. У многих людей *susto* — это состояние страха или истерии, возможно вызванное “силой веры” (см. с. 4). Например, женщина, которая боится, что кто-то околдует ее, становится нервной, не ест и плохо спит. Она начинает слабеть, теряет в массе. Она воспринимает все это как знак того, что ее околдовали, поэтому становится еще более нервной и напуганной. Ее *susto* становится сильнее и сильнее.
2. У младенцев или маленьких детей *susto* обычно совсем другое. Плохие сны заставляют детей кричать, просыпаться от испуга. Сильный жар при любой болезни может вызвать странную речь и поведение (бред). Истощенный ребенок часто выглядит и действует беспокойно (с. 112). Иногда ранние признаки столбняка (с. 182) или менингита (с. 185) тоже называются *susto*.

Лечение:

Когда *susto* вызвано специфической болезнью, лечите эту болезнь. Помогите человеку понять ее причину. Если требуется, обратитесь за медицинской помощью.

Когда *susto* вызвано испугом, попытайтесь успокоить человека и помочь ему понять, что его страх — причина его проблемы. Магическое лечение и домашние средства иногда помогают.

Если испуганный человек дышит тяжело и быстро, его организм получает слишком много воздуха, который и может быть частью проблемы.

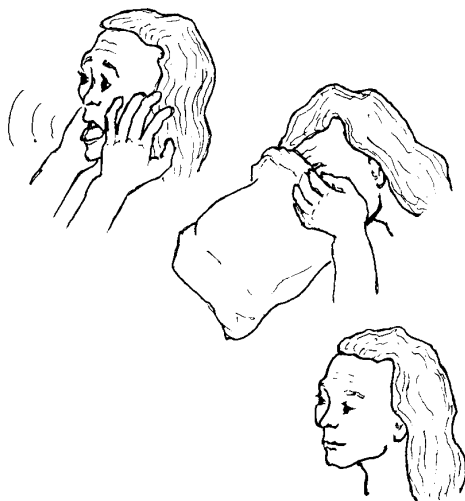
СИЛЬНЫЙ ИСПУГ ИЛИ ИСТЕРИЯ С УЧАЩЕННЫМ ДЫХАНИЕМ (ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИЯ)

Признаки:

- человек сильно испуган;
- дыхание частое и глубокое;
- частое, сильное сердцебиение;
- оцепенение или покалывание лица, рук или ног;
- мышечные судороги.

Лечение:

- Успокойте человека, насколько это возможно.
- Опустите его лицо в бумажный пакет и заставьте медленно дышать. Пусть подышит этим воздухом 2 или 3 минуты. Обычно это успокаивает.
- Объясните ему, что проблема неопасная и ему скоро будет лучше.



НЕДОРАЗУМЕНИЯ ИЗ-ЗА ПУТАНИЦЫ В НАЗВАНИЯХ

На этой санице показаны 2 примера недоразумений, когда такие названия, как “рак” и “проказа”, означают одно для медиков и другое для сельских жителей. В разговоре с медицинскими работниками - и при использовании этой книги:

Избегайте недоразумений — следуйте признакам и истории болезни человека, а не названию болезни, которое ей дали люди.

Испанское название: **CANCER (ПАК)**

Название в Вашей местности: _____

Мексиканские сельчане употребляют слово рак для любой тяжелой кожной инфекции, особенно для сильно инфицированных ран (с. 88) или гангрены (см. с. 213).

В современной медицине рак — не инфекция, а аномальное новообразование или опухоль в любой части тела. Обычные разновидности рака, с которыми сталкиваются:

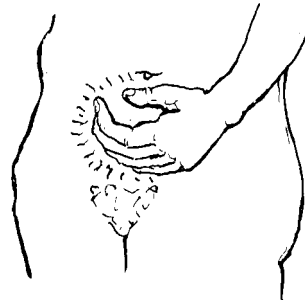
рак кожи (см. с. 211)



рак груди (см. с. 279)



рак матки или яичников (с. 280)



Плотная, болезненная, медленно растущая опухоль в любой части тела может быть раком. Рак опасен и нуждается в хирургическом вмешательстве. При первых подозрениях на рак обратитесь за медицинской помощью.

Испанское название: **LEPRA (ПРОКАЗА)**

Название в Вашей местности: _____

Сельчане Мексики любую открытую растущую рану называют lepra. Это приводит к путанице, потому что медработники используют этот термин только для настоящей проказы (болезнь Хансена, с. 181). Раны, обычно называемые lepra:

- импетиго и другие кожные инфекции (с. 202);
- раны от укусов насекомых или чесотка (с. 199);
- хронические раны или язвы кожи, вызванные плохим кровообращением (с. 213);
- рак кожи (с. 211);
- иногда проказа (с. 131) или туберкулез кожи (с. 212).



У ребенка импетиго, а не лепра.

ПУТАНИЦА МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ, ВЫЗЫВАЮЩИМИ ЖАР

Испанское название: **LA FIEBRE (ЖАР)**

Название в Вашей местности: _____

Правильно выражаясь, жар — это температура тела выше, чем нормальная. Но в Латинской Америке целый ряд серьезных болезней, при которых у человека повышается температура, называют la fiebre или “лихорадка”.

Чтобы предупредить или успешно лечить эти болезни, очень важно знать, как отличить одну от другой.

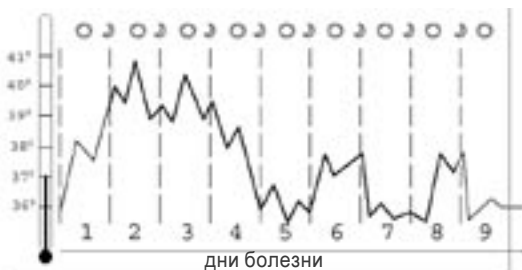
Приведем несколько острых заболеваний, при которых жар — основной признак. На рисунках показаны температурные кривые (рост и падение температуры), которые типичны для каждой из этих болезней.



Малярия: (см. с. 186)

Начинается со слабости, озноба и жара. Жар может держаться в течение нескольких дней с дрожью (ознобом), когда температура поднимается, и потливостью, когда она падает. Затем температура может подниматься на несколько часов через каждые два или три дня. В другие дни человек может чувствовать себя более или менее хорошо.

МАЛЯРИЯ-ТИПИЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ КРИВАЯ



БРЮШНОЙ ТИФ - ТИПИЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ КРИВАЯ

жар усиливается с каждым днем

Брюшной тиф: (см. с. 188)

Начинается как простуда, температура поднимается понемногу каждый день. Пульс относительно медленный (спокойный). Иногда понос и обезвоживание. Дрожь и бред (кошмары). Человек очень болен.



Сыпной тиф: (см. с. 190)

Похож на брюшной тиф. Сыпь похожа на корьевую с крошечными синяками.

ГЕПАТИТ - ТИПИЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ КРИВАЯ

обычно небольшой жар

Гепатит: (см. с. 172)

Человек теряет аппетит. Не хочется есть или пить. Тошнота. Глаза и кожа становятся желтыми; моча оранжевая или коричневая; стул беловатый. Печень увеличивается и появляется боль. Небольшой жар. Человек очень слабый.



Пневмония: (см. с. 171)

Частое, неглубокое дыхание. Температура поднимается бысo. Кашель с зеленой, желтой или кровавой слизью. Может быть боль в груди. Человек очень болен

Суставной ревматизм: (см. с. 310)

Чаще всего бывает у детей и подростков. Боль в суставах. Высокая температура. Чаще появляется после ангины. Может быть боль в груди с одышкой. Неуправляемые движения рук и ног.

Бруцеллез (волнообразная лихорадка, мальтийская лихорадка): (см. с. 188)

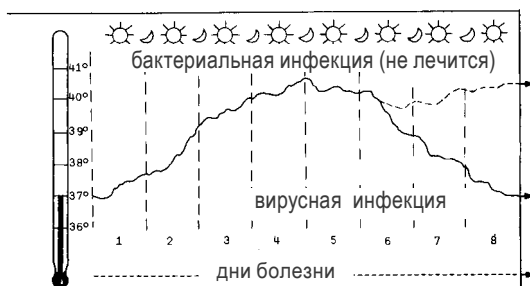
Н а ч и н а е т с я медленно с усталости, головной боли и боли в костях. Жарипотливость, восновном ночью. Жар исчезает, чтобы через несколько дней вернуться снова. Это может продолжаться месяцы или годы

Родильная горячка: (см. с. 276)

Начинается через день или более после родов. Начинается с легкого жара, который позже часто усиливается. Плохо пахнущие выделения из влагалища. Боль и иногда кровотечение.

Все эти болезни могут быть опасными. В дополнение к вышесказанному существует много других болезней (особенно в тропических странах), которые могут вызывать подобные признаки и жар. Об этих болезнях не всегда легко говорить по отдельности. Большинство из них серьезные и опасные. Когда возможно - обратитесь за медицинской помощью.

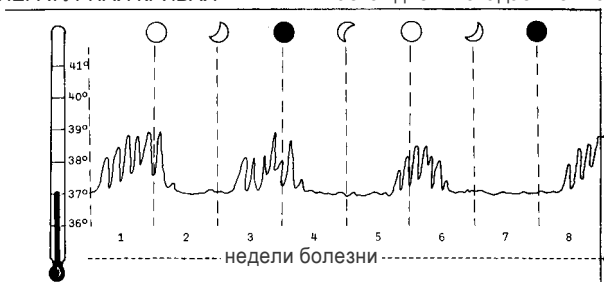
ПНЕВМОНИЯ-ТИПИЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ КРИВАЯ



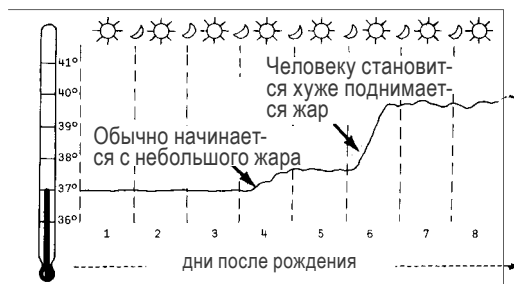
СУСТАВНОЙ РЕВМАТИЗМ-ТИПИЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ КРИВАЯ



БРУЦЕЛЛЕЗ - ТИПИЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ КРИВАЯ



ПОСЛЕРОДОВАЯ ГОРЯЧКА - ТИПИЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ КРИВАЯ



КАК ОСМАТРИВАТЬ БОЛЬНОГО

Чтобы узнать, что надо больному человеку, сначала вы должны расспросить его, а затем тщательно осмотреть. Вам следует найти признаки и симптомы, которые помогут сказать, насколько болен человек и что за болезнь может быть у него.

Всегда осматривайте человека при хорошем освещении, предпочтительно при солнечном свете; **никогда** — в темной комнате.

Есть определенные вещи, о которых надо расспросить, и найти их в том, кто болен. Сюда входят ощущения больного или жалобы (симптомы), а также то, **что вы заметили**, когда осматривали его (признаки). Эти признаки могут быть особенно важны для детей и людей, которые не могут говорить. В этой книге слово “признак” используется и для симптомов, и для признаков.

Когда вы осматриваете больного человека, записывайте ваши выводы и храните их для работника здравоохранения на тот случай, если они ему понадобятся (см. с. 44).

ВОПРОСЫ

Начните с расспросов о болезни. Непременно спросите следующее:

- Что вас беспокоит больше всего сейчас?
- Что заставляет вас чувствовать себя лучше или хуже?
- Как и когда началась ваша болезнь?
- Была ли у вас такая же болезнь прежде, или болел ли кто-нибудь из вашей семьи или из соседей?

Продолжайте задавать другие вопросы, чтобы узнать подробности о болезни.

Например, если у человека боль, спросите его:

- Где болит? (Попросить его показать поточнее место пальцем.)
- Болит постоянно или временами?
- Какая боль? (Резкая? Тупая? Жгучая?)
- Можете ли вы спать с болью?



Если болеет младенец, который не может говорить, ищите признаки боли. Замечайте его движения и как он плачет. (Например, ребенок с ушной болью иногда трется этой стороной головки или тянет за свое ухо).

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Прежде чем трогать больного человека, посмотрите на него внимательно. Понаблюдайте, насколько больным и слабым он выглядит, как он двигается, как он дышит, насколько ясен его ум. Поищите признаки обезвоживания (см. с. 151) и шока (с. 77).

Обратите внимание на то, хорошо или плохо человек кушает. Потерял ли он в весе? Когда человек теряет вес медленно в течение долгого времени, у него может быть хроническое заболевание (которое долго тянется).

Еще обратите внимание на цвет кожи и глаз. Когда человек заболевает, они иногда меняются. (Темная кожа может скрыть изменения цвета. Поэтому осмотрите те части тела, где кожа бледная, такая как на ладонях рук или подошвах ног, на ногтях пальцев или на внутренней поверхности губ или век.)

- Бледность, особенно губ и внутри век - признак анемии (с. 124). Кожа может светлеть в результате туберкулеза (см. с. 179) или квашиоркора (с. 113).
- Потемнение кожи может быть признаком голодания (см. с. 112).
- Синева кожи, особенно синева и потемнение губ и ногтей пальцев, может быть вызвана серьезными проблемами с дыханием (с. 79, 167 и 313) или с сердцем (с. 325). Синевато-серый цвет у ребенка без сознания может быть признаком церебральной малярии (с. 186).
- Серо-белый цвет у холодной влажной кожи часто означает, что человек в шоке (с. 77).
- Желтый цвет (желтуха) кожи и глаз - результат болезней печени (гепатит, с. 172, или цирроз, с. 328, амёбный абсцесс, с. 145) или желчного пузыря (с. 329). Такой цвет может быть у новорожденных (с. 274) и у детей, рожденных с малокровием с серповидным изменением эритроцитов (с. 321).

Посмотрите также на кожу, когда свет падает на нее с одной стороны. Это поможет обнаружить ранний признак корьевой сыпи на лице ребенка с температурой (с. 311).

ТЕМПЕРАТУРА

Весьма благоразумно измерить у больного человека температуру, даже если ему кажется, что жара нет. Если же человек очень болен, измеряйте температуру по крайней мере 4 раза в день и записывайте ее.



Если у вас нет термометра, вы можете определить температуру, положив тыльную сторону ладони одной руки на лоб больного человека, а другой — на свой лоб или на лоб любого здорового человека. Если у больного человека жар, вы должны чувствовать разницу.

Важно определить, когда и как жар начинается, как долго держится и как падает. Это сможет помочь идентифицировать болезнь. Не всякая лихорадка - малярия, хотя в некоторых сахах ее лечат как малярию. Запомните другие возможные причины.

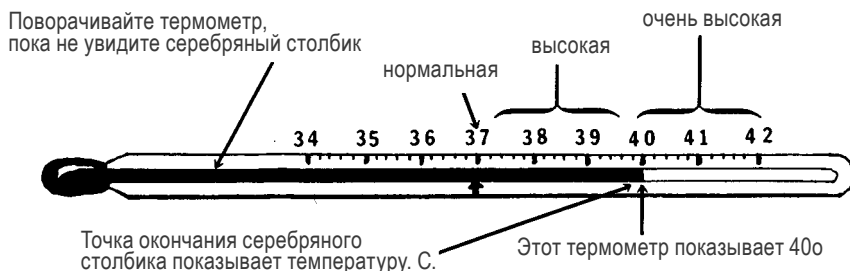
Например:

- Обычная простуда и другие вирусные инфекции (с. 113). Жар обычно умеренный. Брюшной тиф вызывает жар, который поднимается постепенно в течение 5 дней. При малярии лекарства не помогают.
- Туберкулез иногда является причиной умеренного жара днем. Ночью человек часто потеет и жар падает.

Как Пользоваться Термометром

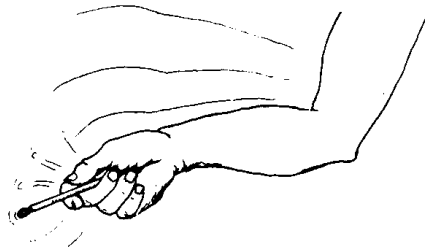
Каждая семья должна иметь термометр. Измерять температуру больного 4 раза в день и всегда записывать ее.

Как прочесть показания термометра (используется стоградусная шкала — °C)



Как измерять температуру:

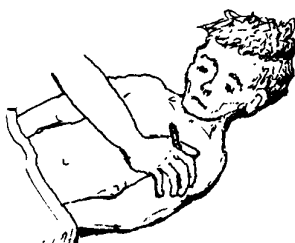
1. Вымойте хорошо термометр водой с мылом или спиртом. Сяхните его сильно кистью руки, пока столбик не упадет ниже 36 градусов.
2. Положите термометр:



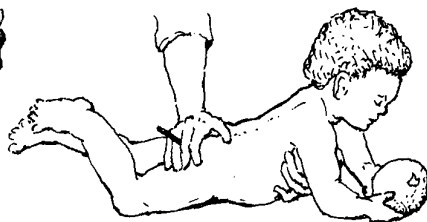
под язык (держите рот закрытым)



под мышку, если опасаетесь прокусить его



осторожно в анус маленького ребенка (намочите или смажьте его сначала)



3. Оставьте его на 3 или 4 минуты.
4. Прочтите показания. (Подмышечная температура будет чуть ниже, чем во рту, а в анусе будет немного выше).
5. Хорошо вымойте термометр хорошо водой с мылом.

Примечание: у новорожденных младенцев необычно высокая температура или необычно низкая (ниже 36°) означает серьезную инфекцию (см. с. 375).

- ♦ Чтобы узнать о графиках температур, (см. с. 26 и 27).
- ♦ Чтобы узнать, что делать при повышенной температуре (см. с. 75).

ДЫХАНИЕ (РЕСПИРАЦИЯ)

Обратите особое внимание на дыхание больного - глубину (глубокое или неглубокое), интенсивность (как часто делаются вдохи) и трудность. Проследите, равномерно ли вздымаются обе стороны груди при дыхании.

Если у вас есть часы или простой таймер, сосчитайте количество вдохов в минуту (когда человек спокоен). До 12-20 вдохов в минуту – это нормально для взрослых и детей постарше. До 30 вдохов в минуту нормально для людей и до 40 – для младенцев. Люди с высокой температурой или серьезным респираторными заболеваниями (как пневмония) дышат чаще, чем обычно. Более 40 неглубоких вдохов в минуту для взрослых или более 60 для маленьких детей обычно означают пневмонию.

Слушайте внимательно звуки дыхания. Например:

- Свист или хрип и затрудненное дыхание могут означать астму (см. с. 267).
- Бульканье или храп и затрудненное дыхание в бессознательном состоянии могут означать, что язык, мокрота (слизь или гной) или что-нибудь еще застряло в горле и не пропускает достаточно воздуха.

Поищите “засосы” на коже между ребрами и у изгиба шеи (позади ключицы), когда человек делает вдох. Это означает, что доступ воздуха в легкие затруднен. Возможно, что-то застряло в горле (с. 79), либо пневмония (с. 171), астма (с. 167) или бронхит (слабое втягивание, см. с. 170).

Если у человека кашель, спросите, беспокоит ли он во время сна. Выясните, есть ли мокрота при кашле, как много, ее цвет и есть ли в ней кровь.

ПУЛЬС (СЕРДЦЕБИЕНИЕ)

Чтобы сосчитать пульс у человека прикоснитесь пальцами к запястью, как показано. (Для счета пульса не пользуйтесь большим пальцем.)



Если вы не можете найти пульс на запястье руки, поищите его на шее за голосовыми связками,



или приложите ухо прямо на грудь и слушайте сердцебиение (или используйте стетоскоп, если у вас он есть).



Обратите внимание на силу, частоту и регулярность пульса. Если у вас есть часы или таймер, сосчитайте пульс в минуту.

НОРМАЛЬНЫЙ ПУЛЬС ДЛЯ ЛЮДЕЙ В СПОКОЙНОМ СОСТОЯНИИ:

взрослые	от 60	до 80 ударов в минуту
дети	от 80	до 100 ударов в минуту
младенцы	от 100	до 140 ударов в минуту

Пульс учащается при физических упражнениях и тогда, когда человек нервничает, напуган или у него жар. Как правило, пульс увеличивается на 20 ударов в минуту на каждый градус (по Цельсию) повышения температуры.

Когда человек очень болен, измеряйте пульс почаще и записывайте его вместе с температурой и частотой дыхания.

Очень важно отмечать изменения частоты пульса. Например:

- Слабый частый пульс может означать состояние шока (см. с. 77).
- Очень частый, очень медленный, или неравномерный пульс может означать перебои с сердцем (см. с. 325).
- Относительно медленный пульс у человека с сильным жаром может быть признаком брюшного тифа (см. с. 188).

ГЛАЗА

Посмотрите на цвет белков глаз. Нормальный, красный (с. 219) или желтый? Отметьте изменения во взгляде больного человека.

Пусть человек поднимает и опускает глаза или смотрит из стороны в сторону. Дергающееся или неровное движение может быть признаком болезни мозга.

Обратите внимание на размер зрачков (черное “окно” в середине глаза). Если они большие, это может означать состояние шока (см. с. 77). Если они очень большие или очень маленькие, это означает отравление или воздействие определенного медикамента.

Посмотрите оба глаза и отметьте какую-нибудь разницу между ними, особенно в размерах зрачков:



Большая разница в размерах зрачков почти всегда означает, что нужна срочная медицинская помощь.

- Если глаз с большим зрачком болит настолько сильно, что вызывает рвоту, у человека может быть ГЛАУКОМА (см. с. 222).
- Если глаз с меньшим зрачком болит достаточно сильно, у человека может быть ИРИТ — очень серьезная болезнь (см. с. 221).
- Разница в размерах зрачков у человека в бессознательном состоянии или у того, кто перенес недавно травму головы, может означать повреждение мозга. Это может также означать УДАР (см. с. 327).

Всегда сравнивайте зрачки человека в бессознательном состоянии или того, кто перенес травму черепа.

УШИ, ГОРЛО, НОС

Уши: Всегда проверяйте на признаки боли и инфекции в ушах — особенно у ребенка при жаре или простуде. У младенца, плачущего, когда трогаешь или тянешь его за ухо, может быть инфекция уха (с. 309).

Осторожно потяните за ушко. Если это усиливает боль, инфекция возможна в трубе уха (ушной канал). Посмотрите на красноту или нарыв внутри уха. Вам поможет электрический или ручной фонарик. Но никогда не засовывайте в ухо палочку, проволоку или другой твердый предмет.

Узнайте, хорошо ли слышит человек или одно ухо слышит хуже другого. Пощелкайте пальцами возле уха, чтобы увидеть слышит человек или нет. (О глухоте и звоне в ушах прочтите на с. 327.)

Горло и рот: При помощи электрического фонарика или солнечного света осмотрите рот и горло. Чтобы сделать это, придавите язык ручкой ложки или заставьте человека произнести “а а ...” Посмотрите, красное ли горло, не опухли ли миндалины (2 бугорка на задней части горла) или есть нарывы (см. с. 309). Обследуйте также рот, нет ли там болячек, воспаленных десен, болезненного языка, гнилых и абсцессных зубов и других проблем. (Читайте Главу 17.)

Нос: Течет ли из носа или он забит? (Присмотритесь, как дышит ребенок через нос.) Посветите внутрь и поищите слизь, гной, кровь; поищите красноту, припухлость или плохой запах. Проверьте признаки свища или сенной лихорадки (с. 165).

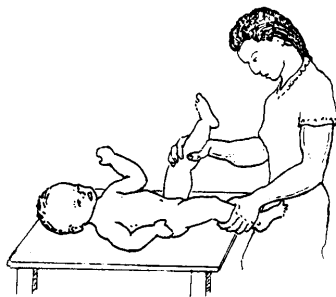
КОЖА

Очень важно обследовать все тело больного человека, несмотря на то, какая у него болезнь. Младенцев и детей необходимо полностью раздеть. Осмотрите внимательно все отклонения от нормы, включая:

- болячки, раны, занозы
- сыпь или ее следы
- пятна, бляшки или любые необычные отметины
- воспаление (признак инфекции с краснотой, жаром, болью и припухлостью)
- припухлость или отечность
- опухшие лимфатические узлы (маленькие бугорки на шее, под мышкой или в паху, см. с. 88)
- ненормальные бугорки или шишки
- необычное истончение или выпадение волос, потеря их цвета или блеска (с. 112)
- выпадение бровей (лепра?) (см. с. 181)

Всегда обследуйте маленьких детей между ягодицами, в половых органах, между пальцами рук и ног, за ушками и в волосах (вши, чесотка, стригущий лишай, сыпь или болячки).

Для определения различных кожных болезней (см. с. 196-198)



ЖИВОТ (ЖЕЛУДОК)

Если у человека боль в животе, постарайтесь узнать поточнее, где болит.

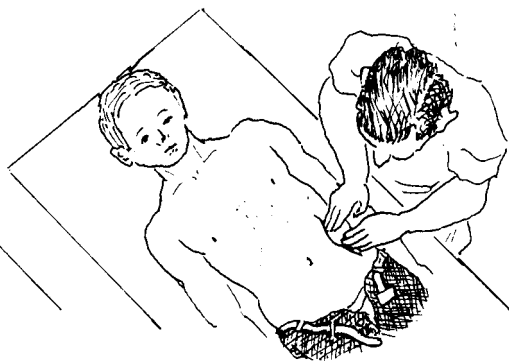
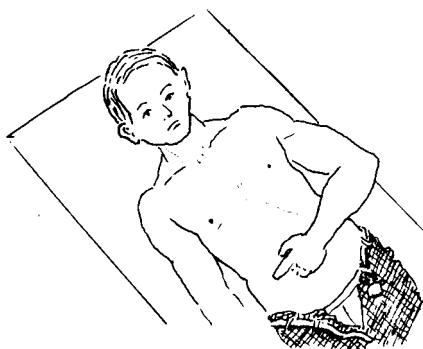
Выясните, постоянна ли эта боль или внезапно приходит и уходит, как судороги или колики.

Когда осматриваете живот, поищите сначала какие-нибудь необычные опухоли и бугорки.

Локализация боли часто дает ключ к причине (смотрите следующую страницу).

Сначала попросите человека указать одним пальцем, где болит.

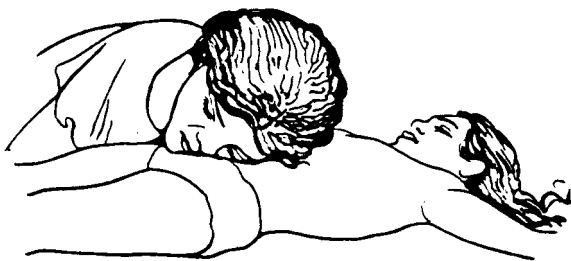
Затем, начиная с противоположной стороны от места, на которое он указал, надавливайте мягко на различные части живота, чтобы увидеть, где болит больше.



Посмотрите, мягкий или твердый живот, может ли человек расслабить мышцы живота. Очень твердый живот может означать “острый живот” — аппендицит или перитонит (см. с. 94).

Если вы подозреваете аппендицит или перитонит, **проверьте на опоясывающую боль**, описанную на с. 95.

Нащупайте необычные опухоли или уплотненные участки живота.



Если у человека постоянная боль в желудке с тошнотой и он не может испражняться, приложите ухо (или стетоскоп) к животу, как на рисунке:

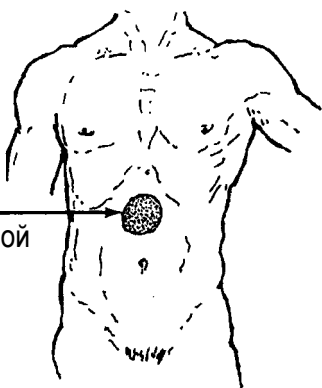
Прислушайтесь к бульканью в кишечнике. Если вы ничего не услышите в течение 2 минут, это опасный признак. (См. Экстренные Проблемы с Кишечником, с. 93.)

Дремлющий живот подобен дремлющей собаке. Остерегайтесь!

Эти рисунки показывают те участки живота, которые обычно болят, когда у человека возникают следующие проблемы:

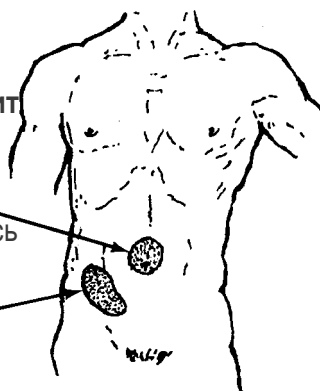
Язва
(см. с. 128)

боль в
подложечной
ямке



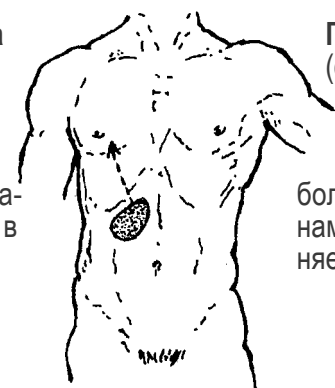
Аппендицит
(см. с. 94)

сначала боль
появляется здесь
затем здесь



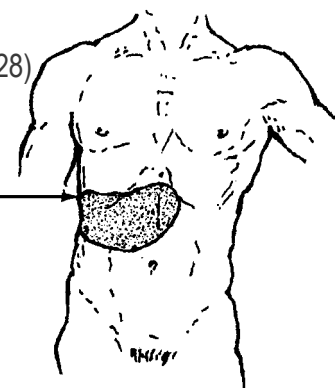
Селезенка
(см. с. 329)

боль ча-
сто отдает в
спину



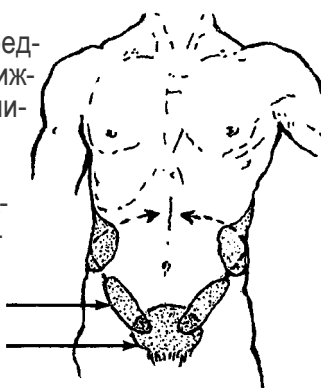
Печень
(см. с. 172, 144 и 328)

боль здесь, време-
нами распростра-
няется на грудь



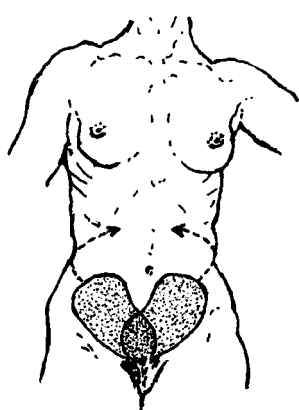
Мочевая система (см. с. 234)

боль в сред-
ней или в ниж-
ней части спи-
ны; часто
идет вдоль
талии к ниж-
ней части жи-
вота
мочеточники
пузырь



**Воспаление
или опухоль
яичников или
внематочная
беременность
и т.д.** (см. с.
280)

боль с одной
стороны или с
обеих, иногда
отдает в спину



Примечание: О различных причинах болей в спине см. с. 173.

МУСКУЛЫ И НЕРВЫ

Если человек жалуется на онемение и слабость или потерю контроля над какой-то частью тела, или вы хотите проверить это, посмотрите, как он ходит, какие у него движения. Пусть он встанет, сядет или ляжет, полностью вытянувшись, а вы внимательно сравните обе стороны тела.

Лицо: Заставьте его улыбнуться, нахмуриться, открыть широко глаза и зажмуриться. Заметьте отвисание или слабость на одной стороне.

Если болезнь началась более или менее внезапно, подумайте о травме головы (с. 91), ударе (с. 327) или параличе Белля (с. 327).

Если она наступает медленно, это может быть опухоль мозга. Немедленно обратитесь за медицинским советом.

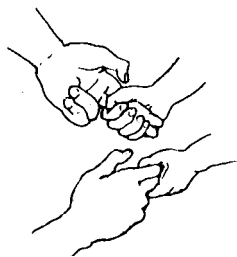
Проверьте также, нормальное ли движение глаз, размеры зрачков (см. с. 217) и зрение.



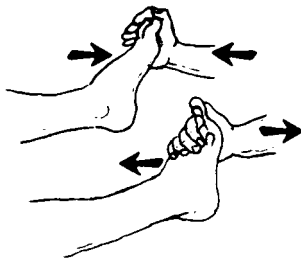
Руки и ноги: Проверьте силу мышц. Отметьте или измерьте разницу в толщине рук или ног.

Понаблюдайте, как он двигается и ходит. Если ослабли мышцы или все тело, можно заподозрить недоедание (с. 112) или хроническую (долготечущую) болезнь типа туберкулеза.

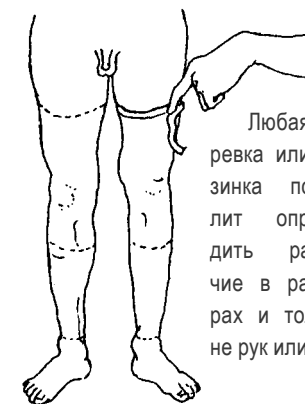
Попросите сжать ваши пальцы, чтобы сравнить силу его рук,



Вытягивайте и сгибайте его ноги своими руками.



Любая веревка или резинка позволит определить различие в размерах и толщине рук или ног

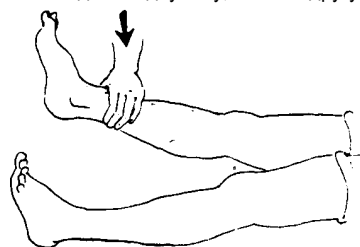


Попросите его вытянуть руки и поворачивать их вверх и вниз.



Попросите его лечь и поднять одну ногу, а затем другую.

Замечайте любую слабость или дрожание.



Если мышцы ослабли или слабость неравномерная или больше с одной стороны, у детей может быть полиомиелит (с. 314); у взрослых - возможны болезни спины, травмы спины или головы или удар.

Для большей информации об исследовании мышц и о физическом обследовании инвалидов см. *Искаленные Деревенские Дети*, Глава 4.

Проверка на подвижность и плотность различных мускулов:

Если челюсть одеревеневшая и не открывается, можно заподозрить столбняк (с. 182) или серьезную инфекцию горла (с. 309) или зубов (с. 231). Если проблема начинается после того, как человек зевает, или после удара в челюсть, то у него может быть вывих челюсти.



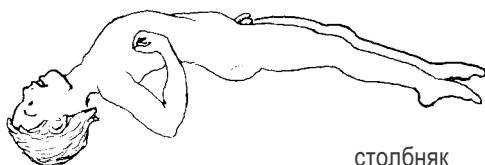
Если у очень больного ребенка шея или спина неподвижна и выгнута назад, подозревать нужно менингит. Если голова не наклоняется вперед или не прижимается к коленям, вероятен менингит (с. 185).



менингит

Если у ребенка постоянно неподвижны некоторые мускулы или у него санные, дергающиеся движения, у него может быть церебральный паралич (с. 320).

Если странные, дергающиеся движения начинаются внезапно с потерей сознания, у него могут быть припадки (с. 178). Если припадки случаются часто, то следует подумать об эпилепсии. Если они случаются во время болезни, причиной может быть сильный жар (с. 76) или обезвоживание (с. 151), или столбняк (с. 182), или менингит (с. 185).



столбняк

Чтобы проверить рефлекс у человека, когда вы подозреваете столбняк, см. с. 185.

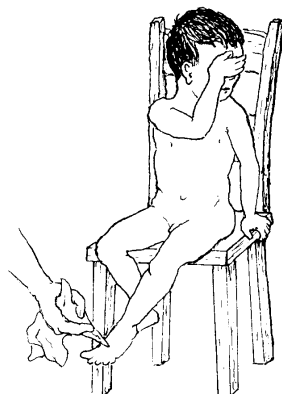
Чтобы проверить потерю чувствительности в руках, ногах или других частях тела:

Попросите больного закрыть глаза. Слегка прикасайтесь или покалывайте кожу в разных местах. Попросите его говорить "да", когда он чувствует это.

Потеря чувствительности в пятнах или около пятен или бляшек на теле может означать проказу (с. 191).

Потеря чувствительности на обеих руках или ногах может вызываться диабетом (с. 127) или проказой.

Потеря чувствительности лишь на одной стороне, возможно, связана с болезнью спины (с. 174) или травмой



КАК УХАЖИВАТЬ ЗА БОЛЬНЫМ

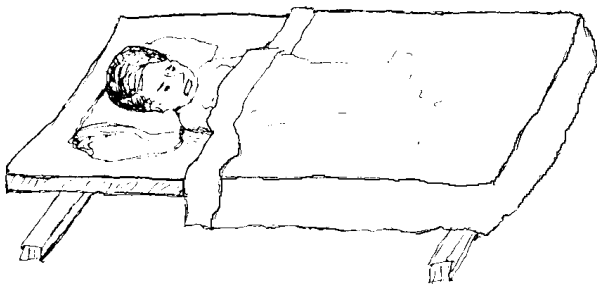
Болезнь ослабляет человека. Чтобы больной набрался сил и поскорее выздоровел, за ним нужен специальный уход.

Уход за больным человеком — самая важная часть его лечения.

Лекарства не всегда нужны. Но хороший уход важен всегда. Хороший уход заключается в следующем:

1. Комфорт для Больного Человека

Больной человек должен лежать в спокойном и уютном месте, где достаточно свежий воздух и света. Ему не следует переохлаждаться или перегреваться. Если воздух холодный или у больного озноб, укройте его простыней или одеялом. Но если погода жаркая или у человека жар, не укрывайте его совсем (см. с. 75).



2. Жидкости

Почти при каждой болезни, особенно при высокой температуре или поносе, больному требуется много жидкости — воды, чая, соков, бульонов и т. д.

3. Личная Гигиена

Очень важно содержать больного в чистоте. Его следует купать каждый день. Если он слишком болен, чтобы вставать с постели, умойте его мылом или тряпочкой теплой водой. Его одежда, простыни и покрывала должны содержаться в чистоте. Следите за тем, чтобы крошки и кусочки еды не оставались в постели.



**БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН
МЫТЬСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ**

4. Хорошая Еда

Если больному человеку хочется есть, пусть кушает. Большинство болезней не требует особой диеты.

Больному человеку нужно употреблять больше жидкости и хорошей пищи (см. Главу 11).

Если человек очень слаб, давайте ему пищи столько, сколько он сможет съесть, и по много раз на день. Если необходимо, то разомните пищу или сделайте из нее супы или соки.

Калорийная пища также очень важна, например, каши из риса, пшеницы, овса, картошки или кассавы. Добавка небольшого количества сахара и растительного масла повышает калорийность. Предлагайте больному пить много сладких напитков, особенно, если он плохо ест.

Несколько болезней требуют специальных диет. Эти болезни описаны на следующих страницах:

Язвы желудка и изжога

Аппендицит, запор, острый живот(в этих случаях не принимают еду)

Диабеты

Болезни сердца

Болезнь селезенки

с. 128

с. 93

с. 127

с. 325

с. 329



ОСОБЫЙ УХОД ЗА ТЯЖЕЛО БОЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКОМ

1. Жидкости

Крайне важно, чтобы тяжело больной человек пил достаточно жидкости. Если он за один раз может выпить очень мало, давайте ему небольшими порциями, но часто. Если он может только глотать, давайте ему маленькими глотками через каждые 5 или 10 минут.

Измерьте количество жидкости, которое человек выпивает каждый день. Взрослому человеку нужно выпивать по 2 литра или больше ежедневно и выделять, по крайней мере, по чашке (60 мл) мочи 3-4 раза за день. Если человек не пьет или не выделяет достаточно мочи, или у него начнут появляться признаки обезвоживания (с. 151), уговорите его пить больше. Он должен пить питательные жидкости, обычно с малой добавкой соли. Если он не может пить их, давайте ему Регидрон (см. с. 152). Если он не может выпить достаточно регидрона и у него развиваются признаки обезвоживания, работник здравоохранения может дать ему внутривенный раствор. Но без этого можно обойтись, если больному часто давать пить маленькими глотками.



2. Пища

Если человек настолько болен, что не может жевать твердую пищу, давайте ему супы, молоко, соки, бульоны и другие питательные жидкости (см. Главу 11). Каша из зерен злаков, овса или риса тоже хороша, но ее надо давать вместе с едой, содержащей вещества, необходимые для жизнедеятельности организма. Супы можно готовить с яйцами, горохом или хорошо отбитым мясом, рыбой или птицей. Если человек может кушать понемногу, ему следует принимать пищу маленькими порциями несколько раз в день.

3. Гигиена

Личная гигиена очень важна для тяжело больного человека. Его нужно мыть каждый день теплой водой.

Меняйте постельное белье ежедневно и всякий раз, когда оно становится грязным. Испачканные или окровавленные вещи, постельное белье и полотенца человека с инфекционными заболеваниями должны быть продезинфицированы. Чтобы уничтожить вирусы или микробы, стирайте белье в мыльной горячей воде или добавьте немного хлорной извести.

4. Изменение Положения в Постели

Человеку, который очень слаб и не может самостоятельно поворачиваться, нужно помочь изменить его положение в постели много раз за день. Это поможет предотвратить пролежни (см. с. 214).

Матери необходимо чаще носить на руках ребенка, который долго болеет.

Частое изменение положения больного помогает предупредить пневмонию — постоянную опасность для любого, кто очень слаб или болен и должен лежать в постели длительное время. Если у человека жар, начинается кашель, а дыхание частое и неглубокое, у него возможна пневмония (см. с. 171).

5. Наблюдение за Изменениями

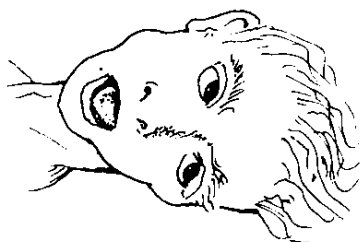
Вы должны следить за любыми изменениями в состоянии больного человека, которые могут подсказать вам, становится ему лучше или хуже. Вести регистрацию его “признаков жизнеспособности”. Записывайте следующие факты 4 раза в день:

Запишите также количество жидкости, выпитой больным, и сколько в день было выделений мочи и испражнений. Сохраните эту информацию для работника здравоохранения или врача.



Очень важно обнаружить признаки, которые предупредят вас, что у больного серьезная или опасная болезнь. Список признаков опасной болезни приведен на следующей странице. Если у человека имеется один из них, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

ПРИЗНАКИ ОПАСНОЙ БОЛЕЗНИ



Человек, у которого присутствует один или больше из следующих признаков, вероятно болен настолько, что ему нельзя лечиться дома без квалифицированной медицинской помощи. Его жизнь может быть в опасности. **Обратитесь за медицинской помощью как можно скорее.** Пока подоспеет помощь, следуйте инструкциям на указанных страницах.

1. Потеря большого количества крови из любой части тела	82, 264, 28
2. Кашель с кровью	179
3. Заметная синева губ и ногтей (если это новое)	30
4. Затрудненное дыхание; не улучшается после отдыха	167, 325
5. Человек не может очнуться (кома)	78
6. Человек так слаб, что падает в обморок, когда встает	325
7. День или больше без выделения мочи	234
8. День или больше без возможности выпить любые напитки	151
9. Сильная рвота или сильный понос, который длится более одного дня или больше нескольких часов у младенцев	151
10. Черный, как деготь, стул или рвота с кровью или фекалиями	128
11. Сильные, непрерывные боли в желудке с рвотой у человека, у которого нет поноса или который не может испражниться	93
12. Любая сильная непрерывная боль, которая продолжается более 3 дней	29-38
13. Кривошея с изогнутой спиной, с или без подвижной челюсти	182, 185
14. Более чем один припадок (конвульсия) у человека с жаром или с серьезной болезнью	76, 185
15. Сильный жар (выше 39°C), который нельзя сбить или который держится более 4-5 дней	75
16. Потеря в массе в течение длительного времени	20, 400
17. Кровь в моче	146, 234
18. Болячки, которые разрастаются и не исчезают при лечении	191, 196, 211, 212
19. Растущая опухоль в любой части тела	196, 286
20. Проблемы с беременностью и родами:	
любое кровотечение во время беременности	249, 281
опухшее лицо и озабоченный вид в последние месяцы	249
большая задержка начала родов после того, как отойдут воды	267
сильное кровотечение	264

КОГДА И КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Обратитесь за медицинской помощью при первых признаках опасной болезни. Не ждите, пока человек заболеет так, что станет трудно или сложно отвезти его в центр здоровья или в больницу.



Если состояние больного или травмированного человека может стать хуже в связи с трудностями транспортировки его в центр здоровья, попытайтесь привезти врача к больному. Но в срочных случаях, когда необходимо особое внимание или операция (например, аппендицит), не ждите работника здравоохранения. Сразу же доставьте больного в центр здоровья или в больницу.

Когда вам нужно отнести больного на носилках, убедитесь, что он лежит удобно, насколько это возможно, и не сможет упасть. Если у него сломаны кости, перед тем, как переносить его, наложите шину (см. с. 99). Если солнце слишком печет, натяните простыню над носилками так, чтобы на больного падала тень и чтобы свежий воздух поступал снизу.

ЧТО ГОВОРИТЬ РАБОТНИКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Работник здравоохранения или врач, прежде чем рекомендовать лечение или правильно прописать лекарства, должен увидеть больного человека. Если больного нельзя двигать, пусть работник здравоохранения придет к нему. Если это невозможно, пошлите к медработнику ответственного человека, который знает детали этой болезни. **Никогда не посылайте маленького ребенка или плохо осведомленного человека.**

Прежде чем послать за медицинской помощью, проведите полный и тщательный осмотр больного человека. Затем подробно опишите его болезнь и общее состояние (см. Главу 3).

На следующей странице представлена форма, по которой вы можете сделать **КАРТОЧКУ ПАЦИЕНТА**. Несколько копий этой формы в конце этой книги. Вырвите одну из форм и тщательно заполните ее, приводя все детали которые сможете.

Когда посылаете кого-то за медицинской помощью, всегда отправляйте с ним заполненную информацией карточку.

КАРТОЧКА ПАЦИЕНТА

Используйте, когда посылаете за медицинской помощью.

Имя больного: _____ Возраст _____

Мужчина _____ Женщина _____ Где он (она)? _____

Какая основная болезнь или проблема со здоровьем сейчас? _____

Когда она началась? _____

Как она началась? _____

Была ли такая же проблема прежде? _____ Когда? _____

Есть ли температура? _____ Какая? _____ Как долго? _____

Боль? _____ Где? _____ Какого типа? _____

Что не соответствует или отличается от нормы в любом из следующих случаев?

Кожа: _____ **Уши:** _____

Глаза: _____ **Рот и горло:** _____

Половые органы: _____

Моча: Много или мало? _____ Цвет? _____ Проблемы с выделением мочи? _____

Опишите: _____

Сколько раз в сутки (24 часа): _____ Сколько раз ночью: _____

Стул: Цвет? _____ Кровь или слизь? _____ Понос? _____

Сколько раз в день? _____ Судороги? _____ Обезвоживание? _____

Мягкий или жесткий? _____ Глисты? _____ Какого вида? _____

Дыхание: Вдохи в минуту: _____ Глубокое, частое или нормальное? _____

Тяжелое дыхание (описать): _____ Кашель (описать): _____

Хрипы? _____ Слизь? _____ С кровью? _____

Есть ли у человека какой-либо **ПРИЗНАК ОПАСНОЙ БОЛЕЗНИ**, описанный на с. 42?

Какой? (Опишите) _____

Другие признаки _____

Принимал ли человек лекарства? _____ Какие? _____

Употреблял ли он какие-либо лекарства, которые вызывали сыпь, крапивницу (или волдыри) с зудом или другие аллергические реакции? _____

Какое? _____

Состояние больного: Не очень серьезное: _____ Серьезное: _____ Очень серьезное: _____

На обратной стороне карточки напишите любую дополнительную информацию, которую вы считаете важной.

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

При большинстве болезней лекарства не требуются. Наш организм обладает собственными защитными свойствами или способностью к сопротивлению и к борьбе с болезнью. В большинстве случаев эти естественные защитные свойства более важны для нашего здоровья, чем лекарства.

Люди хорошо справятся с большинством болезней, включая обычную простуду и грипп, сами, без употребления лекарств.

Чтобы помочь организму бороться или преодолеть болезнь, чаще всего необходимо:

соблюдать чистоту;

побольше отдыхать;

хорошо есть
и пить много
жидкости.



Даже в случае более серьезной болезни, когда могут понадобиться лекарства, организм должен сам преодолевать болезнь; лекарства только помогают. Чистота, отдых, питательная еда и большое количество воды также очень важны.

Высокое искусство сохранения здоровья не зависит и не должно зависеть от употребления лекарств. Даже если вы живете в местности, где нет современных лекарств, можно сделать многое, чтобы предупредить и лечить болезни, если вы узнаете как.

Многие болезни можно предупредить или лечить без лекарств.

Если люди научатся, как правильно пользоваться водой, то это уже может дать больше для предупреждения и лечения болезней, чем все лекарства, которыми сейчас пользуются и злоупотребляют ими.

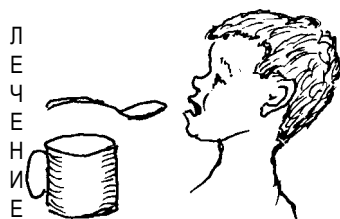
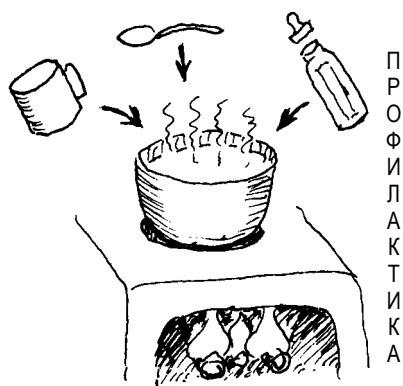
ЛЕЧЕНИЕ ВОДОЙ

Большинство из вас могло бы прожить без лекарств. Но никто не может жить без воды. Действительно, больше половины (57%) человеческого тела состоит из воды. Если каждый из живущих на фермах и в деревнях начнет использовать воду наилучшим образом, то количество болезней и смертность, особенно среди детей, может уменьшиться.

Например, правильное использование воды — это основа для профилактики и лечения поноса. Во многих местах понос — самая распространенная причина болезней и смерти маленьких детей. *Загрязненная* (нечистая) вода является частью этой причины.

Для предупреждения поноса и многих других болезней важно быть уверенным, что питьевая вода неопасна. Охраняйте колодцы и родники от грязи и животных, загораживая их заборами или стенками. Используйте цемент или камни для создания хорошего дренажа вокруг колодцев и родников, чтобы дождь или пролитая вода не стекали в них.

Там, где вода может быть загрязненной, для профилактики поноса очень важно кипятить или фильтровать воду, которую пьют или используют для приготовления пищи. Особенно это важно для младенцев. Детские бутылочки и посуда для еды должны кипятиться. Если регулярное кипячение бутылочек невозможно, то безопаснее пользоваться чашкой и ложкой. Очень важно мыть руки водой с мылом после посещения уборной и перед едой или приготовлением пищи.



Наиболее распространенная причина смертности среди детей с поносом — **сильное обезвоживание** или слишком большая потеря воды из организма (см. с. 15). Напоив ребенка с поносом большим количеством воды (лучше с сахаром или злаками с солью), обезвоживание можно предупредить или устранить (см. Регидрон, с. 152).

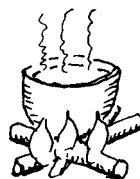
Давать большое количество жидкости детям с поносом более важно, чем давать любое лекарство. Действительно, если давать достаточно жидкости для лечения поноса лекарства обычно не требуются.

На последующих страницах описаны различные ситуации, в которых важнее правильно пользоваться водой, чем лекарствами.

СЛУЧАИ, КОГДА ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ МОЖЕТ ПРИНЕСТИ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ, ЧЕМ ЛЕКАРСТВА.

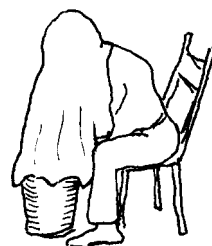
ПРОФИЛАКТИКА

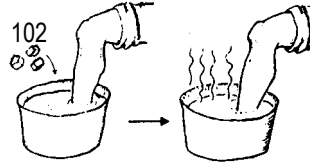
Помогает предупредить	Использование воды	см. с.
1. Понос, глисты, кишечные инфекции	кипятить или фильтровать питьевую воду, мыть руки и т.д.	135
2. Кожные инфекции	частое купание	133
3. Инфицированные раны; столбняк	хорошо промыть раны чистой водой с мылом	84, 89



ЛЕЧЕНИЕ

Помогает лечить	Использование воды	см. с.
1. Понос, обезвоживание	пить большое количество жидкости	152
2. Болезни с температурой	пить большое количество жидкости	75
3. Сильный жар	снимите одежду и протрите тело прохладной водой	76
4. Легкая инфекция в мочевой системе (обычно у женщин)	пить большое количество воды	235
5. Кашель, астма, бронхит, пневмония, коклюш	пить большое количество жидкости и дышать горячим паром (для отхаркивания мокроты)	168



Помогает лечить	Использование воды	см. с.	
6. Болячки, импетиго, стригущий лишай кожи или головы, себорея, угри	промывать чистой водой с мылом	201, 202 205, 211 215	
7. Инфицированные раны, абсцессы, фурункулы	горячие припарки или компрессы	88, 202	
8. Малоподвижные, болезненные мускулы и суставы	горячие компрессы	102, 173, 174	
9. Разрывы и растяжения	В первый день: опускают суставы в холодную воду; в последующие дни в горячую	102	
10. Зудящие, жгучие или мокнущие раздражения кожи	холодные компрессы	193, 194	
11. Легкие ожоги	сразу подержите в холодной воде	96	
12. Воспаление горла или тонзиллит	полощите теплой соленой водой	309	
13. Кислота, щелочь грязь или раздражающее вещество в глазу	сразу же залейте глаз холодной водой и оставьте на 30 мин	219	
14. Забитый нос	втягивайте носом соленую воду	164	
15. Запор, твердый стул	пейте много воды (клизмы также безопаснее слабительного, но не увлекайтесь ими)	15, 126	
16. Простудные болячки или волдыри от жара	при первом признаке приложить лед к волдырям на 1 час	232	

В каждом из вышеперечисленных случаев (исключая пневмонию), если правильно использовать воду, лекарства чаще всего не понадобятся. В этой книге приведены рекомендации способов лечения без употребления лекарств. **Пользуйтесь лекарствами только тогда, когда это абсолютно необходимо.**

ПРАВИЛЬНОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЛЕКАРСТВ

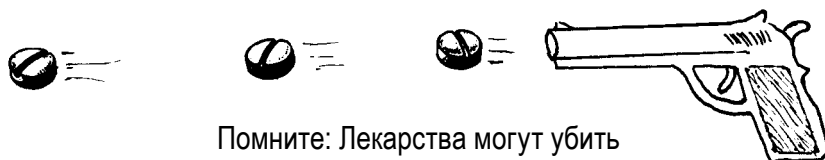
Некоторые лекарства, которыми торгуют в аптеках или в сельских магазинах, могут быть очень полезны. Но многие менее ценны. ВОЗ говорит, что из 60 000 лекарств, продающихся в большинстве стран, только 200 необходимы.

К тому же люди иногда лекарства используют неправильно, поэтому они могут принести больше вреда, чем пользы. Чтобы лекарство принесло пользу, оно должно правильно использоваться.

Некоторые врачи прописывают лекарств намного больше, чем требуется, вызывая этим ненужные болезни и смерти.

Существует некоторая опасность при употреблении любого лекарства.

Одни из лекарств намного опаснее, чем другие. К сожалению, люди иногда пользуются очень опасными лекарствами при легких заболеваниях. (Я видел ребенка, который умер потому, что мать дала ему опасное лекарство, левомицетин, от простуды). **Никогда не пользуйтесь опасным лекарством при легком заболевании.**



Помните: Лекарства могут убить

Руководство по использованию лекарств:

1. Пользуйтесь лекарствами, только когда это необходимо.
2. Выясните все о правильном употреблении и предосторожностях для любого лекарства, которым вы пользуетесь (см. Приложение 1).
3. Убедитесь, что вы даете правильную дозу.
4. Если лекарство не помогает или вызывает проблемы, прекратите его прием.
5. Когда сомневаетесь, обратитесь за советом к работнику здравоохранения.

Примечание: Некоторые работники здравоохранения и многие врачи прописывают лекарства, когда они не требуются, чаще всего считая, что пациенты ожидают лекарств и не удовлетворятся, пока их не получат. Объясните вашему врачу или работнику здравоохранения, что хотите получить только то лекарство, которое действительно вам нужно. Это сэкономит ваши деньги и сохранит ваше здоровье.

Пользуйтесь лекарствами только тогда, когда уверены, что это необходимо, и когда знаете, как ими пользоваться.

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВАМИ

Представляем перечень самых распространенных и опасных ошибок, совершаемых людьми при использовании современных лекарств. Неправильное использование нижеследующих препаратов вызывает ежегодно множество смертей. **БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!**

1. Хлорамфеникол (*Левомецетин*) (с. 357).



Общераспространенное применение этого лекарства при простом поносе или других легких болезнях крайне нежелательно, поскольку это связано с большим риском. Используйте хлорамфеникол только при тяжелых болезнях типа брюшного тифа (см. с. 188). Никогда не давайте его новорожденным.

2. Окситоцин (*Питоцин*), Питуитрин и Эргоновин (*Эргометрин*) (с. 391).



К сожалению, некоторые акушерки применяют эти лекарства, чтобы ускорить роды или “придать силу” матери при родах. Эта практика очень опасна. Можно убить мать или ребенка. Используйте это лекарство только для прекращения кровотечения после родов (см. с. 226).

3. Инъекции лекарств.



Популярное мнение о том, что инъекции обычно лучше, чем лекарства, которые надо глотать, неверное. Во многих случаях лекарства, применяемые внутрь, действуют так же хорошо или даже лучше, чем инъекции. Кроме того, большинство лекарств более опасны в инъекциях, чем когда их глотаешь. Инъекции детям со слабой инфекцией полиомиелита (только с признаками простуды) могут привести к параличу (см. с. 74). Использование инъекций должно быть очень ограничено (читайте внимательно Главу 9)

4. Пенициллин (с. 351).

Пенициллин применяют только против определенных видов инфекции. Применение пенициллина при растяжениях связок, синяках или другой боли или температуре – большая ошибка. Как правило, травмы, которые не повреждают кожу, даже если они вызывают большие синяки, не вносят опасной инфекции; их не нужно лечить пенициллином или другим антибиотиком. Ни пенициллин, ни другие антибиотики не помогают при простуде (см. с. 163)

Пенициллин опасен для некоторых людей. Перед использованием выясните степень риска и предосторожности, которые вы должны предпринять (см. с. 70 и 351).

5. Канамицин и гентамицин (*Гарамицин*) (см. с. 359).

Чрезмерное употребление этих антибиотиков младенцами является причиной долговременной потери слуха (глухоты) у миллионов младенцев. Давайте детям только при угрожающих жизни инфекциях. При многих инфекциях у новорожденных ампициллин действует с таким же успехом и менее опасен.

6. Противопоносные препараты с гидроксихинолином (клиохинол, ди-йодо-гидроксихинолин, галхинол, бросихинолин: *Диодохин, Энтерохинол, Амиклин, Хиогил и многие другие торговые марки*) (с. 370).

В прошлом клиохинолы широко использовались для лечения поноса. Эти опасные лекарства сейчас запрещены по многим странам — но в некоторых еще продаются. Они могут вызывать долговременный паралич, слепоту и даже смерть. Для лечения поноса см. Главу 13.

7. Кортизон и кортикостероиды (*преднизолон и дексаметазон*).

Это сильные противовоспалительные препараты, которые изредка требуются при тяжелых приступах астмы, артрита или при сильных аллергических реакциях. Но во многих странах стероиды прописывают при слабых болях, поскольку они быстро дают результат. Это большая ошибка. Стероиды вызывают серьезные или опасные побочные эффекты — особенно, если их принимать большими дозами или дольше, чем несколько дней. Они понижают защитные свойства человека против инфекции. Они могут намного усугубить туберкулез, вызвать кровотечения при язве желудка и сделать кости настолько слабыми, что они легко ломаются.

8. Анаболические стероиды (*Фенаболон, Ретаболил, Нераболил. Есть еще много других торговых марок*).

Анаболические стероиды производятся из мужских гормонов и по ошибке используются в тониках, чтобы помочь детям набрать массу и рост. Сначала ребенок может расти быстрее, но вскоре рост замедляется и заканчивается раньше, чем должен, если прекратить прием лекарства. Анаболические стероиды вызывают очень опасные побочные эффекты. У девочек начинают расти волосы на лице, как у мальчиков, которые не исчезают даже тогда, когда ребенок перестает принимать лекарство. Не давайте тоников роста детям. Вместо этого помогите вашему ребенку расти, употребив деньги на питание.

9. Лекарство от артрита (*Бутазоны: Бутадион, Реопирин*).

Эти лекарства от боли в суставах (артрит) могут вызвать опасное, иногда смертельное, изменение со стороны крови (агранулоцитоз). Они могут также поражать желудок, печень и почки. Не пользуйтесь этими опасными лекарствами. При артрите аспирин (с. 379) или ибупрофен (с. 380) гораздо безопаснее и дешевле. От боли и высокой температуры можно использовать ацетаминофен (с. 380).

10. Витамин B12 и печеночный экстракт (с. 393).



Эти медикаменты не помогают при анемии или “слабости” за исключением редких случаев. Кроме того, существует определенный риск при их инъекциях. Их следует использовать только тогда, когда специалист пропишет их после анализа крови. Почти во всех случаях анемии препараты, содержащие железо (например, “Феррамид”), помогут гораздо лучше (см. с. 124).

11. Другие витамины (с. 392).

Как правило, НЕ ДЕЛАЙТЕ ИНЪЕКЦИИ ВИТАМИНОВ. Инъекции гораздо опаснее, дороже и обычно не такие эффективные, как таблетки

К сожалению, многие люди тратят свои деньги на сиропы, тоники и “эликсиры”, которые содержат витамины. Но в них отсутствуют важные витамины (см. с. 118). Если же они и содержат их, более мудро покупать побольше хорошей еды. Для жизнедеятельности организма и его защитных свойств необходимы бобы, яйца, мясо, фрукты, овощи и цельные зерна, богатые витаминами и другими питательными веществами (см. с. 111). Если давать худому, слабому человеку почаше хорошую еду, то она поможет больше, чем витаминные препараты и минеральные добавки.

Человек, который ест хорошо, не нуждается в дополнительных витаминах.

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВИТАМИНОВ



Чтобы получить побольше информации о витаминах, когда они необходимы, и продуктах, которые содержат их, читайте Главу 11. особенно с. 111 и 118.

12. Комбинации лекарств.

Иногда 2 или более препаратов смешивают и одной и той же таблетке или, тонике. Обычно они менее эффективны и более дорогие, когда изготовлены таким способом. Иногда **они приносят больше вреда, чем пользы**. Если кто-то хочет прописать комбинированное лекарство, попросите его или ее прописать только то лекарство, которое действительно необходимо. Не тратьте деньги на эти лекарства.

Вот несколько распространенных комбинированных лекарств, которых **следует избегать**:

- **лекарства от кашля**, которые содержат лекарства для сдерживания кашля и отхаркивания мокроты. (Лекарства от кашля почти всегда бесполезны, приобретение их приводит к пустой трате денег.);
- **антибиотики** в сочетании с **противопоносным лекарством**;
- **антациды** для лечения язвы желудка вместе с лекарством для предупреждения спазмов желудка;
- 2 или более **болеутоляющих** (аспирин с ацетаминофеном — иногда также с кофеином — или аспирин с кодеином).

13. Кальций.



Инъекции кальция в вену могут быть крайне опасны. Они могут мгновенно убить, если не вводить препарат очень медленно. Инъекции кальция в ягодичы иногда вызывают очень серьезные абсцессы или инфекции.

Никогда не делайте инъекции кальция, не обратившись сначала за медицинским советом.

Примечание: В Мексике и других странах, где люди едят много маисовых (кукурузных) лепешек или другой пищи, приготовленной со сладким лимоном, глупо пользоваться инъекциями кальция или тониками (хотя это часто делают, чтобы “придать силу” или “помочь расти детям”). Организм получает весь необходимый ему кальций из сладкого лимона.

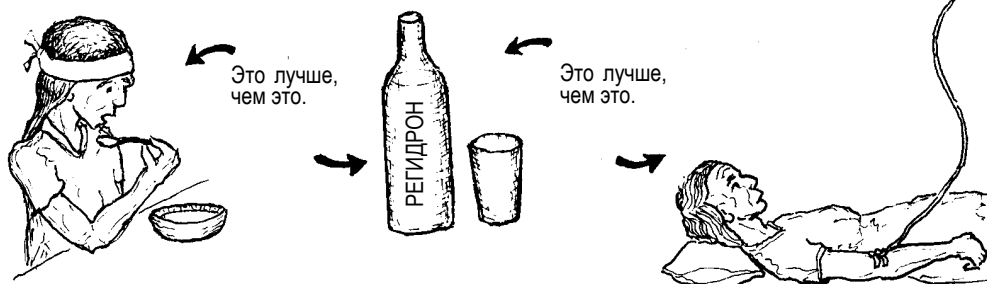
14. “Питание” через вены (Внутривенные или “В.В.” растворы).

В некоторых местах люди анемичные или очень слабые тратят свои последние гроши, чтобы приобрести литр раствора для вливания в вены. Они верят, что это делает их сильнее или обогатит кровь. Но они ошибаются! Внутривенный раствор – ничего более, как чистая вода с солью или сахаром. Он. дает меньше энергии, чем большая конфета, и обедняет кровь, а не обогащает. Он не помогает при анемии и не делает слабого сильнее.

К тому же, когда не очень квалифицированный человек делает вливание В.В. раствора в вену, существует опасность внесения инфекции в кровь. Этим можно убить больного.

Внутривенный раствор должен использоваться только тогда, когда человек ничего не может взять в рот или когда он сильно обезвожен (см. с. 151).

Если больной может глотать, дайте ему 1 литр воды с небольшим количеством сахара и соли (см. Регидрон, с. 152). Это равносильно инъекции литра В.В. раствора. Тем людям, которые способны есть, питательные продукты принесут гораздо больше пользы, чем любой вид В.В. жидкости.



КОГДА НЕ НАДО УПОТРЕБЛЯТЬ ЛЕКАРСТВА ?

Некоторые люди думают, что нельзя готовить и кушать некоторые блюда, когда они принимают лекарства. По этой причине они могут перестать принимать лекарства, которые им нужны. Действительно, никакие препараты не приносят вреда только потому, что их принимают с определенной пищей: будь то свинина, горький перец, апельсины или любая другая еда. Но еда с большим количеством жира или специй может вызвать проблемы с желудком или с кишечником — принимаете ли вы или нет при этом любые лекарства (см. с. 128). Определенные лекарства могут вызвать отрицательные реакции, если человек пьет алкоголь (см. метронидазол. с. 319).

Существуют ситуации, когда, несомненно, лучше всего не принимать определенных лекарств:

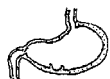
1. Беременные женщины или женщины, которые кормят грудью, должны избегать всех лекарств, которые не абсолютно необходимы. (Однако они могут принимать ограниченное количество витаминов или таблеток, содержащих железо, без всякого риска.)



2. Будьте очень осторожны, когда даете лекарства младенцам. При любой возможности обращайтесь за медицинской помощью прежде, чем дать какое-либо лекарство. Убедитесь в том, что не даете слишком много



3. Человек, имевший когда-либо аллергическую реакцию — крапивницу, зуд и т.д. — после приема пенициллина, ампициллина, сульфаниламида или других лекарств, никогда больше в своей жизни не должен принимать эти лекарства, потому что это опасно (см. Опасные реакции на инъекции некоторых лекарств, с. 70).



4. Люди с язвой желудка или изжогой должны избегать лекарств, содержащих аспирин. Многие болеутоляющие препараты и все стероиды (см. с. 51) вызывают язвы и понижают кислотность. Единственным болеутоляющим, которое не раздражает желудок, является ацетаминофен (парацетамол, см. с. 380).

5. Существуют специфические медикаменты, которые вредно или опасно принимать при некоторых болезнях. Например, человеку с гепатитом нельзя принимать антибиотики или другие сильные лекарства, потому что у него поражена печень, а лекарства отравляют организм (см. с. 172).

6. Человеку, у которого обезвоживание или болезни почек, нужно быть особенно осторожным с лекарствами. Не давайте больше одной дозы лекарства, которое может отравить организм человека, пока не нормализуется выделение мочи. Например, если у ребенка высокая температура и обезвоживание (см. с. 76), не давайте ацетаминофен или аспирин, пока он не помочится. Никогда не давайте сульфаниламид человеку с обезвоживанием.

Антибиотики: Что Это и Как Их Употреблять

Антибиотики – крайне полезные и важные лекарства, если их правильно применять. Они борются с определенными инфекциями и болезнями, которые вызваны бактериями. Хорошо известными антибиотиками являются пенициллин, тетрациклин, стрептомицин, левомецетин и сульфаниламидные препараты, или сульфаниламиды.

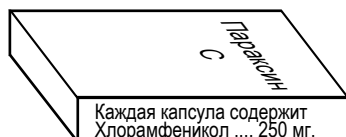
Каждый из антибиотиков эффективен только в отношении определенных видов инфекций. Все антибиотики опасны в употреблении, но некоторые из них опаснее других. Будьте внимательны в выборе и употреблении антибиотиков.

Существует много видов антибиотиков и каждый из них продается под несколькими “торговыми названиями”. Это может приводить в замешательство. Однако самые важные антибиотики распадаются на несколько больших групп.

Группа антибиотиков (общее название)	Примеры торговых названий	Торговое название в вашей местности (запишите)	см. с.
ПЕНИЦИЛЛИНЫ	Пен-В-К		351
АМПИЦИЛЛИНЫ*	Пенбритин		353
ТЕТРАЦИКЛИНЫ	Тетрациклин		356
СУЛЬФАНИЛАМИДЫ	Гантризин		358
КО-ТРИМОКСАЗОЛ	Бактрим		358
АМИНОГЛИКОЗИДЫ	Амбистрин		363,359
ЛЕВОМИЦЕТИН	Хлоромецетин		357
МАКРОЛИДЫ	Эритроцин		355
ЦЕФАЛОСПОРИНЫ	Кефлекс		359

Примечание: ампициллин – это разновидность пенициллина, которая убивает больше видов бактерий, чем обычный пенициллин.

Если у вас есть торговое название антибиотика, а вы не знаете, к какой группе он принадлежит, прочтите мелкий шрифт на бутылке или коробочке. Например, если у вас есть упаковка Папоксин “С”, а вы не знаете, что это такое, прочтите мелкий шрифт. Там говорится “левомецетин”.



Поищите хлорамфеникол в ПРИЛОЖЕНИИ 1 (с. 357) и там вы найдете, что его можно применять только при очень серьезных заболеваниях, таких как брюшной тиф, и он особо опасен для новорожденных.

Никогда не используйте антибиотик, пока не узнаете, к какой группе он принадлежит, с какими болезнями он борется и какие меры предосторожности вы должны соблюдать, чтобы обезопасить себя при его употреблении.

Сведения о применении, дозировке, риске и предосторожностях при приеме антибиотиков, рекомендуемых в этой книге, вы найдете в ПРИЛОЖЕНИИ 1. Найдите название лекарства в алфавитном указателе в начале приложения.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВСЕХ АНТИБИОТИКОВ

1. Если вы не знаете точно, как пользоваться антибиотиком и против каких инфекций его можно употребить, не применяйте его.
2. Употребляйте только тот антибиотик, что рекомендуется от инфекции, которую вы хотите лечить. (Найдите это заболевание в книге.)
3. Узнайте о риске при употреблении антибиотика и принимайте все меры предосторожности (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
4. Употребляйте антибиотики только в рекомендуемых дозах — ни больше, ни меньше. Доза зависит от болезни и возраста или веса больного.
5. Никогда не делайте инъекции антибиотиков, если их можно с таким же успехом глотать. Делайте инъекции лишь тогда, когда это крайне необходимо.
6. Продолжайте прием антибиотиков до полного выздоровления или, по крайней мере, еще 2 дня после того, как спадет температура и исчезнут другие признаки инфекции. (Некоторые заболевания, типа туберкулеза или проказы, нужно лечить в течение многих месяцев или лет после того, как человек почувствует себя лучше. Следуйте инструкциям для каждого заболевания.)
7. Если антибиотик вызывает кожную сыпь, зуд, затрудненное дыхание или другую серьезную реакцию, больной должен прекратить его употребление и **никогда больше не пользоваться им** (см. с. 70).
8. **Используйте антибиотики только тогда, когда это крайне необходимо.** Когда антибиотиков употребляют слишком много, они начинают работать не так хорошо.

РУКОВОДСТВО ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ ОПРЕДЕЛЕННЫХ АНТИБИОТИКОВ

1. Перед инъекцией пенициллина или ампициллина обязательно приготовьте ампулы Адреналина (эпинефрина) на случай аллергической реакции, если она появится (с. 70).
2. Для людей, у которых аллергия на пенициллин, используйте другие антибиотики, такие как эритромицин или сульфаниламиды (см. с. 355 и 358).
3. Не пользуйтесь тетрациклином, ампициллином или другими антибиотиками широкого спектра действия при заболевании, которое можно вылечить пенициллином или другим антибиотиком узкого спектра (см. стр 58) Антибиотики широкого спектра могут убить намного больше видов бактерий, чем антибиотики узкого спектра.
4. Как правило, левомецетин следует употреблять только при тяжелых, угрожающих жизни болезнях, типа брюшного тифа. Это очень опасное лекарство. Никогда не употребляйте его при легких заболеваниях. И **никогда** не давайте его новорожденным (за исключением коклюша, с. 313).
5. Никогда не делайте инъекции тетрациклина или левомецетина. Когда вы их глотаете, они безопаснее, менее болезненны и улучшают здоровье быстрее
6. Не давайте тетрациклин беременным женщинам или детям до 8 лет. Он может разрушать молодые зубы и кости (см. с. 356).

7. Как основное правило, используйте стрептомицин и препараты, что содержат его, только при туберкулезе – и всегда вместе с другими антитуберкулезными лекарствами (см. с. 365). Стрептомицин в сочетании с пенициллином может быть использован при глубоких ранах в кишечнике, аппендиците и других специфических инфекциях, когда ампициллин не доступен (или слишком дорог), но никогда не следует применять его при простуде, гриппе и обычных респираторных инфекциях.
8. Все лекарства группы стрептомицина (включая канамицин и гентамицин) слишком токсичны (отравляющие). Довольно часто их выписывают при легких инфекциях, когда от них больше вреда, чем пользы. Используйте их только при определенных, очень серьезных инфекциях, для которых они рекомендуются.
9. Питание йогуртом или творогом помогает восстановить необходимые бактерии, убитые антибиотиками типа ампициллина, и привести естественный баланс организма к нормальному состоянию (см. следующую страницу).

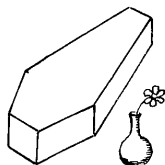
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КАЖЕТСЯ, ЧТО АНТИБИОТИК НЕ ПОМОГАЕТ?

При большинстве обычных инфекций антибиотики начинают приносить улучшение через день или два. **Если кажется, что используемый антибиотик не помогает, возможно:**

1. Это не та болезнь, что вы думаете. Вы принимаете не то лекарство. Попробуйте поточнее установить болезнь и употребить нужное лекарство.
2. Доза антибиотика определена неправильно. Проверьте.
3. Бактерии стали сопротивляться этому антибиотику (он больше не справляется с ними). Испробуйте другой антибиотик, который рекомендуют от этой болезни.
4. Возможно, ваших знаний недостаточно для лечения этой болезни. Обратитесь за медицинской помощью, особенно если состояние больного серьезное и ухудшается.

Эти дети простудились

Что послужило причиной?



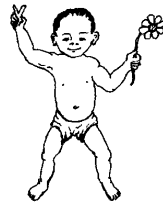
Пенициллин
(см. Аллергический шок, с. 70)

Что повлекло за собой тяжелую потерю?



Левомецетин
(см. риски меры предосторожности для этого лекарства с. 357)

Почему этот ребенок поправился?



Он не принимает опасное лекарство — просто фруктовые соки, хорошая еда и отдых.

Антибиотики не помогают при обычной простуде.

Применяйте антибиотики только при инфекциях, от которых они помогают.

ОГРАНИЧИТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ

Употребление всех медикаментов должно быть ограничено. Но особенно это важно для антибиотиков по следующим причинам:

1. **Отравление и реакции.** Антибиотики не только убивают бактерии, они могут навредить организму, либо отравив его, либо вызвав аллергическую реакцию. Множество людей ежегодно умирает от антибиотиков, которые им не нужны.
2. **Нарушение естественного баланса.** Не все бактерии в организме вредны. Некоторые необходимы для нормального функционирования организма. Антибиотики часто убивают как хорошие, так и плохие бактерии. У детей, которым дают антибиотики, развивается грибковая инфекция во рту (молочница, с. 232) или кожная (монилиоз с. 242). Это потому, что антибиотики убивают бактерии, которые помогают бороться с грибом.

По аналогичным причинам у людей, которые принимают ампициллин и другой **антибиотик широкого спектра** в течение нескольких дней может развиваться понос. Антибиотики могут убить некоторые виды бактерий, которые необходимы для пищеварения, расстраивая тем самым естественный баланс бактерий в кишечнике.

3. **Сопrotивляемость лечению.** В конце концов, самой важной причиной ограничения приема антибиотиков является то, что *когда антибиотики используются в больших количествах, они становятся менее эффективными.*

При многократном употреблении одного и того же антибиотика бактерии становятся сильнее и уже не убиваются этим антибиотиком. Они начинают **сопротивляться** антибиоту. По этой же причине некоторые опасные болезни типа брюшной тиф начинают тяжелее поддаваться лечению, чем несколько лет назад.

В некоторых местах брюшной тиф сопротивляется левомецитину, который обычно представляет собой самое лучшее лекарство для его лечения. Причина в том, что левомецитин часто употребляли и в случаях легких инфекций, в случаях инфекций, для которых другие антибиотики были бы безопаснее и лечили бы лучше, или в тех случаях, когда антибиотики вообще не нужны.

По всему миру основные болезни стали сопротивляться антибиотикам, так как, в основном, антибиотики слишком часто используются при легких инфекциях. **Поскольку антибиотики продолжают спасать жизни, их употребление следует ограничить намного больше, чем сейчас.** Это зависит от разумного использования их врачами, работниками здравоохранения и самими людьми.

При большинстве легких инфекции антибиотики не нужны и их не следует употреблять. Легкие кожные инфекции успешно лечатся мягким мылом и водой, влажными припарками и использованием генцианвиолета (с. 371). Легкие респираторные инфекции лучше всего лечатся большим количеством жидкости, хорошим питанием и отдыхом. **При поносе антибиотики чаще всего совсем не нужны и могут навредить.** Самое важное – пить побольше жидкости (с. 155) и обеспечить хорошее питание, если только ребенок будет кушать.

Не употребляйте антибиотики при инфекциях, с которыми организм может бороться сам. Сохраните их, пока они действительно не понадобятся.

Для дополнительной информации о разумном применении антибиотиков см. **Пособие Для Работников Здравоохранения.** Глава 19.

КАК ОТМЕРЯТЬ И ДАВАТЬ ЛЕКАРСТВО

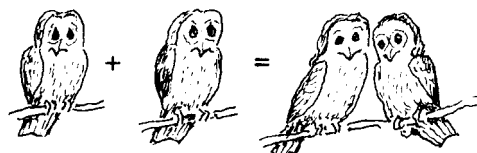
ГЛАВА

8

СИМВОЛЫ:

= означает: **равно** или
то же самое

+ означает: **и** или **плюс**



$$1 + 1 = 2$$

Один плюс один равно два

КАК ИНОГДА ПИШУТСЯ ДРОБИ:

1 таблетка = 1 целая таблетка =

$1/2$ = половина таблетки =

$1 \frac{1}{2}$ = одна целая и одна половина таблетки =

$1/4$ = одна четверть
или одна четвертая
таблетки =



$1/8$ = одна восьмая таблетки (делим на 8
равных частей и берем 1 часть) =



ИЗМЕРЕНИЕ

Лекарства обычно взвешивают в граммах или миллиграммах.

1000 мг = 1 г (1 тысяча миллиграммов равна 1 г)

1 мг = 0.001 г (1 мг равен одной тысячной части грамма)

Примеры:



Одна таблетка аспирина
для взрослых содержит

.3 гр. (gm.)
0.3 гр. (gm.)
0.300 гр. (gm.)
300 мг. (mg.)



Различные
способы записи
300 мг



Одна таблетка аспирина
для детей содержит

.075 гр. (gm.)
0.075 гр. (gm.)
75.0 мг. (mg.)
75 мг. (mg.)



Различные
способы записи
75 мг

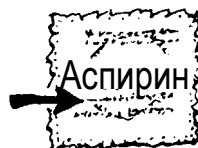
Примечание: В некоторых странах лекарства в гранах; 1 гран = 0,0648 г. То есть в пяти гранах таблеток аспирина весят приблизительно 300 мг.

Во много раз важнее знать, сколько граммов или миллиграммов содержится в лекарстве.

Например, если вы хотите дать маленькую часть таблетки взрослого аспирина ребенку вместо детского, но не знаете какого размера кусочек дать.

читайте мелкий шрифт на ярлыке.

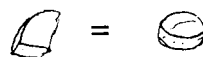
Там говорится: аспирин: ацетилсалициловая кислота
(ацетилсалициловая кислота = аспирин)



3 г = 300 мг и 0.75 г = 75 мг. Итак, вы видите, что одна таблетка аспирина для взрослого весит в 4 раза больше, чем детская.



Если вы разделите взрослый аспирин на 4 равные части, каждая четверть = одной детской таблетке



Если вы разделите взрослый аспирин на 4 части, то можете дать ребенку 1 часть вместо детского аспирина. Они равны, и кусочек взрослого аспирина стоит дешевле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Многие лекарства, особенно антибиотики, поступают разного размера и веса. Например: тетрациклин может поступать в капсулах 3 размеров: 250 мг, 100 мг, 50 мг.



250 мг.



100 мг.



50 мг.

Будьте осторожны и давайте лекарство только в рекомендуемых количествах. Очень важно проверить, сколько граммов или миллиграммов содержится в лекарстве.

Например: если в рецепте говорится: принимайте 1 капсулу тетрациклина весом 250 мг 4 раза в день, а у вас только 50 мг капсулы, вам нужно принимать по пять 50 мг капсул 4 раза в день (20 капсул в день).

50 мг. + 50 мг. + 50 мг. + 50 мг. + 50 мг. = 250 мг.



МЕРА ИЗМЕРЕНИЯ ПЕНИЦИЛЛИНА

Пенициллин часто измеряется в единицах. (ЕД = единица)

Многие формы пенициллина (таблетки, уколы) поступают в дозах 500 000 ЕД, 1000 000 ЕД. 500 000 ЕД = 500 мг; 1 000 000 ЕД = 1 г или 1 000 мг.

ЖИДКАЯ ФОРМА ЛЕКАРСТВА

Сиропы, суспензии, тоники и другие жидкие лекарства измеряются в миллилитрах:

мл = миллилитр

1 литр = 1000 мл.

Часто жидкие лекарства прописывают в чайных или столовых ложках.

1 чайная ложка (ч.л.) = 5 мл

1 столовая ложка (ст.л.) = 15 мл



3 чайные ложки = 1 столовой ложке

Когда в инструкции к лекарству говорится: Принимайте 1 ч.л. — это означает 5 мл.

Многие люди под “чайной ложкой” имеют в виду как 8 мл, так и 3 мл. Когда вам нужно употребить чайную ложку лекарства, очень важно знать, что это 5 мл. Не больше и не меньше.

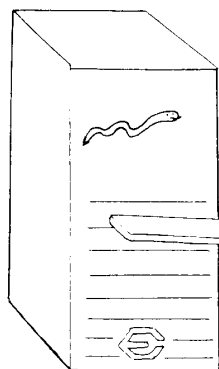
КАК УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ЛЕКАРСТВА ЧАЙНАЯ ЛОЖКА ОТМЕРЯЕТ 5 МЛ?

1. Купите 5 мл измерительную ложку.

или

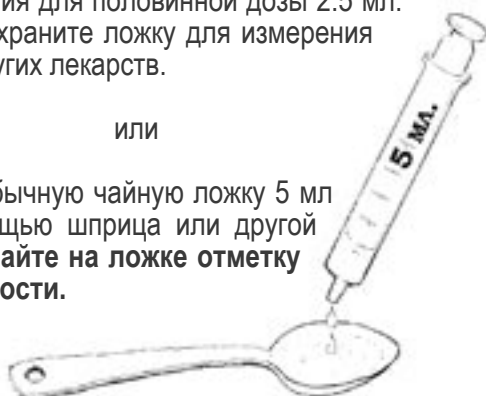


2. Купите лекарство, которое продается с пластиковой ложкой. В ней содержится 5 мл, когда она полная, и иногда имеется линия для половинной дозы 2.5 мл. Сохраните ложку для измерения других лекарств.



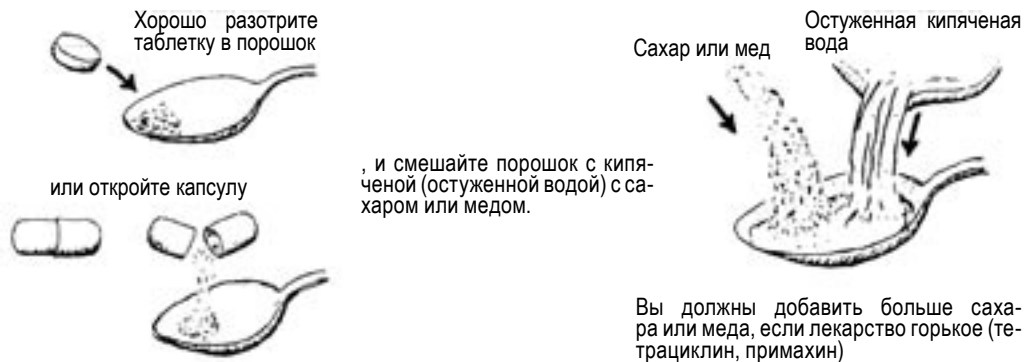
или

3. Наполните обычную чайную ложку 5 мл воды с помощью шприца или другой мерки и сделайте на ложке отметку уровня жидкости.



КАК ДАВАТЬ ЛЕКАРСТВО МАЛЕНЬКИМ ДЕТЯМ?

Многие лекарства, которые выпускаются в порошках или в капсулах, могут также выпускаться в сиропах или суспензиях (специальная жидкая форма) для детей. Если вы сравните количество денег, потраченных на лекарства, окажется что сироп обычно дороже, чем порошки или капсулы. Вы можете сэкономить деньги, приготовив свой собственный сироп следующим образом:

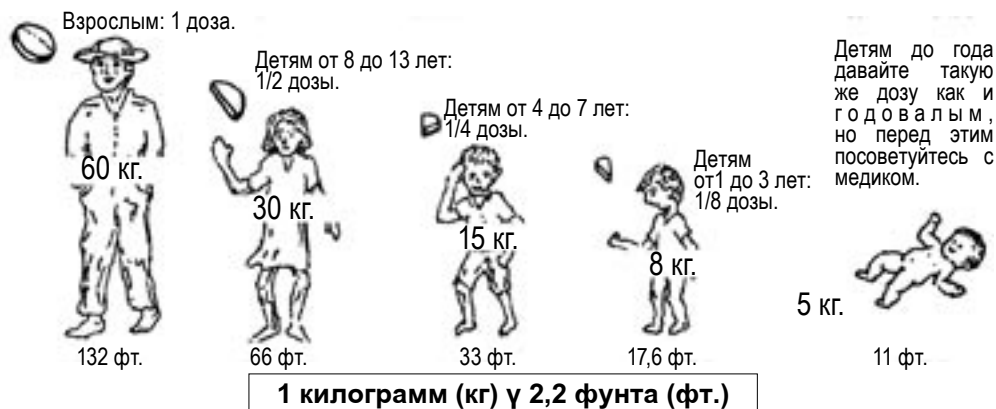


Когда вы готовите сироп для детей из порошка или капсулы, **будьте очень осторожны, чтобы не переусердствовать с лекарством.** Также **не давайте меда детям до 1 года.** Хотя это случается редко у некоторых детей могут появиться опасные побочные эффекты.

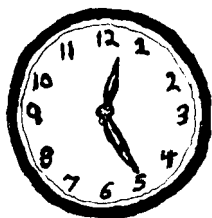
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы ребенок не захлебнулся, не давайте лекарство, когда он лежит на спине или когда его голова запрокинута назад. Обязательно убедитесь, что он сидит прямо или что его голова поднята. Никогда не давайте лекарство в рот, когда у ребенка припадок, когда спит или когда он без сознания.

СКОЛЬКО ЛЕКАРСТВА СЛЕДУЕТ ДАВАТЬ ДЕТЯМ, КОГДА У ВАС ИМЕЕТСЯ ИНСТРУКЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ?

Обычно, чем меньше ребенок, тем меньше ему надо лекарства. Давать больше, чем ему потребуется, опасно. Если у вас есть информация о дозах для детей, тщательно следуйте ей. Если вы не знаете дозу, определите ее по весу и возрасту ребенка. Детям нужно давать следующие порции взрослой дозы:



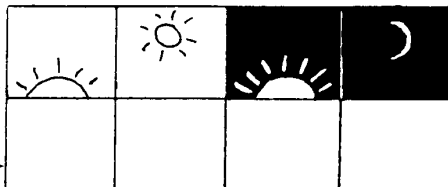
КАК ПРИНИМАТЬ ЛЕКАРСТВА?



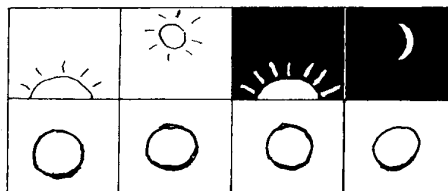
Важно принимать лекарство по мере возможности в то время, которое вам рекомендуют. Некоторые лекарства следует принимать лишь раз в день, другие чаще. Если у вас нет часов, это не имеет значения. Если инструкции говорят "1 пилюля каждые 8 часов", то принимать 3 раза в день: одну утром, одну днем, одну на ночь. Если они говорят "1 пилюлю каждые 6 часов", то принимать 4 раза в день: одну утром, одну в полдень, одну после обеда, одну на ночь. Если в инструкции "1 каждые 4 часа", то принимать 6 раз в день, разделив более или менее равномерно время между приемами.

Если вы кому-нибудь даете лекарство, хорошо бы написать инструкции и заставить человека запомнить, как и когда принимать лекарство. Убедитесь, что он вас правильно понял.

Чтобы напоминать неграмотному человеку, когда принимать лекарство, можете дать ему бланк, подобный этому.



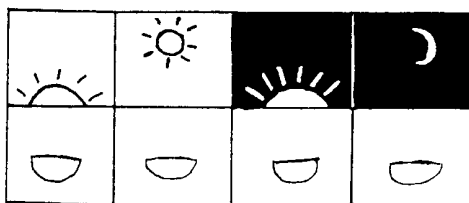
На нижней части бланка нарисуйте количество таблеток, которые он должен принять, и подробно объясните, что это значит.



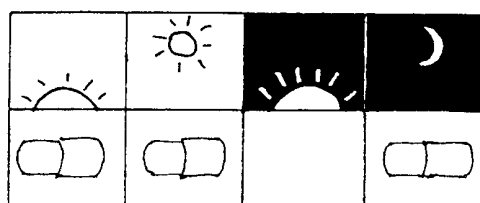
Например:

Это означает по 1 таблетке 4 раза в день: 1 утром, 1 днем, 1 вечером и 1 ночью.

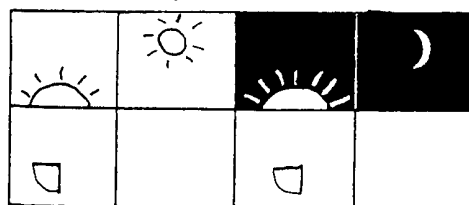
Это означает по 1/2 таблетки
4 раза в день



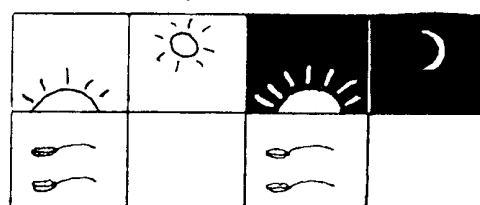
Это означает по 1 капсуле
3 раза в день



Это означает по 1/4 таблетки
2 раза в день



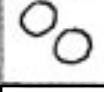
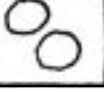
Это означает по 2 чайных ложки
2 раза в день



КОГДА ВЫ ДАЕТЕ ЛЕКАРСТВА КОМУ-НИБУДЬ...

Всегда записывайте всю следующую информацию на бланке с лекарством, если даже человек не может читать:

- имя больного;
- название лекарства;
- от чего оно;
- дозировка.

			
			
Ф.И.О.: Омурбеков Арслан			
Препарат: Пиперазин 500мг. 6 таблеток			
От: Глистов			
Дозировка: По 2 таблетки два раза в день			

Эта информация может быть записана на том же бланке с дозировкой.

Страница с этими бланками дозировки содержится в конце книги. Вырежьте их и пользуйтесь по мере надобности. Когда они закончатся, вы можете сами приготовить такие же.

Когда вы даете кому-нибудь лекарство, хорошо бы сохранить запись этой информации. Если возможно, заполните Карточку пациента (см. с. 44).

ПРИЕМ ЛЕКАРСТВ НА ПОЛНЫЙ ИЛИ ПУСТОЙ ЖЕЛУДОК

Некоторые лекарства действуют лучше, когда их принимают на голодный желудок, т.е. за час до еды.

Другие лекарства в меньшей степени вызывают расстройство желудка или изжогу, когда принимаются вместе с едой или после нее.

Принимайте эти лекарства за 1 час до еды:

- пенициллин
- ампициллин
- тетрациклин

Лучше не пить молоко за час до приема или после приема тетрациклина

Принимайте эти лекарства вместе с едой или сразу после еды:

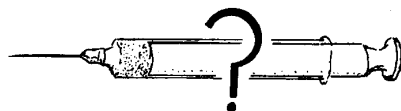
- аспирин и лекарство, содержащее аспирин
- препараты, содержащие железо
- витамины
- эритромицин

Антациды действуют лучше, если принимать их на пустой желудок, через 1 или 2 часа после еды и перед сном.

Примечание: Лучше принимать лекарства, когда вы стоите или сидите. Кроме того, старайтесь пить стакан воды каждый раз, когда принимаете лекарство. Если вы принимаете сульфаниламиды, очень важно пить много воды, по крайней мере, 8 стаканов в день, чтобы не нанести вред почкам.

ИНСТРУКЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИНЪЕКЦИЯХ

9



КОГДА ДЕЛАТЬ ИНЪЕКЦИЮ, А КОГДА НЕТ?

Уколы не надо делать часто. При большинстве болезней, которые требуют медицинского лечения, можно хорошо или даже лучше обойтись приемом лекарства внутрь. Общее правило:

Гораздо опаснее делать уколы, чем принимать лекарство внутрь.

Инъекции должны применяться только тогда, когда они абсолютно необходимы. Кроме срочных случаев, их должны делать только работники здравоохранения или люди с большим опытом.

Пользоваться инъекциями следует только в таких случаях:

1. Когда рекомендуемое лекарство не поступает в таком виде, чтобы его можно было принимать внутрь.
2. Когда человека часто рвет, он не может глотать или он без сознания.
3. В случаях крайней необходимости или в особых случаях (см. следующую страницу).

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ВРАЧ ПРОПИСЫВАЕТ ИНЕКЦИИ?

Врачи иногда прописывают инъекции, когда они не нужны. В конце концов, за инъекции они могут потребовать и больше денег. Некоторые забывают о проблемах и опасности уколов в деревенской местности.

1. Если работник здравоохранения или целитель хочет сделать вам инъекцию, убедитесь в том, что лекарство *подходит вам* и что он предпринимает все необходимые меры предосторожности.
2. Если врач прописывает инъекции, объясните, что вы живете там, где нет опытного человека, чтобы сделать укол и попросите, если это возможно, выписать лекарство для приема вовнутрь.

Если врач хочет выписать инъекции витаминов, печеночного экстракта или витамина B12, но не проверил вашу кровь, скажите ему, что вы предпочитаете вызвать другого врача.

СЛУЧАИ, КОГДА ОЧЕНЬ ВАЖНО СРОЧНО СДЕЛАТЬ ИНЪЕКЦИЮ

При следующих болезнях постарайтесь побыстрее выполнить медицинскую помощь. Если произойдет какая-либо задержка в получении помощи или в доставке больного в центр здоровья, сделайте инъекцию подходящего лекарства как можно скорее. Для уточнения дозировки прочтите внимательно список представленный ниже. Прежде чем сделать инъекцию, выясните все о возможных побочных эффектах и примите нужные меры предосторожности.

↓ От этих болезней	↓ Делайте инъекции этих лекарств
Тяжелая пневмония (с. 171) Инфекции после родов (с. 276)	пенициллин в больших дозах (с. 352) Гангрена (с. 213)
Столбняк (с. 122)	пенициллин (с. 351) сыворотка от столбняка (с. 389) фенобарбитал (с. 389) или диазепам (с. 390)
Аппендицит (с. 94) Перитонит (с. 94) и пулевая или другая колотая рана живота	ампициллин в сильных дозах (с. 353) или пенициллин со стрептомицином (с. 354)
Укусы ядовитых змей (с. 105) Укус скорпиона (у детей, с. 106)	антитоксин от яда змей (с. 388) , антитоксин от яда скорпионов (с. 388)
Менингит (с. 185), когда вы не подозреваете туберкулез	ампициллин (с. 353, 354) или пенициллин (с. 352) в очень больших дозах
Менингит (с. 185), когда вы подозреваете туберкулез	ампициллин или пенициллин вместе со стрептомицином (с. 353, 354) и, если возможно, другие противотуберкулезные препараты (с. 361)
Рвота (с. 161), когда ее нельзя сдержать	антигистамины, например дипразин (Пипольфен) (с. 386)
Сильная аллергическая реакция аллергический шок (с. 76) и сильная астма (с. 167)	эпинефрин (Адреналин, с. 385) и, если возможно, дифенгидрамин (Димедрол), с. 387)
При следующих хронических заболеваниях также применяют уколы, но они редко бывают срочными. По поводу лечения лучше проконсультироваться с работником здравоохранения.	
Туберкулез (с. 179, 180)	стрептомицин (с. 363) вместе с другими лекарствами от туберкулеза (с. 361)
Сифилис (с. 237)	эбензатин пенициллина в очень высоких дозах (с. 238)
Гонорея (с. 236)	канамицин или пенициллин (с. 360)



КОГДА НЕ НУЖНЫ ИНЪЕКЦИИ:

Никогда не делайте инъекции, если можете быстро получить медицинскую помощь.

Никогда не делайте инъекции, если болезнь не очень серьезная.

Никогда не делайте уколы от простуды или гриппа.

Никогда не делайте инъекции тех лекарств, что не рекомендуются от болезни, которую вы хотите лечить.

Никогда не делайте инъекции лекарств, пока вы не выясните и не примените все рекомендуемые меры предосторожности.

ЛЕКАРСТВА НЕ ДЛЯ ИНЕКЦИЙ

Вообще, лучше никогда не использовать для инъекций следующие лекарства:

1. **Витамины.** Редко инъекции витаминов лучше, чем витамины принимаемые вовнутрь. Инъекции намного дороже и опаснее. Пользуйтесь лучше витаминами в пилюлях и сиропах, чем в инъекциях. Еще лучше есть пищу, богатую витаминами (см. с. 111).
2. **Печеночный экстракт и витамин В₁₂.** Не используйте их для инъекций! Они могут вызвать абсцессы или опасные реакции (шок, с. 70). Пилюли, содержащие железо, почти при всех случаях анемии принесут больше пользы (см. с. 393).
3. **Кальций.** Вводить в вены кальций очень опасно, если не делать это очень медленно. Инъекция в ягодицы может вызвать большой абсцесс. Люди без опыта никогда не должны делать инъекции кальция.
4. **Пенициллин.** Почти все инфекции, которые требуют лечения пенициллином, могут эффективно лечиться препаратами группы пенициллина в таблетках. Пенициллин опаснее в инъекциях. Пользуйтесь пенициллином для уколов только при очень опасных инфекциях.
5. **Пенициллин со стрептомицином.** Как правило, избегайте этого комбинированного лекарства. Никогда не пользуйтесь им при простуде или гриппе, потому что оно не действует. Оно может вызвать серьезные проблемы: глухоту или даже смерть. Кроме того, злоупотребление им затрудняет лечение туберкулеза и других серьезных болезней.
6. **Левомецетин или тетрациклин.** Эти лекарства действуют намного лучше, если их глотают. Лучше пользуйтесь капсулами или сиропами, чем уколами (с. 356 и 357).
7. **Внутривенные (В.В.) растворы.** Они употребляются только при сильном обезвоживании и вводятся человеком с большим опытом. Когда их вводят неправильно, они могут вызвать опасные инфекции или смерть (с. 53).
8. **Внутривенные лекарства.** Вводить в вены лекарства настолько опасно, что это могут делать лишь высококвалифицированные работники здравоохранения. Никогда не делайте в мышцы (ягодицы) инъекции лекарств, на которых написано: "Только для внутривенных инъекций". Также никогда не делайте уколы в вену лекарствами, на которых написано: "Только для внутримышечных инъекций".

РИСК И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При инъекции любых лекарств опасность представляют: (1) инфекции, вызванные микробами, входящими с иглой, и (2) аллергические или отравляющие реакции, вызванные самим лекарством.

1. Чтобы уменьшить шанс заражения при уколах, необходимо тщательно соблюдать максимальную чистоту. Очень важно перед инъекцией прокипятить иглу и шприц. После кипячения не трогайте иглу пальцами или еще чем-нибудь.

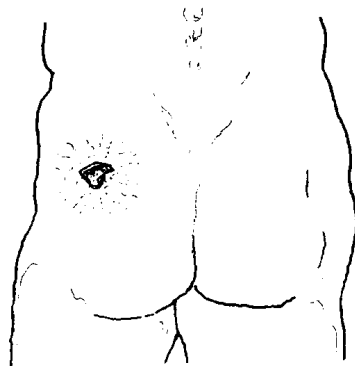
Никогда не пользуйтесь без повторного кипячения той же самой иглой и шприцем, чтобы сделать укол еще одному больному. Внимательно следуйте инструкциям для уколов (см. следующие страницы).

Убедитесь, что вы хорошо вымыли руки, прежде чем подготовить или сделать инъекцию.

2. Очень важно знать, какие реакции может вызвать лекарство, и принять все меры предосторожности перед тем, как делать укол.

Если появились какие-нибудь признаки аллергии или отравления, никогда не давайте то же самое или подобное лекарство:

- крапивница или сыпь с зудом;
- отечность;
- затрудненное дыхание;
- признаки шока (см. с. 70);
- головокружения с тошнотой (желание вырвать);
- проблемы зрения;
- звон в ушах или глухота;
- сильная боль в спине;
- затрудненное мочеиспускание.



Абсцесс, подобный этому, возникает при инъекциях иглой, которую плохо прокипятили и она оказалась не стерильной (абсолютно чистой и без микробов).



Крапивница, или сыпь с зудом, может появиться через несколько часов или через несколько дней после инъекции. Если больному опять дать то же самое лекарство, это может вызвать очень сильную реакцию или даже смерть (см. с. 70).

Этому ребенку сделали укол иглой, которая не была стерильной (прокипяченной и абсолютно чистой от микробов).

Грязная игла стала причиной инфекции, которая вызвала большой, болезненный нарыв (мешок гноя) и высокую температуру у ребенка. В конце концов, нарыв прорвался, как показано на нижнем рисунке.

Этому ребенку сделали укол от простуды. Было бы лучше не давать ему вообще никаких лекарств. Получилось так, что вместо пользы инъекция принесла ребенку больше вреда и страданий.

ОСТОРОЖНО: Если возможно, всегда давайте лекарство внутрь вместо того, чтобы делать инъекции, – особенно детям.



Как избежать проблем, подобных этим:

Делайте уколы, когда это абсолютно необходимо.

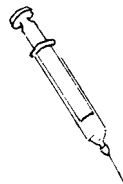
- ◆ Кипятите шприц и иглу прямо перед уколом и соблюдайте все предосторожности, чтобы сохранить их абсолютно чистыми.
- ◆ Пользуйтесь лекарством, которое рекомендуется только от этой болезни, и убедитесь в том, что оно в хорошем состоянии и не испортилось.
- ◆ Делайте укол в правильном месте. Не делайте инъекций младенцам и маленьким детям в ягодицы. Вместо этого сделайте укол выше, в наружную часть бедра. (Обратите внимания, что этому ребенку сделали укол **так низко** в ягодицу, где можно повредить нерв.)

ОПАСНЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ ИНЪЕКЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЛЕКАРСТВ

Следующая группа лекарств иногда вызывает опасную реакцию, называемую АЛЛЕРГИЧЕСКИМ ШОКОМ, вскоре после инъекции:

- пенициллин (включая ампициллин);
- антитоксины, произведенные из лошадиной сыворотки.

} противоядия от укусов
скорпионов и змей
антитоксин от столбняка



Риск серьезной реакции выше у больного, которому делали уже инъекции одним из этих лекарств или другим из этой же группы. Этот риск особенно велик, если препарат вызвал аллергическую реакцию (крапивницу, сыпь, зуд, отек или одышку) через несколько часов или дней после укола.



Очень редко АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ШОК может быть результатом укуса осы или пчелы или лекарства, принятого внутрь через рот.



Чтобы предупредить серьезную реакцию от укола:

1. Делайте уколы только тогда, когда это абсолютно необходимо.
2. Перед тем как сделать укол одним из лекарств, упомянутых выше, приготовьте 2 ампулы эпинефрина (адреналина, с. 385) и ампулу антигистамина типа дипразина (Пипольфена, с. 386) или дифенгидрамина (Димедрола, с. 387).
3. Перед уколом всегда поинтересуйтесь, вызывала ли когда-либо у больного подобная инъекция зуд или другие реакции. Если да, то не используйте это или любое другое лекарство этой же группы ни для уколов, ни для глотания.
4. В очень серьезных случаях, подобных столбняку или укусу змеи, если существует шанс, что антитоксин может вызвать аллергическую реакцию (если человек страдает от аллергии или астмы или он принял лошадиную сыворотку перед этим), сделайте укол дипразина (Пипольфена) или дифенгидрамина (Димедрола) за 15 мин до антитоксина: взрослым от 25 до 50 мг; детям от 10 до 25 мг в зависимости от их веса (см. с. 387).
5. После инъекции любого лекарства всегда оставайтесь с больным не менее 30 минут, чтобы проследить за появлением любого из следующих признаков АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ШОКА:
 - холодная, влажная, бледная, серая кожа (холодный пот);
 - слабый, частый пульс или сердцебиение;
 - одышка;
 - потеря сознания.
6. Если эти признаки появляются, немедленно введите эпинефрин (Адреналин): взрослым 1/2 мл; детям 1/4 мл. Выведите больного из состояния ШОКА (см. с. 77). Дайте двойную дозу антигистамина.

КАК ИЗБЕЖАТЬ СЕРЬЕЗНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ ИНЪЕКЦИЯХ ПЕНИЦИЛЛИНА?

1. При легких и умеренных инфекциях:

давайте пилюли
пенициллина



вместо инъекций.



2. Перед инъекцией спросите у больного:

“У вас были сыпь, зуд
отек или одышка
после инъекций

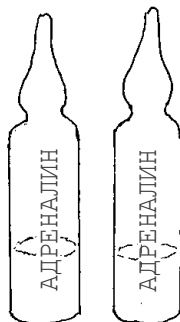
пеницил-
лина?”



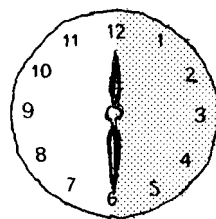
Если он ответит положительно, не используйте пенициллин или ампициллин. Используйте другой антибиотик типа эритромицина (с. 355) или сульфаниламид (с. 358).

3. Перед инъекцией пенициллина:

всегда держите
наготове ампулы с
ЭПИНЕФРИНОМ
(Адреналином).

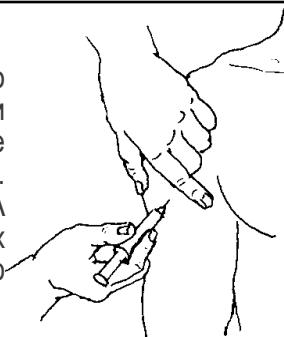


4. После инъекции:



оставайтесь с больным
еще на 30 минут.

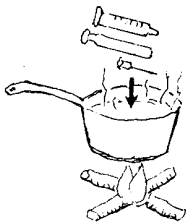
5. Если больной начинает сильно бледнеть, у него учащается пульс, затрудняется дыхание или он начинает терять сознание, срочно сделайте внутримышечно (или просто под кожу — см. с. 167) инъекцию половины ампулы ЭПИНЕФРИНА (Адреналина, четверть ампулы для маленьких детей) и, если это необходимо, повторите инъекцию через 10 минут.



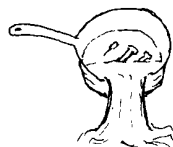
КАК ПРИГОТОВИТЬ ШПРИЦ ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ

Прежде чем приготовить шприц, **вымойте руки водой с мылом.**

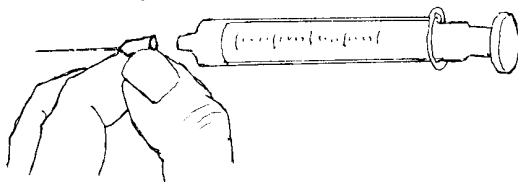
1. Возьмите отдельно шприц и кипятите его и иглу 20 минут.



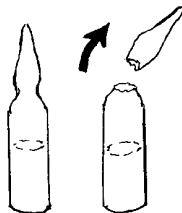
2. Слейте кипяченую воду, не прикасаясь к шприцу или к игле.



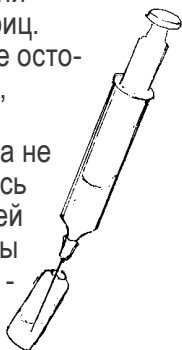
3. Соедините вместе шприц и иглу, прикасаясь только к основанию иглы и кнопке поршня.



4. Протрите хорошо ампулу дистиллированной водой и отломите верхушку.



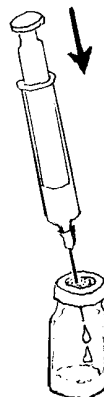
5. Наполните шприц. (Будьте осторожны, чтобы игла не касалась внешней стороны ампулы).



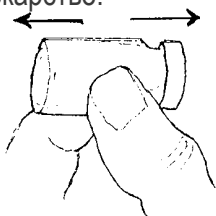
6. Протрите резиновую пробку флакона чистой тряпочкой, смочив ее спиртом или кипяченой водой.



7. Введите дистиллированную воду в пузырек с порошком.



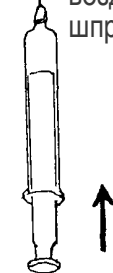
8. Встряхивайте, пока не растворится лекарство.



9. Наполните шприц опять.



10. Удалите весь воздух из шприца.

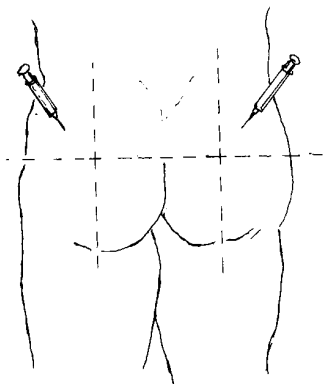


Будьте очень осторожны, чтобы не прикоснуться чем-нибудь к иглке, даже ваткой со спиртом. Если случайно вы прикоснулись к игле своим пальцем или еще чем-нибудь, кипятите ее снова.

КУДА ДЕЛАТЬ УКОЛ?

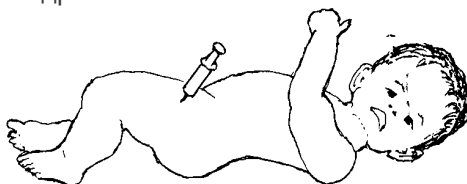
Перед уколом **вымойте руки водой с мылом.**

Предпочтительнее делать инъекцию в мышцу ягодиц, всегда в **верхней внешней четверти.**



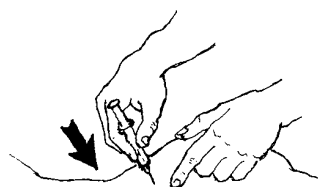
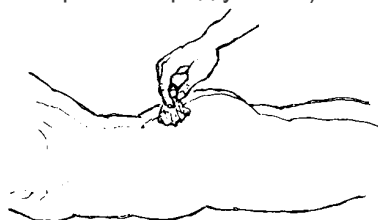
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не делайте инъекцию на том участке кожи, который инфицирован или покрыт сыпью.

Не делайте уколы младенцам и маленьким детям в ягодицу. Делайте укол в верхнюю внешнюю часть бедра.

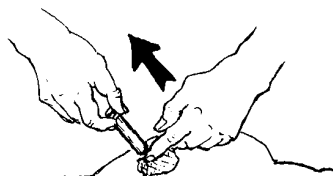
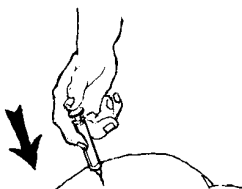
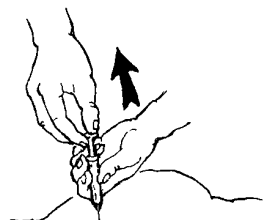


КАК КОЛОТЬ?

1. Протрите кожу мылом и водой (или спиртом — но чтобы не допустить сильной боли, убедитесь, что спирт испарился перед уколом).
2. Вводите иглу прямо. (Если это сделано одним быстрым движением, то боль будет меньше).



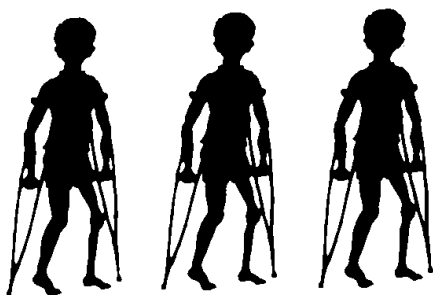
3. Перед уколом потяните назад поршень (если кровь попала в шприц, вытащите иглу и введите ее в другое место).
4. Е с л и крови нет, лекарство вводите медленно.
5. Вытащите иглу и протрите кожу опять.



6. После укола сразу прополощите шприц и иглу. Пропустите воду через иглу, затем отделите шприц от иглы и промойте его. Кипятите снова перед потреблением.

КАК УКОЛЫ МОГУТ ИСКАЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ?

При правильном применении инъекции определенных лекарств важны для здоровья. Вакцины, включая и те, которые вводят уколами, помогают защитить здоровье детей и предупредить увечья. Однако, чтобы уменьшить случаи паралича от полиомиелита, лучше сделать вакцинацию (иммунизацию) или другие инъекции, когда у ребенка температура или признаки простуды. Это может быть легкая инфекция полиомиелита без паралича. Если так, раздражение, вызванное инъекцией, может привести к **постоянному параличу** от полиомиелита. Некоторые эксперты считают, что **ежегодно до 2 миллионов детей поражается параличом при полиомиелите из-за инъекций. Большинство этих инъекций не нужны.**



каждый третий случай полиомиелита
вызван инъекциями

Чтобы получить больше информации о том, как инъекции калечат детей, см. *Искалеченные Деревенские Дети*, Глава 3.

Чтобы убедить людей в опасности и бесполезности инъекций, см. Пособие Для Работников Здравоохранения, Глава 18, 19 и 20.

КАК ЧИСТИТЬ (СТЕРИЛИЗОВАТЬ) ИНСТРУМЕНТЫ

Многие инфекционные болезни, такие как СПИД (см. с. 399), гепатит (см. с. 172) и столбняк (см. с. 182), могут передаваться от больного человека к здоровому через шприц, иглоу или другие инструменты, если их не стерилизовать (сюда включаются инструменты для прокола ушей, акупунктура, татуировки или обрезания). Многие кожные инфекции и абсцессы тоже начинаются с этого. **В любом случае для надреза или прокола кожи следует пользоваться только стерильным инструментом.**

Вот несколько способов стерилизации инструментов:

- Прокипятить 20 минут. (Если у вас нет часов, бросьте в воду 1 или 2 зерна риса. Когда рис сварится, инструмент будет простерилизован).
- Или пропарить 15 минут в особом котле (автоклав).
- Или замочить на 20 минут в растворе из 1 части хлорной извести и 7 частей воды, или в растворе 70% этилового спирта. Если это возможно, готовьте свежие растворы каждый день, поскольку они теряют силу. (Убедитесь, что шприц простерилизован внутри, набирая немного раствора внутрь, а затем выпуская его).

Когда вы помогаете больному с инфекцией, почаще мойте руки водой с мылом.

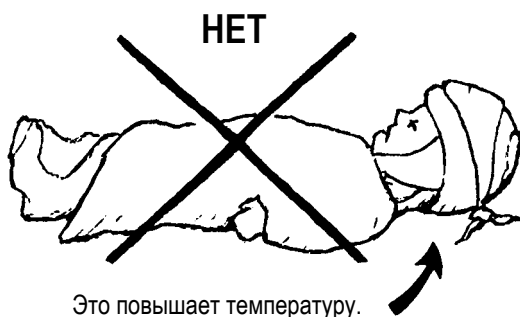
ЖАР

Когда температура тела больного слишком высокая, мы говорим, что у него жар. Жар сам по себе является не болезнью, а признаком многих болезней. Однако высокая температура может быть опасной, особенно для маленьких детей.

Когда у больного жар:

1. Разденьте его полностью.

Маленьких детей необходимо полностью раздеть и оставить голыми, пока не спадет температура



Никогда не закутывайте ребенка в одежду или в одеяло.

Закутывать ребенка с температурой опасно.

Свежий воздух или ветерок не навредят больному с температурой. Наоборот, свежий ветерок помогает снизить температуру.

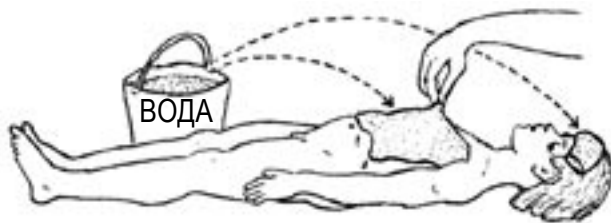
2. Дайте аспирин, чтобы снизить температуру (см. с. 379). Маленьким детям безопаснее дать ацетаминофен (парацетамол, с. 380). Будьте осторожны, не давайте слишком много.
3. Любому, у кого высокая температура, следует пить как можно больше воды, соков и других жидкостей. Для маленьких детей, особенно для младенцев, воду следует сначала прокипятить (а затем остудить). Убедитесь, что ребенок регулярно мочится. Если у него недостаточное выделение мочи или она темная, дайте еще больше воды.
4. Когда возможно, определите и лечите причину жара.

ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ЖАР

Слишком высокая температура может быть очень опасной, если она долго не спадает. Она может вызвать припадки (конвульсии) или даже постоянное мозговое нарушение (паралич, замедление умственного развития, эпилепсию и т.д.). Высокая температура особенно опасна для маленьких детей.

Когда температура поднимается очень высоко (выше 40°), ее надо снижать немедленно:

1. Положите больного в прохладное место.
2. Снимите всю одежду.
3. Обмахивайте его.
4. Полейте больного прохладной (не холодной) водой или положите тряпочки, намоченные в прохладной воде, ему на грудь и на лоб. Проветривайте одежду и меняйте ее почаще, чтобы она оставалась прохладной. Продолжайте делать это до тех пор, пока не снизится температура (ниже 38°).



5. Дайте ему выпить побольше прохладной (не холодной) воды.
6. Дайте ему лекарство, чтобы снизить жар. Хорошо помогают аспирин или ацетаминофен.

Дозировка для аспирина или ацетаминофена (при употреблении 300 мг взрослой таблетки):

Больному старше 12 лет : 2 таблетки каждые 4 часа.

Детям от 6 до 12 лет : 1 таблетку каждые 4 часа.

Детям от 3 до 6 лет : 1/2 таблетки каждые 4 часа.

Детям до 3 лет : 1/4 таблетки каждые 4 часа.

Примечание: Ацетаминофен безопаснее, чем аспирин, для ребенка моложе 12 лет, у которого простуда, грипп или ветрянка (см. с. 379).

Если больной с жаром не может глотать таблетки, разотрите их, смешайте порошок с водой и введите в анус клизмой или шприцом без иглы.

Если жар быстро не снижается или если начались припадки (конвульсии), продолжайте охлаждение водой и обращайтесь за медицинской помощью.

ШОК

Шок – угрожающее жизни состояние, которое может быть результатом сильного ожога, большой потери крови, тяжелой болезни, обезвоживания или тяжелой аллергической реакции. Сильное внутреннее кровотечение – хотя его и не видно – тоже может вызвать шок.

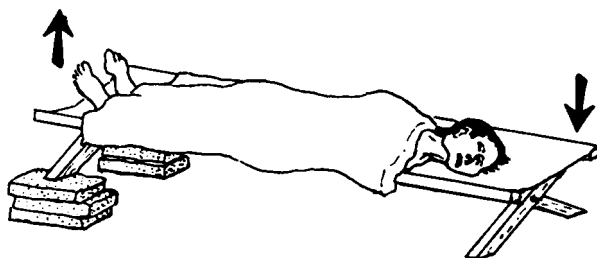
Признаки ШОКА:

- слабый, частый пульс (более 100 ударов в минуту);
- “холодный пот”: бледная, холодная, влажная кожа;
- кровяное давление падает до опасного уровня;
- помрачение рассудка, слабость или потеря сознания.

Что делать для предупреждения или лечения шока:

При первых признаках шока или если существует риск шока . . .

- ◆ Положите человека так, чтобы его ноги были чуть выше головы, как здесь:



Однако если у него сильная головная травма, приведите его в полусидячее положение (с. 91).

- ◆ Остановите любое кровотечение.
- ◆ Если больному холодно, укройте его одеялом.
- ◆ Если он в сознании и может пить, давайте ему глотками воду или другие напитки. Если он выглядит обезвоженным, дайте ему побольше жидкости и регидрон (с. 152).
- ◆ Лечите раны, если они у него есть.
- ◆ Если у него сильная боль, дайте ему аспирин или другое болеутоляющее лекарство, но **без успокаивающего**, такого как кодеин.
- ◆ Держитесь спокойно и успокаивайте больного.

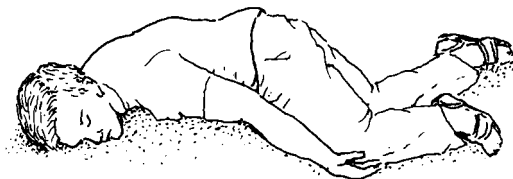
Если больной без сознания:

- ◆ Положите его на бок головой вниз, как показано на верхнем рисунке. Если вам кажется, что он задыхается, вытяните своими пальцами его язык.
- ◆ Если у него рвота, немедленно очистите ему рот. Убедитесь, что его голова внизу, откинута назад и лежит на одной стороне так, чтобы он не вдохнул рвоту в свои легкие.
- ◆ Не давайте ему в рот ничего, пока он без сознания.
- ◆ Если вы или кто-нибудь рядом знает как это сделать, введите быстрыми каплями внутривенный раствор (нормальный физиологический раствор).
- ◆ Обратитесь побыстрее за медицинской помощью.

ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ

Обычными причинами потери сознания являются:

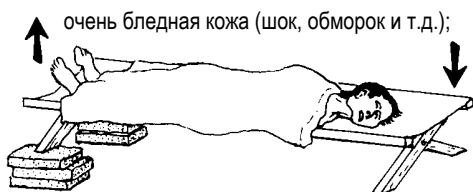
- пьянство;
- удар по голове (сшибающий с ног удар);
- шок (с. 77);
- припадки (с. 178);
- отравление (с. 103);
- обморок (от испуга, слабости и др.);
- тепловой удар (с. 81);
- паралич (с. 327);
- сердечный приступ (с. 25).



Если больной без сознания и вы не знаете почему, **немедленно проверьте следующее:**

1. Хорошо ли он **дышит**? Если нет, наклоните его голову назад, вытяните челюсть и язык вперед. Если что-то застряло у него в горле, вытащите это. Если он не дышит, сделайте сразу искусственное дыхание рот в рот (см. с. 80).
2. Потерял ли он **много крови**? Если так, остановите кровотечение (с. 82).
3. Находится ли он **в шоке** (влажная, бледная кожа: слабый, частый пульс)? Если так, уложите его, чтобы голова была ниже ног, и освободите от одежды (с. 77).
4. Может, это **тепловой удар** (нет пота, высокая температура, горячая, красная кожа)? Если так, заслоните его от солнца, поддерживайте его голову выше ног, облейте его холодной водой (если можно, ледяной) и обмахивайте его (с.81).

Как положить больного без сознания:



Если существует вероятность, что у человека без сознания тяжелая травма:

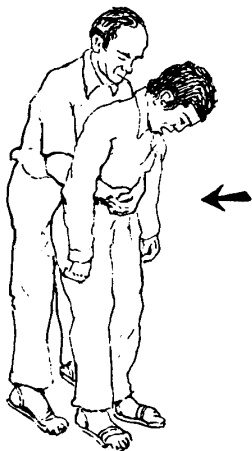
Лучше не двигать его, пока он не придет в сознание. Если вам нужно перенести его, делайте это крайне осторожно, потому что если его спина или шея сломаны, любое изменение положения может усилить травму (см. с. 100).

Осмотрите раны или сломанные кости, но поворачивайте больного по возможности осторожно. Не сгибайте его спину или шею.

Никогда ничего не давите человеку без сознания через рот.

КОГДА ЧТО-ТО ЗАСТРЯЛО В ГОРЛЕ

Когда еда или что-то застревает в горле человека и он не может дышать, сделайте следующее:



- станьте за ним и обхватите его своими руками вокруг талии;
- положите кулак на его живот выше пупка и ниже ребер;
- и надавите на живот отрывистым толчкообразным движением вверх.



УДУШЬЕ

Это выталкивает воздух из его легких и освобождает горло. Если необходимо, повторите несколько раз.

Если больной намного больше вас или уже без сознания, быстро сделайте следующее:

- Положите его на спину.
- Наклоните голову на бок.
- Присядьте над ним, положив нижние части ладоней на его живот между пупком и ребрами. (Полным людям, беременным женщинам, людям в инвалидных колясках, маленьким детям кладите руки на грудь, а не на живот.)
- Сделайте быстрый сильный толчок снизу вверх.
- Повторите несколько раз, если необходимо.
- Если он все-таки не может дышать, попробуйте **дыхание рот в рот** (см. след. с.).

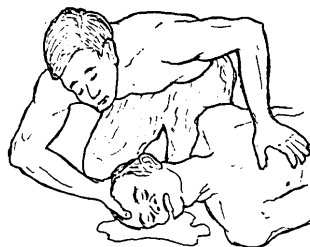


УТОПЛЕНИЕ

Человек, у которого остановилось дыхание, продолжает жить лишь 4 минуты! Вы должны **действовать быстро!**

Сразу же начните дыхание рот в рот (см. след. с.). Если возможно, то даже не тогда, когда тонувшего оттащили на берег, а как только будет довольно мелкое место, чтобы можно было делать дыхание рот в рот.

Если вы не сможете вдохнуть воздух в его легкие, то когда достигнете берега, быстро положите его на бок, чтобы голова была ниже ног, и нажмите на живот, как описано выше. Затем сразу продолжайте дыхание рот в рот.



**ВСЕГДА СРАЗУ НАЧИНАЙТЕ С ДЫХАНИЯ РОТ В РОТ
прежде, чем попытаетесь выдавить воду из груди утопающего.**

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДЫХАНИЕ: ДЫХАНИЕ РОТ В РОТ

Обычные причины остановки дыхания:

- что-то застряло в горле;
- язык или густая мокрота закрывает горло человека без сознания;
- утопление, удушье от дыма или отравление;
- сильный удар по голове или груди;
- сердечный приступ.

Человек может умереть через 4 минуты после того как остановилось дыхание.

Если у человека остановилось дыхание, начинайте НЕМЕДЛЕННО дыхание рот в рот.

Делайте все как можно быстрее.

Шаг 1: Быстро вытащите пальцем вещь, которая застряла во рту или в горле. Вытяните язык вперед. Если есть мокрота в горле, постарайтесь горло быстро очистить от нее.



Шаг 2: Быстро, но осторожно, положите больного лицом вверх. Осторожно запрокиньте его голову назад и вытяните вперед челюсти.

Шаг 3: Зажмите своими пальцами его ноздри, пошире откройте ему рот, закройте его рот своим и сильно выдохните в его легкие, так, чтобы у него поднялась грудь. Подождите, чтобы воздух вышел, и выдохните снова. Повторяйте это через каждые 5 секунд. Младенцам и маленьким детям закройте нос и рот своим ртом и дышите очень осторожно каждые 3 секунды.



Продолжайте **дыхание рот в рот** до тех пор, пока человек сможет дышать сам или пока минует опасность его гибели. Иногда приходится делать это в течение часа или больше.

ТРАВМЫ, ВЫЗВАННЫЕ ПЕРЕГРЕВОМ

Судороги при Перегреве

В жаркую погоду у людей, которые тяжело работают и сильно потеют, появляются иногда болезненные судороги в ногах, руках или желудке. Это вызвано недостатком соли в организме.

Лечение: Бросьте чайную ложку соли на литр кипяченой воды и выпейте ее. Повторяйте каждый час, пока не прекратятся судороги. Посадите или положите больного в прохладное место и осторожно массируйте болезненные места.



Истощение от Перегрева

Признаки: У человека, который работает и сильно потеет в жаркую погоду, может появиться бледность, слабость, тошнота, и он может упасть в обморок. Кожа прохладная и влажная. Пульс быстрый и слабый. Температура тела обычно нормальная (с. 31).

Лечение: положите человека в прохладное место, поднимите его ноги и разотрите ему голени. Дайте выпить соленой воды: 1 ч. ложка на литр воды. (Ничего не давайте в рот, пока больной без сознания).

Тепловой Удар

Тепловой удар случается редко, но он очень опасен. Он особенно поражает старых людей и алкоголиков в жаркую погоду.

Признаки: Кожа красная, очень горячая и сухая. Даже подмышки не влажные. У человека очень высокая температура, иногда выше 42°C. Часто он бывает без сознания.

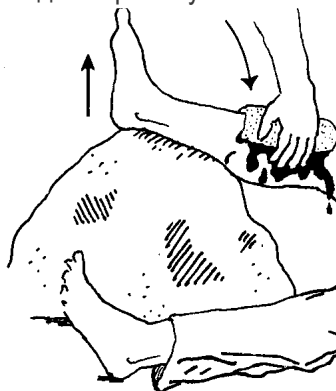
Лечение: Нужно немедленно снизить температуру тела у больного. Положите больного в тень. Протирайте его холодной водой (если возможно, ледяной) и обмахивайте. Продолжайте делать это, пока не упадет температура. Обратитесь за медицинской помощью.

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ "ИСТОЩЕНИЕМ ОТ ПЕРЕГРЕВА" И "ТЕПЛОВЫМ УДАРОМ":	
ИСТОЩЕНИЕ ОТ ПЕРЕГРЕВА	ТЕПЛОВОЙ УДАР:
• потная, бледная, холодная кожа; • большие зрачки; • нет температуры; • слабость.	• сухая, красная, горячая кожа; • сильный жар; • человек очень болен или без сознания.

О травмах, вызванных холодом, см. с. 408 и 409.

КАК ОСТАНОВИТЬ КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ РАНЫ:

1. Поднять раненую часть.



2. Чистой тряпочкой (или рукой, если нет тряпочки) нажмите прямо на рану. Продолжайте нажимать, пока не остановится кровотечение. Это может занять у вас 15 минут, а иногда час или больше. Такого типа прямое нажатие остановит кровотечение почти из всех ран — иногда даже, когда отрезана часть тела.

Если это останавливает кровотечение и если больной теряет много крови, делайте следующее:



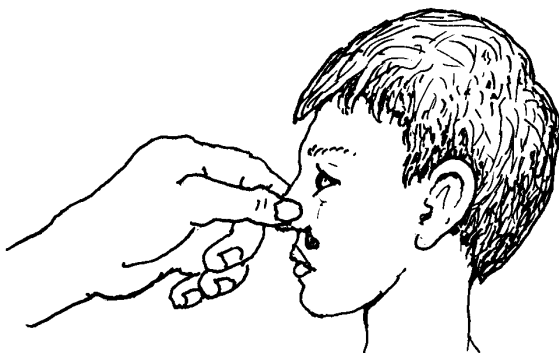
- ◆ Продолжайте нажимать на рану.
- ◆ Держите раненую часть как можно выше.
- ◆ Перевяжите руку или ногу как можно ближе к ране — между раной и телом. Стяните вращением палочки так, чтобы кровотечение остановилось.
- ◆ Для повязки используйте сложенную ткань или широкий пояс; никогда не пользуйтесь тонким жгутом, веревкой или проводом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перевязывайте конечность, если только кровотечение сильное и нельзя остановить нажатием на вену.
- Ослабляйте повязку каждые полчаса, чтобы убедиться, что она еще нужна, и чтобы циркулировала кровь. Оставляя ее надолго, можно повредить руку или ногу так, что ее нужно будет отрезать.
- Никогда не пользуйтесь грязью, керосином, известью или кофе для остановки кровотечения.
- Если кровотечение или травма сильная, поднимите ноги и опустите голову, чтобы предупредить шок (см.с.77).

КАК ОСТАНОВИТЬ КРОВЬ ИЗ НОСА?

1. Сидите спокойно.
2. Высморкайтесь осторожно, чтобы освободить нос от слизи и крови.
3. Крепко зажимайте нос в течение 10 минут или пока не прекратится кровотечение.



Если это не останавливает кровотечение, тогда ...

Введите в ноздри тампон из ваты, оставляя его кончик снаружи. Если это возможно, сначала намочите ватку перекисью водорода, **вазелином**, соком алое (с. 13) или лидокаином с адреналином (с. 381).

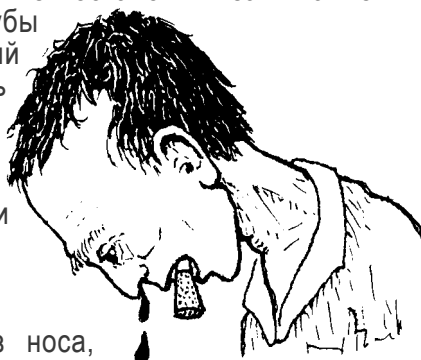


Затем снова крепко зажмите нос. Подержите так 10 минут или больше. Не откидывайте голову назад.



Оставьте тампон в носу на несколько часов после остановки кровотечения; затем осторожно вытащите его.

Особенно у старых людей кровотечение может идти из задней стенки носа и его нельзя остановить зажиманием. В таком случае больной должен взять в зубы пробку, початок кукурузы или другой подобный предмет и, наклонившись вперед, посидеть спокойно и стараться не глотать до тех пор, пока не остановится кровотечение. (Пробка помогает удержаться от глотательных движений, а это дает возможность крови свернуться).



Предупреждение:

Если у человека часто идет кровь из носа, смазывайте небольшим количеством **вазелина** внутри ноздрей два раза в день. Или втягивайте соленую воду в нос (см. с. 164).

Питание апельсинами, помидорами и другими фруктами может помочь укрепить вены так, чтобы нос кровоточил реже.

ПОРЕЗЫ, ЦАРАПИНЫ И МАЛЕНЬКИЕ РАНЫ

Чистота имеет первостепенное значение для предупреждения инфекции и помощи в исцеления ран.

Чтобы лечить раны . . .

Сначала очень хорошо вымойте руки водой с мылом.

Затем обмойте кожу вокруг раны холодной кипяченой водой с мылом

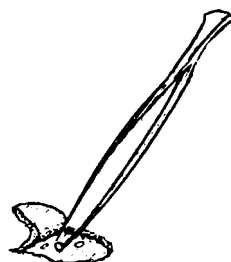
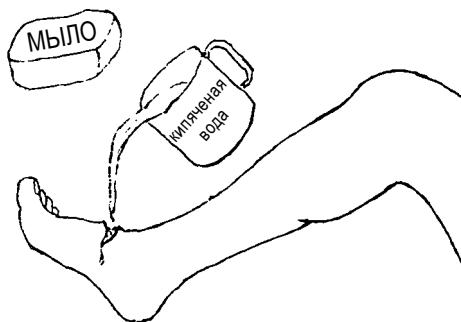
Теперь хорошо промойте рану прохладной кипяченой водой (и мылом, если в ране много грязи. Мыло помогает очистить, но может и повредить кожу).

Когда очищаете рану, постарайтесь осторожно вычистить всю грязь. Приподнимите и очистите под каждым лоскутком кожи. Вы можете использовать чистый пинцет или чистую ткань и марлю, чтобы убрать кусочки грязи, но всегда сначала прокипятите их, чтобы быть уверенными в их стерильности.

Если возможно, промойте рану кипяченой водой из шприца или из резиновой груши.

Любой оставшийся в ране кусочек грязи может вызвать инфекцию.

После того как рана очищена, положите сверху кусочек чистой марли или ткани. Она должна быть достаточно легкой, чтобы воздух мог поступать в рану и способствовать заживлению. Меняйте марлю или ткань каждый день и проверяйте на признаки инфекции (см. с. 88).



НИКОГДА не накладываете на рану животные и человеческие фекалии или грязь. Это может вызвать такие опасные инфекции, как столбняк.

НИКОГДА не капайте спирт, настойку йода или Мерттиолат прямо в рану. Это повредит ткани тела и замедлит заживление.

БОЛЬШИЕ ПОРЕЗЫ: КАК ЗАКРЫТЬ ИХ

Недавний порез, еще чистый, заживет быстрее, если вы соедините концы вместе так, чтобы порез стал закрытым.

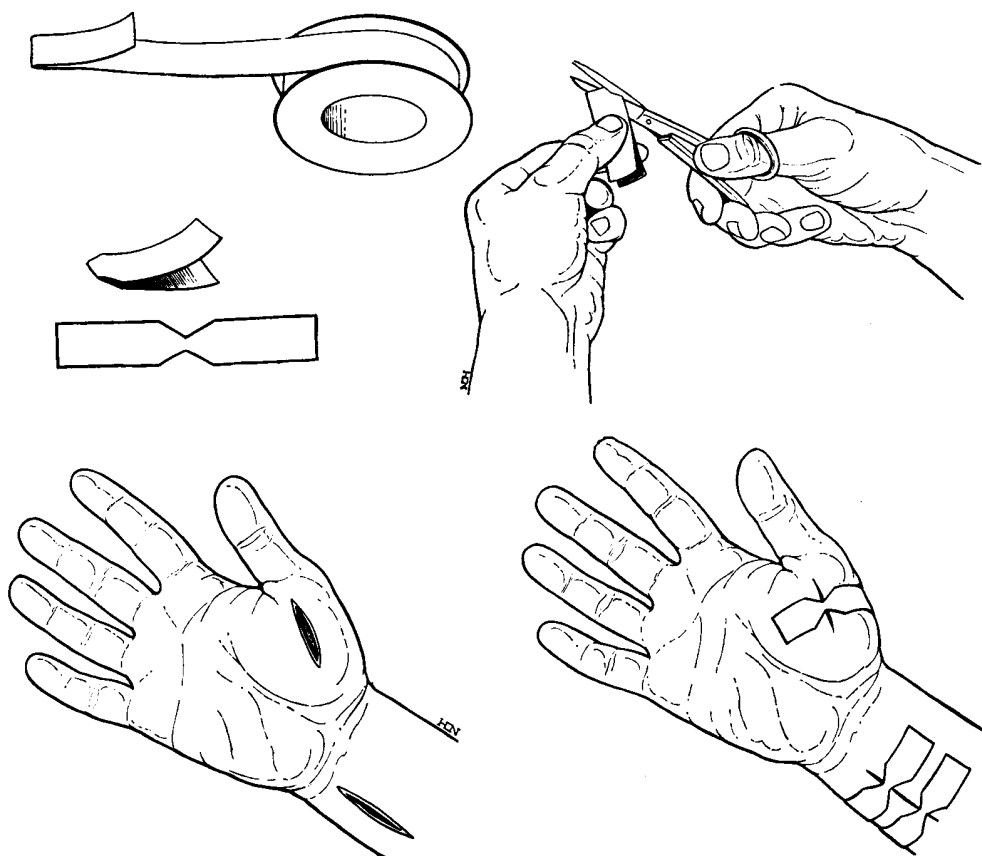
Закрывайте глубокий порез только тогда, когда:

- ране меньше 12 часов.
- рана очень чистая и
- невозможно обратиться к работнику здравоохранения, чтобы закрыть ее в этот же день.

Перед тем как закрыть рану, промойте ее очень хорошо холодной, кипяченой водой (и мылом, если рана грязная). Если можно, то промойте водой из шприца. Надо быть абсолютно уверенным, что грязь или мыло не остались в ране.

Существует два метода закрытия пореза:

ПОВЯЗКА “БАБОЧКА” ИЗ ЛИПКОЙ ЛЕНТЫ

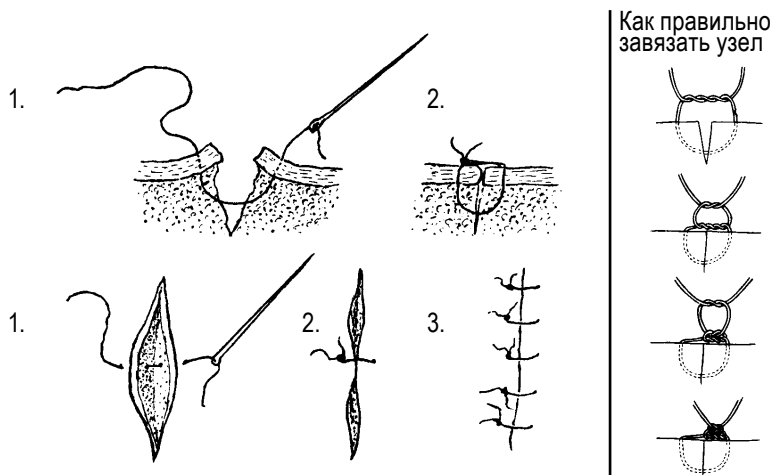


ШВЫ И НАЛОЖЕНИЕ ШВОВ НИТЬЮ

Выясните, надо ли зашивать порез, если края кожи сами сошлись вместе. Если это так, швы не нужны.

Чтобы зашить рану:

- ◆ Прокипятите иглу для шитья и тонкую нитку (нейлоновую или лучше шелковую) в течение 20 минут.
- ◆ Промойте рану прохладной кипяченой водой, как было описано.
- ◆ Очень хорошо вымойте руки кипяченой водой с мылом.
- ◆ Зашейте рану вот так:



1. Сделайте первый стежок в середине раны и плотно стяните его (рис. 1 и 2).
2. Если кожа грубая, удерживайте иглу щипцами (или держателем иглы), которые надо прокипятить.
3. Сделайте столько стежков, сколько нужно чтобы закрыть всю рану (рис. 3).
4. Оставляйте швы на месте 5—14 дней (на лице 5, на теле 10, на ноге или руке 14 дней). Затем снимите швы: отрежьте нитку на одной стороне узла и тяните за узел до тех пор, пока не выйдет нитка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Закрывайте только те раны, которые очень чистые и которым меньше 12 часов. Застаревшие, грязные или инфицированные раны должны оставаться открытыми. Укусы людей, собак, свиней или других животных следует оставлять открытыми. Закрытие этих ран может вызвать опасные инфекции.

Если в закрытой ране появляются признаки инфекции, немедленно снимите швы и оставьте рану открытой (см. с.88).

ПОВЯЗКИ

Повязки помогают содержать раны в чистоте. Поэтому бинты или кусочки ткани, которыми пользуются для перевязки ран должны быть чистыми. Тряпочки, которыми пользуются для перевязки ран, должны быть выстираны, а затем высушены утюгом или на солнце в чистом, не пыльном месте.

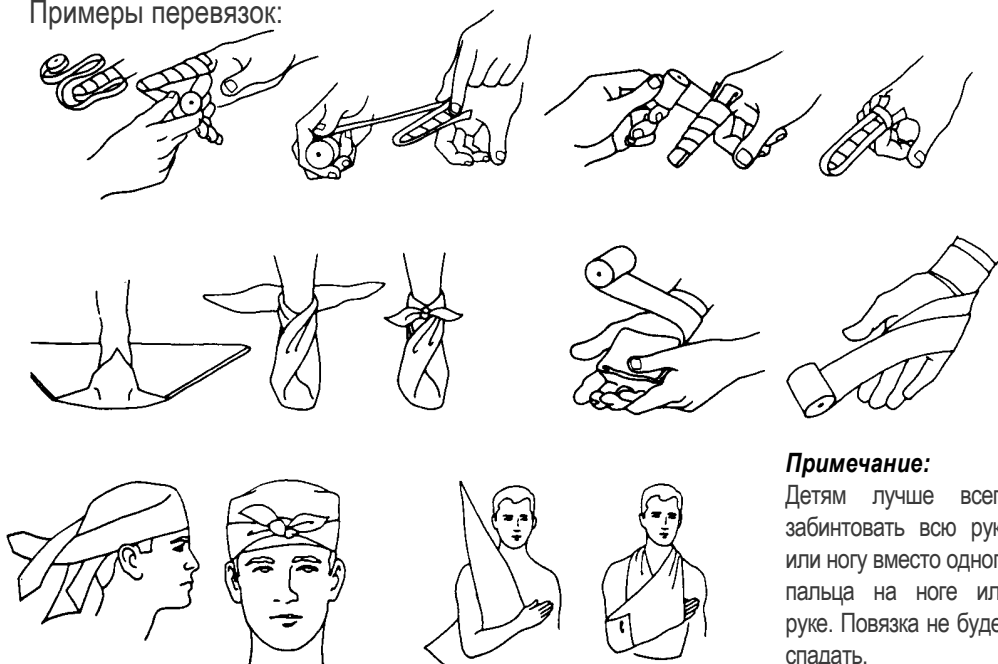
Убедитесь сначала, что рана очищена, как показано на с. 84. Если можно, то перед тем, как перевязывать рану, наложите на нее стерильную марлевую прокладку. Такие прокладки в закрытых пакетах часто продаются в аптеках.

Или приготовьте сами стерильную марлю или ткань. Заверните ее в плотную бумагу, заклейте пластырем и прокалите в духовке 20 минут.

**Лучше не перевязывать рану вообще,
чем делать это грязным или мокрым бинтом.**

Если бинт намок или загрязнился, снимите его, промойте рану снова и наложите чистую повязку. Меняйте ее каждый день.

Примеры перевязок:



Примечание:

Детям лучше всего забинтовать всю руку или ногу вместо одного пальца на ноге или руке. Повязка не будет спадать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Проследите внимательно, чтобы повязка вокруг конечности была не очень тугой, так как это препятствует притоку крови.

Для многих маленьких царапин и порезов повязки не нужны. Они лучше заживают, если их промыть водой с мылом и оставить на открытом воздухе. Самое важное — **содержать их в чистоте.**

ИНФИЦИРОВАННЫЕ РАНЫ: КАК ИХ РАСПОЗНАТЬ И ЛЕЧИТЬ?

Рану можно считать инфицированной, если:

- она становится **красной, опухшей, горячей и болезненной**;
- в ней есть **гной**;
- или если от нее идет **неприятный запах**.

Инфекция распространяется на другие части тела, если:

- она вызывает **жар**;
- появляется **красная полоса над раной**;
- или если **лимфатические узлы становятся опухшими и болезненными**. Лимфатические узлы — часто называемые “гландами” — это маленькие ловушки для микробов, которые образуют небольшие бугорки под кожей, когда в них попадает инфекция.



Лечение инфицированных ран:

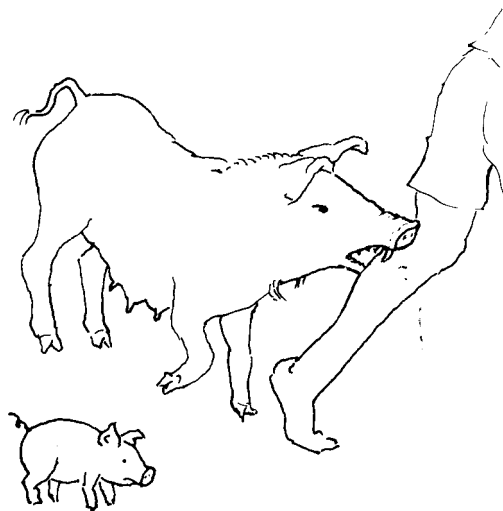
- ◆ Держите горячие компрессы на ране по 20 минут 4 раза в день. Или поддерживайте зараженную руку или ногу в ведре с горячей водой.
- ◆ Поддерживайте зараженную часть тела в спокойном и приподнятом состоянии (поднимите на уровень сердца).
- ◆ Если инфекция серьезная или если больной не был вакцинирован от столбняка, примите антибиотик типа пенициллина (см. с. 351, 352).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если рана плохо пахнет, из нее сочится бурая или серая жидкость или кожа вокруг потемнела и образовались воздушные пузырьки или волдыри, то это может быть гангрена. Немедленно обращайтесь за медицинской помощью. И между тем, следуйте инструкциям по гангрене на с. 213.

РАНЫ, КОТОРЫЕ ВЕРОЯТНО СТАНУТ ОПАСНО ИНФИЦИРОВАННЫМИ

Эти раны весьма вероятно станут опасно инфицированными:

- грязные раны или раны, нанесенные грязными предметами;
- колотые раны или другие глубокие раны, которые сильно не кровоточат;
- раны, нанесенные в местах, где содержатся животные: загоны для скота, свинарники и др.;
- большие раны с серьезным повреждением или кровоизлиянием;
- укусы, особенно свиней, собак или людей;
- пулевые раны.



Особый уход за такой раной “высокого риска”:

1. Промойте рану кипяченой водой с мылом. **Удалите все кусочки грязи, кровяные сгустки и омертвевшую или сильно поврежденную плоть.** Смойте грязь, пользуясь шприцем или резиновой грушей.
2. Если рана очень глубокая, если это укус или есть опасность, что в ней осталась грязь, примите антибиотик. Самый лучший — пенициллин. Если у вас нет пенициллина, воспользуйтесь ампициллином, эритромицином, тетрациклином, ко-тримоксазолом или сульфаниламидом. Дозировку посмотрите в ПРИЛОЖЕНИИ 1.
3. **Никогда** не закрывайте такие раны швами или повязкой “бабочка”. **Оставьте рану открытой.** Если она очень большая, квалифицированный работник здравоохранения или врач сможет закрыть ее позже.

Опасность столбняка очень большая для людей, которые не сделали прививку от этой смертельной болезни. Чтобы снизить риск, человеку, которому не сделали прививку от столбняка, нужно принимать пенициллин или ампициллин сразу после получения раны такого типа, даже если она маленькая.

Если рана такого типа серьезная, человеку, у которого нет прививки от столбняка, нужно принимать большие дозы пенициллина или ампициллина в течение недели или дольше. Антитоксин от столбняка (с. 389) тоже можно принимать, но быть уверенным, что приняты все меры предосторожности со с. 70, если вы пользуетесь антитоксином, приготовленным из лошадиной сыворотки.

ПУЛЕВЫЕ, НОЖЕВЫЕ И ДРУГИЕ ТЯЖЕЛЫЕ РАНЕНИЯ



Опасность инфекции: Любая пулевая или ножевая рана содержит большой риск опасной инфекции. По этой причине следует сразу же принять антибиотик, предпочтительнее пенициллин (с. 351) или ампициллин (с. 353).

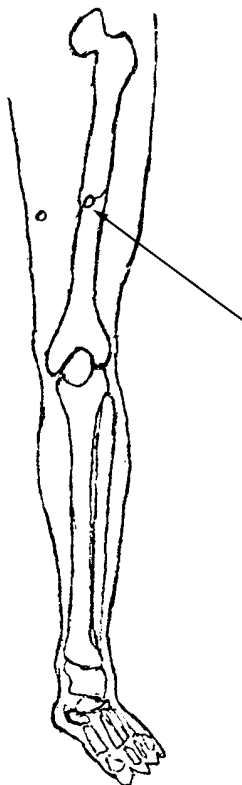
Больным, у которых нет прививки от столбняка, следует, если возможно, сделать инъекцию антитоксина от столбняка (с. 389), а также прививку против столбняка.

Если можно, обратитесь за медицинской помощью.

Пулевые Ранения Рук или Ног



- ◆ Если рана сильно кровоточит, остановите кровотечение как показано на с. 82.
- ◆ Если кровотечение не серьезное, пусть кровь идет некоторое время. Это поможет очистить рану.
- ◆ Промойте рану прохладной кипяченой водой и сделайте чистую повязку. Если рана от огнестрельного оружия, промойте только поверхность (внешнюю часть).
- ◆ Обычно лучше ничего не вкладывать в отверстие раны.
- ◆ Дайте антибиотики.

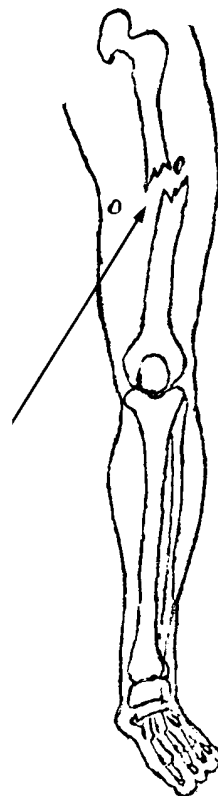


ОСТОРОЖНО:

Если существует вероятность, что пуля застряла в кости, кость может сломаться.

Не нагружайте раненую конечность (например, не стойте на ней) — все это может вызвать более серьезный перелом, такой как этот:

Если подозреваете перелом, лучше наложить шину на конечность и несколько недель соблюдать постельный режим.



Когда рана серьезная, поднимите раненую часть чуть выше сердца и держите больного в совершенно спокойном состоянии.

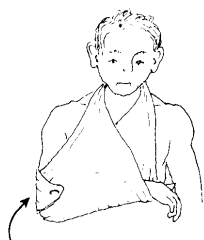
Вот так рана заживет быстрее и вряд ли станет инфицированной.

ДА



Ходить на раненой ноге или сидеть, опустив ее вниз, — все это замедляет заживление и способствует инфицированию.

НЕТ



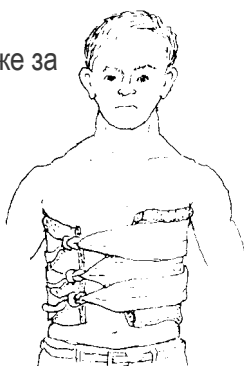
Сделайте перевязку, подобную этой, чтобы поддерживать руку с огнестрельной раной или другим серьезным повреждением.

Глубокие Раны Груды

Раны груди могут быть очень опасными. Обратитесь сразу же за медицинской помощью.

Если рана дошла до легких и воздух поступает через отверстие, когда больной дышит, накройте рану так, чтобы она не пропускала воздух. Намажьте **вазелином** или растительным маслом марлевую салфетку или чистый бинт и плотно перекройте рану, как показано здесь:

(**ОСТОРОЖНО:** Если крепкая повязка затрудняет дыхание, ослабьте ее или снимите.)



- ◆ Положите раненого в такое положение, в котором он чувствует себя удобно.
- ◆ Если есть признаки шока, проведите правильное лечение (с. 77).
- ◆ Давайте антибиотики и болеутоляющие препараты.

Пулевое Ранение Головы

- ◆ Положите больного в полусидячее положение.
- ◆ Накройте рану чистым бинтом.
- ◆ Дайте антибиотики (пенициллин).
- ◆ Обратитесь за медицинской помощью.

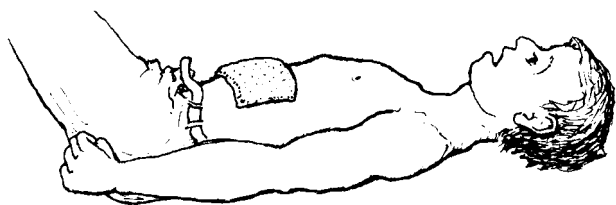
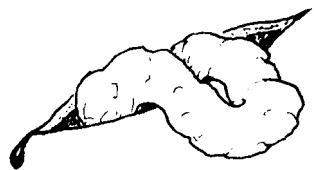


ГЛУБОКИЕ Раны в Брюшине

Любая рана в желудке или в кишечнике очень опасна. Обратитесь **немедленно** за медицинской помощью. Но тем временем:

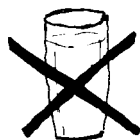
Накройте рану чистым бинтом.

Если кишки частично вылезли из раны, накройте их чистой тряпочкой, смоченной слегка подсоленной, охлажденной кипяченой водой. Не пытайтесь затолкать их обратно. Проверяйте, чтобы тряпочка все время была влажная.

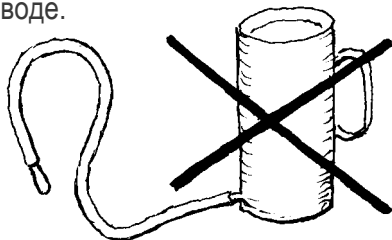


Если раненый в шоке, поднимите его ноги выше головы.

Ничего не давайте в рот: ни еду, ни жидкость, ни даже воду — воздерживайтесь не менее 2 дней, если не доставите раненого в центр здоровья. Затем дайте только воду маленькими глотками.

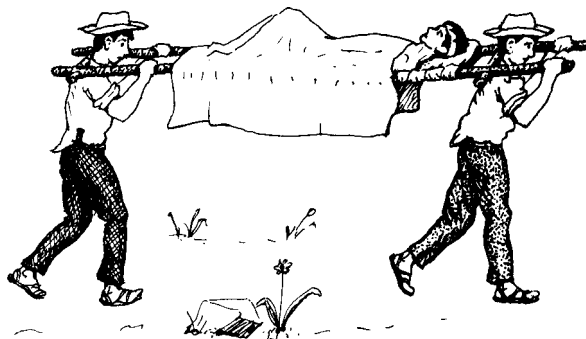
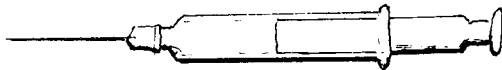


Если больной проснулся и испытывает жажду, дайте ему пососать кусочек ткани, намоченной в воде.



Никогда не делайте клизму, даже если живот вздулся или больной не испражняется несколько дней. Если кишки порваны, клизма или очистительные препараты могут убить его.

Сделайте укол антибиотика (инструкции см. на след. с.).



**НЕ ЖДИТЕ РАБОТНИКА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.**

**НЕМЕДЛЕННО ДОСТАВЬТЕ
РАНЕНОГО В БЛИЖАЙШИЙ
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ИЛИ В
БОЛЬНИЦУ.**

Ему понадобится операция.

ЛЕЧЕНИЕ РАНЫ В КИШЕЧНИКЕ

(Также аппендицита или перитонита)

До тех пор, пока вы не сможете получить медицинскую помощь, делайте следующее:

Делайте инъекцию ампициллина (с. 353) 1 г (4 ампулы по 250 мг) каждые 4 часа.

Если нет ампициллина:

Введите пенициллин (если возможно, пенициллин короткого действия, с. 352) — 5 000 000 ЕД сразу; после этого по 1 000 000 ЕД каждые 4 часа.

Вместе с пенициллином делайте инъекции:

стрептомицина(с. 363) по 2 мл (1 г) 2 раза в день или левомецетина 2 ампулы по 250 мг каждые 4 часа.

Если вы не можете достать эти антибиотики в форме для инъекций, давайте ампициллин или пенициллин в таблетках вместе с левомецетином или тетрациклином и немного воды.

СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С КИШЕЧНИКОМ (ОСТРЫЙ ЖИВОТ)

Острым животом названы многие внезапные серьезные заболевания кишечника, при которых для предотвращения смертельного исхода требуется срочное хирургическое вмешательство. Аппендицит, перитонит и непроходимость кишечника - это примеры таких заболеваний (см. след. с.). Воспалительный процесс в тазу или внематочная беременность у женщин могут также быть причиной острого живота. Часто точную причину острого живота можно установить только во время операции.

Если у больного непрерывная острая боль в кишечнике с рвотой, но нет поноса, следует подозревать острый живот.

“ОСТРЫЙ ЖИВОТ”:

Доставьте в больницу — возможно нужна операция

- постоянная острая боль, которая усиливается;
- запор и рвота;
- живот вздувается, твердеет, больной оберегает его;
- боль не утихает.

МЕНЕЕ СЕРЬЕЗНАЯ БОЛЕЗНЬ:

Можно лечить дома или в центре здоровья

- боль приходит и уходит (спазмы);
- умеренный или сильный понос;
- иногда признаки инфекции, возможна простуда или воспаленное горло;
- аналогичные боли были раньше;
- только умеренная боль.

Если у больного признаки “острого живота”, доставьте его в больницу как можно быстрее.

Непроходимость Кишечника

“Острый живот” может быть вызван чем-то, что блокирует или “закупоривает” часть кишечника, так что пища и стул не могут проходить. Наиболее общие причины:

- клубок или узел аскарид (Аскариды, с. 140);
- петля кишки, ущемленной в грыже (с. 177);
- внедрение одной кишки в другую (инвагинация).

Почти в любом случае “острого живота” могут появляться некоторые признаки непроходимости. Непроходимость вызывается нарушением двигательной функции кишечника.

Признаки непроходимости кишечника:

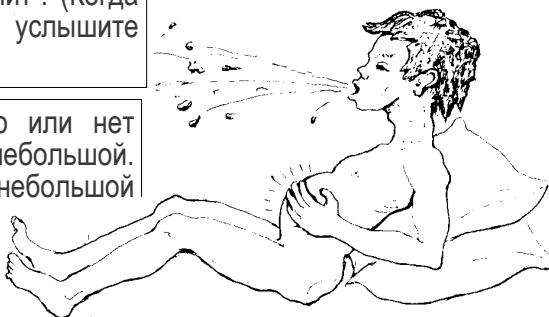
Постоянная сильная боль в животе.

Живот этого ребенка вздутый, твердый и очень болезненный. Он болит еще больше, когда вы притрагиваетесь к нему. Ребенок пытается защитить свой живот и держит ноги согнутыми. Его живот часто “молчит”. (Когда вы приложите к нему ухо, то не услышите звуков обычного бульканья.)

У него обычный запор (мало или нет испражнений). Если есть понос, то небольшой. Иногда все это выходит в виде небольшой кровавой слизи.

Отвезите такого больного в больницу как можно скорее. Его жизнь в опасности и может понадобиться хирургическое вмешательство.

Внезапная рвота с большой силой! Рвотная масса может лететь на метр или дальше. Рвотная масса представляет собой темную зловонную жидкость, похожую на кал.



Аппендицит, Перитонит

Эти опасные состояния часто требуют хирургического вмешательства. Обратитесь за медицинской помощью.

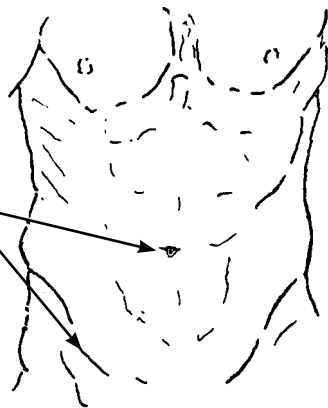
Аппендицит — это инфекция аппендикса, который представляет собой пальцеобразный отросток толстой кишки в нижней правой части живота. Инфицированный аппендикс иногда лопается, вызывая перитонит.

Перитонит — это острая серьезная инфекция внутри полости или сумки, содержащей кишки. Он происходит в результате того, что аппендикс или другая часть кишечника лопается или рвется.

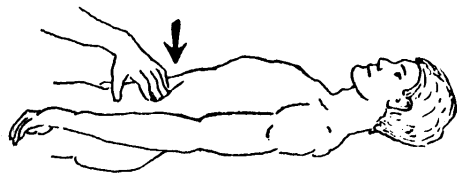


Признаки аппендицита:

- Основной признак — постоянная боль в животе, которая становится все сильнее и сильнее.
- Боль часто начинается вокруг пупка, но быстро смещается к нижней правой стороне.
- Могут быть потеря аппетита, рвота, запор или невысокая температура.



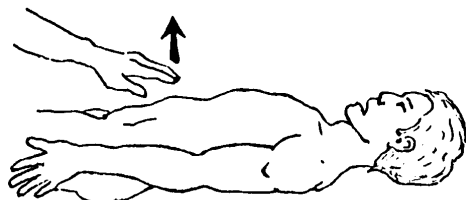
ПРОВЕРКА НА АППЕНДИЦИТ ИЛИ ПЕРИТОНИТ:



Заставьте больного кашлянуть и посмотрите, вызывает ли это резкую боль в животе.

Или медленно, но сильно давите на живот немного выше левого паха, пока не появится легкая боль.

Затем быстро уберите руку.



Если появляется очень резкая боль (опоясывающая боль), когда убрали руку, то весьма вероятно, что это аппендицит или перитонит.

Если не появляется опоясывающая боль выше левого паха, проверьте таким же образом выше правого паха.

ЕСЛИ КАЖЕТСЯ, ЧТО У БОЛЬНОГО АППЕНДИЦИТ ИЛИ ПЕРИТОНИТ:

- ◆ Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если есть возможность, доставьте больного туда, где ему могут сделать операцию.
- ◆ Ничего не давайте в рот и не делайте клизму. Только если у больного начнут появляться признаки обезвоживания, дайте маленькими глотками воду или регидрон (с. 152) — но ничего более.
- ◆ Больного следует осторожно положить в полусидящее положение.

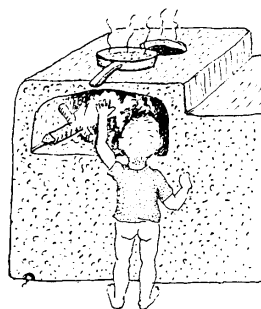


Примечание: Когда проявляется перитонит, живот становится твердым, как доска, и больной ощущает сильную боль даже при легком прикосновении к его животу. Жизнь человека в опасности. Доставьте его немедленно в медицинский центр и по пути дайте ему лекарство, указанное наверху с. 93.

ОЖОГИ

Предупреждение: Большинство ожогов можно было бы не допустить. Уделяйте особое внимание детям!

- ◆ Не разрешайте малышам играть возле огня.
- ◆ Прячьте лампы и спички подальше.
- ◆ Поверните ручки сковородок на плите так, чтобы дети не смогли достать их.



Небольшие Ожоги без Волдырей (I степень)

Чтобы облегчить боль и уменьшить повреждения, вызванные легким ожогом, **сразу же** опустите в холодную воду обожженную часть. Никакого другого лечения не требуется. Примите аспирин от боли.

Ожоги, которые Вызывают Волдыри (II степень)

Не вскрывайте волдыри.

Если волдырь лопнул, промойте его осторожно охлажденной кипяченой водой с мылом. Простерилизуйте немного **вазелина**, нагрев до кипения, и намажьте его на кусочек стерильного бинта. Потом положите бинт на ожог.

Если нет **вазелина**, оставьте рану открытой. Никогда не намазывайте жиром или маслом.

**Очень важно содержать ожог в чистоте.
Защищайте его от грязи, пыли и мух.**

Если появляются признаки инфекции – гной, плохой запах, температура, опухшие лимфатические узлы – делайте компрессы из теплой соленой воды (1 ч. ложка соли на 1 л воды) 3 раза в день. (Если можно, добавьте 2 ст. ложки извести в соленую воду). Прокипятите воду и ткань перед употреблением. Очень осторожно уберите мертвую кожу и плоть. Можно намазать небольшое количество антибиотиковой мази, такой как Левосин (с. 371). В тяжелых случаях желательно принимать пенициллин или ампициллин.

Глубокие Ожоги (III степень)

Такие ожоги разрушают кожу и обнажают живую или обугленную плоть, – всегда серьезные, как и любые ожоги, которые покрывают большие площади тела. Сразу доставьте больного в центр здоровья. Тем временем заверните обожженную часть в чистую ткань или полотенце.

Если нет возможности получить медицинскую помощь, лечите ожог, как описано выше. Если нет Вазелина, оставьте ожог открытым для воздуха, прикрыв его лишь легкой хлопчатобумажной тканью или простыней, чтобы защитить от пыли и мух. Содержите ткань в чистоте и меняйте каждый раз, когда она станет грязной от жидкости или крови из ожога. Дайте пенициллин.

Никогда не накладывайте жир, сало, шкуру, кофе, травы или кал на ожог!

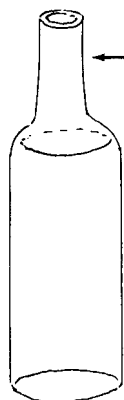
Смазка ожога медом помогает предохранить и остановить инфекцию и ускорить заживление. Осторожно смывайте старый и наносите новый мед, по крайней мере два раза в день.

ОСОБЫЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫХ ОЖОГАХ

У любого человека сильный ожог может легко вызвать состояние шока (см. с. 77) от боли, страха и потери телом жидкости из сочащегося ожога.

Утешьте и успокойте больного с ожогом. Дайте ему от боли аспирин и анальгин. Промывание открытых ран слегка подсоленной водой также помогает успокоить боль. Положите 1 ч. ложку на литр холодной кипяченой воды.

Давайте больному с ожогом побольше жидкости. Если площадь ожога большая (больше двойного размера ладони), приготовьте следующий напиток:



← К 1 литру воды
добавить:

половину чайной ложки соли,



половину чайной ложки бикарбоната соды.



Добавьте также 2 - 3 ч. ложки сахара или меда и немного апельсинового или лимонного сока, если возможно.

Больной с ожогами должен пить этот напиток почаще, пока не участится мочеиспускание. Он должен стараться выпивать 4 литра в день при большом ожоге и 12 литров в день при очень большом ожоге.

Очень важно, чтобы больной с тяжелым ожогом употреблял пищу, богатую протеином (см. с. 110). Не следует исключать никакие продукты питания.

Ожоги Вокруг Суставов

Если у кого-то сильные ожоги между пальцами, под мышкой или на других суставах, необходимо наложить марлевые прокладки с **вазелином** между обожженными поверхностями, чтобы помешать им соединиться при заживлении. Кроме того, пока идет заживление, пальцы руки и ноги следует распрямлять полностью по нескольку раз на день. Это болезненно, но помогает предотвратить образование жестких рубцов, которые ограничивают подвижность. Пока заживает обожженная рука, пальцы следует держать слегка согнутыми.



стерильные
марлевые
прокладки
с **вазелином**

СЛОМАННЫЕ КОСТИ (ПЕРЕЛОМЫ)

Когда сломана кость, то самое важное, что нужно сделать, – это **держат кость в фиксированном положении**. Это предупреждает дальнейшее повреждение и способствует срастанию.

Прежде чем попытаться двигать или переносить больного с поломанной костью, закрепите кости, чтобы они не могли смещаться, с помощью шины, полосы коры или рукава из картона. Позже гипсовую повязку на конечность можно будет наложить в центре здоровья, а возможно, вы и сами сможете наложить гипс согласно местным традициям (см. с. 14).

Установка сломанных костей.

Если кажется, что кости находятся в более или менее правильном положении, лучше не двигать их – это принесет больше вреда, чем пользы.

Если кости смещены, а перелом свежий, вы можете попытаться установить или выпрямить их перед наложением гипса. Чем скорее кости установятся, тем легче будет сращение.

КАК УСТАНОВИТЬ СЛОМАННОЕ ЗАПЯСТЬЕ

Тяните руку медленно с постоянной силой от 5 до 10 мин, увеличивая усилие, чтобы разделить отломки.



Пока один человек все еще тянет за руку, другой осторожно устанавливает и выпрямляет кости.



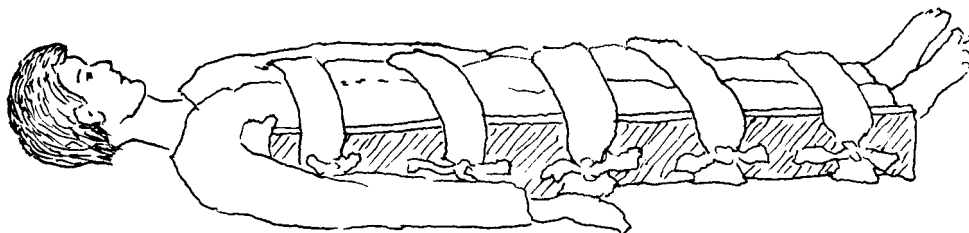
ОСТОРОЖНО: Можно нанести большой вред при попытке установки кости. Идеально это следует делать с помощью опытного человека. Не дергайте и не действуйте силой.

КАК ДОЛГО СРАСТАЮТСЯ СЛОМАННЫЕ КОСТИ?

Чем сильнее перелом и чем старше больной, тем дольше длится лечение. Детские кости заживают быстро. У некоторых старых людей они вообще не срастаются. Сломанная рука должна находиться в гипсе приблизительно месяц, и не следует нагружать ее еще около месяца. Сломанная нога должна оставаться в гипсе до 2-х месяцев.

ПЕРЕЛОМ БЕДРА ИЛИ БЕЗЫМЯННОЙ КОСТИ

Перелом бедра или безымянной кости часто требует особого внимания. Лучше всего наложить шину на все тело вот так.



И сразу же доставить травмированного больного в центр здоровья.

ПЕРЕЛОМ ШЕИ ИЛИ СПИНЫ

Если существует вероятность, что у больного перелом позвоночника или шеи, будьте очень осторожны, когда двигаете его. Старайтесь не менять его положения. Если возможно, то перед тем, как двигать его, пригласите работника здравоохранения. Если вам нужно передвигать больного, делайте это, не наклоняя его шею или спину. Для инструкций по транспортировке травмированного больного см. след. с.

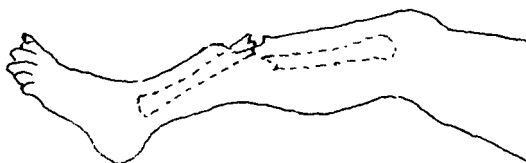
ПЕРЕЛОМ РЕБЕР

Это очень болезненно, но почти всегда проходит само по себе. Лучше не накладывать шину и не бинтовать грудь. Самое лучшее лекарство – это принять аспирин и отдохнуть. Чтобы легкие оставались здоровыми, делайте подряд 4-5 глубоких вдохов через каждые 2 часа. Делайте это ежедневно, пока вы не сможете дышать нормально. Сначала будет очень больно. Это может длиться месяцами, прежде чем боль совсем отпустит.

Сломанное ребро не всегда прокалывает легкие. Но если ребро торчит из кожи или больной кашляет кровью и начинаются трудности с дыханием (не просто боль), примите антибиотики (пенициллин или ампициллин) и обратитесь за медицинской помощью.

СЛОМАННЫЕ КОСТИ, КОТОРЫЕ ТОРЧАТ ИЗ КОЖИ (ОТКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ)

Поскольку в этих случаях опасность инфекции очень велика, лучше всегда обращаться за помощью к работнику здравоохранения или врачу для обследования раны. Очистите рану и торчащую кость очень осторожно, но тщательно, холодной кипяченой водой. Накройте чистой повязкой. **Никогда не вставляйте кость обратно в рану, пока рана и кость не будут полностью чистыми.**



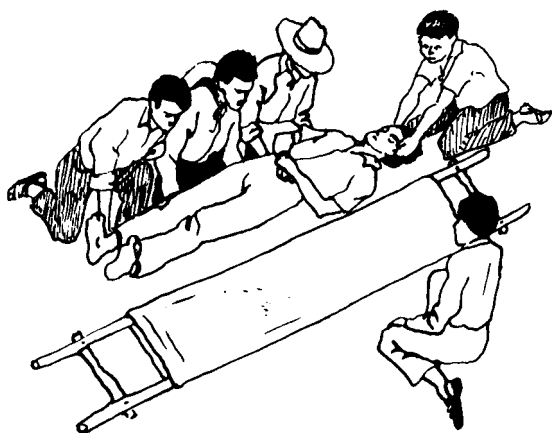
Наложите шину на конечность, чтобы предохранить от более сильного повреждения.

Если кость прорвала кожу, немедленно используйте антибиотики, чтобы сразу предупредить инфекцию: пенициллин, ампициллин или тетрациклин (с. 351, 353 и 356).

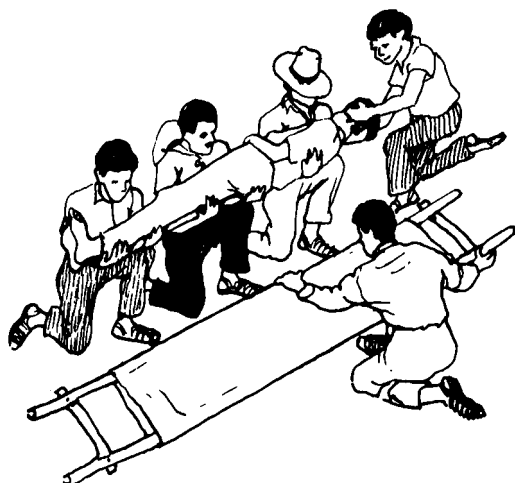
ВНИМАНИЕ: Никогда не растирайте и не массируйте сломанную конечность или ту часть, которая, возможно, сломана.

КАК ПЕРЕНОСИТЬ ТЯЖЕЛО РАНЕННОГО

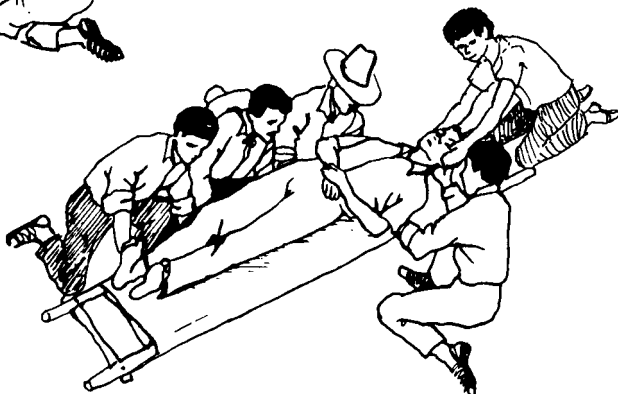
С большой осторожностью поднимите травмированного больного, не сгибая его ни где. Обратите особое внимание на то, чтобы голова и шея не наклонялись.



Нужен еще один человек для того, чтобы поставить на место носилки.



С помощью нескольких людей положите травмированного больного осторожно на носилки.



аккуратно и плотно сложенная одежда

Если шея травмирована или сломана, положите аккуратно сложенную одежду или мешки с песком по обе стороны головы, чтобы удержать ее от движения.

Когда несете, пытайтесь держать ноги вверх, даже на возвышениях.

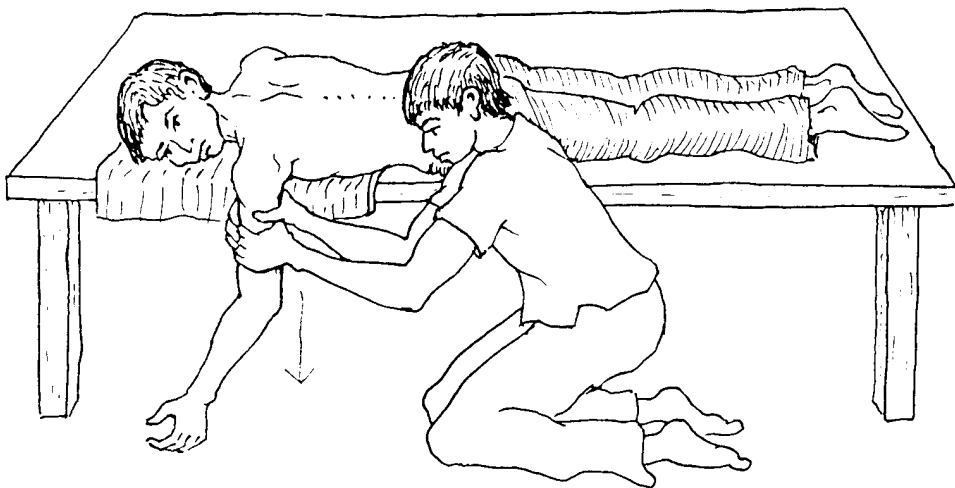
ВЫВИХИ (СМЕЩЕНИЕ СУСТАВНЫХ КОНЦОВ КОСТЕЙ)

Три важных пункта лечения:

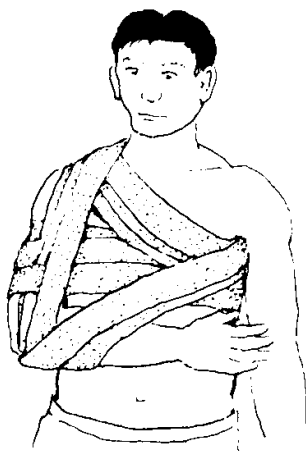
- ◆ Постарайтесь вправить кость на место. **Чем быстрее, тем лучше.**
- ◆ Держите ее плотно забинтованной на месте так, чтобы она не соскользнула снова (около месяца).
- ◆ Оберегайте конечность от сильных нагрузок достаточно долго, до полного заживления сустава (2 или 3 месяца).

КАК ВПРАВИТЬ ВЫВИХНУТОЕ ПЛЕЧО

Положите травмированного больного лицом вниз на стол или другую твердую поверхность, чтобы рука свисала вниз. С равномерной силой тяните к полу руку в течение 15 или 20 мин. Затем осторожно отпустите. Плечо встанет на место.



Или привяжите что-нибудь к руке весом от 4,5 до 9 кг. (начните с 4,5 кг., но не переходите за 9 кг.) и оставьте на 15-20 мин.



После того, как плечо встанет на место, привяжите крепко руку к телу. Держите на повязке 1 месяц. Чтобы помешать плечу стать полностью неподвижным, пожилые люди должны развязывать руку на несколько минут 3 раза в день и ею осторожно делать круговые движения.

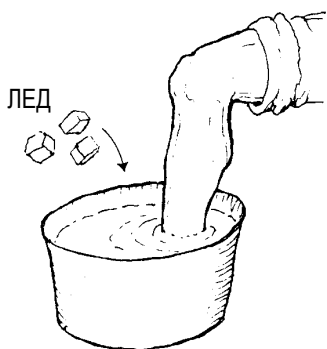
Если вы не можете вправить на место вывихнутую конечность, обратитесь сразу же за медицинской помощью. Чем дольше будете ждать, тем труднее будет вправить.

РАСТЯЖЕНИЯ И РАЗРЫВЫ (УШИБ ИЛИ РАЗРЫВ В ВЫВИХНУТОМ СУСТАВЕ)

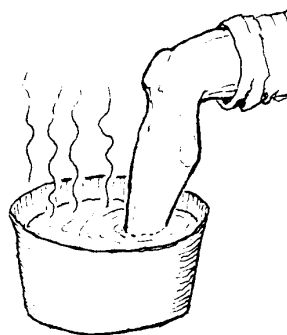
Иногда бывает невозможно узнать, когда нога или рука ушиблена, растянута или сломана. В этом случае поможет рентген.

Но обычно переломы и растяжения лечатся более или менее одинаково. Удерживайте сустав неподвижным. Заверните его чем-нибудь, что дает твердую поддержку. Серьезным растяжениям необходимо по крайней мере 3 или 4 недели для излечения. Переломам требуется больше времени.

Чтобы облегчить боль и уменьшить опухоль, поднимите растянутую часть выше. В течение первых двух дней накладывайте лед, завернутый в ткань или пластырь, или холодную мокрую ткань на опухший сустав на 20-30 минут через каждый час. Это поможет уменьшить опухоль и боль. Через 24-48 часов (если опухоль не увеличивается) поддерживайте сустав в горячей воде несколько раз в день.



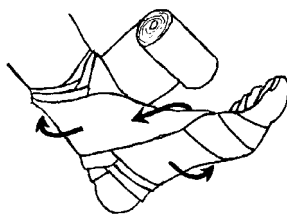
В первый день поддерживайте растянутый сустав в холодной воде.



Через день или два используйте горячую воду.

Вы можете удерживать вывихнутый сустав в правильном положении, пользуясь гипсом, изготовленным дома (см. с. 14), или эластичным бинтом.

Обернув ногу или колено эластичным бинтом, вы можете этим предупредить или уменьшить опухоль. Начните с пальцев на ноге и заворачивайте вверх, как показано здесь. Будьте осторожны и не заворачивайте слишком туго, снимайте повязку каждый час или два. Примите еще и аспирин.



Если боль или опухоль не станут уменьшаться через 48 часов, обратитесь за медицинской помощью.

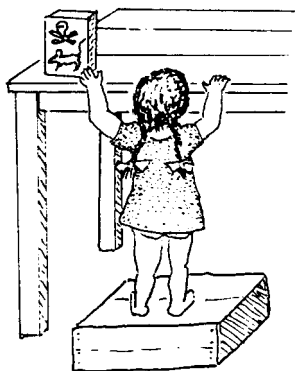
Осторожно: Никогда не растирайте и не массируйте при растяжении и переломе кости. Это больше навредит, чем поможет.

Если кажется, что нога очень подвижна, "гибкая" или больной боится двигать пальцами, обратитесь за медицинской помощью. Возможно, необходимо хирургическое вмешательство.

ОТРАВЛЕНИЕ

Многие дети умирают от того, что глотают ядовитые предметы. Для защиты ваших детей примите следующие меры предосторожности:

Храните все яды так, чтобы ребенок не смог их достать.



Никогда не храните керосин, бензин или другие ядовитые вещества в бутылках из-под лимонада и других безалкогольных напитков, потому что дети могут их выпить.



Самые обычные яды, которых следует остерегаться:

- крысиный яд;
- ДДТ, линдан, дезинфицирующий раствор для овец и другие инсектициды или ядовитые травы;
- лекарства (любые, когда их много проглотить, будьте особенно осторожны с **железосодержащими**);
- настойка йода;
- известь;
- сигареты;
- спирт для натирания или древесный;
- отравленные листья, зерна, ягоды или грибы;
- касторовое масло;
- спички;
- керосин, бензин, растворитель красок, газалин, жидкость для зажигалок;
- щелочи или каустическая сода;
- соль — если слишком много давать младенцам и маленьким детям;
- испорченная пища (см. с. 135).

Лечение

Если вы подозреваете отравление, сделайте немедленно следующее:

- ◆ Если ребенок не спит и беспокоится, заставьте его вырвать. Положите палец ему в горло и дайте ему чайную ложку сиропа рвотного корня (с. 389), разведенную в 1 стакане воды. Или заставьте его выпить воду с мягким мылом или солью (6 ч. ложек соли на 1 чашку воды).
- ◆ По возможности можно дать ему чашку активированного угля (с. 389), смешанного с чашкой воды. (Взрослым 3 стакана этой смеси.)

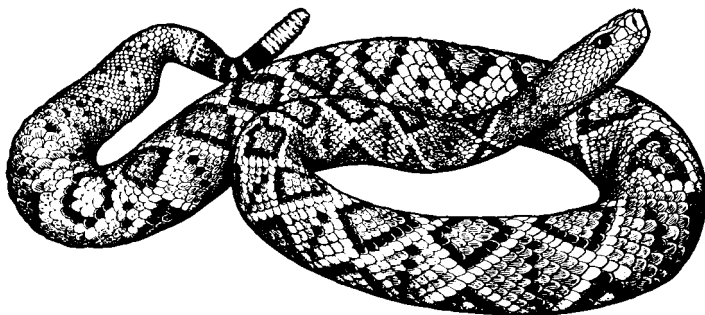
Осторожно: Не вызывайте рвоту у больного, который выпил керосин, газалин, сильную кислоту, едкое вещество (щелочь), или если он без сознания. Если он не спит и встревоженный, дайте ему побольше воды или молока, чтобы растворить яд. (Детям давайте 1 стакан воды каждые 15 мин.).

Накройте больного, если его знобит, но избегайте перегрева. **При сильном отравлении обращайтесь за медицинской помощью.**

УКУСЫ ЗМЕЙ

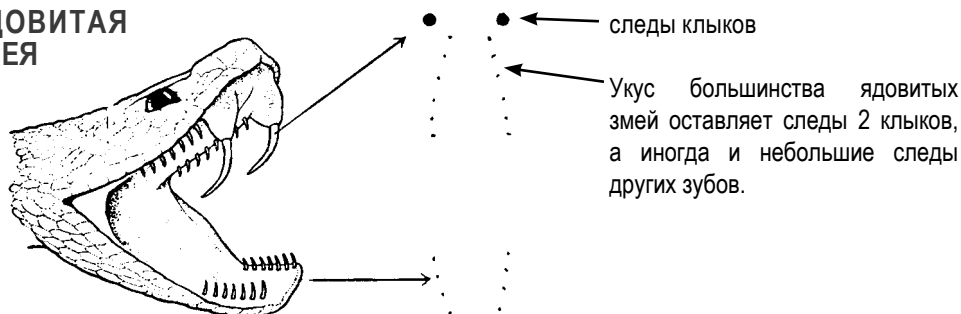
Примечание: Постарайтесь узнать, какие змеи живут в вашей местности, и записать их на этой странице.

ГРЕМУЧАЯ ЗМЕЯ

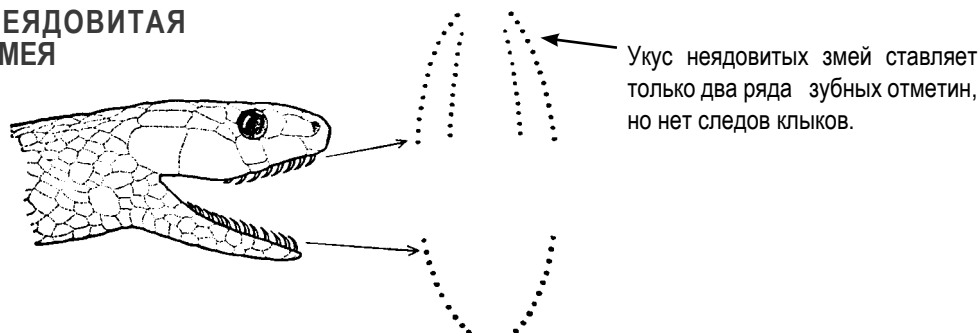


Если кого-то укусила змея, попытайтесь выяснить, ядовитая она или безвредная. Следы от их укусов различаются:

ЯДОВИТАЯ ЗМЕЯ



НЕЯДОВИТАЯ ЗМЕЯ

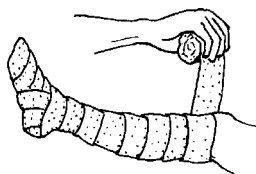
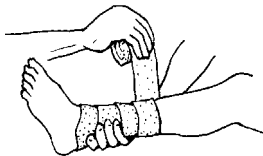


Люди часто верят, что обычные безвредные змеи являются ядовитыми. Постарайтесь узнать, какие змеи в вашей местности ядовитые, а какие – нет. В противовес распространенному мнению, удавы и питоны неядовитые. Пожалуйста, не убивайте неядовитых змей, потому что они не причиняют вреда. Наоборот, убивая мышей и других вредителей, они приносят пользу. Некоторые из них даже убивают ядовитых змей.

Лечение при укусах ядовитых змей

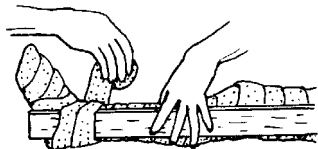
1. Оставайтесь неподвижным; не двигайте укушенную часть. Чем больше двигаетесь, тем быстрее яд распространяется по телу. Если укус на ноге, больной совсем не должен ходить. **Пошлите за медицинской помощью.**

2. Завяжите укушенное место эластичным бинтом или чистой тканью, чтобы замедлить распространение яда. Удерживая ногу или руку в неподвижном состоянии, туго забинтуйте, но не настолько, чтобы остановить пульс на запястье или наверху ноги. Если вы не прощупываете пульс, немного ослабьте повязку.



3. Забинтуйте всю ногу или руку от начала и до конца. Убедитесь в том, что вы чувствуете пульс.

4. Затем наложите шину, чтобы не давать ноге или руке двигаться.



5. Отнесите больного на носилках, если это возможно, в ближайший медицинский пункт. Если вы сможете, возьмите с собой и змею, потому что разные змеи требуют разных противоядий (антитоксин, см. с. 388). Если необходимо противоядие, оставьте повязку, пока не приготовите инъекцию и не предпримите все меры предосторожности от аллергического шока (см. с. 70). Если нет противоядия, снимите повязку.
6. От боли дайте ацетаминофен, а не аспирин. Если возможно, введите вакцину от столбняка. Если укус стал инфицированным, дайте пенициллин.
7. Лед также помогает уменьшить боль и замедлить отравление. Оберните ногу или руку эластичной лентой и толстой тканью. Затем обложите вокруг кусочками льда. (Слишком большое количество льда может повредить кожу и плоть. Если становится холодно до боли, предоставьте больному самому решать, когда убирать лед на несколько минут.)

Укус ядовитой змеи очень опасен. Обратитесь за медицинской помощью – но всегда **сразу же** сделайте все, что показано выше.

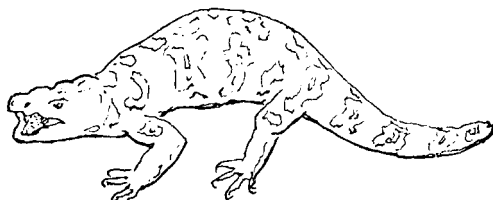
Имейте наготове противоядие от змей в вашей местности и выясните, как им пользоваться, прежде чем кого-то укусят.

Многие народные средства от укусов змей помогают очень мало (см. с.3).

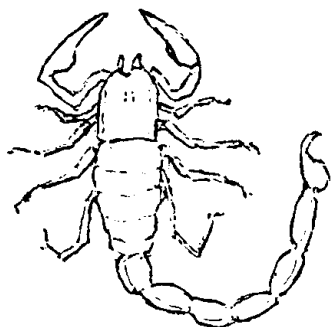
Никогда не пейте спирт после укуса змеи. Это приводит к страшным последствиям.

УКУС ЯДОЗУБА (GILA MONSTER)

Укус ядозуба лечится так же, как и укус ядовитой змеи, за исключением того, что от него нет хорошего противоядия. Укус может быть очень опасен. Как следует промойте место укуса. Избегайте движений и держите место укуса ниже уровня сердца.



УКУС СКОРПИОНА

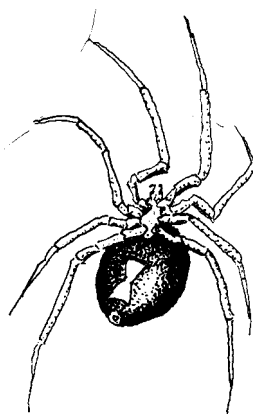


Одни из скорпионов более ядовиты, чем другие. Для взрослых укус скорпиона редко представляет опасность. Примите аспирин, и если возможно, положите лед на укус, чтобы успокоить боль. От ооченелости и боли, которые иногда продолжаютс неделями или месяцами, могут помочь горячие компрессы (см. с. 193).

Для детей до 5 лет укус скорпиона может быть очень опасен, особенно, если укус пришелся в голову или на тело. В некоторых странах применяется антиоксин от укуса скорпиона. (В Латинской Америке его называют Антиалакран, с. 388.) Чтобы он подействовал, его необходимо ввести ребенку в течение 2 часов после укуса. Дайте ему ацетаминофен или аспирин от боли. Если ребенок перестает дышать, сделайте ему дыхание рот в рот (см. с. 80). Если ребенок, которого укусил скорпион, очень маленький или укушен за основную часть тела или вы знаете, что скорпион смертельно опасен – обратитесь как можно скорее за медицинской помощью.

УКУС ЧЕРНОЙ “ВДОВЫ” И ДРУГИХ ПАУКОВ

Большинство укусов пауков, включая тарантула, очень болезненные, но не опасные. Укус нескольких видов пауков, таких как черная “вдова” и родственных видов, может вызвать тяжелое заболевание даже у взрослого. Они могут быть опасными для маленьких детей. Укус черной “вдовы” часто вызывает болезненные судороги мышц по всему телу и резкую боль в мышцах желудка, которые становятся жесткими. (Иногда это путают с аппендицитом!)



Дайте ацетаминофен или аспирин и обратитесь за медицинской помощью. Большинство полезных лекарств можно найти в сельских магазинах. (Инъекция 10% глюконата кальция - 10 мл, сделанная внутривенно **очень медленно** в течение 10 мин., помогает уменьшить спазмы мышц. Кроме того, может быть полезным диазепам (с. 390). Если появляются признаки шока, лечите от аллергического шока (с. 70). Детям нужно сделать инъекцию кортизона.)

ПИТАНИЕ: Что Надо Есть, Чтобы Быть Здоровым

Чтобы человек хорошо рос, много работал и оставался здоровым, нужно хорошо питаться. Многие распространенные болезни являются результатом недостаточного питания.

О человеке, который ослаб или заболел потому, что он ест недостаточно или не ту пищу, что ему нужна, говорят, что он плохо питается или недоедает. Он страдает от недоедания.



Плохое питание может вызвать следующие проблемы со здоровьем:

у детей

- спад в росте или недобор нормального веса (см. с. 301)
- замедленность движения, речи или умственного развития
- большой живот, тонкие руки и ноги
- обычные болезни и инфекции тянутся дольше и тяжелее и чаще вызывают смерть
- недостаток энергии, ребенок грустит и не играет
- отеки ног, лица и рук, часто с болячками или пятнами на коже
- утончение, распрямление или выпадение волос или потеря их цвета и блеска
- плохое зрение ночью, сухость глаз, слепота

у любого человека

- слабость и утомляемость
- потеря аппетита
- анемия
- трещины в углах рта
- болезненный или воспаленный язык
- "горение" или онемение ног

Хотя следующие проблемы могут иметь другие причины, они иногда вызваны и усугубляются при плохом питании:

- понос
- частые инфекции
- звон или жужжание в ушах
- головная боль
- кровотечение или краснота десен
- легкие синяки на коже
- носовое кровотечение
- боль в желудке
- сухость и трещины кожи
- сильное сердцебиение
- беспокойство (нервозность) и различные нервные и психические проблемы
- цирроз (болезнь печени)

Плохое питание во время беременности вызывает слабость и анемию у матери и увеличивает риск ее смерти во время или после родов. Это также может быть причиной выкидыша или рождения мертвого ребенка, или очень маленького, или дефективного.

Правильное питание помогает организму сопротивляться болезни.

Плохое питание может быть непосредственной причиной проблем здоровья, перечисленных выше. Но самое существенное то, что плохое питание ослабляет способность организма сопротивляться всем видам болезней, особенно инфекционным:

- Дети, которые плохо питаются, быстрее заболевают тяжелой формой поноса и умирают от него, чем дети, которые хорошо питаются.
- Корь особенно опасна там, где дети недоедают.
- Туберкулезом болеют чаще и тяжелее те, кто недоедает.
- Цирроз печени, частично вызванный чрезмерным употреблением алкоголя, а обычно чаще и тяжелее у людей, которые плохо питаются.

Даже малые проблемы, такие как простуда, обычно протекают дольше или приводят к пневмонии у людей, которые плохо питаются.

Правильное питание помогает больному стать здоровым.

Хорошая еда не только помогает предупредить болезнь, но она и помогает больному организму справиться с болезнью и стать здоровым. Поэтому, когда человек болеет, особенно важно достаточно хорошо питаться.

К сожалению, некоторые матери прекращают кормить ребенка или не дают определенную питательную еду, когда он болеет или у него понос, – в результате ребенок слабеет, не может бороться с болезнью и может умереть. **Больные дети нуждаются в еде! Если больной ребенок не ест, заставьте его кушать.**

Кормите его столько, сколько он будет есть и пить. И будьте терпеливы. Больной ребенок часто не хочет много кушать. Поэтому кормите его чем-нибудь много раз в течение дня. Убедитесь также в том, что он пьет достаточно жидкости, чтобы писать несколько раз в день. Если ребенок не принимает твердую еду, разомните ее и дайте как пюре или кашу.

Часто признаки плохого питания появляются первыми, когда человек заболевает. Например, у ребенка с поносом в течение нескольких дней начинают отекают руки и ноги, распухает лицо, появляются темные пятна или шелушащиеся болячки на ногах. Это признаки тяжелого недоедания. Ребенку нужно много питательной еды! И как можно чаще.

Во время и после любой болезни очень важно хорошо питаться.

ХОРОШЕЕ ПИТАНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ ЧИСТОТЫ – САМАЯ ЛУЧШАЯ ГАРАНТИЯ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ.



ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ?

У людей, которые питаются неправильно, развивается **недоедание**. Это может произойти от недостатка разнообразной пищи (обычное недоедание или “пониженное питание”), от недостатка нужных продуктов питания (особые виды недоедания) или от чрезмерного употребления пищи (становятся слишком толстыми, см. с. 126).

У любого может развиваться общее недоедание, но оно особенно опасно для:

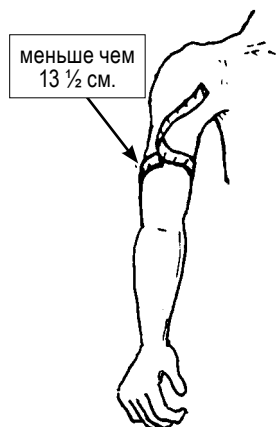
- **детей**, потому что им нужно много еды для роста и для здоровья;
- **женщин** детородного возраста, особенно, если они беременные или кормят грудью, потому что им необходимо дополнительное питание, чтобы оставаться здоровыми, иметь здоровых детей и выполнять свою повседневную работу;
- **пожилых людей**, поскольку часто они теряют зубы и вкус к еде, так что не могут наесться за один раз, хотя им необходимо хорошо кушать, чтобы оставаться здоровыми.

Недоедающий ребенок плохо растет. Он обычно худее и ниже, чем другие дети. Кроме того, он более раздражительный, много плачет, двигается и играет меньше, чем другие дети, и болеет чаще других. Если у ребенка еще и понос или инфекция, он теряет в массе. Лучший способ проверить, есть ли у ребенка признаки недоедания, – это измерить окружность верхней части его руки.

Проверка детей на недоедание: признак верхней части руки

После 1 года любой ребенок, у которого окружность середины верхней части руки меньше $13\frac{1}{2}$ см, недоедает – не имеет значения, насколько толстыми выглядят его ноги, руки и лицо. Если окружность руки меньше $12\frac{1}{2}$ см, то он сильно истощен.

Другой хороший способ выяснить, хорошо питается ребенок или плохо – постоянно взвешивать его: один раз в месяц в течение первого года, затем каждые 3 месяца. Здоровый, хорошо упитанный ребенок набирает вес регулярно. Взвешивание детей и использование Карточки Здоровья Ребенка подробно обсуждаются в Главе 21.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДОЕДАНИЯ

Чтобы оставаться здоровым, нашему организму требуется много хорошей пищи. К еде, которой мы питаемся, предъявляется много требований. Во-первых, она должна обеспечить достаточной энергией, чтобы сохранить нам активность и силу. Кроме того, она должна помогать строить, восстанавливать и защищать различные части наших организмов. Чтобы выполнить все это, нам необходимо разнообразное питание каждый день.

ОСНОВНАЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПИЩА

Во всем мире большая часть людей ест в основном дешевую пищу, главным образом мучнистую. В зависимости от региона это может быть рис, кукуруза, просо, пшеница, кассава, картошка, хлебные злаки или бананы. **Эта основная пища обычно обеспечивает большинство ежедневных потребностей организма.**

Однако одной только **основной пищи** недостаточно, чтобы сохранить человеку здоровье. Обычно требуется и вспомогательная пища. Это особенно относится к растущим детям, беременным или кормящим грудью женщинам и старикам.

Даже если ребенок регулярно получает достаточно основной еды для насыщения, он может оставаться худым и слабым. Это происходит потому, что в основной еде часто так много воды и волокна, что живот ребенка наполняется прежде, чем он получит достаточно энергии для своего роста.

Мы можем сделать две вещи, чтобы помочь удовлетворить энергетические потребности ребенка:

1. **Кормите детей почаще** – по крайней мере, 5 раз на день, когда ребенок очень маленький, слишком худой или плохо растет. В перерывах между приемами пищи давайте ему еще что-нибудь перекусить.

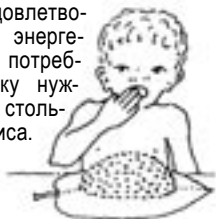


РЕБЯТА, КАК ЦЫПЛЯТА,
ДОЛЖНЫ ВСЕГДА КЛЕВАТЬ.



2. **Добавьте еще высококалорийную “вспомогательную пищу”**, такую как жиры, сахар, мед, к основной. Лучше всего добавить растительное масло или продукты, содержащие масло, – орехи, земляные орехи (арахис), семечки, особенно тыквенные или кунжутные.

Чтобы удовлетворить свои энергетические потребности, ребенку нужно съесть вот столько вареного риса.



Если желудок ребенка наполняется прежде, чем удовлетворяются его энергетические потребности, он будет худым и слабым.



А ему нужно лишь такое количество риса, если добавить растительное масло.

Высококалорийная еда добавляется к основной пище, чтобы помочь обеспечить дополнительной энергией. Еще 2 типа вспомогательной еды следует добавлять к основной пище:

Когда возможно, добавьте пищу для построения тела (протеины), такую как бобы, молоко, яйца, арахис, рыбу, мясо.

Также постарайтесь добавить защитную пищу, такую как апельсины или желтые фрукты и овощи и еще темно-зеленые листовые овощи. Защитная пища обеспечивает важными витаминами и минералами (см. с. 118).

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ СОХРАНЯЕТ ЗДОРОВЬЕ

Главная еда вашей семьи обычно удовлетворяет **большинство (но не все)** потребностей организма в энергии и питании. Но, добавляя **вспомогательную пищу** к **главной**, вы сможете получить дешевую питательную еду. Чтобы оставаться здоровым, вам вовсе не надо есть все продукты, перечисленные здесь. **Ешьте ту основную пищу, к которой вы привыкли, и добавьте любую, доступную в вашей местности, вспомогательную пищу.** Насколько это возможно, постарайтесь включать вспомогательную еду в каждую группу.

ЕДА ДЛЯ РАБОТЫ

(энергетический помощник)

Примеры:

жиры (растительное масло сливочное и топленое масло, сало);

пища, богатая жирами (маслины, мясо);

орехи* (арахис, миндаль, грецкий орех);

семечки (тыква, дыня, кунжут, подсолнух);

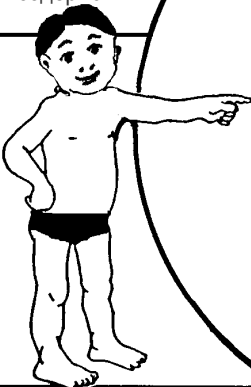
сахар (сахар, мед, патока, сахарный тростник, различные сладости)

*Примечание:

Орехи и семечки очень ценны для построения тела из-за высокого содержания протеина.



Мы поместили основную пищу в центр, так как она покрывает большую часть потребностей организма.



ОСНОВНАЯ ПИЩА



Примеры:

Злаки и зерна (пшеница, маис, рис, миндаль, сорго)

Корни крахмала (кассава, картофель, таро)

Фрукты (яблоки, груши, виноград)

Примечание:

Главная пища — дешевый источник энергии. Злаки также являются дешевым источником протеина, железа и витаминов.

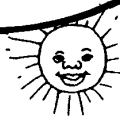
ЗАПОМНИТЕ: Кормить ребенка достаточно и часто (от 3 до 5 раз в день) обычно важнее, чем виды пищи, которой вы его кормите.

ЕДА ДЛЯ РОСТА

(протеины или помощники для строения тела)

Примеры:

плоды бобов (бобы, горох, чечевица); **орехи** (арахис, фундук, миндаль); **масляные семена** (кунжут и подсолнечник); **продукты животного происхождения** (молоко, яйца, сыр, йогурт, рыба, цыплята, мясо)



ЕДА ДЛЯ РУМЯНЦА

(витамины и минералы или защитники)

Примеры: **овощи** (темно-зеленые листовые овощи, томаты, морковь, тыква, сладкий картофель, репа, капуста, лук-порей и перец); **фрукты** (абрикосы, персики, груши, яблоки)

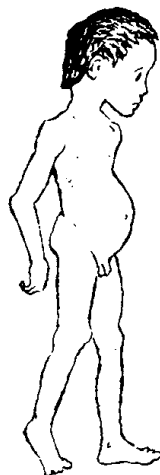
Примечание работникам питания: Такой план распределения пищевых потребностей напоминает учение о "группах питания", но занимает более важное место, поскольку содержит множество традиционных "главных продуктов" и **главным образом предлагает частые кормления с большим количеством богатых энергией продуктов.** Такой подход более приемлемый для ресурсов и ограничений бедных семей.

КАК РАСПОЗНАТЬ НЕДОЕДАНИЕ

Среди бедняков **недоедание** – часто самая серьезная проблема у детей, которым для роста и здоровья необходимо много питательной еды. Здесь приводятся различные формы недоедания.

Легкое недоедание

Это наиболее распространенная форма, но не всегда явная. Ребенок просто не растет или не набирает вес так быстро, как ребенок с хорошим питанием. Хотя он может выглядеть довольно маленьким и худым, но обычно он не кажется больным. Однако, потому что он плохо питается, у него не хватает сил (сопротивляемости), чтобы бороться с инфекциями. Поэтому он **тяжелее** и ему для выздоровления требуется больше времени, чем ребенку с хорошим питанием.



Дети с этой формой недоедания страдают больше от поноса и простуды. Простуда у них обычно тянется дольше и часто переходит в пневмонию. Корь, туберкулез и многие другие **инфекционные болезни намного опаснее** для этих истощенных детей. Многие из них умирают.

Очень важно, чтобы дети такие, как этот, получали особый уход и достаточное количество еды прежде, чем они станут серьезно больными. Вот почему так важны регулярные взвешивания и измерения окружности верхней части руки у малышей. Это помогает распознать раннюю форму недоедания и исправить ее.

Следуйте руководствам для предупреждения недоедания.

СЕРЬЕЗНОЕ НЕДОЕДАНИЕ

Наиболее часто бывает у младенцев, которых рано или внезапно перестали кормить грудью, и у тех, кто не получал важной высококалорийной пищи. Тяжелая форма недоедания чаще всего начинается, когда у ребенка понос или другая инфекция. Мы обычно узнаем детей с серьезной формой недоедания без всяких измерений. Вот 2 основных примера:

СУХОЕ ИСТОЩЕНИЕ, ИЛИ МАРАЗМ

Этот ребенок не получает в достатке никакой еды. Говорят, у него **сухое истощение, или маразм**. Другими словами, он голоден. Тело у него маленькое, очень худое и изможденное.

Этому ребенку нужно больше пищи – особенно энергетической.

- редкие волосы
- лицо старика
- всегда голодный
- выпуклый живот
- очень худой
- мало весит



ЭТОТ РЕБЕНОК - КОЖА ДА КОСТИ

МОКРОЕ НЕДОЕДАНИЕ, ИЛИ КВАШИОРКОР

Состояние этого ребенка называют **“мокрым недоеданием”**, потому что у него **отекающие ноги, руки и лицо**. Это происходит тогда, когда ребенок получает мало продуктов – “строительного материала для организма” – или протеинов. Или это может случиться, когда ему не хватает энергетической пищи и его организм сжигает любые протеины, которые получает с едой.

Одутловатое лицо-“луна”

прекращение роста

шелушение кожи и болячки

отекающие руки и ноги



Волосы и кожа теряют цвет

грусть

тонкие верхние части рук

дряблые мышцы

Еда из бобов, чечевицы или других продуктов, которые хранились в сыром месте и слегка заплесневели, также может быть частью причины.

Сначала ребенок становится одутловатым. Другие признаки появляются позже.

ЭТОТ РЕБЕНОК – КОЖА, КОСТИ И ВОДА.

Этому ребенку нужно есть больше и чаще – побольше энергетической пищи и пищи, богатой протеином (см. с. 111).

И еще старайтесь избегать старых, испорченных и заплесневелых продуктов.

ДРУГИЕ ПРИЗНАКИ ИСТОЩЕНИЯ

У бедняков наиболее распространенные формы тяжелого недоедания вызваны либо голодом (маразм), либо недостатком протеина (квашиоркор). Однако другие формы недоедания могут быть результатом недостатка определенных витаминов или минералов в еде, которой питаются люди. Многие из этих специфических видов недоедания более полно обсуждаются в этой главе и других частях книги:

- **Куриная слепота** у детей, которые недостаточно получают витамина А (см. с. 226).
- **Рахит** от недостатка витамина D (см. с. 125).
- Различные **кожные заболевания, трещины в уголках губ** или **кровоточащие десна** от недостатка фруктов, овощей и других продуктов, содержащих определенные витамины (см. с. 208 и 232).
- **Анемия** у людей, которым не хватает железа в организме (см. с. 124).
- **Зоб** от недостатка йода (см. с. 130).

Чтобы получить побольше информации о проблемах здоровья, связанных с питанием, см. *“Пособие Для Работников Здравоохранения”*, Глава 25, и *Искалеченные Деревенские Дети*, Главы 13 и 30.



Эта мать и ребенок из бедной семьи и с рождения плохо питаются. Отец много работает, но не зарабатывает достаточно, чтобы хорошо кормить семью. Пятна на руках матери представляют собой признаки пеллагры – одного из видов истощения. Она в основном питается кукурузой и ей не хватает таких питательных продуктов, как бобы, яйца, фрукты, мясо, темно-зеленые овощи.

Мать не кормит ребенка грудью. Она ему дает только кукурузную кашу. Хотя каша наполняет живот, она не обеспечивает ребенка достаточным количеством питательных веществ, необходимых для его роста. В результате этот двухлетний мальчик сильно истощен. Он очень маленький и худой, с опухшим животиком, волосы тонкие, а его физическое и умственное развитие будет идти медленнее, чем у нормальных детей. **Чтобы предупредить это, матери и их дети должны питаться лучше.**

КАК ПИТАТЬСЯ ЛУЧШЕ, КОГДА У ВАС МАЛО ДЕНЕГ ИЛИ ЗЕМЛИ



Существует много причин голода и плохого питания. Одна из главных причин – бедность. Во многих частях мира всего лишь несколько богатей являются владельцами большей части земли. Они могут выращивать урожаи кофе или табака, продажа которых приносит деньги, но которые не имеют пищевой ценности. А бедняки могут возделывать лишь маленькие клочки арендованной земли, тогда как владельцы отбирают у них большую часть урожая. Проблема голода и плохого питания никогда не будет полностью решена, пока люди не научатся делиться друг с другом по справедливости.

Но есть вещи, которые люди могут сделать, чтобы питаться лучше и дешевле – а питаясь хорошо, набраться сил, чтобы отстаивать свои права. На страницах с13 и с14 “Обращения к сельскому работнику здравоохранения” представлено несколько предложений по увеличению производства продуктов. Они заключаются в улучшении землепользования посредством севооборота, обводных каналов и ирригации; еще есть идеи по рыбоводству, пчеловодству, хранению зерна, семейным садам. Если вся деревня или группа семей работают вместе над любой из этих проблем, можно многое сделать для улучшения питания.

Когда речь идет о пище и земле, важно помнить, что данная площадь земли может прокормить лишь определенное число людей. Поэтому некоторые люди доказывают, что “маленькая семья живет лучше”. Однако для многих бедных семей иметь много детей – экономическая необходимость. К тому времени, когда детям из бедных семей исполняется по 10-12 лет, они зачастую производят больше, чем на них тратят. При большом количестве детей у родителей повышается шанс на получение помощи и ухода в преклонном возрасте.

Короче, недостаток социальной и экономической безопасности заставляет родителей иметь много детей. Поэтому ответ на установление баланса между людьми и землей лежит не в разговорах о маленьких семьях. Он содержится в справедливом перераспределении земли, заработка и других мерах по преодолению бедности. Только тогда люди смогут позволить себе иметь маленькие семьи и надеяться на достижение устойчивого баланса между людьми и землей. (Рассуждения о здоровье, пище, социальных проблемах см. в Пособии Для Работников Здравоохранения.)

Когда денег в обрез, важно мудро их использовать. Подразумевается ко-операция и взгляд в будущее. Зачастую отец из бедной семьи скорее потратит свои мизерные заработанные деньги на алкоголь и табак, чем купит продукты, курицу, несущую яйца, или что-нибудь еще для улучшения здоровья семьи. Мужчины, которые вместе выпивают, лучше бы иногда собирались вместе трезвыми, чтобы обсудить и решить проблемы здоровья.

Иногда и матери покупают конфеты или напитки своим детям, когда могли бы потратить эти деньги на яйца, молоко, орехи или другие питательные продукты. Их дети стали бы здоровее за эти же деньги. Обсудите этот вопрос с матерями и найдите решение

Н
Е
Т



**ЕСЛИ У ВАС МАЛО ДЕНЕГ, А ВЫ
ХОТИТЕ ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ РАСТИ СИЛЬНЫМ:**

**НЕ ПОКУПАЙТЕ НАПИТКИ ИЛИ КОНФЕТЫ –
КУПИТЕ ЕМУ 2 ЯЙЦА ИЛИ ГОРСТЬ ОРЕХОВ.**



Д
А

Хорошая Еда по Низкой Цене:

Многие люди в мире едят множество продуктов, содержащих крахмал, не добавляя достаточного количества вспомогательной еды, которая обеспечивает организм дополнительной энергией, строительным материалом и защитой. Это отчасти потому, что вспомогательная еда весьма дорогая, особенно животного происхождения – молоко, мясо.

Многие люди не могут позволить себе большое количество продуктов животного происхождения. Для обеспечения животных кормами требуется много земли. А бедная семья обычно может улучшить питание, только **выращивая или покупая растительную пищу (бобы, горох, чечевицу и арахис) вместе с основной едой (такой как маис или рис), а не покупая дорогую животную пищу (например, мясо или рыбу).**

Люди могут быть сильными и здоровыми, когда большая часть протеинов и другой вспомогательной еды поступает с растительной пищей.

Однако там, где позволяют семейные финансы и местные обычаи, разумно кушать, когда можно, еду животного происхождения. Это потому, что даже растения с высоким содержанием протеина (для строения тела) зачастую не могут удовлетворить потребности организма во всех видах протеинов.

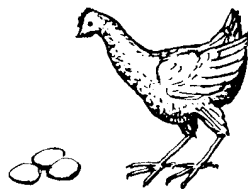
Старайтесь **питаться разнообразной растительной пищей**. Различные растения снабжают организм различными протеинами, витаминами и минералами. Например, бобы и кукуруза вместе удовлетворяют нужды организма лучше, чем по отдельности. А если добавить другие овощи и фрукты, будет еще лучше.

Вот несколько предложений о том, как получить побольше витаминов, минералов и протеинов по низкой цене.

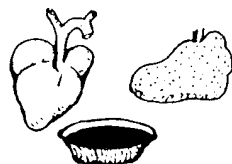
1. **Грудное молоко.** Это самая дешевая, здоровая и полноценная еда для младенца. Мать может питаться большим количеством растительного протеина и перерабатывать его в самое совершенное питание для младенца – грудное молоко. Грудное вскармливание – не только самое лучшее для ребенка, оно экономит деньги и предупреждает болезни!



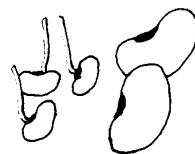
2. **Яйца и цыплята.** Во многих местах яйца – один из самых дешевых и лучших видов животного протеина. Их можно приготовить и смешать с пищей для детей, не получающих грудного молока. Или их можно давать вместе с грудным молоком, когда ребенок подрастет. Сваренная яичная скорлупа, перетертая и смешанная с едой, может обеспечить необходимым организму кальцием беременных женщин, у которых появляются болячки, судороги мышц или выпадают зубы. Цыплята – хорошая, часто крайне дешевая форма животного протеина, особенно, если семья выращивает своих цыплят.



3. **Печень, сердце, почки и кровь.** Они особенно богаты протеином, витаминами и железом (от анемии) и они часто дешевле, чем мясо. И рыба часто дешевле, чем мясо, и тоже очень питательна.



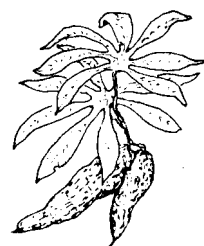
4. **Бобы, горох, чечевица и другие бобовые** представляют хороший дешевый источник протеина. Если возможно, выращивайте их для приготовления пищи – они очень богаты витаминами. Еду для ребенка можно приготовить из бобов, хорошо проварив их, а затем, пропустив через сито или сняв с них кожицу, превратить в протертую массу.



Бобы, горох и другие бобовые – это не только дешевый протеин. При выращивании этих культур почва обогащается, и другие культуры потом растут. Поэтому севооборот и смесь культур – хорошая идея (см. с. с13).



5. **Темно-зеленые листовые овощи** содержат железо, много витамина А и протеин. Листья сладкого картофеля, бобов и гороха, тыквы и кабачка и баобаба особенно питательны. Их можно высушить, измельчить и подмешивать в детскую кашу.



Примечание: Светло-зеленые овощи, такие как капуста, салат, менее питательны. Лучше выращивать овощи с темно-зелеными листьями.

6. **Листья кассавы (маниока)** содержат в 7 раз больше протеина и больше витаминов, чем корни. Если кушать вместе с корнем, они добавляют пище ценность – но не цену. Молодые листья наилучшие.

7. **Вымоченная в лиме кукуруза (маис).** Если перед приготовлением вымочить кукурузу в лиме, как это принято в Латинской Америке, она обогащается кальцием. Замачивание в лиме также позволяет получить больше витаминов (ниацина) и протеина для использования организмом человека.

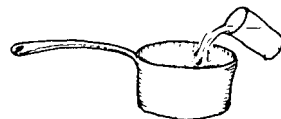


8. **Рис, пшеница и другие злаки** более питательны, если при помоле не удалять внешнюю кожицу. Умеренно смолотый рис и непросеянная пшеничная мука содержат больше протеина, витаминов и минералов, чем белый, перемолотый продукт.



Примечание: протеин в пшенице, рисе, кукурузе и других злаках лучше используется организмом, если их есть с бобовыми.

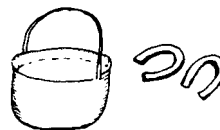
9. **Готовьте овощи, рис и другие продукты** в малом количестве воды. Не переваривайте. Так теряется меньше витаминов и протеина. Пейте отстоянную воду и используйте ее для супов и других блюд.



10. **Многие дикорастущие фрукты и ягоды** богаты как витаминами, так и натуральным сахаром. Они дополнительно обеспечивают витаминами и энергией. (Будьте осторожны, когда едите ягоды или фрукты, – среди них попадаются ядовитые.)



11. **Готовьте в железных котлах** или положите кусочек старого железа или подкову в кастрюлю, когда варятся бобы и другие продукты – это добавит в еду железо и поможет предупредить анемию. Железо еще добавится, если вы положите томаты.



Еще один источник железа: положите немного железных гвоздей в небольшое количество лимонного сока на несколько часов. Затем сделайте лимонад из сока и выпейте его.



12. В некоторых странах дешевые детские смеси готовят из различных сочетаний соевых и хлопковых зерен, сливок и сухой рыбы. Некоторые из них на вкус лучше, чем другие, но большинство представляют собой хорошо сбалансированное питание. Когда их подмешивают в кашу, приготовленную из злаков, или в другую детскую еду, они добавляют питательность – по низкой цене.



ОТКУДА ПОЛУЧАТЬ ВИТАМИНЫ: ИЗ ПИЛЮЛЬ, УКОЛОВ, СИРОПОВ – ИЛИ ИЗ ПИЩИ?

Каждый, кто питается хорошим набором продуктов, включая овощи и фрукты, получает все необходимые витамины. Всегда лучше хорошо питаться, чем покупать таблетки витаминов, инъекции, сиропы или тоники.



Если вы хотите витамины, покупайте яйца или другие питательные продукты вместо порошков или инъекций.



Иногда питательных продуктов недостаточно. Если человек уже сильно истощен, ему следует питаться как можно лучше и, кроме того, принимать витамины.

Витамины в таблетках действуют так же хорошо, как инъекции, стоят меньше и не так опасны. Не делайте инъекции витаминов! Лучше глотайте их – и предпочтительно в виде питательных продуктов.

Если покупаете витаминные препараты, убедитесь, что они содержат все эти витамины и минералы:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ниацин (ниацинамид) ◆ Витамин B1 (тиамин) ◆ Витамин B2 (рибофлавин) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ железо (сульфат железа и т.д.) – особенно для беременных женщин. (Людей с анемией поливитамины не обеспечивают достаточным количеством железа. Пиллюли железа полезнее.) |
|---|--|

Кроме того, некоторым людям нужны дополнительно:

- | | | | |
|---|---|-------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ Фолиевая кислота (фолицин) для беременных женщин ◆ Витамин А ◆ Витамин С (аскорбиновая кислота) ◆ Витамин D ◆ Йод (в местах, где распространен зоб) | } | для малышей | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Витамин B6 (пиридоксин) для маленьких детей и больных, принимающих лекарство от туберкулеза ◆ Кальций для детей и кормящих грудью матерей, которые не получают достаточно кальция в продуктах питания, таких как молоко, сыр, или пища из лимы |
|---|---|-------------|---|

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ В ДИЕТЕ

Множество людей верит, что существуют такие виды продуктов, которые вредят им или которые не следует кушать, когда болеешь. Они могут думать, что есть “горячая” и “холодная” пища и нельзя есть горячие продукты при “горячих болезнях” или холодные продукты при “холодных болезнях”. Или они могут верить, что многие продукты не годятся для матери новорожденного. Некоторые из этих поверий вполне резонны, но некоторые приносят больше вреда, чем пользы. Часто продукты, которых, по мнению людей, нужно избегать во время болезни, — это как раз та еда, в которой они нуждаются, чтобы выздороветь.

Больному человеку необходимо даже больше питательных продуктов, чем здоровому. Мы должны меньше беспокоиться о пище, которая могла бы навредить больному, а думать о той еде, которая помогает поддерживать здоровье всей семьи, — например, высокоэнергетическая пища вместе с фруктами, овощами, бобовыми, орехами, молоком, мясом, яйцами, рыбой. Как общее правило:

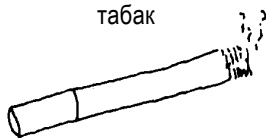
Та пища, которая хороша для нас, когда мы здоровы, она же хороша для нас, когда мы больны.

К тому же, продукты, которые вредят нам, когда мы здоровы, еще больше вредят, когда мы больны. Избегайте следующего:

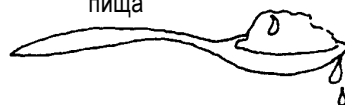
алкогольные
напитки



табак



жирная
пища



большое количество
сахара и конфет



большое количество
кофе



- Алкоголь вызывает или усугубляет болезни печени, желудка, сердца и нервов. Он также создает социальные проблемы.
- Курение может вызвать хронический кашель или рак легких и другие болезни (см. с. 149). Курение особенно вредит людям с легочными заболеваниями, такими как туберкулез, астма, бронхит.
- Злоупотребление жирной едой или кофе может привести к язве желудка и усложнить другие болезни пищеварительного тракта.
- От злоупотребления сахаром и конфетами портится аппетит и гниют зубы. Однако немного сахара с другой пищей поможет обеспечить необходимой энергией больного человека или плохо питающегося ребенка.

Некоторые болезни требуют ограничения пищи. Например, люди с высоким кровяным давлением, некоторыми болезнями сердца или отеками ног должны употреблять мало соли или обходиться без нее. Слишком много соли — это плохо для всех. Язва желудка и диабеты тоже требуют особых диет (см. с. 127 и 128).

НАИЛУЧШАЯ ДИЕТА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

ПЕРВЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ:

В первые 6 месяцев давайте ребенку только молоко матери и ничего больше. Грудное молоко – самая лучшая и чистая еда для младенцев. Оно лучше, чем любое детское питание или молоко. Если вы первые 4-6 месяцев кормите ребенка только грудным молоком, то это поможет уберечь его от поноса и многих инфекций. И лучше не давать воду или чай даже в жаркую погоду.



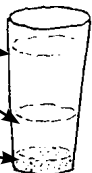
Некоторые матери рано прекращают кормить грудью, считая, что их молоко недостаточно хорошее для ребенка или что молока мало. **Однако материнское молоко всегда самое питательное для ребенка, даже если сама мать худая и слабая.** Кроме того, почти у всех матерей вырабатывается достаточно грудного молока для их детей:

- Наилучший способ для матери иметь достаточно грудного молока – чаще **кормить ребенка грудью, хорошо питаться и пить много жидкости.**
- Не кормите ребенка другими продуктами до того, как ему исполнится 4-6 месяцев. И **всегда кормите ребенка грудью перед тем, как дать что-либо еще.**
- Если в груди матери мало или нет молока, она может снова начать его производить. Для этого она должна хорошо кушать, много пить и прикладывать почаще ребенка к груди перед тем, как прикармливать. После каждого кормления давайте ребенку из чашки (не бутылки) какое-нибудь другое молоко – коровье или козье, консервированное или сухое. (Не пользуйтесь сгущенным молоком). Добавьте немного сахара или растительного масла к любому молоку.

Примечание: К любому молоку добавьте немного холодной кипяченой воды. Вот два примера правильной формулы:

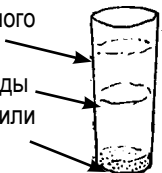
№ 1

2 части холодного кипяченого коровьего молока
1 часть холодной кипяченой воды
1 большую ст. ложку сахара или растительного масла на стакан



№ 2

2 части консервированного выпаренного молока
3 части холодной кипяченой воды
1 большую ст. ложку сахара или растительного масла на стакан



Если пользуетесь обезжиренным молоком, добавьте одну столовую ложку растительного масла.

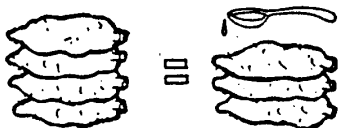
- По возможности кипятите молоко и воду. **Безопаснее кормить ребенка из чашки (или чашка и ложка), чем из детской бутылки.** Детские бутылки и соски трудно содержать в чистоте и можно вызвать инфекцию и понос (см. с. 154). Если вы пользуетесь бутылкой, кипятите ее и соску перед каждым кормлением ребенка.
- Если вы не можете купить молоко ребенку, сделайте кашу из риса, кукурузы или других злаков. Всегда добавляйте к ней немного консервированных бобов, яйца, мясо, цыплят или другие протеины. Смешайте все хорошо и дайте им как жидкость. Если можно, добавьте сахар и масло.

ВНИМАНИЕ: Ребенку недостаточно одной только маисовой или рисовой воды. Он будет плохо расти. Он легко заболеет и может умереть. Ребенку нужна и основная пища и вспомогательная.

ОТ 4 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДА:

1. **Продолжайте кормить грудью**, если можно, пока ребенку не исполнится 2 или 3 года.
2. Когда ребенок от 4 до 6 месяцев, **начинайте его подкармливать другой пищей. Всегда дайте ему сначала грудь, а затем другую еду.** Лучше начинать с каши или пюре, приготовленного из основной еды (с. 111), такой как маис или рис на молоке или воде. Затем начните **добавлять немного растительного масла** для дополнительной энергии. Через несколько дней начните добавлять **другую вспомогательную пищу** (см. с. 110). Но **начинайте с самого малого количества новой еды и добавляйте только 1 раз** или у ребенка будет расстройство желудка. Эти **новые продукты питания нужно хорошо сварить и протереть**. Сначала их можно смешивать с небольшим количеством грудного молока, чтобы ребенку было легче глотать.
3. Приготовьте недорогие, питательные блюда для ребенка, добавляя вспомогательные продукты к основной еде (см. с. 110). Самое важное – это добавлять еду, которая обеспечивает дополнительную энергией (растительное масло) и – когда возможно – дополнительным железом (темно-зеленые листовые овощи).

Помните, что желудок младенца маленький и не может вместить много пищи за один раз. Поэтому **кормите его чаще и добавляйте высокоэнергетические продукты** к основной еде:



Столовая ложка масла, добавленная к пище ребенка означает, что ему следует съесть только 3/4 местной основной пищи, чтобы удовлетворить энергетическую потребность. Добавка масла помогает убедиться в том, что он получает достаточно энергии (калорий) к тому моменту, как его живот наполнится.

Осторожно: Время, когда ребенку чаще всего грозит истощение, от 6 месяцев до 2 лет. Это потому, что грудное молоко само по себе не обеспечивает ребенка достаточной энергией после 6 месяцев. Нужны и другие продукты, но часто пища, которую он получает, также не содержит достаточно энергии. Если мать еще и прекращает кормить грудью, ребенок быстрее становится истощенным.

Чтобы ребенок в этом возрасте был здоровым, мы должны:

- Продолжать кормить грудью – еще больше, чем прежде.
- Кормить его другой питательной пищей тоже, всегда начиная с малого.
- Кормить его, по крайней мере, 5 раз в день и давать ему перекусить между кормлениями.
- Убедитесь, что еда чистая и свежеприготовленная профильтруйте, вскипятите или очистите воду, которую он пьет.
- Соблюдайте правила гигиены в отношении не только ребенка, но и вещей вокруг него, когда он болеет, кормите его лучше и чаще, давайте ему пить как можно больше жидкости.



1 ГОД И СТАРШЕ

Когда ребенку исполнится 1 год, он может кушать **ту же пищу, что и взрослые**, но надо продолжать кормить грудью (или пить молоко, когда только можно).

Каждый день старайтесь давать ребенку все больше основной еды, которую едят взрослые, вместе со вспомогательными продуктами, которые добавляют энергию, протеины, витамины, железо и минералы (как показано на с. 111), чтобы он рос сильным и здоровым.

Если вы хотите убедиться, что ребенок получает достаточно пищи, **подайте ему еду в его собственной посуде**, и пусть он кушает столько времени, сколько ему нужно, чтобы съесть свой обед.

Дети и конфеты: Не приучайте маленьких детей кушать много конфет и сладостей или пить легкие напитки (колу). Когда они едят слишком много сладостей, они плохо едят другую, необходимую для них, пищу. К тому же, конфеты портят зубы.

Однако, когда запасы пищи ограничены или когда в основных продуктах много воды или волокна, добавки сахара и растительного масла к основной еде снабжают дополнительной энергией и дают возможность детям более полно использовать протеин в еде, которую они получают.

ЛУЧШАЯ ДИЕТА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ

ПЕРВЫЕ 4-6 МЕСЯЦЕВ

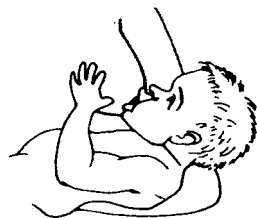
грудное молоко и ничего больше



ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ

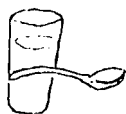
грудное молоко,

а также



коровье,
козье или
сухое
молоко

и другие хорошо
приготовленные
питательные
продукты.



Кормите часто!!!



ВРЕДНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДИЕТЕ

1. Диета матери после рождения ребенка:

Во многих местах существует опасное поверье, что женщина, которая родила ребенка, не должна питаться определенными продуктами. Эта народная диета, которая запрещает некоторые самые питательные продукты и разрешает матери есть только такие продукты, как хлеб из кукурузы, лапша или рисовый суп – делает ее слабой и анемичной. Это может даже привести к ее гибели, так как ослабляет ее сопротивление кровотечению и инфекциям.

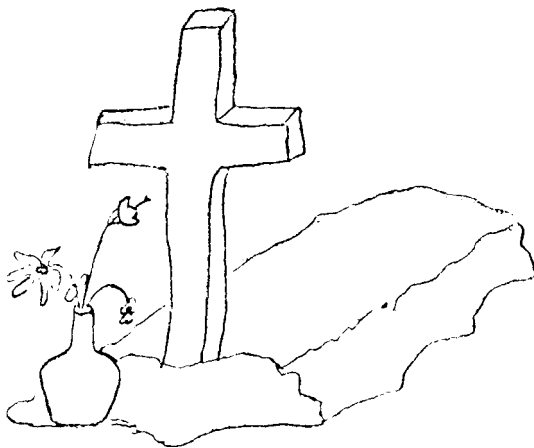
После рождения ребенка матери нужно питаться самой питательной пищей, которую она может получить.

Чтобы бороться с инфекциями или кровотечением и вырабатывать достаточно молока для ребенка, **молодая мама должна питаться основной едой вместе с продуктами, которые помогают строить организм, такими как бобы, яйца, цыплята, и, если возможно, с молоком, мясом, рыбой.** Ей также нужны защитные продукты, такие как фрукты и овощи, и высокоэнергетическая еда (масло и жирная пища). Никакие из этих продуктов не вредят ей; они защитят ее и сделают сильнее.

Вот здоровая мама, которая ест любую питательную пищу после рождения ребенка.



Здесь лежит мать, которая боялась кушать питательную пищу после рождения ребенка.



2. Неверно, что апельсины, гуайяву или другие фрукты нельзя кушать больным, у которых простуда, грипп или кашель. На самом деле такие фрукты, как апельсины и томаты, содержат большое количество витамина С, который помогает бороться с простудой и другими инфекциями.
3. Неверно, что такие продукты, как свинина, приправы или гуайява, нельзя кушать, когда принимаете лекарство. Однако, когда у человека заболевания желудка или других частей пищеварительной системы, употребление большого количества жирной и масляной еды может усугубить болезни – независимо от того, принимает больной лекарство или нет.

ОСОБЫЕ ДИЕТЫ ПРИ НЕКОТОРЫХ БОЛЕЗНЯХ

АНЕМИЯ

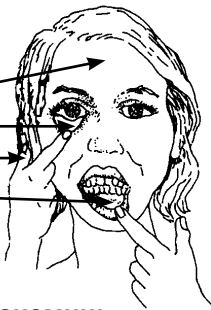
У человека с анемией жидкая кровь. Это случается, когда кровь теряется или разрушение быстрее, чем организм может восстановить ее. Потеря крови из больших ран, кровотечения из язвы или дизентерия могут вызвать анемию. Малярия, которая разрушает красные кровяные тельца, тоже может быть причиной анемии. Недостаточное количество железа в еде может вызвать или усилить анемию.

Женщины могут стать анемичными из-за потери крови во время месячных или родов, если они не едят пищу, в которой нуждается их организм. Беременные женщины рискуют заболеть тяжелой формой анемии, так как они должны вырабатывать дополнительную кровь для растущего ребенка.

У детей анемия может развиваться, если они едят бедную железом пищу. Она также может возникнуть, если не начинать добавлять некоторые продукты к грудному молоку после того, как ребенку исполнится 6 месяцев. Обычными причинами тяжелой формы анемии у детей являются нематодная инфекция (см. с. 142), хронический понос и дизентерия.

Признаки анемии:

- бледная или прозрачная кожа
- бледность внутри век
- белые ногти на пальцах
- бледные десна
- слабость и утомляемость



- Если анемия в тяжелой форме, лицо и ноги могут опухать, сердцебиение учащается и у больного может появиться одышка.
- Дети и женщины, которые любят есть землю, обычно анемичны.

Лечение и предупреждение анемии:

- ◆ **Кушать пищу богатую железом.** Мясо, рыба и цыплята содержат много железа. Особенно высокое содержание железа у печени. Темно-зеленые листовые овощи, бобы, горох и чечевица тоже содержат железо. Повышению количества железа способствует приготовление пищи в железных кастрюлях (см. с. 117). Чтобы помочь организму больше поглощать железа, кушайте сырые овощи и фрукты, избегайте пить кофе или чай с пищей.
- ◆ Если анемия умеренная или тяжелая, больному следует принимать железосодержащие таблетки, с. 393. Это особенно важно для беременных женщин с анемией. В любом случае анемии таблетки железа лучше, чем печеночный экстракт или витамин B12. Как правило, железо нужно принимать **через рот, а не инъекциями**, потому что инъекции железа опаснее и не лучше порошков.
- ◆ Если анемия вызвана дизентерией (понос с кровью), нематодами, малярией или другими болезнями, ее также следует лечить.
- ◆ Если анемия тяжелая и состояние не улучшается, обратитесь за медицинской помощью. Особенно это важно для беременных женщин.

Многие женщины анемичны. У анемичных женщин выше риск выкидыша и опасного кровотечения при родах. **Важно, чтобы эти женщины употребляли столько богатой железом пищи, сколько это возможно**, особенно во время беременности. Нужно 2-3 года воздержаться от новой беременности, чтобы дать возможность женщине восстановить силы и обновить кровь (см. Главу 20).

РАХИТ

У детей, кожа которых практически никогда не видит солнца, могут искривляться ноги и развиваться другие деформации костей (рахит). С этой проблемой можно бороться, если давать ребенку цельное молоко и витамин D (содержится в масле печени рыбы). Однако **самый легкий и самый дешевый способ предупредить его** – это подвергать кожу ребенка действию прямых солнечных лучей, по крайней мере, 10 минут в день. (Следите за тем, чтобы его кожа не обгорела.) Никогда не давайте большую дозу витамина D длительное время, так как он может отравить ребенка.



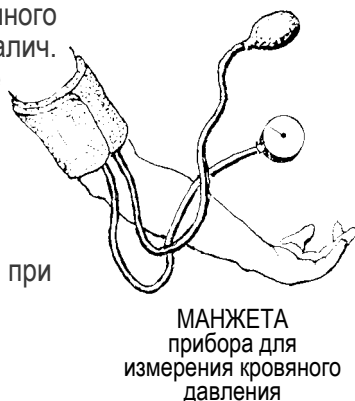
Признаки рахита:
костное ожерелье
кривые кости
большие суставы
кривые ноги
Солнечные лучи – лучшее средство для профилактики и лечения рахита.

ВЫСОКОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ (ГИПЕРТОНИЯ)

Высокое кровяное давление может вызвать много проблем, таких как заболевания сердца, почек и паралич. У полных людей особенно часто бывает высокое кровяное давление.

Признаки опасно высокого кровяного давления:

- частые головные боли;
- сильное сердцебиение и учащенное дыхание при небольших нагрузках;
- слабость и головокружение;
- изредка боль в левом плече и груди.



МАНЖЕТА прибора для измерения кровяного давления

Все эти проблемы могут вызываться другими болезнями. Поэтому, если больной подозревает, что у него высокое кровяное давление, ему следует обратиться к медицинскому работнику и попросить его измерить кровяное давление.

Предупреждение: Сначала высокое кровяное давление не вызывает никаких признаков, и его надо снизить **прежде**, чем опасные признаки начнут развиваться. Люди, которые имеют избыточный вес или подозревают, что у них может быть высокое кровяное давление, должны регулярно его проверять. Инструкции по измерению кровяного давления приведены на с. 410 и 411.

Что делать для предупреждения и устранения высокого кровяного давления:

- ◆ Если есть избыточный вес, сбросьте его (см. след. с.).
- ◆ Избегайте жирной пищи, особенно свинины, и еды с большим количеством сахара или крахмала. Всегда пользуйтесь растительным маслом вместо сала.
- ◆ Готовьте еду с небольшим количеством соли или без нее.
- ◆ Не курите. Не пейте много алкоголя, кофе или чая.
- ◆ Если кровяное давление очень высокое, работник здравоохранения может дать лекарство для понижения его. Многие люди могут снизить свое давление, сбросив лишний вес (след. с.) и отдохнув.

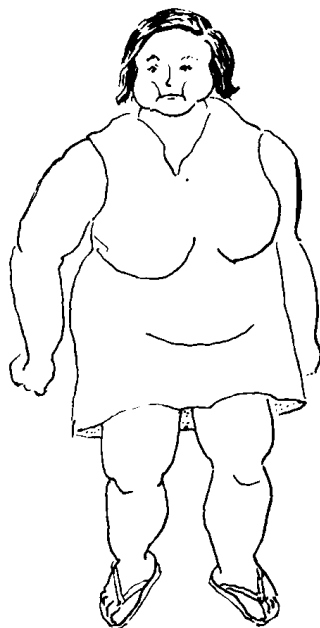
ТОЛСТЫЕ ЛЮДИ

Быть очень толстым – это не признак здоровья. Ожирение способствует появлению повышенного кровяного давления, болезней сердца, инсульта, желчного камня, диабета, артрита и других болезней.

Толстые люди должны снизить вес, для этого необходимо:

- ◆ кушать меньше жирной пищи;
- ◆ употреблять меньше сахара и сладостей;
- ◆ увеличить физические нагрузки;
- ◆ **нельзя переедать пищу**, содержащую крахмал, такую как злаки, хлеб, картошку, рис, мучные изделия, кассаву и др. Толстые люди должны съедать не больше одного кусочка хлеба, лепешки или чапаты с каждой порцией еды. Но они могут употреблять больше фруктов и овощей.

Предупреждение: Когда у вас появляется избыточный вес, начинайте следовать вышеперечисленным директивам.



Чтобы снизить вес, съедайте только половину того, что едите сейчас.

ЗАПОР

О больном, у которого твердый стул и нет опорожнений в течение 3 или более дней, говорят, что у него запор. Запор часто вызывается бедной диетой (особенно, когда не едят достаточно фруктов, зеленых овощей или продуктов с натуральным волокном, таких как зерновой хлеб) или недостатком физических нагрузок.

Пейте побольше воды и кушайте побольше фруктов, овощей, продуктов с натуральным волокном, таких как зерновой хлеб, кассава, пшеничные отруби, рожь, морковь, редька, кишмиш, орехи, тыква, подсолнечные семечки – это лучше, чем принимать слабительные. Помогает также ежедневная добавка в пищу растительного масла. Пожилым людям особенно нужны прогулки или физические нагрузки, чтобы иметь регулярные опорожнения.

Больной, который не опорожняется 4 или больше дней, если у него нет острых болей в желудке, может принять легкое соленое слабительное, такое как гидроокись магния. **Но не принимайте слабительные часто.**

Не давайте слабительное младенцам или маленьким детям. Если у ребенка сильный запор, положите немного перекипяченного растительного масла в прямую кишку (задний проход). Или, если необходимо, осторожно раздавите и вытащите твердый кал пальцем, смазанным маслом.

Никогда не используйте сильные слабительные или очистительные – особенно, если есть боли в желудке.

ДИАБЕТ

У больных диабетом слишком много сахара в крови. Диабет может начаться, когда человек молодой (молодой диабет) или старше 40 лет (взрослый диабет). Он намного серьезнее у молодых и требует лекарство (инсулин), чтобы контролировать его. Но чаще диабет встречается у больных, кому за 40, кто много ест и становится тучным.

Ранние признаки диабета: **Поздние, более серьезные признаки:**

- | | |
|------------------------------------|---|
| • постоянная жажда | • зудящая кожа |
| • обильное и частое мочеиспускание | • периоды неясного зрения |
| • постоянная усталость | • небольшая потеря чувствительности в ногах и руках |
| • постоянный голод | • частые вагинальные инфекции |
| • потеря веса | • незаживающие болячки на ногах |
| | • потеря сознания (в экстремальных случаях) |

Все эти признаки могут быть вызваны и другими болезнями. Чтобы определить, есть ли у человека диабет, проверьте его мочу на наличие в ней сахара. Один из способов проверки – попробовать на вкус. Если она сладкая, заставьте еще 2-х человек попробовать ее. Попросите их попробовать мочу еще 3-х человек. Если каждый согласится, что у этого человека моча слаще, значит у него диабет. (Осторожно: Не пробуйте на вкус мочу, если есть подозрение, что этот человек болен СПИДом.)

Другой способ проверки мочи – это использовать полоски из специальной бумаги (например, Уристикс). Если они изменяют цвет, когда вы окунете их в мочу, значит там есть сахар.

Если больной является ребенком или юношей, его следует показать опытному врачу или работнику здравоохранения.

Когда больному за 40 и у него диабет, болезнь лучше всего контролировать без лекарств, правильным питанием. **Диета для диабетика очень важна и, чтобы жить, он должен придерживаться ее очень строго.**

Диета диабетика: Тучные люди с диабетом должны сбросить вес, чтобы он стал нормальным. **Диабетики не должны есть сахар или конфеты, или пищу, сладкую на вкус.** Для них важно употреблять много волокнистых продуктов, таких как хлеб с отрубями. Но диабетикам нужна и крахмалистая пища – бобы, рис, картофель – и пища с большим содержанием протеина.

Взрослым диабетикам иногда помогает когда они употребляют чай “Арфазетин” (сбор лечебных трав, который вы можете приобрести в аптеке, он стоит дешево).

Для предохранения от инфекций и травм кожи надо чистить зубы после еды, содержать кожу в чистоте, всегда ходить в обуви, чтобы уберечься от ран на ногах. При плохой циркуляции в ногах (потемнение, онемение) отдыхайте, подняв ноги вверх. Следуйте тем же рекомендациям, что и при варикозном расширении вен (с. 175).

КИСЛОТНОЕ РАССТРОЙСТВО, ИЗЖОГА И ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА

Кислотное расстройство и изжога часто появляются после того, как человек съест много тяжелой или жирной пищи или выпьет много алкоголя или кофе. Они заставляют желудок вырабатывать больше кислоты, которая вызывает дискомфорт или “жжение” в желудке или в середине груди. Некоторые люди ошибаются, принимая боль в груди, называемую изжогой, скорее за проблему с сердцем, чем за расстройство. Если боль усиливается, когда вы ложитесь, то вероятнее всего, что это изжога.

Частое или долгое кислотное расстройство – это признак язвы.

Язва – это хроническая рана в желудке или в тонкой кишке, вызванная обилием кислоты. Она может вызывать хроническую, тупую (иногда резкую) боль в подложечной ямке. Как и при кислотном расстройстве, боль часто исчезает, когда больной поест или выпьет много воды. Боль обычно усиливается через час или больше после еды, если больной пропускает прием пищи или выпивает алкоголь, или ест жирную пищу или специи. Боль особенно усиливается ночью. Без специального обследования (эндоскопии) часто трудно узнать, есть ли у больного с частыми болями в желудке язва или нет.



Если язва в тяжелой форме, она может вызвать рвоту, иногда с кровью или с переваренной пищей, которая выглядит как кофейная гуща. Стул с кровью от язвы обычно черный как деготь.

Предупреждение: Некоторые виды язвы безболезненны или “молчащие” и первый признак – **кровь в рвотной массе или черный слипшийся стул.** Требуется срочная медицинская помощь. Больной может быстро истечь кровью и умереть. **СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ.**

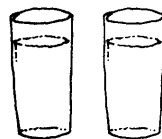
Предупреждение и лечение:

Будь то боль в желудке или груди, вызванная изжогой, кислотное расстройство или язва, несколько основных рекомендаций возможно помогут успокоить боль и помешать ей вернуться.

- **Не пере едайте.** Ешьте понемногу и чаще перекусывайте между приемами пищи. Ешьте те продукты, которые успокаивают, а не вызовут боль.
- **Заметьте, какие продукты или напитки усиливают боль, и избегайте их.** Обычно это алкогольные напитки, кофе, специи, перец, содовые напитки (сода, кола, шипучка) и жирные или масляные продукты.
- Если изжога усиливается ночью, когда лежите ровно, старайтесь спать, подняв тело на что-нибудь.



- ◆ **Пейте много воды.** Старайтесь выпить 2 больших стакана воды до и после еды. Пейте воду почаще между приемами пищи. Если боль приходит часто, продолжайте пить воду даже в то время, когда у вас нет боли.



- ◆ **Избегайте табака.** Курение или жевание табака повышает кислотность желудка и ухудшает болезнь.



- ◆ **Принимайте антациды.** Самые лучшие и безопасные антациды содержат магнезию и гидроксид алюминия. (см. на с. 381 информацию, дозу, меры предостережения для разных антацидов.)

- ◆ При сильной боли или язвах самое лучшее, что можно сделать, попытаться принять циметидин, гастросидин, гастроцепин (см. с. 382) или ранитидин (см. 382). Они весьма дорогие, но обычно очень эффективны для успокоения боли и помогают заживлению раны. Но язва может повториться.

- ◆ **Алоэ вера** – это растение, о котором говорят, что оно лечит язву. Нарезьте губчатые листья на маленькие кусочки, залейте их на ночь водой, а затем пейте по 1 стакану тягучей горькой воды каждые 2 часа.



ОСТОРОЖНО:

1. Многие врачи часто рекомендовали для лечения язвы **молоко**. Но хотя молоко сначала может успокоить боль, оно повышает кислотность в желудке, что усугубляет язву. Сейчас большинство врачей советует **не пить молоко для лечения язвы**.
2. Подобно молоку, некоторые антациды, такие как **двууглекислый натрий** (пищевая сода) и *Алка-Зельцер*, могут быстро успокоить кислотное расстройство, но вскоре вызовут еще большую кислотность. Они могут использоваться только при случайных расстройствах, но никогда не используются при язвах. Это также относится и к антацидам с кальцием.
3. Некоторые **лекарства**, такие как аспирин или соли железа, усугубляют язву. Больные с признаками изжоги или кислотного расстройства должны избегать их – или принимать меры предосторожности (с едой, обилием воды и, по возможности, с антацидами). Кортикостероиды тоже усугубляют язву или вызывают ее (см. с. 51.).

Важно **лечить язву в начальной стадии**. Иногда она может привести к опасному кровотечению или перитониту. При язве больному становится лучше, если он внимательно относится к еде и напиткам. Злость, напряжение и нервозность повышают кислотность в желудке. Научитесь расслабляться и успокаиваться – это большая помощь в лечении. Постоянное внимание необходимо для того, чтобы предупредить повторение язвы.

Еще лучше избегать проблем, **вызванных кислотностью в желудке, не переедая, не употребляя много алкогольных напитков или кофе, отказавшись от курения.**

ЗОБ (ОПУХОЛЬ ИЛИ ШИШКА НА ГОРЛЕ)

Зоб – это опухоль или большая шишка на горле, вызванная ненормальным ростом железы, называемой щитовидной железой.

Большинство зобов вызвано недостатком йода в пище. Недостаток йода в диете беременных женщин иногда является причиной смерти детей или они рождаются умственно отсталыми и/или глухими (кретинизм, с. 318). Это может случиться даже, если у матери нет зоба.

Зоб и кретинизм наиболее распространены в горных местах, где очень мало натурального йода в почве, воде или в пище. В этих местах питание такими продуктами, как маниока, может вызвать у человека зоб.

Как предупредить или лечить зоб и предупредить кретинизм:

Любой, кто живет в том месте, где люди болеют зобом, должен употреблять **йодированную соль**. Используйте ее, чтобы предупредить обычный вид зоба и избавиться от него. (Старый, твердый зоб можно удалить только хирургическим путем, но в этом обычно нет необходимости.)

Если нет возможности достать йодированную соль, пользуйтесь настойкой йода. Каждый день капайте по 1 капле в стакан воды и пейте. Будьте осторожны: Настойка йода в большом количестве – яд. Рекомендуется принимать не больше 1 капли в день, иначе можно усилить зоб. Храните бутылку там, где дети не смогут ее достать. Йодированная соль намного безопасней.

Многие домашние методы лечения от зоба не действуют. Однако пища из крабов и других морских продуктов может принести много пользы, поскольку они содержат йод. Примесь небольшого количества морских водорослей также добавляет йод. Но наилучший способ – употреблять **йодированную соль**.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ЗОБА



НИКОГДА не пользуйтесь обычной солью.

ЙОДИРОВАННАЯ СОЛЬ стоит только чуть дороже, чем другая соль, но намного лучше.



ВСЕГДА употребляйте йодированную соль.

Кроме того, если вы живете в таком месте, где распространен зоб, или у вас начинает развиваться зоб, старайтесь не есть много кассавы или капусты.

Примечание: Если больной с зобом сильно трясется, очень нервный и у него пучеглазие – это может быть другая разновидность зоба (токсический зоб). Обратитесь за медицинской помощью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: КАК ИЗБЕЖАТЬ МНОГИХ БОЛЕЗНЕЙ

Намного легче предупредить болезнь, чем лечить её! Если бы мы все внимание уделяли хорошему питанию, личной чистоте, чистоте своего дома и своей деревни и были бы уверены в том, что наши дети прошли вакцинацию, то мы смогли бы остановить большинство болезней еще до их начала. В Главе 11 мы обсуждали проблему хорошего питания. В этой главе мы поговорим о чистоте и прививках.

ЧИСТОТА – И ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ ИЗ-ЗА ЕЕ НЕДОСТАТКА

Чистота очень важна для предупреждения многих видов инфекций – в кишечнике, на коже, в глазах, легких и во всем организме. Важны и личная чистота (*гигиена*), и общественная чистота (*санитария*).

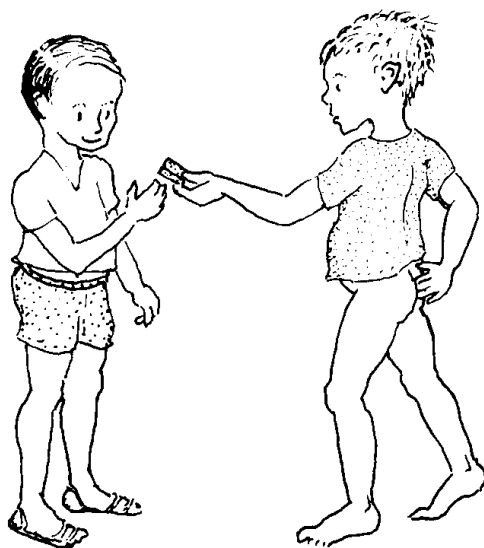
Многие обычные кишечные инфекции передаются от одного человека к другому из-за плохой гигиены и санитарии. Микробы и глисты (или их яйца) тысячами содержатся в стуле или фекалиях инфицированных больных. Они попадают из кала одного человека в рот другого через грязные пальцы или через загрязненные продукты или воду. Болезни, которые распространяются или передаются из кала в рот, включают в себя:

- понос и дизентерию (вызываемые амебами и бактериями);
- кишечные глисты (несколько видов);
- гепатит, брюшной тиф и холеру;
- другие болезни, такие как полиомиелит, распространяющиеся иногда таким же путем.

Способ распространения этих инфекций может быть очень простым.

Например, ребенок, у которого глисты и который забыл вымыть руки после опорожнения, предлагает своему другу печенье. Его пальцы, грязные после стула, покрыты сотнями крошечных яиц глистов (такими маленькими, что их не видно). Некоторые из этих яиц прилипают к печенью. Когда товарищ кушает печенье, он глотает с ним также яйца глистов.

Вскоре его друг заболевает глистами. Его мать может сказать, что это из-за конфет. На самом деле, это из-за кала, который он съел с печеньем.



Неоднократно свиньи, собаки, цыплята и другие животные распространяют кишечную инфекцию и яйца глистов. Например:



Многие виды инфекций, так же как и глисты, передаются от одного человека к другому только что описанным способом.

Если бы семья предприняла **любую** из следующих мер предосторожности, то распространение болезни можно было бы остановить:

- если бы человек пользовался уборной или испражнялся подальше от дома,
- если бы семья не разрешала свиньям входить в дом,
- если бы взрослые не разрешали играть ребенку со свиньей,
- если бы мать вымыла руки после общения с ребенком и перед приготовлением еды.

Если в вашей деревне много случаев поноса, заражения глистами и другими кишечными паразитами, значит люди были не очень чистоплотными. Если много детей умирает от поноса, похоже, что и плохое питание является частью данной проблемы. **Для предупреждения смертности от поноса необходимы чистота и хорошее питание** (см. с. 154 и Главу 11).

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ ЧИСТОТЫ

ЛИЧНАЯ ЧИСТОТА (ГИГИЕНА)



1. Всегда мойте руки с мылом, после опорожнения кишечника и перед едой.



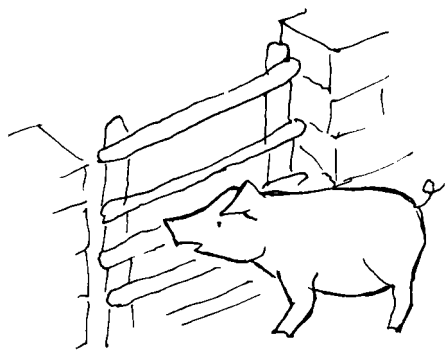
2. Чаще купайтесь – каждый день, когда жаркая погода. Купайтесь после работы или когда потеете. Частое купание помогает предупредить кожные инфекции, перхоть, прыщи, чесотку и сыпь. Больным, включая детей, следует купаться ежедневно.

3. В местностях, где глисты – обычное явление, не ходите босиком и не разрешайте делать это детям. Заражение глистами вызывает тяжелую форму анемии. Эти глисты проникают в организм через подошвы ног (см. стр. 142).



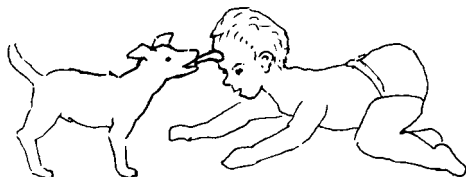
4. Чистите зубы каждый день и каждый раз после того, как вы поели сладости. Если у вас нет зубной щетки или зубной пасты, протрите зубы солью или пищевой содой (см. стр. 320). Чтобы получить больше информации об уходе за зубами, смотрите Главу 17.

ЧИСТОТА В ДОМЕ

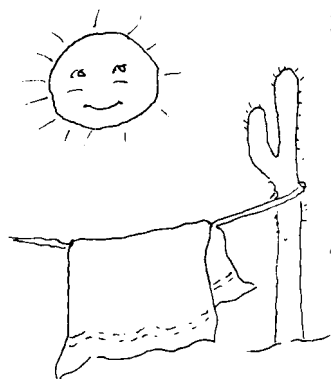


1. Не разрешайте свиньям или другим животным заходить в дом и бывать в тех местах, где играют дети.

2. Не разрешайте собакам лизать ребенка или лезть на кровать. Собаки тоже могут распространять болезни.



3. Если дети или животные роются около дома, сразу убирайте заны. Учите детей пользоваться уборной или по крайней мере отходить подальше от дома.



4. Проветривайте чаще простыни и одеяла на солнце. Если есть клопы, облейте кровати кипятком и постирайте простыни и одеяла — все в течение одного дня (см. с. 200).



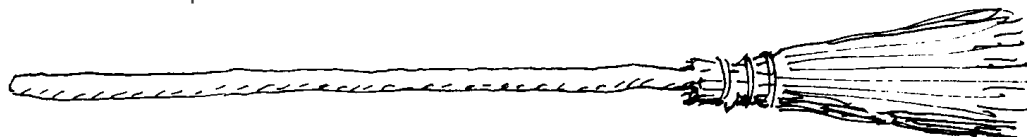
5. Чаще вычесывайте вшей у всей семьи (см. с. 200). Вши и блохи переносят многие болезни. Не следует впускать в дом собак и других животных, у которых есть блохи.



6. Не плюйте на пол. Плевки могут разносить болезни. Когда кашляете или чихаете, закрывайте рот рукой или платком, или кусочком ткани.

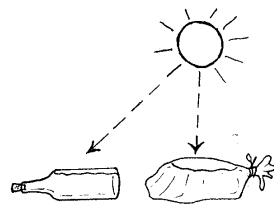


7. Чаще убирайтесь в доме. Подметайте и мойте полы, стены и под мебелью. Закройте все трещины и дыры на полу, на стенах, где могут прятаться тараканы, клопы и скорпионы.



ЧИСТОТА ПРОДУКТОВ И ПИТЬЯ

1. В идеальном случае всю воду, которая не поступает из чистой водопроводной системы, следует кипятить, фильтровать или очищать перед употреблением. Это особенно важно для маленьких детей и в случаях, когда много заболеваний поносом, тифом, гепатитом, холерой. Однако для предупреждения болезней гораздо важнее иметь **достаточно** воды, а не чистую воду. Бедные семьи часто имеют ограниченные запасы и, советуя им жечь дорогие дрова для кипячения **питьевой** воды, можно принести больше вреда, чем пользы, особенно, если не останется дров для приготовления пищи. Чтобы получить больше информации о чистой воде, см. *Пособие Для Работников Здравоохранения*, Глава 15.



Хороший и дешевый способ очистки воды - налить ее в чистую пластиковую бутылку и оставить на солнце на несколько часов. Это убьет многих микробов.



2. Не позволяйте мухам и другим насекомым садиться и ползать по продуктам. Эти насекомые переносят микробы и распространяют болезни. Не оставляйте после еды крошки пищи или грязную посуду, так как они привлекают мух и кормят микробы. Защищайте еду, держите ее закрытой в ящиках или в шкафах с сеткой.

3. Перед тем как есть фрукты, которые упали на землю, хорошо помойте их. Не разрешайте детям подбирать и есть упавшую пищу – сначала вымойте ее.



4. Ешьте только хорошо проваренные мясо или рыбу. Будьте осторожны с жареным мясом, особенно со свининой и рыбой, не оставляйте внутри сырых мест. Сырая свинина вызывает опасные болезни.



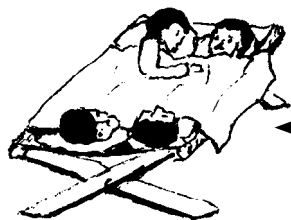
5. Перед варкой промойте цыпленка в чистой воде. Цыплята переносят микробы, которые могут вызвать понос. И еще, вымойте руки после приготовления цыплят, прежде чем трогать другую пищу.

6. Не ешьте старую пищу и пищу с плохим запахом. Такой пищей можно отравиться. Не ешьте консервы, если банка вздулась и содержимое идет струей, когда ее открываете. Особенно будьте осторожны с рыбными консервами. И еще, будьте осторожны с цыплятами, которые были приготовлены несколько часов тому назад. Прежде чем есть давно приготовленную пищу, хорошо разогрейте ее. Если возможно, подавайте только свежеприготовленную еду, особенно детям, пожилым людям и очень больным.



7. Больным туберкулезом, гриппом, простудой или другими инфекционными болезнями следует питаться отдельно от других. Тарелки и посуда больных людей должна кипятиться перед использованием другими людьми.

КАК ЗАЩИТИТЬ ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ



1. Больной ребенок, как этот — должен спать отдельно от здоровых.

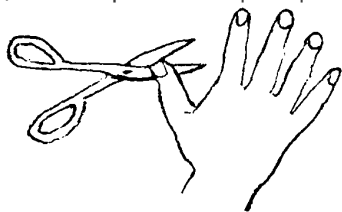


Больные дети или дети с болячками, зудящей кожей или вшами должны спать отдельно от здоровых. Дети с инфекционными болезнями, такими как коклюш, корь, обычная простуда должны спать в отдельных комнатах, если это возможно, и им нельзя находиться около младенцев или малышей.

2. Оберегайте детей от туберкулеза. Люди с хроническим кашлем или другими признаками туберкулеза должны прикрывать рот при кашле. Они **никогда** не должны спать в одной комнате с другими детьми. Их нужно показать работнику здравоохранения и лечить как можно быстрее.



Дети, которые живут в доме с туберкулезным больным, должны пройти вакцинацию от туберкулеза (БЦЖ вакцина).



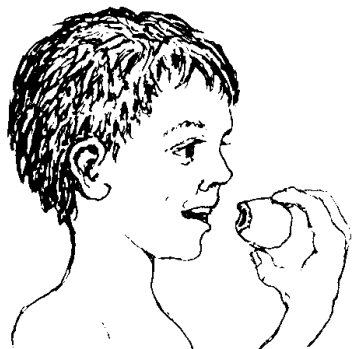
3. Почаще купайте детей, меняйте им одежду и подрезайте ногти. Микробы и яйца глистов часто прячутся под длинными ногтями.

4. Лечите детей, у которых есть инфекционные болезни, как можно быстрее, чтобы болезнь не перешла на других.



5. Следуйте всем правилам чистоты, упомяну-

тым в этой главе. Учите детей следовать этим правилам и объясните, почему они так важны. Воодушевляйте детей на участие в проектах, которые сделают дом или деревню здоровым местом для жизни



6. **Убедитесь, что дети получают достаточно хорошей еды.** Хорошее питание помогает защитить организм от многих инфекций. Упитанный ребенок обычно лучше сопротивляется или борется с инфекциями, которые могут убить истощенного ребенка (читайте Главу 11).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЧИСТОТА (САНИТАРИЯ)

1. Содержите колодцы и общественные водоисточники в чистоте. Не разрешайте животным ходить там, где люди берут воду для питья. Если возможно, поставьте забор вокруг источника, чтобы животные не подходили туда.

Не испражняйтесь или не бросайте мусор около источников. Обращайте особое внимание на то, чтобы реки и ручьи были чистыми в тех местах, где вы берете воду для питья.

2. Сжигайте весь мусор, который можно сжечь. Тот мусор, который не горит, следует закопать в специальной яме или в месте подальше от домов и от места, где люди берут воду для питья.



3. Стройте уборные так, чтобы свиньи и другие животные не могли достать человеческие отбросы. Хорошо подходит глубокая яма с небольшим домиком над ней. Чем глубже яма, тем меньше проблем с мухами и запахом.

Вот рисунок простого отхожего места, которое легко построить.

Чтобы уменьшить запах и избавиться от мух, нужно бросать немного извести, грязи, пепла в яму после каждого опорожнения.

Отхожие места должны строиться по крайней мере в 20 метрах от домов или источников воды.

Если у вас нет отхожего места, уйдите подальше от места, где люди купаются или берут воду для питья. Учите своих детей делать то же самое.

Пользуясь уборными, вы предупреждаете многие болезни.

Советы о постройке лучших уборных можно найти на следующих страницах. И еще, уборные могут быть построены так, чтобы иметь хорошее удобрение для садов.

БОЛЕЕ ХОРОШИЕ УБОРНЫЕ

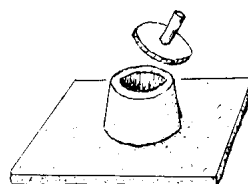
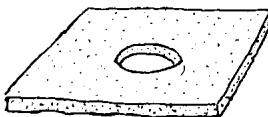
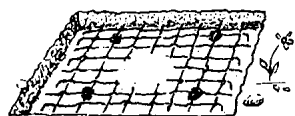
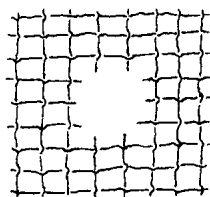
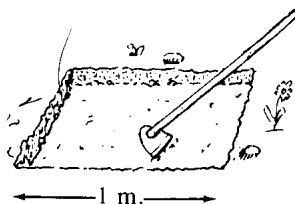
Уборная, или отхожее место, показанное на предыдущей странице, очень простое и его постройка почти ничего не стоит. Но оно открыто сверху и туда залетают мухи.

Закрытые уборные лучше, потому что туда не залетают мухи, а запах остается внутри. В закрытой уборной есть платформа или плита с отверстием в ней и крышка над отверстием. Плита может быть сделана из дерева или цемента. Цемент лучше, потому что плита из него примыкает более плотно и не гниет.

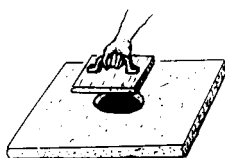
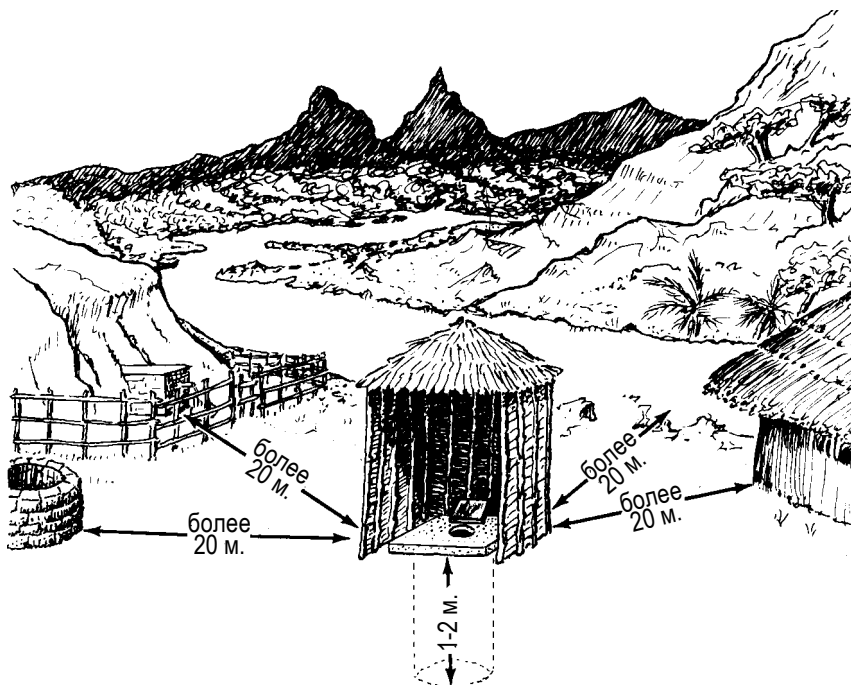
Один из способов изготовления цементной плиты:

1. Выройте мелкую яму площадью около 1 кв. м и глубиной 7 см. Убедитесь, что дно ямы плоское и ровное.
2. Сделайте или отрежьте проволочную сетку или решетку площадью в 1 кв.м. Проволока может быть толщиной 1/4 или 1/2 см, а размер ячейки около 10 см. В середине решетки прорежьте отверстие диаметром 25 см.
3. Положите решетку в яму. Загните концы проволоки или положите маленький камень в каждый угол, чтобы решетка отстояла от земли на 3 см.
4. Поставьте старое ведро на отверстие в решетке.
5. Смешайте цемент с песком, гравием и водой и залейте этот раствор до толщины 5 см. (С каждой лопатой цемента смешать 2 лопаты песка и 3 лопаты гравия.)
6. Уберите ведро, когда цемент начнет твердеть (около 3 часов). Затем накройте цемент сырой тряпкой, песком, сеном или полоской из пластика и постоянно увлажняйте их. Уберите плиту через три дня.

Если вы предпочитаете сидеть, когда посещаете уборную, то сделайте сидение из цемента вот так: Сделайте форму или используйте 2 ведра разных размеров, одно внутри другого.



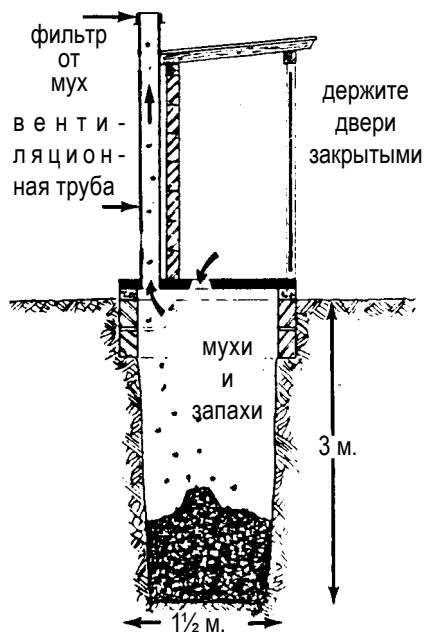
Чтобы сделать **закрытую уборную**, плиту следует поместить над круглой ямой в земле. Выкопайте яму поперечником чуть меньше 1 м и глубиной от 1 до 2 м. Для безопасности уборная должна находиться по крайней мере в 20 метрах от всех домов, колодцев, ручьев, рек или родников. Если уборная расположена вблизи того места, куда люди ходят за водой, то убедитесь, что она стоит **ниже по течению**.



Содержите уборную в чистоте. Чаще мойте плиту. Убедитесь, что отверстие в плите закрыто крышкой. Простая крышка может быть сделана из дерева.

Чтобы построить уборную с вентиляционной вытяжкой (УВВ), сделайте плиту больше (площадью 2 кв.м) с 2 отверстиями в ней. Над одним из отверстий поставьте вентиляционную трубу, прикрытую марлей от москитов или сеткой от мух. Над другим отверстием постройте отхожее место, внутри которого будет очень темно. Оставьте это отверстие открытым.

Такая уборная помогает избежать запаха и мух: запахи проходят через трубу, а мухи попадают в сетку и гибнут.



ГЛИСТЫ И ДРУГИЕ КИШЕЧНЫЕ ПАРАЗИТЫ

Есть очень много видов глистов и других крошечных животных (паразитов), которые живут в кишечнике у людей и вызывают болезни. Те, которые побольше, могут быть видны в испражнениях (фекалиях).

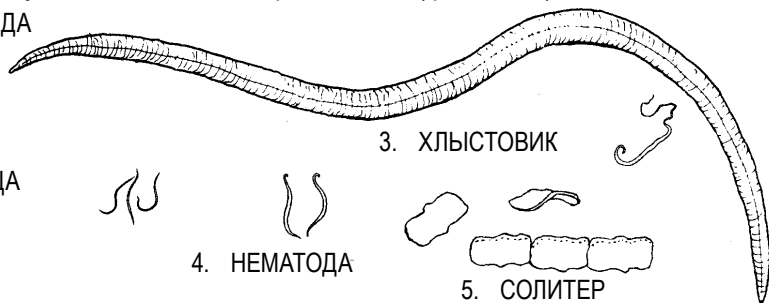
1. АСКАРИДА

2. ОСТРИЦА

3. ХЛЫСТОВИК

4. НЕМАТОДА

5. СОЛИТЕР

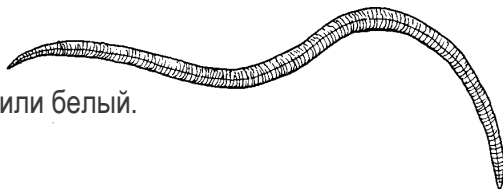


Из глистов только аскариды, острицы и солитеры обычно заметны в кале. Нематоды и хлыстовики могут в большом количестве находиться в кишечнике, но их нельзя увидеть в испражнениях.

Примечание по лекарствам от глистов: Многие противоглистные лекарства содержат пиперазин. Они помогают только от аскарид и остриц и их нельзя давать грудным и маленьким детям. Мебендазол (Вермокс) безопаснее и действует на многие разновидности глистов. Альбендазол и пирантел также лечат от разных видов глистов, но они могут быть более дорогими. Тиабендазол убивает многие виды глистов, но вызывает опасные побочные эффекты и обычно не употребляется. Для дополнительной информации об этих лекарствах смотрите с. 374-376.

Аскариды

Длина от 20 до 30 см. Цвет: розовый или белый.



Как они распространяются:

Фекалии в рот. При отсутствии чистоты яйца аскарид попадают из кала одного человека в рот другого.

Влияние на здоровье:

Из однажды проглоченных яиц вылупляются молодые глисты, которые попадают в кровеносные сосуды; это может вызвать общий зуд. Затем молодые особи попадают в легкие, вызывая иногда сухой кашель или хуже – пневмонию с кашлем и кровью. Молодые аскариды откашливаются, проглатываются и достигают кишечника, где вырастают до нормальных размеров.

Большое количество аскарид в кишечнике могут вызывать дискомфорт, диспепсию и слабость. Дети, у которых есть аскариды, часто имеют большой вздутый живот. Редко, но аскариды могут вызвать астму, припадки или опасное засорение или закупорку кишечника (см. с. 94). Особенно, когда у ребенка жар, аскариды выходят со стулом или выползают через рот или нос. Иногда они ползают по дыхательным путям и вызывают рвоту.

Профилактика:

Пользуйтесь уборными, мойте руки перед едой, защищайте пищу от мух и следуйте всем правилам соблюдения гигиены, изложенным в первой части этой главы.

Лечение:

Обычно помогает избавиться от аскарид мебендазол. Дозировку смотрите на странице 374. Пиперазин также может помочь (см. с. 374). Прекрасно лечат некоторые домашние средства. Из домашних средств лучше всего семена тыквы.

ОСТОРОЖНО: Не употребляйте тиабендазол от аскарид. Он часто заставляет глисты выходить через нос или рот и может вызвать рвоту.

Острицы

Длина 1 см. Цвет: белый. Очень тонкие и похожие на нитки.

Как они переносятся:

Эти глисты откладывают тысячи яиц прямо на внешней поверхности ануса (оральное отверстие). Они вызывают зуд, особенно по ночам. Когда ребенок чешется, яйца попадают под ногти и переносятся на еду и другие предметы. Таким образом они попадают в рот к самому зараженному или другому человеку, вызывая новые инфекции остриц.

Влияние на здоровье:

Эти глисты не опасные. Зуд может нарушить сон ребенка.

Лечение и предупреждение:

- ◆ Ребенок, у которого острицы, должен спать в плотно прилегающем подгузнике или в трусах, чтобы он не мог чесать в анусе.
- ◆ Мойте руки ребенку и ягодицы (задний проход), когда он проснется и после испражнения. Всегда мойте ему руки перед едой.
- ◆ Очень коротко стригите его ногти.
- ◆ Чаще меняйте ему одежду и купайте его – мойте ему ягодицы и ногти особенно тщательно.
- ◆ Намажьте Вазелином внутри и вокруг ануса перед сном, чтобы помочь избавиться от зуда.
- ◆ Дайте ему противоглистное лекарство мебендазол. Дозировку смотрите на странице 374. Пиперазин тоже действует, но его не рекомендуют младенцам и детям (с. 375). Когда лечат одного ребенка от этих глистов, лучше одновременно лечить всю семью. Из домашних средств употребляйте чеснок, см. стр. 13.
- ◆ Самая лучшая профилактика остриц – чистота. Даже если лекарство помогает избавиться от глистов, ими можно заразиться снова, если не будут соблюдаться правила личной гигиены. Острицы живут около 6 недель. **При точном соблюдении правил личной гигиены большинство остриц погибнет через несколько недель, даже без лекарств.**

1 5/5



Хлыстовики

Длина от 3 до 5 см. Цвет: розовый или серый.



Эти глисты, как и аскариды, переносятся от фекалий одного человека в рот другому. Обычно эти глисты причиняют мало вреда, но могут вызвать понос. У детей иногда вызывают выход части кишечника из ануса (выпадение прямой кишки).

Профилактика: Такая же, как и от аскарид.

Лечение: Если глисты вызывают какие-либо проблемы, дайте мебендазол. Дозировку смотрите на странице 374. При выпадении прямой кишки переверните ребенка и полейте холодной водой на кишку. Это заставит ее втянуться назад.

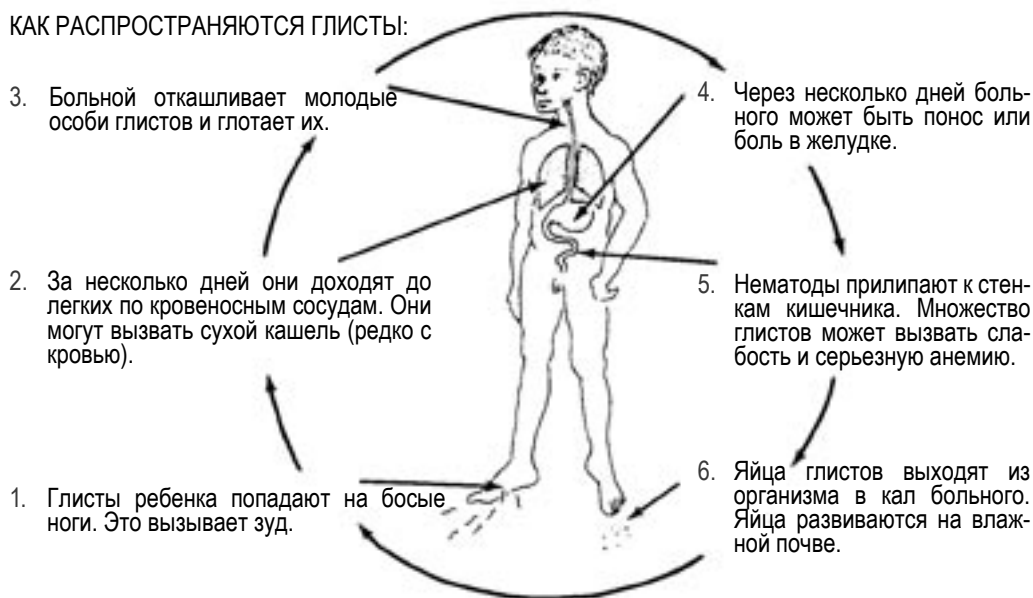
Нематоды



Длина 1 см. Цвет: красный.

Их обычно не видно в кале. Обязательно нужен анализ кала, чтобы обнаружить их.

КАК РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ГЛИСТЫ:



Инфекция нематодами может быть самой опасной болезнью детства. Любой ребенок, который страдает анемией, бледен или кушает грязь, может иметь нематоды. Если возможно, надо сдать его кал на анализ.

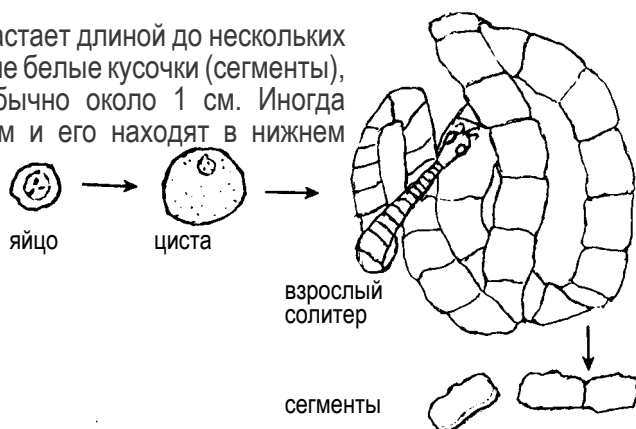
Лечение: Употребляйте мебендазол. Дозировку и меры предосторожности смотрите на с. 374. Для лечения анемии употребляйте пищу, содержащую железо, и, если необходимо, принимайте пилюли железа (с. 124).

**Профилактика нематод: Постройте уборные и пользуйтесь ими.
Не разрешайте ходить детям босиком.**

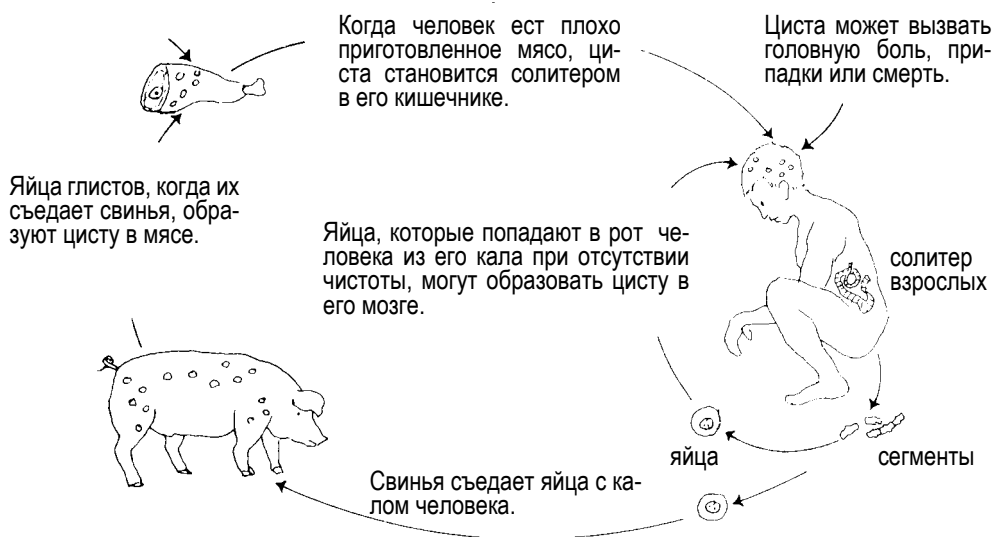
СОЛИТЕР

В кишечнике солитер вырастает длиной до нескольких метров. Но маленькие, плоские белые кусочки (сегменты), найденные на фекалиях, обычно около 1 см. Иногда сегмент может выползти сам и его находят в нижнем белье.

Люди заражаются солитером при употреблении в пищу свинины, говядины или любого другого мяса или рыбы, которые плохо приготовлены.



Предупреждение: Старайтесь хорошо приготовить любое мясо, особенно свинину. Убедитесь в том, что ни одна часть внутри жареного мяса или рыбы не осталась сырой.



Солитеры в кишечнике человека иногда вызывают легкие боли в желудке, но появляется несколько других проблем.

Самая большая опасность существует тогда, когда циста (маленькие мешочки, содержащие маленьких глистов) попадает в мозг человека. Это случается, если яйца попадают из кала человека в его рот. По этой причине **любой зараженный солитером должен особенно тщательно придерживаться правил гигиены – и начинать лечение как можно скорее.**

Лечение: Принимайте никлосамид (Фенасал или Йомесан, с. 376) или празиквантел (с. 376). Тщательно придерживайтесь инструкций.

Трихины

Эти глисты никогда не видны в испражнениях. Они проходят через кишечник и попадают в мышцы. У людей появляются эти глисты, как и солитер, при употреблении инфицированной свинины или другого мяса, которое плохо приготовлено.

Влияние на здоровье: В зависимости от количества инфицированного мяса, которое съел человек, он может не чувствовать никакого воздействия или сильно заболеть, или умереть. У больного может появиться понос и он почувствует боль в желудке по прошествии от нескольких часов до 5 дней с момента употребления инфицированной свинины.

В серьезных случаях у больного может быть:

- жар с ознобом;
- боль в мышцах;
- отеки вокруг глаз и иногда отеки ног;
- небольшие синяки (черные или синие пятна) на коже;
- кровоизлияния в белках глаз.

Тяжелые случаи заболевания могут продолжаться 3 или 4 недели.

Лечение: Сразу обращайтесь за медицинской помощью. Может помочь тиабендазол или мебендазол. Дозировку смотрите на с. 374 и 375. (Могут помочь кортикостероиды, но их должен давать работник здравоохранения или врач.)

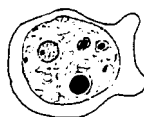
Важно: Если несколько человек заболели после употребления в еду мяса одной и той же свиньи, то надо заподозрить трихинеллез. Это может оказаться опасным, поэтому обратитесь за медицинской помощью.

Профилактика трихинеллеза:

- Ешьте только хорошо приготовленную свинину или другие виды мяса.
- Не давайте свиньям обрезки мяса или остатки из скотобоен, пока мясо не будет приготовлено.

АМЕБЫ

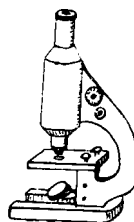
Это не глисты, а крошечные животные – или паразиты – которых можно увидеть только под микроскопом (инструмент, через который предметы выглядят намного больше).



Амеба под микроскопом

Как они передаются:

Испражнения инфицированных людей содержат миллионы этих крошечных паразитов. Из-за плохой санитарии они попадают в источник питьевой воды или в пищу и другие люди заражаются.



Микроскоп

Признаки заражения амебой:

Многие здоровые люди имеют амебы, но сами не болеют. Однако амебы – это распространенная причина сильного поноса или дизентерии (понос с кровью), особенно у людей, уже ослабленных другой болезнью или плохим питанием. Иногда амебы вызывают болезненные, опасные абсцессы в печени.

Типичная амёбная дизентерия состоит из:

- поноса, который появляется и проходит – иногда переходя в запор;
- судорог в животе и частых позывов к испражнению, даже когда ничего не выходит или выходит очень мало, или выделяется просто слизь;
- много жидкого (но обычно не водянистого) стула с большим количеством слизи, иногда окрашенной кровью;
- в тяжелых случаях – много крови; человек чувствует себя очень слабым и больным;
- обычно без жара.

Понос с кровью может быть вызван амёбами или бактериями. Однако бактериальная дизентерия (Шигелла) начинается более внезапно, стул обычно водянистый и почти всегда жар (с. 158). Как общее правило:

Понос + кровь + температура = бактериальная инфекция (Шигелла)
Понос + кровь + без жара = амёбная инфекция

Иногда кровавый понос имеет другие причины. Чтобы убедиться в причине, необходимо сделать анализ кала.

Иногда амёбы попадают в печень и образуют абсцесс или карман с гноем. Это вызывает болезненность или боль в правой верхней части живота. Боль может распространиться на правую сторону груди и усиливаться при ходьбе. (Сравните это с болью в желчном пузыре, с. 329; гепатитом, с. 172; и циррозом, с. 328.) Если больной с этими признаками начинает кашлять коричневой жидкостью, это значит, что амёбный абсцесс просочился в его легкие.

Лечение:

- Если можно, обратитесь за медицинской помощью и сдайте кал на анализ.
- Амёбную дизентерию можно лечить метронидазолом, если возможно, вместе с дилюксанид фуруоатом или тетрациклином. Дозировку, продолжительность лечения и предосторожности смотрите на с. 369.
- Если это амёбный абсцесс, то лечите как амёбную дизентерию, затем принимайте хлорохин в течение 10 дней (см. с. 366).

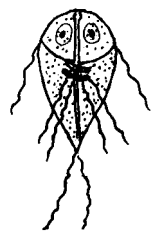
Профилактика: Стройте и пользуйтесь уборными, защищайте источники питьевой воды и следуйте правилам гигиены. Хорошо питайтесь, избегайте усталости и выпивки – это важно для предупреждения амёбной дизентерии.

Лямблия

Лямблия, как амёба, микроскопический паразит, который живет в кишечнике и обычно вызывает понос, особенно у детей. Понос может быть хроническим или перемежающимся (может приходить и уходить).

Если понос желтый, с плохим запахом, пенистый (полно пузырьков), но без крови или слизи, то возможно у больного лямблия. Живот вздут от газов, появляются легкие спазмы кишечника, обычно без температуры. Отрыжка имеет плохой запах тухлых яиц.

Инфекция лямблией иногда проходит сама по себе. Помогает хорошее питание. Тяжелые случаи лучше всего лечить метронидазолом (см. с. 369). Хинакрин (*Атабрин*, с. 370) дешевле и часто действует лучше, но вызывает побочные явления.



Лямблия под микроскопом

КРОВЯНЫЕ СОСАЛЬЩИКИ (ШИСТОСОМЫ, БИЛЬГАРЦИИ)

Эта инфекция вызывается глистами, которые попадают в кровь. Различные типы кровяных сосальщиков обнаружены в разных частях света. Один тип, распространенный в Африке и на Среднем Востоке, вызывает кровь в моче. Другие виды вызывают кровавый понос и распространены в Африке, Южной Америке и Азии. В местах появления этой болезни любому человеку, у которого кровь в моче или кале, надо провериться на наличие яиц сосальщиков.

Признаки:

- Самый распространенный признак – кровь в моче (особенно, когда идут последние капли), для других видов сосальщиков – кровавый понос.
- Боль может появляться в нижней части живота и между ногами; она обычно усиливается в конце мочеиспускания. Низкая температура, слабость и зуд.
- После нескольких месяцев или лет могут быть сильно повреждены почки или печень, что постепенно приведет к смерти.
- Иногда отсутствуют ранние признаки. В местах сильного распространения шистосомоза надо проверять людей с легкими признаками или болью в животе.

Лечение: Празиквантел действует на все виды кровяных сосальщиков. Метрифонат и оксамнихин действуют только на некоторые виды кровяных глистов. Дозировку смотрите на с. 377. Лекарства следует принимать только по назначению опытного работника здравоохранения.



Улитка
(реальный размер)

Профилактика: Кровяные сосальщики не передаются от человека к человеку. Часть своей жизни они живут внутри определенного вида маленькой водной улитки.

Кровяные сосальщики распространяются так:

1. Инфицированный больной мочится или опорожняется в воду.
2. Моча или кал содержат яйца глистов.
3. Из яиц вылупляются глисты и входят в улитку.
4. Молодые глисты покидают улитку и человека.
5. Таким образом, тот, кто купается или умывается в воде, куда помочился или опорожнился больной, тоже становится больным.



Для предупреждения шистосомоза содействуйте программам уничтожения улиток и лечения больных. Но самое важное: Каждый должен научиться пользоваться уборными и никогда не мочиться и не испражняться в воду или около нее.

Для дополнительной информации о риштах смотрите с. 406 и 407.

ВАКЦИНАЦИЯ (ИММУНИЗАЦИЯ) – ПРОСТАЯ И НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Вакцины защищают от многих опасных болезней. Если работники здравоохранения не проводят вакцинацию в вашей деревне, отведите детей в ближайший медицинский центр для вакцинации. Лучше сделать прививки, когда они здоровы, чем потом лечить их, когда они болеют или умирают. Вакцинацию обычно делают бесплатно. (Разные страны пользуются разными расписаниями.) Наиболее важными вакцинами для детей являются:

1. **КДС – от коклюша, дифтерии и столбняка.** Для полной защиты детям нужно сделать 3 инъекции. Их обычно делают в 2, 3 и 4 месяца.
2. **Полио (детский паралич).** Ребенку дают капли в рот при рождении и один раз каждый месяц в течение трех месяцев (они обычно даются вместе с КДС инъекциями). Лучше не кормить грудного ребенка 2 часа до и после приема капель.
3. **БЦЖ – от туберкулеза.** В кожу правого плеча делается одна инъекция. Эту вакцинацию можно провести при рождении ребенка или позже в любое время. Если кто-либо из домашних ребенка болен туберкулезом, то ранняя вакцинация особенно важна. Вакцина образует ранку и оставляет шрам.
4. **Корь.** Делается только одна инъекция не ранее 9 месяцев и до 15, в зависимости от страны.
5. **Столбняк.** Для взрослых и детей старше 12 лет самая важная вакцина – это от столбняка. Делают одну инъекцию ежемесячно в течение трех месяцев, следующую через год, а затем один раз каждые 10 лет. Вакцинация против столбняка необходима каждому. Беременным женщинам следует делать прививку во время каждой беременности, чтобы их дети были защищены от столбняка новорожденных (см. с. 182 и 250).
6. **Оспа.** Эта вакцинация, сделанная на **левом плече**, оставляет круглый шрам. Благодаря вакцинации по всему миру в прошлом, оспа больше не существует. Поэтому вакцинация против нее не требуется.



ПОЛИО ВАКЦИНА
Капли сладкие на вкус.

В некоторых странах делают прививки от холеры, желтой лихорадки, тифа, свинки и коревой краснухи. ВОЗ разрабатывает вакцины от лепры, малярии и менингита.

Проводите вакцинацию ваших детей вовремя. Убедитесь, что они получили полную серию каждой нужной им вакцины.

ВНИМАНИЕ: Вакцина легко портится и потом не действует. Вакцина от кори должна храниться **замороженной**. Старайтесь хранить полиомиелитную вакцину в замороженном состоянии до употребления. В течение трех месяцев ее можно размораживать и замораживать снова. Но при этом вакцину нужно хранить в холоде иначе она испортится. КДС, БЦЖ и вакцину от столбняка нужно держать в холоде (0о-8оС), но **никогда не замораживать**. Хорошая КДС остается мутной по крайней мере один час после встряски. Если она становится прозрачной в течение часа, то она испорчена. О способах сохранения вакцины холодной смотрите *Пособие Для Работников Здравоохранения*, Глава 16.

**Проводите вакцинацию ваших детей вовремя.
Убедитесь, что они получили полную серию каждой нужной им вакцины.**

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ И ТРАВМ

В этой главе мы говорили о способах предупреждения кишечных и других инфекций через **гигиену, санитарию и вакцинацию**. По всей этой книге вы найдете советы по предупреждению болезней и травм – от построения здорового тела при полноценной пище до мудрого использования домашних средств лечения и современных препаратов.

Введение для сельского работника здравоохранения предлагает идеи о совместных усилиях людей по изменению условий, являющихся причиной плохого здоровья.

В оставшихся главах, где обсуждаются специфические проблемы здоровья, вы найдете много предложений по их предупреждению. Следуя этим советам, вы сможете помочь сделать ваш дом и деревню здоровым местом обитания.

Запомните, что один из лучших способов предупреждения серьезной болезни и смерти – это раннее и разумное лечение.

Раннее и разумное лечение – это важная часть превентивной медицины.

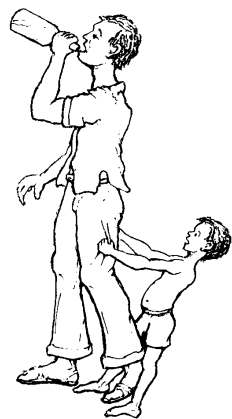
Перед тем как закончить эту главу, я хотел бы упомянуть о нескольких аспектах профилактики, которые приводятся в других частях книги и заслуживают особого внимания.

Привычки, Которые Влияют на Здоровье

Некоторые привычки людей разрушают не только их собственное здоровье, но так или иначе наносят вред окружающим. Многие из этих привычек можно бросить или избежать, но первый шаг – это понять, почему бросить эти привычки так важно.

ПЬЯНСТВО

Если алкоголь приносит много радости человеку, то он также приносит и много страданий – особенно семьям тех, кто пьет. Немного алкоголя сейчас и потом может и не принести вреда. Но очень часто малое ведет к большому. Во всем мире сильная и чрезмерная выпивка лежит в основе главных проблем здоровья – даже для тех, кто не пьет. Вредить выпивка может не только тем, кто пьет (способствует таким болезням как цирроз печени, с. 328, и гепатит, с. 172), но она наносит ущерб семье, обществу. Когда человек пьет, он теряет рассудок и самоуважение – все это ведет к несчастью, утратам и насилию, часто действуя на тех, кого любят больше всего.



Сколько отцов потратили свои последние деньги на выпивку, когда их дети были голодными? Сколько болезней оказалось результатом того, что мужчина тратит часть своих заработанных денег охотнее на выпивку, чем на улучшение условий жизни своей семьи? Сколько людей, ненавидя себя за то, что они делают больно тем, кого любят, пьют опять, чтобы забыться?

Однажды человек понимает, что алкоголь вредит здоровью и счастью окружающих, что он может сделать? Сначала он должен осознать, что его выпивка – это проблема. Он должен быть честным с собой и с другими. Некоторые личности в состоянии сами прекратить выпивку. Чаще люди нуждаются в помощи и поддержке семьи, друзей и других, кто понимает, как тяжело отказаться от этой привычки. Те, кто сами были горькими пьяницами, а потом бросили пить, лучше всех помогут другим сделать то же самое.

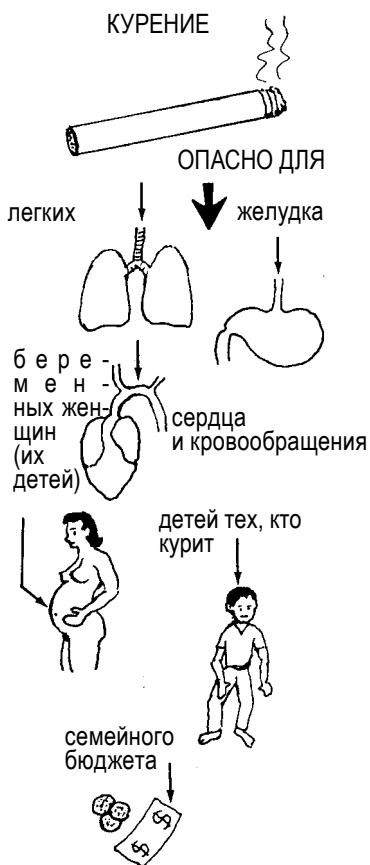
Пьянство – проблема не столько индивидуальная, сколько всего сообщества. Общество, которое сознает это, может многое сделать для поддержки тех, кто хочет измениться. Если вы озабочены злоупотреблением алкоголя в вашем сообществе, помогите организовать собрание для обсуждения этой проблемы и решите, что можно предпринять. Чтобы побольше узнать о вреде алкоголя и действиях общества, смотрите Пособие Для Работников Здравоохранения, Главы 5 и 27.

Многие проблемы можно решить, когда люди работают вместе, помогают и поддерживают друг друга.

КУРЕНИЕ

Существует много причин, почему курение опасно для вашего собственного здоровья и здоровья вашей семьи.

1. Курение повышает риск заболевания раком легких, рта, горла и губ. (Чем больше вы курите, тем больше шансов умереть от рака.)
2. Курение вызывает серьезные болезни легких, включая хронические бронхиты и эмфизему (и оно смертельно для тех, у кого есть эти болезни или астма).
3. Курение вызывает язву желудка или ухудшает ее.
4. Курение повышает шанс заболеть или умереть от болезни сердца или паралича.
5. Дети, чьи родители курят, чаще болеют пневмонией и другими респираторными заболеваниями, чем дети, чьи родители не курят.
6. Младенцы матерей, которые курили во время беременности, меньше и развиваются медленнее, чем дети, чьи матери не курили.



7. Родители, учителя, работники здравоохранения и другие, кто курит, подают нездоровый пример детям и молодым людям, повышая вероятность того, что они тоже закурят.
8. Курение также стоит денег. Кажется, что оно не обходится дорого, но добавляется к расходам. В остальных странах, многие бедняки тратят на табак денег больше, чем страна тратит на человека в рамках программы здоровья. **Если бы деньги, потраченные на табак, были бы истрачены на еду, то дети и целые семьи были бы здоровее.**

Каждый, кто заинтересован в здоровье других, не должен курить и должен призывать других не делать этого.

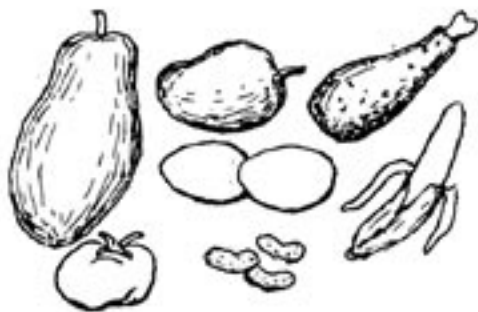
ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ (безалкогольные, содовые, кока-кола, шипучки)

В некоторых местах эти напитки стали очень популярными. Часто бедные матери покупают газированные напитки ребенку, который плохо ест, когда лучше было бы потратить эти деньги на покупку двух яиц или другой питательной пищи.

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТАМ
И У ВАС ЕСТЬ НЕМНОГО ДЕНЕГ, ЧТОБЫ КУПИТЬ ИМ ЧТО-ТО ...

купите им пару яиц или другие питательные продукты,

а не газированные напитки!



ДА



НЕТ

Газированные напитки не имеют питательной ценности без сахара. А для того количества сахара, которое они содержат, они очень дорогие. У детей, которым много дают газированных напитков и других сладостей, часто появляются дырки в зубах и гнилые зубы уже в раннем возрасте. Газированные напитки особенно вредно пить людям, у которых кислотная недостаточность или язва желудка.

Натуральные напитки, приготовленные из фруктов, полезнее и часто намного дешевле, чем газированные напитки.

Не разрешайте вашим детям пить газированные напитки.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ

Большинство детей, которые умирают от поноса, умирают потому, что в их организме остается недостаточно воды. Недостаток воды в организме называется обезвоживанием.

При обезвоживании организм теряет воды больше, чем употребляет. Это случается при сильном поносе, особенно с рвотой. Это может случиться и при очень серьезных болезнях, когда человек настолько болен, что не в состоянии принимать много пищи или жидкости.

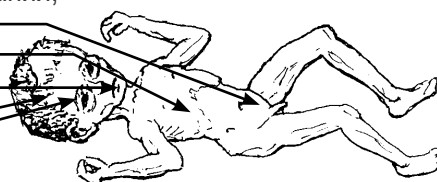
Люди любого возраста могут стать обезвоженными, но обезвоживание развивается наиболее быстро и наиболее опасно у маленьких детей.

Для любого ребенка с сильным поносом существует опасность обезвоживания.

Важно, чтобы каждый – особенно матери – знал признаки обезвоживания и как предупредить и лечить его.

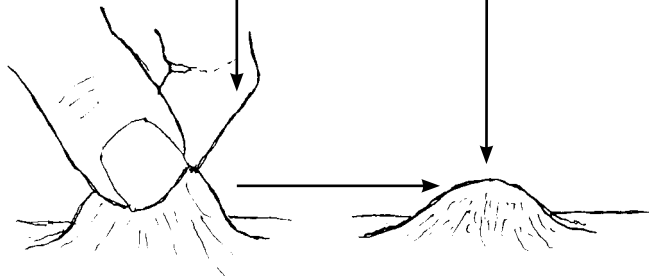
Признаки обезвоживания:

- жажда – часто первый признак обезвоживания;
- мало или нет мочи; моча темно-желтая;
- внезапная потеря веса;
- сухой рот;
- оседание мягкого места у младенцев;
- провалившиеся, без слез глаза;
- потеря эластичности или натяжки кожи.



Оттяните кожу пальцами вот так...

Если складка кожи не падает до нормального уровня, то ребенок обезвожен.



Очень тяжелое обезвоживание вызывает частый, слабый пульс (см. Шок, с. 77), быстрое, глубокое дыхание, жар или припадки (конвульсии, с. 178).

Когда у больного водный понос или понос с рвотой, не ждите признаков обезвоживания. **Действуйте быстро** – смотри следующую страницу.

Предупреждение или лечение обезвоживания: Когда у больного водный понос, действуйте быстро:

- ◆ **Давайте много пить жидкости:** регидроновый напиток самый лучший. Или дайте жидкую кашу из злаков или размазную, чай, суп и даже простую воду.
- ◆ **Продолжайте давать пищу.** Как только больной ребенок (или взрослый) начнет принимать еду, кормите его почаще тем, что он любит и принимает.
- ◆ **Младенцев чаще кормите грудью.**

Специальный напиток **Регидрон** помогает предупредить и лечить обезвоживание, особенно в случаях с тяжелым водным поносом.

2 СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ “ДОМАШНЕЙ СМЕСИ” – НАПИТКА РЕГИДРОН	
1. С САХАРОМ И СОЛЬЮ (Сырой сахар или патока могут быть использованы) В 1 литр ВОДЫ положите половину чайной ложки СОЛИ 8 чайных ложек САХАРА  Осторожно: Перед тем как добавить сахар, попробуйте напиток и убедитесь, что в нем меньше соли, чем в слезах. В напиток добавьте полчашки фруктового сока, воды кокоса или натертый спелый банан, если это доступно. Это обеспечит организм калием, который поможет ребенку принять больше еды и напитков. Важно: Приспособьте напиток к вашим условиям. Если литровых емкостей или чайных ложек нет, применяйте местные меры. Если люди обычно дают злаковую размазную маленьким детям, добавьте еще воды, чтобы сделать ее жидкой и употребляйте. Ищите легкий и простой способ.	2. С растертыми злаками и солью. Лучше толченый рис. Или используйте хорошо тертый маис, пшеничную муку, сорго, вареное картофельное пюре.) В 1 литр ВОДЫ положите половину чайной ложки СОЛИ 8 полных чайных ложек (или 2 горсти) толченых ЗЛАКОВ  Прокипятить 5 или 7 минут, чтобы образовалась жидкая разваренная или водная каша. Остудите быстро напиток и начинайте давать ребенку. Осторожно: Пробуйте напиток каждый раз перед тем, как дать его ребенку, чтобы убедиться, что он не испорчен. Напиток из злаков может испортиться через несколько часов в жаркую погоду.

Давайте обезвоженному больному этот напиток глотками каждые 5 минут, днем и ночью, пока он не начнет мочиться нормально. Взрослому необходимо 3 или больше литров в день. Малышу обычно нужно, по крайней мере, 1 литр в день или 1 стакан на каждое жидкое испражнение. Продолжайте **часто** давать напиток глоточками, **даже если больного рвет**. Не весь напиток выйдет с рвотой.

ВНИМАНИЕ: Если обезвоживание усиливается или появились другие опасные признаки, то обращайтесь за медицинской помощью (см. с. 159). Может быть, необходимо ввести жидкость в вену (внутривенный раствор).

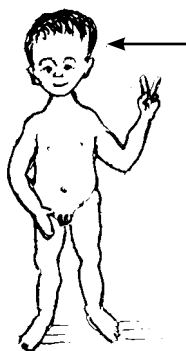
Примечание: В некоторых странах продаются пакеты с порошком регидрон для смешивания с водой. Он содержит простой сахар, соль, соду и калий (см. с. 382). Однако домашние напитки – особенно из злаков – при правильном приготовлении часто дешевле, безопаснее и эффективнее порошков регидрона.

ПОНОС И ДИЗЕНТЕРИЯ

Когда у больного рыхлый или жидкий стул, то у него начался понос. Если в стуле заметна слизь и кровь, то у него дизентерия.

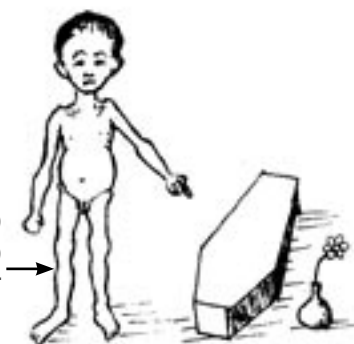
Понос может быть умеренным или тяжелым. Он может быть острым (внезапный и сильный) или хроническим (длится много дней).

Понос более распространен и более опасен у маленьких детей, особенно у тех, кто плохо питается.



Этот ребенок упитанный. Вряд ли у него возникнет понос. Если он появится, то этот ребенок поправится быстрее.

Этот ребенок истощен. У него скорее будет понос – и у него больше шансов умереть от него.



Причин поноса много. Обычно лекарства не требуются и ребенок поправляется через несколько дней, если вы дадите ему побольше Напитка Регидрона и еды. (Если он мало ест, дайте ему кушать понемногу, но часто.) Иногда требуется специальное лечение. Однако в большинстве случаев понос можно успешно лечить дома, даже если вы не уверены в конкретной причине или причинах.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОНОСА

плохое питание (с. 154). Оно ослабляет ребенка и усугубляет понос, вызванный другими причинами;
нехватка воды и грязные условия (без уборной) способствуют распространению микробов, которые вызывают понос;
вирусная инфекция или “кишечный грипп”;
инфекция в кишечнике, вызванная бактериями (с. 131), амёбой (с. 144) или лямблией (с. 145);
глистная инфекция (с. 140-144) (большинство глистных инфекций не вызывают понос);
инфекция вне кишечника (ушные инфекции, с. 309; тонзиллит, с. 309; корь, с. 311; инфекция мочи, с. 234);
малярия (серповидный тип – в частях Африки, Азии и Тихого океана, с. 186);
пищевое отравление (испорченная еда, с. 135);

СПИД (долго текущий понос может быть первым признаком, с. 399);
неспособность переварить молоко (в основном у серьезно истощенных детей и у некоторых взрослых);
трудность в переваривании новой пищи у младенцев (с. 154);
аллергия на определенным видам пищи (морские продукты, раки и т.д., с. 166); у младенцев иногда аллергия на коровье или другие виды молока;
побочные эффекты, производимые определенными лекарствами, такими как ампициллин или тетрациклин (с. 58);
слабительные, очистительные, раздражающие или ядовитые растения, некоторые яды;
употребление большого количества незрелых фруктов или тяжелой жирной пищи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОНОСА:

Хотя у поноса много различных причин, но наиболее распространенные – инфекция и плохое питание. При соблюдении правил гигиены и хорошем питании большинство случаев поноса можно было бы предупредить. А если бы его лечили правильно, давая много питья и еды, то от поноса умерли бы немногие дети.

Дети, у которых появляется понос от плохого питания, умирают от него чаще, чем те дети, которые хорошо питались. Понос сам по себе может быть частью причины недоедания. Но если истощение уже есть, то понос усиливает его.

**Истощение вызывает понос.
Понос вызывает истощение.**

Это результат порочного круга, в котором одно ухудшает другое. По этой причине хорошее питание важно и для предупреждения и для лечения поноса.



**Предупреждайте понос предупреждением истощения.
Предупреждайте истощение предупреждением поноса.**

Чтобы узнать, какая пища помогает организму сопротивляться или бороться с различными болезнями, включая понос, читайте Главу 11.

Предупреждение поноса зависит как от **хорошего питания**, так и от **гигиены**. Предложения по соблюдению личной и общественной санитарии даются в Главе 12. Они включают пользование **уборными**, наличие **чистой воды** и **защиту пищи** от грязи и мух.

Вот еще несколько важных советов по предупреждению поноса у детей:

- ◆ **Грудное вскармливание лучше искусственного.** Первые 4-6 месяцев давайте только грудное молоко. Оно помогает сопротивляться инфекциям, вызывающим понос. Если не можете кормить ребенка грудью, кормите его ложкой из чашки. **Не пользуйтесь бутылкой**, потому что ее труднее содержать чистой и можно скорее получить инфекцию.



- ◆ Когда начинаете давать младенцу новую или твердую пищу, давайте понемногу, хорошо разминая ее и смешивая с небольшим количеством грудного молока. Ребенок должен научиться переваривать новую пищу. **Если начать с большого количества за один раз, то у ребенка может начаться понос. Не прекращайте кормить грудью внезапно.**



- ◆ Начинайте давать дополнительную еду, пока ребенок еще сосет грудь.
- ◆ Держите ребенка в чистоте. Старайтесь, чтобы грязные предметы не попадали ему в рот.
- ◆ Не давайте детям ненужных лекарств.

Лечение поноса:

В основных случаях поноса никакого лекарства не требуется. Если понос сильный, самая большая опасность – **обезвоживание**. Если понос длится долго, самая большая опасность – **истощение**. Поэтому самая важная часть лечения заключается в том, чтобы давать **достаточно жидкости** и **достаточно еды**. Независимо, что вызвало понос, но всегда делайте следующее:

1. **ПРЕДУПРЕДИТЕ ИЛИ ОСТАНОВИТЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ.** Больной с поносом должен пить больше жидкости. Если понос сильный или есть признаки обезвоживания, дайте ему регидроновый напиток (с. 152). Даже если он не хочет пить, уговорите его. Заставьте его делать несколько глотков каждые несколько минут.
2. **УДОВЛЕТВОРИТЕ ПОТРЕБНОСТЬ В ПИЩЕ.** Больной с поносом должен **поесть, как только захочет**. Это особенно важно для маленьких детей или для больных с истощением. И еще у больного с поносом пища проходит через кишечник очень быстро и поэтому не переваривается. **Давайте больному еду много раз в день**, особенно, если он съедает за один раз очень мало.
 - ♦ Младенец должен питаться **только грудным молоком**.
 - ♦ Недоношенный ребенок должен получать калорийную еду и продукты для построения тела (протеины) на протяжении всего периода поноса – и еще добавочно, когда он поправится. Если он перестает кушать, потому что чувствует себя очень больным или его рвет, то он должен начать есть, как только сможет. **Давая регидроновый напиток, вы поможете ребенку начать принимать пищу.** Хотя еда поначалу может вызвать более частый стул чаще, она спасет его жизнь.
 - ♦ Если у недоношенного ребенка понос, который длится много дней или повторяется, то давайте ему больше и чаще еды – 5 или 6 раз в день. Часто никакое другое лечение не требуется.

ПИЩА ДЛЯ БОЛЬНОГО ПОНОСОМ		
Когда больного рвет или он чувствует себя очень плохо, чтобы есть, он должен пить: жидкую кашу или отвар из риса, маисового порошка или картофеля рисовую воду (немного разваренного риса) супы из цыплят, яиц, мяса или бобов Отвар ромашки или похожие на него отвары из противопоносных лекарственных сборов НАПИТОК РЕГИДРОНА Грудное молоко	Как только больной сможет есть, так в дополнение к напиткам, перечисленным слева, он должен питаться сбалансированными наборами следующих продуктов или им подобными: энергетическая пища созревшие или приготовленные бананы, печенье, рис, овес или другие хорошо приготовленные злаки, свежий маис (хорошо сваренный и размятый), картофель, яблочный соус (приготовленный) папайя. (Это поможет, если добавить немного сахара или овощного масла в злаковую пищу.)	пища для построения тела цыплята (вареные или жареные), яйца (вареные), мясо (хорошо, приготовленное без жира или сала), бобы, чечевица или горох (хорошо приготовленные и размятые), рыба (хорошо приготовленная), молоко (иногда вызывает проблемы, см. следующую страницу).
жирную или пищу с салом, большинство сырых фруктов,	НЕ СЛЕДУЕТ ЕСТЬ ИЛИ ПИТЬ любой вид слабительного или очистительного,	слишком острую пищу, алкогольные напитки.

Понос и молоко:

Грудное молоко самое лучшее для детей. Оно помогает предупредить понос и бороться с ним. Продолжайте кормить грудным молоком, когда у ребенка понос.

Коровье молоко, сухое молоко или консервированное могут быть хорошим источником энергии и протеина. Давайте их ребенку с поносом. Только у немногих детей они могут усилить понос. Если это случается, старайтесь давать ему поменьше молока и смешивайте молоко с другими продуктами. Но помните: истощенный ребенок с поносом должен получать в достатке калорийную пищу и протеин. Если даете меньше молока, то следует добавлять хорошо приготовленную и размятую пищу из таких продуктов, как цыпленок, мясо, желток, рыба или бобы. Бобы легче перевариваются, если снять кожицу, сварить и размять.

Как только ребенку станет лучше, он сможет пить больше молока, не опасаясь поноса.

Лекарства от поноса:

В большинстве случаев от поноса не нужны никакие лекарства. Но в некоторых ситуациях очень важно употреблять нужные лекарства. Однако многие из лекарств, обычно используемых от поноса, малоэффективны или вообще не действуют. Некоторые даже вредны.

ОБЫЧНО ЛУЧШЕ НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЛЕКАРСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОНОСА:

Противопоносные лекарства с каолином и пектином (такие как Каопектат, с. 384) делают понос гуще и менее частым. Но они не помогают при обезвоживании и не контролируют инфекцию. Некоторые лекарства, такие как лоперамид (Имодиум) или дифеноксилат (Ломотил), могут навредить или затянуть время болезни.



Противопоносные лекарства действуют как пробки. Они задерживают инфекции, которые должны выходить.



Не следует пользоваться **противопоносными микстурами, содержащими неомицин или стрептомицин**. Они раздражают кишечник и часто приносят больше вреда, чем пользы.

Антибиотики типа ампициллина или тетрациклина используются только в некоторых случаях поноса (см. с. 158). Но они часто сами вызывают понос, особенно у маленьких детей. Если после приема этих антибиотиков в течение более 2 или 3 дней понос усиливается, а не прекращается, перестаньте принимать их – антибиотики могут быть причиной поноса.

Левомецетин имеет определенную опасность при употреблении (см. с. 357) и его никогда не следует использовать при легком поносе или давать детям, которым меньше 1 месяца.

Слабительные и очистительные средства никогда не давайте больным поносом. Они усилят понос и повысят опасность обезвоживания.

Специальное лечение при разных случаях поноса:

Хотя большинство случаев поноса лучше всего принимать побольше **жидкости и еды, а не лечить лекарствами**, но иногда требуется специальное лечение.

При выборе лечения помните, что некоторые случаи поноса, особенно у маленьких детей, вызываются **инфекцией вне кишечника**. Всегда проверяйте **инфекцию в ушах, горле или в мочевой системе**. Если обнаружите, то лечите эту инфекцию. И еще поищите признаки кори.

Если у ребенка легкий понос с признаками простуды, то возможно причиной поноса является вирус или “кишечный грипп” и не нужно специального лечения. Давайте больше жидкостей и всю пищу, которую ребенок принимает.

В некоторых случаях поноса нужно сделать анализ кала и другие анализы, чтобы узнать, как правильно лечить. Но обычно вы достаточно можете узнать, задавая специальные вопросы, посмотрев стул и поискав определенные признаки. Вот несколько указаний для лечения согласно признакам.

1. Внезапный легкий понос. Без жара. (Расстройство желудка? Кишечный грипп?)

- ♦ Пейте больше жидкости. Обычно не надо никакого специального лечения. Лучше не употреблять “пробки от поноса”, такие как каолин с пектином (*Каопектат*, с. 384) или дифеноксилат (*Ломотил*). В них нет необходимости и они не помогают остановить обезвоживание и избавиться от инфекции – поэтому зачем тратить деньги на их покупку? Никогда не давайте их тяжело больным людям или маленьким детям.

2. Понос с рвотой. (Много причин)

- ♦ Если у больного поносом еще и рвота, то увеличивается опасность обезвоживания, особенно у маленьких детей. Очень важно давать регидроновый напиток (с. 152), чай, суп и другие жидкости. **Продолжайте давать ему напиток, даже если его вырвет снова.** Некоторое количество жидкости останется внутри. Давайте глотками каждые 5-10 минут. Если рвота не сразу останавливается, можно употребить прометазин (с. 386) или фенobarбитал (с. 389).



- ♦ Если вы не можете остановить рвоту или если обезвоживание усиливается, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

3. Понос со слизью и кровью. Часто хронический. Без жара. Может быть понос несколько дней, а потом запор. (Может быть амебная дизентерия. Чтобы уточнить, см. с. 144).

- ♦ Употребите метронидазол (с. 369) или дилоксанид фуруат (с. 369). Принимайте лекарство согласно рекомендованной дозе. Если понос продолжается после лечения, обратитесь за медицинским советом.

4. **Острый понос с жаром, с кровью.** (Бактериальная дизентерия- вызванная Шигеллой ?)

- ◆ Дайте ко-тримоксазол (см. с. 358) или ампициллин (см. с. 353). В настоящее время Шигелла часто устойчива к ампициллину , и иногда к ко-тримоксазолу . Если одно из лекарств не дает улучшения в течение двух дней , дайте другое или обратитесь за медицинской помощью.
- ◆ Если имеется сильный понос с лихорадкой , обычно без крови : лихорадка частично может быть вызвана дегидратацией . Дайте Регидрон (см. с. 152).
- ◆ В местах, где распространена тропическая малярия, советуем лечить больных с поносом и лихорадкой еще и лекарствами от малярии (см. с. 365-368), особенно, если у них увеличена селезенка.

5. **Желтый, с отвратительным запахом понос с пузырями или пеной, без крови или слизи.** Часто в животе скапливаются газы и отрыжка с запахом серы. (Лямблия? см. с. 145.)

- ◆ Причиной могут быть микроскопические паразиты, называемые лямблиями, или истощение. В таком случае обильное питье, питательная еда и отдых – часто единственное лечение. Тяжелую инфекцию от лямблии можно лечить метронидазолом (с. 369). Хинакрин (Атабрин) дешевле, но он дает плохие побочные эффекты (с. 370).

6. **Хронический понос** (длительный понос или повторяющийся).

- ◆ Это отчасти может быть от истощения или от хронической инфекции, вызываемой амебами или лямблиями. Следите за тем, чтобы ребенок ел больше питательной пищи, как можно чаще в течение дня (с. 110). Если понос все-таки продолжается, обратитесь за медицинской помощью.

7. **Понос как рисовый отвар.** (Холера?)

- ◆ Стул, похожий на рисовый отвар в больших количествах, может быть признаком холеры. В странах, где бывает эта опасная болезнь, холера часто переходит в эпидемию (сразу поражает многих людей) и обычно протекает в более тяжелой форме у юношей, девушек и взрослых. Очень быстро развивается сильное обезвоживание, особенно если болезнь сопровождается рвотой. Непрерывно лечите обезвоживание (см. с. 152) и давайте тетрациклин (см. с. 356), ко-тримоксазол (см. с. 358) или хлорамфеникол (см. с. 357). О случаях холеры вы должны сообщить в соответствующие органы. Обращайтесь за медицинской помощью.

“Холерную кровать” наподобие этой можно сделать для больного с очень сильным поносом. Наблюдайте за тем, сколько теряет больной, и убедитесь в том, что он выпивает большое количество напитка Регидрона. Давайте ему напиток почти непрерывно и пусть он пьет столько, сколько может.



Уход за Младенцами с Поносом

Понос особенно опасен для младенцев и маленьких детей. Лекарства обычно не нужны, но требуется особый уход, потому что ребенок может быстро умереть от обезвоживания.

ДАВАЙТЕ ЕМУ ГРУДНОЕ МОЛОКО

- ◆ **Продолжайте кормить грудью** и давать глотками напиток **Регидрона**.

◆

Если у больного рвота, давайте грудное молоко почаще, но только понемногу каждый раз. Еще давайте регидроновый напиток маленькими глотками каждые 5 или 10 минут (см. Рвота, с. 161).

◆

Если нет грудного молока, старайтесь давать почаще маленькими глотками любое другое молоко или заменитель молока (молоко типа соевого), **смешанные наполовину с кипяченой водой**. Если молоко усиливает понос, давайте какой-нибудь другой протеин (растертого цыпленка, яйца, нежирное мясо или протертые бобы без кожицы, смешанные с сахаром или хорошо разваренным рисом или другими углеводами и кипяченой водой).



И ЕЩЕ НАПИТОК РЕГИДРОНА

- ◆ Если ребенку меньше 1 месяца, старайтесь найти работника здравоохранения перед тем, как дать лекарства. Если нет работника, а ребенок очень болен, давайте ему "детский сироп", который содержит ампициллин: по половине чайной ложки 4 раза в день (см. с. 353). Лучше не употреблять другие антибиотики.



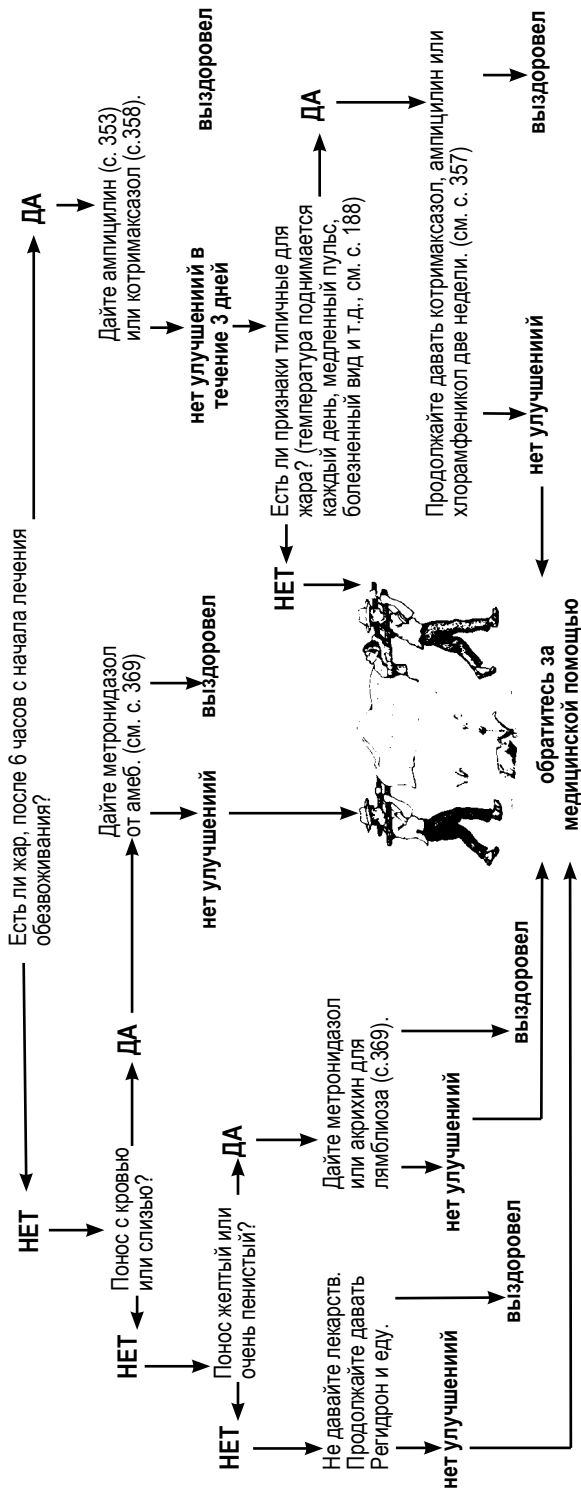
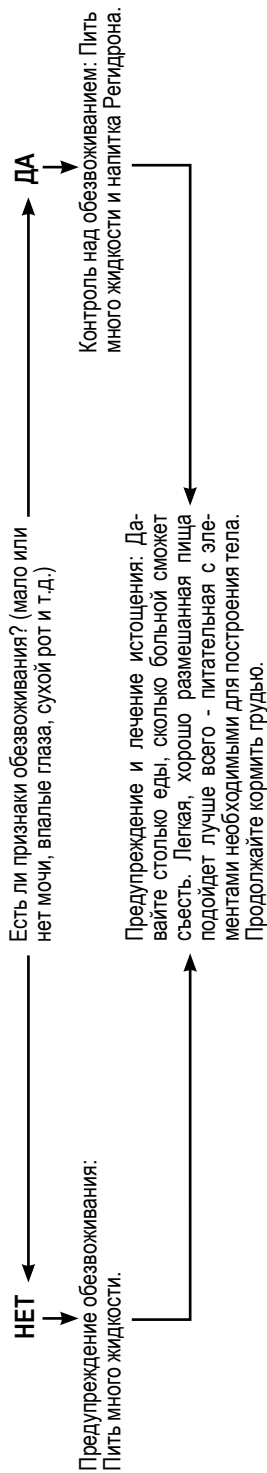
Когда Нужна Медицинская Помощь при Поносе?

Понос и дизентерия могут быть особенно опасными для маленьких детей. **В следующих ситуациях вы должны получить медицинскую помощь:**

- если понос длится более 4 дней и состояние больного не улучшается – или больше, чем 1 день, у маленького ребенка с сильным поносом;
- если у больного наблюдаются признаки обезвоживания и ему становится хуже;
- если ребенка рвет от всего, что он пьет, или он ничего не пьет, или частая рвота продолжается более 3 часов после приема регидронового напитка;
- если у ребенка начинаются припадки или если лицо и ноги отекают;
- если человек был очень болен, слаб или истощен до того, как начался понос (особенно маленькие дети и старики);
- если в стуле много крови. Это может быть опасно, даже если понос легкий (см. Засорение кишечника, с. 94).

КАК ЗАБОТИТЬСЯ О БОЛЬНОМ С ОСТРЫМ ПОНОСОМ

ПОНОС



РВОТА

Многие люди, особенно дети, страдают “расстройством желудка”, которое сопровождается рвотой. Причин этому часто не находят. Это может быть легкая боль в желудке или кишечнике или жар.

Рвота – один из признаков множества болезней, как легких, так и очень серьезных, поэтому крайне важно тщательно обследовать больного. Рвота часто связана с такими болезнями желудка или кишечника: инфекция (см. понос, с. 153), отравление испорченной пищей (с. 135) или “острый живот” (например, аппендицит или закупорка кишечника, с. 94). Кроме этого, почти любая болезнь с высокой температурой или острой болью может вызвать рвоту, особенно малярия (с. 186), гепатит (с. 172), тонзиллит (с. 309), ушная боль (с. 309), менингит (с. 185), инфекция мочевой системы (с. 234), боль в желчном пузыре (с. 329) или головная боль при мигрени (с. 162).



Опасные признаки с рвотой – немедленно обращайтесь за медицинской помощью!

- обезвоживание, которое усиливается и которое нельзя остановить, (с. 152)
- тяжелая рвота, которая длится больше 24 часов
- интенсивная рвота, особенно, если рвотная масса темно-зеленая, коричневая и с запахом кала (признак закупорки, с. 94)
- постоянные боли в кишечнике, особенно, если больной не может оправиться или если вы не сможете услышать бульканья, когда приложите ухо к животу (см. острый живот: закупорка, аппендицит, с. 94)
- рвота с кровью (язва, с. 128; цирроз, с. 328)

Чтобы помочь остановить простую рвоту:



- ◆ Ничего не кушать при сильной рвоте.
- ◆ Пейте маленькими глотками колу и газированный напиток. Могут помочь и некоторые травяные чаи типа настоя ромашки.
- ◆ При обезвоживании почаще давайте пить маленькими глотками колу, чай или регидроновый напиток (с. 152).
- ◆ Если рвота не прекращается, используйте останавливающее рвоту лекарство типа прометазина (с. 386) или дифенгидрамина (с. 387).

Большинство из этих лекарств выпускается в виде пилюль, сиропов, инъекций и свечек (мягкие пилюли, которые вводят в анус). Таблетки или сироп также можно вводить в анус. Размельчите таблетку в небольшом количестве воды. Введите в задний проход клизмой или шприцем без иглы.

Когда глотаете лекарство, запейте небольшим количеством воды и ничего больше не глотайте в течение 5 минут. Никогда не давайте лекарства больше, чем рекомендуется. Не давайте вторую дозу, пока не прекратится обезвоживание и больной не станет мочиться. Если тяжелая рвота и понос представляют затруднения для приема лекарства через рот или через анус, сделайте инъекцию одного из препаратов, останавливающих рвоту. Лучше всего ввести прометазин. Будьте осторожны, чтобы не ввести слишком много.

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ И МИГРЕНИ

От **простой головной боли** может помочь отдых и аспирин. Часто помогает тряпочка, намоченная горячей водой, которую надо положить на заднюю поверхность шеи, или массаж (растирание) шеи и плеч. Помогают и некоторые домашние средства лечения.

Головная боль обычно бывает при любой болезни, которая вызывает температуру. Если боль сильная, проверьте признаки менингита (с. 185).

Головная боль, возникающая время от времени, может быть признаком хронической болезни или плохого питания. Важно хорошо питаться и спать. Если головная боль не проходит, обратитесь за медицинской помощью.

Мигрень – это сильная пульсирующая головная боль часто только на одной стороне головы. Приступы мигрени могут возникать часто или через месяцы, или через годы.

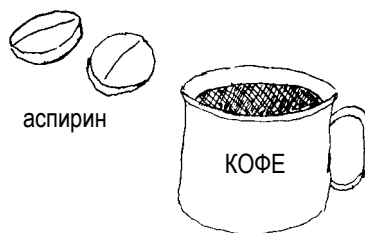
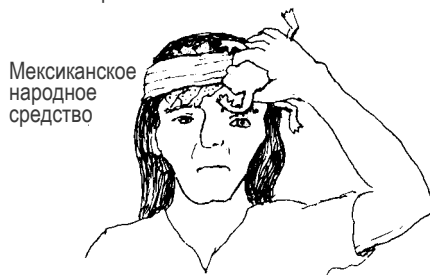
Типичному приступу мигрени могут предшествовать своеобразные зрительные ощущения (мелькание светящихся точек, зигзагов и др.) или онемения одной руки или ноги. Затем следует сильная головная боль, которая длится часами или днями. Часто бывает рвота. Мигрень – очень болезненна, но не опасна.

Чтобы остановить мигрень, **ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ** сделайте следующее:

- ◆ Примите две таблетки аспирина с чашкой крепкого кофе или черного чая.
- ◆ Лежите в темном тихом месте. Постарайтесь расслабиться. Постарайтесь не думать о своих проблемах.
- ◆ При очень сильной головной боли от мигрени, примите аспирин, если можно с кофеином или другим успокаивающим. Хорошо помогают и пилюли эрготамина с кофеином (*Кафергот*, с. 380). Примите две таблетки сначала и по 1 каждые 30 минут, пока не пройдет боль. Не принимайте больше 6 пилюль в день.

ВНИМАНИЕ: Не принимайте *кафергот* во время беременности!

От простой или нервной головной боли народные средства иногда помогают так же хорошо, как и лекарства.



ПРОСТУДЫ И ГРИПП

Простуды и грипп – распространенные вирусные инфекции, которые могут вызывать насморк, кашель, воспаление горла, а иногда температуру или боль в суставах. Может быть легкий понос, особенно у маленьких детей.

Простуды и грипп почти всегда проходят без лекарств. **Не употребляйте пенициллин или тетрациклин, или другие антибиотики**, поскольку они не помогут, а могут и навредить.



- ◆ Пейте побольше воды и хорошо отдыхайте.
- ◆ Аспирин (с. 379) или ацетаминофен (с. 380) помогают снизить температуру и облегчают боль в суставах и головную боль. Дорогие таблетки от простуды не лучше аспирина. Поэтому зачем тратить деньги?
- ◆ Не нужна специальная диета. Но очень полезны фруктовые соки, особенно такие как апельсиновый или лимонад.

Как лечить кашель и забитый нос от простуды см. на следующей странице.

ВНИМАНИЕ: Не давайте никаких антибиотиков или инъекций ребенку с простой простудой. Они не помогут, а навредят. Иногда признаки простуды вызываются вирусом полиомиелита, и когда вы делаете инъекцию, она может вызвать паралич от полиомиелита (с. 314).

Если простуда или грипп длятся больше недели или у больного температура, кашель и *мокрота* (слизь с гноем), острое поверхностное дыхание или боль в груди, скорее всего, у него развивается бронхит или пневмония (см. с. 170 и 171). Можно назначить антибиотики. Опасность перехода простуды в пневмонию велика у стариков, у тех, у кого проблемы с легкими, такие как хронический бронхит, и у людей, которые не могут много двигаться.

Воспаленное горло часто бывает частью простуды. Никакого особого лекарства не нужно, но может помочь полоскание теплой водой. Однако если воспаление горла начинается внезапно с высокой температурой, это может быть стрептококковое горло. Требуется особое лечение (с. 309).

Предупреждение простуды:

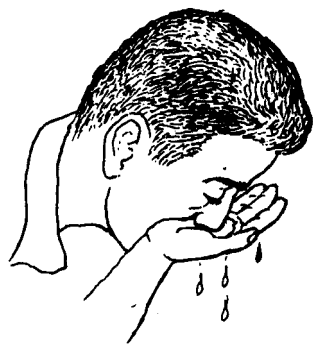
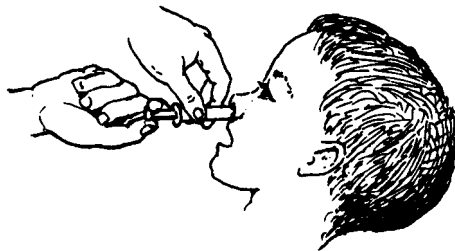
- ◆ Достаточно спать и питаться хорошей пищей, которая предупредит простуду. Очень хорошо помогают апельсины, томаты и другие фрукты, которые содержат витамин С.
- ◆ В противоположность популярному мнению, простуда не возникает от холода и сырости (хотя, когда вы замерзли, промокли или устали – это все ухудшит простуду). Простуду вы можете “подцепить” от других, у кого есть инфекция, когда он чихает, то есть через воздух.
- ◆ Чтобы не передавать простуду другим, больной должен питаться и пить отдельно – и особенно держаться подальше от маленьких детей. Он должен закрывать рот, когда кашляет или чихает.
- ◆ Чтобы предупредить простуду от перехода в ушную боль (с. 309), **старайтесь не сморкаться** – просто вытрите нос. Учите детей делать то же самое.

ЗАБИТЫЙ НОС И НАСМОРК

Забитый нос или насморк может быть результатом простуды или аллергии (см. следующую страницу). Обилие слизи в носу может привести к ушной инфекции у детей или проблеме синуса у взрослых.

Чтобы очистить забитый нос, делайте следующее:

1. У маленьких детей осторожно высосите слизь из носа отсосом или шприцем **без иголки**, как показано здесь.



2. Детям постарше и взрослым можно зачерпнуть немного соленой воды в руку и втягивать в нос. Это помогает освободиться от слизи.

3. Вдыхая горячий пар, как описано на с. 168, вы можете прочистить забитый нос.

Вытирайте нос при насморке, но **не пытайтесь высморкаться**. Высмаркивание

4. может привести к боли в ухе или инфекции синуса.

Люди с частыми ушными болями или инфекцией синусов после простуды

5. предупреждают эти проблемы использованием *деконгестантных* капель для носа, таких как нафтизин (с. 384). После втягивания соленой воды закапайте капли в нос вот так:

Голову набок, закапайте 2 и 3 капли в нижнюю ноздрю. Подождите пару минут и сделайте то же на другую сторону.

ОСТОРОЖНО:

Употребляйте деконгестантные капли не больше 3 раз в день, не больше 3 дней.



Деконгестантный сироп (с фенилефрином или чем-нибудь подобным) тоже может помочь.

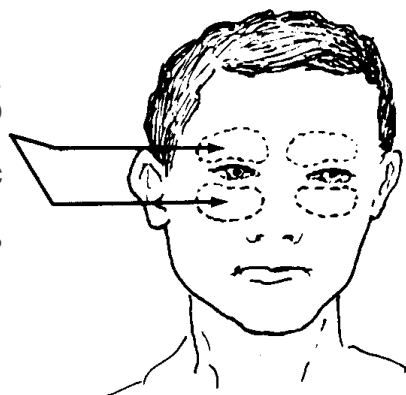
Предупреждайте ушные инфекции и инфекции синуса – старайтесь не сморкаться, просто вытирайте нос.

ЗАБОЛЕВАНИЕ СИНУСА (СИНУСИТ)

Синусит – острое или хроническое (затянувшееся) воспаление полостей синуса в кости, которые открывают нос. Это обычно случается с человеком, у которого инфекция в ушах, горле или после сильной простуды.

Признаки:

- Боль на лице выше или ниже глаз вот здесь. (Особенно больно, когда легко ударите по кости или когда наклоняетесь.)
- Густая слизь или гной в носу, может быть с плохим запахом. Нос часто забит.
- Иногда жар (температура). Могут болеть определенные зубы.



Лечение:

- ◆ Пить как можно больше воды.
- ◆ Втягивайте немного соленой воды в нос (см. с. 164) или вдыхайте пар от горячей воды, чтобы очистить нос (см. с. 168).
- ◆ Положите горячий компресс на лицо.
- ◆ Употребляйте деконгестантные капли, такие как нафтизин (Галазолин или Санорин с. 384).
- ◆ Употребляйте антибиотики, такие как тетрациклин (с. 356), ампициллин (с. 353) или пенициллин (с. 351).
- ◆ Если больному не стало лучше, обратитесь за медицинской помощью.

Профилактика:

Когда у вас простуда или забитый нос, старайтесь держать нос чистым. Следуйте инструкциям на с. 164.

СЕННАЯ ЛИХОРАДКА (АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ)

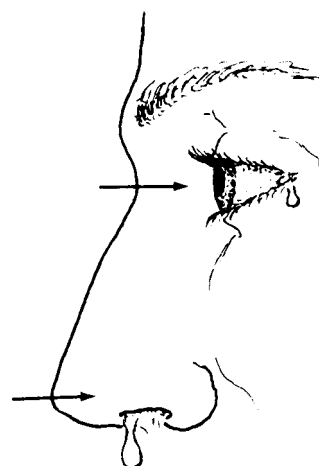
Насморк и зудящие глаза могут быть аллергической реакцией на что-нибудь в воздухе, что вдохнул человек (см. след. с.). Это обычно ухудшается в определенное время года.

Лечение:

Употребляйте антигистамин, такой как хлорфенирамин (с. 387). Дименгидрилат (Дедалон, с. 387), который обычно продается от морской болезни, тоже подходит.

Профилактика:

Определите, какие вещества вызывают эту реакцию (например: пыль, перья цыпленка, пыльца, плесень), и старайтесь избегать их.



АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Аллергия – это необычная чувствительность организма определенных людей к воздействию некоторых факторов окружающей среды при:

- вдыхании;
- еде;
- инъекциях;
- или соприкосновении с кожей.

Аллергические реакции, которые могут быть легкими или очень серьезными, включают:

- зудящую сыпь, волдыри или крапивницу (с. 203);
- насморк и зудящие и горячие глаза (сенная лихорадка, с. 165);
- раздражение в горле, трудное дыхание или астма (см. след. с.);
- аллергический шок (с. 70);
- понос (у детей аллергия на молоко – редкая причина поноса, с. 153).

Аллергия не является инфекцией и не может переходить от одного человека к другому. Однако дети от аллергических родителей тоже склонны к аллергии.

Часто люди с аллергией страдают в определенное время года – или всякий раз, когда они соприкасаются с веществами, которые вызывают ее. Общие причины аллергических реакций это:

пыльца некоторых
цветов и трав;

куриные перья;

пыль;

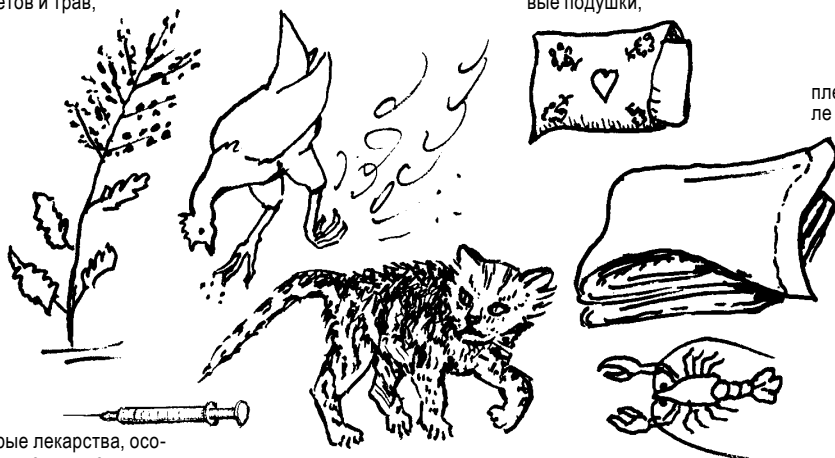
ватные и перьевые
подушки;

плесень на одежде
или белье;

некоторые лекарства, особенно: инъекции пеницилина или лошадиной сыворотки (см. с. 70);

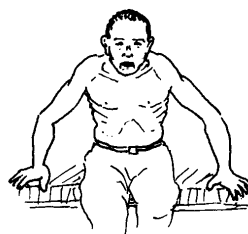
шерсть некоторых кошек
и других животных;

некоторые виды пищи: особенно, рыба, устрицы, пиво и т.д.



АСТМА

У больного астмой бывают припадки или приступы тяжелого дыхания. Прислушайтесь к хрипам или свисту, особенно при выдохе. Когда больной вдыхает, кожа между ключицами и ребрами может втягиваться. Если больному не хватает воздуха, у него синеют ногти и губы, а его шейные вены могут опухать. Обычно температуры не бывает.



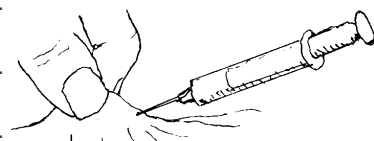
сидите прямо, чтобы дышать

Астма часто начинается в детстве и может остаться проблемой на всю жизнь. Она не заразная, но чаще бывает у детей, родственники которых страдают астмой. Она обычно обостряется в определенные месяцы года или ночью. Если человек болеет астмой много лет, она может перейти в эмфизему (с. 170).

Приступы астмы могут вызываться, когда больной съедает или вдыхает вещества, на которые у него аллергия (см. с. 166). У детей астма чаще всего начинается с обычной простуды. У некоторых людей нервные стрессы или расстройства также вызывают приступы астмы.

Лечение:

- ◆ Если астма обостряется в помещении, больного следует вывести на чистый воздух. Ведите себя спокойно и мягко с больным. Успокойте его.
- ◆ Дайте побольше жидкости. Это помогает выделению слизи и облегчает дыхание. Может помочь ингаляция горячим паром (см. с.168).
- ◆ При легких приступах дайте эфедрин, теофиллин, сальбутамол (с. 385).
- ◆ При сильных приступах можно давать эфедрин или сальбутамол с теофиллином.
- ◆ Если приступ астмы очень сильный, введите эпинефрин (*Адреналин*). Взрослым: 1/3 мл; детям от 7 до 12 лет: 1/5 мл. Вы можете повторять дозу 3 раза через каждые полчаса, пока это нужно. Меры предосторожности см. на с. 386.
- ◆ Если у больного температура или если приступ продолжается более 3 дней, дайте ему капсулы тетрациклина (с. 356) или эритромицина (с. 355).
- ◆ В редких случаях астму вызывают аскариды. Постарайтесь дать пиперазин (с. 375) ребенку, у которого начинается астма, если вы считаете, что ее вызвали аскариды.
- ◆ **Если состояние больного не улучшается, вызовите медицинскую помощь.**



Введите эпинефрин под кожу.

Профилактика:

Больной астмой должен избегать есть или вдыхать то, что вызывает у него приступ. Дом или место работы должны содержаться в чистоте. Не пускайте цыплят или других животных в дом. Проветривайте постельные принадлежности на солнце. Иногда помогает сон на открытом воздухе. Пейте не меньше 8 стаканов воды каждый день, чтобы отхаркивать слизь. Больные астмой могут улучшить свое состояние, если они переедут в другое место, где воздух чище.

Если у вас астма, не курите – курение еще больше вредит вашим легким.

КАШЕЛЬ

Кашель сам по себе не болезнь, а признак многих различных заболеваний, которые поражают горло, легкие или *бронхи* (сеть воздушных труб, ведущих в легкие). Ниже приведены проблемы, которые вызывают различные виды кашля:

СУХОЙ КАШЕЛЬ С НЕБОЛЬШОЙ МОКРОТОЙ ИЛИ БЕЗ НЕЕ: простуда или грипп (с. 163) глисты, когда проходят че- рез легкие (с. 140) корь (с. 311) кашель курильщика (куре- ние, с. 149)	КАШЕЛЬ С МОКРОТОЙ ИЛИ НЕБОЛЬШОЙ СЛИЗЬЮ: бронхит (с.170) пневмония (с. 171) астма (с. 167) кашель курильщика, осо- бенно, по утрам (с. 149)	КАШЕЛЬ С ХРИПОМ ИЛИ КОКЛЮШ И ОДЫШКА: астма (с. 167) коклюш (с. 313) дифтерия (с. 313) сердечные присту- пы (с. 325) что-то застряло в гор- ле (с. 79)
ХРОНИЧЕСКИЙ ИЛИ ПОСТОЯННЫЙ КАШЕЛЬ: туберкулез (с. 179) кашель курильщика или шахтера (с. 149) астма (повторные приступы, с. 167) хронический бронхит (с.170) эмфизема (с. 170)	КАШЕЛЬ С КРОВЬЮ: туберкулез (с. 179) пневмония (желтая, зеленая или слизь с прожилками крови, с. 171) сильная инфекция от глистов (с. 140) рак легких или горла (с.149)	

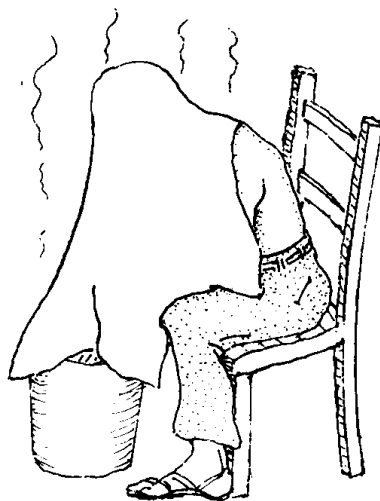
Кашель – это способ, которым организм очищает дыхательную систему и избавляется от мокроты (слизь с гноем) и микробов в легких и в горле. Поэтому, когда с кашлем отхаркивается мокрота, **не принимайте лекарства, чтобы остановить кашель, а лучше сделайте что-нибудь, чтобы помочь выделению мокроты.**

Лечение от кашля:

1. **Чтобы избавиться от мокроты** и облегчить любой вид кашля, пейте больше воды. Это действует лучше, чем любое лекарство.

Еще **можно дышать горячим паром**. Сядьте на стул и поставьте ведро горячей воды у ног. Накиньте простыню на голову и накройте ведро, чтобы удержать поднимающийся пар. Вдыхайте пар глубоко в течение 15 мин. Повторите несколько раз в день. Некоторые люди любят добавлять мяту или листья эвкалипта или *Vaporub*, но горячая вода действует хорошо и без них.

Осторожно: Не используйте эвкалипт или *Vaporub*, если у больного астма. Они обостряют ее.



2. От всех видов кашля, особенно сухого, можно давать следующие сиропы:

СМЕСЬ:



Принимайте чайную ложку каждые 2 - 3 часа. Для маленьких детей и для людей с одышкой не добавляйте алкоголь. Для детей до 1 года, если можно, положите сахар вместо меда.

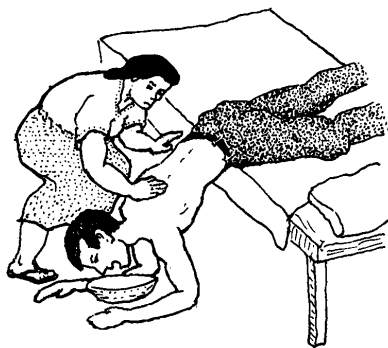
3. От сильного сухого кашля, который не дает спать, вы можете принять сироп с кодеином (с. 384). Таблетки аспирина с кодеином (или даже только аспирина) тоже помогают. Если много мокроты или хрипов, не употребляйте кодеин.
4. От кашля с хрипами (тяжелое, шумное дыхание) см. Астма (с. 167), Хронический Бронхит (с. 170) и Болезни Сердца (с. 325).
5. Попробуйте определить, какая болезнь вызывает кашель, и лечить ее. Если кашель долго не проходит, если в нем кровь, гной или пахнущая мокрота или, если больной теряет в массе или постоянно задыхается, покажите его врачу.
6. Если у вас любой вид кашля – не курите. Курение вредит легким.

**Чтобы предупредить кашель, не курите.
Чтобы вылечить кашель, лечите болезнь, которая вызывает его – и не курите.
Чтобы успокоить кашель и ослабить мокроту, пейте больше воды – и не курите.**

КАК ОТХАРКИВАТЬ СЛИЗЬ ИЗ ЛЕГКИХ (ПОЗА ДЛЯ ДРЕНАЖА):

Когда больной, у которого сильный кашель, старый или слабый и не может избавиться от липкой слизи или мокроты в груди, ему помогает, когда он пьет много воды. Сделайте следующее:

- ◆ Сначала пусть он подышит горячим водным паром, чтобы вызвать мокроту.
- ◆ Затем положите его на кровать так, чтобы голова и грудь свисали. Слегка постучите его по спине. Это поможет ему отхаркивать слизь.



БРОНХИТ

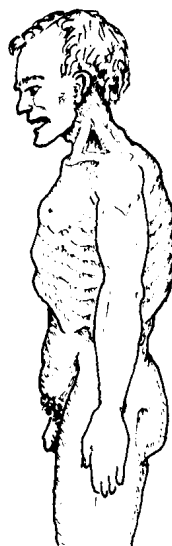
Бронхит – это инфекция бронхов или труб, которые подают воздух в легкие. Он вызывает шумный кашель, часто со слизью или мокротой. Бронхит обычно вызывается вирусом, поэтому антибиотики почти не помогают. Применяйте антибиотики только тогда, когда бронхит продолжается больше недели и не улучшается состояние больного, когда у больного признаки пневмонии (см. следующую страницу) или когда у него хроническая болезнь легких.

ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ

Признаки:

- Кашель со слизью, который тянется месяцами или годами. Иногда кашель усиливается и может появиться температура. Больной, у которого такой вид кашля, но нет другой хронической болезни, такой как туберкулез или астма, возможно имеет хронический бронхит.
- Он чаще появляется у стариков, которые были заядлыми курильщиками.
- Он может привести к эмфиземе, очень серьезной и неизлечимой болезни, при которой крошечные воздушные кармашки легких лопаются. Больной, у которого эмфизема, тяжело дышит, особенно после физических упражнений, и его грудь становится большой “как бочка”.

грудь “бочкой”



Эмфизема может быть результатом хронической астмы, хронического бронхита или курения.

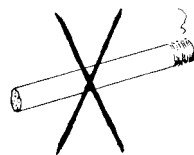
Лечение:

- ◆ Прекратить курение.
- ◆ Принимать лекарства от астмы с эфедринем и теофиллином (с. 385).
- ◆ Больные с хроническим бронхитом должны принимать ампициллин или тетрациклин каждый раз, когда у больного простуда или грипп с температурой.
- ◆ Если больной отхаркивает липкую слизь, пусть подышит горячим паром (с. 168), а затем помогите ему сделать дренаж легких (см. с. 169).



**Если у вас хронический кашель
(или вы хотите предупредить его),**

НЕ КУРИТЕ!

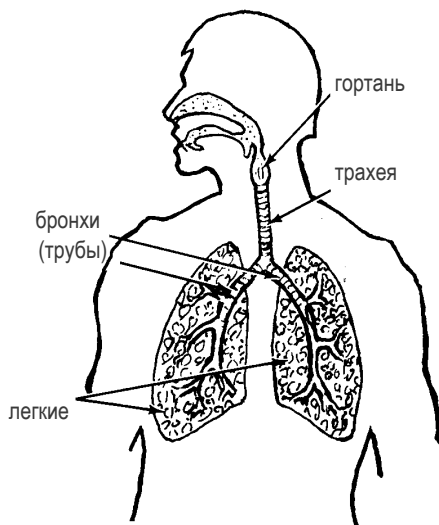


ПНЕВМОНИЯ

Пневмония – это острая инфекция легких. Она часто появляется после респираторных болезней, таких как корь, коклюш, грипп, бронхит, астма – или после очень серьезных болезней, особенно у детей или стариков. У больных СПИДом тоже может развиваться пневмония.

Признаки:

- Внезапный озноб, а затем высокая температура.
- Частое, неглубокое дыхание с небольшим “ворчанием”, иногда с хрипами. Ноздри могут расширяться с каждым вдохом.
- Жар (иногда у новорожденных, стариков или у слабых людей сильная пневмония протекает без температуры или с маленькой температурой).
- Кашель (часто с желтой, зеленоватой, ржавой или с небольшой примесью крови слизью).
- Боль в груди (иногда).
- Человек выглядит очень больным.
- Простудные болячки часто появляются на лице или на губах (с. 232).



У очень больного ребенка, у которого более 50 **мелких** вдохов в минуту, возможно появилась пневмония.

(Если дыхание частое и **глубокое**, проверьте на обезвоживание, с. 151, или гипервентиляцию, с. 24.)

Лечение:

- ◆ От пневмонии лечение антибиотиками может быть вопросом жизни и смерти. Давайте пенициллин (с. 351), ко-тримоксазол (с. 358) или эритромицин (с. 355). В серьезных случаях делайте инъекции прокаина пенициллина (с. 353) взрослым: по 400000 ед. (250 мг) 2 или 3 раза в день или давайте ампициллин в таблетках (с. 353) по 500 мг 4 раза в день. Давайте маленьким детям 1/4 или 1/2 взрослой дозы. На детей до 6 лет лучше действует ампициллин.
- ◆ Давайте аспирин (с. 379) или ацетаминофен (с. 380), чтобы снизить температуру и уменьшить боль.
- ◆ Давайте больше жидкости. Если больной не ест, давайте ему жидкую пищу или регидроновый напиток (с. 152).
- ◆ Облегчите кашель и ослабьте выделение слизи приемом большого количества воды и заставьте больного подышать горячим паром (см. с. 168). Может помочь дренаж легких (см. с. 169).
- ◆ Если больной хрипит, может помочь лекарство от астмы с теофиллином или эфедрином.

ГЕПАТИТ

Гепатит – вирусная инфекция, поражающая печень. Хотя в некоторых местах люди называют его “лихорадкой” (см. с. 26), но при гепатите часто температура поднимается немного или ее нет вообще. Болезнь обычно легко протекает у маленьких детей и более тяжело у стариков и у беременных женщин. Обычно человек болеет 2 недели и слаб еще 1-3 месяца. (Он может заражать других людей в течение 3 недель после исчезновения желтизны в глазах.)

Признаки:

- Нет желания кушать или курить. Проходят дни без принятия пищи.
- Иногда появляется боль в правом боку около печени.



- Может быть жар.
- Через несколько дней глаза желтеют.
- Вид или запах пищи вызывает рвоту.
- Моча приобретает красноватый цвет и стул становится беловатым.

Лечение:

- ♦ Антибиотики не действуют против гепатита. Действительно, некоторые лекарства наносят дополнительный вред пораженной печени. **Не употребляйте лекарства.**
- ♦ Больной должен отдыхать и пить много жидкости. Если он отказывается от пищи, давайте ему соки апельсина, папайи и других фруктов плюс бульон или овощной суп. Могут помочь витамины.
- ♦ Чтобы остановить рвоту, см. с. 161.
- ♦ Как только больной сможет кушать, давайте ему сбалансированную пищу. Хорошо дать овощи и фрукты с небольшим количеством протеина (с. 110 и 111). Но не давайте протеина (мясо, яйца, рыбу и т.д.) много, потому что это тяжелая еда для пораженной печени. Избегайте свиного сала и жирной пищи. **Не употребляйте алкоголь**, по крайней мере в течение 6 месяцев.

Профилактика:

- ♦ Вирус гепатита переносится из стула одного больного в рот другого человека через загрязненную воду и пищу. Чтобы помешать другим заболеть гепатитом, закопайте или сожгите испражнения больного и содержите его в чистоте. Человек, который ухаживает за больным, должен хорошо мыть руки после общения с больным.
- ♦ Маленькие дети часто болеют гепатитом без видимых признаков, но они заражать других. Очень важно, чтобы каждый в доме тщательно следовал всем правилам гигиены (см. с. 133-139).
- ♦ В течение 3 недель после исчезновения признаков гепатита продолжайте принимать все меры предосторожности, чтобы он не перешел к другим. Пользуйтесь отдельной посудой для еды, избегайте секса, даже с презервативом, и не трогайте руками пищу.

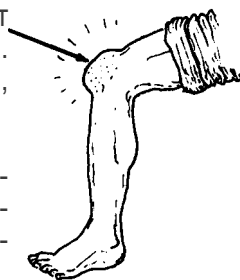
ВНИМАНИЕ: Гепатит еще может передаваться при инъекции нестерильными иглами. Кипятите иглы и шприцы перед каждым употреблением (см. с. 74).

АРТРИТ (БОЛЕЗНЕННЫЕ, ВОСПАЛЕННЫЕ СУСТАВЫ)

Хронические боли в суставах, или артрит, у пожилых людей полностью не вылечиваются. Однако следующие меры часто приносят облегчение:

- ◆ Отдых. Если возможно, избегайте тяжелой работы и сильных нагрузок, которые вызывают боль в суставах. Если артрит вызывает небольшую температуру, то поможет короткий сон в течение дня.
- ◆ Положите горячую влажную тряпочку на больные суставы (см. с. 195).
- ◆ Аспирин помогает успокоить боль; доза при артрите выше, чем при других болях. Взрослые должны принимать по 3 таблетки 4 или 6 раз в день. Если начинает звенеть в ушах, принимайте меньше. Чтобы избежать проблем с желудком, вызываемых аспирином, всегда принимайте его с едой или с большим стаканом воды. Если боль в желудке продолжается, принимайте аспирин не только с едой и водой, а еще со столовой ложкой антацидов, таких как Малокс или Гелусил.
- ◆ Важно выполнять простые физические упражнения, чтобы сохранить или увеличить подвижность в больных суставах.

Если только один сустав опух и горячий на ощупь, он может быть инфицированным – особенно, если есть температура. Используйте антибиотик, такой как пенициллин (см. с. 351), и, если возможно, покажитесь работнику здравоохранения.



Боль в суставах у молодых людей и детей может быть признаком других серьезных заболеваний, таких как суставной ревматизм (с. 310) или туберкулез (с. 179). Подробно о больных суставах см. Искалеченные Деревенские Дети, Главы 15 и 16.

БОЛЬ В СПИНЕ

Боль в спине имеет много причин. Вот некоторые из них.

Хроническая боль в верхней части спины с кашлем и потерей в массе может быть ТБ легких (с. 179).



Боль в середине спины у ребенка может быть ТБ позвоночника, особенно, если на позвоночнике горб или нарост.

Боль внизу спины, которая сильнее после поднятия тяжестей или напряжения, может быть растяжением.

Сильная боль внизу спины, которая возникает внезапно, когда поднимаете что-нибудь или поворачиваетесь, может быть связана с соскользнувшим диском,

особенно, если одна нога или ступня болезненная или онемевшая. Это может быть ущемление нерва.



Если постоянно сидеть или стоять с опущенными плечами, можно вызвать боль в спине.

У пожилых людей хроническая боль в спине часто бывает от артрита.

Боль в верхнем правом боку может быть заболеванием желчного пузыря (с. 329).

Острая (или хроническая) боль вот здесь может быть урологической проблемой (с. 234).

Боль в пояснице нормальна для некоторых женщин во время менструации или беременности (с. 248).

Боль в самом низу спины иногда появляется при заболеваниях матки, яичников или прямой кишки.



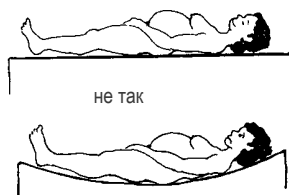
Лечение и предупреждение боли в спине:

- ◆ Если боль в спине вызвана такими болезнями, как ТБ, инфекция мочевых путей или заболевание желчного пузыря, лечите болезнь. Обратитесь за медицинской помощью, если вы подозреваете серьезную болезнь.
- ◆ Простую боль в спине, включая боль при беременности, часто можно предупредить так.

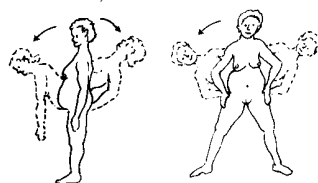
всегда стойте прямо



спите на твердой плоской поверхности как эта

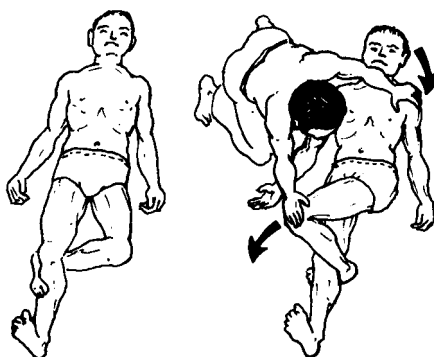


наклоны назад при (делаются очень медленно)



- ◆ Аспирин и горячие примочки (с. 195) помогают успокоить большинство болей в спине.
- ◆ От внезапной, сильной боли в нижней части спины, которая появляется у человека, когда он поворачивается, поднимает тяжести, наклоняется или напрягается, быстрое облегчение могут иногда принести такие меры:

Пусть больной ляжет, подсунув одну ногу под колено другой.

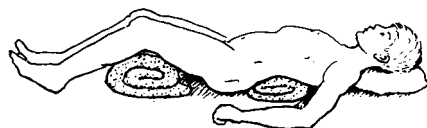


Затем, прижимая это плечо вниз, мягко, но сильно, надавите на колено, как бы переворачивая на спину.

Сделайте сначала это на одной стороне, а затем на другой.

ОСТОРОЖНО: Не делайте этого, если боль в спине от падения или травмы.

- ◆ Если боль в спине при подъеме тяжести или повороте внезапная и сильная, как будто режут ножом, когда вы наклоняетесь, если боль переходит в ноги или если ступня немеет и слабеет, то это серьезно. Нерв, который проходит в спине, может быть ущемлен соскользнувшим диском (прокладка между костями спины). Лучше отдохнуть несколько дней, лежа на спине. Поможет, если подложить что-нибудь твердое под колени и поясницу.



- ◆ Примите аспирин и сделайте горячие примочки. Если боль не пройдет через несколько дней, обратитесь за медицинским советом.

ВАРИКОЗНЫЕ ВЕНЫ

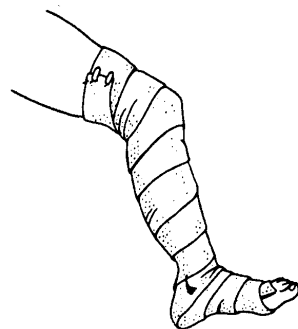
Варикозные вены – это опухшие, перекрученные и часто болезненные вены. Они часто заметны на ногах пожилых людей, беременных и многодетных женщин.

Лечение:

От варикозных вен нет лекарства. Но могут помочь следующие меры:

- ◆ Не проводите много времени, стоя на ногах или сидя с опущенными ногами. Если у вас нет выбора, кроме того, чтобы стоять или сидеть долгое время, постарайтесь через каждые полчаса прилечь на несколько минут, подняв ноги вверх (на уровень сердца). Когда стоите, старайтесь ходить на месте. Или почаще поднимайте пятки от земли и опускайте их. И спите, подняв ноги чуть выше (на подушки).
- ◆ Пользуйтесь эластичными чулками или эластичным бинтом, чтобы поддерживать вены. Но снимайте их на ночь.

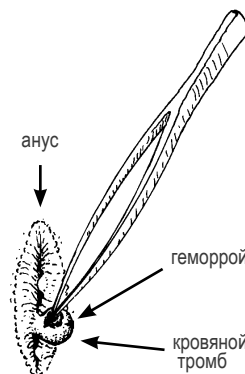
Ухаживая за венами подобным образом, вы предупредите хронические раны или варикозные язвы на лодыжках (с. 213).



ШИШКИ (ГЕМОРРОЙ)

Шишки или геморрой – это варикозные вены ануса или прямой кишки, которые ощущаются как маленькие бугорки или шарики. Они могут быть болезненными, но не опасными. Часто появляются во время беременности, а потом проходят.

- ◆ Горькие соки некоторых растений (дикого орешника, кактуса и т.д.), наложенные на геморроидальные шишки, помогают сжать их. Такое же действие и у свечек (с. 392).
- ◆ Принимая теплые ванны, вы можете исцелить геморрой.
- ◆ Шишки могут частично вызываться запором. Поможет, если вы будете есть много фруктов и волокнистой пищи, такой как кассава или отруби.
- ◆ Если шишки очень большие, может понадобиться операция. Обратитесь за медицинским советом.



Если геморрой начинает кровоточить, кровотечение иногда можно остановить, нажимая чистой тряпочкой прямо на шишки. Если кровотечение не останавливается, обратитесь к врачу. Или постарайтесь остановить кровотечение, смещая тромб внутри опухшей вены. Щипцы можно использовать после того, как они простерилизуются кипячением.

Осторожно: Не старайтесь вырезать геморроидальные шишки. Больной может умереть от кровотечения.

ОТЕКИ НОГ И ДРУГИХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА

Отеки ног могут быть вызваны множеством различных проблем, иногда маленьких, иногда серьезных. Но если опухает также лицо или другая часть тела, то это обычно признак серьезной болезни.

У женщин иногда отекают ноги в течение последних трех месяцев беременности. Это обычно несерьезно. Причина в массе ребенка, который давит на вены, проходящие в ногах, ограничивая таким образом поток крови. Но, если руки женщины или лицо тоже опухли, она чувствует головокружение, возникают проблемы со зрением или выделяется мало мочи, она может страдать от отравления или токсикоза беременных (см. с. 249). Скорее обратитесь за медицинской помощью.

У стариков, которые проводят много времени, сидя или стоя на одном месте, часто опухают ноги из-за плохого кровообращения. Однако у пожилых людей отеки ног могут вызываться болезнями сердца (с. 325) или, менее обычно, болезнями почек (с. 234).

Опухшие ноги у детей могут быть результатом анемии (с. 124) или недоедания (с. 107). В тяжелых случаях руки и лицо могут тоже быть опухшими (см. Квашиоркор, с. 113).

Лечение:

Чтобы уменьшить отеки, лечите болезнь, которая вызвала их. Употребляйте мало соли или не солите пищу. Обычно помогают мочегонные травяные чаи (см. рыльца кукурузы, с. 12). И еще делайте следующее:

КОГДА У ВАС ОТЕКАЮТ НОГИ:

Не сидите с опущенными ногами. От этого они опухают больше.

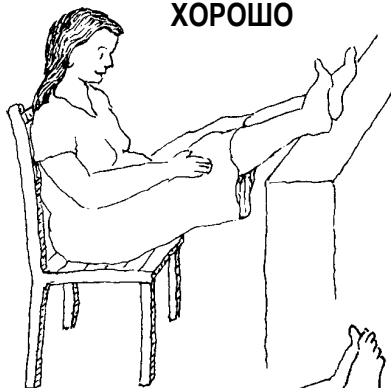
НЕТ



Когда вы сидите, поднимите ноги повыше. Так они отекают меньше. Делайте это несколько раз в день. Ваши ноги должны быть на уровне сердца.

И еще следует спать с приподнятыми ногами.

ХОРОШО



ЛУЧШЕ



ГРЫЖА

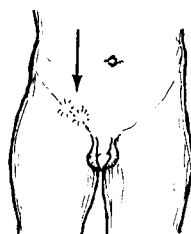
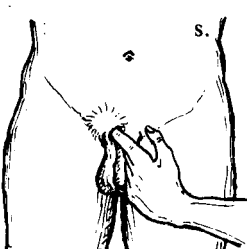
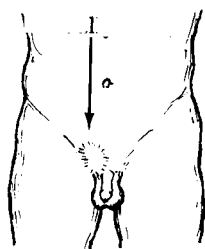
Грыжа – это отверстие или разрыв в мышцах, покрывающих брюшину. Это позволяет петле кишки пройти и образовать шишку под кожей. Грыжи обычно появляются от поднятия тяжестей, или от напряжения (как при родах). Некоторые дети рождаются с грыжей (см. с. 317). У мужчин грыжи обычно бывают в паху. Опухшие лимфатические узлы (с. 88) также могут быть причиной грыжи в паху.

Однако...

Грыжа обычно здесь,

и вы можете ее прощупать пальцем.

Лимфатические узлы
обычно здесь



Она увеличивается при кашле (либо при поднятии тяжестей).

и не увеличивается при кашле.

Как предупредить грыжу

Поднимайте
тяжести так,



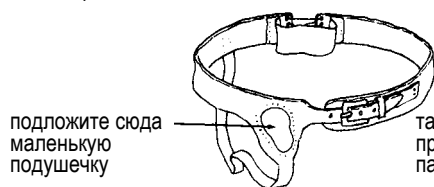
а не так.



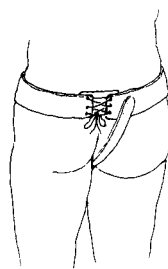
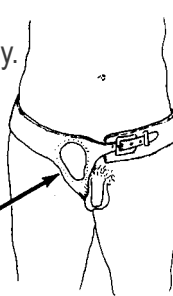
Как жить с грыжей

- ◆ Избегайте поднятия тяжелых вещей.
- ◆ Сделайте бандаж, поддерживающий грыжу.

Схема грыжевого бандажа



так она
прижимается к
паху



Осторожно: Если грыжа вдруг стала больше и болезненнее, постарайтесь убрать ее внутрь снова, лежа с поднятыми выше головы ногами и нажимая мягко на бугорок. Если она не убирается, обратитесь за медицинской помощью.

Если грыжа становится болезненной, вызывает рвоту и больной не может опорожниться, это может быть очень опасно. Может понадобиться операция. Скорее обратитесь к врачу. Тем временем лечите как Аппендицит (с. 95).

ПРИПАДКИ (КОНВУЛЬСИИ)

Мы говорим, что у человека припадки, если он внезапно теряет сознание и делает странные, дергающиеся движения (конвульсии). Причины припадков – это проблемы мозга. У малышей обычные причины припадка – **высокая температура** и **сильное обезвоживание**. У очень больных людей припадки могут вызываться **менингитом**, **малярией мозга** или **отравлением**. Частые припадки могут перейти в **эпилепсию**.

- ◆ Старайтесь определить причину припадка и лечить ее, если возможно.
- ◆ Если у ребенка жар, сразу сбейте его холодной водой (см. с. 76).
- ◆ Если ребенок обезвожен, сделайте медленно клизму из Регидрона. Обратитесь к врачу. Ничего не давайте в рот во время припадка.
- ◆ Если есть признаки менингита (с. 185), начните сразу лечение и обратитесь за медицинской помощью.
- ◆ Если подозреваете церебральную малярию, введите малярийный препарат (см. с. 307).

ЭПИЛЕПСИЯ

Эпилепсия вызывает припадки у людей, которые в других отношениях кажутся совершенно здоровыми. Припадки могут длиться часами, днями, неделями или месяцами. У некоторых они вызывают потерю сознания или непроизвольные движения. Глаза закатываются. В легких случаях эпилепсии больной может внезапно “выключиться” на минуту, делать странные движения или вести себя необычно. Эпилепсия может поразить семью (наследственность). Или может вызываться травмами мозга при родах, высокой температурой в детстве или чистой солитера в мозгу (с. 143). Эпилепсия не инфекционная болезнь и ее нельзя “поймать”. Часто это хроническая болезнь. Однако дети иногда преодолевают ее.

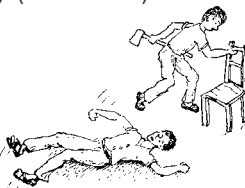
Препараты для профилактики эпилептических припадков:

Примечание: Они не “лечат” эпилепсию, они помогут предупредить припадки. Часто лекарство необходимо принимать всю жизнь.

- ◆ Фенобарбитал часто останавливает эпилепсию. Стоит дешево (см. с. 389).
- ◆ Фенитоин может действовать тогда, когда не помогает фенобарбитал. Для предупреждения припадков используйте минимальную дозу (см. с. 390).

Когда у больного припадок:

- ◆ Постарайтесь удержать больного, чтобы он не навредил себе: спрячьте тяжелые или острые предметы.
- ◆ Ничего не давайте в рот во время припадка – ни пищу, ни питье, ни лекарство, ни любой предмет, чтобы он не прикусил язык.
- ◆ После припадка человек может быть подавленным и сонным. Дайте ему поспать.
- ◆ Если припадок длится долго, введите фенобарбитал или фенитоин. Дозу см. на с. 389 и 390. Если он не прекратится через 15 мин., дайте вторую дозу. Или, если знаете как, введите IV диазепам (Валиум, с. 391) или фенобарбитал в вену. Лекарство для инъекций можно ввести в прямую кишку шприцем без иглы. Или разотрите пилюлю диазепама или фенобарбитала, смешайте с водой и введите в прямую кишку.



Чтобы получить больше информации о припадках, см. *Искалеченные Деревенские Дети*, Глава 29.

СЕРЬЕЗНЫЕ БОЛЕЗНИ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ГЛАВА

14

Болезни, рассмотренные в этой главе, очень часто тяжело или невозможно лечить без медицинской помощи. Нужны многие особые лекарства, которые трудно достать в сельской местности. Домашние средства лечения не помогут. Если у человека одна из таких болезней, то чем скорее он получит медицинскую помощь, тем у него больше шансов вылечиться.

ОСТОРОЖНО: Многие из болезней, рассмотренных в других главах, могут тоже быть тяжелыми и требовать медицинской помощи. Смотри Признаки Опасных Болезней, с. 42.

ТУБЕРКУЛЕЗ (ТБ, ЧАХОТКА)

Туберкулез легких – это хроническая (долготечущая), заразная (легко распространяющаяся) болезнь, которой может заболеть любой. Но он часто поражает людей между 15 и 35 годами, особенно тех, у кого СПИД (с. 399), или слабых, истощенных, или тех, кто живет с больным туберкулезом.

Туберкулез излечим. И все-таки тысячи умирают от него ежегодно. Как для предупреждения, так и для лечения очень важно лечить ранний туберкулез. Поэтому вам следует знать признаки туберкулеза и постоянно следить за ними.

Основные признаки туберкулеза:

- Хронический кашель, особенно плохой после того, как вы проснулись.
- Легкий жар в полдень и потливость всю ночь.
- Боль может быть в груди или в верхней части спины.
- Хроническая потеря в массе и увеличение слабости.

В тяжелых или запущенных случаях:

- Кашель с кровью (обычно понемногу, но иногда сильно).
- Бледная, восковая кожа. Кожа темнокожего становится светлее, особенно на лице.
- Голос становится хриплым (очень сильно).

У маленьких детей кашель может придти позднее. Вместо этого наблюдается:

- Постоянная потеря в массе.
- Частое повышение температуры.
- Светлеет цвет лица.
- Опухоли на шее (лимфатические узлы) или на животе (с. 20).

Туберкулез обычно бывает только в легких. Но иногда он поражает любую часть тела. У маленьких детей он может вызвать менингит (см. с. 185). О кожных проблемах при ТБ см. с. 212.



Если вы думаете, что у вас туберкулез, Обратитесь за медицинской помощью. При первых признаках туберкулеза обратитесь в центр здоровья, где врачи могут провести тест на коже, сделать рентген и исследовать слизь или мокроту, чтобы увидеть есть ли у вас туберкулез или нет. Многие правительства выдают лекарства бесплатно. Обратитесь в ближайший центр здоровья. Вам, видимо, назначат 2, 3 или 4 лекарства из следующих:

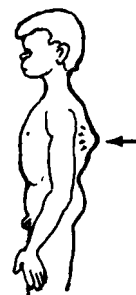
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| • Изониазид (INH) в пилюлях (с. 361) | • Этамбутол в пилюлях (с. 302) |
| • Рифампин в пилюлях (с. 302) | • Стрептомицин в инъекциях (с. 363) |
| • Пиразинамид в пилюлях (с. 362) | • Тиацетазон в пилюлях (с. 363) |

Очень важно принимать лекарства так, как указано. По крайней мере, 2 лекарства нужно принимать одновременно. (О риске и мерах предосторожности при приеме этих лекарств см. с. 361-363.) Продолжайте принимать их до тех пор, пока работник здравоохранения не скажет, что вы излечились. **Не прекращайте прием лекарств только потому, что почувствовали себя лучше. Чтобы вылечить туберкулез полностью, обычно требуется от 6 месяцев до 1 года.**

Питайтесь как можно лучше: побольше энергетической пищи и продуктов, в которых много протеина и витаминов (с. 110 и 111).

Очень важен отдых. Если возможно, прекратите работу и воспринимайте это легко, пока вы не почувствуете себя лучше. С этих пор старайтесь не выполнять тяжелую работу, чтобы не уставать и не затруднять дыхание. Старайтесь больше отдыхать и спать.

Туберкулез в любой части организма лечится так же, как туберкулез легких. Это и туберкулез желез на шее, и туберкулез брюшной полости (см. рисунок на с. 20), и туберкулез кожи (см. с. 212) и туберкулез суставов (например, колена). Ребенку с тяжелой формой туберкулеза позвоночника может понадобиться операция для предотвращения паралича (см. Искалеченные Деревенские Дети, Глава 21).



Туберкулез позвоночника

Туберкулез – очень заразная болезнь. Люди (особенно дети), которые живут вместе с туберкулезным больным, подвержены риску заболеть этой болезнью.

Если у кого-то в доме туберкулез:

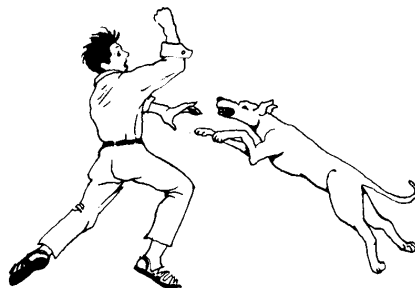
- ◆ Если возможно, проследите за тем, чтобы семьи полностью проверялись на туберкулез (туберкулиновая проба).
- ◆ Сделайте детям прививки от туберкулеза БЦЖ вакциной.
- ◆ Каждый, особенно дети, должны есть питательную пищу.
- ◆ Человек с туберкулезом должен питаться и спать отдельно от детей, если возможно, в другой комнате, пока у него полностью не пройдет кашель.
- ◆ Попросите его прикрывать рот платком при кашле и не плевать на пол.
- ◆ Следите за потерей в массе и другими признаками туберкулеза у членов вашей семьи. Если возможно, взвешивайте каждого, особенно детей, один раз в месяц, пока не пройдет опасность.

ТБ у членов семьи часто начинается медленно и спокойно. Если у кого-то появляются признаки туберкулеза, проверьтесь и **начинайте сразу лечение.**

Раннее и полное лечение – ключ к предупреждению болезни.

БЕШЕНСТВО

Бешенством заражаются при укусе бешеного или "сумасшедшего" животного, обычно бешеной собаки, кошки, лисы, волка, скунса или шакала. Летучие мыши и другие животные тоже могут распространять бешенство.



Признаки бешенства:

У животных:

- Ведут себя странно – временами унылые, беспокойные или раздражительные.
- Пена у рта, не могут есть или пить.
- Иногда животное становится диким (сумасшедшим) и может укусить любого, кто находится рядом.
- Животное умирает через 5-7 дней.

У людей:

- Боль и покалывание в месте укуса.
- Неправильное дыхание, как будто человек только что плакал.
- Больно и тяжело глотать. Много густой, вязкой слюны.
- Человек настороженный, но очень нервный и возбужденный. Могут случаться приступы гнева.
- При приближении смерти припадки (конвульсии) и паралич.

Если у вас есть основания считать, что укусившее животное бешеное:

- ◆ Привяжите животное или посадите в клетку на неделю.
- ◆ Промойте хорошо укус водой с мылом и перекисью водорода. Не закрывайте рану, оставьте ее открытой.
- ◆ Если животное умирает, прежде чем пройдет неделя (или оно было убито или его нельзя поймать), отведите укушенного больного сразу в центр здоровья, где ему могут сделать серию инъекций против бешенства.

Первые признаки бешенства появляются от 10 дней до 2 лет после укуса (обычно в течение 3-7 недель). Лечение надо начинать до появления первых признаков болезни. А уже если болезнь появилась, то не существует такого лечения, чтобы спасти жизнь больного.

Предупреждение:

- ◆ Убейте и закопайте (или запряте в клетку на неделю) любое животное, подозреваемое на бешенство.
- ◆ Организуйте программу по вакцинации животных.
- ◆ Держите детей подальше от любого животного, которое кажется больным или ведет себя странно.

Будьте осторожны в обращении с животным, которое кажется вам больным или ведет себя странно. Даже если оно никого не кусает, его слюна может быть причиной бешенства, если она попадает на порез или царапину.

СТОЛБНЯК

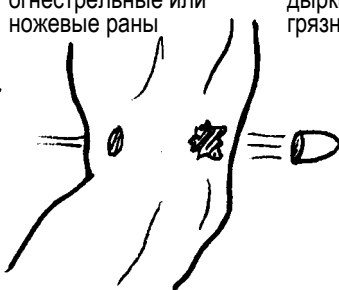
Столбняк появляется в результате проникновения в организм человека через раны микробов, которые живут в фекалиях животных или людей. Особенно опасны глубокие или грязные раны.

РАНЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ СТОЛБНЯК

укусы животных, особенно собак и свиней



огнестрельные или
ножевые раны



дырки в ушах от
грязных иголок



раны от колючей проволоки



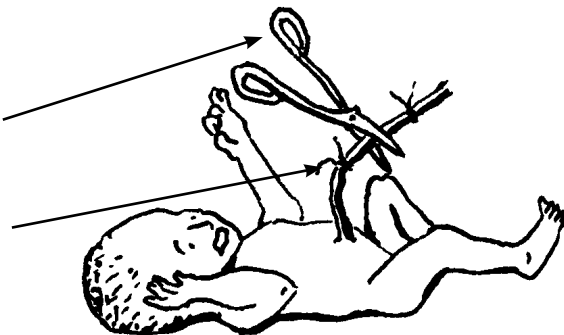
проколы от колючек, гвоздей и осколков



ПРИЧИНЫ СТОЛБНЯКА У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Микробы столбняка попадают через пуповину новорожденного ребенку из-за недостатка чистоты или из-за того, что не соблюдаются простые меры предосторожности. Шанс заболеть столбняком возрастает:

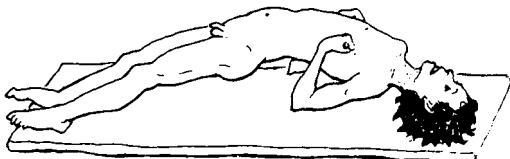
- когда пуповину обрезали инструментом, который не прокипятили и не хранили в чистоте;
- когда пуповину обрезали **далеко** от тела (см. с. 212);
- когда свежееобрезанную пуповину слишком туго перевязали или она не была сухой.



Признаки столбняка:

- Инфицированная рана (иногда нет никакой раны).
- Неудобно и трудно глотать.
- Челюсти сжимаются, затем деревенеют мышцы шеи и других частей тела. Человеку трудно ходить нормально.
- Болезненные конвульсии (внезапное сжатие) челюсти и, наконец, всего тела. Перемещение больного или прикосновение к нему может вызвать внезапные спазмы, такие как эти.

Внезапный шум или яркий свет тоже могут вызвать такие спазмы.



У новорожденных первые признаки столбняка обычно появляются через 3-10 дней после рождения. Ребенок постоянно плачет и не может сосать. Часто область пупка грязная или инфицированная. Через несколько часов или дней появляется сжатие челюстей и другие признаки столбняка.

Очень важно начать лечение столбняка при первых признаках. Если вы подозреваете столбняк (или если новорожденный ребенок непрерывно плачет или перестает спать), сделайте такой тест.

ПРОВЕРКА КОЛЕННОГО РЕФЛЕКСА

Когда нога свободно висит, слегка ударьте по колену суставом пальца ниже коленной чашечки.

Если нога поднимается немного, реакция нормальная.

Если нога подпрыгивает высоко, это указывает на серьезную болезнь, такую как столбняк (или возможен менингит или отравление каким-то лекарством или крысиным ядом).



Этот тест особенно полезен, когда вы подозреваете столбняк у новорожденного.

Что делать, когда есть признаки столбняка:

Столбняк – это смертельная болезнь. Обращайтесь за медицинской помощью при первых признаках. Если помощь задерживается, сделайте следующее:

- Обследуйте все тело на инфицированную рану или болячку. Часто в ране есть гной. Откройте рану, промойте ее холодной кипяченой водой с мылом; полностью очистите от грязи, гноя, заноз, осколков и т.д.; обработайте рану перекисью водорода, если она есть.

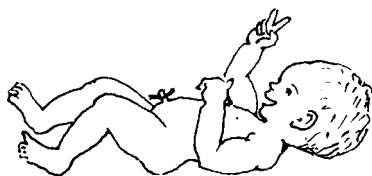
- Введите сразу же 1000000 ЕД прокаина пенициллина и повторяйте инъекции каждые 12 часов (с. 353). (Для новорожденных детей лучше кристаллический пенициллин.) Если нет пенициллина, пользуйтесь другим антибиотиком, таким как тетрациклин.
- Если вы сможете достать, сделайте инъекцию 5000 ЕД человеческого иммуноглобулина или 40000-50000 ЕД столбнячного антитоксина. Соблюдайте все меры предосторожности (см. с. 70 и 389). **Человеческий иммуноглобулин** реже вызывает сильную аллергическую реакцию, но он дороже и его труднее достать.
- Как только больной сможет глотать, почаще давайте ему маленькими глотками питательную жидкость.
- Чтобы прекратить конвульсии, введите фенобарбитал (дозу см. на с. 390) или диазепам (Валиум, с. 390), взрослым: 10–20 мг для начала и больше, если необходимо.
- Пореже прикасайтесь к больному и передвигайте его. Избегайте шума и яркого света.
- Если необходимо, используйте катетер (резиновую трубку), соединенный со шприцем, чтобы отсосать мокроту из носа и горла.
- Новорожденному со столбняком работник здравоохранения или врач должны ввести трубку через нос в желудок, чтобы кормить ребенка грудным молоком. Это обеспечивает ребенка питанием и борется с инфекцией.

Как предупредить столбняк:

Даже в лучших больницах половина людей со столбняком умирает. Гораздо легче предупредить столбняк, чем лечить его.

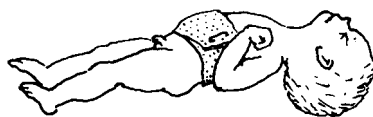
- **Вакцинация:** Это надежная защита от столбняка. И дети, и взрослые должны быть вакцинированы. Сделайте прививки всей вашей семье (см. с. 147). Для полной защиты, вакцинация должна повторяться один раз каждые 10 лет. **Вакцинация женщин при каждой беременности предохранит от столбняка новорожденных младенцев (см. с. 250).**
- Если у вас есть рана, особенно грязная или глубокая, очистите ее и сделайте все так, как описано на с. 89.
- Если рана очень большая, глубокая или грязная, обратитесь за медицинской помощью. Если вы не сделали прививку от столбняка, примите пенициллин. Не забудьте еще сделать инъекцию антитоксина от столбняка (см. с. 389).
- Для предупреждения столбняка у новорожденных детей очень важна чистота. Инструмент для обрезания пуповины должен быть стерильным (см. с. 262); пуповину следует обрезать коротко и место вокруг пупка содержать чистым и сухим.

Этому ребенку отрезали пуповину коротко и оставили открытой.



ОН ОСТАЛСЯ ЗДОРОВЫМ.

Этому ребенку оставили длинную пуповину, туго завязали и не содержали сухой.



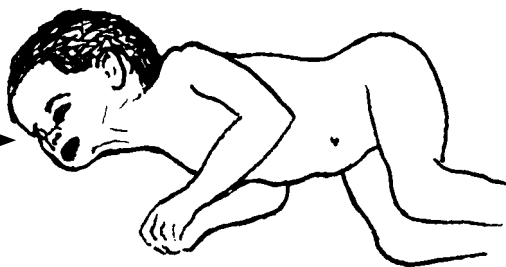
ОН УМЕР ОТ СТОЛБНЯКА.

МЕНИНГИТ

Это очень серьезная инфекция мозга, чаще всего у детей. Она может начаться как осложнение после других болезней, таких как корь, свинка, коклюш или инфекция в ухе. Дети, у которых матери болеют туберкулезом, иногда заболевают туберкулезным менингитом в первые месяцы жизни.

Признаки:

- Жар.
- Сильная головная боль.
- Негнувшаяся шея. Ребенок выглядит больным и лежит, откинув голову и выгнув шею назад, как здесь.
- Спина слишком жесткая, нельзя наклонить голову вниз.
- У детей до 1 года родничок (мягкое место на макушке головы) становится выпуклым.
- Обычно рвота.
- У младенцев и маленьких детей ранний менингит трудно распознать. Ребенок может странно плакать ("менингитный плач"), даже если мать прикладывает ребенка к груди. Или ребенок становится сонным.
- Иногда бывают припадки (конвульсии) или странные телодвижения. Ребенку становится все хуже и хуже и он успокаивается только тогда, когда полностью теряет сознание.
- Туберкулезный менингит развивается медленно в течение дней или недель. Другие формы менингита приходят быстрее за несколько часов или дней.



Лечение:

Нужна скорая медицинская помощь – на счету каждая минута! Если возможно, доставьте человека в больницу. Тем временем:

- ♦ Вводите ампициллин по 500 мг каждые 4 часа (см. с. 353). Или делайте инъекции кристаллического пенициллина по 1000000 ед. каждые 4 часа (см. с. 353). Если возможно, дайте ему хлорамфеникол (см. с. 357).
- ♦ Если у него высокая температура (более 40°), снижайте ее мокрой тряпочкой и ацетаминофеном или аспирином (см. с. 379 и 380).
- ♦ Если у матери туберкулез или если у вас есть другие причины подозревать, что у ребенка туберкулезный менингит, делайте инъекции стрептомицина по 0.2 мл на каждые 5 кг веса и немедленно обратитесь за медицинской помощью. И еще, пользуйтесь ампициллином или пенициллином в случае, если менингит не от ТБ.

Предупреждение:

Для предупреждения менингита у новорожденных детей, матери которых больны туберкулезом, необходимо сделать прививку БЦЖ при рождении. Доза для новорожденных 0.05 мл (половина нормальной дозы в 0.1 мл). Другие советы по предупреждению ТБ см. на с. от 179 и 180.

МАЛЯРИЯ

Малярия – это инфекция крови, которая вызывает озноб и высокую температуру. Малярию распространяют москиты. Москиты высасывают малярийных паразитов с кровью больного человека и вводят их другим людям через свои укусы.

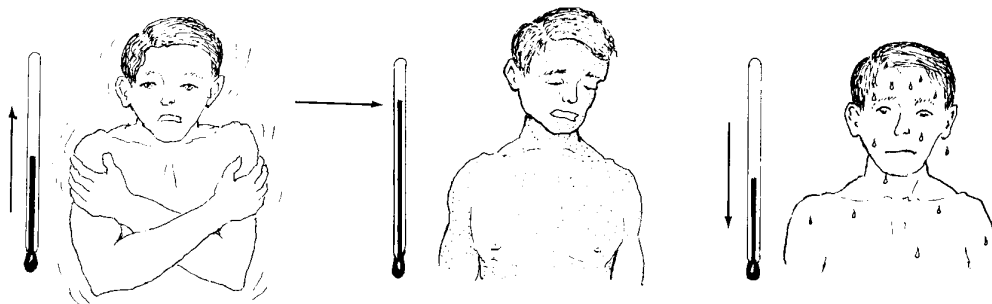
Признаки малярии:

Типичный приступ имеет 3 стадии.

Она начинается с озноба – и часто с головной боли. Человек трясется или дрожит в течение 15 мин или часа.

Озноб сопровождается температурой – часто 40° или больше. Человек слабеет, краснеет (красная кожа), иногда бредит (не в своем уме). Температура держится несколько часов или дней.

Наконец, человек начинает потеть и температура падает. После приступа больной чувствует себя слабым, но может чувствовать себя более или менее хорошо.



- Обычно малярия вызывает лихорадку каждые 2-3 дня (это зависит от вида малярии), но в начале лихорадка может быть каждый день. Температурный график может быть не регулярным и не типичным. Поэтому любой, кто страдает от необъяснимой лихорадки, должен проверить кровь на малярию.
- Хроническая малярия часто вызывает увеличение селезенки и анемию (см. с. 124).
- У маленьких детей анемия или бледность могут начаться в течение дня или двух. У детей малярия действует на мозг (церебральная малярия), за припадками могут следовать бессознательные периоды. Ладони могут быть сине-серого цвета, а дыхание может быть частым и глубоким. (Примечание: Дети, которых не кормят грудью, чаще заболевают малярией.)

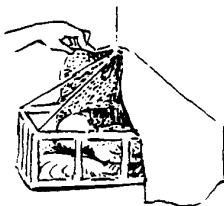
Анализ и лечение:

- Если подозреваете малярию или повторяется жар, проверьте кровь в центре здоровья. В местах, где бывает тропическая малярия – особенно опасная разновидность малярии – немедленно начните лечение.
- В местах, где малярия обычна, лечите любую необъяснимую высокую температуру как малярию. Принимайте лекарства от малярии, которые действуют лучше в вашей местности (см. на с. 365-368 дозы и информацию о лекарствах от малярии).
- Если вам стало лучше после лекарства, но через несколько дней жар начинается снова, нужно принимать другое лекарство. Обратитесь за советом в ближайший центр здоровья.
- Если у больного с предполагаемой малярией начинаются припадки или другие признаки менингита (с. 185), то возможно у него *церебральная малярия*. Сделайте сразу инъекцию лекарства от малярии (с. 367).

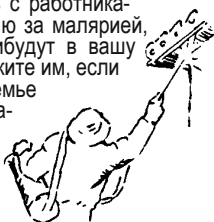
КАК ИЗБЕЖАТЬ МАЛЯРИИ (И ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ)

Малярия часто случается во время жаркой, дождливой погоды. Если все объединить, болезнь можно остановить. Все эти методы контроля должны применяться на практике.

1. Избегайте москитов. Спите там, где нет москитов, или под прибудут простыней. Люльку ребенка накройте сеткой от москитов или тканью.



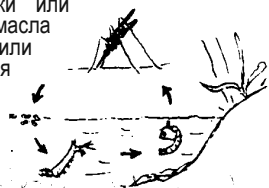
2. Объединитесь с работниками по контролю за малярией, когда они прибудут в вашу деревню. Скажите им, если у кого-то в семье была температура, пусть они возьмут кровь тонкой иглой на анализ.



3. Если вы подозреваете малярию, сразу начните лечение. После вашего излечения москиты, которые вас укусят не передадут малярию другим.



4. Уничтожьте москитов и их яйца. Москиты заводятся в стоячей воде. Чистите пруды, ямы, старые банки или разбитые горшки, в которых застоялась вода. Осушите лужи или налейте немного масла поверхность лужи или болота, где заводятся москиты.



5. Малярию можно предупредить или сильно уменьшить ее действие, если принимать антималярийные препараты по регулярному графику. См. с. 365 – 368.

ЛИХОРАДКА ДЕНГЕ (ЖАР С ЛОМОТОЙ В КОСТЯХ, “ПОХОДКА ФРАНТА”)

Эту болезнь иногда путают с малярией. Она вызывается вирусом, который переносится москитами. В последнее время она распространилась во многих странах. Часто малярия вызывает эпидемии (одновременно заболевают многие люди), обычно в горячий дождливый сезон. Человек может болеть денге несколько раз. Повторная болезнь, часто хуже. Для профилактики денге уничтожайте москитов и защищайтесь от их укусов, как описано выше.

Признаки:

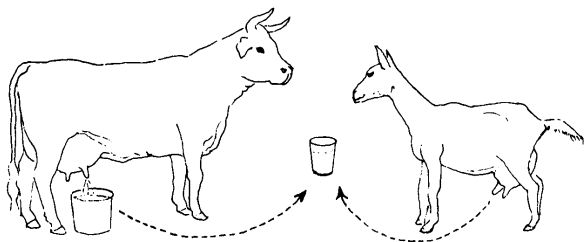
- Внезапный сильный жар с ознобом.
- Сильно болит тело, голова, воспаляется горло.
- Человек чувствует себя очень больным, слабым и жалким.
- Через 3-4 дня состояние больного улучшается на несколько часов или до 2 дней.
- Затем болезнь возвращается на один или 2 дня, часто с сыпью, которая начинается на кистях рук и стопах.
- Сыпь затем распространяется на руки, ноги и по всему телу (обычно не на лице).
- В Юго-Восточной Азии сильная форма денге может вызвать подкожное кровоотечение (маленькие темные пятна) или опасное кровоотечение внутри тела.

Лечение:

- Никакие лекарства не помогают, а болезнь проходит сама через несколько дней.
- Отдых, много жидкости, ацетаминофен (но не аспирин) от жара и боли.
- В случае сильного кровоотечения, лечите от шока, если необходимо (см. с. 77).

БРУЦЕЛЛЕЗ (ЛИХОРАДКА МАЛЫТА)

Это болезнь, которая появляется при употреблении свежего молока от инфицированных коров или коз. Ею могут заразиться через царапины или раны на коже или через легкие люди, которые работают с больным скотом, козами, свиньями.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БРУЦЕЛЛЕЗА:
НИКОГДА НЕ ПЕЙТЕ СЫРОЕ МОЛОКО

Признаки:

- Бруцеллез может начинаться с жара и озноба, но чаще всего начинается постепенно с усталости, слабости, потери аппетита, головной боли, боли в желудке и иногда в суставах.
- Жар может быть умеренным или сильным. Как правило, бруцеллез начинается с послеобеденного озноба и заканчивается тем, что человек потеет под утро. При хроническом бруцеллезе жар может прекратиться на несколько дней, затем вернуться. Без лечения бруцеллез длится годы.
- Могут опухнуть лимфоузлы на шее, под мышками или в паху (с. 88).

Лечение:

- ◆ Если вы подозреваете бруцеллез, посоветуйтесь с медиками, потому что эту болезнь легко перепутать с другими, а лечение бруцеллеза долгое и дорогое.
- ◆ Лечите тетрациклином взрослых: две капсулы по 250 мг 4 раза в день в течение трех недель. О мерах предосторожностей см. с. 356. Или используйте ко-тримоксазол. (Дозу и предосторожности см. на с. 358.)

Предупреждение:

- ◆ Пейте только кипяченое или пастеризованное коровье или козье молоко. В местах, где распространен бруцеллез, безопаснее не питаться сыром, сделанным из сырого молока.
- ◆ Будьте осторожны в обращении со скотом, козами и свиньями, особенно если у вас есть порезы или царапины.
- ◆ Объединитесь с инспекторами за живым скотом, которые проводят проверки здоровья ваших животных.

БРЮШНОЙ ТИФ

Тиф — это инфекция кишечника, которая действует на весь организм. Он передается из кала в рот через загрязненную пищу и воду и часто вызывает эпидемии (одновременно болеет много людей). Из различных инфекций, иногда называемых “лихорадкой” (см. с. 21), брюшной тиф — одна из самых опасных болезней.

Признаки брюшного тифа:

Первая неделя:

- Начинается как простуда или грипп.
- Головная боль, воспаленное горло и часто сухой кашель.
- Жар поднимается понемногу каждый день, пока не дойдет до 40° или больше.
- Пульс часто относительно медленный для такой температуры. Измеряются пульс и температура каждые полчаса. Если пульс замедляется при повышении температуры, у больного возможен брюшной тиф (см. с. 26).
- Иногда есть рвота, понос или запор.

1 день 37½° C



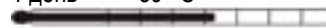
1 день 38° C



1 день 38½° C



1 день 39° C



1 день 39½° C



1 день 40° C



Вторая неделя:

- Сильный жар, пульс относительно медленный.
- На теле могут появиться розовые пятна.
- Дрожь.
- Бред (человек не думает ясно или осмысленно).
- Слабость, потеря в массе, обезвоживание.

Третья неделя:

- Если нет осложнений, жар и другие симптомы потихоньку проходят.

Лечение:

- Обратитесь за медицинской помощью.
- В местах, где тиф сопротивляется хлорамфениколу и ампициллину, давайте ко-тримоксазол (с. 358), по крайней мере 2 недели.
- Или пробуйте хлорамфеникол (см. с. 357) взрослым: 3 капсулы по 250 мг 4 раза в день, по крайней мере 2 недели. Если нет хлорамфеникола, давайте ампициллин (с. 353) или тетрациклин (с. 356).
- Снижайте температуру холодной мокрой тряпкой (см. с. 76).
- Давайте много жидкости: супов, соков и регидронового напитка от обезвоживания (см. с. 152).
- Давайте питательную еду в жидком виде, если это необходимо.
- Больному нужно оставаться в постели, пока жар не пройдет полностью.
- Если у больного в кале кровь или развиваются признаки перитонита (с. 94) или пневмонии (с. 171), доставьте его сразу в больницу.

Предупреждение:

- Для предупреждения брюшного тифа нужно избегать загрязнения воды и пищи человеческим калом. Следуйте правилам личной и общественной гигиены в Главе 12. Стройте и пользуйтесь уборными. Убедитесь в том, что уборные на безопасном расстоянии от места, где люди берут питьевую воду.
- Случаи брюшного тифа часто появляются после наводнения или другой катастрофы, особое внимание нужно уделить чистоте в это время. Убедитесь, что вода для питья чистая. Если есть случаи тифа в вашей местности, нужно кипятить питьевую воду. Ищите причину в загрязненной воде или еде.

- Чтобы избежать распространения тифа, больной должен оставаться в отдельной комнате. Никто не должен есть или пить из его посуды. Его испражнения нужно сжечь или глубоко закопать. Люди, которые ухаживают за ним, должны постоянно мыть руки.
- После выздоровления некоторые люди все еще остаются носителями болезни и могут заражать других. Поэтому любой, у кого был брюшной тиф, должен тщательно соблюдать личную гигиену и не работать в местах приготовления пищи. Иногда ампициллин эффективнее для носителей брюшного тифа.

СЫПНОЙ ТИФ

Сыпной тиф – болезнь похожая, но отличается от брюшного тифа тем, что инфекция переносится укусами



Признаки:

- Сыпной тиф начинается как сильная простуда. Через неделю или больше начинается жар с ознобом, головной болью и болью в мышцах и груди.
- После нескольких дней жара появляется типичная сыпь сначала под мышками, затем на теле, затем на руках, ногах (но не на лице, ладонях рук или подошвах ног). Сыпь выглядит как крошечные синяки.
- Жар держится 2 недели или больше. Сыпной тиф обычно умеренный у детей и сильный у стариков. Эпидемическая форма сыпного тифа особенно опасна.
- Если заражение тифом произошло при укусе клещами, в месте укуса часто появляется большая болезненная рана, а лимфатические узлы около укуса распухают и болят.

Лечение:

- Если вы думаете, что кто-то болеет тифом, обратитесь за медицинским советом. Часто нужны особые анализы.
- Давайте тетрациклин взрослым: 2 капсулы по 250 мг 4 раза в день в течение 7 дней (с. 356). Хлорамфеникол тоже действует, но риск больше (с. 357).

Предупреждение:

- Поддерживайте чистоту. Регулярно проверяйте вашу семью на вши.
- Убирайте клещей с собак и не разрешайте им входить в дом.
- Убивайте крыс. Используйте ловушки или кошек (но не яд, который может быть опасным для других животных и детей).

Убивайте крысиных блох. Не берите в руки мертвых крыс. Блохи могут перепрыгнуть на вас. Утопите и сожгите крыс и их блох. Положите инсектициды в крысиные норы и гнезда.

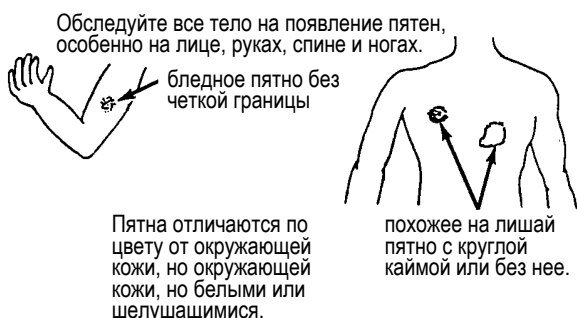


ЛЕПРА (БОЛЕЗНЬ ХАНСЕНА)

Эта умеренно инфекционная болезнь развивается медленно, часто долгие годы. Она может передаваться от человека с не вылеченной проказой к человеку, у которого “низкая сопротивляемость” к болезни. В местностях, где проказа обычна, дети должны проверяться каждые 6-12 месяцев – особенно дети, которые живут с больными проказой.

Признаки: Проказа может вызывать различные кожные проблемы, потерю чувствительности и паралич ног и рук.

Первый признак проказы – это **медленно растущее пятно на коже, которое не чешется и не болит**. Сначала внутри пятна чувствительность может быть нормальной. Следите за ним. Если в пятне чувствительность уменьшается или исчезает (см. с. 38), это возможно проказа.



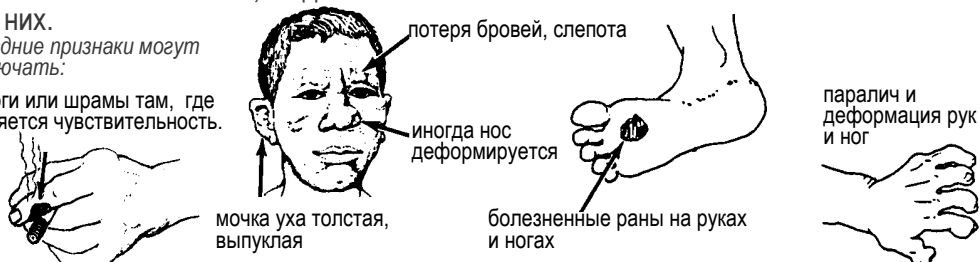
Поздние признаки различаются в соответствии с естественной сопротивляемостью человека к болезни. Следите за:

- Покалыванием, онемением и потерей чувствительности в руках или ногах. За деформациями или потерей чувствительности в кожных пятнах.
- Легкой слабостью или деформацией рук и ног.
- Опухшими нервами, которые образуют толстые жгуты под кожей. Нервы могут быть болезненными, когда нажимаете на них.



Поздние признаки могут включать:

ожоги или шрамы там, где теряется чувствительность.



Лечение проказы: Проказа обычно излечима, но лекарство следует принимать годами. Самое лучшее лекарство дапсон, если возможно, в сочетании с рифампином и клофазимином (см. с. 364 и 365). Если “реакция проказы” (жар, сыпь, боль и, возможно, отеки рук и ног или поражение глаз) при приеме лекарства становится хуже, продолжайте их принимать, но обратитесь за медицинской помощью.

Предупреждение поражения рук, ног, глаз: Большие открытые раны, которые часто видны на руках и ногах больного проказой, не вызываются самой болезнью и их можно предупредить. Они появляются в результате того, что больной теряет чувствительность и не может себя защитить от повреждения.

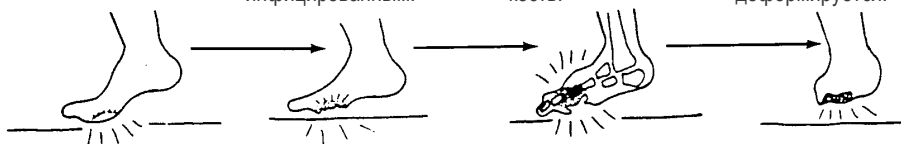
Например, если у человека с нормальной чувствительностью после длительной ходьбы появляется волдырь, он болит, и человек перестает ходить или хромает.

Но когда у человека с проказой появляется волдырь, он не болит.

Он продолжает ходить волдырь лопается и становится инфицированным.

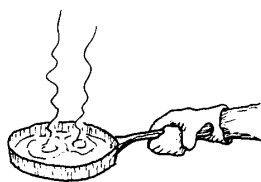
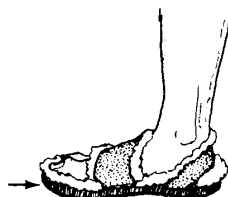
Все еще без боли инфекция проникает глубже и поражает кость.

Со временем кость разрушается и нога все больше и больше деформируется.



1. Защищайте руки и ноги от предметов, которые могут порезать, синяков, волдырей и от ожогов.

Не ходите босиком, особенно там, где есть острые камни или колючки. Носите туфли или сандалии. Положите мягкую прокладку внутрь туфли или под ремешки, которые могут натирать.



Когда работаете или готовите еду, надевайте перчатки. Никогда не поднимайте предметы, которые могут быть горячими, не защитив свои руки толстыми перчатками или сложенной тряпкой. Если можно, избегайте работать с острыми и горячими предметами. Не курите.

2. В конце каждого дня (или даже чаще, если работа тяжелая или ходите далеко) внимательно осмотрите ваши руки и ноги – или пусть кто-то еще осмотрит их. Ищите порезы, синяки или проколы. Еще поищите места или пятна на руках и ногах: красные, горячие, опухшие или где есть волдыри. Если вы найдете какие-нибудь из них, дайте отдохнуть рукам или ногам до тех пор, пока кожа снова полностью не станет нормальной. Это поможет коже загрубить и укрепит ее. Раны можно предупредить.
3. Если у вас открытая рана, содержите ее в чистоте и покое, пока полностью не вылечите. Будьте осторожны, чтобы не повредить это место снова.
4. Защищайте глаза. Многие повреждения глаз вызываются тем, что вы недостаточно мигаете из-за слабости или потери чувствительности. Мигайте почаще, чтобы глаза были влажными и чистыми. Если не можете мигать, закрывайте крепко глаза в течение дня почаще, особенно если в них попадает пыль. Носите солнцезащитные очки в течение дня и шляпу от солнца. Следите за чистотой глаз и избегайте мух.

Если вы будете соблюдать эти правила и начнете раннее лечение, **основные деформации от проказы можно предупредить**. Чтобы получить дополнительную информацию о болезни Хансена, см. *Искалеченные Деревенские Дети*, Глава 26.

Некоторые проблемы кожи вызываются болезнями или раздражениями, которые действуют только на кожу – такие как стригущий лишай, сыпь от пеленок или бородавки. Часто проблемы кожи – это болезнь, которая действует на все тело – такие как сыпь от кори или раны, сухие пятки от пеллагры (недоедание). Определенные типы язвы или состояние кожи могут быть признаком тяжелой болезни – такой как туберкулез, сифилис или проказа.

Эта глава рассматривает более общие кожные проблемы в сельской местности. Однако есть сотни болезней кожи. Некоторые выглядят так, что их трудно определить в отдельности – и все-таки их причины и особое лечение, которого они требуют, могут быть совершенно другими.

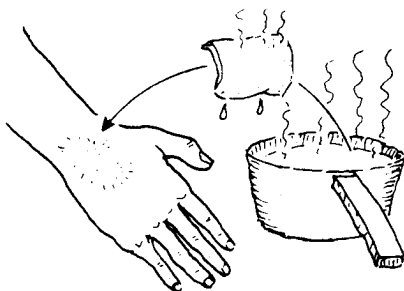
Если кожные проблемы серьезные или осложняются, несмотря на лечение, обратитесь за медицинской помощью.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ КОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Хотя многие кожные болезни требуют особого лечения, есть несколько общих мер, которые обычно помогают.

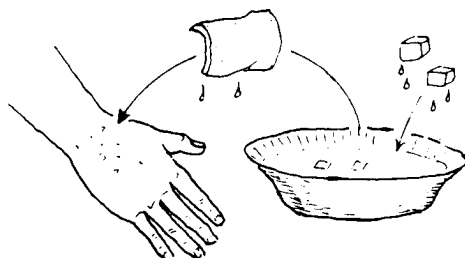
ПРАВИЛО №1

Если пораженное место горит и болит или выделяет гной, лечите его теплом. Положите горячую влажную тряпочку на него (горячий компресс).



ПРАВИЛО №2

Если пораженное место зудит, жжет или выделяет чистую жидкость, лечите его холодом. Положите прохладную мокрую тряпочку на него (холодный компресс).



ПРАВИЛО №1 (в деталях)

Если на коже признаки серьезной инфекции, такие как:

- воспаление (краснота или потемнение кожи вокруг пораженного места),
- опухоль,
- боль,
- жар (горит),
- гной.

Делайте следующее:

- ◆ Держите в покое пораженную часть и держите ее повыше (поднимите выше, чем остальная часть тела).
- ◆ Приложите горячие влажные тряпочки.
- ◆ Если инфекция сильная или у больного жар, дайте ему антибиотики (пенициллин, сульфаниламид или эритромицин).

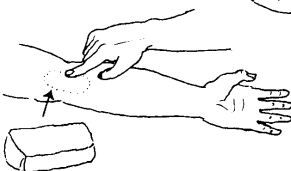
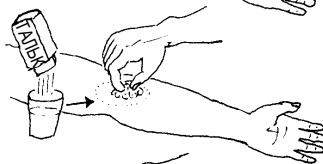
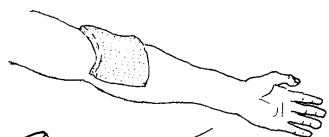
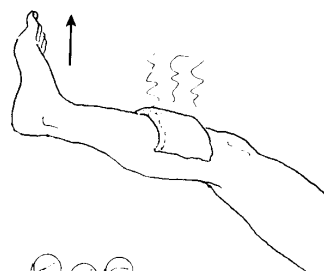
Опасные признаки включают: опухшие лимфоузлы, красная или темная линия сверху инфекционного места или плохой запах. Если не становится лучше после лечения – примените антибиотик и обратитесь быстрее за медицинской помощью.

Правило №2 (в деталях)

Если на пораженном месте образовался волдырь или короста, выделения, зуд, острая боль или ожог, делайте следующее:

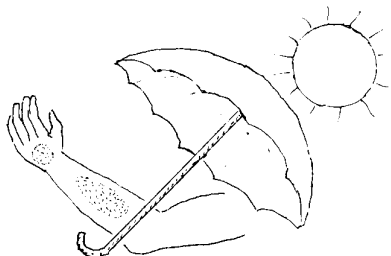
- ◆ Положите тряпочку, намоченную в прохладной воде с белым уксусом (2 ч. ложки уксуса на 1 четверть чистой кипяченой воды).
- ◆ Когда пораженному месту станет лучше и не будет больше выделений и образуется новая нежная кожа, легко наложите смесь из талька и воды (1 часть талька и 1 часть воды).

Когда начали лечение и новая кожа начинает утолщаться или покрываться новым слоем, натрите немного растительным маслом или маслом для тела, чтобы смягчить ее.



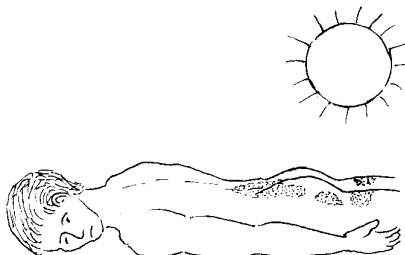
Правило №3

Если пораженное место кожи на теле часто подвергается воздействию солнца, защищайте его от солнца.



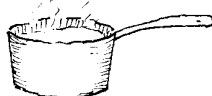
Правило №4

Если пораженное место на коже обычно покрыто одеждой, обнажите его на солнце на 10-20 мин. 2 - 3 раза в день.

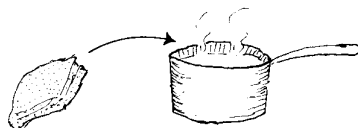


Инструкции по Применению Горячих Компрессов (Горячие Примочки)

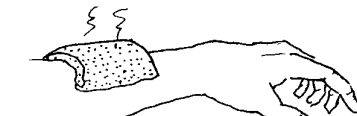
1. Прокипятите воду и остудите ее, пока можно будет держать палец в ней.



2. Сложите чистую тряпочку так, чтобы она слегка была больше, чем место, которое вы хотите лечить, намочите тряпочку в горячей воде и выжмите лишнюю воду.



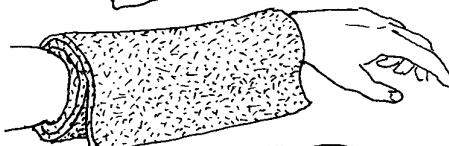
3. Положите тряпочку на пораженную кожу.



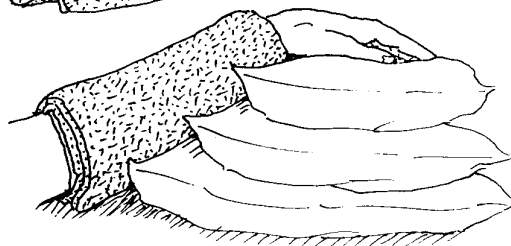
4. Накройте тряпочку тонкой полоской пластика или целлофана.



5. Заверните полотенцем и держите в тепле.



6. Держите пораженную часть приподнятой.



7. Когда тряпочка начнет остывать, положите снова в горячую воду и повторите все.

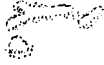
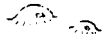
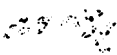
БОЛЕЗНИ КОЖИ (РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ)

ЕСЛИ НА КОЖЕ:	И ВЫГЛЯДЯТ ТАК	У ВАС МОЖЕТ БЫТЬ	см. с.
	Крошечные бугорки или раны с сильным зудом сначала между пальцами, на запястьях или на талии.	чесотка	199
маленькие как угри ранки	Угри или раны с гноем или воспаленные от расчесывания укуса насекомых. Могут опухать лимфатические узлы.	бактериальная инфекция	201
	Нерегулярные, распространяющиеся раны с блестящей, желтой коркой.	импетиго (бактериальная инфекция)	202
	Юношеские угри на лицах, иногда на груди, спине, часто с головками гноя.	прыщи, угри, папулы	211
	Раны на гениталиях без зуда или боли	сифилис, венерическая лимфогранулема	237 238
	с болью и гноем.	мягкий шанкр	403
	Большая хроническая (неизлечимая) рана, окруженная лиловой кожей - на или около лодыжек у пожилых людей с варикозом вен.	язвы от плохой циркуляции (возможно диабет)	213 127
большие открытые раны или язвы на коже	Раны вокруг костей или суставов очень больных людей, которые не могут встать с кровати	пролежни	214
	Раны с потерей чувствительности на ногах или руках. (Они не болят, даже при уколе иглой).	проказа	191
	Опухоли или раны, которые не лечатся везде на теле или на лице	лейшманиоз	406
	Теплая болезненная опухоль, которая иногда вскрывается.	абсцесс или фурункул	202
опухоли под кожей	Теплая болезненная шишка в груди женщины, кормящей грудью	мастит (инфекция от бактерии), возможно рак	278 279
	Опухоль, которая продолжает расти, обычно сначала не болит.	рак (также смотри лимфоузлы)	279 88
	Одна или больше круглых шишек на голове, шее или верхней части тела (или в середине тела или на бедрах).	речная слепота (см. лимфоузлы)	227 88

БОЛЕЗНИ КОЖИ (РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ)

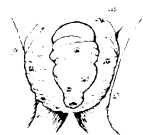
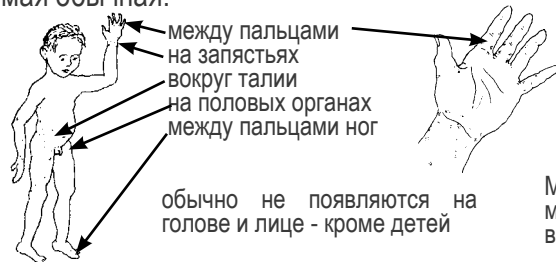
ЕСЛИ НА КОЖЕ:	И ВЫГЛЯДЯТ ТАК	У ВАС МОЖЕТ БЫТЬ	см. с.
опухшие лимфоузлы	Узлы на стороне шеи, которые постоянно лопаются и рубцуются.	скрофула (тип туберкулеза)	212
	Узлы в паху, которые постоянно лопаются и рубцуются.	венерическая лимфогранулема мягкий шанкр	238 403
большие пятна или бляшки	Темные пятна на лбу и щеках беременных женщин.	маска беременности	207
темные	Чешуйчатые места с трещинами, которые выглядят как солнечные ожоги на руках, ногах, шее или лице.	пеллагра (тип истощения)	208 209
	Пурпурные пятна или текущие раны у детей с опухшим животом.	истощение	208 209
	Круглые или неправильной формы пятна на лице или на теле, особенно у детей.	опоясывающий лишай (грибковая инфекция)	206
белые	Белые пятна, особенно на руках, ногах, на губах.	пинта (инфекция)	207
	Красноватые пятна или с волдырями на щеках или позади колен и локтей маленьких детей.	витилиго (потеря цвета, ничего больше)	207
	Красноватые горячие болезненные раны, пятна, которые быстро распространяются.	экзема	216
красноватые или серые	Покраснение кожи между ногами у ребенка.	рожа (воспаления или очень опасная бактериальная инфекция) потница и сыпь от мочи	212 215
	Мясисто-красные пятна с белым молочным творогом в складках кожи.	монилиоз (дрожжевая инфекция)	242
	Припухшие красноватые или серые пятна с серебристой чешуей; особенно на локтях и коленях; хронические (долговременные).	псориаз (или иногда туберкулез)	216 212

БОЛЕЗНИ КОЖИ (РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ)

ЕСЛИ НА КОЖЕ:	И ВЫГЛЯДЯТ ТАК	У ВАС МОЖЕТ БЫТЬ	СМ. С.
	Простые бородавки, не очень большие. 	обычные бородавки (вирусная инфекция)	210
бородавки 	Похожие на бородавки наросты на пенисе, влагалище или вокруг заднего прохода. 	бородавки на половых органах	402
	Большие бородавки (больше 1 см) часто на руках или ногах. 	разновидность туберкулеза кожи	212
	Маленькие кольца, которые разрастаются или распространяются и могут чесаться. 	стригущий лишай (грибковая инфекция)	208
круги (места с приподнятыми или красными краями, чаще чистые в центре) 	Большие круги с утолщенной границей, которые не чешутся. 	запущенная стадия сифилиса	237
	Большие круги, которые немеют в центре. (Укол иглой в них не вызывает боли). 	проказа	191
	Маленькие круги, иногда с маленькой ямкой в середине, расположенные на висках, на носу или на шее. 	рак кожи	211
рубцы или крапивница 	Сильно зудящая сыпь, шишки или бляшки (могут внезапно появляться и исчезать). 	аллергическая реакция	203
	Волдыри с шишками и с сильным зудом и выделениями (сочащиеся). 	контактный дерматит (похож на ожоги листьями плюща или сумаха)	204
волдыри 	Маленькие волдыри по всему телу с невысокой температурой. 	ветряная оспа	311
	Пятно с болезненными волдырями только на одной части тела, чаще половой или грудью. 	опоясывающий герпес (лишай опоясывающий)	204
	Серое или черное плохо пахнущее увеличивающееся пятно с волдырями и с воздушными карманами. 	газовая гангрена (очень серьезная бактериальная инфекция)	213
маленькие красноватые пятна или сыпь по всему телу; жар 	Высыпание по всему телу очень больного ребенка. 	корь	311
	После нескольких дней температуры на теле появляются несколько маленьких розоватых пятен; человек сильно болеет.	брюшной тиф	188

ЧЕСОТКА (СЕМИЛЕТНИЙ ЗУД)

Чесотка особенно распространена среди детей. Она вызывает сильно зудящие маленькие шишки, которые могут появиться по всему телу, но она самая обычная:



Маленькие зудящие ранки на пенисе и мошонке маленьких мальчиков – это почти всегда чесотка.

Чесотку вызывают маленькие животные – похожие на крошечных клещей или тропических блох – которые прокладывают ходы под кожей. Передается болезнь при контакте с зараженной кожей или одеждой или через постельное белье. Царапины могут вызвать инфекцию, раны с гноем и иногда опухшие лимфатические узлы или лихорадку.

Лечение:

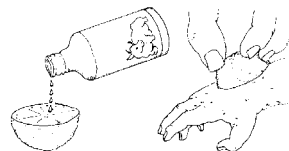
- ◆ Если у человека чесотка, все в семье должны лечиться.
- ◆ Индивидуальная чистота - первое важное условие. Купание и смена одежды ежедневно.
- ◆ Подрезайте ногти очень коротко, чтобы уменьшить возможность распространения инфекции.
- ◆ Стирайте всю одежду и постельное белье или еще лучше кипятите его и вешайте на солнце.
- ◆ Сделайте следующую мазь из линдана (гексахлорид гамма бензола, с. 373) и вазелина (нефтяное желе, с. 371). Во многих странах линдан продается как жидкость для овец и скота.

Энергично мойте мылом и горячей водой все тело.

Нагрейте 15 частей вазелина (или масла для тела) и хорошо смешайте с 1 частью линдана. Смажьте этой мазью все тело (кроме лица - пока оно не поражено). Оставьте на 1 день, а затем хорошо искупайтесь.

После лечения наденьте чистую одежду и постелите чистое постельное белье. Повторите лечение спустя 1 неделю.

- ◆ Вместо этой мази вы можете капнуть 4 капли линдана на половинку лимона. Оставьте на 5 минут, а затем протрите лимоном все тело, кроме лица, начиная с наиболее сильно пораженных мест.



Примечание: Линдан поступает в торговлю в виде мазей или растворов (Квел, Гаммексан, с. 373), но они очень дорогие.

Осторожно: Линдан может вызвать отравление, если пользоваться им очень часто. Не применяйте его больше одного раза в неделю и купайтесь хорошо в этот день после лечения. Не используйте линдан для детей до 1 года. См. на следующей с. безопасное лечение.

- ◆ Порошок серы, смешанный с жиром или маслом для тела, – 1 часть серы на 10 частей жира или масла. Применяйте для всего тела (кроме лица) 3 раза в день в течение 3 дней.

- ◆ Примочки из бензойного бензила (см. с. 373).
- ◆ Кротамитон (Эу-
ракс, с. 373).

ВШИ



Есть три вида вшей: головные, платяные и лобковые (или “крабы”), которые живут в волосистых частях тела. Вши вызывают зуд и иногда инфекцию кожи и опухоль лимфоузлов. Чтобы избежать вшей, внимательно следите за личной гигиеной. Стирайте одежду и постельное белье чаще и вешайте сушиться на солнце. Часто купайтесь и мойте голову. Проверяйте волосы у детей. Если есть вши, лечите их сразу. Не разрешайте ребенку со вшами спать с другими.

Лечение:

От головных и лобковых вшей: Вы всегда можете избавиться от вшей без лекарства мытьем волос обычным мылом или шампунем в течение 10 минут. Хорошо прополаскивайте и тщательно расчесывайте густой расческой. Делайте ежедневно в течение 10 дней.



- ◆ Если необходимо, сделайте шампунь из линдана (с. 373), воды и мыла (1 часть линдана и 10 частей воды). Вымойте волосы, будьте осторожны (чтобы мазь не попала в глаза). Оставьте шампунь на 10 минут, затем прополощите хорошо чистой водой. Повторите спустя неделю. Медпрепараты, содержащие пиретрин с пиперонилом (RID), тоже действуют хорошо от вшей и безопаснее (см. с. 373).
- ◆ Чтобы избавиться от гнид (яйца вшей), намочите волосы теплой уксусной водой (1 часть уксуса к 1 части воды) на полчаса, затем вычесывайте их тщательно густой расческой.

От платяных вшей: Мочите все тело в ванне с горячей водой каждый день в течение 10 дней. После каждой ванны промойте мылом тщательно все тело и сполоснитесь хорошо. Пользуйтесь густой расческой на любое волосистое место. Если необходимо, лечитесь так же, как от чесотки. Держите в чистоте одежду и постельное белье.

КЛОПЫ



Это очень маленькие, плоские, ползущие насекомые, которые прячутся внутри матраца, в постельном белье, мебели и стене. Они обычно кусают ночью.

Чтобы избавиться от клопов, стирайте постельное белье и обливайте кипятком койки и кровати. Сбрызните серой матрац, мебельную обивку и коврики и не пользуйтесь ими в течение 3 дней. Убедитесь, что вы хорошо очистили все от порошка, прежде чем начнете пользоваться снова.

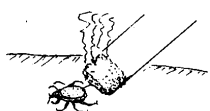
Чтобы предупредить клопов, чаще проветривайте на солнце матрацы, кровати, постельное белье.

КЛЕЩИ И ТРОПИЧЕСКИЕ БЛОХИ

Некоторые опасные инфекции или паралич распространяются укусами клещей. Но осторожное удаление в течение нескольких часов обычно предупреждает эти проблемы. Поэтому проверьте все тело хорошо после того, как вы погуляли в месте, где клещи обычно водятся.

Когда вы удалите клеща, который крепко присасывается, обратите внимание на голову, чтобы она не осталась в коже. Никогда не тяните тело клеща. Удаляйте клеща.

- ◆ Пинцетом схватите клеща поближе к его рту - часть, которая впиивается в кожу. (Старайтесь не давить на опухший живот). Вытягивайте клеща осторожно, но держите крепко. Не трогайте удаленного клеща. Сожгите его.
- ◆ Или прижгите его сигаретой. Или капните на него немного спирта.



Чтобы удалить очень маленьких клещей или блох, пользуйтесь одним из домашних лекарств, которые рекомендуют от чесотки (с. 199). Чтобы облегчить зуд или боль, вызываемые укусом клеща или блохи, примите аспирин и следуйте инструкциям по лечению зуда на с. 203.

Чтобы помочь предупредить от укусов блох или клещей, посыпьте на свое тело порошок серы, прежде чем вы отправитесь в лес или в поле. Особенно присыпьте лодыжки, запястья, талию и подмышки.

Маленькие раны с гноем

Кожные инфекции в форме маленьких ранок с гноем - часто результат расчесывания укусов насекомых, чесотки или маленьких раздражений от грязных ногтей.

Лечение и предупреждение:

- ◆ Хорошо вымойте раны с мылом и прохладной кипяченой водой, осторожно смойте коросту. Делайте это ежедневно до тех пор, пока там не останется гноя.
- ◆ Оставьте маленькие раны открытыми для воздуха. Завяжите крупные раны и чаще меняйте повязки.
- ◆ Если кожа вокруг раны красная и горит или если у больного жар, красные линии идут от раны или опухли лимфоузлы, пользуйтесь антибиотиками - такими как таблетки пенициллина (с. 351) или таблетки сульфамидов (с. 358).
- ◆ Не расчесывайте. Это ухудшает ранки и может распространять инфекцию к другим частям тела. Обрежьте ногти маленьким детям очень коротко. Или наденьте перчатки или носки на руки, чтобы они не могли чесаться.
- ◆ Никогда не разрешайте ребенку с ранами или любой кожной инфекцией играть или спать с другими детьми. Эти инфекции легко передаются.



ИМПЕТИГО

Это болезнь от инфекции бактерий, которые вызывают быстрое распространение ран маленькими светящимися желтыми коростами. Часто она бывает на лицах детей, особенно около рта, импетиго легко распространяется на других людей от ран или загрязненных пальцев.



Лечение:

- ◆ Мойте пораженные части мылом и прохладной кипяченой водой 3 - 4 раза каждый день, осторожно смывая корки.
- ◆ После каждого умывания намажьте раны горечавкой фиолетовой (с. 371) или кремом из антибиотика, содержащего бацитрацин, такой как Полиспорин (с. 371).
- ◆ Если инфекция распространяется на большую площадь или вызывает жар, дайте таблетки пенициллина (с. 351) или диклоксациллина (с. 351). Если у больного аллергия на пенициллин или кажется, что эти лекарства не помогают, дайте эритромицин (с. 355) или ко-тримоксазол (с. 358).

Предупреждение:

- ◆ Следуйте правилам личной гигиены (с. 133). Купайте детей ежедневно и защищайте их от клопов и укусов насекомых. Если у ребенка чесотка, лечите его как можно быстрее.
- ◆ Не разрешайте детям с импетиго спать или играть с другими детьми. Начинайте лечение при первом признаке.

ФУРУНКУЛЫ И АБСЦЕССЫ

Фурункул, или абсцесс, – инфекция, которая образует мешочек гноя под кожей. Это может случиться, когда в корни волос попадает инфекция. Или это может быть результатом от укола раны или инъекции, сделанной грязной иглой. Фурункул очень болезненный и кожа вокруг становится красной и горит. Он может вызвать опухоль лимфоузлов и жар.



Лечение:

- ◆ Положите горячий компресс на фурункул несколько раз в день (см. с. 198).
- ◆ Дайте фурункулу прорваться самому. Когда он прорвется, продолжайте применять горячий компресс. Пусть гной высохнет, но никогда не давите и не прижимайте фурункул, потому что это может вызвать инфекцию, распространить к другим частям тела.
- ◆ Если абсцесс очень болезненный и не вскрывается 2 - 3 дня после горячих примочек, можно вскрыть его, чтобы очистить от гноя. Это быстро уменьшит боль. Если возможно, вызовите медпомощь.

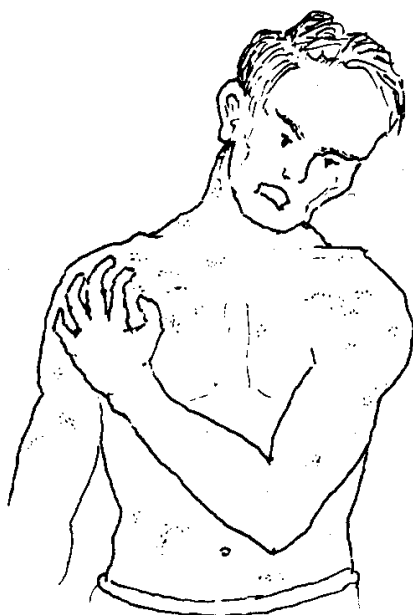
Если фурункул вызывает опухоль узлов или температуру, примите пенициллин в таблетках (с. 351) или эритромицин (с. 355).

ЗУДЯЩАЯ СЫПЬ, ВОЛДЫРИ ИЛИ КРАПИВНИЦА (АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ)

Прикасание, еда, инъекции и вдыхание определенных вещей могут вызвать зудящую сыпь или крапивницу у больных аллергией. Чтобы узнать подробнее, см. Аллергические Реакции с. 166.

Крапивница – это толстые опухшие места или шишки, которые выглядят как укусы пчел и очень сильно зудят. Они могут появиться и быстро исчезнуть или перемещаться от одного места к другому.

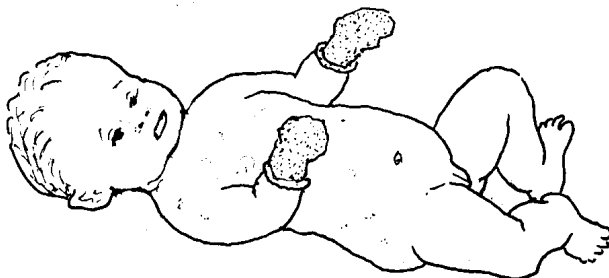
Следите за любой реакцией, которую вызывают определенные лекарства, особенно инъекции пенициллина и противоядия или антитоксин, сделанный из вакцины лошади. Сыпь или крапивница может появиться от нескольких минут до 10 дней после укола.



Если у вас зуд от сыпи, крапивницы или любая другая аллергическая реакция после приема или инъекции любого лекарства, прекратите его прием и никогда не употребляйте этого лекарства снова в вашей жизни!
Это очень важно, чтобы предупредить опасность АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ШОКА (см. с. 70).

Лечение от зуда:

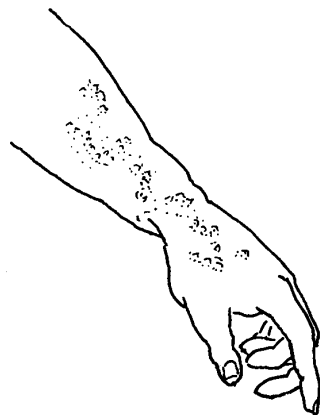
- ◆ Искупайтесь в прохладной воде или сделайте прохладный компресс – ткань, намоченная в холодной или ледяной воде.
- ◆ Компрессы из прохладной овсяной воды также успокаивают зуд. Прокипятите овес в воде, процедите и применяйте воду, когда она охладится. (Крахмал можно использовать вместо овса).
- ◆ Если зуд сильный, примите антигистамин типа хлорфенирамина (с. 387).
- ◆ Чтобы защитить ребенка от того, чтобы не расчесывать себя, подрежьте ему ногти очень коротко или оденьте перчатки или носки на руки.



РАСТЕНИЯ И ДРУГИЕ ВЕЩИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЗУД И ОЖОГИ КОЖИ

Крапива, “жгучие деревья”, сумах, ядовитый плющ и многие другие растения могут вызвать волдыри, ожоги или крапивницу с зудом, когда они дотрагиваются до кожи. Соки или волосики определенных гусениц и других насекомых вызывают подобные реакции.

У людей с аллергией сыпь или “плачущие раны” могут быть вызваны определенными вещами, которые дотрагиваются до кожи или попадают на нее. Резиновая обувь, ремешок от часов, капли в ухо и другие лекарства, кремы на лицо, духи или мыло могут вызвать такие проблемы.



Лечение:

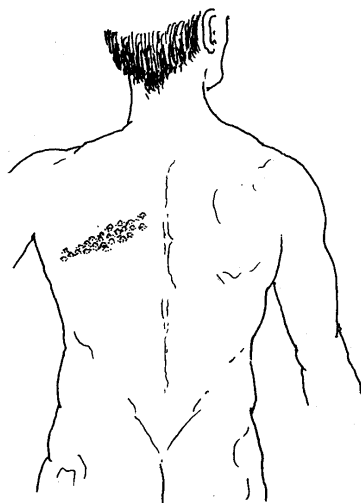
Все эти раздражительные признаки проходят сами по себе, когда вещи, которые вызывают их, не дотрагиваются больше до кожи. Пастообразная мазь из овса и прохладная вода помогают успокоить зуд. Аспирин или антигистамин (с. 386) могут тоже помочь. В тяжелых случаях вы можете пользоваться кремом, который содержит кортизон или кортикостероиды (см. с. 371). Чтобы предупредить инфекции, всегда держите в чистоте раздраженные места.

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ (ГЕРПЕС ОПОЯСЫВАЮЩИЙ)

Признаки:

Линия или заплатка (пятно) болезненных волдырей, которые вдруг появляются на одной стороне тела - это, возможно, опоясывающий лишай. Обычно он бывает на спине, груди, шее, лице. Волдыри обычно держатся 2 или 3 недели, затем проходят сами по себе. Иногда боль продолжается долгое время или после того, как прошли волдыри, возвращается.

Опоясывающий лишай вызывают вирусы, которые вызывают ветряную оспу и обычно действуют на людей, у которых уже была ветрянка. (Однако, иногда это бывает предупреждающим знаком какой-нибудь другой более серьезной болезни - может быть рака или СПИДа, с. 399).



Лечение:

- ◆ Наложите легкую повязку на сыпь так, чтобы одежда не натирала ее.
- ◆ Примите аспирин от боли (антибиотики не помогают).

СТРИГУЩИЙ И ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАИ (ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ)

Грибковые инфекции могут появиться на любой части тела, но чаще проявляются на:

черепе
(опоясывающий лишай)

безволосых частях
(стригущий лишай)

между пальцами рук
и ног (ноги атлета)

между ногами
(зуд в паху)



Многие грибковые инфекции растут в форме кольца. Они часто чешутся. Стригущий лишай на голове может вызвать круглые бляшки с шелушением и потерей волос. Пальцы рук и ног, пораженные грибом, становятся грубыми и толстыми.

Лечение:

- ◆ Мыло и вода. Мыть инфекционную часть каждый день мылом, водой. Может быть это и все, что нужно.
- ◆ Делайте все возможное, чтобы пораженные места были сухими и доступными для воздуха и солнца. Чаще меняйте белье, носки, особенно если потеете.
- ◆ Пользуйтесь кремом из серы и смальца (1 часть серы на 10 частей смальца).
- ◆ Кремы и пудры с салициловой или ундециленовой кислотой или толнафтат (Тинактин, с. 372) помогают вылечить грибок между пальцами ног и рук, и в паху.
- ◆ При сильном распространении опоясывающего лишая или любой грибковой инфекции, которые не улучшаются после лечения, примите гризеофульвин 1 г в день для взрослых и 0,5 г. для детей (с. 372). Возможно, необходимо принимать его в течение недель или даже месяцев, чтобы полностью остановить инфекцию.
- ◆ Многие виды опоясывающего лишая на голове (скальпе) исчезают, когда дети достигают половой зрелости (11-14 лет). Сильные инфекции, которые образуют большие опухшие пятна с гноем, должны лечиться компрессами теплой воды (с. 195). Важно убрать все волосы с пораженной части. Пользуйтесь гризеофульвином, если возможно.



Как предупредить грибковые инфекции:

Стригущий лишай и другие грибковые инфекции являются *заразными* (легко распространяются). Чтобы предупредить распространение их от одного ребенка к другому:

- ◆ Не разрешайте ребенку с грибковой инфекцией спать с другими.
- ◆ Не разрешайте разным детям пользоваться одной и той же расческой, у каждого должна быть своя одежда, полотенце, пока они не будут выстираны или сначала очищены.
- ◆ Лечите инфицированного ребенка сразу же.

БЕЛЫЕ ПЯТНА НА ЛИЦЕ И НА ТЕЛЕ

Лишай разноцветный – это умеренная инфекция, маленькие темные пятна или светлые с отчетливой и неправильной границей, которую часто видно на шее, груди или спине. Эти места слегка могут шелушиться, но обычно не чешутся. Они не требуют медицинского вмешательства.



Лечение:

- ◆ Сделайте крем из серы и смальца (1 часть серы на 10 частей смальца) и мажьте все тело каждый день, пока они не исчезнут. Или применяйте антигрибковый крем (с. 372).
- ◆ Тиосульфат натрия действует лучше. Это гипосульфит натрия, который используется фотографами при проявлении пленок. Растворите столовую ложку тиосульфата натрия в стакане воды и смажьте верхнюю часть тела. Затем вытрите кожу кусочком хлопковой ткани, смоченной в уксусе.
- ◆ Чтобы предупредить возникновение новых пятен, необходимо повторять это лечение каждые 2 недели.
- ◆ Сульфид селена (с. 372) или мазь Вайтфилда тоже может помочь.



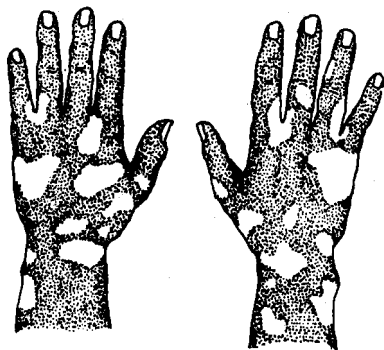
Есть еще другой вид **маленьких беловатых пятен**, обычно бывает у темнокожих детей, которые проводят много времени на солнце. Граница заметна меньше, чем при разноцветном опоясывающем лишае. Эти пятна не инфекционные и не очень требуют лечения. Обычно они проходят сами, когда ребенок подрастает. Избегайте грубого мыла и употребляйте масло. Не требует никакого лечения.

В противовес популярному мнению, ни один из типов белых пятен не является признаком анемии. Они не проходят от тоника или витаминов. Пятна на щеках не требуют лечения.

Осторожно: Иногда бледные пятна бывают признаком **проказы** (см. с. 191), прокаженные пятна никогда не бывают полностью белыми и у них **нет чувствительности**, когда их уколешь иголкой. Если проказа – распространенная болезнь в вашей местности, проверяйте детей.

Витилиго (Белые Участки Кожи)

У некоторых людей определенные места на коже теряют свой естественный цвет (пигмент). Потом появляются белые пятна, обычно на руках, ногах, лице и верхней части тела. Эта потеря цвета кожи - называется витилиго - это не болезнь. Это можно сравнить с белыми волосами у пожилых людей. Никакое лекарство не помогает и не требуется, но белая кожа должна защищаться от солнечного ожога одеждой или мазью из оксида цинка. И еще можно помочь особым цветным кремом, замазать светлые места, чтобы они не были так заметны.



Другие Причины Белых Кожных Пятен

Определенные болезни могут вызвать белые пятна, которые выглядят как витилиго. В Латинской Америке встречается инфекционная болезнь, называемая пинта, она начинается синеватыми или красноватыми прыщами и позже оставляет бледные или белые пятна.

Лечение **пинты** – это 2.4 миллиона единиц бензатина пенициллина инъекции в ягодицы (1.2 миллиона единиц на каждую ягодицу). Для больного с аллергией на пенициллин дайте тетрациклин или эритромицин 50 мг 4 раза в день в течение 15 дней.

Некоторые грибковые инфекции могут вызвать беловатые пятна (см. разноцветный лишай, на противоположной странице).

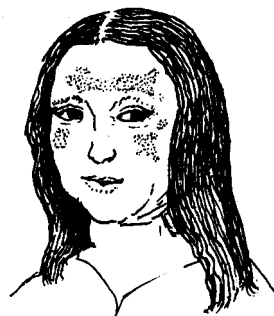


Общая или пятнистая, частичная потеря цвета кожи и волос у детей. Причиной этого может быть сильное истощение (квашиоркор, с. 113 или пеллагра, с. 114).

МАСКА БЕРЕМЕННОСТИ

Во время беременности у многих женщин появляются темные оливкового цвета места на коже лица, груди и внизу середины живота. Иногда они исчезают при рождении ребенка, иногда нет. Эти пятна еще иногда появляются у женщин, которые принимают пилюли от предупреждения беременности.

Они абсолютно нормальное явление и не указывают на слабость и болезнь. Никакого лечения не требуется.

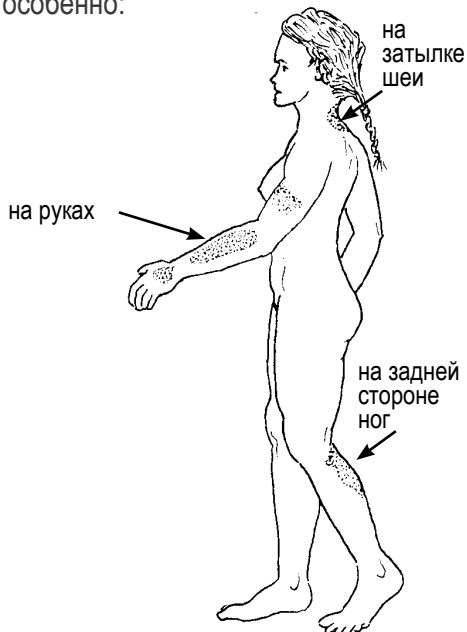


Пеллагра и другие кожные болезни из-за недоедания

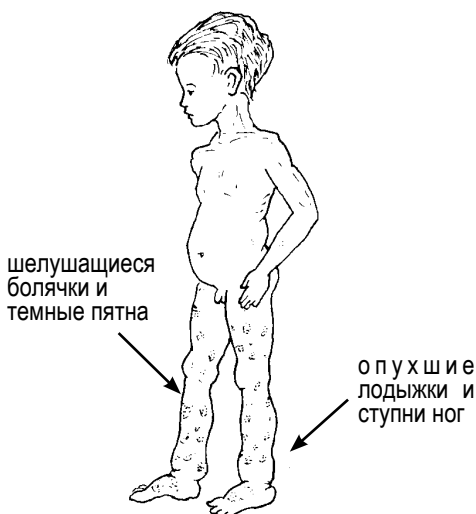
Пеллагра – это форма истощения, которая действует на кожу, а иногда на пищеварительную нервную систему. Она обычна в местах, где люди питаются маисом (кукурузой) или другой крахмальной пищей и недостаточно бобами, мясом, рыбой, яйцами, овощами или другими продуктами для строения тела и защитной пищей (с. 110).

Признаки истощения на коже (смотри рисунки на следующей странице):

У взрослых с пеллагрой кожа сухая и в трещинах: она шелушится как при солнечных ожогах в тех местах, где на нее попадает солнце, особенно:



У детей с недоеданием кожа на (а иногда на руках) имеет темные пятна, похожие на синяки, или даже шелушащиеся болячки; лодыжки и ступни могут опухать (см. с. 113).



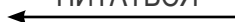
Когда эти признаки присутствуют, часто бывают и другие признаки недоедания: опухший живот, трещинки в углу рта, красный воспаленный язык, слабость, потеря аппетита, потеря веса и т.д. (см. Главу 11, с. 112 и 113).

Лечение:

- ◆ Употребление питательных продуктов вылечивает пеллагру. Каждый день больному нужно стараться есть бобы, арахис или немного цыплят, рыбу, яйца, мясо или сыр. Когда у вас есть выбор лучше ешьте пшеницу, (предпочтительно злак - целую пшеницу) вместо маиса (кукурузы).
- ◆ От тяжелой формы пеллагры и других форм недоедания могут помочь витамины, но хорошее питание важнее. Убедитесь, что те продукты, которыми вы пользуетесь, богаты витаминами В, особенно ниацином. Дрожжи Бревера хороший источник витаминов В.



ПЕРЕД ТЕМ, КАК
ОН СТАЛ ХОРОШО
ПИТАТЬСЯ



И ПОСЛЕ



Опухшие и темные пятна на ногах мальчика и ступнях - результат плохого питания. Он ел в основном маис (кукурузу) без другой пищи, богатой протеином и витаминами.

Через неделю после того, как он стал питаться бобами, яйцами с маисом, опухоли прошли и почти полностью исчезли пятна.



“Ожоговая” кожа на ногах этой женщины является признаком пеллагры – результат плохого питания (см. с. 208).



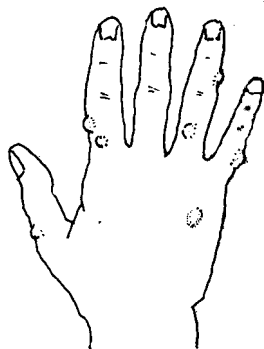
Белые пятна на ногах этой женщины вызваны инфекционной болезнью, которую называют пинта (см. с. 207).

НАРОСТЫ (БОРОДАВКИ)

Большинство наростов, особенно у детей, продолжают с 3 до 5 лет и проходят сами. Плоские, болезненные похожие на бородавки места на подошве ног - это часто подошвенные бородавки (или это могут быть мозоли, см. внизу).

Лечение:

- ◆ Магическое или домашнее лечение часто избавляет от бородавок. Но безопаснее не употреблять сильную кислоту или ядовитые растения, т.к. они могут вызвать ожоги или раны гораздо хуже, чем бородавки.
- ◆ Болезненные подошвенные бородавки может удалить работник здравоохранения.
- ◆ От бородавок на пенисе или влагалище см. с. 402.



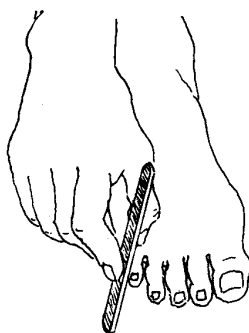
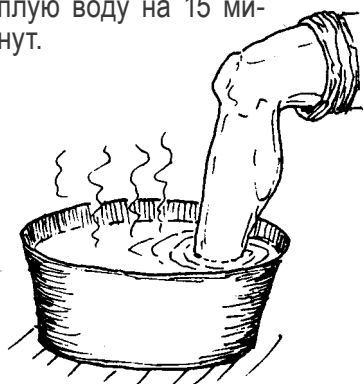
МОЗОЛИ

Мозоль – это твердая толстая часть кожи. Он образуется там, где сандалии или обувь натирают кожу или один палец давит на другой. Мозоли могут быть очень болезненные.

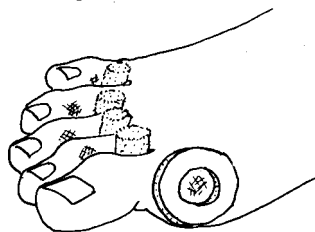
Лечение:

- ◆ Одевайте сандалии или туфли, которые не давят на мозоли.
- ◆ Чтобы меньше болели мозоли, сделайте это:

1. Опустите ноги в теплую воду на 15 минут.
2. Пилкой или рашпилем сточите мозоль, пока она не станет тоньше.



3. Положите что-либо мягкое на ногу вокруг мозоли так, чтобы обувь не давила, или на другой палец ноги. Заверните ногу или палец ноги в мягкую ткань, чтобы сделать толстую прокладку, и вырежьте дырку вокруг мозоли.

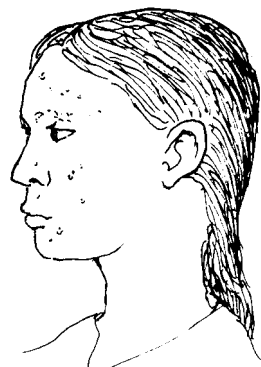


УГРИ И ЧЕРНЫЕ ГОЛОВКИ (ПРЫЩИ)

У молодых людей иногда появляются угри на лице, груди или спине - особенно на их коже, когда она сальная. Угри - это маленькие шишки, которые образуют крошечные белые "головки" гноя или черные головки грязи. Иногда они могут воспалиться и становиться большими.

Лечение:

- ◆ Мойте лицо дважды в день мылом и горячей водой.
- ◆ Мойте волосы каждые 2 дня, если возможно.
- ◆ Солнце помогает очиститься от угрей. Откройтесь солнцу так, чтобы его лучи попадали на пораженные части тела.
- ◆ Питайтесь как можно лучше, пейте много воды и достаточно спите.
- ◆ Не делайте примочек из воска, масла, жира на кожу и волосы.
- ◆ Перед сном положите на лицо маску из смеси спирта и немного серы (10 частей спирта и 1 часть серы).
- ◆ В серьезных случаях образуются шишки и карманы гноя, если не становится лучше от способов, описанных выше, может помочь тетрациклин. Принимайте 1 капсулу в день в течение 3 дней и затем 2 капсулы ежедневно. Может быть, необходимо принимать 1 или 2 капсулы ежедневно в течение нескольких месяцев.



РАК КОЖИ

Рак кожи, чаще бывает у светлокожих людей, которые проводят много времени на солнце. Он обычно появляется в местах, куда солнце попадает особенно сильно:



Рак кожи может принять многие формы. Он обычно начинается с маленького кольца цвета жемчуга с дырочкой в центре. Постепенно оно растет.

Большинство случаев рака кожи не опасны, если их лечить вовремя. Требуется хирургия, чтобы удалить их. Если у вас хроническая рана, которая может быть раком кожи, обратитесь к медработнику.

Чтобы предупредить рак кожи, светлокожие люди должны защищать себя от солнца и всегда носить шляпу. Люди, которые страдают от рака кожи и должны работать на солнце, могут купить особые кремы, которые защищают их. Мазь окиси цинка дешевле и действует лучше.

ТУБЕРКУЛЕЗ КОЖИ И ЛИМФОУЗЛОВ

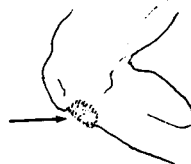
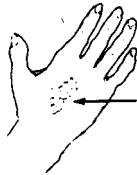
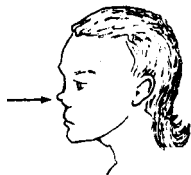
Тот же микроб, который вызывает туберкулез легких, иногда действует на кожу, вызывая безболезненные

опухоли, которые
уродуют,

хронические пятна
ран,

кожные язвы,

или большие
бородавки.

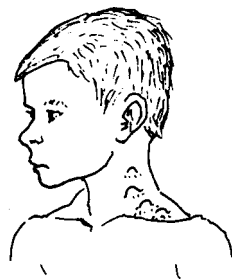


Как правило, туберкулез кожи развивается медленно, продолжается долгое время и появляется снова через месяцы или годы.

Иногда туберкулез также поражает лимфоузлы – в основном чаще на шее или в местах за ключицей между шеей и плечом. Узлы становятся больше, открываются, выделяется гной, закрываются на время, затем открываются и снова появляются выделения. **Обычно они не болят.**

Лечение:

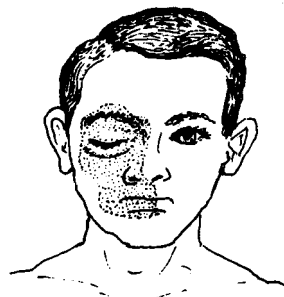
В случае какой-либо хронической раны, язвы или опухших лимфоузлов лучше обратиться за медпомощью. Понадобятся анализы, чтобы узнать причину. Туберкулез кожи лечится так же, как туберкулез легких (см.180). Чтобы предотвратить инфекцию от повторения, лекарства должны приниматься в течение долгих месяцев после того, как кожа станет нормальной.



РОЖА И ЦЕЛЛУЛИТ

Рожа (или огонь святого Антония) очень болезненная острая инфекция на коже. Она вызывает горячую, красную, опухшую заплатку (пятно) с резкой границей. Пятно распространяется быстро по коже. Чаще оно начинается на лице, на краю носа. Это ведет к опухоли лимфоузлов, температуре и простуде.

Целлюлит – это тоже очень болезненная, острая инфекция кожи, которая появляется в любом месте на теле. Обычно она случается после трещины на коже. Инфекция глубоже и границы пятна не так ясны, как при роже.



Лечение:

Как для рожи, так и для целлюлита начинайте лечение как можно быстрее. Пользуйтесь антибиотиками: таблетки пенициллина 400000 единиц 4 раза в день, в серьезных случаях делайте уколы прокаина пенициллина 800000 единиц ежедневно (см. с. 353). Продолжайте применение антибиотика в течение 2 дней после того, как исчезнут признаки инфекции. И еще делайте горячие компрессы – и принимайте аспирин от боли.

ГАНГРЕНА (ГАЗОВАЯ ГАНГРЕНА)

Это очень опасная инфекция раны, в которой образуется серая вонючая или коричневая жидкость. Кожа вокруг раны может иметь темные волдыри и на плоти могут появиться воздушные пузыри. Инфекция начинается между 6 часами и 3 днями после травмы. Без лечения вызывает смерть через несколько дней.



Лечение:

- ♦ Вскройте рану так широко, как это возможно. Вымойте ее прохладной кипяченой водой и мылом. Очистите и уберите пораженную плоть. Если возможно, промывайте рану перекисью водорода каждые 2 часа.
- ♦ Делайте уколы пенициллина 1000000 (миллион) единиц каждые 3 часа.
- ♦ **Оставьте рану непокрытой так, чтобы воздух попадал на нее. Обратитесь за медицинской помощью.**

ЯЗВЫ КОЖИ ОТ ПЛОХОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Язвы на коже или большие открытые раны имеют много причин (см. с. 20). Но хронические язвы на лодыжках пожилых людей, особенно у женщин с варикозными венами, обычно появляются от плохого кровообращения. Кровь не проходит достаточно быстро через ноги. Такие язвы могут стать очень большими. Кожа вокруг язвы темно-синяя, блещит и очень тонкая. Часто нога опухшая.



Лечение:

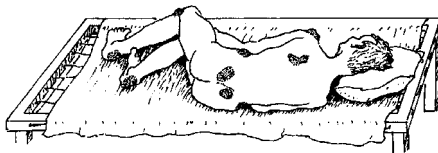
- ♦ Эти язвы заживают очень медленно – и лишь при тщательном уходе. Самое важное держать **ногу вверх** так высоко, как можно. Спите, положив ее на подушку. В течение дня отдыхайте с поднятой ногой каждые 15 или 20 минут. **Ходьба помогает кровообращению, но стоять на одном месте или сидеть с опущенными ногами очень вредно.**
- ♦ Положите теплые компрессы со слабой соленой водой на язву - 1 чайную ложку соли на 1 литр кипяченой воды. Закройте язву легко стерильной марлей или чистой тряпочкой. **Держите ее чистой.**
- ♦ Поддерживайте варикозные вены эластичными чулками или бинтами. Продолжайте пользоваться ими и держите ноги наверху после исцеления язвы. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать или не повредить нежный шрам.
- ♦ Может помочь лечению мед или сахар (см. с. 214).



Предупредите язвы кожи – следите за ранним варикозом вен (см. с. 175).

ПРОЛЕЖНИ (РАНЫ ОТ ДАВЛЕНИЯ)

Эти хронические открытые раны появляются у людей больных настолько, что они не могут переворачиваться в кровати, особенно у очень худых и слабых стариков. Раны образуются на теле около кости, где на кожу давит постельное белье. Они часто видны на ягодицах, спине, плечах, локтях или ногах.



Чтобы получить полную информацию о пролежнях, см. *Искалеченные Деревенские Дети*, Глава 24.

Как предупредить пролежни:

- ◆ Переворачивайте больного каждый час; лицом вверх, лицом вниз; с боку на бок.
- ◆ Купайте больного каждый день и натирайте кожу детским маслом.
- ◆ Пользуйтесь мягкими простынями и подушками. Меняйте их ежедневно и каждый раз, как только постельное белье станет грязным от мочи, стула, рвоты и т.д.
- ◆ Подложите подушки от дивана под больного таким образом, чтобы части тела с костью терлись меньше.



- ◆ Кормите больного как можно лучше. Если он плохо ест, можно давать больше витаминов и железа (см. с. 118).
- ◆ Ребенка, у которого хроническая болезнь, чаще нужно держать матери на руках.

Лечение:

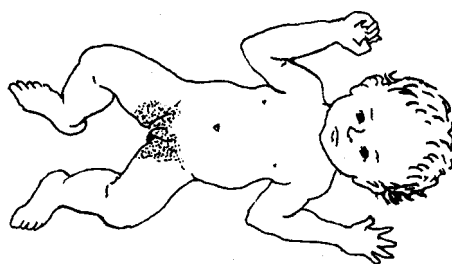
- ◆ Делайте все, о чем упоминалось выше.
- ◆ Раз в день мойте раны прохладной кипяченой водой с мягким мылом. Осторожно уберите любую мертвую плоть. Прополощите хорошо прохладной кипяченой водой.

Чтобы бороться с инфекцией и ускорить исцеление, наполните рану медом, сахаром или черной патокой (паста, приготовленная из меда, сахара, самая легкая для употребления). Важно очистить и наполнять рану, по крайней мере 2 раза в день. Если слой меда или сахара становится слишком тонким от жидкости в ране, значит это кормит микробов больше, чем убивает их.

КОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ У ДЕТЕЙ

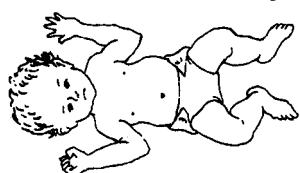
Сыпь от Пеленок

Красноватые пятна раздражения между ножками у ребенка или ягодицами могут быть вызваны мочой в его пеленках (салфетках) или постельном белье.



Лечение:

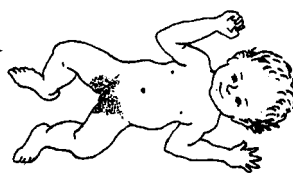
- ◆ Купайте ребенка ежедневно в тепловатой воде, мягким мылом. Вытрите ее тщательно.
- ◆ **Чтобы предупредить или вылечить сыпь, ребенок должен быть голеньким, без пеленок и лучше положить его на солнце.**



← ДА

ГОЛЫШОМ
ЛУЧШЕ ВСЕГО

→ НЕТ



- ◆ Если пеленки использовались, поменяйте их. После стирки пеленок прополощите их в воде, добавьте немного уксуса.
- ◆ Лучше не пользоваться тальком (порошок талька), но если вы делаете это, подождите, пока пройдет сыпь.

Младенческая Кепка (СЕБОРЕЯ, ПЕРХОТЬ)

Младенческая кепка — это маслянисто-желтая корка, которая образуется на голове ребенка. Кожа часто красная и раздраженная. Эта болезнь результат того, что ребенку редко моют голову, или того, что ребенку держат голову покрытой.



Лечение:

- ◆ Мойте голову ребенку ежедневно. Если возможно, пользуйтесь медицинским мылом (см. с. 371). Осторожно очистите от перхоти и корок.
- ◆ Чтобы очистить от корок волосы, сначала заверните голову полотенцем, смоченным в тепловатой воде.
- ◆ Держите голову ребенка **непокрытой**, откройте ее для воздуха и солнечного света.

НЕ ПOKPЫBAЙTE PEБEKY
ГOЛOBY шAПKOЙ ИЛИ ПЛATKOM.
ДEPЖИTE ГOЛOBY HEПOKPЫTOЙ.



← НЕТ

РАЗДЕТОМУ
ЛУЧШЕ

→ ДА



- ◆ Если есть признаки инфекции, лечите ее как импетиго (с. 202).

ЭКЗЕМА (КРАСНЫЕ ПЯТНА С МАЛЕНЬКИМИ ВОЛДЫРЯМИ)

Признаки:

- ◆ У маленьких детей: красные пятна или сыпь образуются на щеках или иногда на руках и ладонях (кистях). Сыпь состоит из маленьких ран или волдырей, которые сочатся, “плачут” (вскрываются и течет жидкость).
- ◆ У старших детей и подростков: экзема обычно суше и самая обычная позади колен и на внутренней стороне локтей.
- ◆ Она не начинается как инфекция, но больше похожа на аллергическую реакцию.



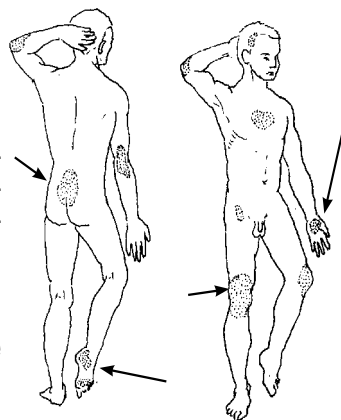
Лечение:

- ◆ Положите холодные компрессы на сыпь.
- ◆ Если развиваются признаки сыпи (с. 88), лечите как от импетиго (с. 202).
- ◆ Пусть солнечные лучи падают на пятна.
- ◆ В трудных случаях применяйте кортизон или кортикостероидный крем (см. с. 371), или угольную смолу (деготь) – тоже может помочь. Обратитесь за медицинским советом.

ПСОРИАЗ

Признаки:

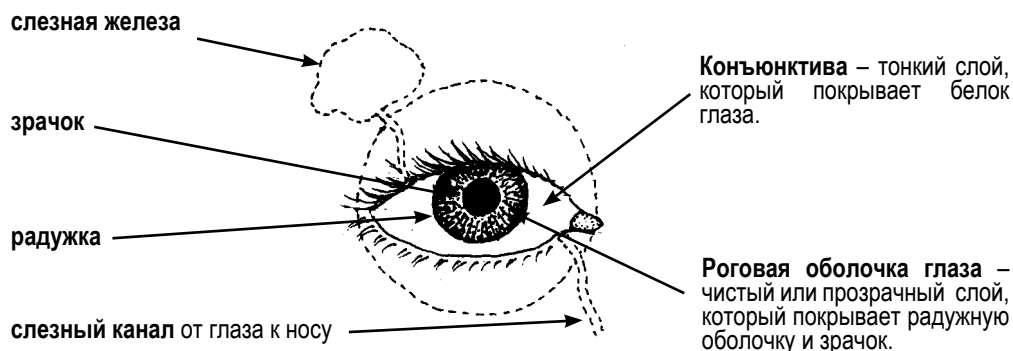
- ◆ Толстые, грубые пятна, красноватая или сине-сероватая кожа, покрытая беловатыми или серебристого цвета чашками. Пятна появляются в основном в местах, показанных на рисунках.
- ◆ Это состояние продолжается долгое время или повторяется снова. Это не инфекция и она не опасна.



Лечение:

- ◆ Помогает часто, когда пораженные участки остаются открытыми для лучей солнца.
- ◆ Иногда помогает купание в океане.

Обратитесь за медицинским советом. Лечение должно проводиться долгое время.



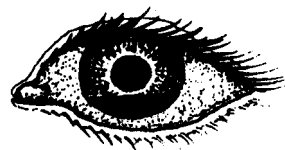
ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ

Глаза очень нежные и требуют хорошего ухода. Обращайтесь срочно за медицинской помощью при появлении любого из следующих опасных признаков:

1. Травма, возникшая при порезе или проколе глазного яблока.
2. Болезненное, сероватое пятно на роговой оболочке с краснотой вокруг роговицы (язва роговой оболочки).
3. Сильная боль внутри глаза (может быть воспаление радужной оболочки глаза или глаукома).
4. Большая разница в размере зрачков при боли в глазу или при головной боли.



Большая разница в размере зрачков может появиться при поражении мозга, ударе, травме глаза, глаукоме или воспалении радужной оболочки. (Маленькая разница нормальна у некоторых людей.)



5. Кровь за роговой оболочкой внутри глазного яблока (см. с. 225).
6. Если зрение падает в одном или обоих глазах.
7. Любая инфекция глаз или воспаление, которые не проходят после 5 или 6 дней лечения антибиотиковой мазью.

ТРАВМЫ ГЛАЗА

Все травмы глазного яблока следует считать опасными, поскольку они могут вызвать слепоту.

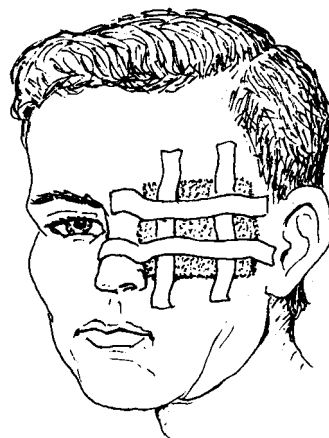
Даже маленькие порезы на **роговице** (прозрачной оболочке, покрывающей зрачок и радужную оболочку) могут вызвать инфекцию и ухудшить зрение при неправильном уходе за ними.

Если рана в глазном яблоке настолько глубокая, что достигает черного слоя под внешним белым слоем, это особенно опасно.

Если резкий удар (например, кулаком) вызывает кровоподтек в глазу, глаз в опасности (см. с. 225). Опасность особенно велика, если боль внезапно усиливается через несколько дней, так как возможна острая глаукома (с. 222).

Лечение:

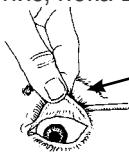
- ◆ Если человек еще видит хорошо поврежденным глазом, положите мазь антибиотика (с. 378) на глаз и накройте мягкой толстой повязкой. Если глазу не становится лучше через день или два, обратитесь за медпомощью.
- ◆ Если больной не может видеть хорошо поврежденным глазом, если рана глубокая или если кровь внутри глаза за роговой оболочкой (с. 225), закройте глаз чистой повязкой и сразу обратитесь за медицинской помощью. **Не давите на глаз.**
- ◆ **Не пытайтесь** убрать колючку или осколок, которые сильно застряли в глазном яблоке. Обратитесь за медицинской помощью.



КАК УДАЛИТЬ СОРИНКУ ИЗ ГЛАЗА

Пусть больной закроет глаза и посмотрит налево, направо, вверх и вниз. Затем, пока вы держите его глаз открытым, заставьте его посмотреть вверх и вниз. Это вызовет слезы и грязь выйдет сама по себе.

Или вы можете удалить кусочек крупинку грязи или песка, промыв глаз чистой водой (с. 219) или используя уголок чистой тряпочки или влажную ватку. Если соринка находится под верхним веком, отыщите ее, отогнув веко на тонкую палочку. Больному нужно смотреть вниз, пока вы делаете это:



Соринку часто находят в маленьком желобке около края века. Удалите ее уголком чистой ткани.

Если вы не можете легко достать соринку, положите мазь антибиотика, накройте глаз повязкой и обратитесь к врачу.

ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ГЛАЗ

Кислоты, щелок, бензин или пестициды, которые попадают в глаз, могут быть очень опасны. Держите глаз открытым, **немедленно промойте его чистой прохладной водой. Промывайте в течение 30 минут** или до тех пор, пока не прекратится жжение. Старайтесь, чтобы эта вода не попала в другой глаз.



КРАСНЫЕ, БОЛЕЗНЕННЫЕ ГЛАЗА – РАЗЛИЧНЫЕ ПРИЧИНЫ

инородное тело (соринка и т.д.) в глазу (с. 218);	обычно действует только на один глаз; краснота и различная боль
ожоги или вредные жидкости (с. 219)	один или оба глаза; краснота и различная боль
“розовый глаз” (конъюнктивит, с. 219) сенная лихорадка (аллергический конъюнктивит, с. 165) трахома (с. 220) корь (с. 311)	обычно обоих глаз (может начинаться и усиливаться в одном) обычно покраснение по внешнему краю “горящая” боль, обычно умеренная
острая глаукома (с. 222) воспаление радужки (с. 221) царапины или язвы на роговой оболочке (с. 224)	обычно только одного глаза ; покраснение ближе к роговице боль часто сильная



Многие проблемы вызывают красные, болезненные глаза. Правильное лечение часто зависит от определения причины, поэтому постарайтесь в каждом случае внимательно проверить все признаки. Эта таблица может помочь вам определить причину:

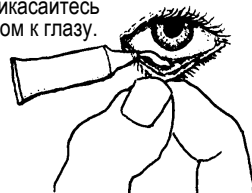
“РОЗОВЫЙ ГЛАЗ” (КОНЪЮНКТИВИТ)

Эта инфекция вызывает красноту, гной и умеренное жжение в одном или обоих глазах. Веки часто слипаются после сна.

Лечение:

Сначала очистите глаза от гноя чистой тряпочкой, смоченной в кипяченой воде. Затем положите мазь из антибиотика (с. 378). Оттяните нижнее веко и положите немного мази внутрь вот так: Нанесение мази с внешней стороны пользы не приносит.

ОСТОРОЖНО:
Не прикасайтесь
тюбиком к глазу.



Предупреждение:

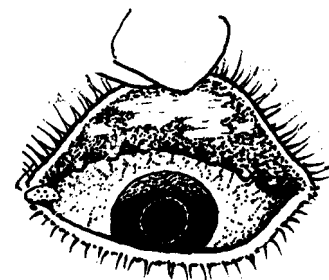
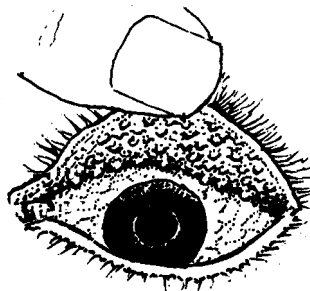
Конъюнктивит очень заразный. Инфекция легко передается от одного человека к другому. Не разрешайте ребенку с розовыми глазами играть или спать с другими или пользоваться одним и тем же полотенцем. Мойте руки после того, как вы трогали глаза.

ТРАХОМА

Трахома – это хроническая инфекция, которая постепенно усиливается. Она может длиться месяцы или многие годы. Если не лечить на ранней стадии, болезнь иногда приводит к слепоте. Она передается прикосновениями или мухами и обычно наиболее распространена там, где люди живут бедно и в тесноте.

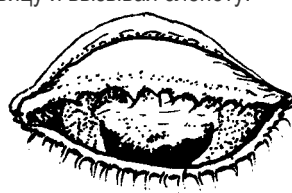
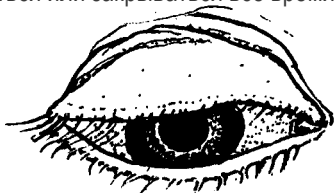
Признаки:

- Трахома начинается с красных, слезящихся глаз как обычный конъюнктивит.
- Через месяц или больше внутри верхнего века образуются маленькие, розовато-серые зерна, называемые фолликулами. Чтобы увидеть их, отверните верхнее веко как показано на с. 218.
- Белок глаза слегка краснеет.
- Через несколько месяцев, если вы внимательно присмотритесь или с увеличительным стеклом, вы обнаружите, что верхний край роговицы выглядит серым, потому что там появились крошечные новые кровяные сосуды (паннус).
- Сочетание фолликулов и паннуса почти всегда означает трахому.
- Через несколько лет фолликулы начинают исчезать, оставляя беловатые рубцы.



Эти рубцы утолщают веки и не дают им открываться или закрываться все время.

Или рубцевание может затягивать ресницы в глаз, царапая роговицу и вызывая слепоту.



Лечение трахомы:

Кладите 1% тетрациклиновую глазную мазь (с. 378) внутрь глаза 3 раза в день или 3% эту мазь 1 раз в день. Делайте это в течение 30 дней. Для полного излечения принимайте также тетрациклин (с. 356) или сульфаниламиды (с. 358) в течение 2 или 3 недель.

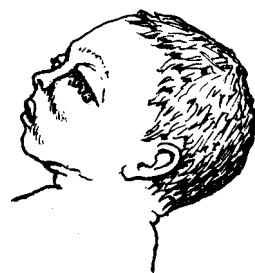
Предупреждение:

Раннее и полное лечение трахомы помогает предупредить распространение болезни. Все люди, живущие с больной трахомой, особенно дети, должны проверять глаза почаще, и если появились признаки болезни, необходимо сразу начинать лечение. Ежедневное умывание помогает предупредить трахому. Еще очень важно соблюдать правила гигиены, приведенные в Главе 12.

Чистота помогает предупредить трахому.

ИНФИЦИРОВАННЫЕ ГЛАЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ (ПОСЛЕРОДОВОЙ КОНЪЮНКТИВИТ)

Если у новорожденного ребенка в первые 2 дня жизни глаза краснеют, опухают и в них много гноя, это может быть **гонорея** (с. 236). Ее нужно лечить сразу, чтобы ребенок не ослеп. Если инфекция глаза начинается между 1 и 3 неделями после рождения, у ребенка может быть **хламида**. Ребенок заразился одной или двумя этими болезнями от матери при родах.



Лечение гонореи:

- Сделайте один укол от 50 до 70 мг канамицина (см. с. 359). Иногда помогает пенициллин: вводите по 200000 ЕД кристаллического пенициллина дважды в день в течение 3 дней. Или попытайтесь неделю давать по половинке чайной ложки сиропа ко-тримоксазола 2 раза в день (см. с. 358). (Если это доступно, то одна инъекция 125 мг цефтриаксона – самое лучшее лечение.)
- Пользуйтесь также мазью тетрациклина: кладите немного в глаз ребенка каждый час в первый день и затем 3 раза в день в течение 2 недель. (Сначала очистите от гноя, как описано на с. 219.)

Лечение хламиды: Лечите глазной тетрациклиновой мазью как описано выше. Давайте еще и сироп эритромицина по 30 мг 4 раза в день в течение 2 недель. (Это будет лечением от пневмонии, которая часто поражает детей с хламидой.)

Предупреждение:

У всех детей глаза должны быть защищены от гонореи и хламиды, особенно глаза детей, у которых матери болеют этими болезнями или отцы страдают от болей при мочеиспускании. (У матерей может быть гонорея или хламиды, а они не знают об этом.)

Закапайте по одной капле 1% раствора нитрата серебра только один раз в каждый глаз при рождении. Или положите немного 1% тетрациклиновой глазной мази, или 5% глазной мази эритромицина в каждый глаз после рождения (см. с. 379).

Если у ребенка развивается гонорея или хламиды глаз, оба родителя должны лечиться от этих инфекций (с. 236).

ИРИТ (ВОСПАЛЕНИЕ РАДУЖКИ)

нормальный глаз



глаз с иритом



ПРИЗНАКИ:

зрачок маленький, часто некруглый
краснота вокруг радужной оболочки
сильная боль

Воспаление радужной оболочки обычно возникает только в одном глазу. Боль может начинаться внезапно или постепенно. Глаз течет сильно. Боль усиливается при ярком свете. Глазное яблоко болит, когда дотрагиваетесь. Но не бывает гноя как при конъюнктивите. Зрение обычно расплывчатое.

Нужна срочная помощь. Мази из антибиотиков не помогают. **Обращайтесь к врачу.**

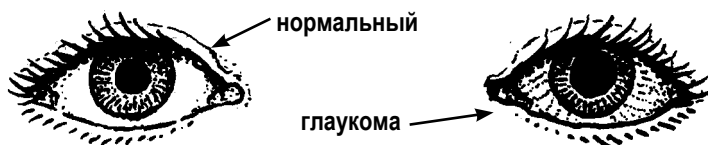
ГЛАУКОМА

Эта опасная болезнь – результат повышенного внутриглазного давления. Обычно начинается в возрасте 40 лет и является причиной слепоты. **Чтобы предупредить слепоту, важно распознать признаки глаукомы и быстро получить медицинскую помощь.**

Есть две формы глаукомы.

ОСТРАЯ ГЛАУКОМА

Она начинается внезапно с головной боли или сильной боли в глазу. Глаз становится красным, зрение расплывчатым. Глазное яблоко твердое при прикосновении, как мрамор. Может быть рвота. Зрачок больного глаза больше зрачка здорового глаза.

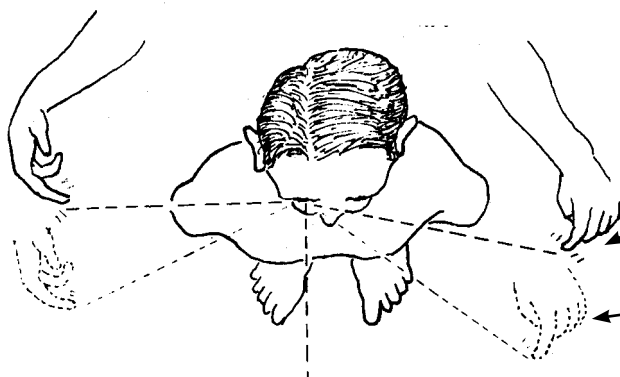


Если не лечить как можно быстрее, острая глаукома приведет к слепоте за несколько дней. **Нужна срочная медицинская помощь.**

ХРОНИЧЕСКАЯ ГЛАУКОМА

Внутриглазное давление повышается медленно. Обычно без боли. Зрение теряется медленно, начиная сбоку, и больной часто не замечает потери. Проверьте боковое зрение – это поможет обнаружить болезнь.

ТЕСТ НА ГЛАУКОМУ



Заставьте больного закрыть один глаз и другим глазом пусть он смотрит на предмет. Проверьте, когда больной первый раз заметит движение пальцев сзади с обеих сторон.

При нормальном зрении пальцы становятся видно здесь.

При глаукоме движение пальцев начинает быть заметным более впереди.

Если болезнь обнаружена рано, лечение специальными глазными каплями (пilocarpinum) может предупредить слепоту. Дозу назначает врач или работник здравоохранения, который может периодически измерять глазное давление. Каплями следует пользоваться до конца своей жизни. Когда возможно, лучше всего сделать хирургическую операцию – эта надежная форма лечения.

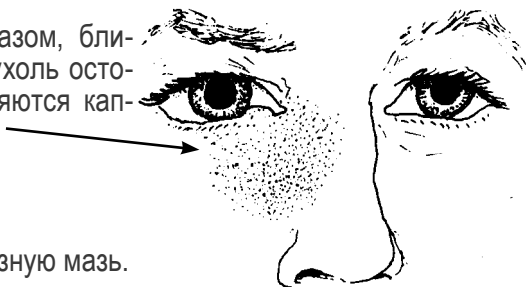
Предупреждение:

Больным, которым за 40 лет или у кого есть родственники с глаукомой, надо проверять давление 1 раз в год.

ИНФЕКЦИЯ СЛЕЗНОГО МЕШОЧКА (ДАКРИОЦИСТИТ)

Признаки:

Краснота, боль и опухоль под глазом, ближе к носу. Глаз слезится. Когда на опухоль осторожно нажимают, в углу глаза появляются капли гноя.



Лечение:

- Применяйте горячие компрессы.
- Используйте глазные капли или глазную мазь.
- Принимайте пенициллин (с. 351).

ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ

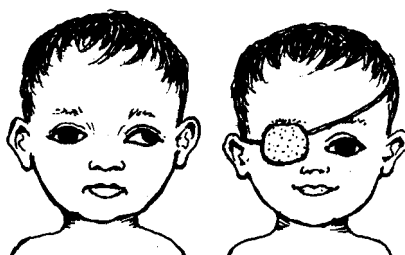
Детям, которые плохо видят или у которых при чтении болит голова или глаза, могут понадобиться очки. Проверьте их глаза.



Пожилым людям с годами все труднее рассматривать близкие предметы. Часто помогают очки для чтения. Они тщательно подбираются, чтобы не напрягать глаза и не вызвать головную боль. Если не помогают очки, обращайтесь к врачу.

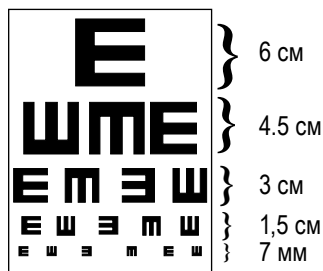
КОСОГЛАЗИЕ И БЛУЖДАЮЩИЙ ИЛИ “ЛЕНИВЫЙ” ГЛАЗ (СТРАБИЗМ)

Если глаз иногда косит как на этом рисунке, но в другое время смотрит вперед нормально, вам не следует беспокоиться. Со временем глаз выровняется. Но если глаз все время поворачивается неправильно и если ребенка не лечить в раннем возрасте, он не сможет никогда смотреть правильно этим глазом. Обращайтесь побыстрее к врачу, чтобы выяснить, что может помочь ребенку: мягкая повязка на здоровый глаз, операция или специальные очки.



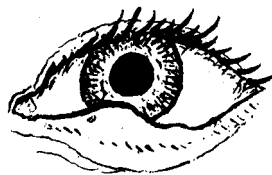
Операция, сделанная в более позднем возрасте, обычно может выправить глаз и улучшить внешность ребенка, но не поможет слабому глазу видеть лучше.

ВАЖНО: Зрение каждого ребенка должно проверяться как можно раньше (лучше около 4 лет). Вы можете использовать карту “Е” (смотри *Пособие Для Работников Здравоохранения*, с. 24-13). Проверяйте каждый глаз отдельно, чтобы обнаружить любую болезнь, которая поражает только один глаз. Если зрение плохое в одном или в двух глазах, обращайтесь к глазному врачу.



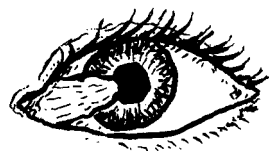
ЯЧМЕНЬ (ХОРДЕОЛУМ)

Красная припухлость на крае века. Чтобы лечить его, делайте теплые влажные компрессы чуть солоноватой водой. Применение глазной антибиотиковой мази 3 раза в день поможет вам предупредить возникновение новых ячменей.



ПТЕРИГИУМ

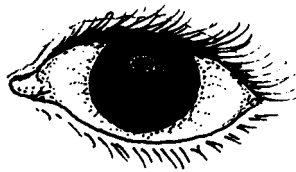
Утолщение плоти на глазной поверхности, которое медленно разрастается от края белка глаза со стороны носа и на роговицу; частично вызывается солнечным светом, ветром и пылью. Темные очки помогут успокоить раздражение и уменьшить рост птеригиума. Его следует удалить хирургическим путем, прежде чем он дойдет до зрачка. К сожалению, часто после хирургического вмешательства птеригиум снова растет.



В народной медицине применяют растертую скорлупу, которая приносит больше вреда, чем пользы. Чтобы успокоить зуд и жжение, можете попробовать холодный компресс. Или пользуйтесь глазными каплями из ромашки (хорошо прокипятить, затем остудить и без сахара).

ЦАРАПИНА, ЯЗВА ИЛИ РУБЕЦ НА РОГОВИЦЕ

Когда очень тонкую, нежную поверхность роговой оболочки оцарапана или поражена инфекцией, это может быть болезненная **язва роговицы**. Если вы посмотрите при хорошем освещении, вы увидите сероватое или тускловатое пятно на поверхности роговицы.



При плохом уходе язва роговицы может привести к слепоте. Применяйте антибиотиковую глазную мазь 4 раза в день в течение 7 дней, давайте пенициллин (с. 351) и закрывайте глаз повязкой. Если состояние глаза не улучшается в течение 2 дней, вызовите врача.

Рубец на роговице – это болезненное белое пятно на ней. Он может быть результатом вылеченной язвы, ожога или другой травмы глаза. Если оба глаза ослепли, но больной еще видит свет, операция на глазу (пересадка роговицы) может вернуть зрение. Но это дорого. Если рубец на одном глазу, а зрение другого глаза хорошее, избегайте хирургического вмешательства. Сделайте все, чтобы защитить хороший глаз от травм.



КРОВОТЕЧЕНИЕ В БЕЛКЕ ГЛАЗА

Болезненное, кроваво-красное пятно на белковой части глаза иногда появляется после подъема тяжести, после сильного кашля (как коклюш) или после сильного удара в глаз. Это состояние – результат разрыва кровеносных сосудов. Оно не вредное как синяк и постепенно проходит без лечения в течение 2 недель.

Маленькие красные пятна обычны на глазах новорожденных. Никакое лечение не требуется.



КРОВОТЕЧЕНИЕ ЗА РОГОВИЦЕЙ (ГИФЕМА)

Кровь за роговицей – опасный признак. Это обычно результат травмы глаза тупым предметом, как кулак. Если есть боль и потеря зрения, немедленно отправьте больного к специалисту по глазам. Если боль умеренная и нет потери зрения, сделайте повязки на оба глаза и поддержите больного в постели несколько дней. Если через несколько дней боль станет намного сильнее, возможно уплотнение глаза (глаукома, с. 222). Сразу отведите больного к главному врачу.



ГНОЙ ИЗ РОГОВИЦЫ (ГИПОПИОН)

Гной за роговицей – это признак сильного воспаления. Его иногда заметны и язвы на роговице, то глаз в опасности. Дайте пенициллин (с. 351) и обратитесь сразу за медицинской помощью. Если язву лечили правильно, гипопион часто проходит сам по себе.



КАТАРАКТА

Хрусталик глаза за зрачком становится мутным и зрачок от этого выглядит серым или белым, когда посветить в него. Катаракта обычно бывает у пожилых людей, но изредка случается и у детей. Если слепой больной с катарактой еще может отличать свет от темноты и замечает движение, хирургическое вмешательство может вернуть ему зрение. Однако больному понадобятся сильные очки и время, чтобы привыкнуть к ним. Лекарства не помогают при катаракте.

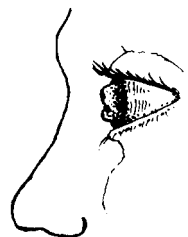
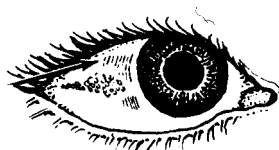


НОЧНАЯ СЛЕПОТА И КСЕРОФТАЛЬМИЯ (ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА А)

Эта болезнь самая обычная у детей в возрасте 1-5 лет. Она возникает из-за недостатка витамина А в пище. Если не распознать ее и не начать раннее лечение, она может привести ребенка к слепоте.

Признаки:

- Сначала у ребенка может быть ночная слепота. Он не может хорошо видеть в темноте, как обычные люди.
- Позже развивается сухость глаз (ксерофтальмия). Белки глаз теряют свой блеск и начинают сморщиваться.
- В глазах могут образоваться пятна из маленьких серых пузырей (пятна Битота).
- Когда болезнь усугубляется, роговица становится сухой и мутной, могут появиться маленькие ямки.
- Затем роговица может быстро стать мягкой, выпуклой или даже лопнуть. Обычно без боли. Слепота может быть результатом инфекции, царапин или других повреждений.
- Ксерофтальмия часто начинается или усугубляется, когда ребенок болеет другими болезнями, такими как понос, коклюш, туберкулез, корь. Откройте глаза ребенка и проверьте на признаки дефицита витамина А.



Предупреждение и лечение:

Ксерофтальмию можно легко предупредить, питаясь продуктами с витамином А. Делайте следующее:

- ◆ Кормите грудью ребенка – до двух лет, если это возможно.
- ◆ После первых 6 месяцев начните давать ребенку еду, богатую витамином А: овощи с темно-зелеными листьями и желтые или оранжевые фрукты и овощи, такие как папайя, манго и тыквенные. Цельное молоко, яйца и печень тоже богаты витамином А.
- ◆ Если ребенок не очень хочет эти фрукты или если у него развиваются признаки ночной слепоты или ксерофтальмии, давайте ему витамин А по 200000 единиц (60 мг ретинола в капсулах или жидкости) один раз каждые 6 месяцев (с. 392). Детям до 1 года следует давать 100000 единиц.
- ◆ Если состояние очень серьезное, дайте ребенку 200000 единиц витамина А в первый день, 200000 единиц во второй день и 200000 единиц через 14 дней. Детям до 1 года достаточно получить половину этого количества (100000 единиц).



- ◆ В местах, где распространена ксерофтальмия, давайте по 200000 единиц витамина А один раз в 6 месяцев женщинам, которые кормят грудью, и беременным во второй половине беременности.

ВНИМАНИЕ: Употребление большого количества витамина А ведет к отравлению. Не давайте больше, чем требуется.

Если состояние глаза ребенка тяжелое, с мутной, покрытой ямками или выступающей роговицей, обратитесь к врачу. Глаз ребенка следует перевязать и сразу дайте ему витамин А, лучше в инъекции 100000 единиц.

Овощи с темно-зелеными листьями, желтые и оранжевые фрукты помогут предупредить слепоту у детей.

ПЯТНА ИЛИ “МУШКИ” ПЕРЕД ГЛАЗАМИ

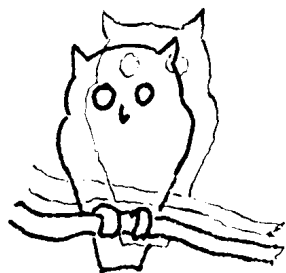
Иногда пожилые люди жалуются на маленькие движущиеся пятна, когда смотрят на яркую поверхность (стенку, небо). Пятна двигаются, когда двигается глаз, и выглядят как крохотные мухи. Они обычно безвредны и не нуждаются в лечении. Но если они внезапно появляются в большом количестве и зрение начинает падать сбоку, срочно нужна помощь (отслойка сетчатки). **Обращайтесь за медицинской помощью немедленно.**

ДВОЕНИЕ В ГЛАЗАХ

Двоение в глазах имеет много причин.

Если оно наступает внезапно, является хроническим или постепенно становится сильнее, это, возможно, признаки серьезной болезни. Обращайтесь к врачу.

Если двоение в глазах появляется время от времени, это может быть признак слабости, истощения от недоедания. Прочтите Главу 11 о хорошем питании и попытайтесь питаться как можно лучше. Если зрение не улучшается, обратитесь за медицинской помощью.



реальный размер

РЕЧНАЯ СЛЕПОТА (ОНХОЦЕРКОЗ)

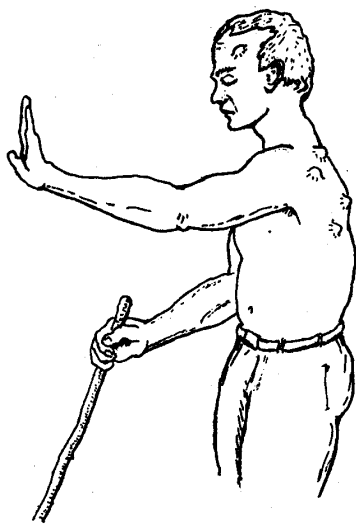
Эта болезнь обычна во многих частях Африки и в некоторых областях южной Мексики, Центральной Америки и северной части Южной Америки. Инфекция вызывается крошечными червями, которые переносятся от человека к человеку маленькими горбатыми мухами или мошками, известными как черные мухи.

Человек заражается червями при укусе инфицированной черной мухи.



ЧЕРНАЯ МУХА

- Спустя несколько месяцев после укуса черной мухи и попадания в тело человека личинок начинает расти опухоль под кожей. В Америке опухоли обычно бывают на голове или в верхней части тела, в Африке на груди, в нижней части и на бедрах. Чаще всего бывает не более 3-6 опухолей. Они медленно растут до размера 2-3 см в поперечнике. Обычно они безболезненны.
- Может быть зуд, когда личинки растут.
- Боли в спине, плечах, пояснице или "общие боли во всем теле".
- Увеличение лимфоузлов в паху.
- Утолщение кожи на спине или животе с большими порами, как кожа апельсина. Чтобы увидеть это, посмотрите на кожу, когда свет падает с одной стороны.
- Если болезнь не лечить, кожа потихоньку становится морщинистой как у стариков. Белые пятна могут появиться на нижней части ног. Может появиться сухая сыпь на нижних конечностях и туловище.
- Глазные проблемы часто приводят к слепоте. Сначала глаза краснеют и слезоточат, затем появляются признаки воспаления радужки (с. 221). Роговица мутнеет и изъязвляется как при ксерофтальмии (с. 226). Наконец, теряется зрение из-за рубцов на роговице, катаракты, глаукомы и других болезней.



Лечение речной слепоты:

Раннее лечение может предупредить слепоту. В местах, где бывает речная слепота, обращайтесь к врачу при появлении первых признаков.

- ◆ Ивермектин (Мектизан) – самое лучшее лекарство от речной слепоты и его можно получить бесплатно через ваши местные отделы здравоохранения. Диэтилкарбамазин и сурамин – другие препараты, используемые для лечения речной слепоты, но они могут иногда принести больным больше вреда, чем пользы, особенно, когда поражение глаз началось. Их могут давать только квалифицированные врачи. Дозу и предосторожности для этих лекарств смотри на с. 378.
- ◆ Антигистамины помогают убрать зуд (с. 386).
- ◆ Раннее хирургическое удаление опухоли уменьшает количество личинок.

Предупреждение:

- ◆ Черные мухи размножаются в проточной воде. Очищая кустарники и остатки растений на берегах быстрых ручьев можно уменьшить количество мух.
- ◆ Избегайте спать на открытом воздухе – особенно в дневное время, когда обычно донимают мухи.
- ◆ Поддерживайте на деле программы по борьбе с черными мухами.
- ◆ **Раннее лечение предупреждает речную слепоту и препятствует распространению болезни.**

ЗУБЫ, ДЕСНЫ И РОТ

УХОД ЗА ЗУБАМИ И ДЕСНАМИ

Хороший уход за зубами и деснами важен, потому что:

- Сильные и здоровые зубы нужны, чтобы жевать и хорошо переваривать пищу.
- Больные полости (дырки в зубах) от гниения и воспаления десен нужно предупредить хорошим уходом за зубами.
- Больные и сгнившие зубы от недостаточной чистки могут привести к серьезным инфекциям, которые действуют на другие части тела

Чтобы сохранить зубы и десны здоровыми:

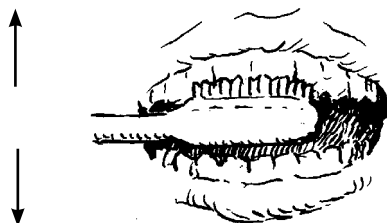
1. **Избегайте сладостей.** Употребление сладостей в большом количестве, таких как: сахар, тростник, конфеты, чай кофе с сахаром, безалкогольных напитков, таких как кола ведет к гниению зубов.

Не приучайте детей к сладостям и безалкогольным напиткам, если хотите, чтобы у них были здоровые зубы.



2. **Чистите зубы хорошо каждый день** – и всегда сразу после сладостей. Начните чистить детские зубы как только они появятся. Позже научите детей самим чистить зубы и наблюдайте за ними, правильно ли они это делают.

“Этот ребенок был сладенкой, но скоро не будет таким” (у него не будет зубов).



Чистите щеткой зубы сверху вниз, как здесь, а не просто со стороны в сторону. Чистите все зубы спереди, сзади, сверху и внизу.

3. В местах, где мало природных фторидов в воде и в пище, положите фториды в воду для питья или прямо на зубы, чтобы предупредить образование полостей в зубах. Некоторые программы здоровья предлагают применение фторидов на детские зубы один или два раза в год. Большинство продуктов моря содержат большое количество фторидов.

Осторожно: Фториды ядовиты, если их принимать в большом количестве. Употребляйте их осторожно и держите подальше от детей. Прежде чем добавлять фториды в питьевую воду, постарайтесь сделать анализ воды, чтобы выяснить, сколько фторидов требуется.

4. Не пользуйтесь бутылками для кормления детей постарше. Постоянное сосание из бутылки омывает зубы детей сладкой жидкостью и вызывает раннее гниение. (Лучше не есть из бутылочки совсем. См. с. 271).

ЗУБНАЯ ЩЕТКА НЕ ОСОБЕННО НУЖНА

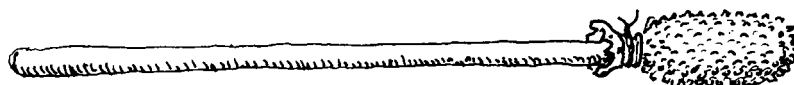
Можете использовать веточку дерева, такую как эта:

Заострите этот конец, чтобы
чистить между зубами.

Разжуйте на этом конце и используйте
волокна как щетку.



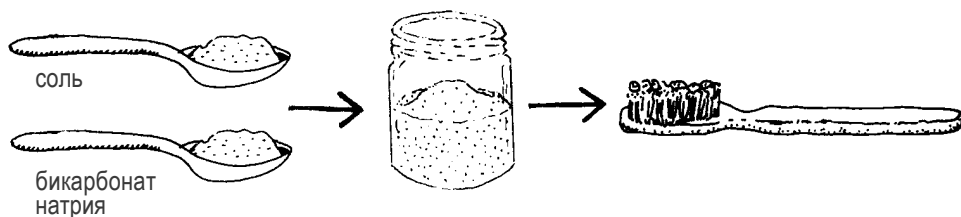
Или обвяжите кусочком грубой ткани конец веточки, или оберните вокруг пальца и используйте как зубную щетку.



кусочек
грубой
ткани

ЗУБНАЯ ПАСТА НЕ ВСЕГДА НЕОБХОДИМА

Просто достаточно воды и хорошо потереть их. Натирание зубов и десен чем то мягким, но немного грубым – вот что чистит их. Некоторые люди натирают зубы угльным порошком или солью. Вы можете сделать зубной порошок, смешивая соль и соду в равных количествах. Сделав порошок, намочите щетку перед тем, как опустить в порошок.



ЕСЛИ В ЗУБЕ УЖЕ ЕСТЬ ПОЛОСТЬ (ДЫРКА ИЗ-ЗА ГНИЕНИЯ)

Чтобы уберечь зубы от боли или образования абсцесса, избегайте сладостей и чистите хорошо зубы после каждого приема пищи.

Если возможно, обращайтесь к зубному врачу немедленно, если вы обратитесь к врачу вовремя, он может почистить и запломбировать зубы, так чтобы сохранить зубы на долгие годы.



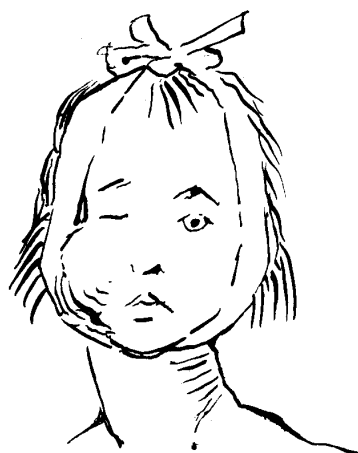
**Если у вас зуб с полостью, не ждите пока он сильно заболит.
Дайте возможность зубному врачу запломбировать зуб быстрее.**

ЗУБНАЯ БОЛЬ И НАРЫВЫ

Чтобы успокоить боль:

- Вычистите дупло в зубе, удаляйте все частички. Затем прополощите рот теплой соленой водой.
- Примите аспирин - лекарство от боли.
- Если инфекция в зубе тяжелая (опухоль, гной, стали болезненными лимфоузлы), используйте антибиотик: таблетки пенициллина (с. 351) или сульфаниламид (с. 358), или тетрациклин в капсулах (только для взрослых. см. с. 356).

Если боль и опухоль не проходят или снова появилась зубная боль, то нужно этот зуб удалить.



Зубная боль появляется в результате инфицирования полости в зубе.

Немедленно лечите абсцесс – до того, как инфекция распространится на другие части тела.

ИНФЕКЦИЯ ДЕСЕН (ПИОРЕЯ)

Воспаленные (красные и опухшие), болезненные десны, которые легко кровоточат, вызываются:

1. Плохой или недостаточно частой чисткой зубов и десен.
2. Недостаточным потреблением питательной пищи (недоедание).



Профилактика и лечение:

- ◆ Хорошо чистить зубы после каждого приема пищи, удаляя остатки пищи палочкой между зубов. Еще, если возможно, соскребите темно-желтую корку, которая образуется, где смыкаются зубы и десны. Это способствует чистоте под деснами, регулярно проводите зубной щеткой (или тонкой ниткой) между зубами. Сначала будет сильно кровоточить, но вскоре десны будут здоровыми и менее кровоточивыми.

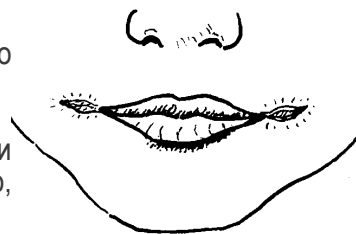
Больше употребляйте защитной пищи, богатой витаминами, особенно яйца, мясо, бобы, темно-зеленые овощи и фрукты, такие как апельсин, лимон, томаты (смотри Главу 11). Избегайте сладостей мелких и волокнистых, которые могут застрять между зубами.

Примечание: Иногда лекарства от припадков (эпилепсии) вызывают опухоль и нездоровый рост десен (с. 390). Если это случилось, проконсультируйтесь у работников здравоохранения и подумайте об употреблении других лекарств.

БОЛЯЧКИ ИЛИ ТРЕЩИНЫ В УГЛУ РТА

Узкие раны в уголках детского рта - это часто признак недоедания.

Дети с такими ранами должны питаться продуктами богатыми витаминами и протеином, такими как молоко, рыба, орехи, яйца, фрукты и зеленые овощи.



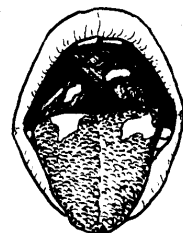
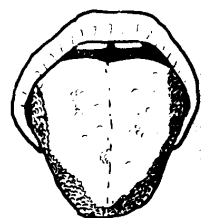
БЕЛЫЕ ПЯТНА ИЛИ ПРЫЩИ ВО РТУ

Язык "покрытый" белым "мехом". Многие болезни вызывают белый или желтоватый налет на языке и на нёбе рта. Это обычно при высокой температуре. Хотя этот налет не опасен, помогает полоскание рта раствором соленой воды и соды несколько раз в день.

Типичные белые пятна, как гранулы соли во рту у ребенка, с жаром могут быть признаком кори (с. 311).

Молочница: маленькие белые пятна на внутренней стороне рта и языка, которые похожи на творог. Ее вызывает грибок или дрожжевая инфекция, которая называется монилиоз (с. 242). Молочница бывает у новорожденных, у людей с вирусом СПИДа и у людей, которые пользуются определенными антибиотиками, особенно тетрациклином и ампициллином.

Как только не нужно будет принимать антибиотики прекратите применять их. Смажьте внутри рта генциан-виолетом. Жуйте чеснок или пейте йогурт - он тоже помогает. В тяжелых случаях пейте нистатин (с. 373).



Гангренозный стоматит: маленькие, белые, болезненные пятна внутри губ и рта. Могут появляться после жары или стресса (беспокойства). В течении 1 или 3 недель проходят. Прополощите рот соленой водой или положите немного перекиси водорода или кортикостероидной мази (с. 371). Антибиотики не помогают.

ПРОСТУДНЫЕ БОЛЯЧКИ И ВОЛДЫРИ ОТ ЖАРА

Маленькие болезненные волдыри на губах (или половых органах) лопаются и образуются трещины. Могут появиться после температуры или стресса. Причина - вирус герпеса. Они вылечиваются через 1-2 недели. Приложите лед к ране на несколько минут, несколько раз в день - может помочь излечить быстрее. Положите квасцы, камфару или горячий сок растения (смотри Кактус древовидный, с. 13) на них, это тоже может помочь излечить быстрее. Никакие медикаменты не могут помочь улучшить положения. Для информации о герпесе на половых органах смотри с. 402.

Чтобы получить больше информации об уходе за зубами и деснами смотри Там, Где Нет Зубного Врача, тоже доступной из фонда Геспериона.

МОЧЕВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

ГЛАВА

18

Мочевая система или тракт служит организму, удаляя остаточный материал из крови и выводя его из организма в виде мочи:

Почки фильтруют кровь и образуют мочу.

Мочеточники – трубы, по которым моча поступает в пузырь.

Мочевой пузырь – мешок, в который собирается моча. При наполнении он растягивается и становится.

Мочевая труба или *мочевой канал* (уретра) выводит мочу через пенис у мужчин или через маленькое отверстие между половыми губами влагалища у женщин.

Гениталии – половые органы.

Мужчина:

пузырь

мочевой канал

пенис – мужской половой орган

мошонка – мешок, где находятся яички

семявыводящий проток

Предстательная железа образует жидкость, которая несет сперму.

Яички образуют сперму, или микроскопические клетки с хвостиками, которые соединяются с яйцом женщины и делают ее беременной.

Женщина:

внешняя губа влагалища

внутренняя губа

анус: конец кишечника

клитор: чувствительная часть, что-то вроде маленького пениса.

мочевое отверстие: дыра, откуда выходит моча.

вход во влагалище или родовой канал. (Вид изнутри см. на с. 280.)

ПРОБЛЕМЫ МОЧЕВОГО ТРАКТА

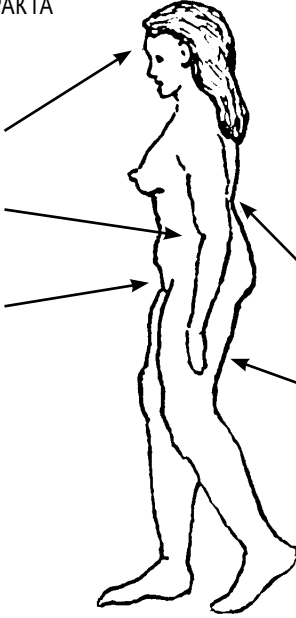
Существует много различных расстройств мочевого тракта. Не всегда легко говорить о них по отдельности. Одна и та же болезнь может проявлять себя по-разному у мужчин и у женщин. Некоторые из этих болезней несерьезны, в то время как другие могут быть очень опасными. Опасная болезнь может начаться с очень легкого симптома. Часто трудно идентифицировать эти расстройства правильно, просто посмотрев в эту книгу. Могут понадобиться специальные знания и проверки. Когда возможно, обращайтесь за советом к работникам здравоохранения.

Обычные **проблемы с мочеиспусканием** включают:

1. Инфекции мочевыделительного тракта. Они наиболее распространены у женщин. (Иногда они начинаются после полового контакта, но могут и в другое время, особенно во время беременности).
2. Камни в почках или в мочевом пузыре.
3. Заболевание простаты (трудности с мочеиспусканием, вызванные увеличением предстательной железы; обычны у пожилых мужчин).
4. Гонорею или хламиду (инфекционные болезни, распространяемые половым путем, которые часто вызывает трудности или боль при мочеиспускании).
5. В некоторых частях света шистосомоз – самая распространенная причина появления крови в моче. Это обсуждается вместе с другими глистными инфекциями (см. с. 146).

Инфекции Мочевого Тракта

Признаки:

- 
- Иногда жар, озноб или головная боль.
 - Иногда боль в боку.
 - Болезненные и частые позывы к мочеиспусканию.
 - Недержание мочи (особенно касается детей).
 - Моча может быть мутной или красноватой (кровянистой).
 - Иногда такое ощущение, что пузырь опорожнен не до конца.
 - Иногда боль внизу спины (почки).
 - Иногда боль отдается в ноги.
 - В тяжелых случаях (заболевание почек) могут опухать ноги и лицо.

Многие женщины страдают от инфекций мочевой системы. У мужчин их гораздо меньше. Иногда единственные симптомы – это **болезненное мочеиспускание и частые позывы к нему**. Другие обычные признаки – **кровь в моче и боль внизу живота**. Боль в средней или нижней части спины, часто отдающая под ребра, и жар указывают на более серьезную проблему.

Лечение:

- **Пейте побольше воды.** Многие легкие инфекции мочевой системы можно вылечить простым питьем воды в большом количестве. Выпивайте по крайней мере 1 стакан каждые 30 минут в течение трех-четырех часов и привыкните пить как можно больше воды. (Но если больной не может мочиться или у него отекло лицо и руки, он не должен пить много воды).
- Если больному не становится лучше от того, что он пьет много воды, или у него жар, ему следует принять таблетки ко-тримоксазола или другие сульфаниламиды (с. 358), ампициллин (с. 353) или тетрациклин (с. 356). Обратите особое внимание на дозу и меры предосторожности. Чтобы полностью остановить инфекцию, возможно следует принимать лекарство в течение 10 дней и больше. Очень важно **продолжать пить много воды, пока вы принимаете эти лекарства**, особенно сульфаниламиды.
- Если больному не стало лучше, обращайтесь к врачу.



КАМНИ В ПОЧКАХ ИЛИ В МОЧЕВОМ ПУЗЫРЕ:

Признаки:

- Первые признаки – это частая острая и сильная боль внизу спины, в боку, или нижней части живота, или у мужчин в основании пениса.
- Иногда мочевой канал закупорен так, что больному тяжело мочиться – или вообще не может. Или иногда капли крови выходят тогда, когда больной начинает мочиться.
- Может быть инфекция в моче в это же время.

Лечение:

- ◆ Точно такое же, как при инфекциях, описанных выше.
- ◆ Дайте еще аспирин или другое болеутоляющее и противосудорожное средство (с. 380).
- ◆ Если вы не можете помочиться, попробуйте сделать это лежа. Иногда это помогает, потому что камень откатывается назад и освобождает проход в мочевой канал.
- ◆ В тяжелых случаях обратитесь к врачу. Иногда необходимо хирургическое вмешательство.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:

Состояние это бывает у мужчин, которым за 40 лет. Вызывается оно опуханием предстательной железы, которая находится между мочевым пузырем и мочевым каналом (уретрой).

- Человеку трудно мочиться, а иногда он и не может. Моча только капает капельками или полностью блокируется. Иногда человек не может помочиться несколько дней.
- Если у человека температура, то это признак инфекции.

Лечение увеличенной предстательной железы:

- ◆ Если человек не может помочиться, ему следует попытаться сделать это, сидя в тазу с теплой водой, как показано на картинке: Если это не помогает, нужно использовать катетер (с. 239).
- ◆ Если у него жар, нужно принять антибиотики такие, как ампициллин (с. 353) или тетрациклин (с. 356).
- ◆ Обратитесь за медицинской помощью. Серьезные и хронические случаи могут требовать хирургического вмешательства.

Примечание: Как простата, так и гонорея (или хламидида) может вызвать трудности с мочеиспусканием. У пожилых людей более вероятно увеличение предстательной железы. Но у молодых людей – особенно если недавно был половой контакт с больным человеком – возможна гонорея или хламидида.

БОЛЕЗНИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ)

На следующих страницах мы обсудим некоторые обычные болезни, распространяемые при сексуальных контактах: **гонорея, хламидида, сифилис, бубон**. СПИД – новая опасная болезнь – и некоторые венерические болезни, которые вызывают болячки на половых органах (**половой герпес, половые бородавки и мягкий шанкр**) – обсуждаются в Приложении 2 (см. с. 399-403).

ГОНОРЕЯ (ТРИППЕР) и ХЛАМИДА

Эти болезни обычно передаются при половом контакте и у них одинаковые ранние признаки. Часто бывает так, что у больного в одно и то же время и гонорея, и хламидида, поэтому нужно лечить обе болезни.

Признаки:

У мужчин:



У женщин:



- Боль или трудности с мочеиспусканием.
- Капли гноя из пениса.
- Иногда болезненно опухшие яички.

После недель или месяцев:

- Болезненные опухоли в одном или обоих коленях, лодыжках или в кистях или многие другие проблемы.
- Сыпь или болячки по всему телу.
- Он может стать стерильным (не сможет сделать женщину беременной).

- Сначала никаких симптомов (она может чувствовать слабую боль, когда мочится, или иметь небольшие выделения из влагалища).
- Если беременная женщина с гонореей не лечится перед родами, инфекция может попасть в глаза ребенка и сделать его слепым (см. с. 221).

После недель или месяцев:

- Боль в нижней части живота (воспаление тазовых органов, с. 243).
- Менструальные проблемы.
- Она может стать стерильной.
- Проблемы мочевыделения (с. 235).

У мужчин первые признаки появляются от 2 до 5 дней (или до 3 недель и больше) после полового контакта с инфицированным человеком. У женщин признаки могут появляться через недели или месяцы. Но человек, у которого нет признаков, может заразить других через несколько дней после того, как он был инфицирован.

Лечение:

- ◆ В прошлом гонорее обычно лечили пенициллином. Но сейчас во многих местах болезнь стала устойчивой к пенициллину, поэтому надо применять другие антибиотики. Лучше воспользоваться местными советами о том, какие лекарства эффективнее и доступнее в вашей местности. Лекарства для лечения гонореи и хламиды представлены на с. 360. Если капание и боль не проходят через 2-3 дня после начала лечения, значит гонорея может сопротивляться этому лекарству или у больного хламиды.
- ◆ Если у женщины гонорея или хламиды, а также жар и боль внизу живота, у нее возможно воспаление тазовых органов (см. с. 243).
- ◆ Каждый, кто имел половой контакт с больным гонореей или хламидой, должен лечиться, особенно жены тех мужей, которые заразились. Даже если у жены не видны признаки, она может быть инфицирована. Если она не будет лечиться одновременно с мужем, она снова может его заразить.
- ◆ Защищайте глаза всех новорожденных детей от хламиды или гонореи, которые ведут к слепоте (см. с. 379). О лечении смотри на с. 221.

Осторожно: Человек, у которого гонорея или хламиды, может иметь и сифилис, сам не зная об этом. Иногда лучше заранее провести полный курс лечения от сифилиса, потому что лечение гонореи и хламиды может предупредить первые симптомы сифилиса, **но не может вылечить болезнь.**

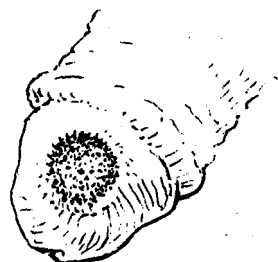
О профилактике болезней, передаваемых половым путем, см. на с. 239.

Сифилис

Сифилис – распространенная и опасная болезнь, которая передается от одного человека к другому при половом контакте.

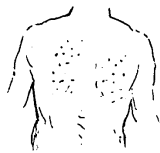
Признаки:

- Обычно первый признак – язвы, называемые шанкром. Они появляются через 2-5 недель после полового контакта с человеком, у которого сифилис. Шанкр может выглядеть как угорь, волдырь или открытая язва. Он обычно появляется на половых органах у мужчины или у женщины (реже на губах, пальцах, анусе или во рту). В такой язве полно микробов, которые легко переходят к другому человеку. **Язва обычно безболезненная, а если она внутри влагалища, то женщина может и не знать об этом – но она легко может заразить других людей.**
- Язвы сохраняются несколько дней, а затем проходят сами без лечения. **Но болезнь продолжает распространяться по всему телу.**



- Спустя недели или месяцы, начинается воспаление горла, легкий жар, язвы во рту или опухают суставы. Или любой из этих признаков может появиться на коже:

болезненная сыпь или
"угри" по всему телу



круглые рубцы (как
крапивница)



зудящая сыпь на
руках и ногах



Все эти признаки обычно проходят сами по себе, а тогда человек думает, что у него все прошло – но болезнь продолжается. **Без адекватного лечения сифилис может поразить любую часть тела, вызывая болезни сердца, паралич, безумие и многие другие проблемы.**

Осторожно: Если появилась какая-то странная сыпь или несколько дней или недель не пропадают угри или язвы на половых органах – это может быть сифилис. Обращайтесь к врачу.

Лечение сифилиса: (Для полного выздоровления необходимо полное лечение.)

- ◆ Если признаки появились и присутствуют меньше 1 года, введите 2.4 миллиона единиц бензатин пенициллина сразу. Введите по половине дозы в каждую ягодицу (см. с. 353). Люди, у которых аллергическая реакция на пенициллин, могут принимать тетрациклин по 500 мг 4 раза в день в течение 15 дней.
- ◆ Если признаки присутствуют больше 1 года, вводите 2.4 миллиона единиц бензатин пенициллина – по половине в каждую ягодицу - раз в неделю в течение 3 недель, до общего количества 7.2 миллиона единиц. Если аллергия на пенициллин, принимайте тетрациклин по 500 мг 4 раза в день в течение 30 дней.
- ◆ Если есть любое подозрение на сифилис, немедленно обращайтесь к работнику здравоохранения. Возможно, потребуется анализ крови. Даже если его нельзя сделать, больной должен лечиться в любом случае.
- ◆ Каждый, у кого был половой контакт с больным сифилисом, должен лечиться, особенно мужья или жены тех, кто знает, что заражен.

Примечание: Беременные или кормящие матери, у которых аллергическая реакция на пенициллин, могут принимать эритромицин в тех же дозах, как и тетрациклин (см. с. 356).

О предупреждении сифилиса смотри на следующей странице.

БУБОН: РАЗРЫВ ЛИМФОУЗЛОВ В ПАХУ (ЛИМФОГРАНУЛЕМА ВЕНЕРИЧЕСКАЯ)

Признаки:

- **У мужчин:** Большие темные опухоли в паху, которые открываются, выбрасывая гной, рубцуются и открываются снова.
- **У женщин:** Лимфоузлы такие, как у мужчин. Или болезненные, мокнущие язвы в анусе.

Лечение:

- ◆ Обратитесь к работнику здравоохранения.
- ◆ Давайте взрослым 250 мг капсулы тетрациклина, по 2 капсулы 4 раза в день – 14 дней.
- ◆ Избегайте половые контакты пока все язвы полностью не излечатся.

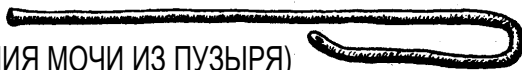
Примечание: Бубоны в паху могут быть признаком мягкого шанкра (см. с. 403).



КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ БОЛЕЗНИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

1. **Будьте осторожны с теми, с кем вы занимаетесь сексом:** Любой, кто вступает в половую связь с множеством различных людей, может заразиться этими болезнями. Особенно опасны проститутки. Чтобы избежать инфекции, имейте только одного надежного партнера по сексу. Если вы вступаете в половой контакт еще с кем то, **всегда пользуйтесь презервативом.** (Применение презерватива помогает предупредить распространение венерических болезней, но это тоже не совсем полная защита.)
2. **Начинайте лечение сразу:** Очень важно, чтобы все люди, инфицированные венерическими заболеваниями, сразу же лечились и не заражали других. Не имейте половых контактов ни с кем, пока не пройдет 3 дня после окончания лечения. (К сожалению, еще нет эффективных лекарств от СПИДа.)
3. **Сообщите другим людям, если они нуждаются в лечении:** Когда человек узнает, что у него или у нее венерическая болезнь, он должен сообщить об этом тем, с кем он имел половой контакт, чтобы они могли лечиться тоже. Особенно важно, чтобы мужчина сказал об этом женщине, потому что она, не зная о болезни, может передать болезнь другим людям и заразить своих детей, которые могут ослепнуть, а сама она со временем станет бесплодной и очень больной.
4. **Помогайте другим:** Настаивайте на том, чтобы ваши друзья, у которых болезнь, принимали лечение сразу и избегали половых контактов до тех пор, пока не вылечатся.

КАК И КОГДА ПРИМЕНЯТЬ КАТЕТЕР (РЕЗИНОВУЮ ТРУБКУ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ МОЧИ ИЗ ПУЗЫРЯ)



Когда пользоваться, а когда не пользоваться катетером.

- **Никогда не пользуйтесь катетером, если в этом нет необходимости** или если невозможно получить вовремя медицинскую помощь. Даже осторожное применение катетера иногда вызывает опасные инфекции или повреждения мочевого канала.
- Если моча выходит полностью, не пользуйтесь катетером.
- Если больной не может помочиться, попробуйте сначала посадить его в таз с теплой водой (с. 236). Дайте ему сразу рекомендованные лекарства (от гонореи или заболевания простаты).
- Если у больного болезненный, переполненный пузырь и он не может помочиться или если у него или у нее появляются признаки отравления мочой, тогда и только тогда пользуйтесь катетером.

Признаки отравления мочой (уремия)

- Дыхание по запаху похоже на мочу.
- Опухают ноги и лицо.
- Рвота, истощение, замешательство.



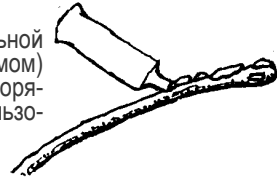
Примечание: Люди, которые страдают от трудностей с мочеиспусканием, от увеличения простаты или от камней в почках, должны купить катетер и держать под рукой на крайний случай.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТЕТЕРОМ

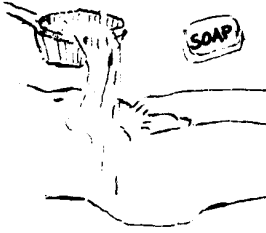
1. Кипятите катетер (и шприц или инструмент, который вы можете использовать) 15 минут.



6. Намажьте катетер стерильной смазкой (скользким кремом) типа желе, которая растворяется в воде (нельзя использовать Вазелин или масло).



2. Хорошо промойте под крайней плотью или между половыми губами и окружающие места.



3. Вымойте руки – если можно, то с медицинским мылом (типа Бетадина). После мытья трогайте только стерильные или очень чистые предметы.



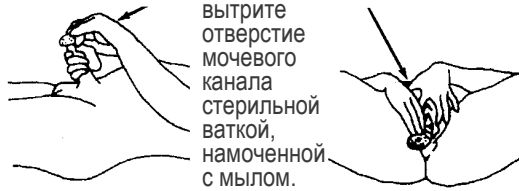
4. Положите очень чистую ткань под и вокруг места.



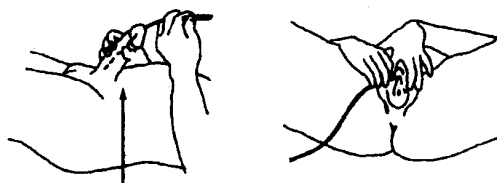
5. Наденьте стерильные перчатки и протрите их спиртом или медицинским мылом.



7. Оттяните плоть или откройте половые губы и



8. Придерживая плоть или половые губы, осторожно вставьте катетер в отверстие канала. Поворачивайте, если нужно, но без усилий.



Держите пенис прямо под таким углом.

9. Для мужчин – вводите катетер, пока не появится моча, затем еще на 3 см. Примечание: Женский канал намного короче мужского.



Важно: Если вы заметили признаки отравления мочой, не давайте сразу выйти всей моче: вместо этого пусть она выходит очень медленно (зажимая или закрывая катетер), понемногу около часа или двух.

Иногда женщина не может помочиться после родов. Если прошло более 6 часов и ее пузырь переполнен, ей нужно вставить катетер. Если пузырь не наполнился, не пользуйтесь катетером, а заставьте ее пить побольше воды.

Чтобы побольше узнать о применении катетера, смотри *Искалеченные Деревенские Дети*, Глава 25.

ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ

Выделения из Влагалища

(слизь или похожее на гной вещество, вытекающее из влагалища)

Все женщины обычно имеют небольшие выделения из влагалища – чистые, молочные или слегка желтоватые. Если нет зуда или плохого запаха, нет и никаких проблем.

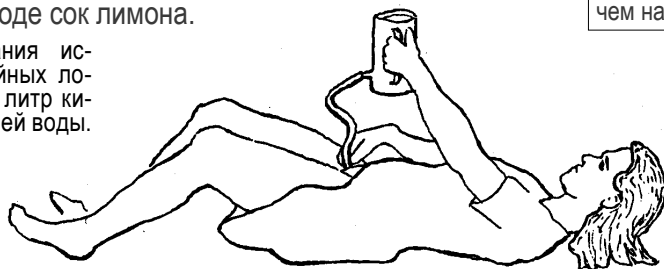
Но многие женщины, особенно во время беременности, страдают от выделений с зудом во влагалище. Эти выделения могут быть вызваны различными инфекциями. Большинство из них неприятны, но не опасны. Однако инфекция, вызванная гонорей или хламидой, может причинить вред ребенку при родах (см. с. 237).

1. **Жидкие и пенистые, зелено-желтые или беловатые, плохо пахнущие выделения с зудом.** Это может быть инфекция, вызванная трихомонадой. Бывает жжение при мочеиспускании. Иногда половые органы болят и опухают. В выделениях может быть кровь.

Лечение:

- ♦ Важно содержать половые органы в чистоте.
- ♦ Промывание влагалища или спринцевание теплой водой и разведенным уксусом тоже может помочь. Если нет уксуса, разведите в воде сок лимона.

Для спринцевания используйте 6 чайных ложек уксуса на 1 литр кипяченой остывшей воды.



Важно: Пусть вода медленно течет в течение 3 минут. Не вводите трубку во влагалище глубже, чем на 7 см.

Осторожно: Не спринцуйтесь в последние 4 недели беременности или 6 недель после родов. Если выделения неприятные, может помочь нистатиновая прокладка во влагалище (смотри пункт 2 на следующей странице).

- ♦ Вы можете применять зубчик чеснока как примочку влагалищную (очистить от кожицы чеснок, осторожнее не проколите ее). Заверните в небольшую чистую ткань или марлю и вложите во влагалище.
- ♦ Делайте спринцевание 2 раза в день, каждую ночь меняйте новую прокладку с чесноком. Делайте это 10-14 дней.
- ♦ Если это не поможет, делайте прокладки с метронидазолом или другими медикаментами от трихомониаза или принимайте метронидазол внутрь. Инструкции и меры предосторожности смотри на странице 370.

Важно: Вероятнее всего, что муж женщины с трихомониазом тоже инфицирован, даже если он ничего не чувствует. (Некоторые мужчины чувствуют жжение, когда мочатся.) Если женщина лечится метронидазолом, ее муж должен тоже его принимать в это же время.

2. **Белые творожистые выделения, пахнущие плесенью или пропавшим хлебом.** Это может быть дрожжевая инфекция (монилиоз, кандидоз). Зуд может быть сильным. Половые губы часто ярко красные и болят. Трудно мочиться. Эта инфекция наиболее часто бывает у беременных женщин или у тех, кто болеет диабетом (с. 127), или у тех, кто принимает противозачаточные пилюли или антибиотики.

Лечение: Спринцевание уксусом, разведенным в воде (с. 241), или разбавленным генциан-виолетом, 2 части генциан-виолета на 100 частей воды (2 чайные ложки на пол-литра). Или пользуйтесь таблетками нистатина для влагалища или любыми другими влагалищными прокладками от монилиоза или кандидоза. Смотрите дозировку и инструкции на с. 370. Вложите несладкий йогурт во влагалище – говорят, прекрасное домашнее средство лечения, помогает остановить дрожжевую инфекцию. **Никогда не пользуйтесь антибиотиками при дрожжевой инфекции. Это может усилить ее.**

3. **Густые молочные выделения с протухшим запахом.** Это может быть бактериальная инфекция. Возможно, будут нужны анализы, чтобы отличить от инфекции трихомонады. Спринцевание уксусом, разведенным в воде (с. 241), или повидон йодином (Бетадин: 6 чайных ложек на 1 литр воды). Еще вы можете попробовать вкладывать во влагалище каждую ночь зубчик чеснока в течение 2 недель (см. с. 241). Если никакое из этих лекарств не помогает, попробуйте метронидазол (с. 369).
4. **Водянистые, коричневые или серые выделения с прожилками крови; плохой запах; боль внизу живота.** Это признаки более серьезных инфекций или может быть рак (с. 280). Если есть жар, принимайте антибиотики (если можно, ампициллин вместе с тетрациклином – см. с. 353 и 356). Срочно обращайтесь за медицинской помощью.

Важно: Если выделения продолжаются долго и состояние не улучшается при лечении, покажитесь врачу.

КАК ЖЕНЩИНА МОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ МНОГИХ ИНФЕКЦИЙ?

1. Половые органы должны быть чистыми. Когда вы купаетесь (по возможности ежедневно), мойтесь хорошо с мягким мылом.
2. После полового акта помочитесь. Это помогает предупредить инфекции мочевой системы (но не предохранит от беременности).
3. Всегда хорошо вытирайтесь после испражнения. Всегда вытирайтесь так.



Вытираясь вперед, можно занести микробы, амёбы или глисты в мочевое отверстие или во влагалище. Еще обратите внимание на то, как вытираются маленькие девочки, и научите их, когда они подрастут, делать так же.

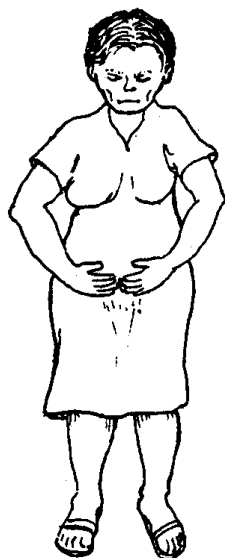
Боль и Дискомфорт в Нижней Центральной Чasti Живота у Женщины

Это может вызываться многими причинами, описанными в различных частях этой книги. Ниже приводится перечень нескольких ключевых вопросов, которые помогут вам выяснить, где что смотреть.

Возможные причины боли внизу живота:

1. **Менструальные нарушения** (с. 246). Бывает ли хуже перед или во время менструации?
2. **Инфекция в мочевом пузыре** (с. 235). Одна из самых обычных причин умеренных болей в нижней части живота. Мочеиспускания частые или болезненные?
3. **Воспаления тазовых органов**. Это почти всегда поздняя стадия гонореи или хламиды (с. 237) с болью в нижней части живота и жаром. Если эти признаки умеренные, лечитесь от гонореи (с. 360) и принимайте тетрациклин (с. 356) или эритромицин (с. 355) 14 дней. Если признаки более серьезные, принимайте от 400 до 500 мг метронидазола 3 раза в день 10 дней. Если женщина пользуется внутриматочной спиралью (ВМС), ее следует удалить. Покажитесь врачу.
4. **Болезни, которые имеют отношение к опухолям или уплотнениям в нижней части живота**. Они кратко обсуждались на странице 280 и включают кисту яичников и рак. Требуется специальное обследование, проведенное опытным врачом.
5. **Внематочная беременность** (когда ребенок начинает развиваться вне матки). Обычно сильная боль и нерегулярное кровотечение. У женщины часто бывают ранние признаки беременности (см. с. 247), она чувствует головокружение и слабость. Немедленно обратитесь за медицинской помощью; ее жизнь в опасности.
6. **Осложнение после аборта** (с. 414). Может быть жар, кровотечение из влагалища со сгустками кусками, боль в брюшной полости, трудности с мочеиспусканием, шок. Начните давать пенициллин (кристаллин, если можно) и сразу же доставьте женщину в больницу. Ее жизнь в опасности.
7. **Инфекция или другое заболевание кишечника или прямой кишки** (с. 145). Относиться ли боль к еде или к опорожнению?

Некоторые из вышеперечисленных проблем не очень серьезные, другие очень серьезные. Их не всегда легко разделить. Требуются анализы или нужно провести обследование.



Если вы не уверены в том, что вызывает боль, или если вам не становится лучше, обратитесь к врачу.

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ (БЕСПЛОДИЕ)

Иногда мужчина и женщина пытаются завести детей, но женщина не может забеременеть. Или мужчина, или женщина могут быть бесплодны (не могут вызвать беременность). Часто ничем нельзя помочь человеку при бесплодии, но иногда что-то можно сделать в зависимости от причины.

ОБЫЧНЫЕ ПРИЧИНЫ БЕСПЛОДИЯ:

1. **Стерильность.** Организм у человека такой, что он или они никогда не смогут иметь детей. Некоторые женщины и мужчины рождаются стерильными.
2. **Слабость или плохое питание.** У некоторых женщин сильная анемия, плохое питание и недостаток йода могут снизить шанс стать беременной. Или это может вызвать смерть неразвившегося ребенка (эмбриона), возможно прежде, чем мать узнает, что она беременна (смотри Выкидыш, с. 281). Женщина, которая не может забеременеть, или если у нее только что был выкидыш, должна хорошо питаться, пользоваться йодированной солью и, если у нее сильная анемия, принимать пилюли железа (с. 247). Это увеличит ее шанс стать беременной и родить здорового ребенка.
3. **Хроническая инфекция,** особенно воспаление тазовых органов (см. Гонорея и Хламиды, с. 243) – обычная причина бесплодия у женщин. Лечение может помочь, если болезнь зашла не слишком далеко. Предупреждение и раннее лечение гонореи и хламиды означают небольшую стерилизацию женщины.
4. Женщина иногда не может забеременеть, потому что у **мужчины** вырабатывается мало спермы. Мужчине следует обойтись без секса несколько дней, прежде чем женщина войдет в свои “плодородные дни” – каждый месяц посередине между предыдущей менструацией и следующей (смотри Метод Ритма или Метод Слизи, с. 291 и 292). Таким способом он отдаст ей полное количество спермы, когда у них будет половой контакт в подходящее для зачатия время.

ВНИМАНИЕ: Гормоны и другие лекарства, которые обычно принимают мужчины и женщины, если не могут иметь детей, почти никогда не помогают, особенно мужчинам. Домашние средства и магическое лечение тоже не могут решить эту проблему. Не тратьте ваши деньги на то, что не поможет.

Если вы женщина и не можете иметь детей, существует много других возможностей, ведущих к счастливой и благополучной жизни:

- Может быть, вы можете организовать уход и усыновить сирот или бездомных детей. Многие пары берут и любят таких детей как своих собственных.
- Возможно, вы сможете стать работником здравоохранения или помогать своим односельчанам другим способом. Вашу любовь, которую вы могли бы дать своим детям, отдайте другим и всем будет польза.
- Вы можете жить в деревне, где люди неодобрительно смотрят на женщин, которые не могут иметь детей. Может быть, вы и другие сможете организовать группу помощи нуждающимся и показать, что иметь детей – это не единственное, что может сделать женщину счастливой.



СВЕДЕНИЯ ДЛЯ МАТЕРЕЙ И АКУШЕРОВ

ГЛАВА

19

МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН)

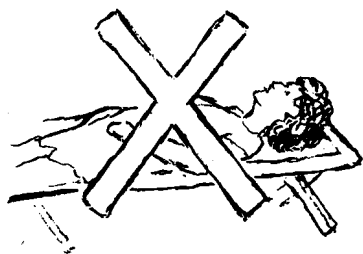
У большинства девочек их первая “менструация” или месячное кровотечение появляется между 11 и 16 годами. Это означает, что они стали достаточно взрослыми, чтобы забеременеть.

Нормальные месячные приходят через 28 дней или около этого и длятся от 3 до 6 дней. Однако это происходит по-разному у разных женщин.

Нерегулярные и болезненные месячные обычно бывают у девочек (подростков). Это вовсе не означает, что есть какое-то нарушение.

Если у вас менструальный период болезненный:

Не следует оставаться в постели. Действительно, лежа спокойно, можно усилить боль.



Больше помогут прогулки и легкая работа или упражнения...



или выпейте горячие напитки, или поместите ваши ноги в горячую воду.



Если месячные очень болезненны, примите аспирин (с. 379) или ибупрофен (с. 380) и положите теплый компресс на живот.

Во время месячных — как и всегда — женщина должна поддерживать чистоту, хорошо спать, питаться хорошо сбалансированной едой. Она может есть все, что ест обычно, и может продолжать делать обычную работу. Не приносит вреда и секс во время менструаций.

Признаки менструальных проблем:

- ◆ Некоторая нерегулярность в появлении месячных для одних женщин нормальна, а для других может быть признаком хронической болезни, анемии, истощения или возможной инфекции или опухоли в матке.
- ◆ Если месячные не пришли вовремя, это может быть признаком беременности. Но для многих девочек, у которых недавно начались менструации, и для женщин, старше 40, часто бывает нормальным явлением отсутствие или нерегулярность прихода менструации. Беспокойство или эмоциональное расстройство тоже могут вызвать задержку месячных.
- ◆ Если кровотечение приходит позже, чем ожидается, или более сильное и длится дольше, это может быть выкидыш (см. с. 281).
- ◆ **Если менструация длится более 6 дней, кровотечение при этом необычно сильное или приходит чаще, чем один раз в месяц, обратитесь за советом к медику.**

МЕНОПАУЗА (КОГДА У ЖЕНЩИН ПРЕКРАЩАЮТСЯ МЕСЯЧНЫЕ)

Менопауза или климакс – это период в жизни женщины, когда у нее перестают приходить месячные. После климакса она не может вынашивать ребенка. Как правило, это “изменение в жизни” происходит в возрасте от 40 до 50 лет. Цикл становится нерегулярным за несколько месяцев до того, как прекратится совсем.

Нет никаких причин, чтобы прекращать секс в течение или после менопаузы. Но женщина может забеременеть в это время. Если же она не хочет больше иметь детей, она должна пользоваться противозачаточными пиллюлями в течение 12 месяцев после того, как прекратятся месячные.

Когда начинается менопауза, женщина думает, что она беременна. А когда через 3 или 4 месяца опять начинается кровотечение, она считает, что у нее выкидыш. Если у женщины 40 или 50 лет снова начинаются месячные после нескольких месяцев их отсутствия, объясните ей, что это может быть менопауза.

Во время менопаузы нормально чувствовать некоторый дискомфорт – беспокойство, стресс, “приливы жара” (внезапное ощущение жара), боль во всем теле, тошнота и т.д. После окончания менопаузы большинство женщин чувствуют себя хорошо.

Женщины, у которых бывает сильное кровотечение или сильные боли в животе во время менопаузы, и те, у которых опять через несколько месяцев или несколько лет после прекращения менструаций начинается кровотечение, должны обратиться к врачу. Обследование необходимо, чтобы убедиться, что нет рака или других серьезных проблем (с. 280).

После менопаузы кости женщины становятся слабее и ломаются легче. Для предупреждения этого нужно есть пищу с кальцием (см. с. 116).

Поскольку женщина не сможет больше иметь детей, у нее появится больше свободного времени для общения с внуками или для большей активности в общественной жизни. Некоторые становятся акушерками или медсестрами в этот период жизни.

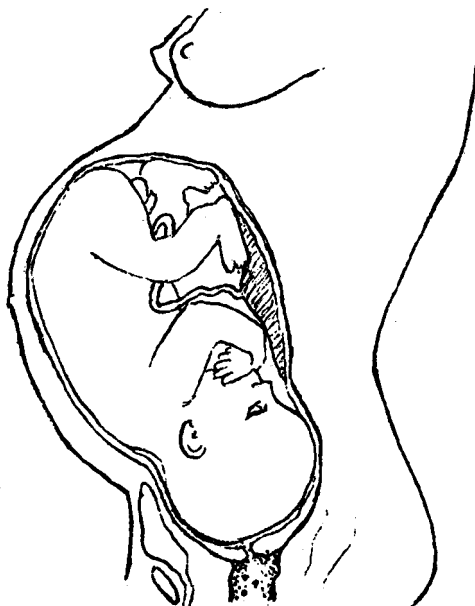


БЕРЕМЕННОСТЬ

Признаки беременности:

Все эти признаки нормальные:

- У женщины нет менструаций (часто первый признак).
- “Утренняя болезнь” (тошнота или ощущение, что вы собираетесь вырвать, особенно утром). Все это усиливается на втором и третьем месяце беременности.
- Она чаще мочится. Живот становится больше.
- Груды становятся больше или болезненными.
- “Маска беременности” (темные места на лице, груди и животе).
- Наконец, на пятом месяце или около этого ребенок зашевелится в матке.



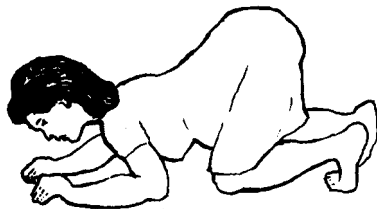
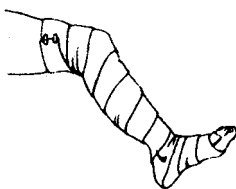
Нормальное положение ребенка в животе матери в 9 месяцев.

КАК ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВОЙ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

- ◆ Очень важно **достаточно есть**, чтобы регулярно набирать вес - особенно, если вы худая.
- ◆ Очень важно **хорошо питаться**. Организм нуждается в еде, богатой протеинами, витаминами и минералами, особенно железом. (Читайте Главу 11 этой книги.)
- ◆ **Употребляйте йодированную соль**, чтобы увеличить шанс рождения психически здорового ребенка. (Но чтобы избежать отека ног и других проблем, не употребляйте слишком много соли.)
- ◆ **Поддерживайте чистоту**. Купайтесь или мойтесь регулярно и чистите зубы каждый день. В последний месяц беременности возможно лучше всего не применять влагалищное спринцевание и **избегать сексуальных контактов**, чтобы не разрушить плодный мешок и не внести инфекцию.
- ◆ **Избегайте приема лекарств**, если это вообще возможно. Некоторые лекарства могут навредить развивающемуся ребенку. Как правило, принимайте только те лекарства, которые рекомендует работник здравоохранения или врач. (Если работник здравоохранения назначает вам лекарство, а вы думаете, что беременны, скажите ему об этом.) Можете изредка принимать аспирин, ацетаминофен или антациды, если они вам нужны. Витамины и таблетки железа полезны и не наносят вред, если принимать правильную дозу.
- ◆ **Не курите и не пейте алкоголь** во время беременности. Курение и выпивка плохо сказываются на матери и вредят развивающемуся ребенку.
- ◆ Держитесь подальше от детей с корью, особенно **коровей краснухой** (см. Краснуха, с. 312).
- ◆ Продолжайте работать и **делать зарядку**, но старайтесь не слишком уставать.
- ◆ **Избегайте ядов и химикатов**. Они могут навредить развивающемуся ребенку. Не работайте около пестицидов, гербицидов или фабричных химикатов. Не храните еду в контейнерах из-под них. Не дышите дымом и пылью от химикатов.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

1. **Тошнота или рвота:** Обычно, хуже по утрам, в течение второго и третьего месяцев беременности. Рекомендуется съесть что-нибудь сухое, типа печенья или сухаря, перед сном и утром перед подъемом. Не съедайте много за один раз, а лучше понемногу несколько раз в день. Избегайте жирной пищи. Еще помогает чай, заваренный из листьев мяты. В тяжелых случаях принимайте антигистамин (см. с. 386) перед сном и утром, когда проснетесь.
2. **Жжение или боль** в подложечной ямке (кислотное несварение и изжога, см. с. 128): Употребляйте только небольшими порциями и почаще пейте воду. Могут помочь антациды, особенно с углекислым кальцием (см. с. 382). Помогает еще и сосание конфеты-леденца. Старайтесь спать, подложив подушку или одеяло под грудь и голову.
3. **Отеки ног:** Отдыхайте время от времени в течение дня с приподнятыми ногами (см. с. 176). Ешьте меньше соли и избегайте соленой пищи. Может помочь чай из кукурузных рыльцев (см. с. 12). Если очень сильно отекают ноги, лицо и руки, обратитесь за советом к врачу. Отеки ног обычно вызываются давлением ребенка на матку в последние месяцы. Отечность усиливается у женщин с анемией, истощением или у тех, кто употребляет много соли. Поэтому **ешьте питательную пищу** с малым количеством соли.
4. **Боль внизу спины:** Это обычно при беременности. В таких случаях может помочь, если вы будете делать физические упражнения и внимательно следить за тем, чтобы стоять и сидеть прямо.
5. **Анемия и недоедание:** Многие женщины в сельской местности страдают анемией даже перед беременностью и становятся еще более анемичными во время беременности. Чтобы родить здорового ребенка, женщине необходимо **хорошо питаться**. Если она очень бледная и слабая или есть другие признаки анемии и истощения (см. с. 109 и 124), ей нужно больше употреблять протеина и еды с железом — бобы, арахис, цыплята, молоко, сыр, яйца, мясо, рыба и темно-зеленые листовые овощи. Ей следует также принимать **пилюли железа** (с. 393), особенно, если трудно достать питательные продукты. Таким образом, она усилит кровь для сопротивления опасному кровотечению после родов. Если возможно, то в пилюлях железа должны содержаться **фолиевая кислота и витамин С**.
6. **Вздутые вены (варикозное расширение вен):** Они обычны при беременности, поскольку ребенок своим весом давит на вены, которые идут от ног. Почаще и повыше поднимайте ноги (см. с. 175). Если вены стали очень большими или болят, оберните эластичным бинтом или пользуйтесь эластичными чулками. Снимайте бинты или чулки на ночь.
7. **Шишки (геморрой):** Это варикозные вены в анусе. Появляются в результате увеличения веса ребенка в матке.
Для облегчения боли встаньте на колени, ягодицами вверх, как здесь, или сядьте в теплую ванну (см. также с. 175).
8. **Запор:** Пейте больше воды. Ешьте фрукты и пищу с большим количеством натуральных волокон, такую как кассава или отруби. Делайте больше физических упражнений. **Не принимайте сильных слабительных препаратов.**



ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

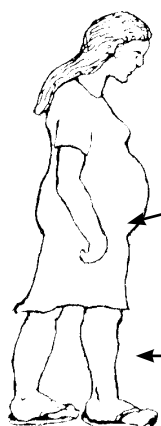
1. **Кровотечение:** Если у женщины во время беременности начинается кровотечение, даже небольшое, это опасный признак. У нее может быть выкидыш (потеря ребенка, с. 281) или ребенок может развиваться вне матки (внематочная беременность, с. 280). Женщина должна лежать спокойно и послать кого-нибудь за врачом.

Кровотечение в поздних сроках беременности (после 6 месяцев) может означать, что плацента (детское место) закрывает отверстие для родов (предлежание плаценты). Без специальной помощи женщина может истечь кровью до смерти. Постарайтесь сразу же ее госпитализировать.

2. **Серьезная анемия:** Женщина слабая, уставшая и имеет бледную или прозрачную кожу (смотри Признаки Анемии, с. 124). Если не лечить, она может умереть от потери крови при родах. При серьезной анемии недостаточно хорошей диеты, чтобы вовремя исправить положение. Обратитесь к гинекологу и принимайте таблетки солей железа (см. с. 393). По возможности она должна рожать ребенка в больнице на тот случай, если понадобится дополнительная кровь.
3. **Отеки** ног, рук и лица, головные боли, головокружение и иногда пелена перед глазами – все это признаки токсикоза или отравления беременных. Внезапное увеличение массы тела, высокое кровяное давление и появление белка в моче являются другими важными признаками. Поэтому по возможности посетите акушерку или медработника, который сможет определить это.

Для лечения ТОКСИКОЗА БЕРЕМЕННЫХ женщина должна:

- ◆ Лежать спокойно в постели.
- ◆ Кушать пищу, богатую протеином, но содержащую мало соли. Избегать соленых продуктов.
- ◆ Если не становится лучше, ухудшается зрение, сильнее отекает лицо или появляются припадки (конвульсии), обратитесь быстрее за медицинской помощью. Ее жизнь в опасности.



В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 МЕСЯЦЕВ
БЕРЕМЕННОСТИ:

Если у вас головная боль или неясное зрение и если лицо и руки начинают отекать, вы можете быть уверены, что это ТОКСИКОЗ БЕРЕМЕННЫХ.

ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ!

Если отекают только ноги, это не страшно. Но наблюдайте за другими признаками токсикоза. Употребляйте мало соли.

Для предупреждения ТОКСИКОЗА БЕРЕМЕННЫХ: употребляйте сбалансированную и малосольную пищу. Убедитесь, что она достаточно богата протеином (с. 110).

ПРОВЕРКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ (ПРЕДРОДОВОЙ УХОД)

Многие центры здоровья и акушерки убеждают беременных женщин приходить для регулярных предродовых (перед родами) проверок и говорить о своих проблемах со здоровьем. Если вы беременны и у вас есть возможность приходить на эти проверки, вы узнаете много вещей, которые помогут вам избежать проблем и иметь здорового ребенка.

Если вы акушерка, вы можете оказать важную услугу будущей матери (и будущему ребенку), пригласив их прийти на предродовые проверки – или сходить самой для их осмотра. Было бы очень хорошо осматривать их **один раз в месяц в первые 6 месяцев беременности, дважды в месяц на 7-м и 8-м месяцах и один раз в неделю в течение последнего месяца.**

Есть некоторые важные вещи, которых следует придерживаться во время предродового ухода:

1. Обмен информацией

Выясните у матери ее проблемы и потребности. Узнайте, сколько у нее было беременностей, когда был последний ребенок и какие осложнения у нее могут быть во время беременности или родов. Расскажите ей о том, каким образом она может помочь себе и ребенку быть здоровыми, включая:

- ♦ **Правильное питание.** Убедите ее кушать пищу, богатую протеином, витаминами, железом и кальцием (смотри Главу 11).
- ♦ **Хорошая гигиена** (Глава 12 и с. 242).
- ♦ Важно принимать **немного лекарств или вовсе не принимать** (с. 54).
- ♦ Важно **не курить** (с. 149), **не пить алкогольные напитки** (с. 148) и **не использовать наркотики** (с. 416 и 417).
- ♦ Выполнять **физические упражнения и отдыхать.**
- ♦ **Вакцинация от столбняка** предупредит столбняк у новорожденного. (Проводить на 6-м, 7-м и 8-м месяце, если они впервые. Если она была привита против столбняка прежде, сделайте одну на 7-м месяце).

2. Питание

Выглядит ли мать хорошо упитанной? Есть ли у нее анемия? Если это так, обсудите способы улучшения питания. Если возможно, проследите, чтобы она принимала пилюли железа – лучше с фолиевой кислотой и витамином С. Посоветуйте ей, как справиться с утренней болезнью (с. 248) и изжогой (с. 128).

Набирает ли она нормально вес? По возможности взвешивайте ее в каждое посещение. Нормально она должна набрать от 8 до 10 килограмм в течение 9 месяцев беременности. Если она перестает набирать вес – это плохой признак. Внезапный рост веса в последний месяц – это опасный признак. Если у вас нет весов, старайтесь определить, набирает ли она вес, по ее внешнему виду.

Или сделайте простые весы.



3. Мелкие проблемы

Спросите у матери, есть ли у нее обычные недомогания при беременности. Объясните, что они несерьезные, и посоветуйте, что делать (см. с. 248).

4. Признаки опасности и особого риска

Проверьте на каждый из опасных признаков по странице 249. Проверяйте пульс матери при каждом посещении. Это даст вам знать, что для нее будет нормальным в случае, если у нее появятся проблемы позже (например, шок от токсикоза или сильное кровотечение). Если у вас есть прибор, измерьте у нее **кровенное давление** (с. 410). И **взвесьте ее**. Особо наблюдайте за следующими опасными признаками:

- ◆ внезапный рост веса
 - ◆ отеки рук и лица
 - ◆ повышение кровяного давления
 - ◆ сильная анемия (с. 125)
 - ◆ любое кровотечение (с. 249)
- } признаки токсикоза беременных (с. 249)

Некоторые акушерки могут иметь специальные бумажные полоски для погружения в мочу или другие методы измерения белка или сахара в моче. Высокий белок может быть признаком токсикоза. Высокий сахар может быть признаком диабета (с. 127).

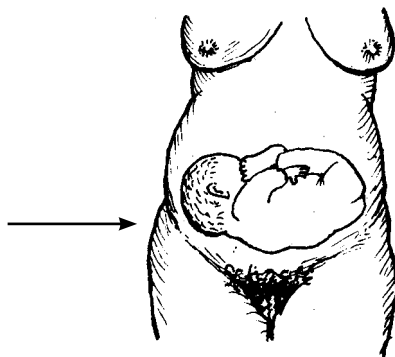
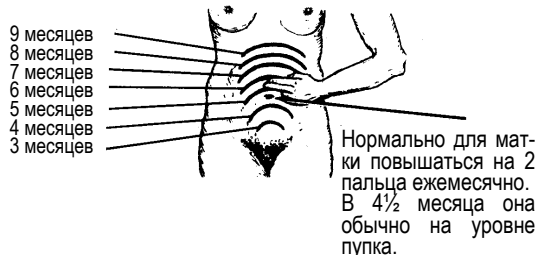
Если появляется какой-либо из опасных признаков, проследите, чтобы женщина поскорее получила медицинскую помощь. Кроме того, проверьте на признаки особого риска, с. 256. Если какой-либо из них есть, будет безопаснее, чтобы роды у матери приняли в больнице.

5. Рост и положение ребенка в матке

Прощупывайте матку матери при каждом посещении; или покажите ей, как сделать это самой.

Ежемесячно записывайте, на сколько пальцев матка выше или ниже пупка. **Если матка кажется слишком большой или растет слишком быстро**, это может означать, что у женщины будет двойня. Или в матке вод больше нормы. Если это так, вам будет трудно прощупать плод. Чрезмерное количество вод в матке представляет больший риск сильного кровотечения при родах и может означать, что ребенок деформирован.

Старайтесь определить положение ребенка в матке. Если окажется, что он лежит боком, матери следует пойти к врачу **перед** родами, потому что может понадобиться операция. Чтобы проверить положение ребенка ближе к родам, смотри с. 257.



6. Сердцебиение ребенка (сердцебиение плода) и шевеление

После 5 месяцев прослушивают сердцебиение ребенка и проверяют шевеление. Вы можете попробовать сделать это, приложив ухо к животу, но так трудно услышать. Будет легче, если вы достанете фетоскоп. (Или сделайте его сами. Подойдет обожженная глина или твердое дерево.)

Если сердцебиение ребенка слышно громче всего ниже пупка в последний месяц, голова ребенка внизу и, вероятно, он будет идти вперед головой при родах.



Если сердцебиение слышно громче вверху, он может идти ягодицами вперед при родах.



ФОНЕНТОСКОП

Пuls ребенка в два раза чаще, чем у взрослых. Если у вас есть часы на другой руке, сосчитайте пульс ребенка. Норма от 120 до 160 ударов в минуту. Если ниже 120 значит, что-то неправильно. (Или может вы неправильно считаете, или прослушиваете сердцебиение матери. Проверьте ее пульс. Сердцебиение ребенка часто трудно услышать. Нужна практика.)

7. Подготовка матери к родам

При приближении родов посещайте ее чаще. Если у нее есть другие дети, выясните, какой была продолжительность предыдущих родов и были ли у нее проблемы. Можете предложить ей отдохнуть, лежа после еды, по часу дважды в день. Поговорите с ней о том, как можно облегчить роды и сделать их менее болезненными (смотри следующие страницы). Вы можете посоветовать ей попрактиковаться дышать глубоко и медленно, чтобы она смогла делать это во время схваток. Объясните, как важно расслабиться между схватками.

Если есть причины подозревать, что при родах могут возникнуть проблемы, с которыми вы не справитесь, отправьте мать рожать в центр здоровья или в больницу. Убедитесь, что она недалеко от больницы к тому времени, когда начнутся роды.

**Как мать может рассчитать дату, когда она вероятно родит:
Начните с даты, когда началась последняя менструация, отнимите 3 месяца и прибавьте 7 дней. Например, ваши последние месячные начались 10 мая.**

Мая 10 минус 3 месяца – это 10 февраля.

Плюс 7 дней – это 17 февраля.

Ребенок предположительно родится около 17 февраля.

8. Ведите записи

Чтобы сравнивать свои заключения месяц от месяца и следить за состоянием матери, ведите простые записи. На следующей странице приведен образец таких записей. Измените его так, как вам подходит. Большой лист бумаги будет лучше. Каждая мать может вести свои записи и приносить их с собой, когда приходит на проверку.

КАРТА ПРЕРОДОВОГО УХОДА

имя _____ возраст _____ количество детей _____ их возраст _____ дата последних родов _____
дата последней менструации _____ приблизительная дата родов _____ проблемы с другими родами _____

Месяц	Дата визита	Частые проблемы	Общее состояние здоровья и знач. проблемы	Анемия (как остро)	Опасные признаки (см. с. 249)	Опухоль (где?)	Пульс	Темп-ра	Вес	Кровяное давление	Белок в моче	Сахар в моче	Положение ребенка в матке	Размер матки (сколько пальцев над или под пупком?)
1														-
2		слабость, тошнота, рвота												-
3														-
4														-
5		сердцебиение плода, первое движение												0
6														прививка от столбняка
7 (1 неделя)		опухоль на ногах												1
(3 неделя)														2
8 (1 неделя)														3
(3 неделя)		варикозные вены												+
9 (1 неделя)		частота дыхания												+
(2 неделя)		частота мочеиспускания												+
(3 неделя)		младенец движется в низ живота												+
(4 неделя)														+
Роды														+

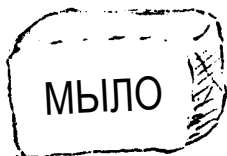
ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ МАТЬ ДОЛЖНА ПРИГОТОВИТЬ К РОДАМ

У каждой беременной женщины к седьмому месяцу беременности должны быть готовы следующие вещи.

Побольше кусочков
очень чистой ткани
или тряпочек.



Антисептическое мыло
(или любое другое мыло)



Чистая жесткая щетка для
очищения рук и ногтей.



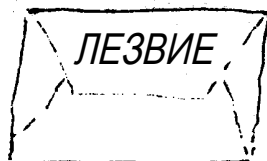
Спирт для протирания
рук после мытья.



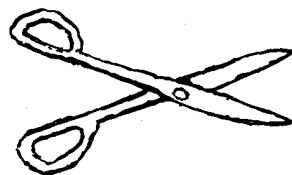
Чистая вата.



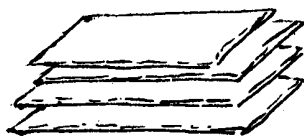
Новое бритвенное
лезвие. (Не
открывать его
до тех пор, пока
не потребуется
обрезать пуповину.)



(Если у вас нет нового
лезвия, приготовьте чистые,
без ржавчины ножницы.
Прокипятите их перед тем,
как обрезать пуповину.)



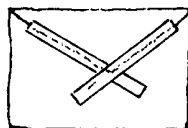
Стерильную марлю или
прокладки из тщательно
отстиранной ткани для
прикрывания пупка.



Две полоски или ленты из чистой
ткани для перевязки пуповины.



Полоски и прокладки
следует сложить
и запечатать в
бумажном пакете,
а потом прожарить
его в духовке или
прогладить.



Дополнительные Средства для Хорошо Подготовленной Акушерки или для Принимающего Роды

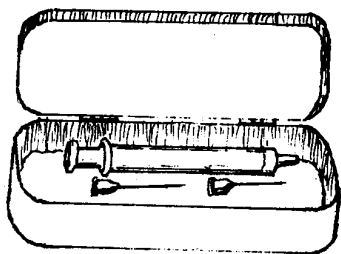
Фонарик (ручной).



Отсос для отсасывания из слизи из носа и рта ребенка.



Стерильный шприц и иглы.



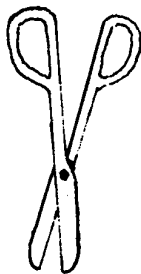
Несколько ампул эргоновина или эргометрина (см. с. 391).



Два таза – 1 для мытья рук и 1 для приема и обследования последа.

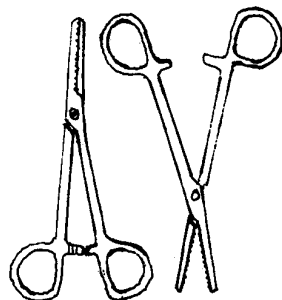


Фетоскоп – или фетальный стетоскоп – для прослушивания сердцебиения ребенка через живот матери.



Ножницы с затупленными концами для обрезания пуповины, прежде чем ребенок полностью выйдет (только в крайнем случае).

Два зажима для зажимания пуповины или зажимания кровоточащих вен при разрывах родового отверстия.



Резиновые или пластиковые перчатки (которые можно простерилизовать кипячением, см. с. 74) надевают, когда осматривают женщину, когда выходит ребенок, когда зажимают разрывы родового отверстия и для приема и осмотра последа.

Стерильная игла и кетгут для наложения швов на разрывы родового отверстия.



Тетрациклиновая глазная мазь, эритромициновая глазная мазь или 1% капли нитрата серебра для ребенка, чтобы предупредить опасную инфекцию (см. с. 221).



ПОДГОТОВКА К РОДАМ

Роды – это нормальное событие. Когда мать здорова и все идет хорошо, ребенок может родиться без чьей-либо помощи. При нормальных родах, **чем меньше работы у акушеров или у обслуживающих роды, тем вероятнее, что все пройдет хорошо.**

При родах случаются трудности, и иногда жизнь матери и ребенка может подвергаться опасности. **Если есть основания считать, что роды могут быть трудными или опасными, при родах должны присутствовать квалифицированная акушерка или опытный врач.**

ОСТОРОЖНО: Если у вас жар, кашель, воспаление горла или раны или инфекции на коже ко времени родов, было бы лучше, чтобы кто-то принял ребенка.

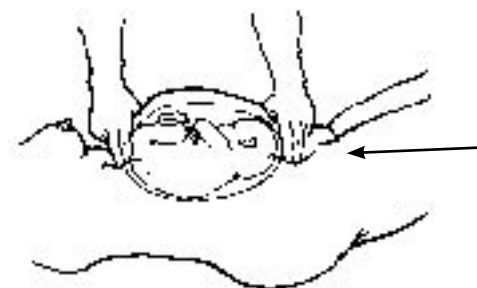
Признаки Особого Риска, которые Делают Необходимым Присутствие Врача или Квалифицированной Акушерки при Родах – если Возможно, в Больнице:

- Если обычная родовая деятельность начинается более чем за 3 недели до ожидаемых родов.
- Если женщина начинает кровоточить перед родами.
- Если есть признаки токсикоза беременных (с. 249).
- Если женщина страдает от хронической или острой болезни.
- Если у женщины анемия или у нее не сворачивается нормально кровь (когда она порежется).
- Если ей до 15, после 40 или после 35 при первой беременности.
- Если у нее больше 5 или 6 детей.
- Если у нее особенно короткие или узкие бедра (с. 267).
- Если у нее было серьезное осложнение или сильное кровотечение при других родах.
- Если у нее диабет или болезнь сердца.
- Если у нее грыжа.
- Если похоже, что у нее будет двойня (с. 269).
- Если кажется, что плод неправильно расположен в матке.
- Если плодный мешок лопается, а роды не начинаются в течение нескольких часов. (Опасность еще больше, если есть жар).



ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕБЕНКА

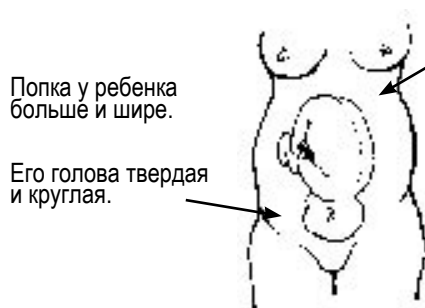
Чтобы убедиться, что ребенок находится головкой вниз, в нормальном положении для родов, прощупайте его головку, как здесь:



1. Заставьте мать постоянно выдыхать.

Большим и вторым пальцем, вдавите здесь, прямо выше тазовой кости.

Другой рукой пощупайте верхушку матки.



Попка у ребенка больше и шире.

Его голова твердая и круглая.

Попка вверх на ощупь больше вверх.



Попка вниз на ощупь больше внизу.



2. Осторожно прощупайте из стороны в сторону, сначала одной рукой, затем другой.

Если попку ребенка легонько сдвинуть в сторону, все тело ребенка тоже сдвинется.

Но если головку осторожно сдвинуть в сторону, она наклонится к шее, а спина не сдвинется.



Если ребенок еще высоко в матке, можно слегка подвинуть головку. Но если она уже опустилась (соскользнула ниже), готовясь к родам, вы не сможете двигать ею.

Первый ребенок у женщины иногда опускается за 2 недели до родов. Следующие дети могут не опускаться до самого начала родов.



Если голова ребенка внизу, его роды пройдут хорошо. Если голова ребенка вверх, роды могут быть тяжелыми (роды ягодицами), и безопаснее для матери рожать в больнице. Если ребенок лежит поперек, мать должна рожать в больнице. Она и ребенок в опасности (см. с. 267).

ПРЕДВЕСТНИКИ БЛИЗКИХ РОДОВ

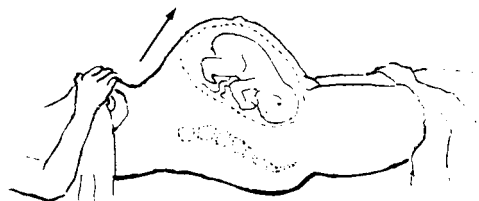
- За несколько дней до начала родов **ребенок опускается ниже** в матке. Женщине становится легче дышать, но зато она мочится чаще, потому что ребенок давит на мочевой пузырь. (При первых родах эти предвестники могут появиться за 4 недели до родов.)
- Незадолго до начала родов может выйти **маленькая пробка слизи** (желеобразная). Или за 2 или 3 дня до родов может выделяться густая слизь. Иногда она бывает с примесью крови. Это нормально.
- **Схватки** (внезапное сжатие матки) или родовые боли могут начаться за несколько дней до родов; сначала промежутки времени между схватками большой – от нескольких минут до нескольких часов. Когда схватки становятся сильнее, регулярнее и чаще, начинаются роды.
- У некоторых женщин бывает несколько **предварительных схваток** за неделю до родов. Это нормально. В редких случаях у женщин бывают **ложные роды**. Это случается, когда приходящие схватки сильные и частые, а потом прекращаются на часы или дни до начала реальных родов. Иногда прогулка, теплая ванна или отдых помогут успокоить схватки, если они ложные, или подвести к родам, если они настоящие. Даже если это ложные роды, схватки помогут подготовить матку к родам.

Родовые боли вызываются схватками или сжатием матки.

Между схватками матка расслаблена ,как здесь:



Во время схваток матка сжимается и поднимается, как здесь:



Схватки толкают ребенка дальше вниз. Это заставляет шейку или “дверь матки” открываться – понемногу в течение каждой схватки.

- **Плодный пузырь**, в котором находится ребенок в матке, обычно разрывается и околоплодные воды иногда изливаются после начала родов. Если воды отходят до начала схваток, обычно это означает начало родов. После отхода вод мать нужно содержать в чистоте. Ходьба вперед и назад может помочь более быстро вызвать роды. Чтобы предупредить инфекцию, избегайте сексуальных контактов, не сидите в ванне с водой, не *спринцуйтесь*. Если роды не начались в течение 12 часов, вызовите врача.

ПЕРИОДЫ РОДОВ

Роды делятся на 3 части или периода:

- Первый период длится от начала сильных схваток до тех пор, пока ребенок не войдет в родовой канал.
- Второй период длится от вхождения ребенка в родовой канал до того, как он родится.
- Третий период длится от рождения ребенка до выхода плаценты.

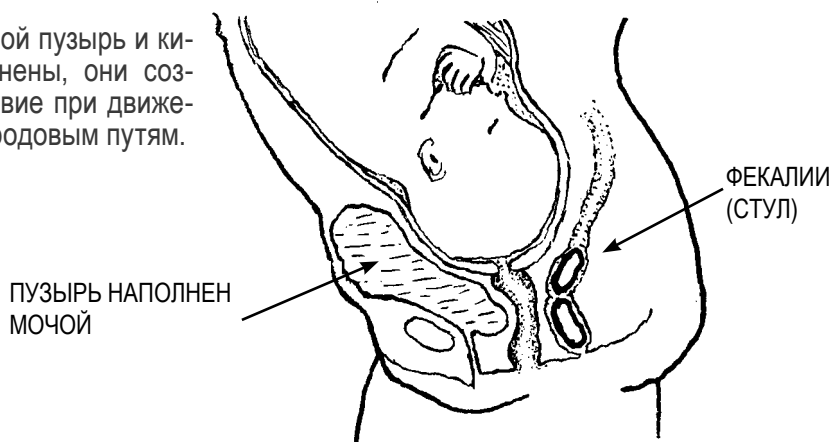
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ обычно продолжается от 10 до 20 часов или больше, если мать рожает первый раз, и от 7 до 10 часов при повторных родах. Продолжительность этого периода сильно меняется.

В течение первого периода родов матери не следует торопиться с рождением. Для этого периода естественно медленное течение. Мать может не чувствовать прогресса и начать беспокоиться. Постарайтесь успокоить ее. Объясните ей, что это относится к большинству женщин.

Матери не следует пытаться вытолкнуть или изгнать плод из матки, пока он не начнет продвижение в родовой канал, а она не почувствует, что должна тужиться.

Матери нужно опорожниться и помочиться.

Если мочевого пузыря и кишечника наполнены, они создают препятствие при движении плода по родовым путям.



Во время родов матери следует часто мочиться. Если она не опорожнилась за несколько часов, клизма может облегчить роды. Во время родов матери следует чаще пить воду или другие напитки. Слишком малое количество воды в организме может замедлить или остановить роды. Если роды затягиваются, ей нужно слегка перекусить. Если ее рвет, она должна пить глотками напиток регидрона, травяной чай или фруктовые соки между схватками.

Во время родов женщине следует почаще менять положение или время от времени вставать и ходить. Ей не следует долгое время лежать на спине.

Во время первого периода родов акушерка или принимающий роды должны:

- ◆ Вымыть хорошо теплой водой с мылом живот женщины, половые органы, ягодицы и ноги. Кровать должна находиться в чистом месте, достаточно освещенном, чтобы было все ясно видно.
- ◆ Расстелите на кровати чистые простыни, полотенца или газеты и меняйте их, как только станут мокрыми или грязными.
- ◆ Держите наготове новое, нераспечатанное бритвенное лезвие для обрезания пуповины и прокипятите пару ножниц в течение 15 минут. Держите ножницы в кипяченой воде в закрытой кастрюле, пока они не понадобятся.

Акушерка **не** должна массировать или давить на живот. Она **не** должна в это время просить мать выталкивать или изгонять плод.

Если мать напугана или у нее сильная боль, заставьте ее делать глубокие, **медленные**, регулярные вдохи во время схваток и нормально дышать между ними. Это поможет остановить боль и успокоить мать. Убедите роженицу, что сильные боли обычны и что они помогают ей выталкивать ребенка.

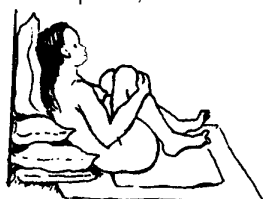
ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ, в котором рождается ребенок: Иногда это начинается, когда разрывается плодный пузырь. Этот период часто легче первого и обычно не занимает больше 2 часов. Во время схваток мать изгоняет (выталкивает) плод со всей своей силой. Между схватками она может выглядеть очень усталой и полусонной. Это нормально.

Чтобы вытолкнуть, женщине следует сделать глубокий вдох и напрячь мышцы живота так, как будто она опорожняется. Если ребенок выходит медленно после того, как отошли околоплодные воды, мать может соединить колени, как здесь, сидя

на корточках,



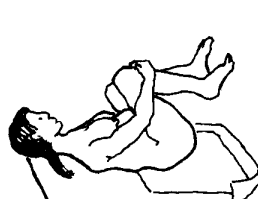
опираясь,



на коленях



или лежа.



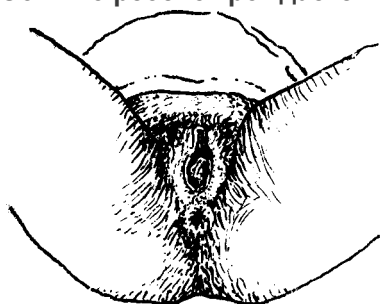
Когда родовое отверстие вытягивается и начинает показываться головка ребенка, акушерка или помощник должны приготовить все для приема новорожденного. В это время мать должна стараться **не** тужиться сильно, так чтобы головка ребенка выходила помедленнее. Это помогает предупредить разрывы отверстия (см. с. 269).

При нормальных родах акушерка никогда не должна всовывать свою руку или пальцы внутрь роженицы. Это наиболее распространенная причина опасных инфекций матери после родов.

Когда выходит головка ребенка, акушерка может поддержать ее, но никогда не должна ее тянуть.

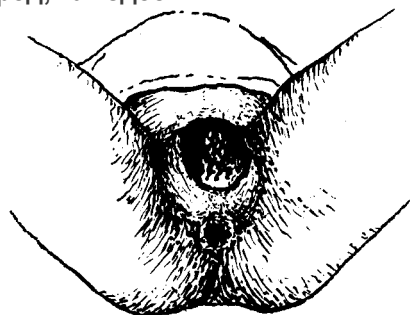
Обычно ребенок рождается головой вперед, как здесь:

1.



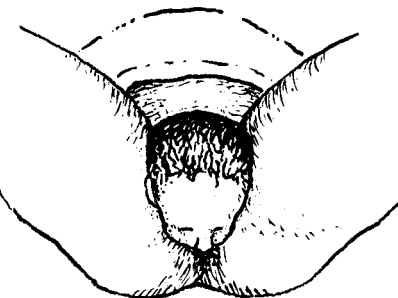
Теперь тужитесь сильно.

2.



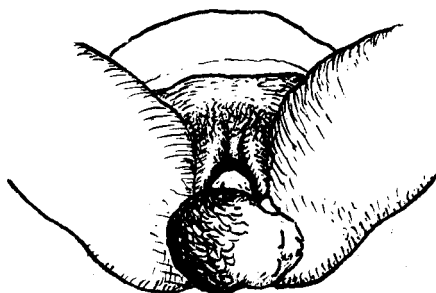
Теперь старайтесь не тужиться. Делайте короткие, частые вдохи. Это поможет избежать разрывов отверстия (см. с. 269).

3.



Головка обычно выходит лицом вниз. Если у ребенка кал во рту и в носу, очистите немедленно (см. с. 262).

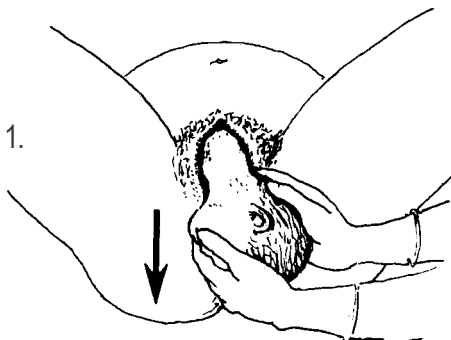
4.



Затем поверните головку ребенка набок, чтобы могли выйти плечи.

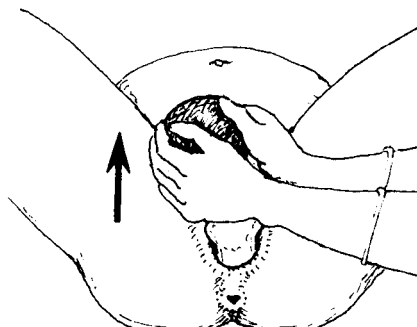
Если плечи застряли, после того, как вышла головка:

1.



Акушерка может взять в руки головку ребенка и очень осторожно опустить ее, так чтобы могло выйти плечо.

2.



Затем она может немного поднять ее, так чтобы вышло другое плечо.

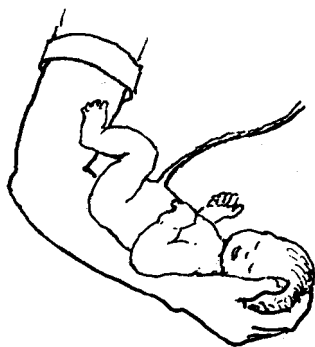
Вся сила должна исходить от матери. Акушерка не должна **никогда тянуть за головку или поворачивать или наклонять шею новорожденного**, потому что это может ему навредить.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ начинается, когда ребенок родился, и продолжается, пока не выйдет плацента (послед). Обычно плацента выходит сама за время от 5 минут до часа после ребенка. Тем временем ухаживайте за новорожденным. Если идет сильное кровотечение (с. 265) или плацента не выходит в течение 1 часа, вызывайте врача.

УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ

Сразу после того, как выйдет ребенок:

- ◆ Опустите головку ребенка вниз так, чтобы слизь вышла изо рта и горла. Держите его в таком положении, пока он не станет дышать.
- ◆ Держите ребенка ниже уровня матери, пока еще не перевязана пуповина. (При этом ребенок получает больше крови и будет сильнее).
- ◆ Если ребенок тотчас не начинает дышать, разотрите его спинку полотенцем или тканью.
- ◆ Если он все же не дышит, уберите слизь из носа и рта резиновой грушей или вытрите чистой тряпкой, обернутой вокруг вашего пальца.
- ◆ Если ребенок не начал дышать в течение минуты после рождения, начните **сразу** дыхание рот в рот (см. с. 80).
- ◆ Заверните ребенка в чистую пеленку. Очень важно, чтобы он не замерз, особенно, если он недоношенный (родился раньше времени).

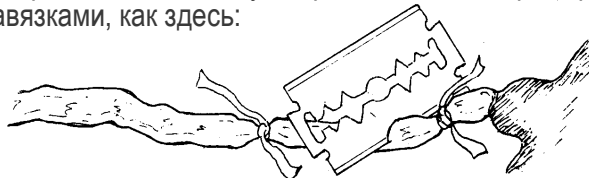


КАК ОБРЕЗАТЬ ПУПОВИНУ

Когда рождается ребенок, пуповина пульсирует, она толстая и синяя. **ЖДИТЕ.**



Позже пуповина становится тонкой и белой. Она перестает пульсировать. Теперь завяжите ее в двух местах чистыми, сухими полосками ткани, веревочками или лентой. Перед этим их следует прогладить или прожарить в духовке. Отрежьте между завязками, как здесь:

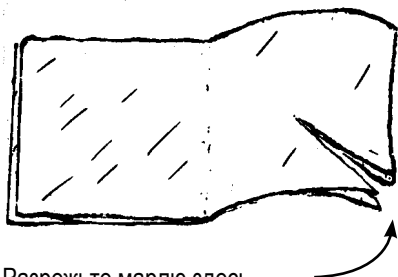


ВАЖНО: Отрежьте пуповину чистым, неиспользованным бритвенным лезвием. Перед тем, как развернуть его, очень хорошо вымойте руки. Или наденьте чистые резиновые или пластиковые перчатки. Если у вас нет нового лезвия, используйте прокипяченные ножницы. **Обрезайте пуповину всегда близко к телу новорожденного ребенка.** Оставьте только 2 см от тела ребенка. Эти меры предосторожности помогут предупредить столбняк (см. с. 182).

УХОД ЗА ОБРЕЗАННОЙ ПУПОВИНОЙ

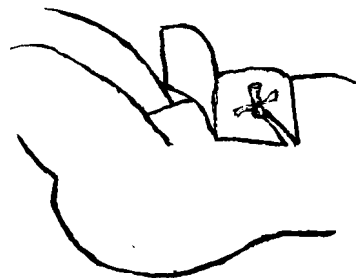
Самый важный способ защитить свежесрезанную пуповину от инфекций — держать ее сухой. Чтобы помочь **держать ее сухой**, к ней должен **поступать воздух**. Если в доме чисто, нет мух, оставьте пуповину открытой. Если есть пыль и мухи, легко закройте ее. Лучше стерильной марлей. Разрежьте ее прокипяченными ножницами и положите как показано на рисунке:

1.

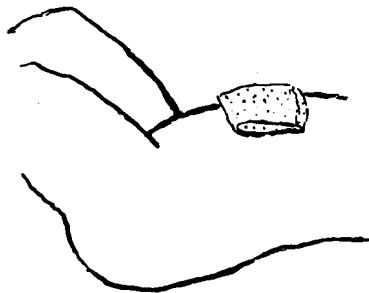


Разрежьте марлю здесь

2.



3.



4.

тонкая и свободная



Если у вас нет стерильной марли, вы можете накрыть пупок очень чистой, свежeproглаженной тканью. Лучше не пользоваться повязкой на живот, но если вы хотите использовать ее, возьмите тонкую легкую ткань, типа марли, и убедитесь, что она достаточно свободна, чтобы пропускать под себя воздух и чтобы пупок оставался сухим. Не накладывайте туго.

Убедитесь, что пеленки (салфетки) ребенка не закрывают пупок, так что пуповина не будет мокрой от мочи.

Очищение Новорожденного Ребенка

Теплой, мягкой, влажной тряпочкой осторожно сотрите кровь или жидкость.

Лучше **не** купать ребенка, пока не отпадет пупок (обычно от 5 до 8 дней). Затем купайте его ежедневно в теплой воде, пользуйтесь мягким мылом.

Сразу Приложите Новорожденного Ребенка к Грудь

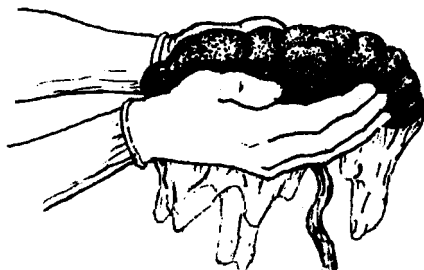
Приложите ребенка к груди матери сразу, как только отрежете пуповину. Если ребенок сосет, это поможет последу выйти быстрее и предупредить или остановить сильное кровотечение.

РОЖДЕНИЕ ПЛАЦЕНТЫ (ПОСЛЕДА)

Обычно плацента выходит за время от 5 минут до часа после рождения ребенка, но иногда выход ее задерживается на много часов.

Проверка последа:

Когда послед выйдет, примите его и проверьте, цел ли он. Если он порван и кажется, что нет кусочков, в таком случае требуется медицинская помощь. Кусочек плаценты, оставленный в матке, может вызвать длительное кровотечение или инфекцию.

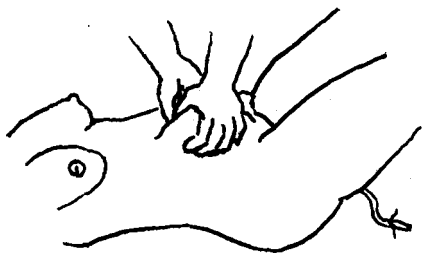


Когда плацента задерживается с выходом:

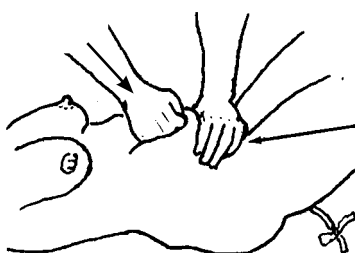
Если мать не теряет много крови, ничего не делайте. **Не тяните пуповину.** Это может вызвать сильное кровотечение. Иногда плацента выходит, если женщина сидит на корточках и немного выталкивает.

Если мать теряет кровь, пощупайте матку через живот. Если он мягкий, делайте следующее:

Массируйте матку осторожно, пока она не станет твердой. Это заставит ее сжаться и вытолкнуть плаценту.



Если плацента долго не выходит и продолжается кровотечение, надавите вниз на верхушку матки очень осторожно, поддерживая дно матки как на рисунке.



Если все-таки плацента не выходит и продолжается сильное кровотечение, упорно пытайтесь его остановить и вызвать медицинскую помощь.

ГЕМОРРАГИЯ (СИЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ)

Отделение последа всегда сопровождается небольшим кровотечением. Обычно оно длится лишь несколько минут и теряется не больше четверти литра (1 чашка) крови. (Маленькое кровотечение продолжается в течение нескольких дней и обычно несерьезное).

ВНИМАНИЕ: Иногда у женщины может быть сильное внутреннее кровотечение. Время от времени ощупывайте ее живот. Если кажется, что он стал больше, возможно, он наполнился кровью. Проверяйте ее пульс почаще и следите за признаками шока (с. 77).

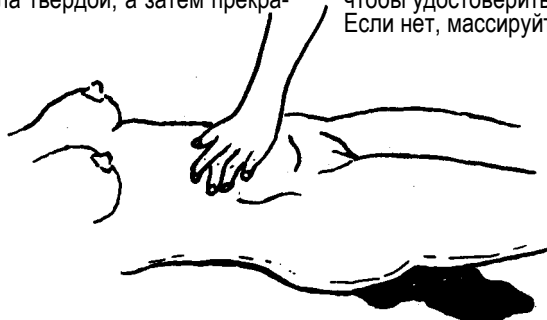
Чтобы предотвратить или остановить сильное кровотечение, **надо дать ребенку сосать грудь матери**. Если ребенок не будет сосать, попросите мужа (если это возможно) осторожно потереть груди матери. Это заставит ее выделить гормон (питуитрин), который помогает останавливать кровотечение.

Если продолжается сильное кровотечение или кровь медленно сочится, делайте следующее:

- ◆ Поскорее окажите медицинскую помощь. Если кровотечение не прекращается, матери необходимо ввести в вену сыворотку крови (переливание).
- ◆ Если у вас есть **эргоновин** или **окситоцин**, введите их, используя инструкцию на следующей странице. (Используйте окситоцин вместо эргоновина, если плацента еще не вышла.)
- ◆ Матери следует пить много жидкости (воды, фруктовых соков, чая, супа или напитка регидрона – с. 152). Если она слабеет или у нее быстрый, слабый пульс или налицо другие признаки **шока**, поднимите ее ноги вверх, а голову опустите (см. с. 77).
- ◆ Если мать теряет много крови и существует опасность, что кровотечение приведет к смерти, постарайтесь остановить кровь, как показано:

Массируйте живот, пока не почувствуете, что матка стала твердой, а затем прекратите массаж.

Если кровотечения нет, проверяйте каждые 5 минут, чтобы удостовериться, что матка остается твердой. Если нет, массируйте опять.



Если кровотечение продолжается, массируйте до тех пор, пока матка не станет твердой, и каждую минуту проверяйте. Если она остается мягкой, массируйте опять.

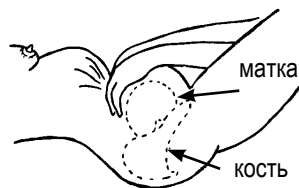
- ◆ **Если кровотечение продолжается, несмотря на массаж матки, делайте следующее:**

Всем своим весом надавите на живот ниже пупка двумя руками, положив одну на другую. Вы должны продолжать давить вниз еще длительное время после того, как кровотечение остановится.



- ◆ Если кровотечение еще не остановилось:

Надавите обеими руками на живот выше матки. Сложите их лопаткой и обхватите живот так, чтобы матка плотно прижалась к тазовой кости. **Придавите так сильно, как только сможете**, используя ваш вес, если у вас недостаточно сильные мышцы. Продолжайте давить еще несколько минут после остановки кровотечения, или пока не вызовете врача.



ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ: ЭРГОНОВИНА, ОКСИТОЦИНА, ПИТОЦИНА И Т.Д.

Стимуляторы – лекарства, которые содержат эргоновин, эргометрин или окситоцин. Они вызывают сокращение матки и кровеносных сосудов. Это важные, но опасные лекарства. При неправильном употреблении они могут вызвать смерть матери или ребенка в матке. Пользуйтесь правильно, иногда они спасают жизни. Вот правильное применение:

1. **Чтобы остановить кровотечение после родов.** Это самое важное применение этих лекарств. В случае сильного кровотечения после выхода плаценты делайте инъекцию одной ампулы, 0,2 мг (или дайте две таблетки по 0,2 мг) эргоновина или эргометрина малеата (Эрготрат и т.д., с. 391) по одному разу каждый час в течение 3 часов или пока не остановится кровотечение. После прекращения кровотечения продолжайте давать по одной ампуле (или пилюле) каждые 4 часа в течение 24 часов. Если нет эргоновина или если сильное кровотечение начинается до выхода плаценты, введите вместо него окситоцин (Питоцин, с. 391).

Важно: Каждая будущая мать и акушерка должны приготовить достаточно ампул окситоцина и эргоновина, чтобы остановить тяжелое кровотечение, если оно случится. Но эти препараты следует использовать только в тяжелых случаях.

2. **Чтобы помочь предупредить сильное кровотечение после родов.** Женщине, которая страдала от сильного кровотечения после предыдущих родов, можно дать 1 ампулу (или 2 таблетки) эргоновина сразу после того, как выйдет плацента, и через каждые 4 часа в течение суток.
3. **Чтобы остановить кровотечение при выкидыше (с. 281).** Применение стимуляторов может быть опасным, и только квалифицированный работник здравоохранения должен использовать их. Но если женщина быстро теряет кровь, а медицинская помощь недоступна, используйте стимулятор, как предлагалось выше. Окситоцин (Питоцин) возможно наилучший.

ВНИМАНИЕ: Употребление *эрготрата*, *питоцина* или *питуитрина*, ускоряющих роды или “дающих силу” матери при родах, опасно для нее и для ребенка. Случаи, когда стимуляторы требуются до рождения ребенка, очень редки, и поэтому лучше, чтобы их применил только квалифицированный принимающий роды. **Никогда не пользуйтесь стимуляторами до того, как родится ребенок.**

ПРИМЕНЕНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ ВО ВРЕМЯ РОДОВ, ЧТОБЫ “ДАТЬ СИЛУ” МАТЕРИ ...



МОЖЕТ УБИТЬ МАТЬ, РЕБЕНКА ИЛИ ОБОИХ.

Не существует безопасных препаратов, придающих силы матери и делающих роды более быстрыми и легкими.

Если вы хотите, чтобы женщина имела достаточно сил для рождения ребенка, ей следует кушать больше питательной еды в течение 9 месяцев беременности (см. с. 107). И еще убедите ее делать промежутки между родами. Предложите ей не беременеть опять до тех пор, пока не пройдет достаточно времени для восстановления сил (см. Планирование Семьи, с. 283).

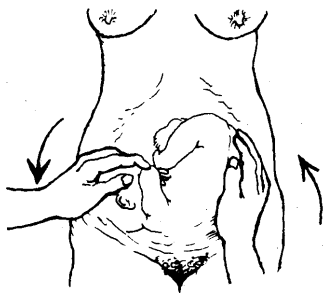
ТРУДНЫЕ РОДЫ

Если во время родов возникают какие-нибудь серьезные проблемы, очень важно получить побыстрее медицинскую помощь. Одни из этих проблем или осложнений серьезнее, чем другие. Вот несколько самых общих из них:

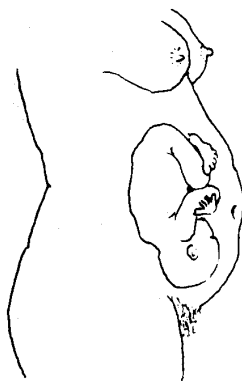
1. РОДЫ ПРЕКРАЩАЮТСЯ ИЛИ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ или затягиваются надолго после интенсивного начала или после отхода околоплодных вод. Возможные причины этого:

- **Женщина может быть напугана или расстроена.** Это может замедлить или даже остановить схватки. Поговорите с ней. Помогите расслабиться. Постарайтесь успокоить ее. Объясните, что роды замедлились, но в этом нет ничего страшного. Попросите ее чаще менять положение, пить, есть и мочиться.

- **Младенец может быть в необычном положении.** Ощупывайте живот между схватками, чтобы заметить, если ребенок лежит **поперек**. Иногда акушерка может развернуть ребенка, **осторожно** управляя животом матери. Старайтесь заставить ребенка понемногу поворачиваться между схватками, пока головка не окажется внизу. Но **не применяйте силу**, так как можно порвать матку или плаценту или зажать пуповину. Если ребенка нельзя развернуть, постарайтесь доставить мать в больницу.



- **Если ребенок обращен лицом вперед, а не назад, вам легче прощупать выпуклые ручки и ножки, чем округлую спинку.** Обычно это небольшая проблема, но роды будут дольше и причинят женщине больше боли в спине. Она должна чаще менять положение, так как это может помочь повернуть ребенка. Пусть она попробует это сделать, опустившись на руки и колени.



- **Голова ребенка может быть слишком большая, чтобы пройти через бедра матери (таз).** Это чаще случается у женщин с очень узкими бедрами или у женщин, которые намного ниже мужа. (Это необычно для женщин, у которых прежде были нормальные роды.) Вы можете почувствовать, что ребенок не продвигается вниз. Если подозреваете эту причину, постарайтесь доставить мать в больницу, поскольку ей может понадобиться операция (кесарево сечение). **Женщины с очень узкими бедрами или очень маленькие женщины должны рожать, по крайней мере, первого ребенка в больнице.**

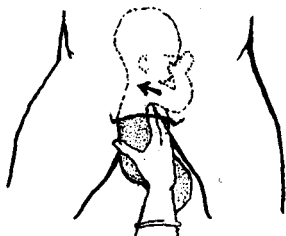
- **Если у женщины тошнота или она не пьет,** возможно у нее обезвоживание. Это может замедлить или остановить схватки. Заставьте ее пить маленькими глотками напиток регидрона или другую жидкость после каждой схватки.

2. РОДЫ ЯГОДИЦАМИ (ягодицы выходят сначала). Иногда акушерка может определить, что ребенок находится ягодицами вниз, ощупав живот матери (с. 257) и прослушав сердцебиение ребенка (с. 252).

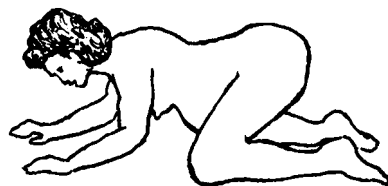
Роды ягодицами вперед будут легче в таком положении.

Если сначала идут ножки ребенка, а не ручки, очень хорошо вымойте свои руки, протрите их спиртом (или наденьте стерильные перчатки), а затем ...

проскользните пальцами внутрь и отведите плечи ребенка назад, вот так:

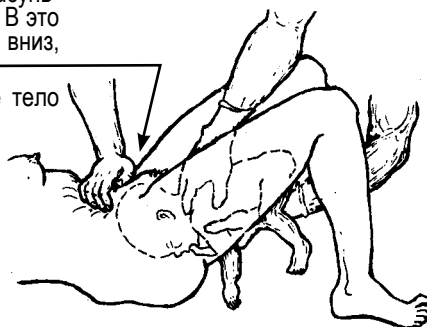


или прижмите его ручки к телу, вот так:



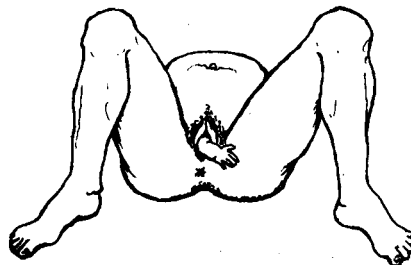
Если ребенок застрял, пусть мать ляжет лицом вверх. Засуньте палец в рот ребенка и подтяните его головку к груди. В это же время кому-то нужно подтолкнуть головку ребенка вниз, надавливая на живот матери вот так:

Мать должна хорошо тужиться. Но никогда не тяните тело ребенка.



3. РОДЫ РУЧКОЙ (сначала рука). Если ручка ребенка идет первой, немедленно вызывайте скорую помощь. Может понадобиться операция, чтобы достать ребенка.

4. Иногда ПУПОВИНА ОБВИВАЕТСЯ ВОКРУГ ШЕИ РЕБЕНКА настолько плотно, что он никак не может выйти. Попытайтесь ослабить пуповину вокруг шеи. Если вы не сможете сделать это, вы можете зажать или перевязать и обрезать пуповину. Используйте прокипяченные ножницы с тупыми концами.



5. КАЛ ВО РТУ И В НОСУ РЕБЕНКА. Когда отходят воды и вы видите, что они содержат темно-зеленную (почти черную) жидкость, возможно, это первородный стул (меконий) ребенка. Ребенку может грозить опасность. Если он вдохнет фекалии в легкие, он может умереть. Как только покажется головка, попросите мать не тужиться, а делать короткие, частые вдохи. Перед тем как ребенок начнет дышать, не упустите время, чтобы отсосать фекалии из его носа и рта резиновой грушей. Даже если он сразу начнет дышать, отсасывайте до тех пор, пока не выйдет весь кал.

6. Двойня. Рожать двойню намного труднее и опаснее – и для матери, и для детей – чем рожать одного ребенка.

Для безопасности женщина должна рожать двойню в больнице.

Так как с двойней роды часто начинаются раньше срока, мать после седьмого месяца беременности должна быть в таком месте, откуда легко добраться до больницы.

Признаки того, что женщина может иметь двойню:

- Живот растет быстрее и матка больше, чем обычно, особенно в последние месяцы (см. с. 251).
- Если женщина набирает вес быстрее нормы или общие недомогания беременных (утренняя болезнь, спинная боль, варикозные вены, шишки, отеки и одышка) протекают тяжелее, чем обычно, проверьте на двойню.
- Если вы чувствуете 3 или больше объектов (головы и попки) в матке, которая выглядит очень увеличенной, возможно это двойняшки.
- Иногда вы можете прослушать 2 различных сердцебиения (отличные от материнского), но это трудно.

В течение последних месяцев, если женщина много отдыхает и старательно избегает тяжелой работы, то менее вероятно, что двойняшки родятся рано.

Близнецы обычно рождаются маленькими и требуют специального ухода. Однако неверно мнение, что близнецы обладают странной или магической силой.

РАЗРЫВЫ РОДОВОГО ОТВЕРСТИЯ

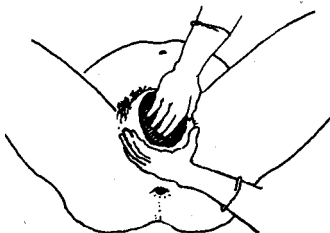
Родовое отверстие должно вытягиваться очень сильно, чтобы ребенок вышел. Иногда оно разрывается. Наиболее часты разрывы при первых родах.

Можно избежать разрывов, если принять меры:

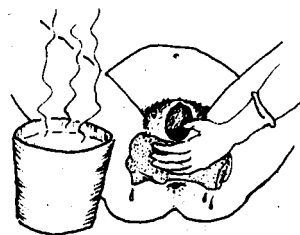
Мать должна прекратить тужиться, когда выходит головка. Это даст время отверстию вытянуться. Чтобы не тужиться, она должна дышать прерывисто (делать много коротких быстрых вдохов).



Когда вытягивается родовое отверстие, акушерка может одной рукой поддерживать его, а другой осторожно держать головку, чтобы она не вышла слишком быстро, вот так:



Еще помогает теплый компресс на кожу ниже родового отверстия. Приложите, когда отверстие начнет вытягиваться. Вы можете намазать вытянутую кожу маслом.



Если есть разрывы, то тот, кто знает, как это сделать хорошо, должен зашить их после выхода плаценты (см. с. 86 и 381).

УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ РЕБЕНКОМ

Пуповина

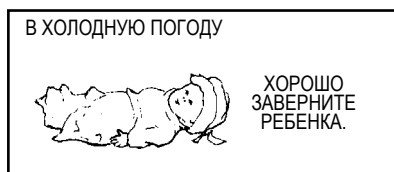
Чтобы инфекция не попала в свежесрезанную пуповину, она должна быть чистой и сухой. Чем суше пуповина, тем скорее она отпадет и скорее заживет пупок. По этой причине лучше не пользоваться повязкой на живот или, если используете ее, она должна быть очень свободной (см. с. 184 и 263).

Глаза

Чтобы защитить глаза новорожденного ребенка от опасного конъюнктивита, капните по капле 1% нитрата серебра или немного глазной тетрациклиновой или эритромициновой мази в каждый глаз сразу же после рождения (с. 221 и 365). Это особенно важно в том случае, если у кого-то из родителей были признаки гонореи или хламиды (с. 236).

ДЕРЖИТЕ РЕБЕНКА В ТЕПЛЕ, НО НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕ

Защищайте ребенка не только от переохлаждения, но и от перегрева. Одевайте его так тепло, как вы бы одели себя.



Чтобы ребенку было достаточно тепло, прижмите его к своему телу. Это особенно важно для недоношенного ребенка или маленького. Смотрите "Особый уход за маленькими, ранними и недоношенными детьми" (с. 405).

Чистота

Очень важно соблюдать правила гигиены, которые обсуждались в главе 12. Обратите особое внимание на следующие:

- ◆ Меняйте детские пеленки (подгузники) или белье всякий раз, как только они намочнут или станут грязными. Если кожа краснеет, меняйте пеленки чаще – или лучше откажитесь от них совсем! (См. с. 215).
- ◆ Как только отпадет пуповина, купайте ребенка ежедневно мягким мылом в теплой воде.
- ◆ Если есть мухи или москиты, накройте детскую кроватку сеткой от москитов или тонкой тканью.
- ◆ Люди с открытыми язвами, простудой, воспаленным горлом, туберкулезом или другими инфекционными болезнями не должны трогать или подходить близко к новорожденному ребенку или к женщине, когда она рождает.

Держите ребенка в чистом месте подальше от дыма и пыли.

КОРМЛЕНИЕ

(Смотри также “Самая лучшая диета для маленьких”, с. 120).

Грудное молоко является самой лучшей пищей для ребенка. Дети, которые питаются молоком матери, растут сильными, реже умирают. Вот почему:

- Грудное молоко больше соответствует потребностям ребенка, чем любое другое молоко, несмотря на то свежее ли оно, консервированное или порошковое.
- Грудное молоко чистое. Когда даете другую еду, особенно в бутылке, очень трудно сохранять все в чистоте, чтобы предупредить понос и другие болезни у ребенка.
- Температура грудного молока всегда нормальная.
- Грудное молоко содержит вещества (антитела), которые помогают защитить детей от определенных болезней, таких как понос, корь и полиомиелит.

Мать должна давать ребенку грудь сразу после его рождения. В первые несколько дней груди матери вырабатывают очень мало молока. Это нормально. Она должна **чаще кормить ребенка грудью** – по крайней мере каждые два часа. Сосание груди ребенком поможет вырабатывать больше молока.

Если ребенок выглядит здоровым, набирает вес и регулярно мочит пеленки (подгузники), значит мать вырабатывает достаточное количество молока.

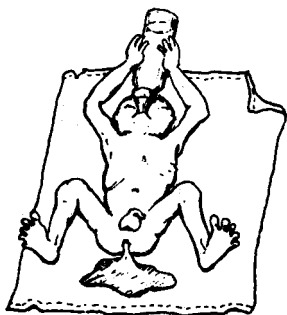
Лучше всего для ребенка, если мать дает ему **только грудное молоко** в первые 4-6 месяцев. После этого она должна продолжать кормить ребенка грудью, но и должна начинать давать ему другие питательные продукты (см. с. 122).

КАК МАТЬ МОЖЕТ ВЫРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ ГРУДНОГО МОЛОКА:

Она должна . . .

- ◆ пить больше жидкостей,
- ◆ питаться как можно лучше, особенно молоком, молочными продуктами и пищей для строения тела (см. с. 110),
- ◆ хорошо спать, избегать усталости и расстройств,
- ◆ кормить ребенка грудью более часто – по крайней мере каждые 2 часа.

ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ РЕБЕНКА
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К БОЛЕЗНЯМ И СМЕРТИ.



ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ РЕБЕНКА
ДЕЛАЕТ ЕГО ЗДОРОВЫМ.



КАК ДАВАТЬ ЛЕКАРСТВА НОВОРОЖДЕННЫМ?

Многие лекарства опасны для новорожденных. Употребляйте только те лекарства, которые, как вы уверены, рекомендуются новорожденным, и используйте их только тогда, когда они абсолютно необходимы. Убедитесь в том, что вы знаете правильную дозу, и не давайте слишком много. Хлорамфеникол особенно опасен для новорожденного . . . и даже более опасен, если ребенок родился преждевременно или недоношенный (менее 2 кг).

БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ

Очень важно заметить любую проблему или болезнь у ребенка – и очень быстро действовать.

**Болезни, которые убивают взрослых
в течение дней или недель,
могут убить ребенка в течение часов.**

ПРОБЛЕМЫ С РЕБЕНКОМ ПРИ РОДАХ (СМОТРИ ТАКЖЕ С. 316)

Они могут быть результатом неправильного развития ребенка в матке или повреждений при самих родах. Внимательно осмотрите ребенка сразу же после рождения. Если заметны некоторые из следующих признаков, вероятно с ним произошло что-нибудь серьезное:

- Если он не дышит сразу после рождения.
- Если у него нельзя прощупать или услышать пульс или он меньше 100 ударов в минуту.
- Если его лицо и тело бледнеют, синеют или желтеют после того, как он начнет дышать.
- Если руки и ноги свободно висят – он не двигает ими ни сам, ни когда вы сжимаете их.
- Если он мычит или тяжело дышит спустя 15 минут после родов.

Некоторые из этих проблем могут быть вызваны повреждением мозга при родах. Они почти никогда не вызываются инфекцией (если после отхода околоплодных вод до родов не пройдет более 24 часов). Обычно лекарства не помогают. Держите ребенка в тепле, но не перегревайте (см. с. 270). Обратитесь за медицинской помощью.

Если ребенок не мочится или не испражняется в первые 2 дня, тоже обратитесь к врачу.

ПРОБЛЕМЫ С РЕБЕНКОМ ПОСЛЕ РОДОВ (В ПЕРВЫЕ ДНИ ИЛИ НЕДЕЛИ)

1. **Гной или плохой запах из пупка** (пуповины) – это опасный признак. Следите за ранними признаками столбняка (с. 182) или бактериальной инфекции в крови (с. 275). Протрите пуповину спиртом и оставьте открытой на воздухе. **Если кожа вокруг пуповины стала горячей и красной**, лечите ампициллином (с. 353) или пенициллином и стрептомицином (с. 354).

2. И низкая температура (ниже 35°), и высокая температура могут быть признаком инфекции. Высокая температура (выше 39°) опасна для новорожденного. Разденьте ребенка и оботрите его губкой, смоченной в прохладной (не холодной) воде, как показано на странице 76. Поищите признаки обезвоживания (с. 151). Если вы обнаружите их, дайте ребенку грудное молоко и еще напиток регидрона (с. 152).
3. Припадки (конвульсии, см. с. 178). Если у ребенка жар, лечите, как описано выше. Убедитесь, что это не обезвоживание. Припадки, которые начались в день рождения, могут быть вызваны повреждением мозга при родах. Если начинаются через несколько дней, внимательно проверьте на признаки столбняка (с. 182) или менингита (с. 185).
4. Ребенок не набирает вес. В первые дни жизни большинство детей немного теряют вес. Это нормально. После первой недели здоровый ребенок должен набрать около 200 г за неделю. За две недели он должен набрать тот вес, который был у него при родах. Если он не набирает или теряет вес, что-то не так. Казался ли ребенок здоровым при родах? Хорошо ли он кушает? Поищите внимательно признаки инфекции или другие проблемы. Если вы не можете правильно определить причину болезни, обратитесь за медицинской помощью.
5. Рвота. Когда здоровые дети срыгивают (или выпускают воздух, заглоченный во время еды), иногда выходит и небольшое количество молока. Это нормально. Помогите ему выпустить воздух после кормления, держа его на плече и похлопывая мягко по спине, как на рисунке:



СРЫГИВАНИЕ У РЕБЕНКА ПОСЛЕ кормления.

Если ребенка рвет, когда вы положите его после кормления, старайтесь поддержать его некоторое время на руках вертикально после каждого приема пищи.

Ребенок, который так сильно и обильно рвет, что начинает терять вес или становится обезвоженным, болеет. Если у ребенка еще и понос, возможно, у него кишечная инфекция (с. 157). Бактериальная инфекция в крови (смотри следующие страницы), менингит (с. 185) или другие инфекции также могут вызвать рвоту.

Если рвота желтая или зеленая, это может быть несварение кишечника (с. 94), особенно если живот опухший и ребенок не опорожняется. Сразу отвезите ребенка в центр здоровья.

6. Ребенок плохо сосет. Если прошло более 4 часов, а ребенок не берет грудь – это опасный признак, особенно, если ребенок кажется сонным или больным, или если он плачет или двигается не так, как обычно. Многие болезни могут вызвать эти признаки, но самые распространенные и опасные причины в первые две недели жизни – бактериальная инфекция в крови (смотри следующие 2 страницы) и столбняк (с. 182).

Ребенок, который перестает сосать со второго по пятый день жизни, может иметь бактериальную инфекцию в крови. Ребенок, который перестает сосать с пятого по пятнадцатый день, может иметь столбняк.

Если Ребенок Плохо Сосет или Кажется Больным

Тщательно и полностью осмотрите ребенка, как описано в Главе 3. Внимательно проверьте следующее:

- Проследите, есть ли у ребенка **затрудненное дыхание**. Если у него забит нос, высосите его как показано на странице 164. Частое дыхание (50 или больше вдохов в минуту), синий цвет, хрипы и втягивание кожи между ребрами с каждым вдохом – признаки пневмонии (с. 171). Маленькие дети с пневмонией часто не кашляют; иногда не присутствует ни один из обычных признаков. Если вы подозреваете пневмонию, лечите как бактериальную инфекцию в крови (смотри следующую страницу).
- Посмотрите на **цвет кожи** ребенка.

Если губы и лицо синие, считайте, что это пневмония (или порок сердца, или другая врожденная болезнь).

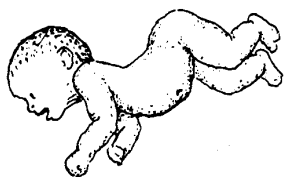
Если лицо и белки глаз начинают желтеть (желтуха) в первый день жизни или после 5 дней – это серьезно. Обратитесь за медицинской помощью. Небольшая желтизна между вторым и пятым днями жизни обычно не опасная. Дайте ребенку побольше жидкости – напиток регидрона является наилучшим в дополнение к грудному молоку (с. 152). Разденьте ребенка и положите его на свет около окна (но не под прямые солнечные лучи).

- Прощупайте **мягкое место на макушке головы** (родничок). Смотри с. 9.



ВАЖНО: Если у ребенка менингит или обезвоживание одновременно, мягкое место может выглядеть нормально. **Внимательно проверьте на другие признаки обезвоживания** (см. с. 151) и менингита (см. с. 185).

- **Наблюдайте за движением и выражением лица ребенка.**



Одеревенелость тела и/или странные движения у ребенка могут быть признаками столбняка, менингита, повреждения мозга при родах или при жаре. Если, когда вы прикасаетесь к ребенку или передвигаете его, мышцы его лица и тела судорожно сокращаются, это может быть столбняк. Посмотрите, открывается ли у него челюсть, и проверьте его коленный рефлекс (с. 183).

Если глаза ребенка закатываются назад или дрожат от волнения, когда он делает внезапные или резкие движения, у него явно **нет** столбняка. Такие приступы могут быть вызваны менингитом, но наиболее распространенная причина – это обезвоживание или сильный жар. Можете ли вы положить головку ребенка между его коленями? Если ребенок не сгибается при этом или кричит от боли, вероятно, у него менингит (см. с. 185).

- Ищите признаки бактериальной инфекции в крови.

БАКТЕРИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ В КРОВИ (СЕПСИС)

Новорожденные не могут хорошо бороться с инфекциями. Следовательно, бактерия, которая попала на кожу или пуповину ребенка во время родов, часто проникает в кровь и распространяется по всему телу. Поскольку это занимает день или два, сепсис чаще всего бывает после второго дня жизни.

Признаки:

Признаки инфекции у новорожденных детей отличаются от признаков у детей старшего возраста. У малыша почти любой признак может быть вызван наличием серьезной инфекции в крови. Возможные признаки:

- плохо сосет
- выглядит очень сонным
- очень бледный (анемия)
- рвота или понос
- жар или низкая температура (ниже 35°)
- опухший живот
- желтая кожа (желтуха)
- припадки (конвульсии)
- временами ребенок синеет

Каждый из этих признаков может быть вызван чем-либо еще кроме сепсиса, **но если у ребенка несколько из этих признаков одновременно, то наиболее вероятен сепсис.**

У новорожденных детей при серьезной инфекции не всегда бывает жар. Температура может быть высокой, низкой или нормальной.

Лечение, когда вы подозреваете сепсис у новорожденных:

- ◆ Вводите ампициллин (с. 353) по 125 мг 4 раза в день – если возможно, вместе с канамицином (с. 359) по 25 мг **2 раза в день.**
- ◆ Или вводите пенициллин – по 150 мг (250000 единиц) кристаллического пенициллина 3 раза в день, вместе со стрептомицином – по 20 мг на каждый килограмм веса ребенка (60 мг для ребенка весом в 3 кг) **один раз в день.** Будьте осторожны, чтобы не дать слишком много стрептомицина (см. с. 354).
- ◆ Убедитесь, что ребенок получает достаточно жидкости. Если необходимо, давайте ложкой грудное молоко и напитки регидрона (с. 152).
- ◆ Попытайтесь получить медицинскую помощь.

Инфекции у новорожденных детей иногда трудно распознать. Часто они протекают без жара. Если возможно, обратитесь за медицинской помощью. Если нет – лечите ампициллином, как описано выше. Ампициллин представляет собой один из самых безопасных и наиболее пригодных антибиотиков для детей.



ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ ПОСЛЕ РОДОВ

ДИЕТА И ЧИСТОТА

Как отмечено в Главе 11, после рождения ребенка **мать может и должна есть любую питательную пищу, которую она сможет достать**. Она не должна избегать никаких продуктов. Для нее особенно хороши молоко, сыр, цыплята, яйца, мясо, рыба, фрукты, овощи, злаки, бобы, арахис и т.д. Если ее пищу составляют кукуруза и бобы, она должна каждый раз есть их вместе. Молоко и другие молочные продукты помогают матери вырабатывать больше молока для ребенка.

Мать может и должна купаться в первые же дни после родов. В первую неделю ей лучше обтираться мокрым полотенцем и не принимать ванну. **Купание не вредит после родов**. Действительно, женщины, которые не купаются много дней, могут заполучить инфекцию, которая сделает их кожу нездоровой, а их детей больными.

В течение дней и недель после родов женщина должна:

есть питательную еду

и

регулярно мыться



Родильная Горячка (Инфекция После Родов)

Иногда у матери развивается лихорадка и инфекция после родов, обычно из-за недостаточной внимательности акушерки, чтобы содержать все в чистоте, или лазила руками внутрь женщины.

Признаки родильной горячки: Озноб или жар, головная боль или боль внизу спины, иногда боль в животе и вониючие или кровянистые выделения из влагалища.

Лечение:

Давайте пенициллин: инъекции по 500000 единиц прокаина пенициллина дважды в день или 2 таблетки по 400000 единиц 4 раза в день целую неделю (смотри с. 351). Вместо пенициллина можно использовать ампициллин, ко-тримоксазол или тетрациклин.

Родильная горячка может быть очень опасной. Если матери не становится лучше, вызовите врача. Для очень серьезных инфекций может понадобиться лечение более сильными антибиотиками (хлорамфеникол, гентамицин, канамицин или цефалоспорин) в дополнение к высоким дозам пенициллина или ампициллина.

УХОД ЗА ГРУДЬЮ

Хороший уход за грудью важен как для матери, так и для ее ребенка. Кормление грудью надо начинать в тот же день, когда родился ребенок. Сначала ребенок не может сосать много, но это поможет матери привыкнуть к сосанию и поможет предупредить трещины на сосках. Самое первое молоко, которое выделяет молочная железа матери (называется молозиво), также защищает ребенка от инфекций и богато протеином. **Хотя оно выглядит водянистым, это первое молоко очень полезно для ребенка.** Поэтому . . .

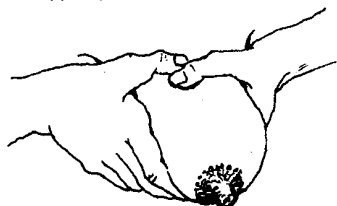
Начинайте кормление грудью в день рождения ребенка.

Обычно в груди вырабатывается столько молока, сколько нужно ребенку. Если ребенок высосет все, молока начинает вырабатываться больше. Если ребенок не высасывает все, молока становится меньше. Но когда ребенок болеет и перестает сосать, через несколько дней грудь перестает вырабатывать молоко. Поэтому, когда ребенок в состоянии сосать снова и ему нужна полная порция молока, у матери его недостаточно. По этой причине,

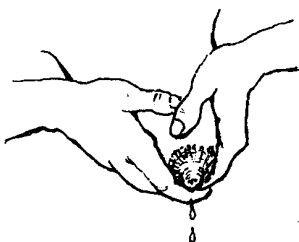
Когда ребенок болен и не может высасывать много молока, важно, чтобы мать вырабатывала достаточно молока, сцеживая молоко из груди своими руками.

ЧТОБЫ СЦЕДИТЬ МОЛОКО РУКАМИ

Держите грудь сзади, как здесь,



затем передвигайте руки вперед, сдвигая,



и, наконец, выдавите молоко из соска.



Другая причина, почему важно сцеживать молоко из груди, когда ребенок перестает сосать – это сдерживать грудь от наполнения. Когда в груди полно молока, она болит. Переполнение груди молоком может привести к абсцессу. Кроме того, ребенок с трудом сосет переполненную грудь, даже когда он хочет кушать.

Когда ваш ребенок слишком слаб, чтобы сосать, сцеживайте молоко из груди рукой и давайте его ребенку ложкой или пипеткой.

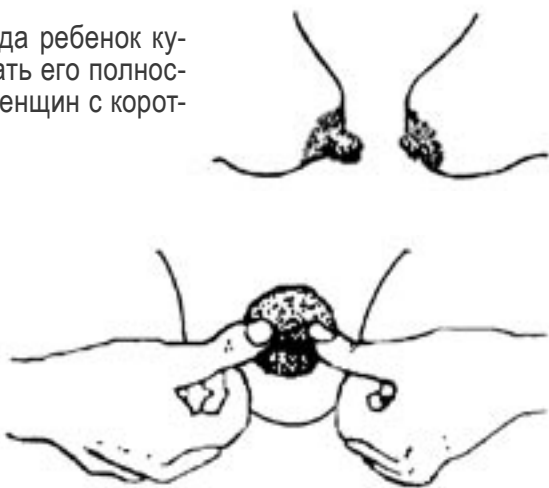
Всегда содержите свою грудь в чистоте. Перед кормлением ребенка протрите ваши соски чистой, влажной тканью. Не употребляйте мыло каждый раз, когда вытираете соски, так как это приводит к трещинам кожи, ранкам на сосках и инфекции.

Раны на сосках

Раны на сосках развиваются, когда ребенок кусает за сосок вместо того, чтобы брать его полностью в рот. Это обычно случается у женщин с короткими сосками.

Профилактика:

Женщинам с короткими сосками или сосками, втянутыми вгрудь, помогает выдавливание сосков несколько раз в день во время беременности, как показано на рисунке. Это облегчит кормление ребенка грудью и уменьшит риск получить раны на сосках.



Лечение:

Важно продолжать кормить ребенка грудью, даже если больно. Сначала пусть сосет ту грудь, где меньше ран. Прекращать кормление грудью только тогда, когда из соска выделяется много крови или гноя. В этом случае сцеживайте молоко из груди руками до тех пор, пока не заживут соски. Когда ребенка начнете кормить снова, убедитесь, что он захватывает в рот весь сосок.

Абсцесс Груды (Инфекция Внутри Груды, Мастит)

Нарыв в груди – это результат инфекции, которая проникла через ранки или трещины на соске. Это наиболее распространено в течение первых недель или месяцев грудного кормления.

Признаки:

Часть груди становится горячей, красной, опухшей и очень болезненной. Лимфоузлы под мышками часто воспалены и опухшие. Сильный нарыв иногда лопается и выделяет гной. У женщин может быть жар.



Профилактика:

- ◆ Держите груди в чистоте. Если на соске появляется ранка или болезненная трещина, кормите ребенка грудью меньше времени, но чаще.
- ◆ Смазывайте соски после каждого кормления небольшим количеством растительного или детского масла.

Лечение:

- ◆ Пусть ребенок продолжает сосать из воспаленной груди или выдавливайте молоко рукой, если это менее болезненно.
- ◆ Пользуйтесь холодной водой или ледяным компрессом для облегчения боли. Примите аспирин.
- ◆ Принимайте антибиотики как при родильной горячке (см. с. 276).

Различные виды опухолей в груди:

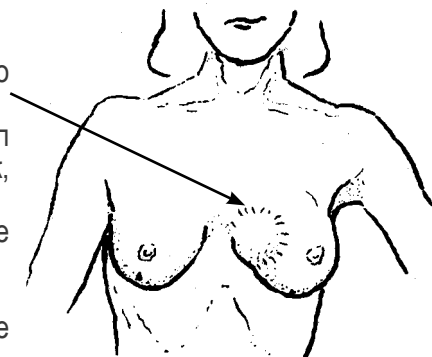
**Болезненная, горячая опухоль в груди кормящей матери, возможно, абсцесс груди (инфекция).
Безболезненная опухоль может быть раком или кистой.**

Рак Грудь

Рак груди обычно бывает у женщин и всегда опасен. Успешное лечение зависит от распознавания первого признака возможного рака и скорейшего получения медицинской помощи. Обычно необходимо хирургическое вмешательство.

Признаки рака груди:

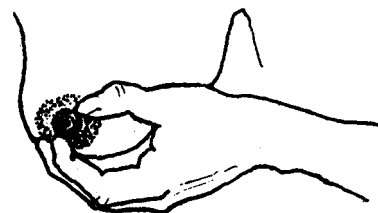
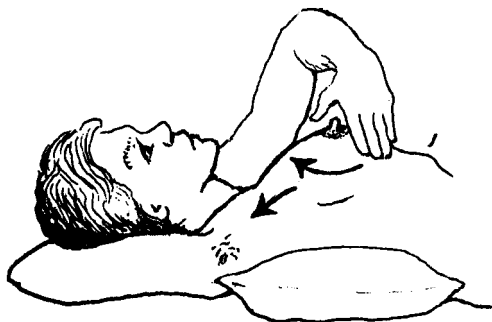
- Женщина может заметить опухоль, обычно в этой части груди.
- Или грудь может иметь необычный выступ или впадину – или много крошечных ямок, как на коже апельсина.
- Часто увеличенные, но безболезненные лимфоузлы под мышкой.
- Опухоль растет медленно.
- Сначала обычно не болит или горит. Позже может болеть.



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ГРУДИ

Каждая женщина должна знать, как обследовать свою собственную грудь, чтобы определить возможные признаки рака. Она должна делать это один раз в месяц. Предпочтительно на десятый день после начала месячных.

- ◆ Посмотрите внимательно нет ли новых различий между левой и правой грудью в размере и форме. Попробуйте заметить любой из перечисленных признаков.
- ◆ Лежа на подушке или на сложенном одеяле под спиной, ощупывайте свою грудь подушечками пальцев. Нажимайте на грудь и перекачивайте под кончиками своих пальцев. Начните вокруг сосков и двигайте к подмышкам.
- ◆ Затем надавите на соски и проверьте, нет ли крови или выделений.



Если найдете опухоль или любой другой ненормальный признак, обратитесь за медицинской помощью. Многие опухоли не представляют собой рак, но важно определить это пораньше.

ОПУХОЛИ И НОВООБРАЗОВАНИЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЖИВОТА

Конечно, большинство обычных опухолей вызвано нормальным развитием ребенка. Ненормальные опухоли или массы могут быть вызваны:

- кистой, или водянистой опухолью, в одном из яичников;
- ребенком, который начал развиваться вне матки (внематочная беременность) или
- раком.

Все эти 3 состояния обычно безболезненные или вызывают умеренное неудобство вначале, а позже становятся очень болезненными. Все требуют врачебного вмешательства – обычно хирургического. Если вы обнаружили необычную, постепенно растущую опухоль, обратитесь за медицинской помощью.



РАК МАТКИ

Рак матки, шейки матки или яичников наиболее распространен у женщин после 40 лет. Первым признаком может быть анемия и необъяснимое кровотечение. Позже в животе можно заметить неудобную или болезненную опухоль.

Существует специальный тест, называемый Пап-мазок, для выявления рака шейки матки в начальной стадии. Если это доступно, все женщины после 20 лет должны попытаться проходить этот тест 1 раз в год.

При первых признаках рака обращайтесь за медицинской помощью.

Домашние лекарства обычно не помогают.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ИЛИ ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

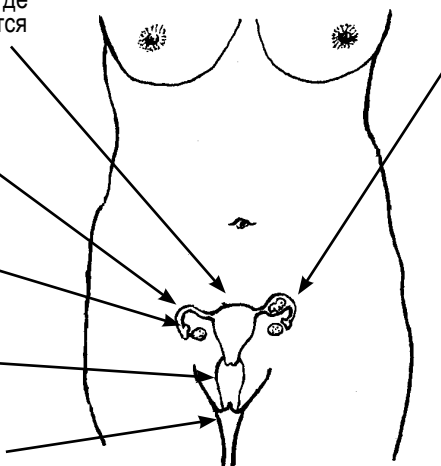
матка – место, где обычно находится ребенок

яйцевод

яичник – место, где находятся яйцеклетки

вагина

вульва – или половые губы



Иногда ребенок начинает развиваться вне матки, в одной из труб, которые идут от яичников.

Может быть ненормальное менструальное кровотечение вместе с признаками беременности – также сильные спазмы внизу живота и болезненная опухоль вне матки.

Ребенок, который начинает формироваться вне матки, не может жить. Внематочная беременность требует хирургического вмешательства. Если вы подозреваете эту проблему, обратитесь за медицинской помощью, потому что опасное кровотечение может начаться в любое время.

ВЫКИДЫШ (САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ АБОРТ)

Выкидыш – это потеря не рожденного ребенка. Выкидыш чаще всего бывает в первые 3 месяца беременности. Обычно ребенок еще не полностью сформирован, и это естественный способ избежать проблем.

У большинства женщин бывает один или более выкидышей в жизни. Во многих случаях они и не понимают, что произошел выкидыш. Они могут подумать, что месячные сместились или задержались, а затем прошли странным образом, с большими кровавыми сгустками. Женщина должна научиться узнавать, когда у нее выкидыш, потому что это опасно.

Женщина, у которой случилось сильное кровотечение после того, как она пропустила одну или больше менструаций, возможно имела выкидыш.

Выкидыш напоминает роды тем, что эмбрион (зародыш ребенка) и плацента (послед) должны выйти. Сильное кровотечение с большими сгустками крови и болезненными спазмами часто продолжается до тех пор, пока и то, и другое полностью не выйдет.

Эмбрион выкидыша может быть не длиннее, чем 1 или 2 сантиметра.

30 дней



60 дней



Лечение:

Женщина должна лежать и принимать аспирин (с. 379), ибупрофен (с. 380) или кодеин (с. 384) от боли.

Если сильное кровотечение продолжается много дней:

- ◆ Вызовите врача. Может понадобиться простая операция, чтобы вычистить матку (расширение и выскабливание или отсос).
- ◆ Оставайтесь в постели до полного прекращения кровотечения.
- ◆ Если поднимается температура и развиваются другие признаки инфекции, лечите так, как **Родильную Горячку** (см. с. 276).
- ◆ У женщины может продолжаться небольшое кровотечение несколько дней после выкидыша. Это очень похоже на менструацию.
- ◆ Ей не **следует спринцеваться** или заниматься сексом, по крайней мере 2 недели после выкидыша или пока не кончится кровотечение.

Если она использует ВМС и у нее произошел выкидыш, может иметь место серьезная инфекция. **Быстрее обратитесь за медицинской помощью**, удалите ВМС и дайте антибиотики.

БОЛЬШОЙ РИСК МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ

Примечание для акушеров или работников здравоохранения или для любого, кто ухаживает:

У некоторых женщин бывают трудные роды и послеродовые проблемы, а их дети бывают недоношенными и больными. Часто это одинокие, бездомные, голодающие, очень молодые, умственно отсталые матери или те матери, у которых уже есть истощенные или больные дети.

Часто, если акушерка, работник здравоохранения или кто-либо еще проявляет особый интерес к таким матерям и помогает им отыскать возможности обеспечить себя едой, заботой и общением, в которых они нуждаются, то это может существенно улучшить благосостояние и матерей и их детей.

Не ждите, чтобы они пришли к вам. Идите к ним сами.



ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ — ИМЕТЬ СТОЛЬКО ДЕТЕЙ, СКОЛЬКО ВЫ ХОТИТЕ

ГЛАВА

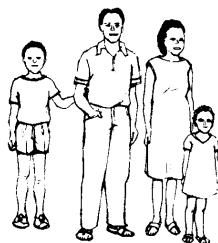
20

ОБЕ ЭТИ СЕМЬИ ЖИВУТ В БЕДНЫХ ОБЩЕСТВАХ:

Эта семья живет там, где социальные блага распределены несправедливо.



Эта семья живет там, где социальные блага распределены справедливо.



Некоторые отцы и матери хотят иметь много детей — особенно в странах, где бедные люди обделены землей, ресурсами и социальными благами. Это потому, что дети помогают им в работе и обеспечивают их старость. В таких местах иметь мало детей — это привилегия, которую могут позволить себе только зажиточные люди.

Положение совсем другое в тех бедных странах, где источники и блага распределены честно. Там, где работа, дом и охрана здоровья гарантированы и где у женщин равные возможности для образования и работы, люди обычно предпочитают иметь меньше детей. Отчасти потому, что им не нужно зависеть от своих детей в отношении экономической безопасности.

Но для любого общества полезно, если семьи сами контролируют, когда и сколько иметь детей.

Когда у матери рождается ребенок за ребенком, без промежутка между ними, она сильно слабеет. В груди мало молока. Ее дети чаще умирают (с. 271). К тому же после многочисленных беременностей у нее возрастает опасность умереть при родах и оставить своих детей без матери. Поэтому многие пары сейчас сами решают, какой промежуток выбрать между беременностями — два года или больше — чтобы избежать большого количества детей.

Если мужчина и женщина имеют много детей, то, когда дети вырастут, может просто не хватить земли, чтобы выращивать еду, которая нужна всей семье. Дети могут умирать от голода. Это случается во многих местах.

Хотя сегодня голод в основном можно предупредить, если справедливо распределять землю и богатство, рост населения создает проблемы. Но решение не в том, чтобы насильно заставлять бедняков ограничивать количество детей, которых они хотят иметь. Задача общества — обеспечить достаточную социальную защищенность, чтобы бедняки могли позволить себе иметь мало детей.

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ И КОНТРОЛЬ РОЖДАЕМОСТИ



Многие родители по различным причинам хотят ограничить размер своей семьи. Некоторые молодые родители решают, что должны заработать достаточно денег, чтобы позволить себе иметь детей и хорошо заботиться о них. Некоторые родители считают, что маленькое количество детей достаточно. Другие могут хотеть сделать промежуток между детьми в несколько лет, так чтобы и дети, и мать были здоровыми. Некоторые родители могут чувствовать себя слишком старыми, чтобы иметь еще детей.

Планирование семьи – это желание иметь столько детей, сколько хотите и когда хотите.

Когда мужчина или женщина решают, когда они хотят иметь детей и когда не хотят, они могут выбрать какой-либо метод предупреждения беременности у женщины в течение нужного ей для этого времени. Это методы контроля рождаемости и контрацепции.

О парах, которые хотели бы иметь детей, но не могут, см. на с. 244.

ХОРОШ ЛИ КОНТРОЛЬ РОЖДАЕМОСТИ – И БЕЗОПАСНО ЛИ ЭТО?

1. Хорошо ли это?

В некоторых частях света было много дискуссий о том хороши ли и безопасны различные формы контроля рождаемости. Некоторые религии против любой формы контроля рождаемости, кроме ограничения сексуальных контактов. Но все большее число лидеров этих религий понимает, как важно для здоровья и благополучия семьи и общества, чтобы люди могли пользоваться более легким и надежным методом контроля рождаемости.

К тому же во многих местах беременные женщины, когда не хотят иметь ребенка, делают аборт, чтобы прервать беременность. Там, где аборты легальные, их могут делать в центрах здоровья в санитарных условиях и они обычно не так опасны для женщин. Но там, где аборты запрещены, многие женщины делают аборты нелегально и тайно, часто у неквалифицированных людей в антисанитарных условиях. Тысячи женщин умирают от таких абортов. Если женщине предоставить возможность использовать метод контроля рождаемости и информацию о его правильном применении, многие аборты, легальные и нелегальные, будут не нужны. Многие ненужные страдания и смерти можно предупредить (см. Осложнения после абортов, с. 414 и 415).

Некоторые люди считают, что большие усиливая по планированию семьи предпринимаются богатыми странами или богатыми людьми, которые хотят сохранить контроль над бедными, регулируя их количество. Богатые и имущие не считаются с тем, что их способ управления земельными угодьями и ресурсами вносит большой вклад в мировой голод. Они видят только растущее количество людей. В некоторых странах специалисты насильно стерилизуют бедных женщин или испытывают на них новые или ненадежные методы. По этим причинам социальные реформаторы и представители бедняков часто протестуют против контроля рождаемости.

Это неразумно. Объектом атаки должны быть не методы контроля, а неправильное их использование. Выступать следует против социальной несправедливости и нечестного распределения земли и богатств. При правильном использовании контроль рождаемости действительно может помочь беднякам набраться сил для работы на основе их человеческих прав. А решения и ответственность за планирование семьи должны быть в руках самих людей.

**Решите для себя, как вы хотите планировать семью.
Не разрешайте никому решать это за вас.**

2. Безопасно ли это?

Очень часто те, кто выступает против контроля рождаемости по религиозным или политическим мотивам, стараются запугать женщин разговорами о большом риске. Некоторые методы действительно связаны с определенным риском. Однако важнее, чтобы все женщины усвоили, **что контроль рождаемости менее опасен**, чем беременность, особенно для женщин моложе 20 лет и старше 35 лет и для женщин, уже имеющих много детей.

Риск серьезных заболеваний или смерти, вызванных беременностью, в много раз выше, чем риск, содержащийся в использовании обычных методов контроля рождаемости.

Много говорится о риске при приеме противозачаточных пилюль. Но риск, связанный с беременностью, намного выше. Пиллюля работает настолько хорошо для предупреждения беременности, что для большинства женщин она безопаснее – с точки зрения сохранения их жизнью – чем другие, “менее рискованные”, но и менее эффективные методы.

ВЫБОР МЕТОДА КОНТРОЛЯ РОЖДАЕМОСТИ

На следующих страницах описаны несколько методов контроля рождаемости. Для некоторых людей одни методы работают лучше других. Изучите эти страницы и обсудите с акушеркой, работником здравоохранения или доктором, какой из методов вам подойдет и будет работать наилучшим образом. Необходимо рассмотреть различия в **эффективности, безопасности, удобстве, пригодности и стоимости**. Мужья и жены должны вместе решать эти вопросы и вместе делить ответственность.

СРЕДНЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ КОНТРОЛЯ РОЖДАЕМОСТИ

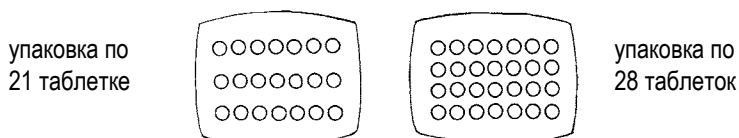
Из каждых 20 женщин, использующих этот метод . . .	в среднем столько могут забеременеть в зависимости от метода	и столько должны (или могли бы) прервать метод из-за проблем.
ПИЛЮЛИ	■	■
ПРЕЗЕРВАТИВ	■■	
КОЛПАЧОК	■■■	■
ПЕНА	■■■■	
ВМС	■	■■■■■■
ИЗЪЯТИЕ	■■■■■	
СТЕРИЛИЗАЦИЯ		*
ИНЪЕКЦИИ		■■
ИМПЛАНТЫ	■	■
ГУБКА (ДОМАШНИЙ МЕТОД)	■■■■■■■	■■■
РИТМ	■■■■■■■	
СЛИЗЬ	■■■■■■■	■■■■■
	СОВМЕСТНЫЙ	

* При стерилизации изредка могут быть хирургические проблемы, но метод безотказный.

ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ ТАБЛЕТКИ

Противозачаточные таблетки изготовлены из химических препаратов (гормонов), которые обычно присутствуют в женском организме. При правильном приеме “таблетка” – один из наиболее эффективных методов для контроля беременности. Однако некоторым женщинам не следует принимать противозачаточные таблетки, если они могут пользоваться другими средствами (см. с. 288). Противозачаточные таблетки не предохраняют от СПИДа или венерических заболеваний. Для предохранения от таких болезней пользуйтесь презервативом (см. с. 290). Противозачаточные таблетки следует принимать под наблюдением работников здравоохранения, медсестер или других опытных людей.

Таблетки обычно выпускают в упаковках по 21 или 28 штук. Упаковки по 21 штуку часто дешевле, чем другие. Количество лекарств различается в различных упаковках. Чтобы подобрать те лекарства, которые вам подходят, смотри Приложение 1, с. 394 и 395.



Как принимать пилюли – упаковки по 21 шт.:

Первую таблетку примите на пятый день от начала менструации, считая первый день месячных номером один, затем принимайте по 1 таблетке каждый день, пока упаковка не опустеет (21 день). **Принимайте ваши пилюли в одно и то же время ежедневно.**

После окончания пакета подождите 7 дней до начала следующего приема таблеток. Затем начните другой пакет по 1 таблетке ежедневно.

Таким образом, вы будете принимать пилюли в течение 3 недель каждый месяц, затем пропускать 1 неделю. Обычно месячные приходят тогда, когда не принимаются таблетки. Даже если месячные не придут, начинайте новую упаковку через 7 дней после окончания предыдущей.

Если вы не хотите забеременеть, важно принимать таблетки так, как указано – по 1 каждый день. Если в какой-то день вы забыли принять таблетку, примите ее, как только вспомните об этом, или примите 2 на следующий день.

Пакет из 28 пилюль:

Примите первую таблетку на пятый день месячных, так же как и с упаковками по 21 штуке. Принимайте по 1 в день. Семь из всех таблеток, возможно будут отличаться по размеру и по цвету. Принимайте эти таблетки последними (одну в день), когда выпьете все остальные. На следующий день после окончания упаковки из 28 таблеток начинайте другую упаковку. Принимайте по 1 таблетке ежедневно, не пропуская ни дня, одну упаковку за другой, столько времени, сколько вы не хотите стать беременной.

Не следует придерживаться специальной диеты во время приема таблеток. Даже если вы простынете или заболев какой-либо обычной болезнью, продолжайте принимать таблетки по этим же правилам. Если вы перестанете принимать таблетки прежде, чем закончится упаковка, вы можете забеременеть.

Побочные эффекты:

У некоторых женщин, когда они впервые начинают принимать пилюли, появляются незначительная утренняя болезненность, распухание груди или другие признаки беременности. Это происходит потому, что пилюли содержат такие химические вещества (гормоны), которые женский организм вносит в ее кровь при беременности. Эти признаки не означают, что она не здорова или должна прекратить прием пилюль. После первых 2 или 3 месяцев они обычно исчезают. Если признаки не исчезают, то она вынуждена поменять сорт пилюль с другим количеством гормонов. Эта тема обсуждается в приложении 1 (с. 394 и 395).

Большинство женщин при приеме пилюль меньше кровоточат, чем обычно, в период своих месячных. Такое изменение обычно не важно.

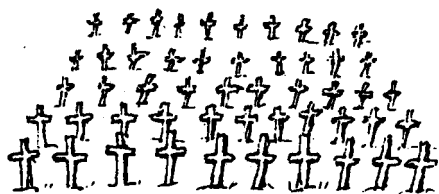
“Опасно ли принимать оральные противозачаточные средства?”

Как всякое лекарство, контролирующие рождаемость, пилюли обычно вызывают серьезные проблемы у определенных людей (смотрите следующие страницы). Самые серьезные из них – это кровяной тромб в сердце, легких или мозгу (см. Паралич, с. 327). Такое наиболее часто встречается у женщин, которые курят, особенно если им за 35. Однако шанс приобретения опасных тромбов выше, когда женщина беременеет во время приема пилюль.

Хотя это происходит редко, женщина может забеременеть во время приема пилюль. Если это произошло, немедленно прекратите принимать пилюли, потому что это может навредить развитию малыша.

Смерть из-за приема пилюль редка. В среднем беременность и роды в 50 раз опаснее, чем прием пилюль.

Из 15000 беременных женщин пятьдесят умирают из-за сложных ситуаций во время беременности или родов.



Из 15000 женщин, принимающих пилюли, только одна может умереть из-за проблем, связанных приемом пилюль.



Вывод:

НАМНОГО БЕЗОПАСНЕЕ ПРИНИМАТЬ ПИЛЮЛИ, ЧЕМ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ.

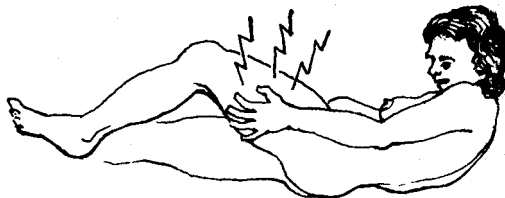
Для большинства женщин эти пилюли относительно безопасны. Определенно они более безопасны, чем беременность. **Однако для некоторых женщин как беременность, так и прием пилюль несут в себе более высокий риск. Такие женщины должны использовать другие методы контроля рождаемости.**

Кто не Должен Принимать Пилюли, Контролирующие Рождаемость?



Женщина, у которой имеется любой из следующих признаков, **не** должна принимать оральные (или в инъекциях) контрацептивы:

- Женщина, у которой задерживаются месячные, и она подозревает беременность.
- **Глубокая или постоянная боль в одной ноге или бедре.** Это может быть вызвано воспалением вен (флебит или тромб в крови). Не пользуйтесь противозачаточными пилюлями. (Женщина с **варикозными венами**, которые не воспалены, обычно может принимать пилюли без проблем. Но она должна прекратить их прием, если вены воспалятся.)
- **Паралич.** Женщина с любым признаком паралича (с. 327) не должна принимать пилюли.
- **Гепатит (с. 172), цирроз (с. 328) или другое заболевание печени.** Женщины с такими осложнениями или те, чьи глаза желтели во время беременности, не должна принимать пилюли. После гепатита лучше в течение года не принимать оральные контрацептивы.
- **Рак.** Если у вас есть или вы подозреваете рак груди или матки, не используйте оральные контрацептивы. До начала использования оральных контрацептивов тщательно исследуйте свою грудь (см. с. 279). В некоторых центрах здоровья вам смогут сделать простой тест (Пап-мазок) по поводу рака шейки матки. Противозачаточные пилюли не вызывают рак груди или матки. Но если рак уже есть, то пилюли могут ухудшить положение.



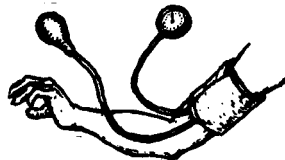
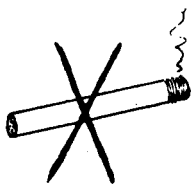
Некоторые заболевания ухудшаются при использовании оральных контрацептивов. Если у вас есть любая из следующих проблем, то лучше использовать другой метод, если сможете:

- **Мигрень** (с. 162). Женщина, страдающая от сильной мигрени, не должна принимать оральные контрацептивы. Но простая головная боль, исчезающая после приема аспирина, не причина для отказа от пилюль.
- **Инфекция мочевой системы с опуханием ступней** (с. 234).
- **Болезни сердца** (с. 325).
- **Высокое кровяное давление** (с. 125).

Если вы страдаете астмой, туберкулезом, диабетом или эпилепсией, то лучше всего получить проконсультироваться с медиком до приема пилюль. Однако большинство женщин с этими болезнями принимают оральные контрацептивы без последствий.

Меры Предосторожности при Использовании Противозачаточных Пилюль

1. Не курите, особенно, если вам за 35. Это может вызвать сердечные проблемы.
2. Ежемесячно обследуйте грудь на предмет опухоли или возможных признаков рака (см. страницу 279).
3. Измеряйте кровяное давление каждые 6 месяцев.



4. Следите за любыми ситуациями, упомянутыми на странице 288, особенно:
 - Сильные и частые головные боли при мигрени (с. 162).
 - Головокружение, головная боль или потеря сознания, в результате которых трудно смотреть, говорить или двигать частью лица или тела (см. Паралич, с. 327).
 - Боль с воспалением ног или бедер (вероятность кровяного тромба).
 - Сильная и повторяющаяся боль в грудной клетке (см. Болезни сердца, с. 325).

Если одна из этих проблем развивается, то прекратите прием пилюль и обратитесь за советом к медицинскому работнику. Предупреждайте беременность, пользуясь другим методом, так как эти проблемы сделают беременность особенно опасной.

Вопросы и Ответы о Противозачаточных Пилюлях

 Некоторые люди утверждают, что пилюли вызывают рак. Это так?	Нет! Однако если рак груди или матки уже есть, то прием пилюль может ускорить рост опухоли.
? Может ли женщина иметь ребенка вновь после прекращения приема пилюль?	Да. (Иногда проходит 1 или 2 месяца прежде, чем она сможет стать беременной.)
?? Увеличивается ли вероятность заиметь двойню или дефективного ребенка, если женщина пользовалась оральными контрацептивами?	Нет. Шансы такие же, как для женщин, которые не принимали пилюль.
?  Действительно ли, что грудь матери усохнет, если она начнет принимать противозачаточные пилюли?	При приеме пилюль у некоторых женщин будет меньше вырабатываться молока. Так что лучше использовать другой метод контроля рождаемости в течение 6 первых месяцев, а затем принимать пилюли. Или она может принимать “мини-пилюли” (с. 395), которые содержат так мало гормонов, что обычно не действуют на молоко.

Информацию о выборе противозачаточных пилюль смотрите на с. 394 и 395.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ РОЖДАЕМОСТИ

ПРЕЗЕРВАТИВ – это узкий резиновый или каучуковый мешочек, который мужчины надевают на свой пенис во время полового акта. Обычно он очень хорошо предохраняет от зачатия. **Это также единственное надежное средство для профилактики от СПИДа и других болезней, передающихся половым путем, но не дающее полных гарантий.**



Наденьте презерватив на возбужденный пенис, оставив на кончике свободное место для спермы. Скатите презерватив вниз пениса. Мужчина может прорвать презерватив, когда вынимает свой пенис из партнера.

Вы можете приобрести презервативы в большинстве аптек. Презервативы иногда освобождают от больниц или от клинического планирования семьи. Презерватив следует использовать только один раз. Маловероятно, что повторно использованный презерватив предохранит от болезни или от беременности. (Для верности сначала его вымойте.)

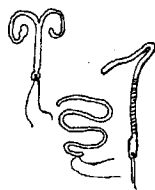
КОЛПАЧОК – неглубокая чашечка из мягкой резины. Женщина носит его в своем влагалище во время половых сношений. Он должен оставаться во влагалище не менее шести часов после полового акта. Это довольно безопасное средство, если применять его вместе с контрацептивным кремом или желе. Работник здравоохранения или акушерка могут помочь подобрать колпачок, поскольку разным женщинам требуются колпачки разного размера. Регулярно проверяйте, нет ли в колпачке дырочек или трещин, просматривая его на свет. Если есть хотя бы малюсенькая дырочка, замените колпачок на новый. Они обычно используются в течение года или дольше. После использования вымойте его в теплой мыльной воде, прополощите и высушите. Храните в сухом чистом месте.



КОНТРАЦЕПТИВНАЯ ПЕНА выпускается в тубиках или баночках. Женщина вводит ее в свое влагалище специальным аппликатором. Ее следует вводить не более чем за 1 час до полового акта, и она должна оставаться там не менее 6 часов после него. Введение пены следует повторять перед каждым половым актом, даже если они происходят в течение одной ночи. Это довольно безопасное средство, если им правильно пользоваться.



ВНУТРИМАТОЧНАЯ СПИРАЛЬ (ВМС) представляет собой пластмассовый (или иногда металлический) предмет, который специально вводится работником здравоохранения или акушеркой внутрь матки. Пока он находится в матке, он предохраняет от беременности. ВМСы у некоторых женщин выпадают, у некоторых вызывают боль, дискомфорт, периодами сильные кровотечения, а иногда и более серьезные проблемы, но у многих женщин они не вызывают никаких забот. Для этих женщин ВМС могут представлять самое простое и наиболее экономичное средство. Посмотрите с. 396 прежде, чем решитесь применять ВМС.



ИЗЪЯТИЕ ИЛИ ВЫТАСКИВАНИЕ (ПРЕРЫВАНИЕ СОВОКУПЛЕНИЯ) – метод, при котором мужчина вытаскивает свой пенис из женщины прежде, чем начнет извергаться сперма. Этот метод лучше, чем никакой, но может помешать партнерам или не сработать, потому что некоторые мужчины не смогут вытащить пенис вовремя, особенно, если они выпили. Этот метод рискованный, поскольку сперма частично присутствует и в первых каплях чистой жидкости, которая выходит из мужского пениса.

МЕТОД РИТМА

Этот метод не очень надежный для предупреждения беременности, но его преимущество в том, что он ни во что не обходится. **Он наиболее подходящий для женщин, у которых месячные приходят более или менее регулярно каждые 28 дней.** К тому же, муж и жена должны быть готовы ежемесячно проводить одну неделю без интимной близости.

Обычно женщина имеет шанс забеременеть лишь в течение 8 дней из ее месячного цикла – ее “дни зачатия”. Эти 8 дней попадают на середину ее периода, начиная с 10 дней после первого дня ее менструального кровотечения. Чтобы избежать беременности, женщина не должна заниматься сексом со своим мужем в течение этих 8 дней. В оставшиеся дни месяца вероятность забеременеть у нее очень маленькая.

Чтобы не запутаться, женщина должна отметить в календарике 8 дней, когда она не должна заниматься сексом.

Например: Предположим, что ваш цикл начинается 5 мая. Считаем этот день номером 1.

Отметим его:

Затем отсчитаем 10 дней. Начиная с 10-го дня, подчеркнем линией следующие 8 дней:

В течение этих 8 “дней зачатия” нельзя иметь половых сношений.

Сейчас предположим, что ваш следующий цикл начнется 1 июня. Отметим этот день таким же образом:

Опять отсчитайте от него 10 дней и подчеркните следующие 8 дней, в течение которых вы не должны иметь сексуальных контактов.

Если женщина и ее муж будут регулярно избегать сексуальных контактов в течение этих 8 дней ежемесячно, возможно, что они проведут годы, не зачиная ребенка. Несмотря на то, что некоторые пары успешно пользуются этим методом очень длительное время, он не очень надежный. Тем не менее, он используется в комбинации с другими методами, такими как колпачок и презервативы, особенно в течение нескольких дней от конца менструации до тех пор, пока не пройдут дни зачатия.

МАЙ						
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

ИЮНЬ							
							1
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30							

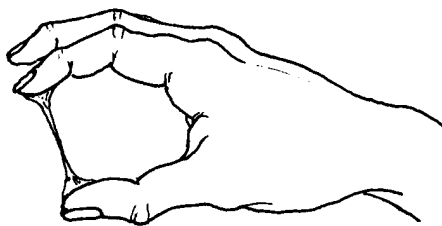
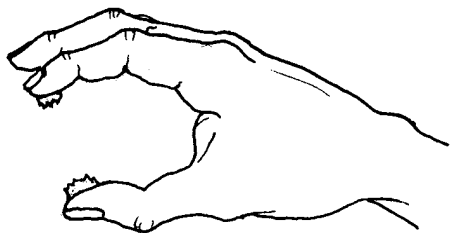
МЕТОД СЛИЗИ

Это один из вариантов метода ритма. Женщина определяет, когда она могла бы забеременеть, проверяя ежедневно слизь в своем влагалище. Он работает хорошо для одних пар и плохо для других. В основном он не может считаться надежным способом предохранения от беременности, но он ничего не стоит и нет никакого риска для здоровья, кроме самой беременности. Однако он более сложный, если у женщины влагалищная инфекция с обильными выделениями или если ее период не регулярный.

Каждый день, за исключением месячных, женщина должна контролировать слизь из влагалища. Возьмите немного слизи из влагалища чистыми пальцами и попытайтесь растянуть ее между пальцами, как показано на рисунке.

Пока слизь липнет как паста – не тягучая или вязкая – вы, вероятно, не забеременеете, и можете далее продолжать сексуальные отношения.

Когда слизь начнет становиться тягучей, как сырое яйцо или если растягивается между пальцами, вы можете стать беременной, если будете продолжать половую жизнь. Итак, **не занимайтесь сексом, когда слизь вязкая или тягучая, или еще 4 дня после того как слизь перестанет быть тягучей и вязкой и снова станет пастообразной.**



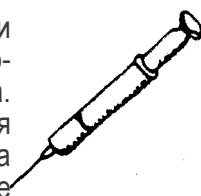
Слизь обычно становится тягучей в течение нескольких дней посередине между месячными. Это те же дни, когда вы не должны иметь сексуального контакта с вашим мужчиной, как если бы вы использовали метод ритма.

Для большей надежности используйте метод слизи и метод ритма одновременно. Чтобы быть еще более уверенной, смотри ниже.

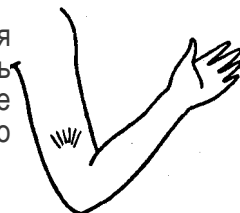
КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ:

Если вы хотите быть более уверенной в том, что не забеременеете, лучше всего использовать два метода одновременно. Метод ритма или метод слизи в комбинации с использованием презерватива, колпачка, пены или губки надежнее, чем любой из этих методов по отдельности. Если мужчина пользуется презервативом, а женщина колпачком или пеной, то вероятность забеременеть очень мала.

ИНЪЕКЦИИ. Существуют специальные инъекции для предохранения от беременности. Одна из них Депо-Провера. Инъекцию обычно делают каждые 3 месяца. Побочные эффекты и противопоказания те же, что и для противозачаточных таблеток. После того как женщина перестанет делать инъекции, она может год или больше не беременеть. Но чтобы избежать беременности, разумно применять другие методы контроля рождаемости.



ИМПЛАНТЫ. При этом методе 6 маленьких капсул вводятся под кожу. Если оставить их там, они могут предотвращать беременность в течение почти 5 лет. Первый год менструальное кровотечение может усилиться. Обратитесь в клинику, если это произойдет.

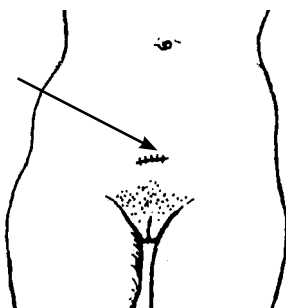
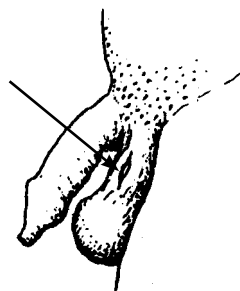


Инъекции и импланты полезны для женщин, которые боятся забыть принять таблетки или у которых возникают проблемы при использовании других методов контроля рождаемости. См. с. 396 для получения большей информации об этих методах.

МЕТОДЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ

СТЕРИЛИЗАЦИЯ. Для тех, кто никогда больше не хочет иметь детей, существуют совершенно безопасные, простые операции как для мужчин, так и для женщин. Во многих странах такие операции доступны. Обратитесь в центр здоровья.

- **Для мужчин** операция называется вазектомия. Ее можно сделать просто и быстро в кабинете врача или в центре здоровья, обычно без наркоза. Маленькие надрезы делают в этом месте так, чтобы трубы от мужских яичек можно было надрезать и перевязать. Яички не удаляются.
- Операция не влияет на сексуальные желания мужчины и на получение удовольствия. Жидкость у него выходит, но без спермы.
- **Для женщин** операция называется перевязкой труб. При этом делается маленький надрез в нижней части живота так, чтобы трубы, идущие из яичников, можно было надрезать и перевязать. Операцию обычно можно делать без наркоза в кабинете врача или в центре здоровья. Хотя, как правило, эта операция безопасна, но риск внести инфекцию при ней выше для женщин, чем для мужчин.



Эта операция не влияет на менструальный цикл женщин или на их сексуальные желания, а женщина сможет получить большее наслаждение, поскольку у нее не будет страха перед беременностью.

ДОМАШНИЕ МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

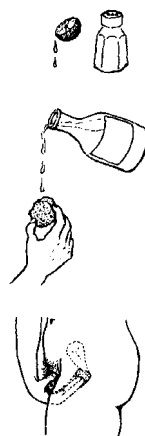
В каждой местности существуют “домашние методы” для предупреждения или прерывания беременности. К сожалению, большинство из них либо не помогает, либо опасно. Например, некоторые женщины считают, что промыв влагалище или помочившись после полового акта, они не забеременеют, **но это неправда.**

КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ. Пока женщина кормит грудью своего младенца, вероятность забеременеть у нее меньше, особенно, если грудное молоко является единственной пищей для ее малыша. Шанс забеременеть намного повышается через 4-6 месяцев, когда ребенка начинают подкармливать и другой пищей. Но даже тогда кормление грудью может помочь предохраниться от беременности, если женщина кормит грудью и днем, и ночью, и грудное молоко является главной пищей. Для большей уверенности, что она не забеременеет, мать, которая кормит грудью, должна начинать применять другие методы контроля рождаемости, когда младенцу исполнится 3 или 4 месяца. Любой другой метод, отличный от использования противозачаточных таблеток, лучше, поскольку такие таблетки у некоторых женщин вызывают уменьшение производства молока. (“Мини-таблетки” вызывают меньше проблем. см. с. 395.)



МЕТОД ГУБКИ. Этот домашний метод безопасный и иногда помогает. Вы не можете быть уверены, что он поможет всегда, но его можно применять, когда больше нет ничего подходящего.

Вам потребуется губка и **уксус**, **лимон** или **соль**. Подойдет либо морская губка, либо искусственная. Если у вас нет губки, используйте шарик из хлопкового волокна, коры капки или мягкой ткани.



- ◆ Смешать:
 - 2 столовых ложки уксуса с 1 стаканом чистой воды
 - или
 - 1 чайную ложку лимонного сока с 1 стаканом чистой воды
 - или
 - 1 ложку соли с 4 ложками чистой воды
- ◆ Пропитать губку одной из этих жидкостей.
- ◆ Вложить мокрую губку глубоко во влагалище перед половым актом. Вы можете это сделать и за час до начала секса.
- ◆ Оставить губку, по крайней мере, на 6 часов после полового акта. Если вы с трудом извлекаете губку, в следующий раз привяжите к ней резинку или кусочек ленточки, чтобы облегчить ее извлечение.

Губку можно вымыть и использовать много раз. Храните ее в чистом месте.

Остаток жидкости можно слить и хранить в бутылочке.

**Жизненная сила не в большом, а в достаточном количестве еды.
Планируйте свою семью.**

ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНИ ДЕТЕЙ

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ



Главы 11 и 12 больше рассказывают о значении питательной еды, чистоты и прививок. Родители обязаны прочитать эти главы внимательно и использовать их как помощь во время ухода за своими детьми для их обучения. Главные моменты здесь кратко повторяются.

Питательная Еда

Важно, чтобы дети ели самую питательную пищу, какую могут получить, чтобы они хорошо росли и не заболели.

Самыми лучшими продуктами для детей в разном возрасте являются:

- ♦ в первые 4-6 месяцев: **грудное молоко** и ничего более.
- ♦ от 6 месяцев до года: **грудное молоко и другие питательные продукты** - такие как вареные злаки, бобовое пюре, яйца, мясо, вареные фрукты и овощи.
- ♦ в возрасте больше года: ребенок должен есть **ту же пищу, что и взрослые, но более часто**. К основным продуктам (рис, кукуруза, пшеница, картофель или маниок) добавляются “вспомогательные продукты”, о которых говорилось в Главе 11.
- ♦ Прежде всего, дети должны получать **достаточно** еды.

Все родители обязаны следить за признаками недоедания у своих детей и давать им самую лучшую пищу, какую они могут.

Чистота

Дети с большей вероятностью будут здоровы, если их деревня, их дома и они сами содержатся в чистоте. Следуйте принципам чистоты, разъясненным в 12 главе. Обучите детей следовать им - и понимать их важность. Повторим самые важные принципы:

- Чаще купайте и переодевайте детей.
- Приучите детей всегда мыть руки утром, когда они встают, после опорожнения и до еды или когда берут пищу руками.
- Делайте уборные или "домик во дворе" - и научите детей пользоваться ими.
- Если можно, не позволяйте детям ходить босиком; заставьте их одевать сандалии или башмаки.
- Обучите детей чистить зубы щеткой; и не давайте им много конфет, сладкого или газированных напитков.
- Обрезайте ногти на пальцах очень коротко.
- Не позволяйте детям, которые болеют или у которых есть язва, чесотка, вши или стригущий лишай, спать с другими детьми или пользоваться одной и той же одеждой, или полотенцем.
- Сразу лечите детей от чесотки, стригущего лишая, кишечных глистов и других инфекций, которые легко распространяются от ребенка к ребенку.
- Не позволяйте детям брать грязные вещи в рот или лизать их лица собакам или кошкам.
- Держите свиней, собак и цыплят вне дома.
- Используйте для питья только чистую, кипяченую или отфильтрованную воду. Это особенно важно для малышей.
- Не кормите малышей из бутылочек, так как трудно сохранить их чистыми, а грязь может вызвать заболевание. Кормите малышей ложкой из чашки.

Прививки

Вакцинации защищают детей от многих самых опасных болезней детства - коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори и туберкулеза.

Дети должны получить разные вакцинации в течение первых месяцев жизни, как показано на с. 147. Капли от полиомиелита желательно дать первыми, если возможно, то еще при рождении, но не позже двухмесячного возраста, поскольку риск развития младенческого паралича (полиомиелита) самый высокий у детей до года.

Важно: Для полной защиты, вакцины КДС (коклюш, дифтерия, столбняк) и поливакцины необходимо давать раз в месяц в интервале трех месяцев и один раз после года.

Защитить новорожденного от столбняка можно вакцинируя его мать во время беременности (см. с. 250).



Убедитесь, что ваши дети получили все необходимые прививки.

РОСТ ДЕТЕЙ – И “ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ”

Здоровый ребенок постоянно растет. Если он достаточно ест питательную еду и если у него нет серьезных заболеваний, то ребенок каждый месяц набирает вес.

Ребенок, который хорошо растет - здоров.



Ребенок, который набирает вес более медленно, чем другие дети, не прибавляет вес или уменьшает вес, - не здоров. Он или не ест достаточно, или у него серьезное заболевание, или то и другое.

Хорошим способом проверки, здоров ли ребенок и получает ли он достаточно питательную пищу, является его ежемесячный вес, по которому видно, что он набирает вес нормально. Если ежемесячно записывать вес ребенка в Медицинскую карту ребенка, то при беглом осмотре легко увидеть, набирает ли вес ребенок нормально.

При умелом использовании такие карточки расскажут матерям и работникам здравоохранения, что ребенок не растет нормально, и можно рано предпринять некоторые меры воздействия. Они могут убедиться, что ребенок получает много еды, и могут контролировать и лечить заболевание, которое может быть есть у ребенка.

На следующей странице дана стандартная Медицинская Карта Ребенка, на которой показан “коридор здоровья”. Эту карту можно вырезать и скопировать. Или более того готовые карточки можно получить (в Англии, Франции, Испании, Португалии или ОАЭ) через Службы Обучения по Низкой Цене (TALC адрес смотрите на с. 429). Подобные карточки на местном языке делают Отделы Здоровья во многих странах.

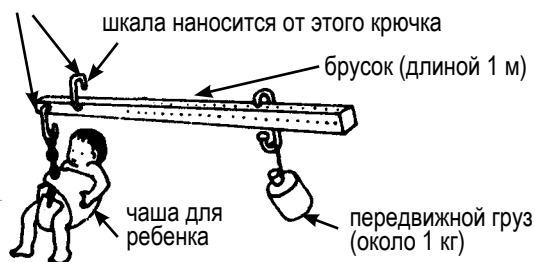
Хорошей целью для каждой матери является сохранение Карты Здоровья каждого из ее детей до 5 лет. Если есть по близости центр здоровья или десткая клиника, мать должна ежемесячно приводить туда своего ребенка с его карточкой для взвешивания и проверки. Медицинский работник поможет понять карточку и разъяснит как ей пользоваться.

Для сохранности Карты Здоровья Ребенка держите ее в пластиковом конверте.

ДОМАШНИЕ РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ

Вы можете сделать домашние весы из сухого дерева. В качестве подвижного груза используйте мешок, бутылку или оловянную банку с песком.

два крючка через 5 см

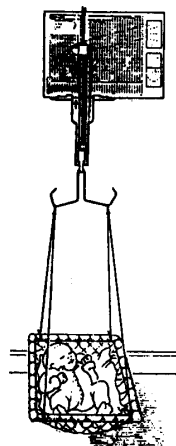


Вес правилен, когда брус стоит горизонтально.

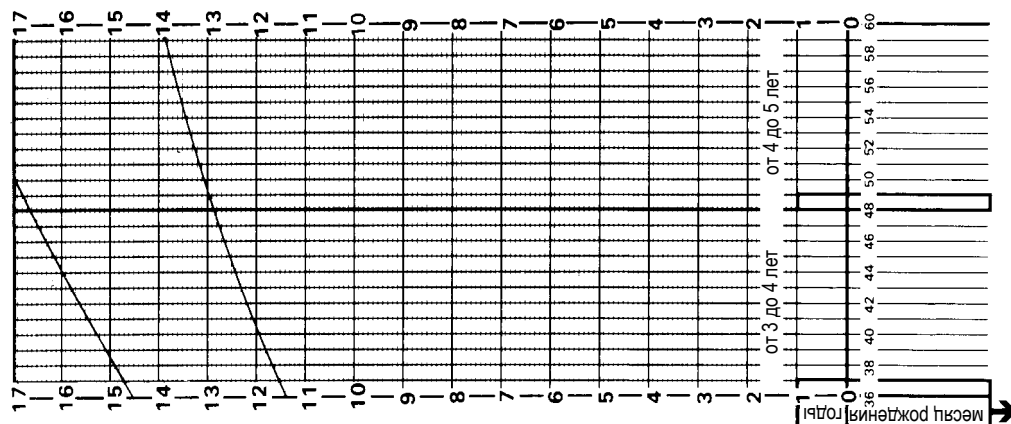
РЕГИСТРИРУЮЩИЕ ВЕСЫ

изготовленные в
TALC (см. с. 429)

Карточка роста скользит позади измерителя, так что вы можете записать вес ребенка сразу на карточку.



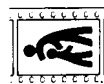
КАРТА ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА



Имя ребенка	мальчик девочка
Дата родов	Вес ребенка
Имя матери	
Нянька, если нет матери	
Имя отца	
Где живет ребенок	
Карта выдается и мать заполняет ее	

Выясните у матери причины, по которым ребенок нуждается в усиленном уходе.

TALC

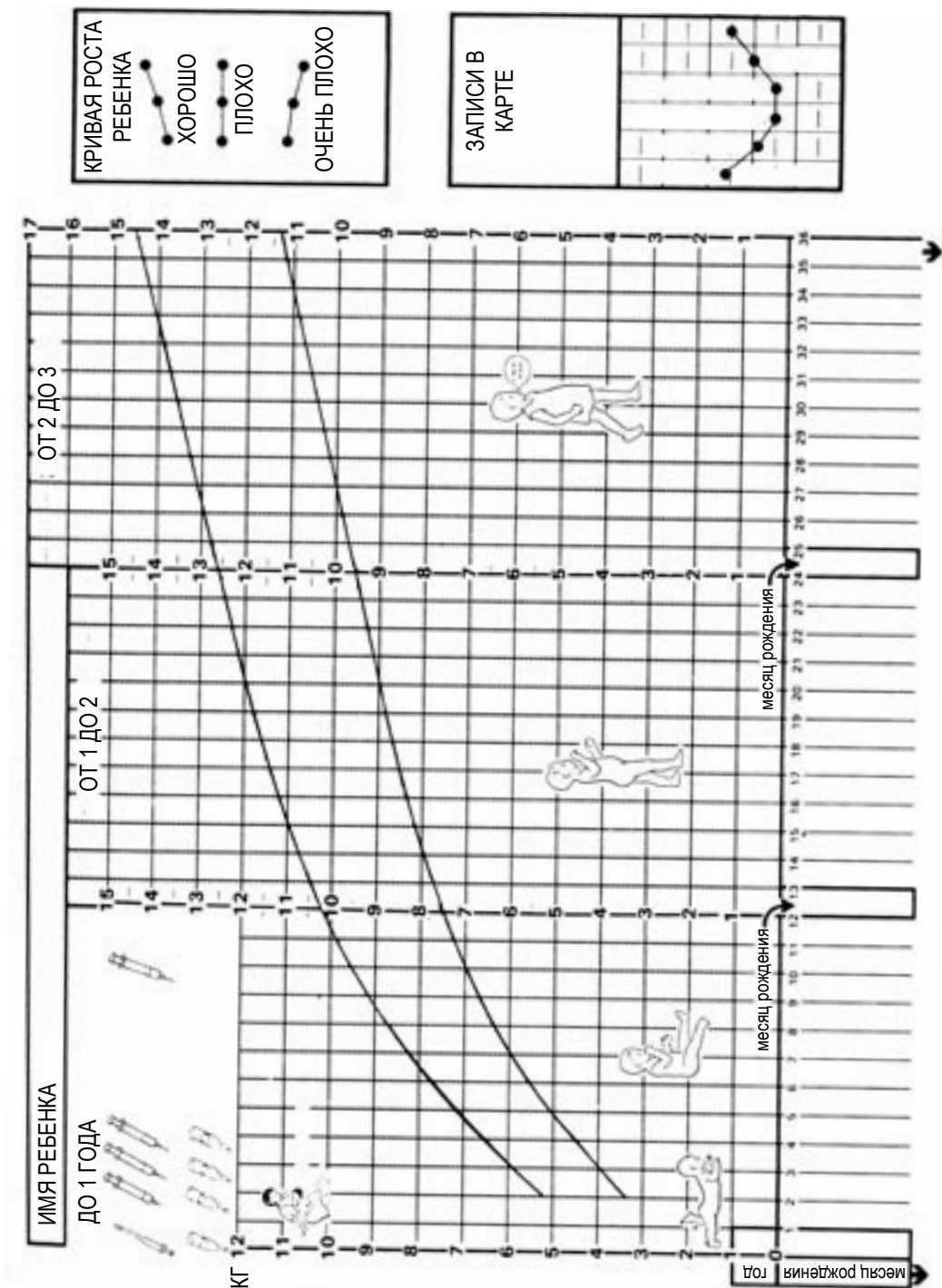


Прививки	Дата
БЦЖ	
Полиомелит	первая доза вторая доза третья доза четвертая доза
КДС	первая доза вторая доза третья доза
Корь	
Против столбняка	первая доза вторая доза третья доза

Оральная регидрация	
---------------------	--

Дата визита

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЧКОЙ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА

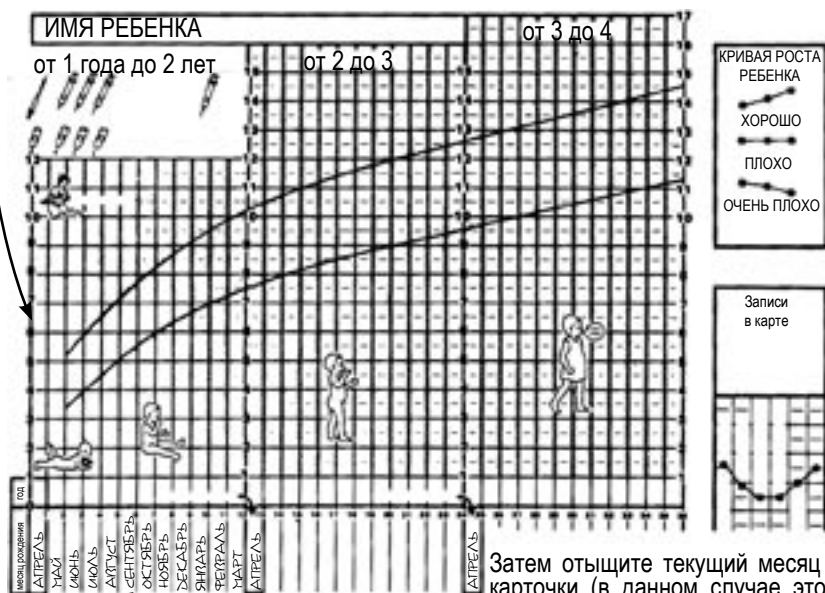
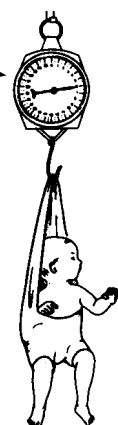
ПЕРВОЕ, впишите месяцы года в маленькие квадратики внизу карточки.



Впишите месяц рождения ребенка в первый квадратик для каждого года. На этой карточке показано, что ребенок родился в марте.

ВТОРОЕ, вес ребенка. Предположим, что ребенок родился в апреле. Сейчас август, и ребенок весит 6 кг.

ТРЕТЬЕ, посмотрите на карточку. Килограммы написаны сбоку карты. Найдите вес ребенка (в данном случае, 6).



Затем отыщите текущий месяц в нижней части карточки (в данном случае это август первого года ребенка).

ЧЕТВЕРТОЕ, следуем
за линией, что идет от 6

и

за линиями,
что идут от августа.



Легко определить, где ставить
точку, если приложить бумажный
квадрат к карточке.

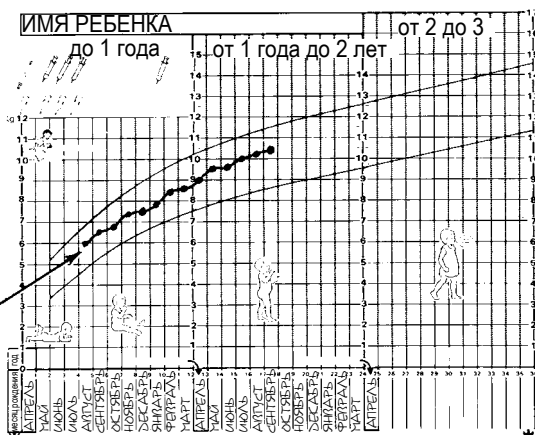
1 Приложим один
край квадрата
к линии веса
ребенка.



Каждый месяц взвешиваем
ребенка и ставим другую точку
на карте.

Если ребенок здоров, то каж-
дый месяц на карте будет по-
являться новая точка выше,
чем предыдущая.

Чтобы видеть, как хорошо рас-
тет ребенок, соедините точки
линией.

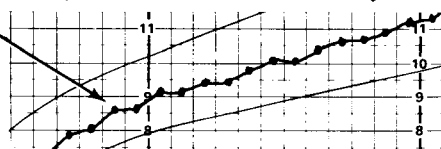
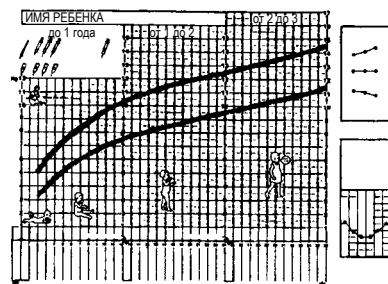


Как Читать Карточку Здоровья Ребенка

Две длинные кривые на карте ограничивают "Путь к Здоровью", на которой должен попасть вес ребенка.

Линия из точек отмечает вес ребенка от месяца к месяцу и от года к году.

Для большинства нормальных, здоровых детей линия из точек попадает между двумя длинными кривыми. Вот почему пространство между этими линиями называется Путь к Здоровью.



Если линия из точек постоянно поднимается в том же направлении как длинные кривые, то это указывает, что ребенок здоров.

Здоровый ребенок, который получает достаточно питательную пищу, обычно начинает сидеть, гулять и говорить в сроки показанные здесь.

Типичная карта здорового, хорошо питающегося ребенка

Делает 10 шагов самостоятельно

Короткие фразы

Сидит сам

отдельные слова



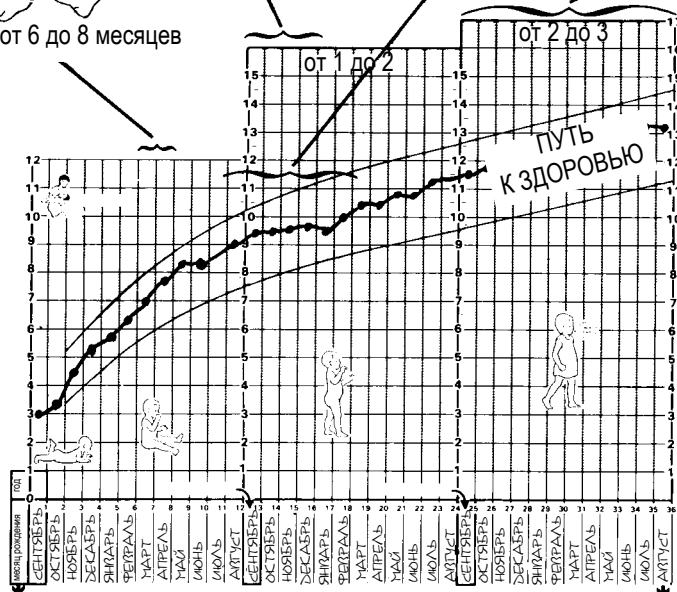
от 6 до 8 месяцев

от 12 до 16 месяцев

от 11 до 18 месяцев

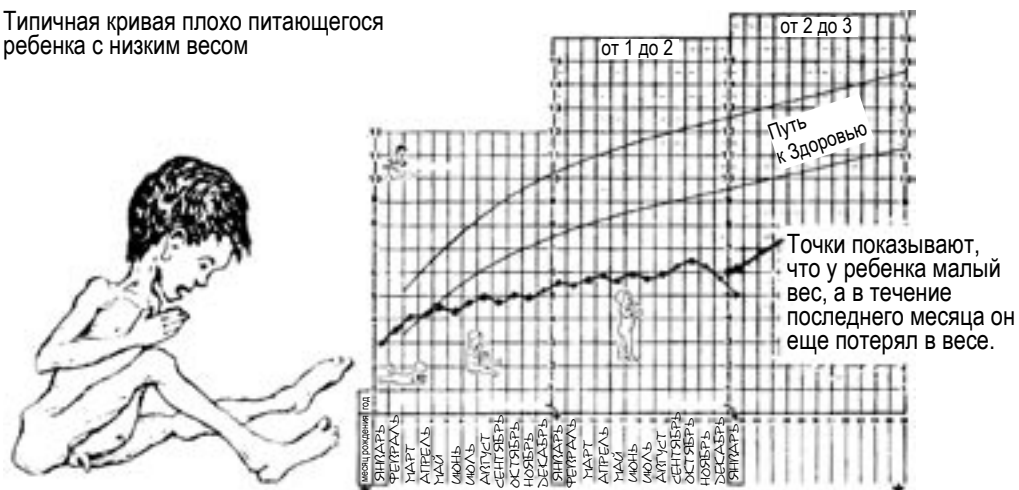
3 год

У здорового, хорошо питающегося ребенка вес растет постоянно. Точки обычно лежат внутри линий, которые образуют Путь к Здоровью



Плохо питающийся, больной ребенок имеет карту, похожую на карту внизу. Заметим, что линия из точек (его вес) лежит ниже Пути к Здоровью. Линия из точек также нерегулярная и не растет сильно вверх. Это показывает, что ребенку становится хуже.

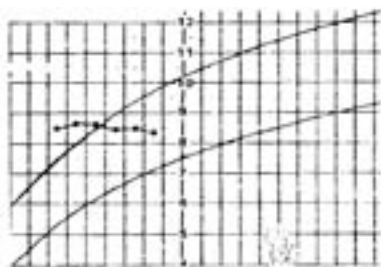
Типичная кривая плохо питающегося ребенка с низким весом



Ребенок с подобной картой здоровья имеет серьезный недовес. Возможно он не получает достаточно еды. Или же он болен туберкулезом или малярией. Или и тем и другим. Он должен потреблять как можно больше пищи, и как можно чаще. Его следует проверить на возможные болезни и отводить к врачам до тех пор, пока кривая не придет в норму.

ВАЖНО: Следите за направлением кривой.

Направление кривой говорит намного больше, чем положение отдельных точек внутри или за пределами ограничивающих линий.



Хотя точки кривой этого ребенка лежат внутри границ, ребенок не набирает вес в течение нескольких месяцев.



Точки кривой этого ребенка лежат за границами, но их направление говорит о том, что ребенок набирает вес. Некоторые дети по природе меньше других. Возможно, их родители не очень крупные.

Типичная Карта Здоровья Ребенка, показывающая его развитие:

Этот ребенок здоров и набрал хорошо вес в течение первых 6 месяцев жизни, поскольку мать кормила грудью.

В 6 месяцев мать снова стала беременной и прекратила грудное кормление. Ребенок питался мало и в основном зерном и рисом. Он перестал набирать вес.

В 10 месяцев развивается хронический понос и начинается потеря веса. Он очень худеет и заболевает.

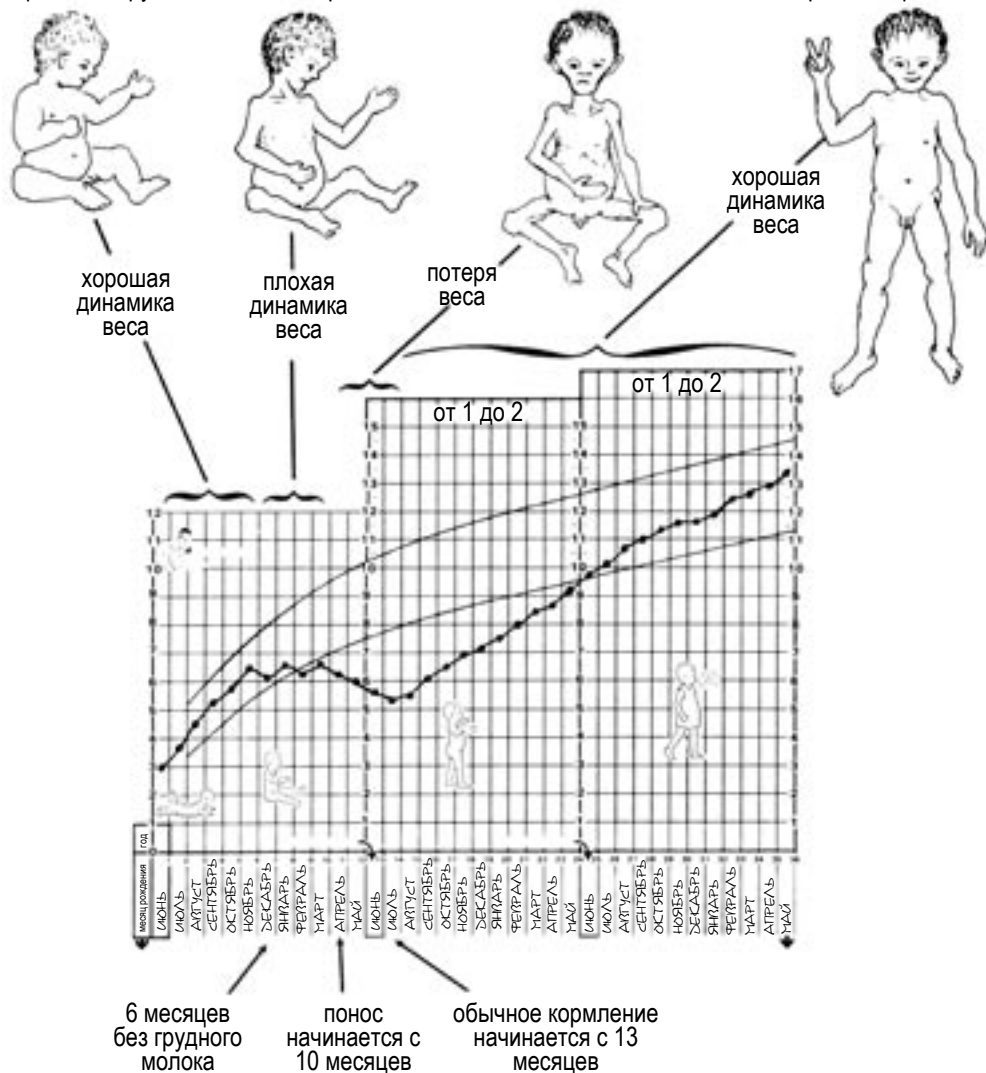
Когда ребенку было 13 месяцев, его мать поняла, как важно дать ребенку достаточно хорошее питание. Он начал быстро набирать вес. К 2 годам он вернулся на Путь к Здоровью.

кормление грудью

плохое кормление

понос

хорошее кормление



Важно иметь Карточки Здоровья Ребенка. При правильном использовании они помогут матерям узнать, когда их дети требуют более питательной пищи и особого внимания. Они помогают медицинским работникам лучше понять потребности ребенка и его семьи. Они также позволяют матери узнать, когда она действует правильно.

ОБЗОР ПРОБЛЕМ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ, РАССМОТРЕННЫХ В ДРУГИХ ГЛАВАХ

У детей обнаруживают многие из болезней, обсуждаемых в других главах этой книги. Здесь кратко рассматриваются некоторые из наиболее часто встречающихся проблем. Для большей информации о конкретной проблеме смотрите указанные страницы.

О специальном уходе и проблемах новорожденных смотрите с. 270-275 и с. 405.

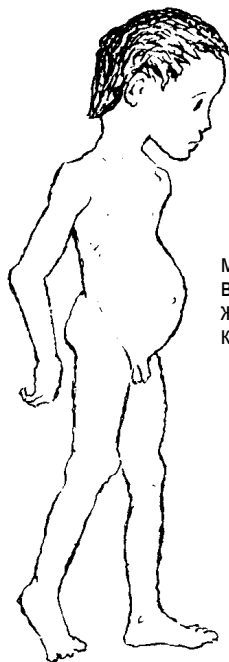
Помните: У детей очень быстро болезни становятся опасными. Болезнь, которая сильно вредит или убивает взрослого в течение дней или недель, может убить маленького ребенка за часы. Так что важно рано заметить признаки болезни и уделить им внимание правильным образом.

Истощенные Дети

Многие дети получают неполноценную пищу, потому что они недостаточно едят. Или они потребляют много продуктов, но с большим количеством воды и клетчатки подобно маниоке или жидкой каше из кукурузы, их животы надуются до того, как они получат достаточно калорий необходимых для тела. Также некоторые дети несомненно недополучают такой важный компонент в их питании, как витамин А (см. с. 226) или йод (см. с. 130). Полное обсуждение детского питания читайте в Главе 11, особенно с. 120-122.

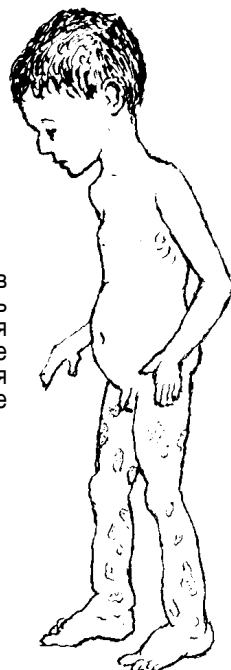
ЭТИ ДВА РЕБЕНКА ИСТОЩЕНЫ

НЕ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО



маленький недобор в массе, большой живот, тонкие руки, кожа и ноги, язвы.

СЕРЬЕЗНО



унылый, недобор в массе (может набирать массу некоторое время из за отекаания), темные пятна, шелушащаяся или открытые опухшие ступни.

Недоедание может вызвать много различных проблем у детей, включая:

В умеренных случаях:

- ◆ замедление роста,
- ◆ вздутый живот,
- ◆ худое тело,
- ◆ потеря аппетита,
- ◆ потеря энергии,
- ◆ бледность (анемия),
- ◆ желание есть землю (анемия),
- ◆ язвы в уголках рта,
- ◆ частые простуды и другие инфекции,
- ◆ куриная слепота.

В более опасных случаях:

- ◆ недобор в массе,
- ◆ отеки ног,
- ◆ (иногда и лица),
- ◆ темные пятна, “синяки”, или открытые шелушащиеся язвы,
- ◆ утончение или выпадение волос,
- ◆ нежелание веселиться или играть
- ◆ язвы во рту,
- ◆ отставание в нормальном умственном развитии,
- ◆ “сухие глаза” (ксерофтальмия),
- ◆ слепота (с. 226).

Тяжелыми формами общего недоедания являются “сухое истощение”, или ма-разм, и “мокрое истощение”, или квашиоркор. Их причины и профилактика обсуждаются на с. 112 и 113.

Симптомы недоедания часто проявляются после острых заболеваний, подобных поносу или кори. Ребенок, который болеет или поправляется после болезни, нуждается даже больше в обильной хорошей пище, чем здоровый.

Профилактика и лечение истощения заключаются в том, чтобы давать вашим детям достаточно еды и как можно чаще. Добавляйте такие высококалорийные продукты, как масло или жир, к основным продуктам детского питания. Также старайтесь добавлять в большом количестве продукты, необходимые для роста и защиты организма такие, как бобы, чечевица, фрукты, овощи и, если возможно, молоко, яйца, рыбу или мясо.

Понос и Дизентерия

(Более полную информацию смотрите на с. 153-160)

Наибольшей опасностью для детей с поносом является **обезвоживание**, или потеря слишком большого количества жидкости из тела. Опасность увеличивается, если ребенка еще и рвет. Дайте **напиток Регидрона** (с. 152). Если ребенок находится на грудном питании, то **продолжайте давать грудное молоко**, но также добавляйте обезвоживающий напиток.

Другой большой опасностью для детей с поносом является недоедание. **Давате ребенку пищу, как только он захочет есть.**



ЖАР (см. с. 75)

У маленьких детей большая температура может легко вызвать припадки или повреждение мозга. Чтобы уменьшить жар, **разденьте ребенка**. Если ребенок плачет и кажется несчастным, то дайте ему **ацетаминофен** (парацетамол) или аспирин в нужной дозе (см. с. 380), давайте много жидкости. Если он очень горячий и его знобит, то **смочите прохладной (но не холодной) водой и обмахивайте его.**



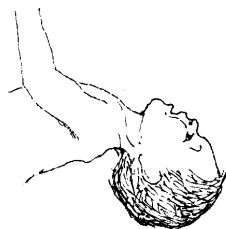
Припадки (Конвульсии) (см. с. 178)

Обычными причинами припадков или конвульсий у детей являются сильный жар, обезвоживание, эпилепсия и менингит. Если жар высокий, то немедленно уменьшайте его (см. с. 76). Проверяйте симптомы обезвоживания (с. 151) и менингита (с. 185). Припадки, которые появляются неожиданно без жара или других причин, возможно эпилептические (с. 178), особенно если ребенок кажется здоровым в промежутках между ними. Припадки или спазмы, при которых вначале челюсть, а затем все тело становится окостеневшим, вызваны столбняком (с. 182).



Менингит (см. с. 185)

Эта опасная болезнь может придти как осложнение после кори, свинки или других заболеваний. Дети матерей, у которых есть туберкулез, могут получить туберкулезный менингит. Очень больной ребенок, который лежит с опрокинутой головой, у которого шея слишком одеревенела в изгибе вперед и тело совершает странные движения (припадки), болеет менингитом.



Анемия (см. с. 124)

Общие симптомы у детей:

- бледность, особенно внутри век, десны и ногтей;
- слабый, легко устает;
- любит есть землю.

Обычные причины:

- пища бедна железом (с. 124);
- хронические кишечные инфекции (с. 145);
- глисты (с. 142);
- малярия (с. 186).



Профилактика и лечение:

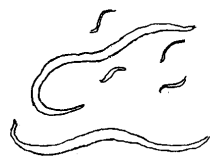
- Есть продукты, богатые железом, такие как мясо и яйца. Бобы, чечевица, арахис (земляной орех) и темно-зеленые овощи также содержат железо.
- Лечить причину анемии – и не позволять ходить босиком, если глисты распространены.
- Если вы подозреваете глисты, то необходим медицинский работник, чтобы рассмотреть стул ребенка под микроскопом. Если обнаружены яйца глистов, то лечите от глистов (с. 374-376).
- Если необходимо, дайте соли железа через рот (сульфат железа с. 393).

Осторожно: Не давайте таблеток железа грудным или маленьким детям. Они могут отравить их. Вместо этого дайте железо в виде жидкости.
Или размельчите таблетку в порошок и смешайте с пищей.

Глисты и Другие Паразиты Кишечника (см. с. 140)

Если у одного ребенка в семье есть глисты, то лечиться должна вся семья. Для профилактики глистных инфекций дети должны:

- ◆ Соблюдать правила гигиены (с. 133).
- ◆ Пользоваться уборными.
- ◆ Никогда не ходить босиком.
- ◆ Никогда не есть сырое или полусырое мясо или рыбу.
- ◆ Пить только кипяченую или чистую воду.



Кожные Проблемы (см. Главу 15)

У детей самые общие включают:

- чесотку (с. 199)
- заразные язвы и кожную сыпь (с. 201 и 202)
- стригущий лишай и другие грибковые заражения (с. 205)



Чтобы предотвратить кожные проблемы, соблюдайте правила гигиены (с. 133).

- ◆ Часто купайте детей и вычесывайте вшей.
- ◆ Следите за клопами, вшами и чесоткой.
- ◆ Не позволяйте детям с чесоткой, вшами, стригущим лишаем или заразными язвами играть и спать вместе с другими детьми. Рано их лечите.

Красные Глаза (Конъюнктивит) (см. с. 219)

Чисто обтирайте веки мокрой чистой тряпочкой несколько раз в день. Накладывайте глазную мазь с антибиотиком (с. 379) вовнутрь век 4 раза в день. Не позволяйте ребенку с конъюнктивитом играть или спать с другими. Если он не поправляется за несколько дней, покажите его медицинскому работнику.



Простуды и Грипп (см. с. 163)

Обычная простуда, при которой течет нос, умеренная температура, кашель, болит горло, а иногда понос, часто бывает у детей, но не представляет серьезной проблемы.

Лечите большим количеством жидкости. Дайте ацетаминофен или аспирин (с. 379). Пусть дети, когда хотят, остаются в постели. Хорошая пища и большое количество фруктов поможет детям избежать простуд и быстро поправиться.



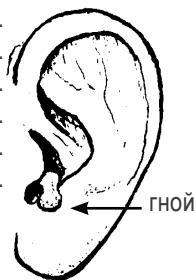
При обычной простуде или гриппе не надо давать пенициллин, тетрациклин и другие антибиотики. Не обязательно делать инъекции при простудах.

Если ребенку с простудой становится очень плохо, у него большой жар и поверхностное быстрое дыхание, то у него возможно пневмония (см. с. 171), и необходимо дать антибиотики. Также наблюдайте за инфекцией ушей (следующая страница) или ангиной (с. 310).

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ, НЕ РАССМОТРЕННЫЕ В ДРУГИХ ГЛАВАХ

Ушная Боль и Инфекции Ушей

Ушные инфекции обычны у маленьких детей. Инфекция часто начинается через несколько дней после простуды с заложенным носом. Жар может усиливаться, а ребенок часто плачет или трется одной стороной своей головы. Иногда в ухе можно видеть гной. У малышей ушная инфекция иногда сопровождается рвотой или поносом. Поэтому, если ребенок поносит и температурит, проверьте его ушки.



Лечение:

- ♦ Важно рано лечить ушные инфекции. Дайте антибиотики, такие как пенициллин (с. 351) или ко-тримоксазол (с. 358). Детям младше 3 лет лучше давать ампициллин (с. 353). От боли дайте ацетаминофен (с. 380). Также подойдет аспирин, но он менее безопасен (см. с. 379).
- ♦ Чаще убирайте гной из уха ватой, но не закупоривайте ухо ватой, палочкой, листом или еще чем-нибудь.
- ♦ Дети с гноем, вытекающим из уха, должны регулярно купаться, но не плавать или нырять, по крайней мере 2 недели после выздоровления.

Профилактика:

- ♦ Учите детей вытирать, но не высмаркивать носы, когда они простужаются.
- ♦ Не кормите малышей из бутылки - или если делаете это, то не кладите их на спину, так как молоко может попасть в нос и привести к ушной инфекции.
- ♦ Когда носы детей закупорены, используйте солевые капли и убирайте слизь из носа как описано на с. 164.

Инфекция ушного канала:

Чтобы обнаружить, инфицирован ли канал, или трубка, находящаяся в ухе, осторожно оттяните ухо. Если это вызовет боль, значит канал инфицирован. Капайте в ухо уксус, разбавленный водой, 3 или 4 раза в день. (Смешайте 1 ложку уксуса с 1 ложкой кипяченой воды). Если есть жар или гной, то используйте также антибиотик.

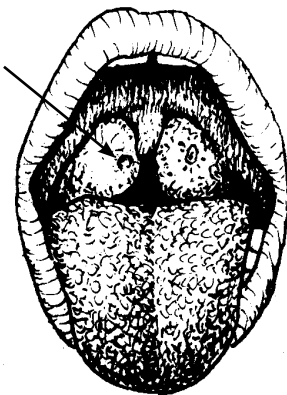
Больное Горло и Воспаление Миндалин

Эти проблемы начинаются с обычной простуды. Горло краснеет и болит при глотании. Миндалины (два лимфатических узла, выглядящих как шишки на каждой стороне задней части горла) могут увеличиваться, болеть или сочиться гноем. Температура может достичь 40°.

Лечение:

- ♦ Полощите теплой соленой водой (1 чайная ложка соли на стакан воды).
- ♦ Принимайте ацетаминофен или аспирин от боли.

Если вдруг появляются боль и жар или они продолжаются более 3 суток, смотрите следующую страницу.



Воспаленное горло и опасность ревматического жара

При воспаленном горле, часто возникающем при простой простуде или гриппе, обычно антибиотики не используются, и они не приносят пользы. Лечите полосканием и ацетаминофеном (или аспирином).

Однако один вид заболевания горла – **называемый ангиной** – необходимо лечить пенициллином. Ангиной чаще всего болеют дети и молодые люди. Обычно начинается неожиданно с болезненного воспаления горла и высокой температуры, часто без признаков простуды или кашля. Задняя часть рта и миндалины становятся очень красными и лимфатические узлы под челюстью и на шее разбухают и становятся чувствительными.

Давайте пенициллин (с. 351) в течение 10 дней. Если рано начать давать пенициллин и продолжать принимать его в течение 10 дней, то уменьшится опасность приобретения суставного ревматизма. Ребенок с ангиной должен есть и спать отдельно от других, чтобы предотвратить ее распространение.

Суставной Ревматизм

Это болезнь детей и молодых людей. Обычно начинается через 1-3 недели после заболевания ангиной (см. выше).

Главные симптомы (обычно присутствуют только 3 или 4 этих симптомов):

- жар;
- боль в суставах, особенно на запястьях и лодыжках, позже в коленях и локтях. Суставы разбухают, и часто горячие и красные;
- изогнутые красные линии или бугры под кожей;
- в более тяжелых случаях слабость, короткое дыхание и возможно боль в сердце.



Лечение:

- ◆ Если вы подозреваете суставной ревматизм, покажите медицинскому работнику. Есть риск повредить сердце.
- ◆ Принимайте аспирин в больших дозах (с. 380). В 12-летнем возрасте можно принимать от 2 до 3 таблеток по 300 мг 6 раз в день. Принимайте их вместе с молоком или пищей во избежание желудочной боли. Если в ушах появляется звон, уменьшайте дозу.
- ◆ Дайте пенициллин (см. с. 351).

Профилактика:

- ◆ Чтобы защититься от ревматического жара, рано лечите стрептококковую ангину пенициллином – в течение 10 дней.
- ◆ Чтобы предупредить возврат ревматического жара и дополнительного повреждения сердца, ребенок, у которого однажды был ревматический жар, должен принимать 10 дней пенициллин при первом признаке болезненности горла. Если у него уже появляются признаки нарушения сердечной деятельности, он должен принимать пенициллин на регулярной основе или делать ежемесячные инъекции бензатина пенициллина (с. 353) и иметь возможность находиться в покое. Следуйте совету знающего медицинского работника или доктора.

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ДЕТСТВА

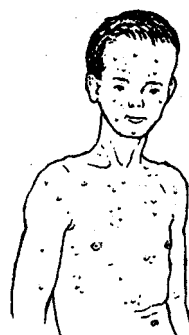
ВЕТРЯНАЯ ОСПА

Эта умеренная вирусная инфекция начинается через 2-3 недели после общения с больным ребенком.

Признаки:



пятна,
волдыри
и струпья.



Вначале появляется множество маленьких, красных, зудящих пятен. Они превращаются в маленькие прыщи или пузырьки, которые лопаются и образуют струпья. Обычно они появляются на теле, а позже – на лице, руках и ногах. Одновременно могут быть пятна, пузырьки и струпья. Жар обычно средний.

Лечение:

Инфекция обычно исчезает за неделю. Купайте ребенка ежедневно теплой водой с мылом. Чтобы успокоить зуд, прикладывайте прохладные тряпочки, смоченные в отваре из овсяной муки. Подрезайте очень коротко ногти на пальцах. Если струпья инфицировались, следите за их чистотой. Применяйте горячие влажные компрессы и накладывайте на них мазь из антибиотиков.

КОРЬ

Эта тяжелая вирусная инфекция **особенно опасна для детей**, которые **плохо питаются** или имеют **туберкулез**. Через 10 дней после контакта с больным корью заболевание начинается с признаков простуды – жара, текущего носа, воспаленных красных глаз и кашля.

Ребенок становится все более и более больным. Рот становится болезненным и может развиться понос.

Через 2 или 3 дня во рту появляются несколько крошечных белых пятен, напоминающих крупинки соли. Через день или 2 появляется сыпь – сначала за ушами и на шее, затем на лице и теле и в конце на руках и ногах. После появления сыпи ребенок обычно начинает чувствовать себя лучше. Сыпь длится около 5 дней. Иногда она рассыпается черными пятнами, вызванными кровотечением под кожей ("черная корь"). Это признаки тяжелой формы болезни. Обратитесь за медицинской помощью.



Лечение:

- ◆ Ребенок должен находиться в постели, пить много жидкости и получать питательную еду. Если он не может глотать твердую пищу, дайте ему жидкость в виде супа. Если малыш не может сосать, давайте грудное молоко ложкой (см. с. 120).
- ◆ Можно дать витамин А для защиты от поражения глаз (с. 392).
- ◆ От жара и дискомфорта дайте ацетаминофен (или аспирин).
- ◆ Если развивается боль в ухе, дайте антибиотик (с. 351).
- ◆ Если обнаруживаются признаки пневмонии, менингита или угрожающей боли в ухе, или в животе, получите медицинскую помощь.
- ◆ Если у ребенка понос, дайте напиток Регидрона (с. 152).

Профилактика кори:

Ребенок с корью должен быть изолирован от других детей, даже от братьев и сестер. Особенно пытайтесь защитить детей, которые плохо питаются или если у них есть туберкулез или другие хронические заболевания. Дети из других семей не должны приходить в дом, где есть корь. Если дети в семье, где есть корь, сами не болеют ею, то они не должны ходить в школу или магазины, или в другие общественные места в течение 10 дней.

Для профилактики кори у ослабленных детей обеспечьте всем детям хорошее питание. Ваши дети должны получить вакцинацию против кори в возрасте 8-14 месяцев.

КОРЕВАЯ КРАСНУХА

Коревая краснуха не так тяжела как обычная корь. Она длится 3 или 4 дня. Сыпь-средняя. Часто лимфатические узлы на затылке и шее раздуваются и болезненны.

Ребенок должен оставаться в постели и, если необходимо, принимать ацетаминофен или аспирин.

Женщина, которая болеет коревой краснухой в первые три месяца беременности, может родить поврежденного или деформированного ребенка. По этой причине **беременная женщина**, которая еще не болела коревой краснухой или не уверена в этом, **должна остерегаться** детей болеющих такой корью. Лучше, когда девочки или женщины переболеют коревой краснухой до беременности. Вакцина против коревой краснухи есть, но она часто не доступна.

Свинка

Первые признаки появляются после 2 или 3 недель с момента контакта с больным.

Свинка начинается с температуры и боли при открывании рта или еде. За 2 дня появляются мягкие опухоли под ушами в углах челюсти. Часто свинка появляется на одной стороне и позже на другой.

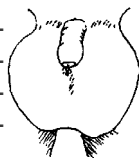


Лечение:

Опухоль спадает сама по себе в течение 10 дней без необходимости медицины. Против боли и жара можно принимать ацетаминофен или аспирин. Кормите ребенка нежной, питательной пищей и содержите его рот в чистоте.

Осложнения:

У взрослых и детей старше 11 лет после первой недели заболевания может появиться боль в животе или болезненная опухоль в мужских яичках. Больные с такой опухолью должны быть спокойными и накладывать пакеты со льдом или холодные влажные салфетки на разбухшие части, чтобы уменьшить боль и опухоль.



Если появляются симптомы менингита, обращайтесь за медицинской помощью (с. 185).

Коклюш

Коклюш начинается через неделю или две после контакта с больным ребенком. Он начинается с озноба с жаром, текущего носа и кашля.

Двумя неделями позже начинается коклюш. Ребенок часто кашляет без вреда для здоровья, пока он выкашливает пробку из слизи, она при сильном кашле увлекается воздухом назад в легкие. Во время кашля его губы и пальцы синеют из-за недостатка воздуха. После кашля он может вырвать. В промежутках кашля ребенок кажется весьма здоровым.



Коклюш часто длится 3 месяца и более.

Коклюш **особенно опасен для малышей** до года, так как вакцинировать детей рано. У маленьких детей типичный коклюш не развивается, поэтому тяжело определить, есть ли у них коклюш или нет. Если у ребенка судороги кашля и распухшие, отекшие глаза и если в вашей местности коклюш, лечите его **сразу**.

Лечение:

- ◆ Антибиотики помогут на ранней стадии коклюшного кашля, до начала коклюша. Используйте эритромицин (с. 355) или ампициллин (с. 353). Помогает также хлорамфеникол, но он более опасен. Дозу для малышей смотрите с. 358. Особенно важно лечить малышей до 6 месяцев при первом же признаке.
- ◆ В тяжелых случаях коклюша может помочь фенobarбитал (с. 389), особенно если кашель мешает ребенку спать или вызывает конвульсии.
- ◆ Если после кашля дыхание у ребенка останавливается, поверните его и вытащите изо рта своим пальцем комок слизи. Затем шлепните его по спине ладонькой.
- ◆ Во избежание потери веса и недоедания убедитесь, что ребенок достаточно получает питательной пищи. Давайте ему понемногу есть и пить после рвоты.

Осложнения:

Ярко-красное кровоизлияние (кровотечение) внутри белка глаз может быть вызвано кашлем. Лечение не нужно (см. с. 224). Если появляются судороги и симптомы пневмонии (с. 171) обратитесь за медицинской помощью.

**Защищайте всех детей от коклюша.
Проследите, чтобы первую вакцинацию они
получили в 2 месяца.**

Дифтерия

Она начинается как озноб с жаром, с головной боли и болезненного горла. Желто-серая пленка или мембрана могут образоваться на задней стенке горла, а иногда в носу и на губах. Шея ребенка может распухнуть. Его обоняние сильно ухудшается.



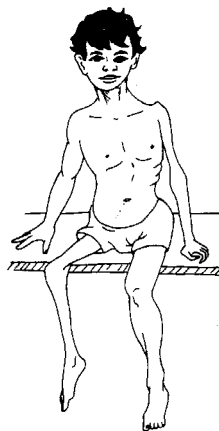
Если вы предполагаете, что у ребенка дифтерия:

- ◆ Уложите его в кровать в комнате, отделив его от других
- ◆ Предоставьте быстро медицинскую помощь. Против дифтерии есть специальный антитоксин.
- ◆ Дайте пенициллин, 1 таблетку в 400000 ЕД 3 раза в день детям старшего возраста.
- ◆ Полощите горло теплой водой с небольшим количеством соли.
- ◆ Часто или постоянно заставляйте дышать горячим паром.
- ◆ Если ребенок начинает задыхаться и синеть, попытайтесь снять пленку с его горла, используя кусочек материи обернутый вокруг вашего пальца.

Дифтерия - опасная болезнь, но может быть легко предупреждена вакцинацией КДС. **Убедитесь, что ваш ребенок вакцинирован.**

Детский Паралич (Полио, Полиомиелит)

Полиомиелит наиболее распространен среди детей до 2 лет. Он вызывается вирусной инфекцией, подобной простуде, часто с температурой, рвотой, поносом и болями в мышцах. Обычно ребенок полностью выздоравливает через несколько дней. Но иногда часть тела становится слабой или парализованной. В большинстве случаев это случается с одной или двумя ногами. Со временем слабая конечность становится тонкой и не растет дальше как другая.



Лечение:

Когда болезнь уже началась, никакие лекарства не нейтрализуют паралич. (Однако иногда частично или полностью утраченная сила медленно возвращается.) Антибиотики не помогают. На ранней стадии лечения успокойте боль ацетаминофеном или аспирином и накладывайте горячие примочки на болезненные мышцы. Положение ребенка должно быть удобным и не стесненным. Мягко выпрямите его руки и ноги так, чтобы ребенок лежал, как можно прямее. Положите подушки под его колени, если это необходимо для уменьшения боли, попытайтесь сохранить его колени прямыми.

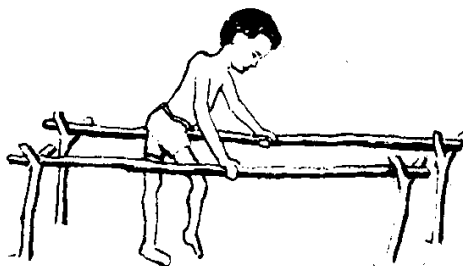
Профилактика:

- ◆ Наилучшая защита от полиомиелита – это вакцинация.
- ◆ Не делайте инъекций любых лекарств ребенку с признаками простуды, жара или другими симптомами, которые возможно вызваны вирусом полиомиелита. Инъекция может вызвать раздражение, которое превратит средней тяжести случай полиомиелита без паралича в тяжелый случай с параличем. **Никогда не делайте инъекцию любыми лекарствами, пока в этом нет абсолютной необходимости.**
- ◆ Содержите всякого ребенка с признаками простуды и жара в отдельной комнате отдельно от других детей. Мать и отец должны мыть свои руки после контакта с ребенком.

Проследите, чтобы дети были вакцинированы против полиомиелита «каплями полиомиелита» в 2,3 и 4 месячном возрасте.

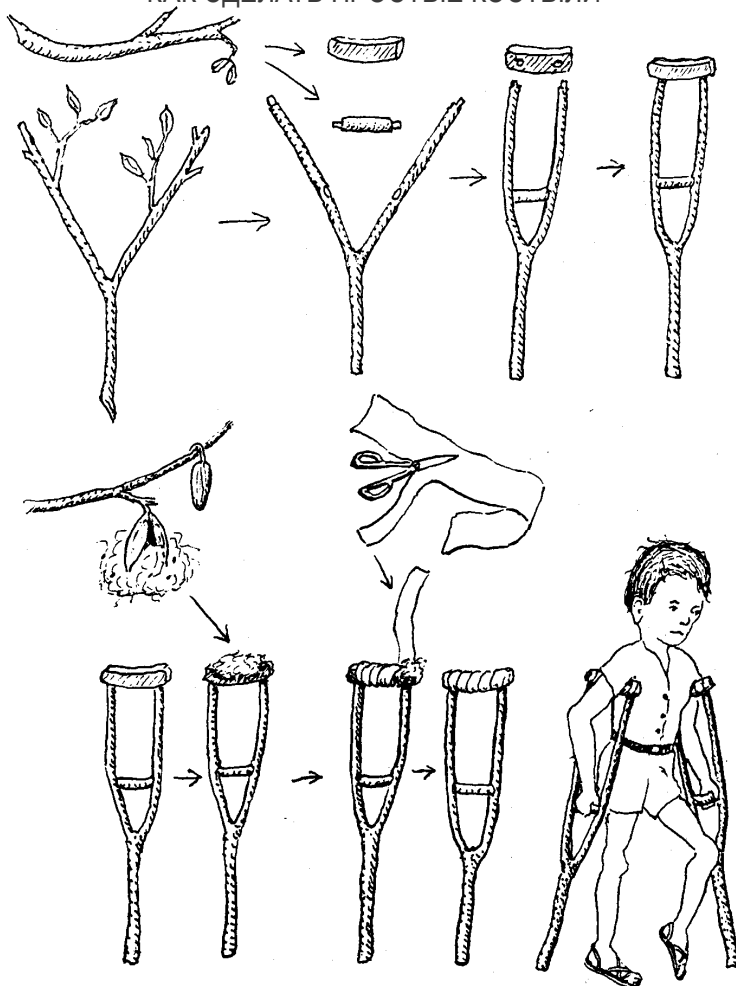
Ребенок, парализованный после полиомиелита, должен есть питательную пищу и выполнять упражнения по усилению оставшихся мышц.

Помогите ребенку научиться гулять так, как для него лучше всего. Закрепите два шеста для споры, как показано здесь, и позже сделайте ему какие-нибудь костыли. Подпорки для ног (кронциркули, костыли и другие вспомогательные средства помогут ребенку лучше двигаться и возможно предотвратят деформации.



Более полную информацию о полиомиелите и других детских нетрудоспособностях смотрите в книге *Искаленные Деревенские Дети*, которая также опубликована Фондом Геспериана.

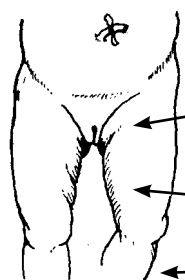
КАК СДЕЛАТЬ ПРОСТЫЕ КОСТЫЛИ



ВРОЖДЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ДЕТЕЙ

ВЫВИХНУТОЕ БЕДРО

Некоторые дети рождаются с вывихнутым бедром – нога выскальзывает из места соединения с бедровой костью. Ранний уход (забота) может предотвратить последующую хромоту и ущерб. Таких малышей необходимо контролировать для возможного установления бедренной кости в течение около 10 дней после рождения.



1. Сравните 2 ноги. Если одно бедро вывихнуто, то на этой стороне можно увидеть:

Верхняя часть ноги частично перекрывает часть тела на вывихнутой стороне.

Здесь мало складок.

Нога кажется короче или повернута под непривычным углом.

2. Держите обе ноги с согнутыми коленями как показано здесь



и раскройте их широко как здесь.



Если одно нога останавливается раньше или делает рывок или щелчок, когда вы раскрываете их широко, то бедро вывихнуто.

Лечение:

Держите малыша с высоко поднятыми и широко раскрытыми коленями:

используя много толстых салфеток, как здесь



или скрепляя булавкой его ноги как здесь (когда малыш спит),



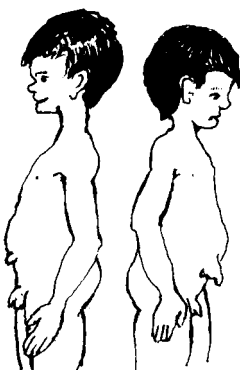
или делая так.



В положениях, при которых малыш обычно раскидывает свои ноги на бедрах матери, часто не обязательно другое лечение.

Пупочная Грыжа (Выпирающий Узелок на Животе)

Нет проблем, когда шишечка на животе высывается так, как здесь. В лечении или медикаментах нет необходимости. Тугое обвязывание материей или "поясом для живота" вокруг живота не поможет.



Даже большая пупочная грыжа, подобная этой, не опасна и часто проходит сама по себе. Если она существует еще и после 5 лет, то необходима операция. Получите медицинскую консультацию.

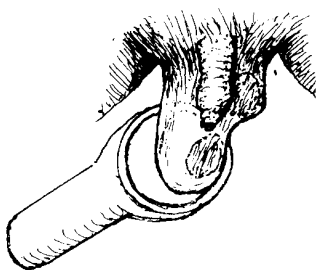
"Опухшее Яичко" (Водянка или Грыжа)

Если мошонка малыша или мешочек, который содержит его яички, раздута с одной стороны, то, обычно, это вызвано наполнением жидкостью (водянка) или проникновением кишечной петли в нее (грыжа).



Чтобы определить причину, просветите светом опухоль.

Если опухоль легко просвечивается, то, возможно, это водянка.



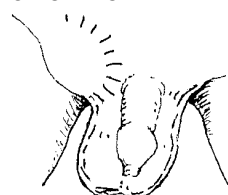
Водянка, обычно, проходит со временем без лечения. Если она длится больше года, обратитесь к врачу.

Если не просвечивается и если опухоль становится больше, когда малыш кашляет или плачет, то это грыжа.



При грыже необходимо хирургическое вмешательство (см с.177).

Иногда грыжа обусловлена опухолью, находящейся выше и на одной стороне детской мошонки, но не в ней.



Вы можете отличить это по разбухшему лимфатическому узлу (с.88), потому что грыжа раздувается, когда малыш плачет или его держат вертикально, и исчезает, когда он лежит спокойно.

УМСТВЕННО ОТСТАЛЫЕ, ГЛУХИЕ ИЛИ УРОДЛИВЫЕ ДЕТИ

Иногда у родителей появляется ребенок, который от рождения глухой, умственно неразвитый (отсталый) или с *врожденными дефектами* (иногда с неправильными частями тела). Часто причину невозможно найти. Некого упрекнуть. Часто кажется, что это происходит случайно.

Однако определенные обстоятельства значительно увеличивают вероятность дефектов рождения. **Малыш, вероятно, в меньшей степени поймет что-нибудь неправильное, если родители примут определенные меры предосторожности.**

1. **Недостаток питательной пищи** во время беременности может быть причиной умственной отсталости или врожденных дефектов у детей.

Чтобы иметь здоровых детей, беременная женщина должна есть достаточно питательную пищу (см с.110).

2. **Недостаток йода** в диете беременной женщины может вызвать кретинизм ее малыша. Лицо малыша отекает и он смотрит тупо. Его кожа и глаза могут остаться желтыми (пораженные желтухой) длительное время после рождения. Его язык высовывается наружу и его лоб может быть волосатым. Он слабый, плохо ест, мало плачет и много спит. Он отстает в развитии, может быть глухим и обычно имеет пупочную грыжу. Он начнет ходить и говорить позже, чем нормальные малыши.

Для предупреждения кретинизма беременная женщина должна использовать йодированную соль вместо обычной (см. с.130).

Если вы подозреваете, что у вашего малыша может быть кретинизм, то сразу же покажите его медицинскому работнику или доктору. Чем быстрее малыш получит специальный препарат (тироид), тем быстрее он станет поправляться.

3. **Курение или выпивка алкоголя** во время беременности являются причиной того, что малыши рождаются маленькими или имеют другие проблемы (см. с. 149). **Не выпивайте и не курите – особенно во время беременности.**

4. **После 35 лет** больше шансов, что мать будет иметь ребенка с врожденными дефектами. *Монголизм* или болезнь Дауна, которая выглядит, до некоторой степени, как кретинизм, с большей вероятностью возникает у малышей, чьи родители старые.

Благоразумнее планировать вашу семью так, чтобы не иметь детей после 35 лет (см. Главу 20).

5. **Многие медикаменты** могут нанести вред развивающемуся внутри беременной женщины малышу. **Пользуйтесь как можно меньше медикаментами во время беременности – и только теми, которые известны как безопасные.**

6. **Когда родители кровные родственники** (например, двоюродные), то возникает более высокий шанс, что их дети будут дефективными или отсталыми. **Косоглазие, лишние пальцы на руках или ногах, косоплоскость, заячья губа и расщепленное небо** – распространенные дефекты.

Чтобы уменьшить вероятность этих и других проблем, не женитесь на близких родственниках. И если у вас есть более одного ребенка с врожденными дефектами, придите к решению не заводить больше детей (см. Планирование семьи, Глава 20).

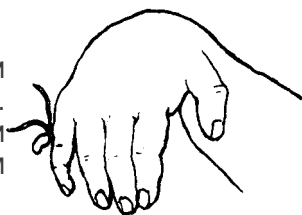


КРЕТИНИЗМ

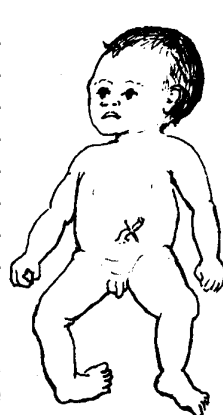
Если ваш ребенок родился с врожденным дефектом, то принесите его в центр здоровья. Часто можно что-нибудь предпринять.

- ◆ О косоглазии смотри с. 225.

- ◆ Если лишний палец на руке или ноге очень маленький и без косточек, то очень туго перевяжите его у основания. Палец засохнет и отпадет. Если же он большой или есть кость, то либо надо оставить либо хирургическим способом удалить.



- ◆ Если новорожденный малыш имеет вывернутые внутрь ступни или неправильную форму ступни (кляушкообразную), то попытайтесь изогнуть их до нормальной формы. Если вы сможете сделать это легко, то повторяйте эту процедуру несколько раз ежедневно. Ступни (или ступня) постепенно станут нормальными.



КОСОЛАПОСТЬ



В ГИПСЕ

- ◆ Если невозможно изогнуть ступни малыша до нормального состояния, то принесите его **сразу** в центр здоровья, где его ступни вправят в правильное положение или положат гипсовую повязку. Чтобы достичь наилучшего результата, **важно сделать это через 2 дня после рождения.**

- ◆ Если губа малыша или верхняя часть рта (небо) разделены (треснуты), то он может испытывать затруднения при грудном кормлении, поэтому необходимо кормить из ложки или капельницей. С помощью хирургии губу и небо малыша можно исправить так, что они будут выглядеть почти нормальными. Наилучший возраст для операции губы обычно от 4 до 6 месяцев и 18 месяцев для неба.



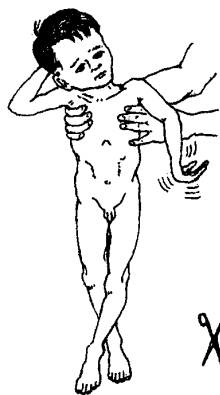
ЗАЯЧЬЯ ГУБА И
РАСРЕЗАННОЕ НЕБО

7. **Трудности до и во время рождения** иногда приводят к **повреждениям мозга**, что является причиной **спастического ребенка** или **судорог**. Вероятность опасности становится больше, если при рождении малыш вяло дышал или, если акушерка ввела матери окситоцин до рождения малыша (лекарство, ускоряющее рождение или "дающее силу матери", с. 266).

Тщательно выбирайте акушерку – не разрешайте вашей акушерке использовать окситоцин до рождения малыша.

Для большей информации о детях с врожденными дефектами обратитесь к книге Искалеченные Деревенские Дети, Глава 12.

СПАСТИЧЕСКИЙ РЕБЕНОК (ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ)



ноги скрещены
как ножницы

Спастический ребенок имеет тугие, негибкие мускулы, которыми он плохо управляет. Его лицо, шея или тело искривлены и движения отрывисты. Часто тугость мускулов на внутренней стороне ног приводит к их скрещиванию подобно ножницам.

При рождении ребенок может казаться нормальным или возможно пассивным. Одеревенелость наступает, когда он становится старше. Он может, а может и не быть умственно отсталым.

Мозговая травма, которая вызывает церебральный паралич, часто является результатом повреждения мозга при рождении (когда малыш недостаточно быстро начинает дышать) или из-за менингита в раннем детстве.

Нет лекарств, которые бы лечили травму мозга, в результате которой ребенок становится спастическим. Ребенок нуждается в специальном уходе. Чтобы помочь предотвратить сжимание мускулов на ногах или ступнях, выпрямляйте и сгибайте их **очень медленно** несколько раз в день.

Помогите ребенку научиться ворочаться, сидеть, стоять и, если возможно, ходить (как на с. 314). Поощряйте его попытки пользоваться как умом, так и телом все больше и больше, насколько возможно (см. с. 322). Даже если он с трудом говорит, он может быть умственно развитым и способным обучиться разному мастерству, если дать ему шанс. **Помогите ему научиться обслуживать самого себя.**

Для большей информации о церебральном параличе см. Главу 9, книги *Искалеченные Деревенские Дети*.

ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ УМСТВЕННУЮ ЗАДЕРЖКУ ИЛИ ВРОЖДЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ У СВОЕГО РЕБЕНКА, ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ:

1. Не выходить замуж за двоюродного или другого близкого родственника.
2. Питаться хорошо во время беременности как это возможно: стараться есть бобовые, овощные, мясные, яичные и молочные продукты.
3. Использовать йодированную соль вместо обычной, особенно во время беременности.
4. Не курить или выпивать во время беременности (см. с. 149).
5. Исключать всякий раз лекарства по-возможности при беременности – пользоваться только теми, которые известны как безопасные.
6. При беременности избегать лиц, болеющих коревой краснухой.
7. Быть осторожной в выборе акушерки – и не разрешать акушерке пользоваться окситоцином до рождения ребенка (см. с. 266).
8. Не иметь больше детей, если уже есть более одного ребенка с любым врожденным дефектом (см. Планирование Семьи, с. 283).
9. Рассмотреть ситуацию – не иметь детей после 35 лет.

ОТСТАВАНИЕ В РАЗВИТИИ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ЖИЗНИ

Некоторые дети не растут хорошо, хотя родились здоровыми. Их ум и тело медленно развиваются из-за плохого питания. Во время первых месяцев жизни мозг развивается более быстро, чем в другое время. По этой причине питание новорожденного имеет большое значение. Грудное молоко самая лучшая еда для малыша (см. Наилучшая диета для малышей, с. 120).

Болезнь Серповидной Клетки

Некоторые дети африканского происхождения рождаются со “слабостью крови”, называемой болезнью серповидной клетки. Эта болезнь идет от родителей, которые не знают, что несут в себе черты “серповидной клетки”. Малыш кажется нормальным до 6 месяцев, затем начинают появляться признаки заболевания.

Признаки:

- жар и плаксивость;
- иногда отеки ступней и пальцев на руках, которые продолжают 1 или 2 недели;
- большой живот, в верхней части которого ощущается твердость;
- анемия и иногда желтый цвет глаз (желтуха);
- ребенок часто болеет (кашель, малярия, понос);
- ребенок медленно растет;
- в возрасте 2 лет могут появиться на голове костистые шишки (“шишковатый”).



Малярия или другие инфекционные заболевания могут вызвать “серповидной клетки кризис” с высокой температурой и жестокими болями в руках, ногах или животе. Анемия становится сильнее. Опухоли на костях могут начать гноиться. Ребенок может умереть.

Лечение:

Нет никакого способа изменить слабость в крови. Защищайте ребенка от малярии и других заболеваний и инфекций, которые могут привести к “кризису”. Регулярно, ежемесячно посещайте с ребенком медицинского работника для обследования и терапии.

- ◆ Малярия. В местах, где малярия распространена, ребенок должен регулярно принимать противомаларийную терапию, чтобы предотвратить болезнь (см. с. 365). Дополнительно к этому ежедневная доза фолиевой кислоты (с. 393) поможет укрепить кровь. Обычно терапия железом (железной солью) не обязательна.
- ◆ Инфекции. Ребенок должен быть вакцинирован против кори, коклюша и туберкулеза в самые ранние сроки, какие рекомендованы. Если ребенок проявляет признаки жара, кашля, поноса, слишком частого мочеиспускания или болей в животе, ногах или руках, то покажите его медицинскому работнику как можно скорее. Возможно, необходимы антибиотики. Давайте пить воду в избытке, а также ацетаминофен (с. 380) от болей в костях.
- ◆ Избегайте охлаждения. Если необходимо, то по ночам сохраняйте тепло одеялом. Если возможно, то пользуйтесь пенным (пушистым) матрасом.

ПОМОЩЬ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ

Пока ребенок растет, он обучается только части того, чему его учат. Знания и умение, которые он получит в школе, помогут ему позже понять и выполнять многое. Школа весьма важна.

Но ребенок достигнет многого в своем обучении и дома и в лесу, и в поле. Он обучается наблюдая, слушая и пытаясь сделать что-то сам из того, что он видит вокруг. Он не так интенсивно обучается, когда люди ему рассказывают, чем когда он видит, как они действуют. **Некоторым из наиболее важных действий ребенок может обучиться, но такие как доброта, ответственность и участие можно привить ему только хорошими примерами.**

Ребенок учится через событие. Он нуждается в обучении как делать что-то для себя, даже если он при этом и делает ошибки. Когда он очень молод, защищайте его от опасности. Но когда он подрастет, помогайте ему обучиться заботиться о себе. Дайте ему такую возможность. Уважайте его мнение, даже если оно отличается от вашего.

Когда ребенок маленький, он думает в основном об исполнении только своих собственных нужд. Позже он открывает более глубокое удовольствие в помощи и создании вещей для других. Приветствуйте помощь детей и пусть они знают, как много это значит.

Дети не боятся задавать много вопросов. Если родители, учителя и другие выделяют время на честные и четкие ответы и говорят, что они не знают, когда они не знают, то ребенок сохраняет желание задавать волнующие его вопросы, и, пока он растет, можно отыскать способы сделать его среду или его деревню лучшим местом для жизни.

Несколько самых лучших идей помощи в обучении детей и вовлечении их в общество заботы о здоровье развиваются через программу от Ребенка-к-ребенку. Оно описано в Главе 24 Пособия Для Работников Здравоохранения.

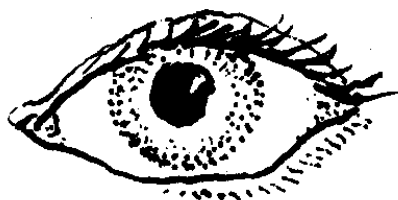


Это глава о профилактике и лечении болезней, встречающихся обычно у пожилых людей.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ, ОБСУЖДАЕМЫХ В ДРУГИХ ГЛАВАХ Трудности со ЗРЕНИЕМ (см. с. 225)

После 40 лет у многих людей появляются трудности с ясным видением близких предметов. Они становятся *дальнозоркими*. Часто им помогают очки.

Каждый человек после 40 лет должен следить за признаками глаукомы, которая может привести к слепоте, если оставить ее без лечения. Любой с признаками глаукомы (см. с. 222) должен обратиться за медицинской помощью.



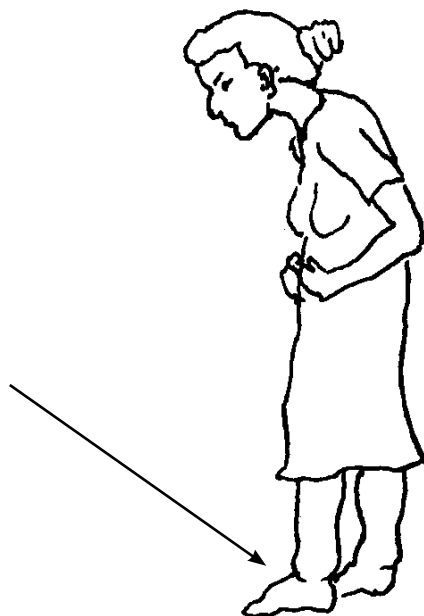
Катаракта (см. с. 225) и “мушки перед глазами” (крошечные движущиеся пятна – с. 227) – также обычные проблемы пожилых людей.

Слабость, Усталость и Режим Питания

Понятно, что пожилые люди обладают меньшей энергией и силой, чем когда они были моложе, но они станут еще слабее, если не будут хорошо питаться. Хотя старые люди чаще всего не едят очень много, они все же должны ежедневно употреблять сбалансированную пищу для построения тела и его защиты (см. с. 110 и 111).

Отеки Ступней (см. с. 176)

Они могут быть вызваны многими болезнями, но у пожилых это чаще всего происходит из-за плохого кровообращения (см. с. 213) или болезни сердца (см. с. 325). В любом случае **самое лучшее лечение – поднимать ступни**. Помогает также прогулка, но не увеличивайте сильно время стояния или сидения, когда ступни внизу. При любой возможности поднимайте ступни.



ХРОНИЧЕСКИЕ РАНКИ НОГ И СТУПНЕЙ (см. с. 20)

Они могут быть результатом плохого кровообращения из-за варикозных вен (с. 175). Иногда диабет – частичная причины (с.127). О других возможностях см. с. 20.

Язвы, вызванные плохим кровообращением, излечиваются очень медленно.

Содержите язвы в чистоте. Промывайте их кипяченой водой с мягким мылом и почаще меняйте повязку. Если обнаружите признаки инфекции, лечите как указано на с. 88.

Когда сидите или спите, поднимайте ноги повыше.



Трудности с Мочеиспусканием (см. с. 235)

Пожилые мужчины, у которых трудности с мочеиспусканием или моча которых выходит каплями, возможно страдают из-за увеличения предстательной железы. Вернитесь к странице 235.

ХРОНИЧЕСКИЙ КАШЕЛЬ (см. с. 168)

Старые люди, которые много кашляют, не должны курить и должны посоветоваться с медиком. Если у них были симптомы туберкулеза в более молодом возрасте или они когда-либо откашливались кровью, то у них может быть туберкулез.

Если старый человек кашляет с хрипом или у него одышка (астма), или отекают ноги, то тогда у него может быть сердечное заболевание (см. следующую страницу).

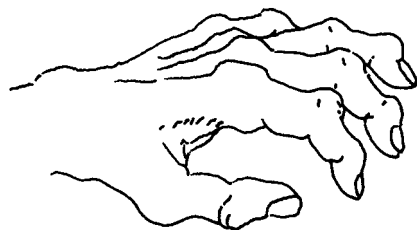


РЕВМАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ (БОЛЬНЫЕ СУСТАВЫ) (см. с. 173)

Многие пожилые люди болеют артритом.

Помощь при артрите:

- ◆ Дайте отдых суставам, которые болят.
- ◆ Используйте горячие компрессы (см. с. 194).
- ◆ Принимайте лекарства от боли; лучше всего – аспирин. При тяжелых артритах принимайте от 2-3 таблетки аспирина 6 раз в день с пищевой содой, антацидом (см. с. 381), молоком или большим количеством воды. (Если начинает звенеть в ушах, уменьшите дозу.)
- ◆ Важно делать упражнения, которые помогают сохранить, насколько возможно, подвижность больных суставов.



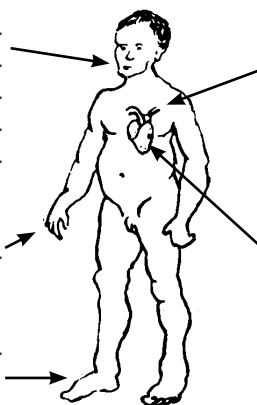
ДРУГИЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В СТАРОМ ВОЗРАСТЕ

Болезни Сердца

Сердечные заболевания наиболее часто встречаются у старых людей, особенно у тучных, курящих и с высоким кровяным давлением.

Признаки сердечных заболеваний:

- Напряженность и одышка после физических нагрузок; напоминающие астму приступы, которые усиливаются, когда человек лежит (сердечная астма).
- Учащенный, слабый или неритмичный пульс.
- Отеки ног – усиливаются после обеда.
- Внезапные приступы боли в грудной клетке, в левом плече или руке, которые возникают после упражнений и исчезают после нескольких минут отдыха (грудная жаба).
- Резкая сдавливающая боль; не исчезает при отдыхе (сердечный приступ).



Лечение:

- ◆ Разные сердечные заболевания требуют различных специфических лекарств, которые следует применять с большой осторожностью. Если вы считаете, что у человека сердечное заболевание, обращайтесь за медицинской помощью. Важно, чтобы он получил нужное лекарство, когда ему это понадобится.
- ◆ Люди с сердечным заболеванием не должны выполнять тяжелую работу, при которой у них возникает боль в груди или появляется одышка. Однако регулярные физические упражнения помогут предотвратить сердечный приступ.
- ◆ Люди с сердечными заболеваниями не должны есть жирную пищу, а должны сбросить лишний вес. Им не следует курить и употреблять алкоголь.
- ◆ Если у старого человека начинаются приступы одышки или отекают ноги, он не должен употреблять соль или есть соленую пищу. Всю оставшуюся жизнь он должен есть мало соли или не есть ее совсем.
- ◆ Ежедневный прием одной таблетки аспирина также может помочь предотвратить сердечный приступ или паралич.
- ◆ Если у человека грудная жаба или сердечный приступ, он должен быстро лечь отдохнуть в прохладном месте, пока не отпустит.

Если боль в груди очень сильная и не проходит даже при отдыхе или если у человека появляются признаки шока (см. с. 77), то сердцу угрожает серьезная опасность. Человек должен лежать в постели по крайней мере неделю или пока есть боль или **шок**. Затем он может начинать садиться или медленно передвигаться, но должен делать это очень спокойно на протяжении месяца или более. Подумайте о возможности получения медицинской помощи.



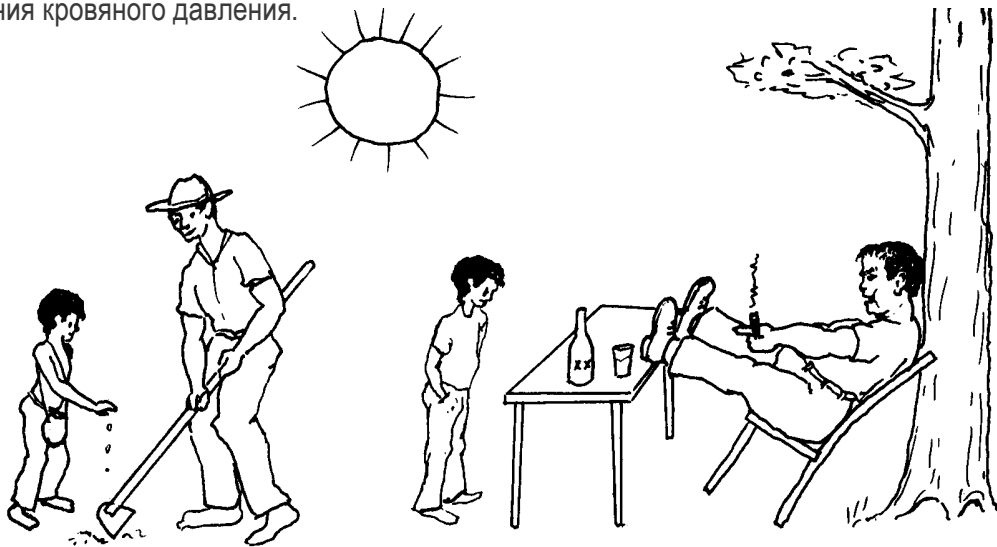
Профилактика: Смотри следующую страницу.

ОБРАЩЕНИЕ К Молодым Людям, Которые Хотят Быть Здоровыми в Старости

Многие проблемы среднего и пожилого возраста, включая высокое кровяное давление, уплотнение артерий, сердечные заболевания и паралич, являются результатом образа жизни человека и того, что он ел, пил и курил, когда был моложе. Ваши шансы на долголетие и здоровье увеличатся, если вы:

1. **Хорошо питаетесь** – достаточно питательной пищи, но не слишком обильной, жирной или соленой. Избегайте лишнего веса или ожирения.
2. **Не пьете много алкогольных напитков.**
3. **Не курите.**
4. **Сохраняете физическую и умственную активность.**
5. **Пытаетесь достаточно отдыхать и спать.**
6. **Научитесь расслабляться и справляться с ситуациями, которые мучают или огорчают вас.**

Высокое кровяное давление (с. 125) и уплотнение артерий (атеросклероз), которые возникают из-за болезней сердца и паралича, обычно можно предупредить или уменьшить, выполняя вышеуказанные рекомендации. Понижение высокого кровяного давления важно для профилактики сердечного заболевания и паралича. Люди с высоким кровяным давлением, должны время от времени контролировать его и принимать меры для снижения давления. Тем, кто не добивается успеха в понижении давления, ограничив себя в еде (если имеют избыточный вес), отказавшись от курения, выполняя больше физических упражнений и научившись расслабляться, может помочь прием препаратов для понижения кровяного давления.



У КАКОГО ИЗ ЭТИХ ДВУХ МУЖЧИН БОЛЬШЕ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОЖИТЬ ПОДОЛЬШЕ И ОСТАТЬСЯ ЗДОРОВЫМ В СТАРОСТИ? КОТОРЫЙ СКОРЕЕ УМРЕТ ОТ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА ИЛИ ПАРАЛИЧА? ПОЧЕМУ? СКОЛЬКО ПРИЧИН ВЫ МОЖЕТЕ НАСЧИТАТЬ?

УДАР (Паралич, Апоплексия, Инсульт)

У старых людей *паралич* или *инсульт* в основном является результатом тромба в крови или кровоизлияния в мозг. Слово удар используется, потому что такое состояние часто наступает без предупреждения. Человек может вдруг упасть без сознания. Лицо часто краснеет, дыхание хриплое и шумное, пульс – сильный и медленный. Человек может оставаться в коме (без сознания) несколько часов или дней.



Если человек остался жив, то у него могут быть затруднения с речью, зрением, мышлением или одна сторона лица и тела могут оказаться парализованными. При незначительных ударах некоторые из этих проблем могут возникнуть без потери сознания. Осложнения, вызванные параличом, иногда со временем проходят.

Лечение:

Уложите человека в постель, чтобы голова была выше, чем ноги. Если человек без сознания, откиньте его голову назад и положите ее на одну сторону, чтобы его слюна (или рвотная масса) вытекали изо рта, а не в легкие. Пока он без сознания, не давайте есть, пить или принимать лекарства через рот (см. Человек без сознания, с. 78). Если возможно, окажите медицинскую помощь.

После удара, если человек остался частично парализованным, помогите ему гулять с палочкой и пользоваться здоровой рукой, чтобы обслуживать себя. Человек должен исключить тяжелые упражнения и не гневаться.

Профилактика: Смотрите предыдущую страницу.

Примечание: Если более молодого или среднего возраста человека развивается паралич одной стороны его лица без других признаков удара, то возможно это *временный паралич лицевого нерва (паралич Белля)*. Он обычно исчезает сам по себе через несколько недель или месяцев. Причина, как правило, не известна. Лечение не обязательно, но могут помочь горячие компрессы. Если один глаз не закрывается полностью, то на ночь закройте его повязкой, чтобы предотвратить угрозу его высыхания.

ГЛУХОТА

Глухота, которая наступает постепенно без боли или других симптомов, происходит чаще всего у мужчин старше 40. Обычно неизлечима, хотя может помочь слуховой аппарат. Иногда глухота появляется в результате ушных инфекций (см. с. 309), повреждений головы или пробки из сухой серы. Информацию о том, как удалить ушную серу, см. на странице 405.



ГЛУХОТА СО ЗВОНОМ В УШАХ И ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

Если старый человек теряет слух на одно или на оба уха – временами с сильным головокружением – и слышит громкий 'звон' или гул, возможно у него болезнь Миньера. Он может также чувствовать тошноту, его может вырвать, он сильно потеет. Он должен принять антигистамин, такой как дименгидринат (Дедалон, с. 387), и полежать в постели, пока не исчезнут симптомы. Он не должен использовать в пищу соль. Если ему вскоре не станет лучше или проблема вернется, он должен немедленно проконсультироваться с медиком.

ПОТЕРЯ СНА (БЕССОННИЦА)

Обычно старым людям требуется для сна меньше времени, чем молодым. И по ночам они часто просыпаются. В длинные зимние ночи старые люди часами не могут спать.

Некоторые лекарства могут помочь уснуть, но лучше не пользоваться ими, если в этом нет абсолютной необходимости.

Несколько советов как уснуть:

- ◆ Давать физические нагрузки в течение дня.
- ◆ Не пить кофе или черный чай, особенно после обеда или вечером.
- ◆ Выпить стакан теплого молока или молока с медом перед сном.
- ◆ Принять перед сном теплый душ.
- ◆ В постели попытаться расслабить каждую часть тела – затем все тело и мозг. Вспомнить приятные моменты.
- ◆ Если вы все еще не можете уснуть, попробуйте принять антигистамин типа дипразина (Пипольфен, с. 386) или дименгидрината (Дедалон, см. с. 387) за полчаса до сна. Чем сильнее лекарство, тем меньше привыкание.

БОЛЕЗНИ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ У ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 40 ЛЕТ

ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ

Цирроз печени возникает у мужчин старше 40 лет, которые годами употребляя много спиртного и плохо питались.

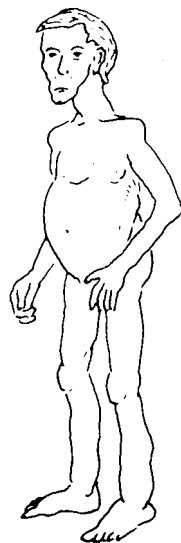
Признаки:

- Цирроз печени начинается как гепатит со слабости, потери аппетита, расстройств желудка и боли с правой стороны под ребрами.
- Когда болезнь усиливается, человек все худеет и худеет. У него может быть рвота с кровью. В тяжелых случаях опухают ступни, а живот наполняется жидкостью до тех пор, пока не станет выглядеть как барабан. Глаза и кожа желтеют (желтуха).

Лечение:

Когда цирроз запущен, то курс лечения труден. Нет лекарств, которые хорошо помогают. Большинство людей с запущенным циррозом умирает от него. Если вы хотите остаться живым, **то при первом признаке цирроза** делайте следующее:

- ◆ Никогда больше не пейте спиртного! Алкоголь – яд для печени.
- ◆ Питайтесь как можно лучше: овощи, фрукты, а также протеина (с. 110 и 111). Но не употребляйте много протеина (мясо, яйца, рыба и т.д.), так как он заставляет поврежденную печень работать с нагрузкой.
- ◆ Если человек с циррозом печени распухает, он не должен употреблять соль совсем.



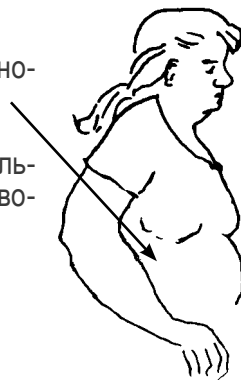
Профилактика этого заболевания простая: **НЕ ПИТЬ ТАК МНОГО.**

ПРОБЛЕМЫ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Желчный пузырь – это маленький мешочек, прикрепленный к печени. В нем собирается горький зеленый сок, называемый желчью. Заболевание желчного пузыря чаще всего бывает у женщин с избыточной массой тела старше 40 лет, у которых сохранен менструальный цикл.

Признаки:

- Острая боль в животе в правом подреберье: Иногда эта боль доходит по правой стороне до верха спины.
- Боль может наступить через час или более после обильной еды или жирной пищи. Сильная боль может вызвать рвоту.
- Отрыжка или жжение с плохим привкусом.
- Иногда бывает жар.
- Иногда могут пожелтеть глаза (желтуха).



Лечение:

- ◆ Не ешьте жирную пищу. Люди с избыточным весом (толстые) должны мало есть и сбрасывать вес.
- ◆ Для успокоения боли принимайте спазмолитики (см. с. 381). Часто необходимы сильные болеутоляющие средства. (Аспирин может не помочь.)
- ◆ Если у человека жар, он должен принять тетрациклин (с. 356) или ампициллин (с. 353).
- ◆ В тяжелых или хронических случаях обратитесь за медицинской помощью. Иногда требуется операция.

Профилактика:

Женщина с избыточным весом должна сбросить его (см. с.126). Исключите сладкую, жирную и жирную пищу – и не ешьте слишком много.

ЖЕЛЧНОСТЬ

Во многих странах и на разных языках о людях с плохим характером говорят “желчные”. Некоторые люди верят, что припадки гнева наступают, когда у человека слишком много желчи.

В действительности люди с самым плохим характером не имеют ничего плохого с желчным пузырем или с желчью. Однако люди, страдающие от заболеваний желчного пузыря, часто живут в постоянном страхе возвращения резкой боли и по этой причине иногда раздражены или постоянно обеспокоены своим здоровьем. (Фактически термин “ипохондрия”, который означает чрезмерное внимание к своему здоровью, происходит от “гипо”, означающего под, и “хандра”, означающего ребро, – относится к положению желчного пузыря!)

ПРИНЯТИЕ СМЕРТИ

Старые люди часто более готовы принять приближение собственной смерти, чем те, кто их любит. Люди, прожившие полноценную жизнь, не боятся смерти. Смерть после всего – естественный конец жизни.

Мы часто делаем ошибку, пытаясь любой ценой сохранить умирающего человека живым как можно дольше. Иногда это добавляет как больному, так и его семье страдания и напряженности. Во многих случаях самым хорошим является не поиск “лучшего лекарства” или “лучшего доктора”, а поддержка и сближение с умирающим человеком. Дайте ему понять, что вы довольны за все то время, когда делили радость и горе, и что вы тоже готовы принять его смерть. В последние часы любовь и смирение сделают много больше, чем медицина.

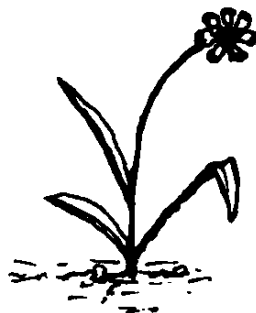
Старые или хронически больные люди часто предпочитают быть дома, в семейном кругу с теми, кто их любит, чем в больнице. Временами это может означать, что человек умрет легче. Но это не обязательно плохо. Мы должны ощущать его чувства и желания как собственные. Иногда умирающий человек больше страдает, сознавая, что цена сохранения его живым вынуждает его семью влезть в долги и дети его голодают. Он может только просить разрешения умереть – и наступает момент, когда это может быть мудрым решением.

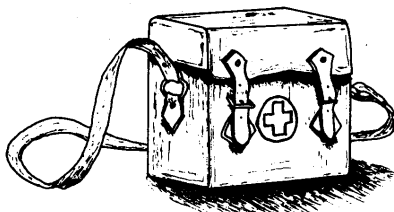
Некоторые люди все же боятся смерти. Даже если они страдают, им все же трудно оставить после себя знакомый мир. Каждая культура имеет систему представлений о смерти и идеи о жизни после смерти. Эти идеи, мысли и традиции могут предложить некоторое утешение при встрече лицом к лицу со смертью.

Смерть может подойти к человеку внезапно и неожиданно, а может быть долгожданной. Нелегко помочь тем, кого мы любим, подготовиться к приближающейся смерти и принять ее. Часто самое большое, что мы можем сделать, это предложить поддержку, доброту и понимание.

Смерть молодого человека или ребенка не может быть легкой. Здесь важны как доброта, так и честность. Ребенок – или любой умирающий – часто узнают о приближении смерти по тому, что ему подсказывает его собственный организм, и частично по страху и отчаянию, которое он видит в тех, кто любит его. Во всяком случае, если молодой или старый умирающий человек просит сказать правду, скажите ее, только сделайте это деликатно и оставьте некоторую возможность для надежды. Плачьте, если вам нужно, но пусть он знает, что даже когда вы любите его и поскольку вы любите его, у вас есть сила дать ему покинуть вас. Это придаст ему силы и смелости оставить вас. Позвольте ему знать то, что вы вынуждены не говорить ему. Вам необходимо почувствовать это и показать.

Все мы должны будем умереть. Возможно, самая главная работа целителя заключается в том, чтобы помочь принять смерть, когда ее уже невозможно дольше избежать, и помочь облегчить страдание тем, кто еще жив.





Каждая семья и каждое село должны иметь специальный набор медицинских инструментов для оказания первой помощи:

- Семья должна иметь домашнюю аптечку (см. с. 334) с необходимыми лекарствами для оказания первой помощи при простых инфекциях и при решении наиболее общих проблем здоровья.
- Деревня должна иметь наиболее полную аптечку (см. Сельская аптечка, с. 336), содержимое которой должно соответствовать решению проблем на каждодневный случай, а также на случай серьезной болезни или на крайний случай. Хранить ее должен ответственный человек - медицинский работник, учитель, родитель, лавочник или любой другой, кому доверяет общество. Если возможно, все члены деревни должны принять участие в создании и покупке аптечки. Те, кто может себе позволить больше, должны вложить больше. Но каждый должен понять, что **аптечка выгодна для всех** - тем, кто может купить, и тем, кто не может.

На следующих страницах вы найдете советы, что должна содержать аптечка. Вы захотите изменить эти списки, чтобы наилучшим образом удовлетворить нужды в соответствии с возможностями в вашей местности. Хотя список включает наиболее современные лекарства, можно также включить важные домашние средства от болезней, известные как безопасные и хорошо помогающие.

Как много каждого лекарства необходимо иметь?

Количество лекарств, рекомендованных для аптечки, самое минимальное, которое должно быть в распоряжении. В некоторых случаях достаточно только **начать** лечение. Может возникнуть необходимость, доставить больного человека до больницы или идти сразу за большим количеством лекарств.

Количество лекарств, хранящихся в вашей аптечке, будет зависеть от того, как много людей будут пользоваться ею и как далеко придется ходить за лекарствами по мере их использования. Это также будет зависеть от цены и от того, как много семей или деревень могут позволить себе ее. Некоторые лекарства из вашей аптечки будут дорогими, но благоразумно иметь в распоряжении достаточно этих лекарств на непредвиденный случай.

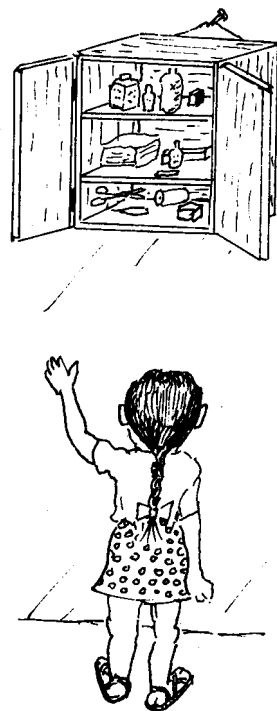
Примечание: **Принадлежности аптечки для новорожденного** - вещи акушеров и беременных матерей необходимо иметь готовыми до родов - напечатаны на с. 254-255.

КАК ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕЙ АПТЕЧКЕ

1. **ВНИМАНИЕ:** Храните все лекарства в недоступном для детей месте. Любое лекарство в больших дозах может быть ядовитым.
2. Убедитесь, что все лекарства хорошо маркированы и что инструкции по их использованию хранятся с каждым лекарством. Храните экземпляр этой книги с аптечкой.
3. Храните все лекарства и медицинские принадлежности в чистом, сухом прохладном месте, защищенном от тараканов и крыс. Защищайте инструменты, марлю и вату, заворачивая их в запечатанные пластиковые мешочки.
4. Постоянно храните запас важных лекарств на крайний случай. Каждый раз по мере использования восстанавливайте лекарство как можно быстрее.
5. Отметьте дату истечения срока каждого лекарства. Если дата прошла или лекарство выглядит испорченным, уничтожьте его и получите новое.

Примечание: Некоторые лекарства, особенно тетрациклин, могут стать опасными, если у них просрочены сроки. Однако пенициллин в сухой форме (таблетки или порошок для сиропа и инъекций) можно использовать долго, год после даты истечения срока, если хранить его в сухом, чистом и чуть прохладном месте. Старый пенициллин теряет часть своей силы воздействия, так что можно увеличить дозу. (**ВНИМАНИЕ:** Если с пенициллином это и безопасно, то с другими лекарствами чаще очень опасно давать дозу больше, чем рекомендовано.)

Храните лекарства вдали от детей.



ПОКУПАЯ ЗАПАСЫ ДЛЯ АПТЕЧКИ

Большинство из лекарств, рекомендованных в этой книге, можно купить в аптеках больших городов. Если некоторые семьи или сельчане делают совместную покупку сразу, то фармацевты могут продать им по низкой цене. Или если запас лекарств осуществляется через оптовую торговлю, то цены будут еще ниже.

Если аптека не поставяет лекарства, какие вы хотите, то купите заменитель, но убедитесь, что по действию это лекарство аналогичное, и проверьте дозировку.

Когда покупаете лекарства, сравнивайте цены. Некоторые виды лекарств намного дороже, хотя действие лекарств одинаковое. Более дорогостоящее лекарство может оказаться не очень эффективным. Когда можно, **покупайте распространенный вид лекарства**, чем лекарства с торговой маркой, поскольку обычные лекарства чаще много дешевле. Иногда вы можете сберечь деньги, купив большое количество. Например, пузырек пенициллина в 600 000 единиц часто стоит немногим больше, чем пузырек в 300 000 единиц – так что купите большой пузырек и используйте его на две дозировки.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

Каждая семья должна иметь следующие предметы в своей аптечке. Их запасы должны быть достаточны для лечения в сельских районах.

Включите в вашу аптечку также полезные домашние средства.

НАБОРЫ

Назначение	Набор	Цена (впишите)	Рекомендуемое количество	См. с.
ОТ РАН И КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:				
стерильные марлевые подушечки в индивидуальных запечатанных оболочках			20	97, 218, 263
3-, 5-, и 8-сантиметровые марлевые бинты в рулонах			2 каждого	87
чистая вата			1 небольшой пакет	14, 72, 83, 254
липкая лента (липкий пластырь) шириной 3 см			2 рулона	85, 218
мыло – если возможно, мыло дезинфицирующее типа Протекс			1 кусок или маленький флакон	371
70% спирт ... 5% спиртовой раствор йода			1/4 литра	72, 201, 211, 254
перекись водорода (разведенная) в темной бутылке			1 маленький флакон	83, 183, 213
нефтяная мазь (Вазелин) в банке или тубике			1	91, 97, 141, 199
белый уксус			1/2 литра	200, 241, 294, 309
сера			100 гр.	200, 205, 206, 211
ножницы (чистые, не ржавые)			1 пара	85, 254, 262
пинцет с острыми концами			1 пара	84, 175
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ:				
термометры				
для рта			по 1 каждого	
для прямой кишки				30, 41
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАПАСОВ:				
пластиковые мешочки			несколько	195, 332

ЛЕКАРСТВА

Назначение	Лекарство (основное название)	Местное название и цена	Рекомендуемое количество	См. с.
ОТ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ:				
1.	Пенициллин, 250 мг таблетки		40	351
2.	Ко-тримоксазол (Бисептол) (сульфаметоксазол, 400 мг, с триметопримом, 80 мг)		100	358
3.	Ампициллин, 250 мг в капсулах		24	353
ОТ ГЛИСТОВ:				
4.	Мебендазол в таблетках		40 табл. по 100 мг или 2 бутылки	374
ОТ ЖАРА И БОЛИ:				
5.	Аспирин, 300 мг (5 гран.) таблетки		50	379
6.	Ацетаминофен, 500 мг таблетки		50	380
ОТ АНЕМИИ:				
7.	Железо (сульфат железа), 200 мг пилюли (лучше, если пилюли содержат также витамин С и фолиевую кислоту)		100	393
ОТ ЧЕСОТКИ И ВШЕЙ:				
8.	Линдан (гамма гексахлорид бензола) и/или порошок серы		1 бутылка 20 мг	373
ОТ ЗУДА И РВОТЫ:				
9.	Дипразин (Пипольфен) 25 мг таблетки		12	386
ОТ ЛЕГКИХ ИНФЕКЦИЙ КОЖИ:				
10.	Горечавка фиолетовая, маленькая бутылка; или антибиотиковая мазь		1 бутылка 1 тюбик	371
ОТ ГЛАЗНЫХ ИНФЕКЦИЙ:				
11.	Антибиотиковая глазная мазь		1 тюбик	378

ДЕРЕВЕНСКАЯ АПТЕЧКА

Она должна иметь все лекарства и предметы, перечисленные в Домашней Аптечке, но в большем количестве в зависимости от величины вашей деревни и расстояния до центра снабжения. Сельская аптечка также должна содержать вещи, перечисленные здесь, поскольку многие из них лечат от более опасных болезней. Вы можете изменить или добавить к списку в зависимости от болезней в вашем районе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ

Назначение	Набор	Цена	Кол-во	См. с.
ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ:	шприцы 5 мл и 2 мл иглы # 20 мм , 40 мм и 60 мм длиной		2 3-6 2-4	65
ПРИ ЗАТРУДНЕННОМ МОЧЕИСПУСКАНИИ:	катетер (резиновый или пластиковый # 16)		2	239
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ СВЯЗОК И РАСШИРЕНИИ ВЕН:	эластичные бинты шириной 5 и 8 см.		3-6	102, 75, 213
ДЛЯ ОТСОСА СЛИЗИ:	отсасывающий сосуд		1-2	84, 255, 262
ДЛЯ ОСМОТРА УШЕЙ:	маленький фонарик		1	34, 255, 309

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Назначение	Лекарство	Местное название и цена	Кол-во	См. с.
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ИНЪЕКЦИЙ:			20-40	352
1. Пенициллин, вводимый, если только он прокаин пенициллин 600000 ЕД./мл				
2. Ампициллин для инъекций, 250 мг ампулы и/или стрептомицин 1 г флаконы для смешивания с пенициллином (если ампициллин очень дорогой)			20-40	353
3. Тетрациклин, капсулы или таблетки 250 мг			20-40	354
ПРИ ИНФЕКЦИЯХ АМЕБЫ И ЛЯМБЛИИ:			40-80	356
4. Метронидазол, 250 мг таблетки			40-80	369
ОТ ПРИПАДКОВ, СТОЛБНЯКА И КОКЛЮША:				
5. Фенобарбитал 15 мг таблетки и 200 мг инъекции			40-80 15-30	389

Назначение	Лекарство	Местное название и цена	Кол-во	См. с.
ПРИ ОСТРЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ И АСТМЕ:				
	6. Эпинефрин (Адреналин) инъекции, ампулы 1 мг		5-10	385
ОТ АСТМЫ:				
	7. Эфедрин, 15 мг таблетки		20-100	385
ОТ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ РОДОВ:				
	8. Эргометрин, инъекции 0,2 мг		6-12	391
ЛЕКАРСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ВО МНОГИХ, НО НЕ ВО ВСЕХ МЕСТНОСТЯХ ГДЕ ПРОБЛЕМА СУХИХ ГЛАЗ (КСЕРОФТАЛЬМИЯ):				
	Витамин А, 200 000 Е. капсулы		10-100	392
ГДЕ ПРОБЛЕМА СТОЛБНЯКА:				
	Противостолбнячный антитоксин 50 000 Е. (если можно, лиофильный)		2-4 флакон	389
ГДЕ ПРОБЛЕМА УКУСА ЗМЕЙ ИЛИ СКОРПИОНОВ:				
	Специальное противоядие		2-6	388
ГДЕ ПРОБЛЕМА МАЛЯРИИ:				
	Хлорохин таблетки 150 мг с основой (или любое другое лекарство, которое лучше всего действует в вашей местности)		50-200	365 365
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИЛИ ЛЕЧЕНИЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ:				
	Витамин К, инъекции 1 мг		3-6	394

Лекарства от хронических болезней

Может быть благоразумно, а может и нет иметь лекарства от хронических болезней, таких как **туберкулез, проказа и шистосомоз** в Сельской Аптечке. Чтобы убедиться, что человек имеет одну из этих болезней, часто необходимо проделывать особые тесты в центре здоровья, где обычно можно получить нужные лекарства. Эти ли или другие лекарства будут включены в сельские медицинские аптечки - зависит от местной ситуации и медицинских знаний ответственных лиц.

Вакцины

Вакцины не были включены в Сельскую Аптечку, потому что они обычно обеспечиваются Отделом Здоровья. Однако необходимо приложить большое усилие, чтобы проследить, что все дети вакцинированы не позже назначенного срока для разных вакцин (см. с. 147). Поэтому если доступно замораживание, то вакцины должны стать частью деревенских медицинских принадлежностей – особенно КДС, полиомиелит и коревые вакцины.

ОБРАЩЕНИЕ К ДЕРЕВЕНСКИМ ЛАВОЧНИКАМ (ИЛИ ФАРМАЦЕВТАМ)

Дорогой друг,

Если вы продаете лекарства в вашей лавке, люди возможно спросят вас о лекарстве, которое покупают, когда и как им пользоваться. Вы оказываете значительное влияние на знания о здоровье и на здоровье людей.

Эта книга поможет вам дать точный совет и убедиться, что ваши покупатели берут те лекарства, в которых они действительно нуждаются.

Как известно, люди чаще тратят мало денег на лекарства, которые не смогут помочь им. Но вы можете более четко объяснить таким людям, в чем их здоровье нуждается и истратить их деньги более разумно. Например:

- Если человек пришел просить сироп от кашля, Каопектат от частого поноса, витамин B12 или печеночный экстракт для лечения простой анемии, пенициллин для лечения растянутых связок или от боли, или тетрациклин при простуде, объясните ему, что эти лекарства не требуются и можно наделать больше вреда, чем пользы. Обсудите с ним, что делать взамен.
- Если кто-нибудь захочет купить укрепляющие витамины, подтолкните его вместо этого купить яйца, фрукты или овощи. Помогите ему понять, что по деньгам они содержат больше витаминов и пищевой массы.
- Если человек спрашивает лекарство для инъекций, когда есть лекарство, принимаемое через рот, которое гораздо более эффективно и безопасно, – скажите ему.
- Если кто-нибудь хочет купить “холодящие таблетки” или другую форму “дорогостоящего аспирина” для понижения температуры, посоветуйте ему купить обыкновенный аспирин (или ацетаминофен) в таблетках, и принять их с большим количеством жидкости.

Если вы нашли информацию в этой книге, то вам будет более легко рассказать людям о ней или прочитать книгу вместе с ними.

Прежде всего, продавайте только полезные лекарства. Суть вашего рассказа о лекарствах и принадлежностях помещен в Домашней и Сельской Аптечке, а также в других лекарствах, которые важны от распространенных болезней в вашей местности. Старайтесь снабжать недорого стоящими основными товарами, или, по крайней мере, дорогостоящими высшего качества. И никогда не продавайте лекарства, у которых истек срок годности, они могут быть опасны или бесполезны.

Ваш рассказ поможет людям научиться заботиться о своем собственном здоровье. Если вы желаете помочь людям разумно пользоваться лекарством, убедитесь, что любой, кто покупает его, тоже хорошо информирован о правильном пользовании и о дозировке, а также знает о риске и осторожности при их применении, этим вы окажите большую службу вашему обществу.

Желаю удачи!



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УПОТРЕБЛЕНИЕ, ДОЗЫ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ЛЕКАРСТВ, НА КОТОРЫЕ ССЫЛАЮТСЯ В ЭТОЙ КНИГЕ



Лекарства в этом разделе разделены на группы соответственно их применению. Например, все лекарства, которые употребляются против инфекций, вызываемых глистами, находятся в списке под заголовком: От глистов.

Если вы хотите узнать о лекарстве, посмотрите его название в списке лекарств, начало на с. 341. Или поищите его в индексе лекарств, начало на с. 345. Когда вы найдете название лекарства, которое вы ищете, вернитесь на страницу, указанную там.

Лекарства представлены в списке согласно их основным (научным) названиям, а не их торговым маркам (названия, которые дают им компании-производители). Это потому, что научные названия одинаковы везде, а торговые марки в разных местах различные. Кроме того, лекарства гораздо дешевле, когда вы покупаете основные, а не с торговой маркой.

В нескольких случаях хорошо известные названия торговой марки даются после научных. В этой книге названия торговой марки выделены курсивом и начинаются с заглавной буквы. Например, Пипольфен – торговая марка антигистамин под названием дипразин (дипразин – основное название).

С информацией на каждое лекарство пустое место оставлено для вас, чтобы вписать название и цену наиболее обычного или наименее дорогого продукта в вашей местности. Например, если самая дешевая или доступная форма тетрациклина в вашем месте Террамицин, вы должны написать на пустом месте вот так:

Тетрациклин (тетрациклин HCl, окситетрациклин и т.д.)

Название: ***Terramycin*** _____ цена: ____ за _____

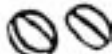
Однако, если вы узнаете, что можете купить лекарство с научным названием тетрациклин дешевле, чем с торговой маркой Террамицин, напишите так:

Название: ***Tetracycline*** _____ цена: ____ за _____

Примечание: Не все лекарства, представленные в Приложении 1, нужны в домашней или в сельской аптечках. Поскольку в разных странах доступны разные лекарства, то иногда информация приводится для набора лекарств, которые выполняют одинаковую работу. **НО САМОЕ РАЗУМНОЕ ХРАНИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЕКАРСТВ.**

Информация о Дозах:

КАК ИНОГДА ПИШУТСЯ ДРОБИ

- 1 таблетка = одна таблетка = 
- 1/2 таблетки = половина таблетки = 
- 1 1/2 таблетки = одна и половина таблетки = 
- 1/4 таблетки = четверть или одна четвертая таблетки = 
- 1/8 таблетки = одна восьмая таблетки (разделите ее на 8 равных кусочков и возьмите 1 кусочек) = 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЗЫ ПО ВЕСУ ЧЕЛОВЕКА

На этих страницах большинство инструкций дается в соответствии с возрастом больного – так что дети получают дозу меньше, чем взрослые. Однако будет точнее определить дозу согласно весу больного. Информация для этого иногда заключается кратко в скобки () для применения работниками здравоохранения, у которых есть весы. Если вы читаете . . .

(100 мг/кг/день),

это означает 100 мг на кг веса тела на один день. Другими словами, во время периода в 24 часа вы даете 100 мг лекарства на каждый кг веса больного.

Например, представьте, что вы хотите дать аспирин мальчику с ревматической лихорадкой, который весит 36 кг. Рекомендуемая доза аспирина от ревматической лихорадки 100 мг/кг/день. Итак, умножьте:

$$100 \text{ мг} \times 36 = 3600 \text{ мг.}$$

Мальчику нужно получить 3600 мг аспирина в день. Одна таблетка содержит 300 мг аспирина. 3600 мг выходит на 12 таблеток. Итак, давайте мальчику по 2 таблетки 6 раз в день (или по 2 таблетки каждые 4 часа).

Это один способ разделить дозы различных лекарств. Чтобы получить больше информации по измерению и определению дозы, см. Главу 8.

Примечание для педагогов, для тех, кто планирует программу оздоровления, и для местных распространителей этой книги:

Если эта книга используется в программе обучения сельского работника здравоохранения или распространяется местной программой здравоохранения, то **книгу должны сопровождать информация о местных названиях и ценах лекарств.**

Местным распространителям разрешается снимать копию с листа с этой информацией так, чтобы она могла быть скопирована в книге тем, кто ею пользуется. Когда возможно, включайте местные источники **для основных или дешевых лекарств и наборов.** (См. “Покупая Наборы для Санитарной Сумки”, с. 333).

СПИСОК ЛЕКАРСТВ В ПРИЛОЖЕНИИ 1

Список составлен в порядке их упоминания

АНТИБИОТИКИ		Сульфаниламиды:	
Пенициллины:		Недорогое лекарство от общих инфекций	
Очень важные антибиотики	См.		
Пенициллин в рот	с.	Сульфадиазин, сульфисоксазол, сульфамидин, тройной сульфамид	358
Пенициллин G или V	351	Ко-тримоксазол (сульфаметоксазол с триметопримом)	358
Пенициллин для инъекций			
Пенициллин короткого действия: кристаллин пенициллин, бензилпенициллин, пенициллин G, водный пенициллин, растворимый пенициллин, пенициллина натриевая соль,		Канамицин и гентамицин	359
пенициллина калиевая соль	352	Цефалоспорины	359
Пенициллин среднего действия: прокаин пенициллина, прокаин пенициллина алюминия		Лекарства	
моностеарат (ПАМ)	352	от гонореи и хламиды	360
Долгодействующий пеницил- лин:	352		
бензатин или бенетамин пенициллина	353		
Ампициллин: широкого дей- ствия		ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА	
(широкого спектра)	353		
пенициллин	354	Изониазид (INH)	361
		Рифампин (рифампицин, рифамицин)	362
Пенициллин со стрептомицином		Пиразинамид	362
		Этамбутол	362
Эритромицин:		Стрептомицин	363
Альтернатива пенициллину	355	Тиацетазон	363
Тетрациклины:			
Антибиотики широкого спектра			
Тетрациклин, тетрациклин HCl, окситетрациклин и т.д.	356	ОТ ПРОКАЗЫ	
Доксициклин	356	Дапсон (диаминодифенилсульфон, DDS)	364
Хлорамфеникол:		Рифампин (рифампицин, рифамицин)	364
Антибиотик от определенных тяжелых инфекций	357	Клофазимин (Лампрен)	364

Другие лекарства

От малярии

Хлорохин	365
Хинин	366
Мефлохин	367
Пириметамин с сульфадоксином (Фанзидар)	368
Прогуанил	368
Примаквин	368
Тетрациклин	368

От Амебы и Лямблии

Метронидазол	369
Дилоксанид фураат	369
Тетрациклин	356
Хлорохин	365
Хинакрин	370
Гидроксихинолины (клиохинол, йодохинол)	370

От инфекций во влагалище

Белый уксус	370
Метронидазол	370
Нистатин или миконазол – таблетки, крем и тампоны во влагалище	370
Генциан-виолет (кристалл-виолет)	370
Повидон йодин	371

От кожных проблем

Мыло	371
Сера	371
Генциан-виолет (кристалл-виолет)	371
Мази антибиотиковые	371
Кортикостероидная мазь или примочки	371
Желе из нефти (петролатум, Вазелин)	371

От стригущего лишая и других грибковых инфекций

Мази с ундециленовой, бензойной или салициловой кислотой	372
Сера и уксус	372
Натрия тиосульфат (гипо)	372
Селена сульфид (Сельсун, Эксел)	372
Толнафтат (Тинактин)	372
Гризеофульвин	372
Генциан-виолет – от дрожжевой инфекции (молочница)	373
Нистатин или миконазол	373

От чесотки и вшей

Гамма бензил гексахлорид (линдан, Квелл)	373
Бензил бензоат, крем или примочки	373
Сера в вазелине или лярд	373
Пиретрин с пиперонилом (RID)	373
Кротамитон (Эуракс)	373

От бородавок на половых органах	
Подofilлин	374
Двуххлоруксусная кислота	374

От глистов

Мебендазол (Вермокс) – от многих видов глистов	374
Альбендазол (Зентел) – от многих видов глистов	374
Пиперазин – от аскарид, булавочных (нитяных) глистов	375
Тиабендазол – от многих видов глистов	375
Пирантел – от булавочных глистов, нематод и аскарид	376
Никлозамид (Йомесан) – от солитера	376
Празиквантел (Билтрицид Дронцит) – от солитера	376

От шистосомоза

Празиквантел (Билтрицид, Дронцит)	377
Метрифонат (Биларцил)	377
Оксамнинин (Ванзил, Манзил)	377

От речной слепоты (Онхоцеркоз)		Бикарбонат натрия (пищевая сода)	381
		Кальция карбонат	382
		Циметидин (Тагамет)	382
		Ранитидин (Зантак)	382
Ивермектин (Мектизан)	378	От обезвоживания	
Диэтилкарбамазин	378		
Сурамин	378		
От глаз		Регидроновый напиток	382
Антибиотиковая глазная мазь – от конъюнктивита и для глаз новорожденных		От твердого стула (Запора):	
Капли нитрата серебра, 1% – для глаз новорожденного	378	Слабительные	
	379		
От боли		Молоко магнезии (магния гидроокись)	383
Анальгетики		Горькая соль (сульфат магния)	383
		Нефть	383
Аспирин		Глицериновые свечи (Дулколакс)	383
Детский аспирин	379	От легкого поноса	
Ацетаминофен (парацетамол)	380		
Ибупрофен	380		
Эрготамин с кофеином – от мигреновой головной боли	380		
	380	Каолин с пектином	384
Для прекращения боли		От забитого носа	
При закрытых ранах:			
Анестезирующие			
Лидокаин (ксилокаин)	380	Капли для носа с эфедрином или фенилефрином	384
От желудочных спазмов:		От кашля	
Спазмолитики			
Белладонна (с или без фенобарбитала)	381	Кодеин	384
От кислотного несварения, из- жоги		От астмы	
и язвы желудка			
Алюминия гидроокись или магния гидроокись	381	Эфедрин	385
		Теofilлин или аминофиллин	385
		Сальбутамол (Альбутерол)	385
		Эпинефрин (Адреналин, Адреналин)	385

От аллергических реакций и рвоты:		От шишек (геморрой)	
Антигистамины		Свечи от геморроя	392
Дипразин(Пипольфен)	386	От недоедания и анемии	
Дифенгидрамин (Димедрол)	387	Порошковое молоко (сухое молоко)	392
Хлорфенирамин	387	Поливитамины	392
Дименгидринат (Дедалон)	387	Витамин А –от ночной слепоты и ксерофтальмии	392
Антитоксины		Железа сульфат (закисного железа сульфат) – от анемии	393
Антитоксин от укуса скорпиона или противоядие	388	Фолиевая кислота – от анемии	393
Антитоксин от укуса змеи или противоядие	388	Витамин В12 (цианокобаламин) – только от злокачественной анемии	393
Антитоксин от столбняка	389	Витамин К (фитоменадион) – от кровотечения у новорожденных	394
От проглоченных ядов		Витамин В6 (пиридоксин) – для больных, принимающих INH	394
Сироп из рвотного корня	389	Методы планирования семьи	
Активированный уголь в таблетках или в порошке	389	Контроль рождаемости	
От припадков (конвульсий)		Оральные контрацептивы (противозачаточные пилюли)	394
Фенобарбитал (фенобарбитон)	389	Презервативы	396
Фенитоин (дифенилгидантоин, Дилантин)	390	Колпачок	396
Диазепам (Валиум)	390	Контрацептивная пена	396
От сильного кровотечения после родов		Контрацептивные свечи (Нео Шампунь)	396
(Послеродовое кровотечение)		Внутриматочная спираль (ВМС)	396
Эргоновин или эргометрина малеат (Эрготрат, Метергин)	391	Инъекции контрацептивные	396
Окситоцин (Питоцин)	391	Контрацептивные импланты (Норплант)	396
		Пустые бланки для записи информации о других лекарствах или домашних средствах лечения	397

ИНДЕКС ЛЕКАРСТВ В ПРИЛОЖЕНИИ 1

Список по алфавиту: А Б В Г Д Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Я

Примечание: Лекарства, которых нет в списке Приложения 1, но которые упоминаются в этой книге, представлены в главном Индексе.

А		Билакрил (метрифонат)	377
Адреналин	385	Билтрицид (празиквантел)	376,377
Адреналин (эпинефрин)	385	Боль, лекарства	379
Активированный уголь	389	Бородавки на половых органах, лекарства	374
Алка-Зелтцер(бикарбонат натрия)	381	Бревикон (пилюли противозачаточные)	395
Аллергические реакции, лекарства	386	Бревикон 1+35 (пилюли противозачаточные)	394
Альбендазол	374	Бревинор (пилюли противозачаточные)	395
Альбутерол	385	Броксихолин	370
Алюминия гидроокись	381	Брюшной тиф, лекарства	357
Амеба, лекарства	368		
Амиклин	370	В	
Аминофиллин	385	Вагинальные инфекции, лекарства от	370
Ампициллин	353	Вазелин (нефтяное желе)	371
Анальгетики	379	Вайтфилда мазь	372
Анемия, лекарства	393	Валиум (диазепам)	390
Анестезирующие	380	Вансил (оксамнихин)	377
Антациды	381	Вермокс (мебендазол)	374
Антиаплакран Мин (противоядие)	388	Вибрамицин (доксциклин)	356
Антибиотики	351	Витамины	392
Антигистамины	386	Внутриматочная спираль (ВМС)	396
Антиминт (пирантел)	376	Вода как лекарство	384
Антитоксины	388	Вши, лекарства	373
Антитоксин от столбняка	389		
Антрипол (сурамин)	378	Г	
Арален (хлорохин)	366	Галхинол	370
Аспирин	379	Гамма бензил гексахлорид (линдан)	373
Астма, лекарства	385	Гаммезан (линдан)	373
Атабрин	370	Гарамицин (гентамицин)	359
Атропин	381	Гелмекс (пирантел)	376
Ацетаминофен (парацетамол)	380	Геморрагия, лекарства	391
Ацетилсалициловая кислота (аспирин)	379	Геморрой, лекарства	392
Б		Гентамицин	359
Байер 205 (сурамин)	378	Генциан-виолет	371
Бактрим (ко-тримоксазол)	358	Германин (сурамин)	378
Баноцид (диэтилкарбамазин)	378	Гетразан (диэтилкарбамазин)	378
Белладонна	381	Гидроксихинолины	370
Белый уксус	372	Гиосциамин (атропин)	381
Бенадрил (дифенгидрамин)	387	Гипер-тет (иммуноглобулин от столбняка)	389
Бенетамин	353		
Бензатин	353		
Бензилбензоат	373		
Бензойная кислота	372		
Бетадин (повидон йодин)	371		
Бикарбонат натрия	381		

Глаза, лекарства	378	Инъекции контрацептивные	396
Глисты, лекарства	374		
Глицериновые свечи	383		
Головная боль, лекарства	379	Й	
Гонорея, лекарства	360		
Горькая соль	383	Йодохинол	370
Грибковые инфекции, лекарства	372	Йодохлоргидроксидин	370
Гризеофульвин	372	Фенасал (никлосамид)	376

К

Д			
Дапсон (диаминодифенилсульфон, DDS)	364	Канамицин	359
Двуххлоруксусная кислота	377	Кантрекс	359
Дельфен (контрацептивная пена)	396	Каолин с пектином	384
Демулен (пилюли противозачаточные)	395	Каопектат (каолин с пектином)	384
Депо-Провера (инъекция противозачаточная)	396	Карбонат кальция	382
Диазепам	390	Кафергот (эрготамин с кофеином)	380
Диiodогидроксидин	370	Кашель, лекарства	384
Диклосациллин	351	Квелл (линдан)	373
Дилантин (фенитоин)	390	Квогил	370
Дилоксанид фураат	390	Клавуланниковая кислота	360
Дименгидринат	387	Клиохинол	370
Диодохин (диiodогидроксидин)	370	Клоксациллин	351
Дифенгидрамин	387	Клофазимин	364
Дифенилгидантоин (фенитоин)	390	Ко-тримоксазол	358
Дизтилкарбамизин	378	Кобрантрил (пирантел)	376
Доксициклин	356	Кодеин	384
Дедалон (дименгидринат)	387	Кожные проблемы, лекарства	371
Дронцит (празиквантел)	376,377	Колпачок	396
Дулколакс (глицериновые свечи)	383	Кольцо безопасности (ВМС)	396
		Конвульсии (припадки), лекарства	389
		Контрацептивная пена	396
		Контрацептивные свечи	396
		Контрацептивы, оральные	394
Ж		Кортизон	392
Железа закисного сульфат	393	Кортикостероид	371
Железа сульфат	393	Кристалл-виолет	371
		Кровотечение, лекарства	391
		Кротамитон	373
З		Ксерофтальмия, витамины для	392
Зантак (ранитидин)	382	Ксилокаин (лидокаин)	380
Зентел (альбендазол)	374		

Л

И			
Ибупрофен	380	Лампрен (клофазимин)	364
Ивермектин	378	Лариад (мефлохин)	367
Изониазид (INH)	361	Лемпо (контрацептивная пена)	396
Иммуноглобулин от столбняка	389	Лидокаин	380
Инсектициды от чесотки и вшей	373	Линдан	373
Инфекции, лекарства	351	Липлес петля (ВМС)	396
		Ло-Оврал (пилюли противозачаточные)	395

Ло-Феменал (пилюли противозачаточные)	395	Нео-Синефрин (фенелефрин)	384
Логинон (пилюли противозачаточные)	394	Неогинон (пилюли противозачаточные)	395
Лозэстрин 1/20 (пилюли противозачаточные)	395	Неокон (пилюли противозачаточные)	394
Люминал (фенобарбитал)	389	Неомицин	371
Лямблия, лекарства	368	Левосин (антибиотиковая мазь)	371
М		Нет-Эн (контрацептивные инъекции)	396
Магния гидрооксид	383	Нефтяное желе (нефть, Вазелин)	311
Магния сульфат	383	Нивембин	370
Малаярия, лекарства	365	Никлозамид	376
Манзил (оксамнихин)	377	Нистатин	373
Мебендазол (Вермокс)	374	Нор-QD (пилюли противозачаточные)	395
Медь 7 (BMC)	396	Нордет (пилюли противозачаточные)	395
Медь Т (BMC)	396	Нордиол (пилюли противозачаточные)	395
Мектизан (ивермектин)	378	Норидей 1+50 (пилюли противозачаточные)	394
Мепакрин	370	Норимин (пилюли противозачаточные)	394
Метергин (метилэргоновин малеат)	391	Норлестрин (пилюли противозачаточные)	395
Метициллин	351	Норплант (контрацептивная имплантация)	396
Методы планирования семьи	394	Нос, лекарства	384
Метрифонат	377	О	
Метронидазол	369	Обезвоживание, лекарства	382
Мефлохин	367	Овисмен (пилюли противозачаточные)	395
Миамбутол (этамбутол)	362	Овисмен 1/35 (пилюли противозачаточные)	394
Миконазол	370	Овкон (пилюли противозачаточные)	395
Микровлар (пилюли противозачаточные)	395	Оврал (пилюли противозачаточные)	395
Микрогинон 30 (пилюли противозачаточные)	395	Оврет (пилюли противозачаточные)	395
Микролют (пилюли противозачаточные)	395	Овулен (пилюли противозачаточные)	395
Микроновум (пилюли противозачаточные)	395	Овум 50 (пилюли противозачаточные)	395
Микронор (пилюли противозачаточные)	395	Оксамнихин	377
Минеральное масло	383	Оксациллин	351
Мини-таблетки	395	Окситетрациклин	356
Миновлар (пилюли противозачаточные)	395	Окситоцин	391
Модикон (пилюли противозачаточные)	395	Онхоцеркоз, лекарства	378
Молоко магнелии	383	Оральные контрацептивы	394
Молоко порошковое	393	Оральные регидроновые соли	382
Мыло	371	Орто-Новум 1/35 (пилюли противозачаточные)	394
Н			
Натрия бикарбонат	381		
Натрия тиосульфат	372		
Нафурид (сурамин)	378		
Нафциллин	351		
Нео Шампунь (контрацептивные свечи)	396		

Орто-Новум 1/50 (пильюли противозачаточные)	394
Отравление, лекарства	389
Отхаркивающие	384

П

Палудрин (прогуанил)	368
Парацетамол	380
Пенициллины	356
Ампициллин	353
Бенетамин	353
Бензатин	353
Бензилпенициллин (пенициллин G)	352
Для сопротивляемости пенициллину	351
Кристаллин	352
ПАМ (прокаин пенициллина алюминия моностеарат)	352
Прокаин	352
Со стрептомицином	
Феноксиметил (пенициллин V)	351
Перле	394
Перле LD	395
Пиперазин	375
Пиразинамид	362
Пирантел	376
Пиретрин с пиперонилом	373
Пиридоксин (Витамин B)	394
Пириметамин с сульфадоксином	368
Питоцин (окситоцин)	391
Питуитрин	391
Повидон йодин	389
Подофиллин	374
Поливалент Кроталид Антивенин (от укусов змеи)	388
Полимиксин	371
Полиспорин (полимиксин)	371
Понос, лекарства	384
Порошковый уголь	389
Празиквантел от солитера	376
Празиквантел от шистосомоза	377
Презервативы	396
Примахин	368
Примовлар (пильюли противозачаточные)	395
Припадки (конвульсии), лекарства	389
Пробенецид	360
Прогуанил	368
Проказа, лекарства	363
Прометазин	386
Противозачаточные	394
Противоядия	388

Р

Ранитидин	382
Рвота, лекарства	386
Рвотного корня сироп	389
Ретинол	392
Речная слепота, лекарства	378
RID (пиретрин с пиперонилом)	373
Рифампин (рифампицин, рифамицин) от ТБ	362
Рифампин (рифампицин, рифамицин) от проказы	364

С

Сальбутамол	385
Салициловая кислота	372
Селена сульфид	372
Сельсун (селена сульфид)	372
Септра (ко-тримоксазол)	358
Сера	371
Серебра нитрат	379
Симетикон	381
Синофаз (пильюли противозачаточные)	394
Сироп рвотного корня	389
Скорпиона укус, лекарства	388
Слабительные	383
Смесь от обезвоживания	328
Спазмолитики	381
Спазмы кишечника, лекарства	381
Спектиномицин	360
Стрептомицин	363
Стригущий лишай, лекарства	372
Сульфамиды (сульфонамиды)	358
Ко-тримоксазол	358
Сульфадиазин	358
Сульфадимидин	358
Сульфаметазин	358
Сульфисоксазол	358
Триметоприм с сульфаметоксазолом (ко-тримоксазол)	358
Тройной сульфамид	358
Сульфонез (дапсон, DDS)	364
Сурамин	378
Суэро Антикроталико (противоядие от укуса змеи)	388

Т

Тагамет (циметидин)	382
Теofilлин	386
Тетрациклин	356

Тетрациклин	356	Х	
Доксициклин	356		
Окситетрациклин	356	Хинакрин	370
Тетрациклин HCl	356	Хинин	366
Тиабендазол	375	Хламида, лекарства	360
Тиацетазон	363	Хлорамбин	370
Тинактин (толнафтат)	372	Хлорамфеникол	357
Толнафтат	372	Хлоромецетин	
Триновум (пилюли противозачаточные)	394	(хлорамфеникол)	357
Тринордиол (пилюли противозачаточные)	399	Хлорохин	365
Трипхасил (пилюли противозачаточные)	394	Хлортетрациклин	356
Трихилар (пилюли противозачаточные)	394	Хлорфенирамин	387
Туберкулез, лекарства	361	Ц	
У		Цефалоспорины	359
Уголь, порошок или активированный	389	Цефтриаксон	360
Уксус	372	Цианокобаламин (витамин В)	393
Укусы змеи, противоядие	388	Циметидин	382
Ундециленовая кислота	372	Ципрофлоксацин	360
		Ч	
		Чесотка, лекарства	373
		Э	
Ф		Эксел (селена сульфид)	372
Фанзидар (пириметаним с сульфадоксином)	368	Эмко (контрацептивная пена)	396
Феменал (пилюли противозачаточные)	395	Энтеро-Веоформ	370
Фемулен (пилюли противозачаточные)	395	Энтерохинол	370
Фенерган (прометазин)	386	Эпинефрин	385
Фенитоин	390	Эргометрин	396
Фенобарбитал	389	Эргоновин	391
Фенобарбитон	389	Эрготамин с кофеином	380
Феноксиметил (пенициллин V)	351	Эрготрат (эрготамин тартрат)	390
Фитоменадион (витамин К)	394	Эритромицин	355
Фитонадион	394	Этамбутол	362
Флагил (метронидазол)	369	Эугинон (пилюли противозачаточные)	395
Флорахин	370	Эуракс (кротамитон)	373
Фолиева кислота	393	Эфедрин	385
Фурамид (дилоксанид фураот)	369	Я	
		Язвы, лекарства	381



**УПОТРЕБЛЯЙТЕ ЛЕКАРСТВО ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ВЫ
УВЕРЕНЫ,
ЧТО ОНО НУЖНО, И КОГДА ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ.**

Примечание: Некоторые лекарства могут вызывать негативную реакцию, если их принимать вместе. Если возможно, проконсультируйтесь у врача перед принятием двух или более лекарств одновременно. Также перед принятием лекарств внимательно читайте указания на упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКАРСТВАХ

Антибиотики

Пенициллины:

Очень важные антибиотики

Пенициллин – один из наиболее полезных антибиотиков. Он борется с определенными инфекциями, включая те, что вызывают нагноения. Он не помогает при поносе, большинстве мочеполовых инфекций, спинной боли, синяках, обычной простуде, ветрянке или других вирусных инфекциях (с. 18, 19).

Пенициллин измеряется в миллиграммах (мг) или в единицах (ЕД). Для пенициллина G 250 мг = 400000 ЕД.

Риск и предосторожности для всех видов пенициллина (включая ампициллин):

Для большинства людей пенициллин – одно из самых безопасных лекарств. Употребление большого количества не приносит вреда, а просто требует денег. Слишком малое количество не остановит полностью инфекцию и может вызвать сопротивляемость у бактерий (труднее убить их).

У некоторых людей пенициллин вызывает аллергические реакции. Легкие реакции представляют собой зудящую сыпь или пятна. Часто они появляются через несколько часов или дней после приема пенициллина и длятся днями. Антигистамины (см. с. 386) помогают успокоить зуд.

Очень редко пенициллин вызывает опасную реакцию – аллергический шок. Вскоре после приема пенициллина человек внезапно бледнеет, начинает задыхаться и впадает в состояние шока (см. с. 70). Следует сразу же сделать укол эпинефрина (Адреналина).

Когда делаете инъекцию пенициллина (см. с. 385), держите наготове эпинефрин.

Человеку, у которого хоть раз была любая аллергическая реакция на пенициллин, никогда не следует больше давать пенициллин или ампициллин. Это потому, что в следующий раз реакция может быть хуже или может убить его. (Но расстройство желудка после приема пенициллина – это не аллергическая реакция и не причина, из-за которой нужно прекратить прием).

Люди, которые не могут принимать пенициллин, могут принимать тетрациклин или эритромицин внутрь (см. с. 355 и 356 применение, предосторожности).

При многих инфекциях, которые лечатся пенициллином, можно принимать его внутрь. Пенициллин для инъекций опаснее, чем тот, который принимается внутрь.

Пользуйтесь пенициллином для инъекций только в очень тяжелых формах опасных инфекций.

Перед инъекциями пенициллина или лекарств, содержащих его, принимайте меры предосторожности на с. 70.

Сопrotивляемость пенициллину:

Иногда пенициллин не действует против инфекции с нормальным контролем. Это потому что бактерия сопротивляется так, что пенициллин не причиняет ей вреда.

Инфекции, которые постепенно сопротивляются пенициллину, включают импетиго, язвы на коже с гноем, инфекции в костях (остеомиелиты). Если какая-нибудь из этих инфекций не отвечает на обычный пенициллин, нужно попробовать другой вид или особые формы (метициллин, нафциллин, оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин), которые могут действовать.

Во многих странах гонорея уже не лечится пенициллином; см. с. 360 о других антибиотиках. Пневмония тоже иногда сопротивляется пенициллину – пробуйте ко-тримоксазол (с. 358) или эритромицин (с. 357).

Пенициллин в рот

Пенициллин G или Пенициллин V

Название _____ цена _____ для _____

Часто выходит в:

250 мг (400000 ЕД.) таблетки;
также: суспензии или порошок для суспензии 125 или 250 мг на чайную ложку.

(Пенициллин V усваивается организмом легче, чем пенициллин G, но он дороже).

Пенициллин в рот (лучше чем инъекции) следует использовать при умеренных или средних инфекциях, включая:

зубы, инфицированные или с абсцессом

инфекционные раны или многие инфекционные язвы

широко распространенная импетиго

кожное воспаление

ушные инфекции

синуситы

некоторые случаи бронхита

предупреждение столбняка у людей без прививки и с грязными ранами

ревматическая лихорадка

пневмония

Если инфекция тяжелая, может быть лучше всего начать с инъекций пенициллина, но часто пенициллин внутрь улучшает состояние быстрее.

Если не начинается улучшение через 2 или 3 дня, начните применять другой антибиотик и старайтесь обратиться за медицинским советом.

Дозировка пенициллина в рот – используя таблетки 250 мг (20 до 60 мг/кг/день):

От средних инфекций:

взрослым: 1 или 2 таблетки (250 - 500 мг) 4 раза в день

детям от 7 до 12: 1 таблетка (250 мг) 4 раза в день

детям от 2 до 6: 1/2 таблетки (125 мг) 3 или 4 раза в день

детям до 2: 1/4 таблетки (65 мг) 3 или 4 раза в день

От более серьезных инфекций: удвойте данную выше дозу.

Важно: Продолжайте принимать пенициллин, по крайней мере, 5 дней, и 2 или 3 дня после того, как спадет жар и исчезнут другие признаки инфекции.

Чтобы помочь организму лучше усвоить пенициллин, принимайте всегда пенициллин на пустой желудок, за час до еды. (Это важнее для пенициллина G, чем для пенициллина V).

Пенициллин для инъекций

Пенициллин для инъекций следует принимать при определенных тяжелых инфекциях, включая:

менингит

сепсис (бактерии в крови)

столбняк

тяжелая пневмония

тяжелые инфекционные раны

гангрена

инфекционные кости и предупреждение инфекции, когда кость торчит из кожи

гонорея

сифилис

воспаление тазовой кости

Пенициллин для инъекций выходит в виде различных препаратов. Перед употреблением пенициллина убедитесь и проверьте количество и вид.

Выбирайте правильный тип пенициллина для инъекций:

Некоторые виды пенициллина действуют быстро, но не надолго. Другие действуют медленно, но долго. Бывает так, что лучше пользоваться одним видом, чем другим.

Пенициллин короткого действия: Он известен по многим названиям, включая кристаллический, бензилпенициллин, водный пенициллин, растворимый пенициллин, натриевый пенициллин, калиевый пенициллин и G для инъекций. Эти виды действуют быстро, но остаются в теле на короткое время, поэтому они должны вводиться инъекциями каждые 6 часов (4 раза в день). Пенициллин короткого действия - самый лучший выбор для тяжелых инфекций, когда требуется большая доза пенициллина. Например, от газовой гангрены или, когда поломанная кость протыкает кожу, или при менингите.

Пенициллин среднего действия: Прокаин пенициллина или прокаин пенициллина алюминия моностеарат (ПАМ). Он действует медленнее и держится в теле около 1 дня, поэтому инъекции надо делать ежедневно. Пенициллин прокаина и сочетание прокаина и пенициллина короткого действия - это самый лучший выбор для основных инфекций, когда требуется пенициллин для инъекций.

Долгодействующий пенициллин: Бензатин или бенетамин пенициллина. Этот пенициллин поступает в кровь медленно и остается на месяц. Основное назначение – лечение гнойной ангины, сифилиса и предупреждение ревматической лихорадки. Он полезен, когда человек не может сам сделать укол или не может рассчитать дозу пенициллина в рот. При легких инфекциях достаточна 1 инъекция. Бензатин пенициллина часто совмещают с быстродействующими пенициллинами.

Кристаллин пенициллин (короткого действия)

Название: цена: за ____
Часто выходит в: флаконах по 1 миллиону Е. (625 мг) или 5000000 ЕД. (3125 мг)

Дозировка кристаллин пенициллина или любого краткогодействующего пенициллина – от серьезных инфекций:

Делайте инъекции каждые 4 и 6 часов.

В каждой инъекции давайте:
взрослым и детям старше 8 лет:

1000000 ЕД.,

детям от 3-8 лет: 500000 ЕД.

детям до 3 лет: 250000 ЕД.

От менингита и других тяжелых инфекций должна даваться высокая доза.

Прокаин пенициллина (среднего действия)

Название: цена: за ____
Часто выходит в: ампулах по 300000 ЕД.,

400000 ЕД. и больше.

Дозировка прокаина пенициллина - от умеренно тяжелых инфекций:

Делайте 1 инъекцию в день.

С каждой инъекцией давайте:

взрослым: 600000 ЕД. - 1200000 ЕД.

детям 8-12 лет: 600000 ЕД.

детям 3-7 лет: 300000 ЕД.

детям до 3 лет: 150000 ЕД.

новорожденным: не ДАВАТЬ,

если доступен другой

пенициллин или ампициллин.

В крайних случаях, 75000 ЕД.

При очень тяжелых инфекциях давайте двойные дозы. Однако лучше пользоваться пенициллином короткого действия.

Дозировка прокаина пенициллина в сочетании с пенициллином короткого действия такая же, как и для одного прокаина пенициллина.

Для лечения гонореи, которая не сопротивляется пенициллину, прокаин пенициллин - самый лучший. Нужна очень высокая доза. Чтобы узнать дозу, см. с. 360. При воспалениях в тазовой области доза та же, что и от гонореи.

Бензатин пенициллин (долгодействующий)

Название: цена: за ____
Часто выходит в: флаконах по 1200000 ЕД или 2400000 ЕД.

Дозировка бензатин пенициллина - от легкой до умеренно-тяжелой инфекции.

Делайте 1 инъекцию каждые 4 дня. От легкой инфекции может быть достаточно 1 инъекции.

взрослым: от 1200000 ЕД до 2400000 ЕД.

детям 8-12 лет: 900000 ЕД.

детям 1-7 лет: 300000 ЕД до 600000 ЕД.

От гнойной ангины 1 инъекцию указанной дозы.

Для предупреждения возврата инфекции у людей, перенесших ревматическую лихорадку, давайте указанную дозу каждые 4 недели (см. с. 310).

Для лечения сифилиса лучше всего бензатин пенициллина. Дозу смотри на с. 238.

Ампициллин: широкого действия (широкого спектра) пенициллин

Ампициллин

Название: _____

Часто выходит в: растворах 125 или 250 мг /ч.л. цена: _____ за _____

капсулах 250 мг цена: _____ за _____

инъекциях 500 мг цена: _____ за _____

Ампициллин – это пенициллин широкого спектра (широкого действия), который убивает намного больше видов бактерий, чем другие пенициллины. Он безопаснее, чем другие антибиотики широкого спектра, и особенно полезен младенцам и маленьким детям.

Из-за высокой цены и из-за того, что он иногда вызывает понос или “молочницу”, ампициллин не следует употреблять, если хорошо помогает обычный пенициллин (см. с. 58).

Ампициллин хорошо действует, когда его принимают внутрь. Инъекции лучше делать от тяжелых болезней таких, как менингит, перитонит и аппендицит, или когда больного человека рвет или он не может глотать лекарства.

Ампициллин часто полезен при лечении следующих болезней:

сепсис или необъяснимая болезнь у новорожденных
пневмония или ушная инфекция у детей до 6 лет
менингит
перитонит или аппендицит
тяжелые инфекции мочеполового тракта
брюшной тиф (если он устойчив к хлорамфениколу)
гонорея

Люди, у которых аллергия к пенициллину, не должны принимать ампициллин. См. Риск и Меры Предосторожности для пенициллина, страница 351.

Дозировка ампициллина

В рот – (25-50 мг/кг/день):

капсулы 250 мг; сироп из 125 мг на чайную ложку (5 мл)

Давайте 4 дозы в день.

В каждой дозе давайте:

взрослым: 2 капсулы или 4 чайные ложки (500 мг)

детям от 8 до 12 лет: 1 капсула или 2 чайные ложки (250 мг)

детям от 3 до 7 лет: 1/2 капсулы или 1 чайная ложка (125 мг)

детям до 3 лет: 1/4 капсулы или 1/2 чайной ложки (62 мг)

новорожденным младенцам: то же самое, что и детям до 3 лет.

От гонореи доза должна быть выше. См. с. 360.

Инъекции, от тяжелых инфекций – (50-100 мг/кг/день – до 300 мг/кг/день от менингита): флаконы по 500 мг.

Давайте 4 дозы в день, один раз каждые 6 часов.

В каждой дозе давайте:

взрослым: 500 до 1000 мг (от одного до двух 500 мг флаконов)

детям от 8 до 12 лет: 250 мг (1/2 500 мг флакона)

детям от 3 до 7 лет: 125 мг (1/4 500 мг флакона)

детям до 3 лет: 62 мг (1/8 500 мг флакона)

новорожденным младенцам: 125 мг (1/4 500 мг флакона) только дважды в день.

Продолжайте давать ампициллин по крайней мере 2 дня после того, как исчезнет инфекция.

Пенициллин со стрептомицином

Продукты, представляющие собой смесь пенициллина со стрептомицином, имеются в большинстве стран и часто употребляются больше, чем следует. Если один из этих продуктов широко используется в вашей местности, напишите название, состав и цену.

Название: мг пенициллина: _____

мг стрептомицина: цена: ____ за ____

Пенициллин и стрептомицин следует употреблять вместе только в особых случаях, как альтернативу ампициллину, когда ампициллин нельзя достать или он слишком дорогой. Их не следует употреблять от легких инфекций или от обычной простуды или гриппа.

Частое употребление стрептомицина от других болезней, кроме ТБ, делает бактерию устойчивой к стрептомицину, и, следовательно, лечение сильно затрудняется. И еще стрептомицин может вызвать глухоту.

Стрептомицин с пенициллином можно употреблять от большинства болезней, для которых рекомендуется ампициллин (см. с. 353), но ампициллин безопаснее, особенно для малышей.

Обычно дешевле и легче определить правильную дозу, если стрептомицин и пенициллин делаются инъекциями отдельно, лучше чем в сочетании.

Дозировка пенициллина со стрептомицином – от тяжелых инфекций:

Давайте краткосействующий пенициллин, по крайней мере 25000 Е./кг 4 раза в день, и стрептомицин, не больше чем 30-50 мг/кг/день.

Новорожденным давайте краткосействующий пенициллин 50000 Е./кг дважды в день вместе со стрептомицином 20 мг/кг один раз в день.

Давайте пенициллин со стрептомицином

короткого действия
взрослым 1000000 Е. 1 г (обычно
4-6 раз в 2 мл)
раз в день день

детям
от 8 до 12 . . 500000 Е. 750 мг
4-6 раз в (1 1/2 мл)
день раз в день

детям
от 3 до 7 . . . 250000 Е. 500 мг (1 мл)
4-6 раз в раз в день
день

детям
до 3 лет . . . 125000 Е. 250 мг (1/2 мл)
4-6 раз в раз в день
день

младенцам . 150000 Е. 60 мг (1/8 мл)
дважды в раз в день
день

От очень тяжелых инфекций, таких как перитонит, аппендицит, менингит или острая инфекция кости (остеомиелит), можно давать более высокую дозу пенициллина, но дозу стрептомицина никогда нельзя превышать.

От менее серьезных инфекций, вместо пенициллина со стрептомицином, можно использовать прокаин пенициллина и стрептомицин. Дозу прокаина пенициллина смотри на с. 353. Дозировка стрептомицина та же.

Внимательно прочитайте Риск и Меры Предосторожности для пенициллина и стрептомицина, с. 351 и 363.

Эритромицин:
альтернатива пенициллину

Эритромицин
Название: _____

Часто выходит в:
таблетках или
капсулах 250 мг Цена: ____ за ____
сиропах из 125 Цена: ____ за ____
или 200 мг в 5 мл

Эритромицин действует против многих инфекций, как пенициллин или тетрациклин, но он дороже. Во многих частях света эритромицин сейчас действует лучше, чем пенициллин, в некоторых случаях пневмонии или при определенных кожных инфекциях.

Эритромицин может употребляться вместо пенициллина теми, у кого аллергия к пенициллину. Еще его можно употреблять тем, у кого аллергия к тетрациклину, и беременными женщинами, которым не следует употреблять тетрациклин. В некоторых случаях эритромицин не очень хорошая замена тетрациклину. См. разделы книги, в которых обсуждаются болезни.

Эритромицин абсолютно безопасен, но нужно позаботиться о том, чтобы не дать больше рекомендуемой дозы. Не принимайте его больше 2 недель, так как он может вызвать желтуху.

Дозировка эритромицина:

Принимайте эритромицин во время еды, чтобы избежать расстройства желудка.

Давайте 1 дозу 4 раза в день.

В каждой дозе давайте:
взрослым: 500 мг (2 таблетки или 4 чайные ложки)

детям от 8 до 12: 250 мг (1 таблетка или 2 чайные ложки)

детям от 3 до 7: 150 мг (1/2 таблетки или 1 чайная ложка)

детям до 3: 75-150 мг (от 1/4 до 1/2 таблетки или от 1/2 до 1 чайной ложки)

Тетрациклины:
Широкого действия антибиотики

Тетрациклин (тетрациклин HCl, окситетрациклин и т.д.)

(Главная, но дорогая марка: Террамицин).

Название: _____

Часто выходит в:

капсулах 250 мг Цена: ____ за ____

микстура, 125 мг/5 мл Цена: ____ за ____

Тетрациклины – широкого спектра антибиотики; они борются с широким рядом различных бактерий.

Тетрациклин нужно употреблять в рот, так как он хорошо действует и вызывает меньше проблем, чем в инъекциях.

Тетрациклин можно применять от:
понос или дизентерия, вызванные бактериями или амебами
синусит
респираторные инфекции (бронхит и т.д.)

инфекции мочеполового тракта

тиф

бруцеллез

холера

трахома

инфекции желчного пузыря

хламида

гонорея

тазовые воспаления

Тетрациклин не помогает при обычной простуде. При многих обычных болезнях он не действует так, как пенициллин или сульфамиды. Он более дорогой. Его применение следует ограничить.

Риск и предосторожности:

1. Беременные женщины не должны принимать тетрациклин, так как он может поразить или окрасить детские зубы и кости. По этой же причине детям до 8 лет можно принимать тетрациклин только в крайних случаях и только короткое время. Принимайте вместо него эритромицин.
2. Тетрациклин может вызвать понос или расстройство желудка, особенно если принимать долгое время.
3. Опасно пользоваться тетрациклином, если он “старый”, т.е. прошел срок годности.

4. Чтобы тетрациклин лучше усвоился, не следует пить молоко или антацид 1 час до или после приема лекарства.

5. У некоторых людей, когда они принимают тетрациклин, во время пребывания на солнце может появиться сыпь.

Дозировка тетрациклина –

(20-40 мг/кг/день); – капсулами

250 мг и микстурой 125 мг в 5 мл –

Давайте тетрациклин в рот 4 раза в день.

В каждой дозе давайте:

взрослым: 250 мг (1 капсулу)

детям от 8 до 12: 125 мг (1/2 капсулы или 1 чайную ложку)

детям до 8: Как общее правило,

не пользуйтесь тетрациклином –

вместо него употребляйте ко-

тримоксазол или эритромицин.

Если нет выбора, то давайте:

детям от 4 до 7: 80 мг (1/3 капсулы или 2/3 чайной ложки)

детям от 1 до 3: 60 мг (1/4 капсулы или 1/2 чайной ложки)

малышам до 1 года: 25 мг (1/10

капсулы или 1/5 чайной ложки)

новорожденным малышам (когда

другие антибиотики недоступны):

8 мг (1/30 капсулы или 6 капель микстуры).

В сложных случаях или от инфекции гонореи, хламиды, тазового воспаления, холеры, тифа, бруцеллеза удвоить указанную дозу (кроме маленьких детей).

Для большинства инфекций тетрациклин следует продолжать принимать 1 или 2 дня после исчезновения признаков инфекции (обычно в общей сложности 7 дней). От некоторых болезней требуется более длительное лечение: тиф 6-10 дней, бруцеллез 2-3 недели, холера - 3-5 дней, гонорея и хламида 7-10 дней, тазовое воспаление 10-14 дней.

Доксициклин (Торговая марка: Вибрамицин)

Название: _____

Часто выходит в:

капсулах или таблетках 100 мг

Цена: ____ за ____

ампулах 100 мг для инъекций

Цена: ____ за ____

Доксициклин - дорогая форма тетрациклина, который принимают дважды в день вместо 4 раз в день. Когда возможно, он может быть использован от тех же болезней, что и тетрациклин. Его можно употреблять с молоком или едой. Риск и предосторожности те же, что и от тетрациклина (см 356).

Дозировка доксициклина - таблетки 100 мг. Принимайте доксициллин в рот дважды в день. В каждой дозе давайте: взрослым - 100 мг (1 таблетка), детям от 8-12 - 50 мг (1/2 таблетки), детям до 8 - не употреблять доксициллин.

Хлорамфеникол (левомицетин):
антибиотик от определенных тяжелых болезней

Хлорамфеникол (Левомецетин)

Название: _____

Часто выходит в:

капсулах 250 мг Цена: ___ за ___

микстуре 125 мг в 5 мл Цена: ___ за ___

инъекциях 1000 мг в флаконе Цена: ___ за ___

Антибиотик широкого спектра борется с широким рядом различных бактерий. Он дешевый, но есть некоторая опасность в его употреблении. По этой причине его применение должно быть ограничено.

Хлорамфеникол следует употреблять только от тифа и очень сильного поноса или других инфекций, которые не лечатся сульфамидами, пенициллином, тетрациклином или ампициллином. От болезней, которые угрожают жизни, таких как менингит, перитонит, глубокие раны кишечника, сепсис или тяжелая родильная горячка, можно употреблять хлорамфеникол, когда менее опасные лекарства (типа цефалоспорины) недоступны.

Ампициллин обычно действует хорошо, может быть лучше чем хлорамфеникол и может быть безопасным. К сожалению, ампициллин дорогой, поэтому иногда хлорамфеникол должен употребляться вместо него.

ВНИМАНИЕ: Хлорамфеникол действует на кровь некоторых людей. Он даже более опасен для новорожденных малышей, особенно родоразрешенных детей. Новорожденным детям с серьезными инфекциями давать ампициллин лучше, чем хлорамфеникол, если это только возможно. Как правило, нельзя давать хлорамфеникол малышам до 1 месяца.

Будьте внимательны и не давайте больше рекомендуемой дозы хлорамфеникола. Для малышей доза очень маленькая (см. ниже).

Избегайте долгого или повторного употребления.

При лечении тифа перейдите от хлорамфеникола к ампициллину, как только остановите болезнь. (В регионах, где известно, что тиф сопротивляется хлорамфениколу, все лечение должно быть из ампициллина или ко-тримоксазола.)

В некоторых местах Центральной и Южной Америки тиф стал сопротивляться и хлорамфениколу и ампициллину и больше не лечится ими. Пробуйте ко-тримоксазол (см. с. 358).

Хлорамфеникол внутрь приносит часто больше пользы, чем инъекции, и он менее опасен. Кроме некоторых случаев, когда больной не может глотать, тогда сделайте инъекцию хлорамфеникола.

Дозировка для хлорамфеникола –

(от 50 до 100 мг/кг/день):

– капсулами 250 мг или микстурой 125 мг в 5 мл –

Давайте в рот 4 раза в день.

В каждой дозе дайте:

взрослым: 500-700 мг (2 или 3 капсулы) от тифа, перитонита и других опасных инфекций
следует дать дозу выше

(3 капсулы 4 раза в день - 12 капсул в день).

детям от 8 до 12: 250 мг (1 капсулу или 2 чайные ложки микстуры).

детям от 3 до 7 лет: 125 мг (1/2 капсулы или 1 чайную ложку).

новорожденным от 1 месяца до 2 лет: дайте 12 мг (1/2 мл микстуры или 1/20 часть капсулы) на каждый килограмм веса тела. (Таким образом, ребенок 5 кг получит 10 мг, которые составляют 1/2 чайной ложки микстуры или 1/4 капсулы на каждую дозу. С 4 дозами это означает, что ребенок 5 кг получит 1 капсулу или 2 чайные ложки микстуры в день.

новорожденным: Как правило, не давайте хлорамфеникол. Если нет другого выбора, дайте 5 мг (1/4 мл или 5 капель микстуры) на каждый килограмм веса. Ребенку весом 3 кг дайте 15 мг (15 капель микстуры 4 раза в день или 1/4 капсулы в день). Не давайте больше.

Сульфонамиды:
недорогие лекарства от обычных болезней

Сульфадиазин, сульфисоксазол, сульфадимидин или "тройной сульфамид"

Название: _____

Часто выходит в:

таблетках 500 мг Цена: ____ за ____

микстурах 500 мг в 5 мл Цена: ____ за ____

Сульфонамиды убивают многие виды бактерий, но они слабее антибиотиков и вызывают аллергические реакции (зуд) и другие проблемы. Поскольку они дешевле и их можно глотать, они все же полезны.

Очень важно применять сульфамиды при инфекциях мочеполовой системы. Их можно применять от инфекций ушей, от импетиго и от гнойных инфекций кожи.

Не все сульфамиды применяются одинаково и с одинаковой дозой. Если у вас есть другие сульфамиды, перед применением убедитесь в правильности употребления и дозе. Сульфатиазол похож на вышеперечисленные сульфамиды и очень дешевый, но не рекомендуется, так как он больше вызывает побочных эффектов.

Сульфамиды не помогают при поносе, потому что многие микробы, вызывающие понос, адаптировались к этому лекарству. Давая сульфамид больному, который обезвожен от поноса, можно вызвать опасное заболевание почек.

ВНИМАНИЕ:

Для предупреждения болезни почек очень важно при приеме сульфамида пить побольше воды (не менее 8 чашек в день).

Если сульфамид вызывает сыпь, зуд, боль в суставах, жар, боль внизу спины или кровь в моче, прекратите прием и пейте побольше воды.

Никогда не давайте сульфамид больному с обезвоживанием или малышу до 1 года.

Примечание: Чтобы сульфамид помог, нужно принимать правильную дозу, хотя она и большая. Убедитесь, что приняли достаточно – но не слишком много!

Дозировка для сульфадиазина, сульфисоксазола, сульфамидина или тройного сульфамида (200 мг/кг/день):

– таблетки 500 мг или микстура 500 мг в 5 мл –

Дайте 4 дозы в день – и много воды!

В каждой дозе дайте:

взрослым и детям старше 10 лет: от

3 до 4 г (6-8 таблеток) на

первую дозу; затем 1 г (2

таблетки) на другую дозу

детям от 6 до 8 лет: 750 мг (1 1/2

таблетки или 1 чайную ложку) в

каждой дозе

детям от 1 до 5 лет: 500 мг

(1 таблетка или 1 чайная ложка)

в каждой дозе

малышам до 1 года: Не давайте

сульфамиды. Если нет выбора,

дайте 250 мг (1/2 таблетки или 1

чайную ложку) 4 раза в день

Ко-тримоксазол (сульфаметоксазол с триметопримом) (Торговые марки: Бактрим, Септра, Бисептол)

Название: _____

Часто выходит в:

таблетки 100 мг сульфаметоксазола с

20 мг триметоприма Цена: ____ за ____

таблетки 400 мг сульфаметоксазола с

80 триметоприма Цена: ____ за ____

микстура 200 мг сульфаметоксазола с

40 мг триметоприма в 5 мл Цена: ____ за ____

Примечание: Это лекарство выходит в таблетках двойной силы (Бактрим DS и Септра DS). Принимайте половину дозы.

Это сложное лекарство борется с целым рядом бактерий и дешевле ампициллина.

Ко-тримоксазол можно употреблять для лечения:

инфекции в моче
понос с кровью и жаром (шигелла)
брюшной тиф
холера
бруцеллез
респираторные инфекции(пневмония)
импетиго
ушные инфекции
мягкий шанкр
гонорея

Дозировка ко-тримоксазола:

– применяя таблетки по 400 мг
сульфаметоксазола с 80 мг триметоприма
Давать 2 дозы в день – и много воды!

В каждой дозе дать:

взрослым и детям старше 12 лет:

2 таблетки или 4 чайные ложки

детям от 9 до 12 лет: 1 1/2

таблетки

или 3 чайные ложки

детям от 4 до 8 лет: 1 таблетку или

2 чайные ложки

детям от 1 до 3 лет: 1/2 таблетки

или 1 чайную ложку

малышам до 1 года: Не

давать.Если

нет выбора, давайте 1/4

таблетки или 1/2 чайной ложки

2 раза в день.

От инфекций в моче давайте эту дозу 10-14 дней. От острого бронхита и брюшного тифа давайте 14 дней. От шанкра давайте 7 дней. От дизентерии давайте от 5 до 10 дней.

От устойчивой к пенициллину гонорее нужна очень высокая доза (см. с. 360).

КАНАМИЦИН И ГЕНТАМИЦИН

Канамицин и гентамицин – это антибиотики для инъекций, которыми злоупотребляют в некоторых странах. Прием этих опасных лекарств следует сильно ограничить, так как они вызывают глухоту и поражают почки. К тому же, бактерии быстро привыкают к ним и они теряют свою силу. (Стрептомицин – другое лекарство из этой же группы, но обычно его принимают только при ТБ, см. с. 305).

Их должны давать опытные врачи только от серьезных инфекций, когда нет других безопасных лекарств или они слишком дорогие. Канамицин иногда применяют от гонореи (см. след. с.) или от глазной инфекции (конъюнктивит) у новорожденных малышей (с. 221).

Канамицин (Кантрекс)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выходит в:

флаконах для инъекций 75 мг, 500 мг
или 1000 мг.

Риск и предосторожности:

Слишком большое количество канамицина в течение длительного времени может вызвать глухоту. Если есть звон в ушах и ухудшение слуха, прекратите прием лекарства и обратитесь к работнику здравоохранения. Канамицин не следует принимать беременным женщинам или людям с больными почками.

Дозировка канамицина (15 мг/кг/день):

– флаконы жидкости; или порошок для смеси с водой, чтобы дать 1 г канамицина в 2 мл.

Давайте дважды в день.

С каждой инъекцией дайте:

взрослым: 500 мг

детям от 8 до 12: 250 мг

детям от 3 до 7 лет: 125 мг

детям до 3 лет: 63 мг

малышам: дайте 15 на каждый кг веса ребенка, т.о. 3 кг ребенок получает 45 мг.

От гонореи большее количество в одной дозе: от инфекции глаз у новорожденных сделать одну инъекцию 25 мг на каждый кг веса ребенка (т.о. 3 кг ребенок получит 75 мг). От гонореи у взрослых см. с. 360.

Гентамицин (Гарамидин)

Во многих странах сегодня гентамицин употребляется вместо канамицина. Его действие, риск и предосторожности те же, но дозировка меньше (2-5 мг/кг/день). Эту дозу делят и дают 3 раза в день.

ЦЕФАЛОСПОРИНЫ

Это новые сильные антибиотики, действующие против многих видов бактерий. Они очень дорогие и малодоступны. По этой причине мы не рекомендуем их как первоочередное лекарство. Однако у них меньше риска и побочных эффектов, чем у многих других антибиотиков, и когда это приемлемо, они могут быть полезны в лечении определенных тяжелых болезней.

Есть много различных типов, включая цефазолин (Ансеф), цефалексин (Кефлекс), цефрадин (Велосеф), цефуразин (Цефтин), цефокситин (Мефоксин), цефтриаксон (Роцефин), цефотаксим (Клафоран) и цефтазидим (Фортаз, Таксидим, Тазицеф). Различные цефалоспорины можно давать от пневмонии, инфекций в моче, тифа, инфекций кишечника или таза, костных инфекций и менингита. Некоторые, типа цефтриаксона, могут быть полезны при лечении венерических болезней, таких как шанкр, глазные инфекции у младенцев или гонорея, которые сопротивляются пенициллину.

Выясните дозировку и побочные эффекты перед приемом этих лекарств. И еще, не употребляйте их от легких болезней или от таких, которые хорошо лечатся более дешевыми антибиотиками.

ЛЕКАРСТВА ОТ ГОНОРЕИ И ХЛАМИДЫ

Во многих частях света пенициллин уже не действует на гонорею, потому что бактерии стали ему сопротивляться. Нужно применять другие антибиотики. Выясните, какие лекарства эффективны в вашей местности. Здесь представлены те, которые можно рекомендовать по мере их доступности.

Если боль и выделения не проходят после 3 дней лечения гонореи, эта болезнь либо сопротивляется лекарству либо у больного хламиды. У этих болезней одинаковые ранние признаки и они часто бывают вместе (см. с. 236). Если эти болезни обычны в вашей местности, их следует лечить вместе. (Но не забывайте пользоваться презервативом, пока не убедитесь, что ваш партнер полностью вылечился).

Некоторые лекарства, представленные здесь, вызывают серьезные побочные эффекты, если их давать долгое время, малышам, или беременным женщинам. В ПРИЛОЖЕНИИ 1 перед лечением ознакомьтесь с информацией об этих лекарствах. Дозы приведены для взрослых.

От гонореи применяйте одно из следующих:

1. Ко-тримоксазол (с. 358) можно использовать для лечения гонореи. Пользуясь таблетками с 400 мг сульфаметоксазола и 80 мг триметоприма. Давайте 5 таблеток дважды каждый день 2 или 3 дня.

2. 1 инъекцию 2 г канамицина (с. 359).
3. Тетрациклин (с. 356) или эритромицин (с. 355) в таблетках можно применять одновременно для лечения гонореи или хламиды, но иногда гонорея не реагирует на тетрациклин. Давайте 500 мг по 4 раза в день 7-10 дней.
4. Сделайте инъекцию 2 г стрептомицина (с. 363). Но стрептомицин используйте только от гонореи, которая устойчива к пенициллину, когда ни одно другое лекарство недоступно. Слишком большое употребление стрептомицина от болезней, кроме ТБ, уменьшает его полезность.
5. Если гонорея в вашей местности сопротивляется пенициллину, сделайте инъекцию 4.8 миллиона единиц прокаина пенициллина или 5 миллионов единиц кристаллин пенициллина за один раз. Уколите по половине дозы в каждую ягодицу и дайте проглотить 1 г пробенецида в то же время. Или примите внутрь 3500 мг ампициллина и 1 г пробенецида.

Если clavulanic acid (клавованиковую кислоту) добавить к одному из таких лечений пенициллином, это улучшит лечение от гонореи, которая приспособилась к пенициллину. Если доступно, дайте 125-250 мг clavulanic acid (клавованиковой кислоты) вместе с пенициллином или ампициллином. (Аугментин - сочетание таблетки clavulanic acid (клавованиковой кислоты) и разновидности пенициллина).

6. Возможно, в вашем регионе есть более дорогие, но и более эффективные лекарства (цефтриаксон, ципрофлоксацин, спектиномицин, тиамфеникол) от гонореи. Посоветуйтесь с опытным медработником перед употреблением этих лекарств.

От хламиды пользуйтесь следующим:

1. Давайте тетрациклин (с. 356) или эритромицин (с. 355): 500 мг 4 раза в день 7-10 дней.
2. Или давайте доксициклин (с. 356): 100 мг дважды в день 7-10 дней.
3. Сульфамидные лекарства (с. 358) тоже можно использовать. Например, давайте 500 мг сульфисоксазола в рот 4 раза в день 10 дней.

ЛЕКАРСТВА ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА

При лечении туберкулеза (ТБ) очень важно всегда употреблять 2,3 или даже 4 анти-ТБ лекарств одновременно. Если применять только 1 лекарство, бактерия приспосабливается к нему и лечение затрудняется.

Туберкулез надо лечить долго – 6-9 месяцев или больше. Время лечения зависит от используемых лекарств. Чтобы болезнь не возвратилась, очень важно провести полное, длительное лечение.

Некоторые лекарства от ТБ очень дорогие (рифампин, пиразинамид, этамбутол), если покупать в аптеке. Но многие правительства проводят программу по обследованию на ТБ и выдают лекарства бесплатно или по низкой цене.

Важен квалифицированный совет, поскольку лечение меняется, бактерия приспосабливается и становятся доступными новые лекарства. К тому же, некоторые программы дают лекарства только дважды в неделю, в больших дозах.

Изониазид (INH) следует всегда употреблять в лечении ТБ. Рифампин – очень эффективное лекарство, которое всегда следует употреблять по мере возможности, особенно, пока не придет отрицательный результат на тест “слюны”. Этамбутол и стрептомицин тоже часто используются для лечения ТБ. Принимая пиразинамид с INH и рифампином, можно сократить время лечения. Тиациетазон – недорогое лекарство от ТБ, но так часто дает побочные эффекты, что многие больные не могут пользоваться им.

Если лекарство вызывает зуд, покраснение кожи и глаз (желтуху) или боли в желудке, обратитесь к врачу, чтобы изменить дозу или лекарства. Если появляются волдыри, прекратите прием лекарства, пока не посоветуетесь с врачом. Избегайте алкоголь, когда принимаете лекарства от ТБ, особенно INH.

Рекомендуемое лечение

Принимайте одно из следующих сочетаний лекарств в зависимости от их доступности:

1. Пейте изониазид, рифампин, этамбутол и пиразинамид 2 месяца. Затем не принимайте пиразинамид, а продолжайте пить рифампин, изониазид и этамбутол еще 4 месяца.
2. Принимайте изониазид, рифампин и этамбутол 9 месяцев.

1. Принимайте комбинированно изониазид, рифампин, стрептомицин и пиразинамид 2 месяца. Затем пользуйтесь изониазидом с этамбутолом и стрептомицином или возможно тиациетазоном 6 месяцев. У этого лечения есть преимущества: оно дешевле, потому что меньше нужен рифампин.
2. Если рифампин недоступен или слишком дорогой, принимайте изониазид, этамбутол, стрептомицин 2 месяца, или пока слюна не покажет отрицательный результат. Затем продолжайте давать стрептомицин 2 месяца еще и давайте INH и этамбутол 1 год.
3. Беременным женщинам с ТБ нужно обратиться за опытным медицинским советом. Иначе давайте изониазид и этамбутол рифампин или тиациетазон 18 месяцев. Еще дайте 50 мг витамина В (пиридоксина). Не давайте пиразинамид или стрептомицин во время беременности.

Изониазид (INH)

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выходит в: таблетках 100 и 300 мг.

Это самое активное анти-ТБ лекарство. Для лечения ТБ всегда должны принимать по крайней мере 1 другое анти-ТБ лекарство. Для профилактики можно принимать только одно.

Риск и предосторожности:

Редко, но изониазид вызывает анемию, нервные боли в руках, ногах, скрученные мышцы и даже припадки, особенно у истощенных людей. Побочные эффекты лечатся, принимая 50 мг пиридоксина (витамин В₆) ежедневно в рот (с. 394).

Иногда изониазид может навредить печени. Людям, у которых при приеме изониазида появились признаки гепатита (желтый цвет кожи и глаз, зуд, потеря аппетита, боль в желудке см. с. 172), следует прекратить его прием.

Дозировка изониазида – (5-10 мг/кг/день):
–употребляя таблетки 100 мг –

Давайте изониазид один раз в день.

В каждой дозе дайте:

взрослым: 300 мг (3 таблетки)
детям: 50 мг (1/2 таблетки) на
каждые 5 кг веса ребенка.

Для детей с тяжелым ТБ или больных с ТБ менингитом удвойте вышеуказанную дозу пока не наступит улучшение.

Для профилактики ТБ среди членов семьи с больными ТБ часто рекомендуется приведенная доза INH на 6-9 месяцев.

Рифампин (рифампицин, рифамицин)

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выходит в: таблетках или капсулах

150 мг или 300 мг.

Это дорогой антибиотик, но сильный в борьбе с ТБ. Он может сократить время лечения на несколько месяцев, если его комбинировать с изониазидом и по крайней мере с еще другим лекарством от ТБ. (Рифампин употребляют от проказы – см. с. 304 для дозы).

Очень важно употреблять рифампин регулярно без перерыва. Постарайтесь достать еще, пока не кончился ваш запас.

Риск и предосторожности:

Рифампин может серьезно навредить печени. Человек с больной печенью или беременная женщина должны принимать это лекарство только под наблюдением врача.

Побочные эффекты: Моча, слезы, фекалии, слюнь от кашля (слюна) и пот окрашены в красно-оранжевый цвет от рифампина. Редко, но рифампин вызывает рвоту, жар, потерю или увеличение аппетита, тошноту, обморок, кожную сыпь и проблемы с месячными.

Рифампин уменьшает эффективность оральных противозачаточных средств. Поэтому женщины, принимающие таблетки, должны получить медицинский совет по повышению дозы. Или когда принимаете лекарство, используйте другой метод, такой как презерватив, ВМС, колпачок.

Дозировка рифампина от ТБ–

(10 мг/кг/день): – таблетки, капсулы по 150 и 300 мг –

Дайте рифампин раз в день либо за час до, либо через 2 часа после еды.

В каждой дозе давайте:

взрослым: 100 мг (две таблетки по 300 мг или 4 по 150 мг)

детям 8-12 лет: 450 мг

детям 3-7 лет: 300 мг

детям до 3 лет: 150 мг.

Пиразинамид

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выходит в: таблетках 500 мг.

Риск и предосторожности:

Беременным женщинам не следует принимать пиразинамид.

Побочные эффекты: может вызвать боль в суставах, потерю аппетита, тошноту, рвоту, болезненное мочеиспускание, утомление и жар.

Дозировка пиразинамида – (от 20-30

мг/кг/день): – принимая таблетки

500 мг –

Принимайте ежедневно 2 месяца, вместе с другими ТБ лекарствами. В каждой дозе дайте:

взрослым: 1500 или 2000 мг (3-4 таблетки)

детям от 8 до 12 лет: 1000 мг (2 таблетки)

детям от 3 до 7 лет: 500 мг (1 таблетка)

детям до 3 лет: 250 мг (1/2 таблетки).

Этамбутол (торговая марка Миамбутол)

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выходит в: таблетках 100 и 400 мг.

Риск и предосторожности:

Этамбутол может вызвать глазную боль, если принимать много и долгое время. Если это произойдет, прекратите прием лекарства. Болезнь глаз от этамбутола медленно прекращается после отмены лекарства.

Дозировка этамбутола – (25 мг/кг/день на первые 2 месяца, затем 15 мг/кг/день):

–100 мг таблетки или 400 мг таблетки–
Давать один раз в день.

В первые 2 месяца в каждой дозе давайте:

взрослым - 1200 мг (3 таблетки 400 мг или двенадцать 100 мг)

детям: Давайте 15 мг на каждый кг веса ребенка. Но от ТБ менингита дайте 25 мг на каждый кг веса ребенка.

После первых 2 месяцев дайте:

взрослым: 800 мг (две 400 мг таблетки или восемь по 100 мг)

детям: Дайте 15 мг на каждый кг веса ребенка.

Стрептомицин

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выходит в: флаконах для инъекций
по 500 мг в каждом мл

Стрептомицин – полезное лекарство для лечения туберкулеза. Но он всегда должен употребляться в сочетании с другими лекарствами.

Риск и предосторожности:

Надо употреблять осторожно, чтобы не превысить дозу. Слишком большое количество стрептомицина и длительное его употребление могут вызвать глухоту. Если появляется звон в ушах или слабеет слух, прекратите прием лекарства и обратитесь к работнику здравоохранения.

Стрептомицин не следует принимать беременным женщинам или почечным больным.

Дозировка стрептомицина (15 мг/кг/день):

– флаконы с жидкостью; или порошок для разведения в воде, чтобы дать 1 г стрептомицина в 2 мл.

Для лечения туберкулеза:

очень тяжелые случаи, делайте 1 инъекцию ежедневно 3-8 недель
в легких случаях делайте 1 инъекцию 2 или 3 раза в неделю в течение 2 месяцев.

С каждой инъекцией давайте:

взрослым: 1 г (или 2 мл)
взрослым старше 50: 500 мг (1 мл)
детям от 8 до 12: 750 мг (1 1/2 мл)
детям от 3 до 7: 500 мг (1 мл)
детям до 3 лет - 250 мг (1/2 мл)
новорожденным малышам: дайте 20 мг на каждый кг веса ребенка; т.о. 3 кг ребенок получит 60 мг (1/8 мл).

Используйте стрептомицин от других болезней:

В срочных случаях стрептомицин и пенициллин вместе можно применять для лечения других серьезных болезней (см. с. 354, ПЕНИЦИЛЛИН СО СТРЕПТОМИЦИНОМ). Однако прием стрептомицина от других болезней, кроме туберкулеза, ограничьте, так как частое применение стрептомицина вызывает устойчивость к нему у туберкулеза и затрудняет лечение. Стрептомицин иногда используют для лечения гонореи, которая приспособилась к пенициллину - нужна слишком большая доза (см. с. 310).

Тиацетазон

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выходит в: таблетках по 50 мг
тиацетазона (часто в сочетании с 100 мг или 133 мг изониазида).

Побочные эффекты: Может вызвать сыпь, рвоту, головокружение, потерю аппетита. Побочные явления наблюдаются часто и могут быть тяжелыми у людей, зараженных вирусом СПИДа.

Дозировка тиацетазона – (2,5 мг/кг/день):

– таблетки по 50 мг тиацетазона с или без изониазида –

Давать один раз в день.

В каждой дозе дайте:

взрослым: 3 таблетки (150 мг)
детям от 8 до 12: 2

таблетки

(100 мг)

детям от 3 до 7: 1 таблетку (50

мг)

детям до 3: 1/2 таблетки (25 мг).

ЛЕКАРСТВА ОТ ПРОКАЗЫ

При лечении проказы важно знать, какой из двух основных типов проказы есть у больного. Если существуют светлоокрашенные кожные пятна с потерей чувствительности, но без опухолей или утолщения кожи, тогда больной возможно болен проказой туберкулезного типа и требуется только 2 лекарства. Если есть опухоли, то у человека возможна проказа лепроматус и лучше пользоваться 3 лекарствами. Если возможно, то лекарства от проказы следует принимать под руководством опытного работника здравоохранения или врача, согласно национальному плану.

Лечение проказы должно обычно продолжаться по крайней мере 6 месяцев, а иногда всю жизнь. Для предупреждения сопротивляемости бактерий (бацилл), которые вызывают проказу, важно принимать лекарство регулярно, без перерыва. Постарайтесь достать больше лекарства, перед тем, как закончится ваш запас.

Рекомендуемое лечение:

От проказы туберкулезного типа
принимайте оба лекарства, по крайней
мере 6 месяцев:

Дапсон ежедневно
Рифампин каждый месяц

От проказы лепроматус
принимайте все эти лекарства от 2 до
5 лет:

Дапсон ежедневно
Клофазимин ежедневно, а в
больших дозах каждый

месяц
Рифампин - каждый месяц

Примечание: Хотя лечение проказы
ускоряется при приеме дапсона вме-
сте с другими лекарствами, иногда
доступен только дапсон. Прием одного
дапсона часто дает хорошие резуль-
таты, но медленнее, поэтому лечение
должно быть долгим, по крайней мере
2 года, а иногда всю жизнь от проказы
лепроматус.

Иногда у больного при приеме
лекарств от проказы развивается се-
рьезная проблема, называемая "реак-
цией лепры". Могут быть опухоли или
воспаленные места, жар и распухшие
болезненные нервы. Она может вы-
звать боли в суставах, болезненные
лимфоузлы и яички, распухание рук и
ног или покраснение и боль глаз, что
может привести к потере зрения.

В случае тяжелой "реакции ле-
пры" (боли вдоль нервов, онемение
или слабость, раздражение глаз или
болезненные яички) лучше продол-
жить лечение проказы, но принимать
и противовоспалительные лекарства
(кортикостероиды). Обратитесь по
этому поводу за квалифицированным
медицинским советом, поскольку
кортикостероиды тоже могут вызвать
серьезные проблемы.

Дапсон (диаминодифенилсульфон,
DDS)

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выходит в: таблетках 50 и 100
мг.

Дапсон иногда вызывает анемию
или кожную сыпь, которая может быть
тяжелой. Если появляются тяжелые
кожные струпья, прекратите прием
лекарства.

ВНИМАНИЕ: DDS опасное лекарство.
Храните его там, куда не смогут
добраться дети.

Дозировка DDS – (2 мг/кг/день):

– применяя таблетку 100 мг –

Принимать один раз в день.

взрослым: 100 мг (одну 100 мг
таблетку)

детям от 13 до 18 лет: 50 мг
(половина

100 мг таблетки)

детям от 6 до 12 лет: 25 мг (четверть
100 мг таблетки)

детям от 2 до 5 лет: 25 мг (четверть
100 мг таблетки) только 3 раза в
неделю

Рифампин (рифампицин, рифамицин)

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выходит: в таблетках или капсулах
150 и 300 мг.

Рифампин – очень дорогое лекарство,
но его нужно применять для лечения
проказы только в очень маленьком ко-
личестве, поэтому общая стоимость не
очень высокая. См. с. 362 для побочных
эффектов и риска. Принимайте рифампин
только по совету опытного работника
здравоохранения или врача.

Дозировка рифампина от проказы –
(10-20 мг/кг): – применяя таблетки
300 мг.

От проказы давать рифампин 1 раз в
месяц. Его нужно принимать за 1 час до
еды или через 2 часа после еды.

Ежемесячная доза дается:

взрослым: 600 мг (две по 300 мг
таблетки)

детям от 8 до 12 лет: 450 мг (одна

и

половина 300 мг таблетки)

детям от 3 до 7 лет: 300 мг (одна
300 мг таблетка)

детям до 3 лет: 150 мг (половина
300 мг таблетки)

Клофазимин (Лампрен)

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выходит в: капсулах 50-100 мг.

Клофазимин - это тоже очень дорогое
лекарство. Хотя оно менее эффективно в
борьбе с бактерией проказы, чем рифам-
пин, у него есть преимущество в том, что
он помогает до некоторой степени кон-
тролировать реакцию лепры, особенно у
людей с проказой лепроматус.

Побочные эффекты: Вызывает красно-пурпурный цвет кожи. Это временное явление, которое будет исчезать в течение 1-2 лет после прекращения приема лекарства. Может вызвать желудочные проблемы. Не рекомендуется беременным женщинам.

Дозировка клофазимина – (1 мг/кг/день)
– для использования капсул по 50 мг.

Давайте 1 дозу клофазимина каждый день и вторую, большую один раз в месяц.

В каждой ежедневной дозе давайте:

взрослым: 50 мг (одну 50 мг капсулу)
детям от 8 до 12: 37 мг (3/4 50 мг капсулы)
детям от 3 до 7: 25 мг (1/2 50 мг капсулы)
детям до 3: 12 мг (1/4 50 мг капсулы).

В ежемесячном приеме давайте:

взрослым: 300 мг (шесть 50 мг капсул)
детям от 8 до 12: 225 мг (четыре и половину 50 мг капсулы)
детям от 3 до 7: 150 мг (три 50 мг капсулы)
детям до 3 лет: 75 мг (одна и половина 50 мг капсулы).

Примечание: Большую дозу клофазимина, которую нужно употреблять ежедневно, чтобы остановить реакцию лепры, лучше давать по совету опытного медработника или врача.

ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА ЛЕКАРСТВА ОТ МАЛЯРИИ

Есть несколько видов лекарств, которые борются с малярией. К сожалению, во многих частях света малярийные паразиты приспособились к лучшим лекарствам от малярии. Это особенно относится к очень тяжелому виду малярии (тропической малярии).

Очень важно узнать в министерстве здравоохранения или в центре здоровья, какие лекарства лучше действуют у вас. Разрабатываются новые лекарства, но уже существующие лекарства эффективны хоть на то время, пока к ним не выработалась устойчивость.

ВАЖНО: Малярия может быстро убить больных, у которых отсутствует иммунитет. Дети и люди, которые посещают места с малярией, должны немедленно лечиться.

Лекарства от малярии можно применять 2 способами:

1. **ЛЕЧЕНИЕ** человека, который болен малярией. Лекарство дается ежедневно в течение нескольких дней.

2. **ПРОФИЛАКТИКА:** Удерживать от нанесения вреда малярийных паразитов, находящихся в крови. Профилактика должна проводиться в местах распространения малярии, особенно для защиты детей, больных или слабых людей. Это относится и к тем, кто посещает малярийные области, не имея прививки от этой болезни. Лекарство обычно дается еженедельно. Для профилактики малярии следуйте совету на с. 187, чтобы избежать укусы москитов.

Некоторые противомаларийные лекарства применяются только для лечения приступов малярии, а некоторые – для профилактики. Другие можно применять в обоих случаях.

Как и в 1992, хлорохин – самое лучшее лекарство для профилактики и лечения малярии в Мексике, Центральной Америке и Гаити, но к нему уже тоже приспосабливаются, как и в других частях света – Южной Америке, Восточной Африке и особенно в Юго-Восточной Азии. Хинин – наилучшее лекарство для лечения тяжелых форм малярии и для лечения малярии, действующей на мозг.

Мефлохин – новое лекарство, используемое для предупреждения и лечения малярии, устойчивой к хлорохину. Фанзидар – это другое лекарство для лечения малярии, устойчивой к хлорохину. Прогунил принимают с хлорохином для профилактики. Примахин иногда принимают после лечения другими лекарствами от малярии, чтобы избежать повторения болезни. Тетрациклин сейчас иногда применяют для профилактики и лечения малярии.

Хлорохин

Хлорохин выпускают двух видов – хлорохина фосфат и хлорохина сульфат. Дозы различные, так что постарайтесь узнать, какой у вас тип хлорохина и какое количество лекарства (основа хлорохина) в таблетках.

В некоторых местах и от некоторых форм малярии нужны дополнительные лекарства для полного курса лечения.

ХЛОРОХИНА ФОСФАТ (торговые марки: Арален, Резохин, Авлохлор)

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выходит в: 250 мг таблетках (в которых 150 мг хлорохина) или 500 мг (в которых 300 мг хлорохина).

Дозировка хлорохина фосфата внутрь:
– принимая 250 мг таблетки –

Для лечения острых приступов малярии:

В первой дозе давайте:

взрослым: 4 таблетки (1000 мг)
детям от 10 до 15: 3 таблетки (750 мг)
детям от 6 до 9: 2 таблетки (500 мг)
детям от 3 до 5: 1 таблетка (250 мг)
детям от 1 до 2: 1/2 таблетки (125 мг)
малышам до 1 года: 1/4 таблетки (63 мг).

Затем давайте следующую дозу спустя 6 часов после первой, 1 день спустя после первой дозы и 2 дня спустя после первой дозы:

взрослым: 2 таблетки (500 мг)
детям от 10 до 15: 1 1/2 таблетки (375 мг)
детям от 6 до 9: 1 таблетку (250 мг)
детям от 3 до 5: 1/2 таблетки (125 мг)
детям от 1 до 2: 1/4 таблетки (63 мг)
малышам до 1 года: 1/8 таблетки (32 мг).

Для профилактики малярии (где она не приспособилась к хлорохину):

Давайте один раз в неделю, начиная за 1 неделю до и продолжая 4 недели после исчезновения малярии в этой местности:

взрослым: 2 таблетки (500 мг)
детям от 10 до 15: 1 1/2 таблетки (375 мг)
детям от 6 до 9: 1 таблетку (250 мг)
детям от 3 до 5: 1/2 таблетки (125 мг)
детям от 1 до 2: 1/4 таблетки (63 мг)
малышам до 1 года: 1/8 таблетки (32 мг)

ХЛОРОХИНА СУЛЬФАТ (торговая марка: Нивахин)

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выходит в: 200 мг таблетках (которые содержат 150 мг хлорохина)

Дозировка хлорохина сульфата внутрь:
200 мг таблетка.

Для лечения острых приступов малярии:

Первую дозу принимать:

взрослым: 4 таблетки (800 мг)
детям от 10 до 15: 3 таблетки (600 мг)
детям от 6 до 9: 2 таблетки (400 мг)
детям от 3 до 5: 1 таблетку (200 мг)
детям от 1 до 2: 1/2 таблетки (100 мг)
малышам до года: 1/4 таблетки (50 мг)

Затем принимайте следующую дозу спустя 6 часов после первой дозы:

взрослым: 2 таблетки (400 мг)
детям от 10 до 15: 1 1/2 таблетки (300 мг)
детям от 6 до 9: 1 таблетку (200 мг)
детям от 3 до 5: 1/2 таблетки (100 мг)
детям от 1 до 2: 1/4 таблетки (50 мг)
малышам до года: 1/8 таблетки (25 мг)

Для профилактики малярии:

Принимать один раз в неделю, начиная за 1 недели до и продолжая 4 недели после исчезновения малярии в этом месте:

взрослым: 2 таблетки (400 мг)
детям 10-15: 1 1/2 таблетки (300 мг)
детям 6-9: 1 таблетку (200 мг)
детям 3-5: 1/2 таблетки (100 мг)
детям 1-2: 1/4 таблетки (50 мг)
малышам до года: 1/8 таблетки (25 мг).

Для лечения абсцесса печени от амебы:

– принимая таблетки 250 мг хлорохина фосфата или 200 мг хлорохина сульфата –

взрослым: 3 или 4 таблетки дважды в день 2 дня и затем 1 1/2 или 2 таблетки ежедневно 3 недели.

Детям давайте меньше, исходя из их возраста и веса.

Хинин (хинина сульфат или хинина бисульфат)

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выходит в: таблетках 300 мг или 650 мг.

Хинин употребляют, чтобы лечить приспособленную малярию (не наступает улучшение при применении других лекарств) и тяжелую малярию, включая ту, которая поражает мозг. Его лучше принимать внутрь. Если при приеме хинина возникает рвота, может помочь прометазин.

Побочные действия: Хинин иногда вызывает потливость кожи, звон в ушах или двойной слух, неясное зрение, головокружение, тошноту, рвоту и понос.

Дозировка хинина для лечения приступов малярии:

—прием таблеток 300 мг —

Давать 3 раза в день 3 дня:

взрослым: 2 таблетки (600 мг)

детям 10-15 лет: 1 1/2 таблетки (450 мг)

детям 6-9 лет: 1 таблетку (300 мг)

детям 3-5 лет: 1/2 таблетки (150

мг)

детям 1-2 лет: 1/4 таблетки (75 мг)

малышам до 1 года: 1/8 таблетки (38 мг)

Примечание: В некоторых частях света таких, как Юго-Восточная Азия, необходимо применять хинин 7 дней.

Инъекции хинина и хлорохина: когда применять их:

Инъекции хинина или хлорохина следует применять только в редких случаях, срочных. Если больной с признаками малярии или живет в местах с малярией - рвет, припадки (конвульсии) или показывает признаки менингита (см. с. 185), у него может быть церебральная малярия (малярия мозга). Делайте инъекцию хинина сразу. (Или если у вас нет доступного другого лекарства, сделайте инъекцию хлорохина). Надо быть очень осторожным, чтобы выбрать правильную дозу. Обратитесь за медпомощью.

ИНЪЕКЦИИ ДИХЛОРИДА ХИНИНА, 300 мг в 2 мл:

Инъекции хинина должны вводиться медленно и не прямо в вену - это может повлиять на сердце. Особенно будьте осторожны с детьми.

Вводите половину этой дозы в каждую ягодицу. Перед инъекцией оттяните назад поршень: если появляется кровь, сделайте инъекцию в другую сторону. Повторите эту дозу спустя 12 часов:

взрослым: 600 мг (2 ампулы 2 мл)

детям: 0.7 мл (1/15 мл или 10 мг) на каждый кг веса ребенка (на ребенка 1 года, который весит 10 кг нужно 70 мл).

ИНЪЕКЦИИ ХЛОРОХИНА, 200 мг в 5 мл:

Сделайте эту дозу 1 раз только (инъекция 1/2 в каждую ягодицу):

взрослым: 200 мг (вся ампула 5 мл)

детям: введите 0.1 мл (1/10 мл) на каждый кг веса ребенка (ребенку 1 года, который весит 10 кг нужно 1 мл).

Дозу можно повторить спустя 1 день, если нет улучшения.

Мефлохин (торговая марка: Лариам)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выпускается в: таблетках 250 мг.

Мефлохин может предупредить и остановить острые приступы малярии, которая приспособилась к хлорохину.

Предосторожности и побочные эффекты: Его нельзя принимать беременным женщинам или больным эпилепсией. Сердечникам или психическим больным перед приемом лекарства следует посоветоваться с опытным медработником. Мефлохин вызывает иногда странное поведение, смятение, головокружение, расстройство желудка, головную боль, проблемы зрения и иногда признаки или потерю сознания.. Принимать с большим количеством еды. Побочные эффекты возникают при большой дозе при лечении.

Дозировка мефлохина:

Для лечения острого приступа малярии:

Принимайте один раз:

взрослым: 5 таблеток (1250 мг)

детям 10-15 лет: 4 таблетки (1000 мг)

детям 8-11 лет: 3 таблетки (750 мг)

детям 5-7 лет: 2 таблетки (500 мг)

детям 1-4 лет: 1 таблетку (250 мг)

детям до 1 года: 1/2 таблетки (125 мг)

Для профилактики малярии:

Принимать один раз в неделю, пока не пройдет 4 недели после исчезновения малярии в этом месте.

взрослым: 1 таблетку (250 мг)

детям выше 45 кг: 1 таблетку (250 мг)

детям 31-45 кг: 3/4 таблетки (188 мг)

детям 20-30 кг: 1/2 таблетки (125 мг)

детям 15-19 кг: 1/4 таблетки (63 мг)

детям до 15 кг: не рекомендуется.

Пириметамин с сульфадоксином (Фанзидар)

Название: _____ цена: _____ за _____

Выпускается в комбинированных
таблетках 25 мг пириметамина и
500 мг сульфадоксиона.

Фанзидар употребляется для лечения
приспособленной малярии.

ВНИМАНИЕ:: Фанзидар не следует употре-
блять людям, у которых была реакция на
сульфамидные лекарства. Если лекарство
вызывает сыпь или зуд, пейте много воды и
прекратите прием лекарства снова.

Дозировка для лечения острого приступа
малярии:

Дайте 1 раз:

взрослым: 3 таблетки
детям 9-14 лет: 2 таблетки
детям 4-8 лет: 1 таблетку
детям 1-3 года: 1/2 таблетки
малышам до 1 года: 1/4 таблетки

Прогуанил (Палудрин)

Название: _____ цена: _____ за _____

Выходит в: таблетках по 100 мг.

Прогуанил принимают с хлорохином для
предупреждения сопротивления малярии
хлорохину. Это лекарство не употребляют
для лечения острых приступов малярии.

Дозировка прогуанила для профилактики:

Применяйте лекарство каждый день,
начиная со дня появления малярии в
вашем месте, пока не пропадет малярия
спустя 28 дней.

взрослым: 2 таблетки (200 мг)
детям 9-14 лет: 1 1/2 таблетки
(150 мг)
детям 3-6 лет: 1 таблетку (100 мг)
детям 1-2 лет: 1/2 таблетки (50 мг)
малышам до 1 года: 1/4 таблетки
(25 мг)

Примахин

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выпускается в: таблетках 26.3 мг
примахина фосфата, который
содержит 5 мг примахина основы.

Примахин обычно употребляется
после лечения хлорохином или другим
лекарством от малярии, чтобы она не
вернулась назад. Примахин сам по себе
не лечит острые приступы.

Побочные действия: Не следует упо-
треблять беременным женщинам. У
некоторых людей, особенно темных, вы-
зывает анемию. Обратитесь за местным
советом.

Дозировка примахина:

Принимайте один раз в день 14 дней.

В каждой дозе принимайте:

взрослым: 1 таблетку (основа 15 мг)
детям 8-12 лет: 1/2 таблетки
(основа 7 мг)
детям 3-7 лет: 1/4 таблетки
(основа 4 мг).

Тетрациклин

Тетрациклин можно употреблять,
чтобы лечить острые приступы малярии
в Юго-Восточной Азии и некоторых ме-
стах, где существует малярия с сопро-
тивлением хлорохину, т.к. он действует
медленно, его следует давать с другими
лекарствами (обычно хинином). Те, кото-
рые посещают эти места, употребляют
доксциклин ежедневно для предупреж-
дения. См. с. 356 дозы тетрациклина и
доксциклина, риск и предосторожности.

ОТ АМЕБЫ И ЛЯМБЛИИ

При поносе или дизентерии, вы-
званных амебой, часто бывает стул со
слизью и кровью. Бывают часто спазмы
кишечника, но иногда жар, иногда без
него. Амебная дизентерия лучше лечится
метронидазолом вместе с дилоксанида
фуроатом или тетрациклином. Иногда
употребляют хлорохин, когда метрони-
дазол не доступен или в случае амебного
абсцесса. Иодохинол - это другое лекар-
ство, которое употребляют для лечения
амебной дизентерии, но у него побочные
опасные действия.

Чтобы убить всех амеб в кишечнике,
необходимо длительное (2-3 недели) и
дорогое лечение. Часто имеет смысл
прекратить лечение лекарствами, когда
у человека исчезнут симптомы, а затем
пусть организм сам борется с оставши-
мися амебами. Это особенно относится
к тем регионам, где большой риск приоб-
рести ее снова.

Если понос от лямблии, стул часто желтый и пенистый, но без крови и слизи. Часто применяют метронидазол, но Хинакрин дешевле.

Метронидазол (торговая марка: Флагил)

Название: _____

Часто выпускается в:

таблетках 200, 250 или 500 мг

Цена: _____ за _____

тампонах во влагалище, 500 мг

Цена: _____ за _____

Метронидазол употребляется от инфекции кишечника, вызванной амебой и лямблией и иногда от поноса, который появляется от антибиотиков широкого действия (такие как ампициллин). Он также употребляется от влагалищных инфекций, вызванных трихомонусом или какими-то определенными бактериями. Он может также помочь лечить симптомы ришты.

ОСТОРОЖНО: Не употребляйте алкогольные напитки, когда принимаете метронидазол, так как он вызывает сильную тошноту.

ВНИМАНИЕ: Метронидазол может вызывать дефекты при родах. Беременным женщинам следует избегать употребление этого лекарства, если возможно, особенно первые 3 месяца беременности. Те, которые кормят детей грудью, не должны кормить грудью детей 24 часа после приема метронидазола. Люди, у которых больна печень, не должны принимать это лекарство.

Дозировка от амебной дизентерии – (25-50 мг/кг/день): –прием 250 мг таблетки–

Принимать 3 раза в день 5-10 дней.

В каждой дозе приема:

взрослым: 750 мг (3 таблетки)

детям 8-12 лет: 500 мг (2 таблетки)

детям 4-7 лет: 375 мг

(1 1/2 таблетки)

детям 2-3 лет: 250 мг (1 таблетка)

детям до 2 лет: 80-125 мг (1/3 - 1/2 таблетки).

Дозировка при инфекции лямблии:

Принимать 3 раза в день 5 дней.

В каждой дозе приема:

взрослым: 250 мг (1 таблетка)

детям 8-12 лет: 250 мг (1 таблетка)

детям 3-7 лет: 125 мг (1/2 таблетки)

детям до 3 лет: 62 мг (1/4 таблетки).

Дозировка от ришты:

Принимайте ту же дозу, как от лямблии, 3 раза в день 10 дней.

Дозировка от инфекции трихомонуса во влагалище:

Женщинам следует принимать 8 таблеток (2 г) в рот одной дозы. Или если инфекция несерьезная, она может сделать тампоны во влагалище дважды в день 10 дней. Оба, как мужчина, так и женщина должны лечиться в одно и то же время. (Он должен это делать даже, если нет симптомов или может снова заразить женщину).

Дозировка от бактериальной инфекции во влагалище:

Женщине следует принимать 2 таблетки (500 мг) метронидазола дважды в день 5 дней. Если инфекция появится снова и женщина, и мужчина должны принять одно и то же лечение в одно время.

Дилоксанида фуруат (Фурамид)

Часто выпускается в: 500 мг таблетках и в виде сиропа 125 мг в 5 мл.

Название: _____ цена: _____ за _____

Дилоксанида фуруат употребляется, чтобы лечить амебную дизентерию вместе с метронидазолом и тетрациклином.

Побочные действия: Иногда вызывает газ, боль в желудке или тошноту.

Дозировка дилоксанида фуруата–

(20 мг/кг/день): – таблетки 500 мг –

Принимать 3 раза в день с едой. Для полного излечения принимать 10 дней.

В каждой дозе приема:

взрослым: 1 таблетка (500 мг)

детям 8-12 лет: 1/2 таблетки

(250 мг)

детям 3-7 лет: 1/4 таблетки (125 мг)

детям до 3 лет: 1/8 таблетки (62 мг)

или меньше в зависимости от веса.

Тетрациклин (см. с. 356)

Хлорохин (см. с. 366).

Хинакрин (мепакрин)
(торговая марка: Атабрин)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выпускается в: 100 мг таблетках.

Хинакрин часто употребляют для лечения лямблии, малярии, ленточных глистов (солитера), но не самое лучшее лекарство от этих болезней. Оно принимается, потому что дешевое. Хинакрин часто вызывает головную боль, головокружение или рвоту.

Дозировка хинакрин для лечения лямблии:

Принимать 3 раза в день неделю. В каждой дозе принимать:

взрослым: одну 100 мг таблетку
детям до 10 лет: 50 мг (1/2 таблетки).

Дозировка для лечения солитера:

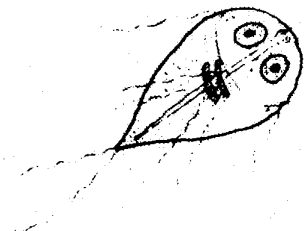
(За полчаса до приема хинакрин, принять антигистамин такой, как прометазин, чтобы помочь предупредить рвоту).

Давать только одну дозу:

взрослым: 1 г (10 таблеток)
детям 8-12 лет: 600 мг (6 таблеток)
детям 3-7 лет: 400 мг (4 таблетки)

Гидроксифинолины (клиохинол, йодохинол, ди-йодогидрохинолин, галхинол, броксифинолин) (торговые марки: Диодохин, Амиклин, Флорахин, Энтерохинол, Хлорамбин, Нивембин, Квогил, Энтеро-Виоформ и многие другие марки).

Эти лекарства были обычными в прошлом для лечения поноса. Они известны тем, что вызывают постоянный паралич, слепоту и даже смерть. Не употребляйте эти опасные лекарства. (См. с. 51).



ОТ ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Вагинальные выделения, зуд и дискомфорт могут быть вызваны различными инфекциями, самые обычные из них трихомониаз, дрожжевая (кандида, монилиоз) и бактериальная инфекции. Чистота и спринцевание уксусной водой (вагинальное подмывание) помогут от многих влагалищных инфекций. Специальные лекарства уже перечислены выше.

Белый уксус для спринцевания (подмывания)

Цена: _____ за _____

Смешайте 2 и 3 столовые ложки белого уксуса в 1 л кипяченой воды. Как показано на с. 241 делайте от 1 до 3 спринцеваний в день неделю, затем через день. Это особенно хорошо действует на вагинальные инфекционные бактерии.

Метронидазол, таблетки принимать внутрь и тампоны во влагалище (см. с. 369):

От трихомониаза и бактериальных инфекций во влагалище. (Только употребляйте метронидазол от бактериальных инфекций, если не действует спринцевание уксуса с водой).

Нистатин или Миконазол таблетки, крем и тампоны во влагалище (см. с. 373):

От дрожжевой инфекции (кандида, монилиоз) влагалища.

Генциан-виолет (кристалл-виолет) 1% раствор (см. с. 371):

Цена: _____ за _____

Для лечения дрожжевой инфекции (кандида, монилиоз) и другой инфекции вульвы и влагалища.

Смазывайте генциан-виолетом ежедневно в течение 3 недель.

Провидон йодина (Бетадин)

Цена: _____ за _____

Для лечения бактериальных инфекций во влагалище. Смешайте 2 столовые ложки провидона йодина в 1 л теплой кипяченой воды. Как показано на с. 241, делайте 1 спринцевание в день 10-14 дней.

ОТ КОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Мытье рук и частое купание мылом и водой помогает предупредить многие инфекции, как на коже, так и в кишечнике. Раны следует тщательно промыть мылом, кипяченой водой перед тем, как их закрыть или завязать.

Частое мытье мылом и водой – единственное необходимое лечение от перхоти, шапеси (себореи), угрей, легкого импетиго, так же как и от стригущего лишая, опоясывающего лишая и других грибковых инфекций кожи головы. Для этих целей лучше, если мыло имеет антисептики, такие как йодин, провидон йодина (Бетадин). Но Бетадин может раздражать кожную ткань и не следует употреблять на открытую кожу.

Сера

Часто выпускается в желтых порошка.

Цена: _____ за _____

Также выходит во многих кожных примочках или мазях.

Сера полезна для многих кожных болезней.

1. Избежать или избавиться от разного вида клещей и блох. Перед выходом в поле, лес, где их много, смажьте кожу - особенно ноги или колени, кисти (запястья рук), талию и шею - серой.
2. Помогает лечить чесотку, норных блох, все виды клещей внутри или на коже. Сделайте мазь. Смешайте 1 часть серы и 10 частей вазелина или жира и смажьте этой смесью кожу (см. с. 200).
3. От стригущего и опоясывающего лишая и других грибковых инфекций пользуйтесь той же мазью 3,4 раза в день или примочкой из серы и уксуса (см. с. 205).

4. От себореи (младенческой кепки) и сильной перхоти та же самая мазь может быть использована или голову можно смазать серой.

Генциан-виолет (кристалл-виолет)

Часто выпускаются темно-синие кристаллы.

Цена: _____ за _____

Генциан-виолет (горечавка фиолетовая) помогает бороться против определенных кожных инфекций, включая импетиго или язвы с гноем. Можно также лечить дрожжевую инфекцию (кандида, молилиз) во рту (молочница) или в вульве или складках кожи.

Растворите чайную ложку горечавки фиолетовой в половине литра воды. Это получится 2% раствор. Смазывайте кожу или во рту или в вульве.

Антибиотиковые мази

Название: _____ цена: _____ за _____

Они дорогие и часто приносят не больше пользы, чем горечавка фиолетовая. Однако они не красят кожу или одежду и лечат более легкие болезни, такие как импетиго. Хорошая мазь – это одна из тех, что содержат комбинацию неомицин/полимиксин (например, Неоспорин или Левосин). Можно употреблять мазь тетрациклина.

Кортикостероидные мази или примочки

Название: _____ цена: _____ за _____

Они могут употребляться от “текущих” или сильно зудящих кожных раздражений, вызванных укусом, прикосновением к определенным ядовитым растениям и другими вещами. Они также полезны при лечении сильной экземы (см. с. 216) и псориаза (с. 216). Употребляйте 3 или 4 раза в день. Избегайте применения на долгий период.

Нефтяное желе (нефть, Вазелин)

Цена: _____ за _____

Полезно для приготовления мази или повязки при лечении:

чесотки (см. с. 199 и 373)
стригущего лишая (с. 372)
зуда от остриц (с. 141)
ожогов (с. 96 и 97)
ран груди (с. 91)

ОТ СТРИГУЩЕГО ЛИШАЯ И ДРУГИХ ГРИБКОВЫХ ИНФЕКЦИЙ

От многих грибковых инфекций очень трудно избавиться. Для полного исцеления лечение должно продолжаться много дней или недель после того, как исчезнут признаки. Важна чистота и купание.

Мази с ундециленовой, бензойной или салициловой кислотой

Название: _____ цена: _____ за _____

Мази с этими кислотами можно употреблять для лечения лишая, опоясывающего голову и другой инфекции на голове. Часто они могут быть скомбинированы с серой. Мази с салициловой кислотой и серой могут лечить себорею (младенческую кепу).

Вайтфилда мазь - это сочетание салициловой и бензойной кислот. Очень полезна от грибковых заболеваний, включая опоясывающий разноцветный лишай. Применяется дважды в день 2-4 недели.

Мази и примочки дешевле, если делаете их сами. Смешайте 3 части салициловой кислоты и/или 6 частей бензойной кислоты и 100 частей Вазелина, нефти, минерального масла, сала или 40% спирта (или рома). Втирайте в кожу 3-4 раза в день.

Сера и уксус

Примочки из 5 частей серы и 100 частей уксуса, помогают в борьбе против грибковой инфекции кожи. Высушите на коже. И еще мазь можно приготовить, употребив 1 часть серы и 10 частей жира.

Натрия тиосульфат (гипо)

Выпускается в виде белых кристаллов, продается в фотомагазинах как "гипо".

Цена: _____ за _____

Употребляется от инфекции лишая разноцветного на коже (см. 216).

Растворите столовую ложку "гипо" в 1/2 чашке воды и нанесите на кожу кусочком ваты или ткани. Затем потрите кожу кусочком ваты, смоченной в уксусе. Делайте дважды в день, пока пятна не исчезнут и затем снова каждые 2 недели, чтобы болезнь не вернулась.

Селена сульфид (Сельсун, Эксел)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выпускается в виде примочек, содержит 1 и 2.5 процента сульфида селена.

Примочки с этим лекарством полезны для лечения разноцветного опоясывающего лишая. Смажьте пораженные места и смойте после 30 минут. Применяйте ежедневно одну неделю.

Толнафат (Тинактин)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выходит в виде крема, пудры и 1 % раствора толнафата.

Он может применяться для лечения грибковых инфекций, вызываемых грибом на ногах, паху, голове, руках и на теле. Смазывайте дважды в день 2 недели пока все симптомы не пройдут.

Гризеофульвин

Название: _____ цена: _____ за _____

Выпускается в: таблетках или капсулах 250 мг или 500 мг.

Лучше всего мелкокристаллическая форма препарата.

Это очень дорогое лекарство и его следует применять только при очень сильных грибковых инфекциях кожи и глубокой грибковой инфекции головы. Еще применяется при грибковых поражениях ногтей, но следует применять месяцами и не всегда действует. Следует избегать гризеофульвина беременным женщинам.

Дозировка гризеофульвина –

(15 мг/кг/день): – в мелкокристаллической форме, 250 мг капсулы –

Принимать один раз в день по крайней мере месяц.

взрослым: 500 или 1000 мг (2-4 капсулы)

детям 8-12 лет: 250 или 500 мг (1-2 капсулы)

детям 3-7 лет: 125 - 250 мг (1/2 или 1 капсулу)

детям до 3 лет: 125 мг (1/2 капсулу).

Генциан-виолет – от дрожжевых инфекций (см. с. 371)

Нистатин или Миконазол

Название: _____ цена: _____ за _____

Выпускается в: растворах, порошках, влагалищных таблетках, мазях и кремах

Применяется для лечения дрожжевых инфекций (кандида, монилиоз) во рту (молочница), во влагалище или в складках кожи. Нистатин действует только на инфекции, вызванные дрожжевым грибом, а миконазол действует против других инфекций.

Доза нистатина и миконазола – одинакова для взрослых и детей.

Молочница во рту: возьмите в рот 1 мл раствора и держите там по крайней мере 1 минуту перед тем, как проглотить. Делайте 3-4 раза в день.

Дрожжевой грибок на коже: высушите, а затем прикладывайте мазь или порошок нистатина или миконазола 3-4 раза в день.

Дрожжевая инфекция в вульве или влагалище: вкладывайте крем во влагалище дважды в неделю или таблетку внутрь влагалища на ночь в течение 10-14 дней.

ОТ ЧЕСОТКИ И ВШЕЙ: ИНСЕКТИЦИДЫ

Гамма бензил гексахлорид (линдан) (торговые марки: Квелл, Гаммезан)

Название: _____ цена: _____ за _____

Препарат выходит в дорогих упаковках для людей и дешевых для животных, который действует так же как на людей. Линдан для овец или крупного скота - дешевый, но часто выпускается концентрированный в 15% растворе и должен быть разбавлен до 1%. Смешайте 1 часть 15% линдана концентрированного с 15 частями воды или Вазелина и применяйте на кожу от чесотки, следуя инструкциям на с. 199. От вшей головы см. с. 200.

ОСТОРОЖНО: Линдан ядовит и может вызвать побочные действия, включая припадки у детей. Не злоупотребляйте им. Применяйте только один раз; если необходимо, повторите через неделю.

Бензил бензоат, крем или примочки

Название: _____ цена: _____ за _____

Применяйте так же, как гамма бензил гексахлорид (линдан) крем или примочки.

Сера в желе из нефти (Вазелин) или в сале

Пользуйтесь от вшей, если не можете достать вышеупомянутые препараты.

Смешайте 1 часть серы и 20 частей Вазелина, минерального масла или сала, чтобы сделать 5% серную мазь.

Пиретрины с пиперонилом (RID)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выпускают как жидкий раствор, содержащий пиретрины и пиперонил бутоксид.

Хорошо действует на все виды вшей и безопаснее гамма гексахлорида. Без добавления воды наносите жидкость на сухие волосы, пока полностью не смочите их. (Не намазывайте брови и ресницы). Подождите 10 минут, не больше. Вымойте голову теплой водой с мылом или шампунем. Повторите через 1 неделю. Чтобы избавиться от гнид (яйца вшей), см. с. 200.

Кротамитон (Эуракс)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выпускается как крем или примочки содержит 10% кротамитон.

Кротамитон применяется для лечения только чесотки, не вшей. После купания нанесите на все тело от подбородка до пальцев ног - не пропускайте складки и втирайте в кожу. На следующий день можно повторить процедуру. Примите ванну или душ, чтобы очиститься от крема или примочек, через 2 дня после последней обработки. Нужно менять одежду и постельные принадлежности.

ОТ БОРОДАВОК НА ПОЛОВЫХ ОРГАНАХ

Подofilлин

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выпускается в растворах,
содержащих 10-25 % подофилина,
смешанного с бензойной смолой.

Он употребляется для того, чтобы
усохли бородавки на половых органах.
Подofilлин раздражающе действует на
здоровую кожу, поэтому надо обращаться
с ним осторожно. Перед применением
намажьте кожу вокруг бородавки желе из
нефти (Вазелином) или другой жирной ма-
зью. Приложите раствор на бородавку и
дайте полностью высохнуть. (Это особен-
но важно для тех мест, где нормальная
кожа такая, как крайняя плоть у пениса,
соприкасается с бородавкой). Тщательно
смойте через 4 или 6 часов. Лечение мож-
но повторить через 1 неделю. Обычно на
лечение требуется несколько недель.

ОСТОРОЖНО: Если появилось сильное
кожное раздражение, не пользуйтесь
больше. Подofilлин не должен при-
меняться на кровоточащие бородавки.
Беременным женщинам или кормящим не
следует им пользоваться.

Двуххлоруксусная кислота

Название: _____ цена: ____ за ____

Выпускается как прозрачная жидкость.
Если подофилин недоступен, можно
пользоваться двуххлоруксусной кислотой,
чтобы убрать бородавки. Но она тоже
действует на здоровую кожу, поэтому при-
менять нужно осторожно. Предохраняйте
кожу вокруг бородавки Вазелином или
другой жирной мазью. Осторожно уберите
мертвую ткань с большой или толстой бо-
родавки. Зубочисткой нанесите маленькую
каплю кислоты на бородавку. Осторожно
размажьте кислоту по бородавке кончиком
зубочистки. Обычно требуется несколько
еженедельных сеансов лечения.

ОСТОРОЖНО: Эта кислота вызывает
сильные ожоги. Защищайте руки и другие
здоровые участки кожи от кислоты и смы-
вайте сразу в случае контакта.

ОТ ГЛИСТОВ

Лекарств самих по себе недостаточно,
чтобы избавиться от глистов надолго.
Правила личной и общественной гигиены
должны соблюдаться обязательно. Когда
у 1 человека в семье есть глисты, будет
мудро лечить всю семью.

Мебендазол (Вермокс) – от многих
различных глистных инфекций

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выпускается в таблетках 100 мг.

Это лекарство действует против гли-
стов, хлыстовиков, аскарид, нитяных и
других глистов, называемых стронгилида-
ми. Действует лучше в случаях смешан-
ных инфекций. Может хорошо действовать
от трихинеллеза. При лечении от глистов
могут быть боли в кишках, понос, но побоч-
ных эффектов почти не наблюдается.

ВНИМАНИЕ: Не давайте мебендазол бе-
ременным женщинам или детям до 2 лет.

Дозировка мебендазола– используя 100
мг
таблетки –

Дозы одинаковые для детей и
взрослых.

От остриц: одна таблетка один раз в
неделю 3 недели.

От аскарид, хлыстовиков и стронгилд:
1 таблетка дважды в день (утром и вече-
ром) 3 дня (всего 6 таблеток).

Альбендазол (Зентел) – от многих
различных глистных инфекций

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выпускают в: таблетках по 200 или
400 мг.

Это лекарство похоже на мебендазол,
но очень дорогое. Работает против гли-
стов, хлыстовиков, стронгилд, аскарид и
остриц. Побочные эффекты очень редки.

ВНИМАНИЕ: Не давайте его беременным
женщинам и детям до 2 лет.

Дозировка альбендазола – прием 200 мг таблеток –

Одинаковая доза детям и взрослым.

От остриц, аскарид, хлыстовиков и нематод 400 мг (2 таблетки) один раз.

От стронгилид: 400 мг (2 таблетки) дважды в день 3 дня и повторите спустя неделю.

Пиперазин – от аскарид и остриц

Название: _____

Выпускается как пиперазина цитрат, тартрат, гидрат, адипат или фосфат.

Часто выходит в:

500 мг таблетках Цена: ____ за ____
микстуре 500 мг в 5 мл Цена: ____ за ____

Большая доза дается 2 дня от аскарид, потом маленькие дозы 1 неделю от нитяных. Мало побочных действий.

Дозировка пиперазина от аскарид – (75 мг/кг/день): – 500 мг таблетки или микстура 500 мг в 5 мл –

Давать один раз в день 2 дня:

взрослым: 3500 мг (7 таблеток или 7 чайных ложек)
детям 8-12 лет: 2500 мг (5 таблеток или 5 чайных ложек)
детям 3-7 лет: 1500 мг (3 таблетки или 3 чайных ложки)
детям 1-3: 1000 мг (2 таблетки или 2 чайных ложки)
малышам до 1 года: 500 мг (1 таблетку или 1 чайную ложку)

Дозировка пиперазина от остриц – (40 мг/кг/день):

Давать 2 дозы ежедневно 1 неделю.

взрослым: 1000 мг (2 таблетки или 2 чайные ложки)
детям 8-12 лет: 750 мг (1 1/2 таблетки или 1 1/2 чайные ложки)
детям 3-7 лет: 500 мг (1 таблетку или 1 чайную ложку)
детям до 3 лет: 250 мг (1/2 таблетки или 1/2 чайной ложки)

Тиабендазол – от многочисленных глистных инфекций

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выпускается в: 500 мг таблетках или микстурах 1 г в 5 мл.

Из-за того, что тиабендазол вызывает больше побочных действий, чем мебендазол или альбендазол, его можно применять только от глистов, когда эти лекарства недоступны или инфекция от глистов вне кишечника.

Он может применяться для лечения нематод, хлыстовиков или других глистов, называемых стронгилидами. Он действует на аскариды и нитяных червей, но пиперазин меньше оказывает побочных действий. Он может быть полезным в лечении ришты и в лечении от трихинеллеза.

ОСТОРОЖНО: Тиабендазол может заставить аскариды выходить из горла. Это может блокировать дыхание. Поэтому если вы знаете, что у человека есть аскариды в добавление к другим глистам, будет мудро сначала лечить пиперазином перед тем, как дать тиабендазол.

Побочные эффекты: Тиабендазол часто вызывает усталость, слабость и иногда рвоту.

Дозировка тиабендазола – (25 мг/кг/день): – 500 мг таблетки или микстура 1 г в 5 мл –

Давать дважды в день 3 дня. Таблетки следует жевать.

В каждой дозе давайте:

взрослым: 1500 мг (3 таблетки или 1 1/2 чайных ложки)
детям 8-12 лет: 1000 мг (2 таблетки или 1 чайную ложку)
детям 3-7 лет: 500 мг (1 таблетку или 1/2 чайной ложки)
детям до 3 лет: 250 мг (1/2 таблетки или 1/4 чайной ложки)

Пирантел (Антиминт, Кобрантрил, Гелмекс)

Название: _____

Выпускается как памоат или эмбонат.

Часто выпускается в:

250 мг таблетках Цена: _____ за _____

микстурах 250 мг в 5 мл Цена: _____ за _____

Это лекарство действует на остриц, нематод и аскарид, но может быть очень дорогим. Пирантел иногда вызывает рвоту, головокружение или головную боль.

Дозировка пирантела – (10 мг/кг/день):
– прием 250 мг таблеток–

От нематод и аскарид дайте один раз.
От остриц повторите дозу через 2 недели.

В каждой дозе примите:

взрослым: 750 мг (3 таблетки)
детям 10-14 лет: 500 мг (2
таблетки)
детям 6-9 лет: 250 мг (1 таблетку)
детям 2-5 лет: 125 мг (1/2
таблетки)
детям до 2 лет: 62 мг (1/4
таблетки)

ОТ СОЛИТЕРА

Есть несколько видов солитера. Никлозамид действует в основном на большинство из них, а празиквантел – является еще одним хорошим лекарством.

Никлозамид (Йомесан) – от инфекций солитера

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выпускается в: таблетках 500 мг (разжевывать).

Никлозамид возможно самое лучшее лекарство против солитера. Оно действует против основных видов солитеров в кишечнике, но не против цист вне кишечника.

Дозировка никлозамида от солитера – 500 мг таблетки:

Хорошо разжуйте и проглотите одну только дозу. Не ешьте до этого или спустя 2 часа после приема лекарства. Давая слабительное может помочь избавиться от солитера.

взрослым и детям старше 8 лет:

2 мг (4 таблетки)

детям 2-8 лет: 1 мг (2 таблетки)

детям до 2 лет: 500 мг (1 таблетку)

Празиквантел (Билтрицид, Дронцит)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выпускается в: таблетках 150 мг и 600 мг

Празиквантел очень эффективен в лечении многих типов солитеров, но он дороже, чем никлозамид.

ВНИМАНИЕ: Беременным женщинам и детям до 4 лет не следует принимать его. Кормящим матерям не следует кормить детей грудью, пока они принимают празиквантел и 72 часа после приема (сцедите молоко и вылейте его).

Побочные действия: Празиквантел может вызвать усталость и головокружение, головную боль и потерю аппетита, но эти побочные действия редкие при маленькой дозе для лечения солитера.

Дозировка празиквантела от солитера–
(10-20 мг/кг):
–принимая 600 мг таблетки–

Принимать один раз только

взрослым: 600 мг (1 таблетку)

детям 8-12 лет: 300 мг (1/2

таблетки)

детям 4-7 лет: 150 мг (1/4 таблетки)

Если не действует это лечение, у вас может быть другой тип солитера (карликовый или H.papa), которому требуется больше доза:

Принимать только один раз:

взрослым: 1500 мг (2 1/2 таблетки)

детям 8-12 лет: 600 - 1200 мг

(1-2 таблетки)

детям 4-7 лет: 300 - 600 мг (1/2-1 таблетку)

Хинакрин (мепакрин, Атабрин) от солитера см. с. 370

ОТ ШИСТОСОМАТОЗА (КРОВЯНЫЕ ЧЕРВИ, БИЛГАРЦИОЗ)

В различных странах мира есть разные типы шистосомоза, которым требуется разное лечение. Празиквантел действует против всех форм болезни. Метрифонат и оксамнихин эффективнее против некоторых видов шистосомоза. Лекарство нужно принимать под присмотром опытного медработника.

Празиквантел (Битрицид, Дронцит)

Название: _____ цена: _____ за _____

ВНИМАНИЕ: Беременным женщинам не следует принимать празиквантел. Кормящим матерям следует прекратить кормить детей грудью во время приема празиквантела и 72 часа после приема (сцеживайте молоко и выливайте). Не давайте празиквантел детям до 4 лет.

Побочные действия: Празиквантел может вызвать усталость, головокружение, головную боль и потерю аппетита, но при появлении этих эффектов лечение не следует прекращать. Для уменьшения побочных эффектов празиквантел лучше всего принимать во время еды.

Дозировка празиквантела от шистосомоза –(40 мг/кг): –600 мг таблетки–

Для лечения шистосомоза, который вызывает кровь в моче (*S. hematobium*), дать одну дозу:

взрослым: 2400-3000 мг (4-5 таблеток)

детям 8-12 лет: 1200-1800 мг (2-3 таблетки)

детям 4-7 лет: 600 мг (1 таблетку)

Приведенные дозы будут лечить и еще один вид шистосомоза, обнаруженный в Восточной и Центральной Африке и Южной Америке, который вызывает кровь в стуле (*S. mansoni*). Но в Восточной Азии для шистосомоза, вызывающего кровь в стуле (*S. japonicum*), нужна большая доза (60 мг/кг):

Принимать в один день:

взрослым: 3600-4200 мг (6-7 таблеток)

детям 8-12 лет: 1800-2400 мг (3-4 таблетки)

детям 4-7 лет: 900 мг (1 1/2 таблетки)

(Чтобы уменьшить побочные действия, это количество можно разделить на 3 маленькие дозы и дать за один день).

Метрифонат (Метрифонат, Биларцил)

Метрифонат – самое дешевое лекарство для лечения шистосомоза, который вызывает появление крови в моче (*S. hematobium*). Нельзя употреблять его беременным женщинам.

Название: _____ цена: _____ за _____

Выпуск в: 100 мг таблетках

Дозировка метрифоната от шистосомоза– (7.5-10 мг/кг на дозу):

–100 мг таблетки–

Дайте 3 дозы – интервал 2 недели.

В каждой дозе прием:

взрослым: 400-600 мг (4-6 таблетки)

детям 6-12 лет: 300 мг (3 таблетки)

детям 3-5 лет: 100 мг (1 таблетку)

Оксамнихин (Ванзил, Манзил)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выпускают в:

капсулах 250 мг Цена: _____ за _____

сироп 250 мг в 5 мл Цена: _____ за _____

Оксамнихин употребляют для лечения шистосомоза, который вызывает кровь в стуле в Южной и Центральной Америке (*S. mansoni*). (Чтобы лечить *S. mansoni*, обнаруженного в Африке, нужна большая доза, чем дается выше.) Это лекарство принимать после еды.

ВНИМАНИЕ: Нельзя принимать его беременным. Оно может вызвать головокружение, сонливость, припадки, но редко. Людям с эпилепсией следует принимать оксамнихин вместе с лекарством от эпилепсии.

Дозировка оксамнихина– (взрослым: 15 мг/кг/день, детям: 10 мг/кг/дважды в день):

–250 мг капсулы–

Принимать только один день.

Для взрослых давать 750-1000 мг (3 или 4 капсулы) в одной дозе.

Для детей давайте следующую дозу дважды в день:

детям 8-12 лет: 250 мг (1 капсулу)

детям 4-7 лет: 125 мг (1/2 капсулы)

детям 1-3 лет: 68 мг (1/4 капсулы)

ОТ РЕЧНОЙ СЛЕПОТЫ (ОНХОЦЕРКОЗ)

Самое лучшее лекарство для лечения речной слепоты – это ивермектин. Это новое лекарство убивает зародыши червей медленно и не вызывает опасных реакций, как другие лекарства. Если ивермектин недоступен, опытный медработник может дать сначала диэтилкарбамазин, а затем сурамин.

Ивермектин (Мектизан)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выпускается в: таблетках 6 мг

Чтобы выбрать правильную дозу, если возможно, сначала взвесьте больного. Дайте одну дозу. Другая иногда нужна спустя 6 месяцев или 1 год.

ОСТОРОЖНО: Не давайте детям, которые весят меньше 15 кг (или детям до 5 лет), беременным или кормящим грудью или больным менингитом или другими серьезными болезнями.

Дозировка ивермектина:

Давать один раз:

тяжелым взрослым (больше 64 кг):

2 таблетки (2 мг)

средним взрослым (45-65 кг): 1 1/2

таблетки (9 мг)

легким взрослым и молодым

(26-44 кг): 1 таблетку (6 мг)

детям (15-25 кг): 1/2 таблетки (3 мг)

Чтобы избежать повреждения глаз, важно начинать с маленькой дозы 1 1/2 мг для взрослых и постоянно повышать количество до 150 мг в день, примите полную дозу за 2-3 недели. Принимать после еды.

Диэтилкарбамазин может вызвать сильную аллергическую реакцию, которую частично можно остановить антигистаминным или кортикостероидами, которые дает медработник.

Побочные действия: Это лекарство иногда вызывает головную боль, усталость, слабость, потерю аппетита, расстройство желудка, кашель, боль в груди, боль в мышцах суставах, жар и сыпь.

Сурамин (Нафурид, Байер 205, Антрипол, Германия)

Название: _____ цена: _____ за _____

Оно эффективнее, чем диэтилкарбамазин, убивает взрослых глистов и можно им пользоваться после лечения диэтилкарбамазином, когда реакции почти остановятся. Иногда сурамин травит почки. Если отекают ноги или появляются другие признаки отравления мочой, прекратить прием лекарства. Людям с больными почками не следует принимать его.

Сурамин следует принимать внутривенно и только с помощью опытного медработника. Взрослым делать инъекцию 1 г сурамина в 10 мл дистиллированной воды один раз в неделю 5-7 недель. Начните с маленькой дозы 200 мг. Лечите аллергическую реакцию антигистаминным.

ОТ ГЛАЗ

Диэтилкарбамазин (Гетразан, Баноцид)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выпускают в: 50 мг таблетках.

Диэтилкарбамазин убивает молодых червей, но не взрослых. Лекарство следует принимать только под наблюдением опытного медработника.

Антибиотиковая глазная мазь – от “розовых глаз” (конъюнктивита)

Полезные примеры:
окситетрациклиновая или
хлортетрациклиновая глазные мази

Название: _____ цена: _____ за _____

Эти глазные мази могут употребляться от "розовых глаз", вызванных бактериями, и от трахомы. Чтобы полностью вылечить трахому, следует принимать тетрациклин внутрь (см. с. 356).

Чтобы глазная мазь хорошо действовала, ее следует закладывать внутрь века, а не наружу. Делайте это 3-4 раза в день.

Чтобы защитить глаза новорожденных от гонореи или хламиды, пользуйтесь глазной тетрациклиновой мазью 1% или эритромициновой 0.5%. При рождении положите немного мази во внутренний угол каждого глаза и не вытирайте и не полощите их.

О лечении новорожденного этой мазью см. с. 221.

Глазные капли нитрата серебра. 1% – для защиты глаз новорожденных

Название: _____ цена: _____ за _____

Если у вас нет антибиотиковых глазных мазей, упомянутых выше, капните по одной капле 1% раствора нитрата серебра в каждый глаз новорожденного сразу после родов. Это защитит глаза новорожденного от гонореи (но не от хламиды).

ВНИМАНИЕ: Не употребляйте серебряные нитратные капли слишком концентрированные, иначе может быть ожог глаз из-за испарения.

ОТ БОЛИ: АНАЛЬГЕТИКИ

Примечание: Есть много различных видов болеутоляющих лекарств, многие из которых опасны (особенно те, которые содержат дипирон). Пользуйтесь только теми, в относительной безопасности которых вы уверены, – аспирин и ацетаминофен (парацетамол). Из более сильных болеутоляющих см. ибупрофен (с. 380) или кодеин (с. 384).

Аспирин (ацетилсалициловая кислота)

Часто выпускается в:

300 мг (5 гр.) таблетках Цена: _____ за _____
75 мг (1 1/4 гр. таблетках для детей (или детский аспирин) Цена: _____ за _____

Аспирин – очень полезное, низкостоящее болеутоляющее лекарство. Оно помогает снять боль, снизить температуру и уменьшить воспаление. Оно еще помогает немного успокоить кашель и уменьшить зуд.

Продается много различных лекарств от боли, артрита или простуды, содержащих аспирин, но они дороже и часто не помогают так, как аспирин.

Риск и предосторожности:

1. Не принимайте аспирин от боли в желудке или несварения. Аспирин – кислота – и может ухудшить болезнь. По этой же причине люди с язвой желудка никогда не должны пить аспирин.
2. Аспирин вызывает боль или изжогу у некоторых людей. Чтобы избежать этого, пейте аспирин с молоком, немного пищевой соды или много воды – или вместе с едой.
3. Не давайте больше 1 дозы аспирина обезвоженным людям, пока они не будут хорошо мочиться.
4. Лучше не давать аспирин детям до 12 лет и особенно малышам (ацетаминофен – безопаснее) или больным астмой (это может вызвать приступ астмы).
5. Держите аспирин подальше от детей. Большая доза может отравить их.
6. Не давайте беременным женщинам.

Дозировка аспирина – от боли или жара:
– таблетки 300 мг (5 гр.) –

Принимать каждые 4-6 часов (4-6 раз в день), но детям не давать больше 4 раз в день.

взрослым: 1-2 таблетки (300-600 мг)
детям 8-12 лет: 1 таблетку (300 мг)
детям 3-7: 1/2 таблетки (150 мг)
детям 1-2 лет: 1/4 таблетки (75 мг)

(Доза может быть удвоена при сильных менструальных болях, сильном артрите или ревматической лихорадке. Или дайте 100 мг/кг/день. Если есть звон в ушах, уменьшите дозу.)

– 75 мг таблетки детского аспирина –

Детям давать аспирин 4 раза в день:

детям 8-12 лет: 4 таблетки (300 мг)

детям 3-7 лет: 2-3 таблетки
(150-225 мг)

детям 1-2 лет: 1 таблетку (75 мг)

не давать аспирин детям до 1 года

Ацетаминофен (парацетамол) – от боли и жара

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выходит в: 500 мг таблетках.

Есть еще и сироп.

Ацетаминофен (парацетамол) безопаснее для детей, чем аспирин. Он не вызывает раздражение в желудке и его можно употреблять людям с язвой желудка. Беременные женщины тоже могут употреблять его.

Дозировка ацетаминофена – от боли и жара:

– 500 мг таблетки –

Принимать его внутрь 4 раза в день.

В каждой дозе прием:

взрослым: 500 мг-1 г (1 или 2 таблетки)

детям 8-12 лет: 500 мг (1 таблетка)

детям 3-7 лет: 250 мг (1/2 таблетки)

детям 1-2 лет: 125 мг (1/4 таблетки)

малышам до 1 года: 62 мг (1/8 таблетки)

Ибупрофен

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выходит в: таблетках 200 мг

Ибупрофен помогает при распухании мышц и боли в суставах от артрита, при менструальной боли, головной, снижает жар. Он дороже аспирина.

ВНИМАНИЕ: Ибупрофен не следует употреблять тем, у кого аллергическая реакция к аспирину. Беременным тоже не следует употреблять его.

Дозировка ибупрофена – от боли и жара:

– 200 мг таблетки –

Принимайте внутрь каждые 4 или 6 часов.

В каждой дозе принимать:

взрослым и детям 12 лет и старше:

200 мг (1 таблетку)

детям до 12 лет: Не давать.

Если одна таблетка не снимает боли или жара, можно принять 2. Не употребляйте более 6 таблеток за 24 часа.

Эрготамин с кофеином (Кафергот) – от мигрени

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выпускается в: таблетках 1 мг эрготамина.

Дозировка эрготамина с кофеином от мигрени:

взрослым: Примите 2 таблетки при первых признаках мигрени, затем по 1 таблетке каждые полчаса, пока не пройдет боль. Не принимайте больше 6 таблеток в общем.

ВНИМАНИЕ: Не принимайте часто это лекарство. Не давайте беременным.

ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ БОЛИ, КОГДА
ЗАКРЫВАЮТ РАНЫ: АНЕСТЕТИКИ

Лидокаин (Ксилокаин)

2% (с или без эпинефрина)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выходит в: ампулах или бутылочках для инъекций.

Лидокаин можно вводить вокруг краев раны, перед тем, как зашивать ее, чтобы обезболить этот участок или чтобы он занемел.

Вводите укол в и под кожу на точках на расстоянии около 1 см. Старайтесь оттянуть поршень перед инъекцией (см. с. 73), вводите медленно. Применяйте около 1 мл обезболивающего на каждые 2 см кожи. (Не употребляйте более 20 мл вместе). Если рана чистая, вы можете делать укол по краю самой раны. Если рана грязная, сделайте укол через кожу (после ее очистки) вокруг раны, а затем очистите рану очень тщательно перед тем, как закрыть ее.

Применяйте лидокаин с эпинефрином для зашивания большинства ран. Эпинефрин надолго делает рану нечувствительной и помогает остановить кровотечение.

Пользуйтесь лидокаином без эпинефрина для ран на пальцах рук и ног, пенисе, ушах и носу. Это важно, потому что эпинефрин может остановить приток крови в эти места и вызвать большое повреждение.

Еще одно применение лидокаина с эпинефрином. При сильном носовом кровотечении намочите тампоны из ваты и вложите в нос. Эпинефрин вызовет сужение вен и поможет остановить кровотечение.

ОТ СПАЗМОВ ЖЕЛУДКА: СПАЗМОЛИТИКИ

Белладонна (с или без фенотарбата)

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выходит в: таблетках с 8 мг белладонны.

Есть много различных антиспазматических препаратов. Большинство содержит белладонну или что-нибудь похожее (атропин, гиосциамин) и часто фенотарбат фенотарбитон). Эти препараты нельзя принимать регулярно, но иногда можно для лечения боли или спазмов (коликов) в желудке или в кишечнике. Они могут успокоить боль инфицированного мочевого пузыря или воспаленного желчного пузыря. Иногда они полезны при лечении язв.

Дозировка белладонны – от спазмов кишечника:

– таблетки с 8 мг белладонны

взрослым: 1 таблетка 3-6 раз в день
детям 8-12 лет: 1 таблетка 2-3 раза в день

детям 5-7 лет: 1/2 таблетки 2 или 3
раза в день
не давать детям до 5 лет.

ВНИМАНИЕ: Это лекарство – яд, если его принимать выше дозы. Держите подальше от детей.

Больные глаукомой не должны принимать лекарство с содержанием белладонны или атропина.

ОТ КИСЛОТНОГО НЕСВАРЕНИЯ, ИЗЖОГИ И ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА

Алюминия гидроксид или магнезия гидроксид (Молоко магнезии)

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выпускается в: таблетках 500-750 мг или в микстурах с 300-500 мг в 5 мл

Иногда их смешивают вместе или с магнезия трисиликатом. Если добавить симетикон, то это поможет вывести газ.

Эти антациды можно применять иногда от кислотного несварения или изжоги или как регулярную часть лечения язвы желудка (пищеварительной). Самое важное время для приема антацидов – через 1 час после еды и на ночь. Жуйте 2 или 3 таблетки. При сильной язве желудка необходимо принимать от 3 до 6 таблеток (или чайных ложек) каждый час.

ОСТОРОЖНО: Не употребляйте эти лекарства, если принимаете тетрациклин. Нейтрализующие с магнием иногда вызывают понос, а с алюминием могут вызвать запор.

Натрия бикарбонат (бикарбонат соды, пищевая сода)

Выпуск в белом порошке. Цена: ____ за ____

Как антацид она должна употребляться в очень ограниченном виде, когда у кого-то случается расстройство желудка с изжогой или кислотное несварение. Ее нельзя употреблять при лечении хронического несварения или желудочной язвы (пищеварительной). Хотя сначала кажется, что она помогает, она заставляет желудок выделять больше кислоты, что ухудшает положение. Сода еще полезна при "похмелье", когда человек перепил спиртного. Для этой цели (но не от кислотного несварения) ее можно принять с ацетаминофеном или аспирином. Алка-Зелцер – это смесь пищевой соды и аспирина. В редких случаях в качестве нейтрализующего можно использовать раствор 1/2 чайной ложки соды в воде. Часто этим не пользуйтесь.

Для чистки зубов вместо зубной пасты можно использовать пищевую соду или смесь "соды" и соли (см. с. 230).

ВНИМАНИЕ: Люди с некоторыми сердечными заболеваниями или с отеками ног или лица не должны применять соду или продукты с высоким содержанием натрия (как соль).

Кальция карбонат

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выходит в: таблетках 350–850 мг.

Действует медленнее, чем сода пищевая. Полезен иногда при кислотном несварении или изжоге, но не следует пользоваться долго. Разжуйте 850 мг таблетку или 2 по 350 мг, когда появляются симптомы. Если необходимо, примите еще одну дозу через 2 часа.

Циметидин (Тагамет)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выпускается в: таблетках 200 мг или в инъекциях от 200 мг в 2 мл

Циметидин – дорогое, но эффективное лекарство для лечения язв желудка и кишечника. Он успокаивает боль и помогает исцелению. Долгое употребление помогает предупредить большинство обычных типов язвы (язвы кишечника) от возникновения снова. Но чтобы предупредить появление, следуйте особой диете и другим советам по уходу за язвой на с. 128, 129.

Предосторожности: Циметидин не следует принимать беременным и кормящим грудью женщинам и детям.

Побочные действия: Иногда бывает понос, головокружение, сыпь и сонливость.

Дозировка от активной язвы кишечника:

400 мг (две по 200 мг таблетки) дважды в день или 800 мг (4 по 200 мг таблетки) перед сном в течение 6 или 8 месяцев.

Дозировка от активной язвы желудка:

300 мг (одна и половина 200 мг таблетки) 4 раза в день, 6-8 месяцев.

Дозировка для предупреждения повторного появления язвы кишечника:

400 мг (2 по 200 мг таблетки) перед сном в течение 1 года

Ранитидин (Зантак)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выпускают в: таблетках по 150 мг или 300 мг.

Ранитидин похож на циметидин, но дороже. Он может успокоить боль и помочь исцелить язву. Но старайтесь следовать советам на с. 128 и 129 при лечении и профилактике язвы.

Дозировка ранитидина для лечения язвы:

150 мг дважды в день или 300 мг в обеденное время 6-8 недель.

Дозировка для предупреждения повторного появления язвы кишечника:

150 мг (одна таблетка 150 мг) 6-8 недель.

ОТ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ

Инструкции по изготовлению регидратационного напитка со злаками и обычным сахаром см. с. 152.

В некоторых странах пакеты простого сахара (глюкозы) и соли, чтобы сделать обезвоживающий напиток, продают в магазинах или доступны в центрах здоровья. Иногда эти пакеты очень удобны, а сделанный дома напиток с использованием злаков, как описано на с. 152, хорошо прекращает понос. Домашняя смесь с сахаром и немного соли тоже действует неплохо. Лучше сделать домашнюю смесь, чем тратить деньги, вы можете купить на них еду. Старайтесь продолжать кормить грудью малыша с поносом. И начните давать еду, как только больной ребенок сможет принимать еду. Еда вместе с обезвоживающим напитком прекращает обезвоживание эффективнее и защищает ребенка от слабости.

ВНИМАНИЕ: В некоторых странах пакеты с "ORS" (оральные обезвоживающие соли) продаются в различных препаратах, которые требуют различного количества воды для правильного препарата. Если вы пользуетесь ORS пакетом, постарайтесь узнать, сколько добавить воды. Слишком много воды может быть опасным.

ОСТОРОЖНО: Если вы собираетесь доставить ребенка с поносом в центр здоровья или в больницу, перед уходом из дома дайте ему побольше жидкости или домашний регидроновый напиток. И если вы сможете, возьмите немного напитка (если его нет, то просто воду) с собой, чтобы дать ребенку по пути в центр здоровья. Давайте напиток почаще. Если у ребенка рвота, давайте маленькое количество ежеминутно. Немного напитка останется внутри и это поможет уменьшить рвоту.

ОТ ТВЕРДОГО СТУЛА (ЗАПОРА): СЛАБИТЕЛЬНЫЕ

О пользе и вреде различных слабительных и очистительных лекарств написано на с. 15. Слабительными пользуются слишком часто. Они должны применяться крайне редко, чтобы помочь смягчить твердый болезненный стул (запор). Никогда не давайте слабительного больным с поносом или болями, или с обезвоживанием. Не давайте слабительного маленьким детям до 2 лет.

Обычно самый лучший смягчитель стула – это грубая пища с большим содержанием волокна, такая как отруби, кассава. Также помогает при запоре большое количество жидкости (по крайней мере, 8 стаканов воды в день) и фруктов.

Молоко магнезии (магния гидроксид)
(слабительное и нейтрализующее)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выпускается как молочный раствор.

Встряхните как следует перед употреблением. Каждый раз перед приемом выпейте немного воды.

Дозировка молока магнезии:

Как антацид:

взрослым и детям старше 12 лет:

1-3 чайные ложки 3-4 раза в день

детям 1-12 лет: 1/2–1 чайная

ложка

3-4 раза в день

Как легкое слабительное принимайте 1 дозу перед сном:

взрослым и детям выше 12 лет:

2-4

столовые ложки

детям 6-11 лет: 1-2 столовые

ложки

детям 2-5 лет: 1/3-1 столовая

ложка

не давать детям до 2 лет

Горькая соль (сульфат магnezия)

как слабительное и от зуда

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выходит в белом порошке или в кристаллах.

Дозировка горькой соли:

Как легкого слабительного – смешайте следующее количество соли в стакане воды и пейте (лучше на пустой желудок):

взрослым: 2 чайные ложки

детям 6-12 лет 1/2 до 1 чайной ложки

детям 2-6 лет 1/4 до 1/2 чайной ложки

не давать детям до 2 лет

Для прекращения зуда – смешайте 8 чайных ложек соли с литром воды и приложите компресс на зудящую кожу.

Минеральное масло – как слабительное

Название: _____ цена: _____ за _____

Его иногда принимают люди с геморроем, у которых твердый болезненный стул. Но на самом деле он не смягчает стул, а просто смазывает его. Пища, богатая волокном, как отруби или кассава – намного лучше.

Дозировка минерального масла как слабительного:

взрослым и детям старше 12 лет: 1-3 столовые ложки в рот, по крайней мере, после вечернего приема пищи. Не принимайте с едой, потому что масло крадет витамины из пищи.

ОСТОРОЖНО: Не давайте это лекарство детям до 12 лет, беременным и кормящим женщинам, людям, которые не могут встать с кровати, или людям, у которых есть проблемы с глотанием.

Глицериновые свечи (Дулколакс)

Название: _____ цена: _____ за _____

Эти пулеобразные пилули вводятся в анус. Они стимулируют кишечник и вызывают его опорожнение.

Дозировка глицериновой свечи:

взрослым и детям старше 12 лет: введите 1 свечу в задний проход и оставьте там на 15-20 минут (это поможет опустить стул вниз). Чем дольше вы будете держать свечи внутри заднего прохода, тем лучше они действуют.

ОТ ЛЕГКОГО ПОНОСА: ПРОТИВОПОНОСНЫЕ

Каолин с пектином (Каопектат)

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выпускается как молочные микстуры.

Это лекарство употребляется, чтобы сделать гуще понос (менее водным) и менее мучительным. Он не лечит причину поноса и не помогает лечить или предупредить обезвоживание. Он никогда не нужен при лечении поноса, а его обычное употребление – большая трата денег. Его не следует давать людям, которые очень больны, или маленьким детям. **МЫ ГОВОРИМ О НЕМ ЗДЕСЬ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРЕДОСТЕРЕЧЬ ОТ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

Дозировка каолина с пектином от легкого поноса только:

–примените стандартную микстуру, такую как Каопектат–

Дайте одну дозу после каждого стула или 4-5 раз в день.

В каждой дозе приема:

взрослым: 2-8 столовых ложек
детям 6-12 лет: 1-2 столовые ложки
детям до 6 лет: НЕ ДАВАТЬ

ОТ ЗАБИТОГО НОСА

Чтобы помочь очистить нос – часто все то, что нужно сделать – это втягивать воду с солью в нос, как описано на с. 164. Иногда капли деконгестанта (откупорка) можно употреблять как следующие:

Носовые капли с эфедрином и фенелефрином (Нафтизин, Санорин)

Название: _____ цена: ____ за ____

Они должны употребляться от забитого носа или насморка, особенно, если у больного есть (или часто получает) инфекция во внутреннем ухе.

Дозировка деконгестантных капель:

Закапайте 1-2 капли в каждую ноздрю, как показано на с. 164. Делайте это 4 раза в день. Не применяйте более 3 дней или сделаете себе привычку употреблять эти капли.

Капли для носа делают из таблеток эфедрина см. с. 385.

ОТ КАШЛЯ

Кашель – это способ, которым организм очищает трубы для воздуха, идущие к легким, и предохраняет легкие от попадания микробов и слизи из этих труб. Поскольку кашель является защитной реакцией организма, лекарства, которые останавливают и успокаивают кашель, иногда больше вредят, чем приносят пользы. Эти успокаивающие (или супрессанты) кашель препараты следует применять только от раздражающего сухого кашля, который не дает спать больному. Есть и другие лекарства, которые называют помощниками кашля (или экспекторантами), которые помогают отхаркивать слизь.

Правда, оба вида сиропа от кашля (успокаивающие и помощники) применяются больше, чем они нужны. Большинство популярных сиропов от кашля помогают мало.

Самое лучшее и важное лекарство от кашля – это вода. Нужно пить много воды и дышать горячим паром, чтобы освободиться от слизи и успокоить кашель. Для инструкций см. с. 168. Приготовление домашнего сиропа от кашля описано на с. 169.

Успокаивающие кашель (подавляющие): кодеин

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выходит в: сироп от кашля, или жидкость. Бывает в таблетках с или без аспирина.

Кодеин – сильное болеутоляющее и одно из самых сильных успокаивающих кашель, но из-за того, что он наркотик, его тяжело достать. Он часто выходит в виде сиропов или в таблетках. Доза приводится вместе с препаратом. Чтобы успокоить кашель у взрослых, обычно достаточно 7-15 мг кодеина. Детям нужно меньше, в соответствии с возрастом или весом (см. с. 62).

ОТ АСТМЫ

Чтобы предупредить астму или справиться с ней, см. с. 167. Люди, которые страдают астмой, должны держать лекарство дома. Начните их принимать при первых признаках хрипа или сжатия в груди.

Эфедрин

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выходит в: таблетки 15 мг (еще 25 мг).

Эфедрин полезен для прекращения легких приступов астмы и между сильными приступами для предупреждения их. Он действует, помогая открывать трубы, которые ведут в легкие так, чтобы воздух мог проходить легче. Он может еще применяться, когда есть трудности в дыхании из-за пневмонии или бронхита.

Эфедрин часто выходит в сочетании с теофиллином или аминофиллином и иногда с фенотеролом. Избегайте эти сочетания кроме тех случаев, когда недоступны другие лекарства от астмы.

Дозировка эфедрина от астмы— (1 мг/кг 3 раза в день, когда случаются симптомы):
— прием 15 мг таблетки—

Принимайте внутрь 3 раза в день.

В каждой дозе приема:

взрослым: 15-60 мг (1-4 таблетки)
детям 5-10 лет: 15-30 мг (1-2 таблетки)
детям от 1-4 лет: 15 мг (1

таблетка)
детям до 1 года: НЕ ДАВАТЬ

От забитого носа следует употреблять капли эфедрина в нос. Их можно сделать, растворяя 1 таблетку в 1 чайной ложке воды.

Теofilлин или Аминофиллин

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выходит в: таблетках и сиропах различной силы. Чтобы остановить астму и предупредить приступы.

Дозировка— (3-5 мг/кг/каждые 6 часов):
— прием 100 мг таблетки—

Давать каждые 6 часов:

взрослым: 2 таблетки
детям 7-12 лет: 1 таблетку
детям до 7 лет: 1/2 таблетки
малышам: НЕ ДАВАТЬ

В тяжелых случаях или если астма не останавливается с указанной дозой, удвойте дозу, но не больше. Если больной не может говорить, скорее обратитесь за скорой помощью.

Сальбутамол (Альбутерол)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выходит в: таблетках 4 мг в виде сиропа с 2 мг в 5 мл.

Чтобы остановить астму и предупредить приступы. Сальбутамол можно применять самостоятельно или с теофиллином.

Дозировка сальбутамол— (0.1 мг/кг каждые 6-8 часов):

—прием 4 мг таблеток или сироп с 2 мг в 1 чайной ложке—

Принимать каждые 6-8 часов:

взрослым 1 таблетка или 2 чайные ложки
детям 6-12 лет: 1/2 таблетки или 1 чайная ложка
детям 2-5 лет: 1/4-1/2 таблетки или 1/2-1 чайная ложка
малышам: НЕ ДАВАТЬ

Эпинефрин (адреналин, Адреналин)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выпускается в ампулах от 1 мг в 1 мл.

Эпинефрин следует употреблять от:

1. сильных приступов астмы, когда трудно дышать
2. сильных аллергических реакций или аллергического шока, вызванных инъекцией пенициллина, противостолбнячного антитоксина, столбняка или других антитоксинов, изготовленных из лошадиной сыворотки (см. с. 70).

—пользуясь
внутримышечными
инъекциями, 25 мг в мл—

Сделайте 1 укол и
снова через 2-4 часа, если
необходимо

Дифенгидрамин (Димедрол)

Название: _____

Часто выпускается в:
таблетках по 50 мг.

Цена: ____ за ____
инъекциях – ампулы 10 мг
или 50 мг в
каждом мл
Цена: ____ за ____

ОСТОРОЖНО: Не давайте ди-
фенгидрамин новорожденным
малышам или кормящим жен-
щинам. Лучше не употреблять
его беременным, пока это не
будет абсолютно необходимо.

Дозировка дифенгидрамина—
—прием таблеток 50 мг

Давайте 1-2 раза в день

взрослым: 25-50 мг (1-2
таблетки)
детям 6-12 лет: 25 мг (1
капсулу)
детям 2-7 лет: 12.5 мг
(1/2 капсулы)
малышам: 6 мг (1/4
капсулы).

—прием внутримышечных инъекций, 25 мг в
каждом мл.

Дифенгидрамин следует вводить только в слу-
чае аллергического шока. Делайте 1 инъекцию и
снова через 2-4 часа, если это необходимо:

взрослым: 25-50 мг (2.5-5.0 мл) детям 6-12
лет : 15-25 мг (1.5-2.5 мл.)
детям 2-5 лет : 5-15 мг (0.5-1.5 мл.)
малышам: 2-5 мг (0.2-0.5 мл.)

Хлорфенирамин

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выпускается в: 4 мг таблетках (также
таблетках других размеров, в виде сиропов и т.д.)

Дозировка хлорфенирамина:

Принимать 1 дозу 3-4 раза в день.

В каждой дозе давать:

взрослым: 4 мг (1 таблетку)
детям до 12 лет: 2 мг (1/2 таблетки)
малышам: 1 мг (1/4 таблетки).

Дименгидринат (Дедалон))

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выходит в: 50 мг таблетках

Он в основном продается от приступов тошно-
ты, но может употребляться как другие антигис-
тамины, чтобы успокоить аллергические реакции и
склонность ко сну.

Дозировка дименгидрината:

Принимать 4 раза в день.

В каждой дозе давать:

взрослым: 50-100 мг (1-2 таблетки)
детям 7-12 лет: 25-50 мг (1/4 - 1/2
таблетки)
детям 2-6 лет: 12-25 мг (1/4-1/2
таблетки)
детям до 2 лет: 6-12 мг (1/8-1/4
таблетки)

АНТИТОКСИНЫ

ВНИМАНИЕ:

Многие антитоксины сделаны на основе лошадиной сыворотки, такие как от столбняка и противоядие от укуса змеи и скорпиона. Есть риск, что они могут вызвать опасную аллергическую реакцию (аллергический шок, см. с. 70). Перед инъекцией антитоксина из лошадиной сыворотки всегда держите наготове эпинефрин на случай оказания срочной помощи. Людям, которые страдают аллергией или которым делали инъекцию антитоксина любого вида из конской сыворотки прежде, лучше сделать инъекцию антигистамина, такого как прометазин (Фенерган) или дифенгидрамин (Бенадрил), за 15 минут до антитоксина.

Антитоксин от укуса скорпиона или противоядие

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выпускается лиофильным (в виде порошка) для инъекций.

Различные противоядия выпускаются от укуса скорпиона в различных частях света. В Мексике выпускается Антиалакран Мин Лабораторией Мин в Мехико, D.F.

Противоядием от укуса скорпиона следует пользоваться только в тех местах, где водятся опасные или смертельные виды скорпионов. Обычно противоядие нужно только тогда, когда укусили ребенка, особенно если его укусили в верхнюю часть тела или голову. Чтобы улучшить состояние, противоядие нужно ввести инъекцией, как можно быстрее после укуса.

Противоядие обычно поступает с полной инструкцией. Следуйте им обязательно. Маленьким детям обычно требуется больше противоядия, чем старшим. Нужно будет 2 или 3 пузырька.

В основном скорпионы не опасны для взрослых. Поскольку противоядие таит в себе некоторую опасность, его лучше не принимать взрослым.

Противоядие от укуса змеи или антитоксин

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выпускается в бутылках или комплектах для инъекций.

Противоядие, или лекарство для защиты от отравления, от укусов ядовитых змей производят во многих частях света. Если вы живете там, где люди иногда бывают укушены или убиты укусом ядовитой змеи, найдите сразу доступное противоядие, запаситесь им заранее и держите под рукой. Некоторые противоядия – в сухой или “лиофильной” форме – можно хранить без холодильника. Другие следует держать в холоде.

Следующий список – несколько видов продуктов, которые продают во многих частях света.

Северная Америка: Поливалент Кроталид Антивенин. Через лабораторию Виет. От укусов гремучей змеи и других ямкоголовых гадюк.

Мексика и Центральная Америка: Суэро Антикроталико (гремучая змея) и Суэро Антивиперино (гремучая змея, ямкоголовая гадюка, степная гадюка и многие другие ядовитые змеи). Через лаборатории Мин, Мексика, D.F.

Таиланд: Особые противоядия от различных укусов. Через Красный Крест, Институт Пастера, Бангкок.

Индия: Поливалентное противоядие (от разных змей). Через Институт Хоффкинса, Бомбей.

Эфиопия: Поливалентное противоядие. Через лаборатории Бехринверке.

Египет: Поливалентное противоядие. Доступное только через правительство.

Западная Африка: Поливалентное противоядие против Ешис-Битис-Ная (ковровая гадюка, габонская гадюка и кобра) обычно предоставляет правительство. Противоядие против ковровой гадюки (Ешис) изготавливают в некоторых местах.

Инструкции по употреблению противоядия от укусов змей обычно должны быть в аптечке. Изучите их перед тем, как они вам потребуются. Чем больше змея или меньше человек, тем большее количество противоядия требуется. Иногда нужно 2 или больше пузырьков. Чтобы лучше помогла инъекция, противоядие нужно ввести сразу после укуса.

Постарайтесь предпринять все меры предосторожности, чтобы избежать аллергического шока (см. с. 70).

Антитоксин от столбняка

Столбнячный иммуноглобулин (человеческий) выпускается в: флаконах по 250 Е.

Антитоксин от столбняка (лошадиный) часто выходит в: флаконах по 1500, 20000, 40000 и 50000 Е.

Там, где люди не вакцинированы от столбняка, в аптечке всегда должен быть антитоксин от столбняка. Он бывает двух видов: один из сыворотки человека (иммуноглобулин столбнячный, Гипертет) и другой из лошадиной сыворотки (столбнячный антитоксин). Если это доступно, используйте столбнячный иммуноглобулин, т.к. он меньше вызывает аллергическую реакцию.

Но если вы употребляете столбнячный антитоксин, следует принять все меры предосторожности от аллергии. Если больной страдает астмой или другими аллергиями, или ему уже вводили другой антитоксин из лошадиной сыворотки, сделайте ему инъекцию антигистамина, такого как прометазин, за 15 минут до инъекции антитоксина.

Если человек, не вакцинированный от столбняка, получил серьезную рану, которая может вызвать эту болезнь (см. с. 89), сделайте ему инъекцию 250 Е. (1 флакон) столбнячного иммуноглобулина, до появления первых признаков столбняка. При использовании столбнячного антитоксина вводите 1500-3000 Е. Детям вводить 750 Е. столбнячного антитоксина.

Если у больного развиваются признаки столбняка, введите 5000 Е. столбнячного иммуноглобулина или 50000 Е. столбнячного антитоксина. Делайте инъекции внутримышечно в большие мышцы тела (ягодицы и бедра). При возможности половину количества введите внутривенно.

Признаки столбняка обычно усиливаются, несмотря на лечение антитоксином. Другие методы лечения (см. с. 183-184) равнозначны или важнее. Начинайте лечение сразу же и обратитесь за медицинской помощью.

ОТ ПРОГЛОЧЕННЫХ ЯДОВ

Сироп рвотного корня – чтобы вызвать рвоту

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выходит в: виде сиропа (Не употребляйте эликсир.)

Чтобы вызвать рвоту, когда человек проглотил яд. Не употребляйте, если человек проглотил сильную кислоту, щелочь, бензин или керосин.

Дозировка рвотного корня:

1 столовая ложка для любого возраста. Повторите через полчаса, если больного не вырвало.

Порошковый уголь (или активированный уголь) – от проглоченного яда

Цена: _____ за _____

Уголь всасывает проглоченный яд и обезвреживает его.

Дозировка порошкового угля:

1 столовая ложка, смешанная с водой или фруктовым соком.

Дозировка активированного угля:

1 полная чашка, смешанная с равным количеством воды или фруктового сока.

ОТ ПРИПАДКОВ (КОНВУЛЬСИЙ)

Фенобарбитал и фенитоин обычные лекарства, которыми пользуются, чтобы предупредить припадки или конвульсии при эпилепсии. Иногда доступны другие, более дорогие лекарства, и врачи часто прописывают 2 или больше лекарств. Однако обычно одно лекарство действует лучше и с малым побочным эффектом. Препараты для предупреждения припадков лучше принимать перед сном, потому что они часто вызывают сонливость. Диазепам можно давать для прекращения длительных припадков эпилепсии, но это не обычный дневной прием для предупреждения.

Фенобарбитал (фенобарбитон, Люминал)

Часто выходит в:

таблетках 15 мг, 30 мг, 50 мг и 100 мг

Цена: _____ за _____

ампулах 65 мг, 130 мг, 200 мг в 1 мл

Цена: _____ за _____

в виде сиропа 15 мг в 1 мл

Цена: _____ за _____

Фенобарбитал можно принимать внутрь, чтобы помочь предупредить припадки или конвульсии (эпилепсию) и спазмы от столбняка. От эпилепсии его часто необходимо принимать всю жизнь. Нужно употреблять самую маленькую дозу, чтобы предупредить припадки. Такая же маленькая доза уменьшит кашель при коклюше или предотвратит сильную рвоту.

ВНИМАНИЕ: Слишком много фенобарбитала может замедлить или остановить дыхание. Его действие начинается медленно и длится долгое время (до 24 часов или больше, если человек не мочился). Будьте осторожны, не давайте слишком много!

Дозировка фенобарбитала–
(3-6 мг/кг/день):

– принимая таблетки 100 мг–

Примите 1 дозу в рот (перед сном от эпилепсии).

В каждой дозе принимать:

взрослым и детям до 12 лет: 100-200 мг (1-3 таблетки)

детям 7-12 лет: 50-100 мг (1/2-1 таблетку)

детям до 7 лет: 20-50 мг (1/4-1/2 таблетки)

Инъекции фенобарбитала можно сделать, чтобы остановить припадки эпилепсии или от спазмов, вызванных столбняком.

Дозировка фенобарбитала в инъекциях:

– прием ампул с 200 мг в 1 мл–

Делайте 1 инъекцию внутримышечно:

взрослым: 200 мг (1 мл)

детям 7-12: 150 мг (3/4 мл)

детям 2-6: 100 мг (1/2 мл)

детям до 2 лет: 50 мг (1/4 мл)

Если припадки не остановились, можно дать еще 1 дозу через 15 минут, но не больше. От столбняка повторите дозу 3 раза в день и если спазмы прекратились, начните понемногу снижать дозу.

Фенитоин (дифенилгидантоин, Дилантин)

Название: _____

Часто выходит в:

капсулах 25 мг, 30 мг и 100 мг

Цена: ____ за ____

в виде сиропа 125 мг в 5 мл (1 чайная ложка)

Цена: ____ за ____

Он помогает предупредить припадки при эпилепсии. Лекарство возможно придется принимать всю жизнь. Нужно употреблять самую низкую дозу, чтобы предупредить припадки.

Побочные эффекты: Опухоли или ненормальные наросты на деснах часто появляются от долгого употребления фенитоина. Если это серьезно, следует поменять лекарство. Болезнь десен можно частично предупредить, поддерживая чистоту во рту и хорошо очищая щеткой зубы и десна после приема пищи.

Дозировка фенитоина от припадков –
(5 мг/кг/день):

– прием капсулы 100 мг –

Начните со следующей дозы раз в день перед сном.

В каждой дозе принимать:

взрослым и детям старше 12 лет

100-300 мг (1-3 капсулы)

детям 7-12 лет: 100 мг (1 капсулу)

детям до 7 лет: 50 мг (1/2 капсулы)

Если припадки полностью не прекратились с этой дозой, удвойте ее, но не больше.

Если припадки предупреждены, пытайтесь снижать дозу понемногу, пока не найдете самую низкую, чтобы предупредить припадки.

Диазепам (Валиум)

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выпускается в: инъекциях 5 мг в 1 мл жидкости

Употребление диазепама похоже на фенобарбитал, но он дороже. Его включили сюда потому, что он может быть получен, когда не будет фенобарбитала.

Чтобы остановить припадки эпилепсии у взрослых, доза 5-10 мг. Повторите через 2 часа, если необходимо.

От столбняка дайте столько, чтобы остановить спазмы. Начните с 5 мг (меньше у детей) и дайте больше, если нужно, но не более 10 мг в один раз или 50 мг в день. Если необходимо, диазепам можно дать вместе с фенобарбиталом, но осторожно, чтобы не дать слишком много.

Для прекращения припадков свечи диазепама или фенobarбитала можно вставить в анус. Если у вас есть лекарство только для инъекций или жидкое, вставьте в анус пластиковый шприц без иглы. Или разотрите пилюлю диазепама или фенobarбитала, смешайте с водой и вставьте в анус.

Диазепам полезен и в случаях крайнего страха (истерии) или беспокойства, но употребление от этого должно быть сильно ограничено.

Дозировка для инъекций диазепама
–прием ампулы 10 мг в 2 мл–
взрослым и детям до 12 лет: 5-10 мг

(1-2 мл)
детям 7-12 лет: 3-5 мг (2/3-1 мл)
детям 1-6 лет: 1-5 мг (1/5-1 мл)
детям до 1 года: НЕ ДАВАТЬ

Повторите дозу через 3-4 часа, если необходимо.

ВНИМАНИЕ: Хотя безопаснее делать инъекцию диазепама в мышцу, чем в вену, но тогда он действует не так хорошо и не так быстро. Если вводить в вену, уколите в большую вену и вводите очень медленно.

Большое количество диазепама замедляет или останавливает дыхание. Осторожно, чтобы не дать слишком много.

ОТ СИЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ РОДОВ (ПОСЛЕРОДОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ)

Информацию о правильном применении лекарств для остановки кровотечения после родов см. на с. 266. Как правило, окситокси (эргонин, окситоцин и т.д.) следует употреблять для остановки кровотечения только после рождения ребенка. Их применение для ускорения родов или придания силы матери при родах может быть опасным для матери и для ребенка. Его никогда не следует давать, пока не родится ребенок, а еще лучше до выхода последа. Если много крови перед выходом плаценты (но после рождения ребенка), введите в мышцу 1/2 мл (5 Е.) окситоцина. Не употребляйте эргонин перед выходом последа, так как это может помешать выходу последа.

Питуитрин напоминает окситоцин, но более опасный, и его следует применять только для оказания срочной помощи при кровотечении, когда окситоцин и эргонин недоступны.

От кровотечения у новорожденного ребенка применяйте витамин К (с. 394).

Эргоновин и эргометрина малеат (Эрготрат, Метергин)

Название: _____

Часто выходит в:
инъекциях по 0.2 г в 1 мл ампуле
Цена: _____ за _____
таблетках по 0.2 мг
Цена: _____ за _____

Для предупреждения или остановки сильного кровотечения после выхода плаценты.

Доза для инъекций эргоновина:

От сильного кровотечения (более чем 2 чашки) после выхода плаценты (последа) введите 1 или 2 ампулы (0.2-0.4 мг) эргоновина внутримышечно (или 1 ампулу внутривенно в случаях оказания срочной помощи). Дозу можно повторить, если необходимо, через полчаса или 1 час. Помните на таблетки, как только прекратится кровотечение.

Доза эргоновина в рот – прием таблеток 0.2 мг:

Чтобы предупредить сильное кровотечение после родов или уменьшить потерю крови (особенно у матерей с анемией), дайте по 1 таблетке 3-4 раза ежедневно, начиная со времени выхода последа. Если кровотечение тяжелое, 2 таблетки можно дать в каждой дозе.

Окситоцин (Питоцин)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выходит в: ампулах по 10 Е. в 1 мл

Чтобы помочь остановить сильное кровотечение у матери после рождения ребенка и перед выходом плаценты. (Еще помогает выбросить плаценту, но не следует употреблять для этого, пока есть сильное кровотечение или большое отклонение).

Дозировка окситоцина для матери после рождения ребенка: Укол 1/2 мл (5 единиц). Если продолжается сильное кровотечение, сделайте другой укол 1/2 мл через 15 минут.

ОТ ШИШЕК (ГЕМОРРОЯ)

Свечи от геморроя

Название: _____ цена: ____ за ____

Это специальные пулеобразные таблетки вводятся в анус. Они помогают уменьшить геморрой и сделать его менее болезненным. Есть еще много различных препаратов. Те, которые хорошо помогают, дороже, содержат кортизон или кортикостероид. Специальные мази тоже доступны. Важны диеты для смягчения стула (см. с. 126).

Дозировка:

Вставьте свечу в анус после дневного испражнения, а другую перед сном.

ОТ НЕДОЕДАНИЯ И АНЕМИИ

Порошковое молоко (сухое молоко)

Название: _____ цена: ____ за ____

Молоко – один из лучших продуктов для предупреждения и лечения истощения. Для малышей самое лучшее молоко матери. Молоко богато витаминами для строения тела и минералами. В каждой деревенской станции здоровья или в сумке следует держать запас порошкового молока для лечения истощенных детей. Чтобы ребенок получил полное питание, смешайте сухое молоко с сахаром и маслом (см. с. 120).

В 1 чашку кипяченой воды положите:
12 полных чайных ложек сухого молока,
2 полные чайные ложки сахара,
и 3 чайные ложки масла

Смесь витаминов (или поливитамины)

Название: _____ цена: ____ за ____

Они выходят во многих формах, но таблетки обычно самые дешевые и действуют хорошо, инъекции витаминов редко необходимы. Это трата денег, вызывает ненужные боли и иногда нарывы. Тоники и эликсиры часто не имеют важные витамины и обычно слишком дорогие для того, как они действуют.

Питательная еда – наилучший источник витаминов. Если нужны дополнительные витамины, то употребляйте витаминные таблетки.

В некоторых случаях при плохом питании может помочь добавка витаминов. Убедитесь, что в таблетках содержатся важные витамины, необходимые больному (см. с. 188). Пользуйтесь стандартными таблетками поливитаминов, достаточно 1 таблетки ежедневно.

Витамин А (ретинол) – от ночной темноты и ксерофтальмии

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выходит как: капсулы по 200000 Е.,
60 мг ретинола
(также в меньших дозах)
инъекции по 100000 Е.

ВНИМАНИЕ: Слишком много витамина А может вызвать припадки. Не давайте слишком много и держите подальше от детей.

Для профилактики: В тех местах, где ночная слепота и ксерофтальмия – обычные проблемы у детей, они должны кушать больше желтых фруктов и овощей и овощных растений с темно-зелеными листьями, животную пищу, такую как яйца и печень, масло. В печени рыбы очень много витамина А. Или можно дать витамин А в капсулах. Принимайте капсулу один раз каждые 4-6 месяцев – не больше для предупреждения.

Матери могут предупредить глазные болезни детей, принимая 1 капсулу витамина А (200000 Е.) внутрь, когда ребенок родится или в течение 1 месяца после рождения.

У детей с корью особенно большой риск ксерофтальмии и им следует давать витамин А, когда начинается болезнь.

В местах, где дети не получают достаточно витамина А, добавляют продукты или капсулы с витамином А, что часто помогает детям пережить корь и другие серьезные болезни.

Для лечения: Дайте 1 капсулу витамина А (200000 Е.) в рот или инъекция в 100000 Е. На следующий день дайте 1 капсулу витамина А (200000 Е.) в рот и другую капсулу 1-2 недели спустя. Для детей до 1 года уменьшите все дозы вдвое.

Железа сульфат (закисного железа сульфат) – от анемии

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выходит в: таблетках 200, 300 или 500 мг (также в каплях, микстурах и эликсирах для детей)

Закисного железа сульфат полезен при лечении или предупреждении большинства анемий. Лечение сульфатом закисного железа обычно занимает по крайней мере 3 месяца. Если не наступает улучшение, анемия возможно вызвана чем-то другим, а не недостатком железа. Обратитесь за медицинской помощью. Если это трудно, старайтесь лечиться фолиевой кислотой.

Закисного железа сульфат особенно важен для беременных женщин, у которых может быть анемия и истощение.

Железо действует лучше, если его принимать вместе с витамином С (или с фруктами и овощами или витамином С в таблетках).

Закисного железа сульфат иногда вызывает расстройство в желудке и его лучше применять с едой. Еще он может вызвать запор и от него испражнения могут быть черными.

Для детей до 3 лет кусочек таблетки растереть очень хорошо и смешать с едой.

ВНИМАНИЕ: Постарайтесь, чтобы доза была правильной. Слишком много закисного железа сульфата может быть ядом. Держите таблетки подальше от детей. Не давайте его сильно истощенным людям.

Дозировка закисного железа сульфата от анемии:

–прием таблеток по 200 мг–

Принимать 3 раза в день с едой.

В каждой дозе принимать:

взрослым: 200-400 мг (1-2 таблетки)

детям выше 6 лет: 200 мг

(1 таблетку)

детям 3-6 лет: 100 мг (1/2 таблетки)

детям до 3 лет: 25-50 мг (1/8-1/4

таблетки) растереть хорошо и смешать с едой.

Фолиевая кислота – от некоторых видов анемии

Название: _____ цена: ____ за ____

Часто выходит в: таблетках 5 мг

Фолиевая кислота может быть важной в лечении того вида анемии, в которой клетки крови разрушаются в венах как в случаях с малярией. Человек с анемией, у которого увеличена селезенка или если он выглядит желтым, нуждается в фолиевой кислоте, особенно если она не проходит от закисного железа сульфата. Малышам (с анемией), которые питаются козьим молоком, и беременным женщинам с анемией или с истощением часто нужна фолиевая кислота так же, как и железо.

Фолиевую кислоту можно получить, когда вы питаетесь темно-зелеными овощами с листьями, мясом или печенью или принимаете фолиевую кислоту в таблетках. Обычно 2-недельное лечение достаточно для детей, хотя в некоторых местах дети с серповидной болезнью или тем видом анемии, который называется талассемия, могут нуждаться в этом годами. Беременным женщинам, у которых анемия и истощение, поможет прием фолиевой кислоты и железных таблеток ежедневно все время беременности.

Дозировка фолиевой кислоты от анемии:

– прием 5 мг таблеток–

Принимать внутрь один раз в день.

взрослым и детям выше 3 лет:

1 таблетку (5 мг)

детям до 3 лет: 1/2 таблетки

(2 1/2 мг)

Витамин В₁₂ (цианокобаламин) – от злокачественной анемии только

Это упоминается только для того, чтобы отговорить его употребление. Витамин В₁₂ полезен только от редкого типа анемии, которую почти никогда не находят, кроме некоторых людей выше 35 лет, чьи предки вышли из Северной Европы. Многие врачи прописывают ее, когда в нем не нуждаются, просто, чтобы дать своим пациентам что-нибудь. Не тратьте своих денег на витамин В₁₂ и пусть врач или медработник дает вам до тех его, когда сделают анализ крови и он покажет вам, что у вас злокачественная анемия.

Витамин К (фитоменадион, фитонадион)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выходит в: ампулах 1 мг в 2.5 мл
молочного раствора.

Если у новорожденного ребенка начинается кровотечение из любой части тела (рот, пуповина, анус), это может быть вызвано недостатком витамина К. Сделайте инъекцию 1 мг (1 ампула) витамина К во внешнюю часть бедра. Не делайте больше инъекций, даже если кровотечение продолжается. У малышей, рожденных с малым весом (ниже 2 кг), инъекция витамина К может уменьшить риск кровотечения.

Витамин К не употребляется для остановки кровотечения у матери после родов.

Витамин В₆ (пиридоксин)

Часто выходит в: 25 мг таблетках
Цена: _____ за _____

У больных туберкулезом, которые лечатся изониазидом, иногда развивается недостаток витамина В₆. Чтобы предупредить это, можно принимать ежедневно 50 мг витамина В₆ (пиридоксина), пока пьете изониазид. Или витамин нужно давать только людям, у которых возникают проблемы из-за его недостатка. Признаки включают боль или покалывание в пальцах рук и ног, судороги мышц, нервозность и бессонницу.

Дозировка витамина В₆ – принимая изониазид.

Принимайте 2 таблетки по 25 мг ежедневно.

МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ: ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ

Оральные Контрацептивы (противозачаточные пилюли)

Информацию об употреблении, риске и мерах предосторожности для противозачаточных пилюль можно найти на с. 286, 289. Следующая информация о выборе правильных таблеток для каждой женщины.

Большинство противозачаточных таблеток содержит 2 химических вещества или гормоны подобные тем, которые вырабатываются в теле женщины для контроля над ее периодом. Эти гормоны называются эстроген и прогестерон. Пилюли выходят под многими различными торговыми марками, различной силы и сочетаниями из 2 гормонов.

Обычно марка, которая содержит относительно малое количество обоих гормонов, самая безопасная и хорошо действует для большинства женщин. Многие женщины начинают с пилюль из Группы 1 или 2.

Группа 1. довольно низкое количество эстрогена и прогестерона.

Бревикон 1+35
Неокон
Норинил 1+35, 1+50
Норимин
Орто-Новум 1/35, 1/50
Перле
Норидей 1+50
Овисмен 1/35

Логинон	Количество гормонов
Синофаз	в этих марках меняется
Тринордиол	в течение месяца,
Триновум	поэтому важно принимать
Трихилар	эти пилюли по порядку.
Трипхасил	

Название: _____ цена: _____

Чтобы убедиться в эффективности и свести к минимуму “мазню” крови, важно принимать пилюли в одно и то же время каждый день, особенно с пилюлями, у которых низкое количество гормонов.

Женщины, обеспокоенные мазней во время второй недели после периода, могут уменьшить проблему, принимая 2 таблетки ежедневно вместо одной в то время, когда появляется мазня. (Чтобы избежать путаницы, примите дополнительно таблетки из отдельной упаковки, убедившись, что они одинакового цвета.)

Если мазня продолжается после 3-4 месяцев, вы можете поменять на одну из марок Группы 2. Если же продолжается кровотечение между периодами после 3 или более месяцев, попробуйте марку из Группы 3.

Как правило, женщины, которые принимают противозачаточные таблетки, меньше кровоточат во время своих периодов. Это выгодно, особенно для женщин с анемией. Но если у женщин пропускается период в течение месяцев или она обеспокоена малым количеством крови в ее периоде, она может поменять на марку с повышением эстрогена, в Группе 3.

Для женщин, у которых сильные менструальные кровотечения или болят груди перед началом цикла, может быть лучше марка с высоким прогестероном, но с низким эстрогеном. Например:

Группа 2. высокий прогестерон, низкий эстроген

Ло-Фемал
Ло-Оврал
Микрогинон 30
Микровлар
Нордет

Название: _____ цена: _____

Марки из Группы 2 не рекомендуются для женщин, у которых прыщи, много волос под мышкой или на губе – большое количество прогестерона усилит или даже вызовет эти явления.

Женщинам, у которых продолжается смещение периодов или мазня после употребления марки из Группы 2 или которые забеременели раньше, чем меняли вид таблеток, можно заменить на таблетки с меньшим количеством эстрогена. Например:

Группа 3. несколько выше содержание эстрогена. Большинство из них имеют больше прогестерона.

Миновлар
Норлестрин
Овкон 50
Фемал
Эугинон
Нордиол
Оврал
Примовлар
Неогинон

Название: _____ цена: _____

Марки Овулен и Демулен часто останавливают мазню, которая продолжается даже, когда принимаете пилюли из группы 3. Но они сильные по эстрогену, и поэтому их редко рекомендуют. Они иногда полезны женщинам с сильными угрями.

Женщинам, которых беспокоят утрення тошнота или другие побочные эффекты после 2 или 3 месяцев приема пилюль, и женщины, у которых большой риск сгустков крови (см. с. 288), могут пользоваться маркой противозачаточных пилюль с низким эстрогеном и прогестероном. Например:

Группа 4. очень низкий эстроген и прогестерон

Бревикон
Бревинор
Модикон
Овкон
Овисмен
Перле LD
Лозэстрин 1/20

Название: _____ цена: _____

Недостатки марок Группы 4 те, что они часто вызывают мазню в середине периода и есть повышенный риск забеременеть, если забыть даже одну таблетку.

Женщины, которые кормят грудью, или те, кто нерегулярно принимает таблетки из-за головной боли, легкого повышения кровяного давления или потому, что им за 40, могут захотеть употреблять пилюли только с прогестероном. Это называется “мини-пилюли”. Например:

Группа 5. только прогестерон – мини-таблетки

Фемулен
Микронон
Микролют
Микроновум Нор-QD
Оврет

Название: _____ цена: _____

Эти таблетки должны приниматься в тоже время каждый день, даже во время периода. Менструальные кровотечения часто нерегулярные. Есть повышенный шанс забеременеть, если таблетка забыта.

Презервативы (Резинки, Предохранители, Футляры)

Название: _____ цена: _____ за _____

Часто выходят в упаковке по 3.

Есть много различных марок презервативов. Некоторые из них смазаны, некоторые различаются цветом и некоторые со спермицидами.

Кроме того, что презервативы помогают избежать беременности (особенно со спермицидами), они могут помешать распространению болезней, передаваемых половым путем. Многие люди пользуются презервативами без других противозачаточных средств.

О применении презервативов см. с. 290.

Колпачок

Название: _____ цена: _____

Для эффективности колпачок следует употреблять со спермицидным кремом или желе, намазывая ими ободок колпачка перед тем, как вложить во влагалище (см. с. 290).

Название желе или крема _____ цена: _____

Контрацептивная Пена (Хорошо известные марки: Эмко, Лемпко, Дельфен)

Название: _____ цена: _____

Об употреблении пены см. с. 290.

Контрацептивные свечи (Обычная марка: Нео Шампунь)

Название: _____ цена _____

Это таблетка со спермицидом, которую женщина закладывает глубоко во влагалище около шейки матки. Свеча закладывается за 15 минут до секса. (Следуйте инструкциям на пакете.) Это очень эффективный метод контроля рождаемости, особенно если пара пользуется презервативом.

Внутриматочная спираль (ВМС)

Название: _____ цена _____
плата за их введение: _____

Для информации о ВМС см. с. 290. Есть несколько разных видов: Медь Т, Медь 7, Липпес петля и Безопасная спираль. Другой вид, называемый Прогестасерт, следует убирать чаще других. Один вид ВМС – Щит Далкона – вызывает больше проблем, чем другие, и лучше им не пользоваться.

Из-за инфекций и других проблем, которые могут произойти с ВМС, пользоваться ими могут только женщины, которые живут близко от медицинского центра. ВМС могут пользоваться женщины, которые не хотят больше иметь детей, но при появлении инфекции трудно будет забеременеть позже.

Наилучший момент для введения ВМС – это месячные или сразу после них.

Инъекции Контрацептивов

(обычные марки: Депо-Провера, Нет-Эн)

Название: _____ цена: _____

Инъекции контрацептивов используют во многих странах, несмотря на возражения по поводу безопасности. Многие верят, что они безопасны, кроме тех женщин, которые по медицинским причинам не могут пользоваться противозачаточными пиллюлями (с. 293).

Месячные могут приходиться нерегулярно, становится скудными или прекратиться через год. Это несерьезно, но беспокоит многих. Стареющие женщины по ошибке принимают это за климакс, перестают делать инъекции и беременеют. В случае сильных кровотечений обратитесь к врачу.

Противозачаточные импланты (Обычная марка: Норплант)

Название: _____ цена _____
плата за их введение: _____

Импланты – очень эффективная и удобная форма контроля рождаемости. Они содержат только прогестерон и их могут использовать женщины, которым не следует регулярно пить таблетки из-за головной боли, повышенного кровяного давления или потому, что им за 40.

Шесть маленьких резиновых трубок вшиваются опытным медработником под кожу в верхнюю часть руки женщины. Они предупреждают беременность в течение 5 лет, но можно убрать сразу, как только женщина захочет забеременеть. Трубочки вшиваются спустя 7 дней после начала цикла.

ВПИШИТЕ СЮДА ИНФОРМАЦИЮ О ДРУГИХ ЛЕКАРСТВАХ ИЛИ ДОМАШНИХ
СРЕДСТВАХ ЛЕЧЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫХ В ВАШЕЙ МЕСТНОСТИ.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ПРИЛОЖЕНИЕ 2

В это исправленное издание книги “Там, где нет доктора” мы добавили несколько новых тем, чтобы сделать книгу более полной и современной. Одна из тем — **СПИД** — о новой болезни, которая быстро распространяется по всему миру. Осложнения после **нелегального аборта, отравления пестицидами и пристрастие к наркотикам** — это проблемы, которые пагубно воздействуют в последнее время на все большее число людей. Другие темы мы включили по многочисленным просьбам. Мы добавили раздел по измерению кровяного давления, поскольку книга широко используется работниками здравоохранения, некоторые из которых имеют приборы для измерения кровяного давления.

СПИД (СИНДРОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА, ВИЧ)

СПИД — это новая и опасная болезнь, которая передается от человека к человеку посредством вируса. Он обнаружен сейчас во многих странах и становится все более распространенной болезнью.

СПИД лишает организм возможности сопротивляться болезни. Человек со СПИДом заболевает очень легко различными болезнями, такими как понос, пневмония, туберкулез или тяжелый вид рака кожи. Большинство больных СПИДом умирают от этих болезней, так как организм не может с ними справиться.

СПИД передается, когда кровь, сперма или выделения из влагалища кого-то с вирусом СПИДа попадают в тело другого человека. Он может распространяться через:

Секс с человеком, зараженным СПИДом



Человек с беспорядочными половыми связями, подвержен большому риску СПИДа.

Использование одной иглы или шприца (или другого инструмента, которым разрезают кожу) без стерилизации.



Наркоманы, которые делают инъекции одной и той же иглой, тоже сильно рискуют.

Инфицированная мать заражает вирусом неродившегося ребенка.



иглой, тоже сильно рискуют. у матерей с вирусом СПИДа заражаются.

ВАЖНО: Вы можете заразиться СПИДом от человека, который выглядит совершенно здоровым. Часто проходят месяцы или годы с того дня, когда вирус попал в организм и когда появились первые признаки — **но человек все же может передавать СПИД другим при сексе или при использовании одной иглы.**

СПИД не передается при ежедневном бытовых контактах, таком как пожатие руки или совместное проживание, игра и питание. И еще он не распространяется через пищу, воду, насекомых, туалеты или общую посуду.

Признаки: Признаки СПИДа у разных людей проявляются не одинаково. Часто они являются типичными признаками других болезней, но тяжелее и продолжаются больше, чем обычно.

Если появляется совокупность этих 3 признаков и человек болеет сильнее и чаще, у него или у нее может быть СПИД (но вы не можете быть уверены в этом без специального теста):

- постепенная потеря массы тела. Человек худеет.
- понос больше 1 месяца
- и жар больше 1 месяца. Иногда он появляется и проходит.

У больного могут быть один или больше этих признаков:

- сильный кашель, который продолжается больше 1 месяца;
- дрожжевая инфекция во рту (“молочница”, см. стр. 232);
- опухшие лимфатические узлы в любом месте тела (стр. 88);
- кожная сыпь;
- бородавки или язвы, которые растут и не проходят при лечении, особенно вокруг половых органов и ягодиц;
- постоянное чувство усталости;
- больные с вирусом СПИДа быстрее заболевают туберкулезом (стр. 179) или бруцеллезом (стр. 204).



В Африке СПИД часто называют дистрофией, т.к. больной СПИДом сильно теряет в массе.

Лечение:

До сих пор нет лекарства для лечения СПИДа. Но потому, что больные СПИДом не могут бороться с инфекциями, им следует лечиться от этих инфекций:

- ◆ От поноса давайте регидроновый напиток (стр. 152).
- ◆ От молочницы применяйте генциан-виолет, нистатин или миконазол (стр. 232 и 373).
- ◆ От бородавок пользуйтесь двуххлоруксусной кислотой или подофиллином (стр. 374 и 402).
- ◆ От жара давайте побольше жидкости, аспирин и снижайте жар прохладными ваннами (стр. 75 и 76).
- ◆ Лечите кашель и пневмонию антибиотиками (стр. 170 и 171). Если кашель и жар сильные, проверьтесь на туберкулез. Проконсультируйтесь о предупреждении и лечении ТБ у больных с вирусом СПИДа.
- ◆ При зудящей коже давайте антигистамин (стр. 386) и лечите любую инфекцию (стр. 202).
- ◆ Берегите здоровье, насколько это возможно, хорошо питайтесь (см. Главу 11), не пейте, не курите, не употребляйте наркотики, хорошо отдыхайте и спите.

Нет нужды в том, чтобы больные СПИДом жили и спали отдельно от других. Их кожа и дыхание не распространяют инфекцию.

Дома семья и друзья могут дать больному любовь и поддержку, чтобы помочь ему подготовиться к приближению смерти (см. стр. 330).

Профилактика СПИДа:

- ◆ У вас должен быть только один надежный сексуальный партнер.
- ◆ Пользуйтесь презервативом, если вы или ваш партнер имели других партнеров по сексу (см. стр. 290). **Использование презерватива уменьшает риск заражения СПИДом.**
- ◆ Не вступайте в половую связь с людьми, у которых много партнеров по сексу, такими, как проститутки (женщины и мужчины) или с людьми, которые делают нелегально инъекции наркотиков.
- ◆ Лечите болезни, передаваемые половым путем, как можно раньше – особенно те, которые вызывают язвы.
- ◆ Не делайте уколы, пока не убедитесь, что инструменты простерилизованы. **Работники здравоохранения никогда не должны заново использовать шприц или иглу без предварительной стерилизации (см. стр. 74).**
- ◆ Не делайте нелегальные инъекции наркотиков. Если делаете, то не давайте эту же иглу или шприц кому-нибудь еще, пока не простерилизуете их в извести или в кипятке в течение 20 минут (см. стр. 74).
- ◆ Убедитесь в том, что инструменты для обрезания, проколов уха, акупунктуры и для традиционной практики такой, как рубцевание, простерилизованы.
- ◆ Если возможно, не применяйте переливание крови, пока не проверят сначала кровь. Избегайте переливания крови кроме тех случаев, когда это необходимо.
- ◆ Ищите способы защитить и научить детей-беспризорников, детей рабочих-мигрантов, наркоманов и детей других людей “высокого” риска какие принимать меры предосторожности, чтобы не заболеть СПИДом.
- ◆ В дальнейшем СПИД лучше всего предупредить борьбой за справедливые социальные и экономические условия, чтобы семьям не нужно было разъединяться в поисках работы и чтобы люди не продавали свое тело для секса.

Больным СПИДом, у которых температура, понос или боль, нужен особый уход. Это обычно делается без риска. Но чтобы предупредить распространение вируса, следует помнить некоторые вещи:

- ◆ Кровь, открытые язвы, кровавый понос и рвота с кровью могут распространять вирус. Чтобы предупредить прикосновение к ним, следует, если возможно, носить резиновые или пластиковые перчатки. Чаще мойте руки.
- ◆ С испачканной кровью одеждой или постельным бельем, или полотенцами нужно обращаться осторожно. Стирайте их в горячей мыльной воде или добавьте немного хлорной извести.



Будьте добрыми к больным СПИДом.

ЯЗВЫ НА ПОЛОВЫХ ОРГАНАХ

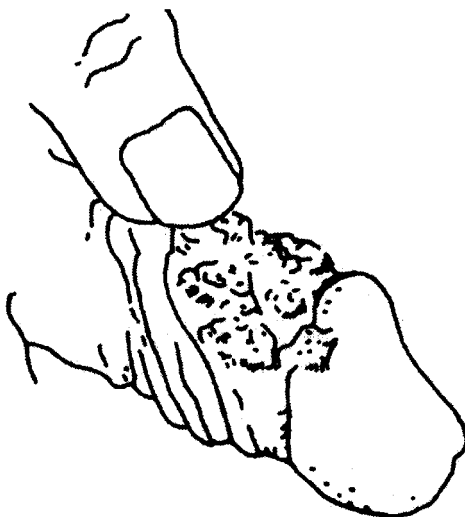
Отдельная, безболезненная язва на половых органах может быть признаком сифилиса (см. стр. 237). Но несколько язв, похожие, являются признаком другой передаваемой половым путем болезни: половые бородавки, половой герпес или мягкий шанкр.

Половые Бородавки (ВЕНЕРИЧЕСКИЕ Бородавки)

Причина этих бородавок – вирус, который передается половым путем. Они выглядят как бородавки на других частях тела (см. стр. 210), но их обычно больше.

Признаки:

Маленькие, плотные, беловатые или коричневатые кожные наросты с грубой поверхностью. У мужчин они обычно растут на пенисе, но могут также расти на мошонке или анусе (задний проход). У женщин они растут на губах влагалища, внутри влагалища или вокруг ануса.



Лечение:

Наложите небольшое количество двуххлоруксусной кислоты или подофиллина (см. стр. 374) на каждую бородавку. (Если возможно, сначала намажьте немного Вазелина или другой жирной мази на кожу вокруг каждой бородавки, чтобы защитить здоровую кожу.) Подофиллин должен быть смыт через 6 часов. Обычно требуется несколько сеансов лечения. Бородавки сморщиваются и проходят, но часто появляются опять.

Профилактика:

Мужчина должен надевать презерватив (см. стр. 290) во время секса, если у него или его партнера есть половые бородавки.

Использование презерватива каждый раз во время полового контакта помогает предупредить распространение бородавок, герпеса, мягкого шанкра, СПИДа и других болезней, передаваемых половым путем.

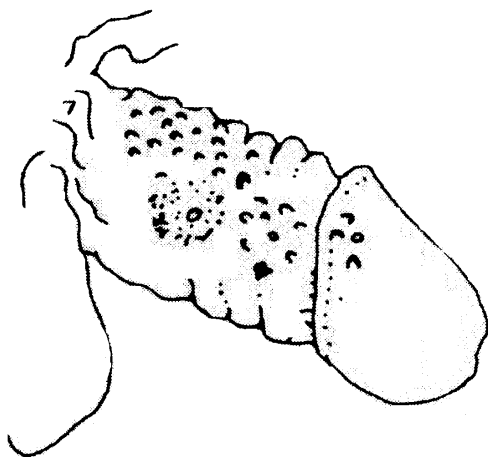
Половой Герпес

Половой герпес – это болезненная кожная инфекция, вызванная вирусом. На половых органах появляются маленькие волдыри. Половой герпес передается от человека к человеку во время полового контакта. Половой герпес иногда появляется во рту при оральном сексе. Но этот герпес отличается от другой разновидности герпеса, который обычно бывает во рту, но не передается половым путем (см. Простудные болячки, стр. 232).

Признаки:

- На половых органах (пенисе или влагалище), анусе, ягодицах или бедрах появляется один или несколько маленьких болезненных волдырей, похожих на капли воды.
- Волдыри лопаются и образуют маленькие открытые язвы.
- Они высыхают и образуют струпья.

Язвы герпеса могут продолжаться в течение 3 недель и больше с жаром, болью, ознобом и опухшими лимфатическими узлами в паху. У женщин возникают проблемы с мочеиспусканием.



Вирус остается в организме после исчезновения всех признаков. Новые волдыри могут появиться в любое время спустя недели и годы. Обычно новые язвы появляются на том же месте, но меньше, не такие болезненные, лечатся быстрее.

Лечение

Нет лекарств для лечения герпеса. Содержите в чистоте половые органы. Не имейте половых контактов, пока есть волдыри или болячки – даже с презервативом.

Мойте руки и старайтесь не трогать раны. Инфекция может попасть в глаза, если человек трет их после того, как он трогал ранки.

ОСТОРОЖНО: Если у женщины герпес, при родах ее ребенок может заразиться. Это очень опасно. Если у вас герпес на половых органах, сообщите об этом работнику здравоохранения или акушерке.

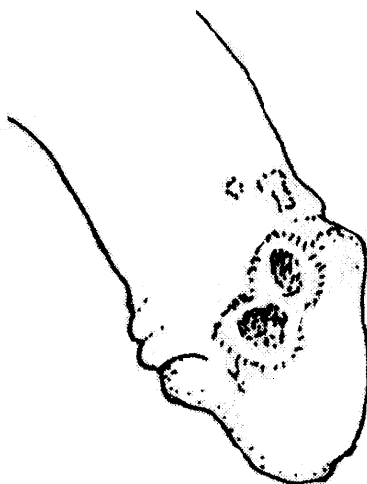
Мягкий Шанкр

Признаки:

- мягкая, **болезненная** язва на половых органах или анусе
- увеличение лимфатических узлов (бубоны) в паху

Лечение

- ◆ Давайте ко-тримоксазол (стр. 358) или эритромицин (стр. 355) в течение 7 дней.
- ◆ Хорошо одновременно проводить лечение и от сифилиса (стр. 237).
- ◆ Если увеличены лимфатические узлы, найдите врача, который сможет вывести гной из них при помощи дренажа.



ОБРЕЗАНИЕ И ОТРЕЗАНИЕ (ОТРЕЗАНИЕ КОЖИ ОТ ПОЛОВОГО ОРГАНА)

Во многих странах обрезание мальчиков – а в некоторых частях мира даже девочек – традиционный “обряд” или “обычай”. Для здоровья в этом нет необходимости. Мальчикам обычно оно не приносит вреда. **Но для девочек эта практика – называемая отрезанием – очень опасна и от нее следует сильно отговаривать.**

Мальчики

Мальчик рождается со свободной складкой кожи (крайняя плоть), покрывающей “головку” его пениса. Пока моча выходит из дырочки на кончике, проблем не бывает. Крайняя плоть обычно полностью покрывает головку пениса пока мальчику меньше 4 лет. Это нормально и обрезание **не обязательно**. Не старайтесь силой оттянуть плоть назад.

Однако если плоть становится красной, опухшей и такой жесткой, что мальчик не может мочиться без боли, это ненормально. Отведите его поскорее к работнику здравоохранения для обрезания.

Как семейный ритуал, простое обрезание здорового мальчика может быть сделано акушеркой или человеком с опытом. Пользуясь новой бритвой, она отрезает немного плоти над головкой пениса. После обрезания будет небольшое кровотечение. Крепко зажмите пенис чистой тканью или марлей на 5 минут, пока не остановится кровотечение. Некоторые целители используют сок растения, чтобы помочь остановить кровотечение (см. стр. 13).



Если кровотечение не остановилось, смойте сгустки крови чистой водой и зажмите конец плоти между пальцами кусочками чистой ткани до тех пор, пока не остановится кровотечение. Не нужны никакие лекарства.

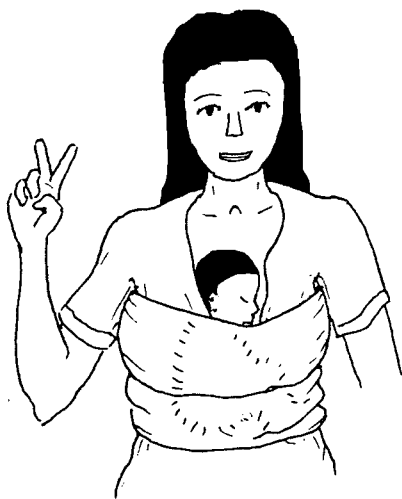
Девочки

При обрезании девочек или “отрезании” отрезается мягкая шишка плоти (клитор) в верхней части влагалища. Иногда отрезается и часть половых губ. Убирать клитор так же плохо, как и отрезать головку пениса мальчика. **Отрезание не следует делать.** У девочек, которым сделали отрезание, часто бывают инфекции мочевой системы и влагалища и трудности во время родов.

Существует опасность сильного кровотечения во время отрезания. **Ребенок может умереть** за несколько минут. Действуйте быстро. Вымойте сгустки, чтобы определить точку, откуда идет кровь, и придавите сильно на 5 минут. Если кровотечение продолжается, держите зажатым кровоточащее место, пока несете ребенка к работнику здравоохранения или к врачу для оказания помощи.

ОСОБЫЙ УХОД ЗА МАЛЕНЬКИМИ, РАННИМИ И НЕДОНОШЕННЫМИ ДЕТЬМИ – “КЕНГУРУ”

Ребенок, который рождается очень маленьким (весит меньше 2 1/2 кг или 5 фунтов), нуждается в особом уходе. Если возможно, доставьте ребенка в центр здоровья или в больницу. В больнице этих детей держат в теплом и защитном специальном боксе с контролируемой температурой, который называется инкубатором. Но ребенка, который в основном здоров, мать сама может обеспечить таким же теплом и защитой, используя способ “кенгуру”:



- Поместите ребенка голым, в пеленке или без нее прямо к себе под одежду между грудями. (Поддерживать его помогает свободная блуза, свитер или повязка на талии).
- Давайте ребенку сосать грудь столько, сколько он хочет, по крайней мере каждые 2 часа.
- Спите так, чтобы поддерживать ребенка в вертикальном положении.
- Мойте ребенка лицо и низ живота каждый день.
- **Убедитесь, что ребенку все время тепло.** Если прохладно, оденьте ребенку еще одежду и закройте ему головку.
- Пока вы купаетесь или отдыхаете, попросите отца или другого члена семьи “сделать кенгуру”.
- Регулярно показывайте ребенка работнику здравоохранения. Убедитесь, что ему сделали все прививки (см. стр. 147).
- Давайте ребенку железо и витаминные добавки – особенно витамин D (см. стр. 392).

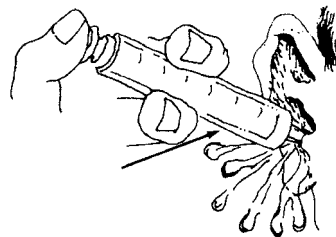
УШНАЯ СЕРА

Немного серы в ушах нормально. Но у некоторых людей накапливается слишком много серы или она засыхает твердым куском близко к барабанной перепонке. Это может блокировать ушной канал так, что человек начинает плохо слышать.

Лечение:

Чтобы удалить серу, сначала размягчите ее, налив несколько капель теплого растительного масла в ухо человека. Затем положите его на бок, ухом вверх на 15 минут. После этого хорошо промойте ухо, вливая в него несколько чашек теплой (не горячей) воды.

Если это не поможет, уберите иглу из шприца, наполните шприц теплой водой и введите его в ушной канал. Повторите это несколько раз, пока сера не выйдет. Прекратите, если человек чувствует головокружение. Если все-таки сера не вышла, обратитесь к врачу.



шприц без иглы

ЛЕЙШМАНИОЗ

Эта болезнь обнаружена в Африке, в Индии, на Среднем Востоке, в южной части Мексики, Центральной Америке и Южной Америке. Инфекция передается от человека к человеку маленькой песчаной мухой, которая заражает человека при укусе.

Некоторые формы болезни вызывают поражения внутри тела (Внутриполостной лейшманиоз, Кала-азар, Дум-дум лихорадка). Их очень трудно распознать, а лечение сложное и дорогое. Если можно, обратитесь за медицинской помощью.

Другие формы воздействуют в основном на кожу (Кожный лейшманиоз, Тропические язвы, Протозойное поражение кожи, Лесная фрамбезия, Ута, Язва слизистой оболочки рта). Их легче лечить.

Признаки лейшманиоза кожи:

- Через 2-8 недель после укуса появляется опухоль в месте укуса мухи.
- Опухоль становится открытой раной, обычно с гноем.
- Раны могут заживать сами, а могут не заживать несколько недель и до 2 лет.
- Раны очень легко становятся инфицированными (бактериями).

Лечение:

Промойте рану прохладной кипяченой водой.

- ◆ Приложите горячую влажную тряпочку на рану (не очень горячую, чтобы не обжечь кожу) на 10-15 минут.
- ◆ Делайте это по 2 раза в день в течение 10 дней. Такое "горячее лечение" часто приносит полное выздоровление.
- ◆ Если раны выглядят инфицированными (красные и болезненные), давайте антибиотики (см. стр. 351).

РИШТА

Ришта – это длинные, тонкие черви, которые живут под кожей и вызывают болезненную рану на лодыжке, ноге или еще где-нибудь на теле. Червь, который выглядит как белая нитка, может быть длиной до 1 метра. Ришта водится в некоторых частях Африки, Индии и Среднего Востока.

Ришта передается от человека к человеку вот так:

1. Инфицированный человек с открытой раной переходит вброд водоем. Червь высовывает головку из раны и откладывает тысячи яиц в воду.
2. Крошечные водяные блохи подбирают яйца червей.
3. Другой человек пьет ту же воду. Блохи с яйцами глистов заглатываются.
4. Некоторые яйца медленно превращаются в червей под кожей, но сначала человек ничего не чувствует. Спустя год, образуются язвы, когда взрослые черви протыкают кожу, чтобы отложить яйца.

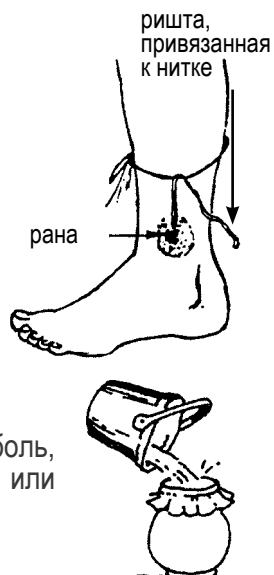


Признаки:

- Болезненные опухоли развиваются на лодыжке, ноге, яичке или еще где-нибудь на теле.
- Через неделю появляются волдыри, которые лопаются и образуют язву. Это часто случается, когда стоите в воде или купаетесь. Кончик белой, нитеподобной ришты можно видеть торчащим из раны.
- Если рана грязная и инфицированная, боль и опухоль распространяются и хождение становится невозможным. Иногда появляется столбняк (см. стр. 182).

Лечение:

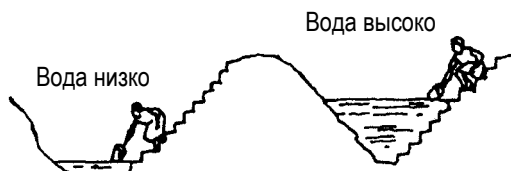
- ◆ Соблюдайте чистоту вокруг раны. Подержите рану в холодной воде, чтобы вылезли головки червей.
- ◆ Привяжите нитку к червь или оберните его вокруг палочки и осторожно вытягивайте, понемногу каждый день. Это может занять неделю или больше. Червь может быть длиной больше метра! Старайтесь не порвать его, потому что это может вызвать сильную инфекцию.
- ◆ Давайте метронидазол и тиабендазол, чтобы помочь уменьшить дискомфорт и облегчить вытягивание глиста. (Лекарство не убивает глистов. Дозу и меры предосторожности см. на стр. 369 и 375).
- ◆ Введите противостолбнячную вакцину (стр. 147).
- ◆ Если рана инфицирована (распространяется боль, краснота, опухоль и температура), дайте пенициллин или диклосикллин или подобный антибиотик (см. стр. 351).



Предупреждение:

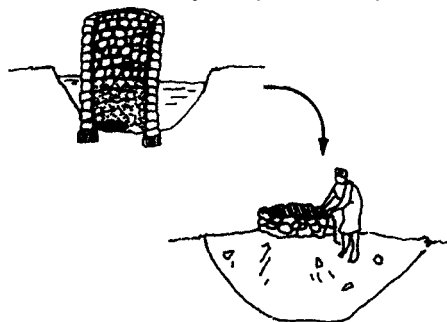
Используйте для питья водопроводную воду, если можно. Если источник воды единственный, тогда не пейте прямо из него. Процедите воду через чистую тряпочку в специальный питьевой горшок. Тряпочка профильтрует зараженную блохами воду.

- Если общество может построить каменные ступеньки к источнику воды, люди могут черпать воду с последней сухой ступени без того, чтобы намочиться.



**ВСЕГДА ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОСЛЕДНЕЙ СТУПЕНЬКОЙ.
НИКОГДА НЕ СТУПАЙТЕ В ВОДУ.**

- Или превратите водный источник в колодец так, чтобы люди могли достать воду ведром на веревке.



Если никто не ходит или не купается в воде, которую используют для питья, эта инфекция не сможет передаваться другим и со временем исчезнет из этой местности.

СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРОСТУДЕ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ Тела (ГИПОТЕРМИЯ)

В холодном климате или при холодной, мокрой и ветряной погоде, люди, которые недостаточно тепло одеты, могут терять тепло своего тела. **Это очень опасно.** Часто человек не может понять, что с ним случилось. Он настолько теряется, что не просит помощи и может умереть.

Признаки:

- неудержимое дрожание;
- медленная и невнятная речь;
- спотыкается, когда идет;
- не может думать ясно;
- чувствует себя очень усталым.

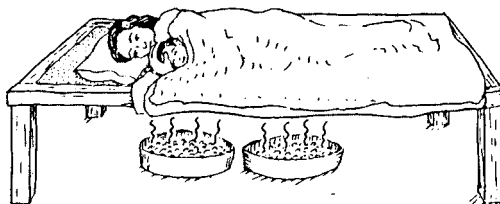
Лечение:

- ◆ Быстро отведите человека в сухое место, защищенное от ветра.
- ◆ Если у него мокрая одежда, снимите ее и накройте его сухой одеждой. Заверните его в сухое одеяло.
- ◆ Убедитесь, что его голова, ноги и руки накрыты.
- ◆ Нагрейте несколько камней на огне и заверните их в тряпку. Положите теплые камни на спину, грудь и пах.



ВНИМАНИЕ: Не согревайте больного слишком быстро, так как это может вызвать проблемы с сердцем и смерть.

- ◆ Делайте все, что можете, чтобы держать его в тепле. Если это ребенок, спрячьте его к себе под одежду ближе к телу (см. "Кенгуру", стр. 405). Или спите с ним на руках. Если можно, пусть кто-нибудь ляжет с другой стороны. Или поставьте горячие сковородки с углями или масляные лампы под койку. (Будьте осторожны, чтобы не обжечься и не было жарко).
- ◆ Дайте ему съесть или выпить сладости, такие как сахар, леденцы, мед, сладкие спелые фрукты или фруктовые соки. Если у вас их нет, дайте ему крахмалистую пищу типа риса, хлеба, бананов или картошки.



сковородки с горячими углями

Если человек перестал дрожать, но все же присутствуют некоторые из вышеописанных признаков, или если он без сознания, его состояние очень серьезное. Постарайтесь согреть его, но если он не просыпается, **быстро вызывайте медицинскую помощь.**

ОПАСНОЕ ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ У ДЕТЕЙ И БОЛЬНЫХ

Иногда, особенно в прохладную погоду, младенец, больной ребенок и очень старый, больной, истощенный или слабый человек могут так замерзнуть, что температура у них опускается ниже нормальной. Могут появиться признаки, упомянутые на предыдущей странице, и человек может умереть. Старайтесь поднять температуру тела, согрев больного, как описано на стр. 408.

ОБМОРОЖЕННАЯ КОЖА (ОТМОРОЖЕНИЕ)

В морозную погоду, если человек одет недостаточно тепло, у него могут замерзнуть руки, ноги, уши и иногда лицо. **Отморожение очень опасно.** При полном отморожении кожа отмирает и позже становится черной (стр. 213). Эта часть может быть отрезана (ампутирована).

Признаки отморожения:

- Сначала онемение, а чаще резкая боль в одной части тела.
- Затем чувствительность пропадает и эта часть замерзает сильнее.
- Эта часть становится бледной и чувствуется уплотнение, когда дотрагиваются до нее.

Лечение легкого отморожения: Если ощущаете, что кожа еще мягкая, возможно, у больного "легкое отморожение". Заверните эту часть в сухую тряпочку и согрейте ее от другой части тела больного или от другого человека. Старайтесь двигаться и выбраться из холода как можно быстрее.

Лечение сильного отморожения: **ОСТОРОЖНО:** Не начинайте лечение от сильного отморожения до тех пор, пока вы не попадете туда, где все тело больного можно держать в тепле во время и после лечения. Лучше позволить руке или ноге оставаться замерзшими несколько часов, чем нагреть, а потом заморозить снова. Когда попадете в теплое защищенное место:

- ◆ Наполните большую емкость теплой водой (**не горячей**), чтобы ощущать комфорт, когда вы держите в ней руки.
- ◆ Подержите замерзшее место больного в воде, пока оно не согреется.
- ◆ Если вода остывает, добавляйте теплой. Но убирайте руку или ногу больного из воды, когда делаете это. Помните, замерзший не может чувствовать, насколько вода горячее, и вы можете легко обварить его.
- ◆ Как только замерзшая часть согреется, она становится болезненной. Дайте аспирин или кодеин (стр. 379 и 384).
- ◆ Когда больной отходит от мороза, он должен оставаться в тепле и отдыхать.
- ◆ Будьте очень осторожны с отмороженным участком. Лечите, как лечили бы серьезную рану или ожог (стр. 96). Обратитесь за медицинской помощью. Иногда омертвевшие части тела должен удалять хирург.



Согрейте руки и ноги у тела.

Постарайтесь укутать лицо и уши.

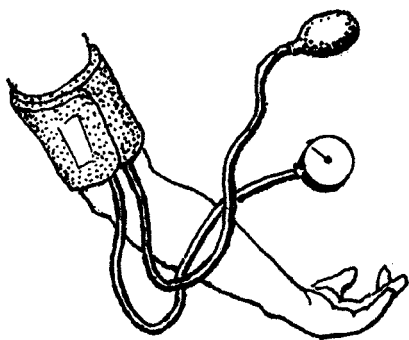


КАК ИЗМЕРЯТЬ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Измерение кровяного давления должно быть важным профессиональным навыком у работников здравоохранения и акушеров. Это особенно полезный инструмент для обследования:

- Беременных женщин (см. стр. 249, 251 и 253).
- Матерей до родов и после рождения ребенка (см. стр. 265).
- Больных, которые потеряли много крови из любой части тела, внутреннее или внешнее кровотечение (см. стр. 77).
- Больного, который находится в шоке (см. стр. 77), включая аллергический шок (см. стр. 70).
- Людям, кому за 40 лет.
- Тучным людям (см. стр. 126).
- Любому, у кого признаки болезни сердца (стр. 325), удара (стр. 327), одышка, частые головные боли, опухоли, диабет (стр. 127), хронические проблемы с мочевой системой (стр. 234) или распухшие или болезненные вены (стр. 175).
- Людям, у которых высокое кровяное давление (см. стр. 125).
- Женщинам, которые принимают (или думают принимать) противозачаточные пилюли (см. стр. 288).

Есть 2 типа инструментов для измерения кровяного давления:



Манжета с прибором для измерения кровяного давления



и старый ртутный сфигмоманометр, который показывает уровень ртути.

Чтобы измерить давление:

- **Предложите человеку расслабиться.** Недавние физические упражнения, злость, нервозность могут поднять давление и дать неправильные показания. Объясните, что вы собираетесь делать, чтобы люди не удивлялись и не пугались.
- **Закрепите манжету** вокруг верхней части голей руки.
- **Закройте клапан** на резиновой груше, повернув винтик по часовой стрелке.
- **Поднимите давление** до 200 миллиметров ртутного столба.
- **Приложите стетоскоп** к внутренней поверхности локтя.
- **Слушайте внимательно пульс**, когда потихоньку выпускаете воздух из манжеты. Пока стрелка измерительного прибора (или уровень ртути) медленно падает, отметьте 2 показания:

1. **Снимите первое показание в тот момент, когда вы услышите мягкие глухие удары пульса.** Это происходит, когда давление в манжете упадет до высшего давления в артерии (систолическое или “верхнее” давление). Это верхнее давление достигается каждый раз, когда сердце сокращается и выталкивает кровь в артерию. У нормального человека верхнее давление обычно около 110-120 мм.
2. Продолжайте медленно снижать давление, слушая внимательно. **Снимите второе показание, когда звук пульса начинает затихать или исчезать.** Это происходит, когда давление в манжете падает до самого низкого давления в артерии (диастолическое или “нижнее” давление). Это нижнее давление достигается, когда сердце расслабляется между сжатиями. Нормальное давление около 60-80 мм.

Когда вы записываете кровяное давление человека, всегда пишите как верхнее, так и нижнее показания. Мы говорим, что нормальное кровяное давление у взрослых (КД) “120 на 80” и пишем так:

КД 120/80

120 – это верхнее (систолическое) давление,

80 – это нижнее (диастолическое) давление.

Работнику здравоохранения лучше назвать “верхнее” и “нижнее” числа (ВЧ и НЧ), чем пользоваться такими сложными словами, как систолическое и диастолическое.

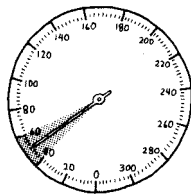
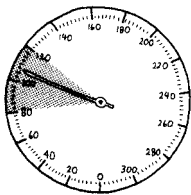
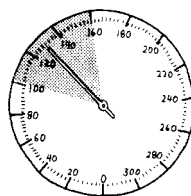
Обычно нижняя цифра говорит о здоровье человека. Например, если у больного кровяное давление 140/85, нет большой необходимости в уходе. Но если оно 135/110, то у него серьезное **высокое кровяное давление** и следует сбросить избыточный вес (если толстый человек) или лечить этого человека. Нижняя цифра выше 100 обычно означает, что кровяное давление достаточно высокое, чтобы требовать внимания (диета и лекарство).

Нормальное кровяное давление для взрослых обычно около 120/80, но от 100/60 до 140/90 может считаться нормальным.

Если у человека постоянно **пониженное кровяное давление**, нет повода к беспокойству. Действительно, если кровяное давление находится у нижней границы нормы – от 90/60 до 110/70 – это означает, что человек способен жить долго и меньше будет страдать от сердечных болезней или удара.

Внезапное падение кровяного давления – это опасный признак, особенно, если оно падает ниже 60/40. Работник здравоохранения должен наблюдать за любым внезапным падением кровяного давления людей, которые теряют кровь или у которых может быть риск шокового состояния (см. стр. 77).

Чтобы получить дополнительную информацию об измерении кровяного давления, см. *Пособие Для Работников Здравоохранения*, Глава 19.



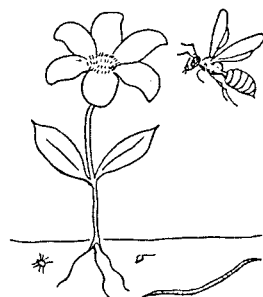
ОТРАВЛЕНИЕ ПЕСТИЦИДАМИ

Пестициды – ядохимикаты, которые применяются для уничтожения некоторых растений (пестициды), грибов (фунгициды), насекомых (инсектициды) или других животных (например, яд для крыс). В последние годы возрастающее злоупотребление пестицидами стало большой проблемой во многих развивающихся странах. Эти опасные химикаты могут вызвать тяжелые осложнения здоровья. Они могут еще и нарушить “баланс в природе”, который постепенно приведет к уменьшению урожая.



Многие пестициды крайне опасны. Сельчане часто применяют их, не зная о риске и о том, как защитить себя при их использовании. В результате многие **тяжело заболевают, слепнут, стерилизуются, парализуются**, а у детей могут быть **врожденные пороки**. И еще, работа с этими химикатами или употребление пищи, на которую попали пестициды, иногда могут вызвать **рак**.

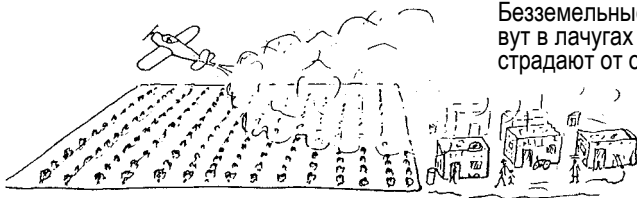
Ядохимикаты, используемые для уничтожения насекомых и сорняков, сначала позволяют фермерам собрать большой урожай. Но сегодня посевы, обработанные пестицидами, часто дают меньшие урожаи, чем посевы, которые не обрабатывались пестицидами. Это случается потому, что пестициды убивают также “полезных” птиц и насекомых, которые обеспечивают естественный контроль за паразитами и полезны для почвы. И еще, насекомые и сорняки становятся устойчивыми и требуется все большее количество более ядовитых типов пестицидов. Итак, начав однажды пользоваться этими ядохимикатами, фермеры попадают в зависимость от них.



Пестициды убивают также и полезных животных, таких как пчелы и дождевые черви.

Как только зависимость фермеров от химических пестицидов и удобрений возрастает, так и растет цена. Когда бедные фермеры, не имеющие больших участков, уже не могут позволить себе приобрести их, они вынуждены бросать землю. Как только земля переходит в собственность нескольких “гигантских” фермеров и все больше и больше людей становятся безземельными, то начинает расти число истощенных и голодных людей.

Риск отравления пестицидами очень высок для этих безземельных, плохо оплачиваемых фермеров и их семей. Многие живут в лачугах на краю полей, которые обработаны пестицидами. Яд может легко попасть в их дома или в водисточник. Это особенно опасно для малышей, которые могут серьезно заболеть даже от малого количества этих ядов. У фермеров, пользующихся компактным распылителем, который часто течет, тоже большой риск отравиться.



Безземельные фермеры и их семьи, которые живут в лачугах поблизости от больших ферм, часто страдают от отравления пестицидами.

Нужны законы, чтобы запретить самые опасные пестициды и обеспечить экологическую чистоту. К сожалению, после того, как правительства промышленных стран ограничили применение пестицидов, химические производства начали продавать свои опасные товары развивающимся странам, где законы не такие строгие.

Некоторые из самых опасных пестицидов – это алдрин, диэлдрин, эндрин, хлордан, гептахлор, DDT, DBCP, HCH, BHC, этилена дибромид (EDB), паракват, паратион, желтый агент (2-4D с 2-4-5T), кампехлор (токсафен), познтахлорфенил (PCP) и хлордимеформ. Внимательно читайте мелкий шрифт, потому что пестициды могут не быть частью торговой марки.

ВНИМАНИЕ: Если вы используете пестициды, принимайте следующие меры предосторожности:

- ◆ Смешайте химикаты и аккуратно заполните распылитель.
- ◆ Стойте так, чтобы ветер относил брызги от вас.
- ◆ Одевайте защитную одежду, которая закрывает все тело.
- ◆ Мойте руки перед едой.
- ◆ Вымойте все тело и смените одежду сразу после опыления.
- ◆ Постирайте одежду после опыления.
- ◆ Не позволяйте, чтобы после мытья вода попала в питьевой источник.
- ◆ Убедитесь, что емкости с пестицидами хорошо подписаны, и храните их подальше от детей. Не используйте эти емкости для еды и воды.



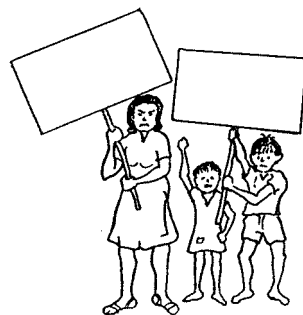
Осторожно: Убедитесь, что дети и беременные или кормящие грудью женщины, остаются далеко от всех пестицидов.

Лечение от отравления пестицидами:

- ◆ Если человек не дышит, быстро сделайте дыхание рот в рот (см. стр. 80).
- ◆ Следуйте инструкциям на стр. 103, чтобы вызвать у больного рвоту, и дайте порошковый уголь (или белки яиц), чтобы они впитали яд в кишечнике. Но не вызывайте у больного рвоту, если вы не знаете какой пестицид был использован или если он проглотил пестицид с бензином, керосином, ксиленом или другими жидкостями на нефтяной основе.
- ◆ Уберите любую испачканную пестицидом одежду и вымойте кожу, на которую попали пестициды.

Предложенные выше меры помогают лечить отравление пестицидами. Но для избежания этой проблемы в будущем потребуются:

1. Образование, для того, чтобы избегать опасных пестицидов, и законы, строго запрещающие их применение.
2. Организовать фермеров, чтобы они настаивали на защите своих прав и соблюдении мер безопасности.
3. Справедливое распределение земли.



ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ АБОРТА

Когда женщина принимает меры для прерывания беременности, прежде чем ребенок сформировался для дальнейшего выживания – это называется абортom. (В этой книге мы употребляем слово “аборт” только тогда, когда эта акция запланирована. Незапланированную, естественную потерю неродившегося ребенка мы называем “выкидыш”).

Решение делать или не делать аборт может быть трудным. Принимая решение, большинству женщин поможет мягкий уважительный совет и дружеская поддержка. Когда аборт делается в стерильных условиях клиники или больницы квалифицированным медицинским работником, он обычно безопасен для женщины. Аборты безопаснее, когда делаются при ранней беременности.



Но когда аборты делаются дома не квалифицированными людьми или в грязных условиях, они могут быть очень опасными. В местах, где аборты незаконные и их трудно сделать – эти “домашние” аборты часто становятся главной причиной смерти у женщин от 12 до 50 лет.

Методы прерывания беременности, такие как введение палок или других жестких предметов во влагалище или матку, сжимающих матку, или использование современных наркотиков или лекарственных трав, могут вызвать **сильное кровотечение, инфекцию и смерть.**

Опасные признаки осложнений при аборте:

- жар,
- боль в животе,
- сильное кровотечение из влагалища.

Если вы заметили эти признаки у женщины, которая может быть беременна, они могут быть результатом аборта. Но они могут быть и признаками выкидыша (стр. 281), внематочной беременности (стр. 280) или тазовой инфекции (стр. 243).



Некоторые женщины с проблемами после аборта идут за медпомощью, но они боятся или стесняются сказать, что случилось на самом деле. Другие могут быть напуганы или смущены так, что не обращаются за медпомощью, особенно, если аборт был тайным или незаконным. **Сильное кровотечение (больше чем при нормальной менструации) или инфекция, вызванная абортом, очень опасна. Сейчас же вызывайте медицинскую помощь!**

Между тем сделайте следующее:

- ◆ Попытайтесь остановить кровотечение. Следуйте инструкциям на стр. 281 от кровотечения при выкидыше. Дайте эргоновин (см. стр. 391).
- ◆ Лечите от шока (см. стр. 77).
- ◆ Если есть признаки инфекции, дайте антибиотик, как при родильной горячке (см. стр. 276).

Чтобы предупредить болезнь и смерть после аборта:

- ◆ Давайте антибиотики (ампициллин, стр. 353, тетрациклин, стр. 356) после любого аборта, делали его дома или в центре здоровья. Это уменьшит риск инфекции и опасных осложнений.
- ◆ **Предупреждайте нежелательную беременность.** Контроль над рождаемостью должен быть доступным для женщин и мужчин (см. Главу 20).
- ◆ Работайте, чтобы сделать ваше общество добрее и лучше, особенно, к женщинам и детям. Если общество гарантирует удовлетворение потребностей каждого, мало кто из женщин захочет делать аборт.
- ◆ Аборты, сделанные в чистых и безопасных условиях квалифицированными работниками здравоохранения, должны быть доступны для женщин – бесплатно или по низкой цене. Тогда эти женщины не захотят делать опасный, незаконный аборт.

Женщина, у которой есть **любые** признаки осложнений после аборта, независимо от того, делали его дома или в больнице – должна **немедленно** обратиться за медпомощью. Врачи и медперсонал **никогда не должен стыдить женщину, которая сделала аборт, а, наоборот, поддержать ее.**

НАРКОМАНИЯ

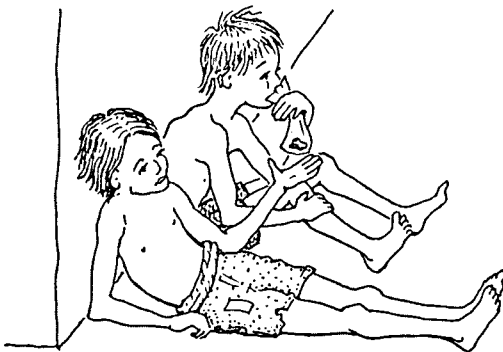
Сегодня употребление **вредных, вызывающих привыкание наркотиков** – растущая проблема мира.

Хотя **алкоголь и табак** официально разрешены в большинстве стран – это также пагубные привычки. Они приводят к плохому здоровью и к смерти миллионов людей каждый год. Злоупотребление алкоголем причиняет огромный вред семье, здоровью и это особая проблема всего мира. Курение сигарет было основной причиной смерти в течение многих лет в богатых странах и сейчас все еще остается основной причиной смерти в бедных странах. Как только люди в богатых странах перестали курить, табачные компании повернулись к “третьему миру” как к новому и самому легкому рынку.

Проблемы здоровья, связанные с употреблением алкоголя и табака, обсуждались на стр. 148 и 149.

Кроме алкоголя и табака многие люди в различных частях света употребляют “запрещенные” наркотики. Они отличаются в разных регионах и включают **марихуану** (травка, гашиш, ганджа), **опиум** (героин, морфин) и **кокаин** (ломка, снежок, качка).

Растущая проблема у бедных детей в городах – это **нюханье химикатов**, особенно **клея**, а иногда растворителей для красок, полиролей для обуви, газаolina и чистящих жидкостей. А некоторые люди злоупотребляют лекарствами – очень сильными болеутоляющими, стимуляторами и “заглушающими аппетит” наркотиками.



Наркотики можно глотать, вводить, курить, жевать или нюхать. Различные наркотики оказывают различное воздействие на тело и мозг. Кокаин или орех кола могут заставить человека почувствовать себя энергичным и счастливым, но спустя некоторое время эти ощущения сменяются усталостью, раздражением и депрессией. Некоторые наркотики, такие как алкоголь, опиум, морфин и героин, могут сначала заставить человека почувствовать себя спокойным и расслабленным, а позже вызывают в нем подавленность, заторможенность, потерю самоконтроля и даже сознания. Другие наркотики такие, как марихуана, PCP, LSD, заставляют человека воображать вещи, которые не существуют, или создавать мечтательные фантазии.

ВНИМАНИЕ: Употребление сигарет, алкоголя или других наркотиков беременными женщинами может навредить неродившемуся ребенку. Инъекции наркотиков, которые делают одной и той же иглой нескольким людям, распространяют опасные болезни. См. гепатит (стр. 172) и СПИД (стр. 399).

Люди обычно начинают принимать наркотики, чтобы избежать лишений, забыть голод или успокоить боль в своей ежедневной жизни. Но начав однажды, они часто попадают на “крючок” или у них появляется склонность к наркотикам. Если они пытаются прекратить, то становятся жалкими, больными или вспыльчивыми. Чтобы достать наркотики, они часто совершают преступления, ходят голодными или бросают семью. Таким образом, наркотики становятся проблемой для всей семьи и общества.



Такие наркотики, как кокаин и героин, вызывают быстрое привыкание; человек может попробовать наркотик один лишь раз и почувствовать необходимость принимать его и дальше. Другие наркотики вызывают привыкание после длительного приема. Склонность к наркотикам – это ловушка, которая ведет к проблемам со здоровьем и даже смерти. Но **благодаря решительности, силе воли и поддержке людей наркоманию можно преодолеть.**

Когда человек бросает первый раз наркотик, к которому у него склонность, он обычно чувствует себя жалким и странно ведет себя. Это называется “выход”. Человек может быть очень нервным, депрессивным или злым. Он чувствует себя так, как будто не может жить без наркотиков.

С некоторыми наркотиками, такими как героин или кокаин, выход может быть таким тяжелым, что человек приходит в ярость и травмирует себя или других. Такой человек нуждается в особой клинической помощи. А от таких наркотиков, как алкоголь, марихуана, табак и нюханье химикатов, помощь медиков не является необходимой, но важна забота и поддержка семьи и друзей.

Вот несколько советов, чтобы помочь решить проблему употребления наркотиков и привыкания к ним:

- ◆ Помогите и поддержите по возможности тех, кто хочет избавиться от пагубной привычки. Помните, что их тяжелое настроение из-за склонности к наркотикам, но не из-за вас.
- ◆ Члены общества, бросившие употреблять наркотики, могут образовать “группу поддержки” и помочь другим попытаться бросить пить и принимать наркотики. Анонимные Алкоголики – одна из таких организаций (см. стр. 429). Эта группа выздоровевших алкоголиков успешно помогает людям во всем мире справиться с проблемой склонности к наркотикам.
- ◆ Семьи, школы и работники здравоохранения могут рассказать детям об опасности сигарет, алкоголя и наркотиков. Помогите детям узнать, что есть другие безвредные способы “чувствовать себя хорошо”, вести себя как взрослые или протестовать.
- ◆ Работайте, чтобы искоренить некоторые проблемы в вашем обществе, которые могут привести людей к употреблению наркотиков: голод, тяжелые условия труда и недостаток возможностей для лучшей жизни. Помогите неимущим людям организовать и бороться за свои права.

Поддержка и доброта действуют лучше, чем наказание и жестокость.

ДРУГИЕ КНИГИ ИЗ ФОНДА ГЕСПЕРИАНА

“Пособие Для Работников Здравоохранения” Дэвида Вернера и Билла Бауэра – книга о методах, помощи и предложениях для сельских работников здравоохранения и их инструкторов. Она описывает централизованный подход людей к уходу за здоровьем и представляет лучшую стратегию для эффективного вовлечения в нее общества. Темы, затронутые в книге, включают: планирование обучения, программы, планирование занятий, изготовление и применение наглядных пособий, пересказы и ролевые пьески. Книга посвящает также целый раздел Обучению пользованию книгой Там, Где Нет Доктора. 640 страниц. Доступна на испанском и английском языках.



“Там, Где Нет Дантиста” Миррэя Диксона показывает людям, как ухаживать за своими зубами и деснами и как предупредить заболевания зубов и десен. Делается упор на распространение этих знаний дома, в обществе и в школе. Автор дает также детальную и хорошо иллюстрированную информацию по использованию зубо-рачебного оборудования, пломбированию и удалению зубов. 208 страниц.



“Искалеченные Деревенские Дети” Дэвида Вернера содержит богатую информацию о наиболее распространенных причинах инвалидности у детей, включая полиомиелит, церебральный паралич, юношеский подростковый артрит, слепоту и глухоту. Автор высказывает свои предложения о простой реабилитации на сельском уровне и объясняет, как оказать различную доступную и дешевую помощь. Обращает внимание на то, как помочь искалеченным детям найти себя и быть принятыми в обществе. 672 страницы. Доступна на английском и испанском языках.



Фонд Геспериана также распространяет и другие книги о здоровье и реабилитации, различные слайды для показа, статьи и иллюстративные материалы. Пожалуйста, напишите нам письмо с описанием всего нашего материала с ценами и заказной информацией, которая вам нужна.

The Hesperian Foundation
P.O. Box 1692
Palo Alto, California 94302
U.S.A.

